

TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPOS

das evidências à prática

Carmem Beatriz Neufeld
Bernard P. Rangé (orgs.)



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPOS

das evidências à prática

Carmem Beatriz Neufeld
Bernard P. Rangé (orgs.)





Aviso

Todo esforço foi feito para garantir a qualidade editorial desta obra, agora em versão digital. Destacamos, contudo, que diferenças na apresentação do conteúdo podem ocorrer em função das características técnicas específicas de cada dispositivo de leitura.

TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPOS

das evidências à prática

**Carmem Beatriz Neufeld
Bernard P. Rangé (orgs.)**

Versão impressa desta obra: 2017



A Artmed é a editora
oficial da FBTC

2017

© Artmed Editora Ltda., 2017.

Gerente editorial: *Letícia Bispo de Lima*

Colaboraram nesta edição:

Coordenadora editorial: *Cláudia Bittencourt*

Capa: *Paola Manica*

Preparação de originais: *Camila Wisnieski Heck*

Leitura final: *Antonio Augusto da Roza*

Projeto e editoração: *TIPOS – design editorial e fotografia*

Produção digital: *Loope* | www.loope.com.br

T315 Terapia cognitivo-comportamental em grupos : das evidências à prática [recurso eletrônico] /
Organizadores, Carmem Beatriz Neufeld, Bernard P. Rangé. – Porto Alegre: Artmed,
2017.
e-PUB.

Editado como livro impresso em 2017.
ISBN 978-85-8271-417-1

1. Psicoterapia. 2. Terapia cognitivo-comportamental. I. Neufeld, Carmem Beatriz. II.
Rangé, Bernard P.

CDU 616.8-085.851

Catálogo na publicação: Poliana Sanchez de Araujo – CRB 10/2094



Reservados todos os direitos de publicação à
ARTMED EDITORA LTDA., uma empresa do GRUPO A EDUCAÇÃO
S.A.

Av. Jerônimo de Ornelas, 670 – Santana

90040-340 – Porto Alegre – RS

Fone: (51) 3027-7000 Fax: (51) 3027-7070

SÃO PAULO

Rua Doutor Cesário Mota Jr., 63 – Vila Buarque

01221-020 – São Paulo – SP

Fone: (11) 3221-9033

SAC 0800 703-3444 – www.grupoa.com.br

É proibida a duplicação ou reprodução deste volume, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, mecânico, gravação, fotocópia, distribuição na Web e outros), sem permissão expressa da Editora.



AUTORES

Carmem Beatriz Neufeld (Org.): Psicóloga. Terapeuta cognitiva certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC). Mestre e Doutora em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Pós-doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professora e orientadora do Programa de Pós-graduação em Psicologia do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (FFCLRP/USP). Coordenadora do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-comportamental (LaPICC) da USP. Vice-presidente da Associação Latino-americana de Psicoterapias Cognitivas (ALAPCO; gestão 2015-2018). Bolsista produtividade do CNPq.

Bernard P. Rangé (Org.): Psicólogo. Terapeuta cognitivo certificado pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC). Mestre em Psicologia Teórico-experimental pela Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). Doutor em Psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Professor do Programa de Pós-graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IP/UFRJ).

Adriana Munhoz Carneiro: Psicóloga clínica. Especialista em Terapia cognitivo-comportamental pelo Ambulatório de Ansiedade da Faculdade de Medicina da USP (AMBAM/FMUSP). Especialista em Avaliação Neuropsicológica pelo Departamento de Neurologia do Hospital das Clínicas (HC) da USP. Mestre em Psicologia – Avaliação Psicológica em Saúde

Mental – pela Universidade São Francisco (USF). Doutoranda em Psiquiatria pela FMUSP. Pesquisadora colaboradora do Programa de Transtornos Afetivos (PROGRUDA) do HCFMUSP.

Altemir José Gonçalves Barbosa: Psicólogo escolar. Mestre em Psicologia Escolar pela PUC-Campinas. Doutor em Psicologia pela PUC-Campinas. Professor do Curso de Psicologia e do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).

Ana Irene F. Mendes: Psicóloga clínica. Terapeuta cognitivo-comportamental certificada pela FBTC. Mestre e Doutora em Psicobiologia pela FFCLRP/USP. Coordenadora do Ambulatório de Terapia Cognitivo-comportamental do HCFMRP/USP.

Ana Lucia Ivatiuk: Psicóloga. Especialista em Terapia Comportamental e Cognitiva pela USP. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Campinas. Doutora em Psicologia como Profissão e Ciência pela PUC-Campinas. Professora Assistente Doutora do Curso de Psicologia da FAE Centro Universitário. Membro do GT Psicologia da Saúde em Instituições e na Comunidade da ANPEPP. Sócia e psicóloga clínica no Grupo Crescer.

Ana Regina Noto: Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicobiologia pela Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp). Professora Adjunta de Medicina e Sociologia do Abuso de Drogas, Departamento de Psicobiologia da Unifesp. Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Saúde e Uso de Substâncias (Nepsis) e do Centro Brasileiro de Formação e Pesquisa em *Mindfulness Based Relapse Prevention* (MBRP-Brasil).

Andressa da Silva Behenck: Enfermeira. Especialista em Saúde Mental Coletiva pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Mestre em Enfermagem em Saúde Mental pela UFRGS. Doutoranda no Programa de Pós-graduação em Enfermagem da UFRGS. Enfermeira psiquiátrica do Serviço de Enfermagem Ambulatorial do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA).

Angélica Gurjão Borba: Psicóloga clínica. Terapeuta cognitivo-comportamental certificada pela FBTC. Pós-graduada em Terapia Cognitivo-comportamental pela UFRJ e em Terapia Através do Movimento pela Faculdade Angel Vianna (FAV-RJ). Mestre e Doutora em Psicologia pela UFRJ.

Aristides Volpato Cordioli: Psiquiatra. Mestre em Psiquiatria pela UFRGS. Doutor em Ciências Médicas – Psiquiatria – pela UFRGS. Professor aposentado da UFRGS.

Bernardo Carramão Gomes: Psicólogo. Mestre em Ciências pelo HCFMUSP. Doutorando em Ciências no HCFMUSP. Colaborador do Programa de Transtorno Bipolar (PROMAN), do Instituto de Psiquiatria (IPq), HCFMUSP.

Carla Rodrigues Zanin: Psicóloga. Especialista em Psicologia Clínica (TCC) pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP). Mestre em Ciências da Saúde pela FAMERP. Psicóloga supervisora do Curso de Aprimoramento em Psicologia da Saúde no Hospital de Base (HB) da Fundação Faculdade Regional de Medicina (FUNFARME). Professora Titular da Graduação em Psicologia da Fundação Educacional de Fernandópolis (FEF). Psicóloga clínica, coordenadora dos cursos de extensão Psicologia da Saúde e Transtornos Mentais do Instituto de Psicologia, Educação, Saúde e Comportamento (IPECS). Subchefe do Serviço de Psicologia do HB/FUNFARME.

Caroline da Cruz Pavan-Cândido: Psicóloga. Especialista em Terapia Analítico-comportamental. Mestre em Ciências – Psicologia – pela FFCLRP-USP. Doutoranda em Psicologia na FFCLRP-USP. Bolsista da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP).

Christian Haag Kristensen: Psicólogo. Especialista em Neuropsicologia. Mestre em Psicologia pela UFRGS. Doutor em Psicologia do Desenvolvimento pela UFRGS. Professor Titular da Escola de Humanidades

da PUCRS. Coordenador do Programa de Pós-graduação em Psicologia da PUCRS. Bolsista produtividade do CNPq-1D.

Conceição Reis de Sousa: Psicóloga clínica. Terapeuta cognitiva certificada pela FBTC. Mestre em Psicossociologia pela UFRJ. Doutoranda no Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde na Unifesp/BS. Psicóloga do Serviço-Escola de Psicologia da Unifesp.

Daniela Schneider Bakos: Psicóloga. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental pela Unisinos. Mestre e Doutora em Psicologia Cognitiva pela UFRGS.

Daniela Tusi Braga: Psicóloga. Mestre e Doutora em Ciências Médicas – Psiquiatria – pela UFRGS. Coordenadora, professora e supervisora do Curso de Formação em Terapia Cognitivo-comportamental do Centro de Estudos Luís Guedes (CELG). Professora e supervisora do Curso de Especialização em Terapias Cognitivo-comportamentais (InTCC).

Denise Petresco David: Psicóloga clínica. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental pelo IPq-HCFMUSP. Mestre em Ciências pela FMUSP. Pesquisadora e coordenadora dos Encontros Psicoeducacionais sobre Depressão e Transtorno Bipolar do PROGRUDA, IPq-HCFMUSP.

Eduarda Rezende Freitas: Psicóloga clínica. Mestre em Psicologia pela UFJF. Doutoranda em Psicologia pela UFJF. Membro da diretoria da Associação de Terapias Cognitivas de Minas Gerais (ATC-Minas).

Fernanda Corrêa Coutinho: Psicóloga. Mestre em Psicologia Clínica pela UFRJ. Doutora em Saúde Mental pela UFRJ. Pós-doutoranda em Psicologia Clínica na PUC-Rio. Coordenadora do Centro de Atendimento em Terapia Cognitiva (CATC).

Fernanda Pereira Hildebrandt: Psicóloga. Especialista em Psicologia Hospitalar pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Mestre em Ciências pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Doutora em Psicologia pela UFRJ. Professora Adjunta da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ).

Isabel Weiss: Psicóloga. Especialista em Terapias Cognitivas pela USP e em Dependência Química e outros Transtornos Compulsivos pela Universidade Estácio de Sá (UNESA/RJ). Mestre em Saúde Coletiva pela UFJF. Doutora em Ciências pela Unifesp. Diretora do Espaço Terapêutico Isabel Weiss Ltda.

Isabela Maria Freitas Ferreira: Psicóloga. Mestre em Psicologia pela FFCLRP/USP. Integrante do LaPICC-USP.

Janaína Bianca Barletta: Psicóloga. Psicoterapeuta cognitivo-comportamental certificada pela FBTC. Especialista em Psicologia Clínica da Saúde pela Universidade de Brasília (UnB) e em Psicoterapia Cognitivo-comportamental pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais (FCMMG). Mestre em Psicologia pela UnB. Doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Professora do Curso de Psicologia da Universidade Paulista (UNIP/DF). Pesquisadora colaboradora do Grupo de Estudos em Prevenção e Promoção de Saúde no Ciclo de Vida (GEPPSVida), UnB.

Josiane Mota Lopes: Psicóloga. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental pelas Faculdades Integradas de Taquara (FACCAT). Mestre em Saúde, Ambiente e Trabalho pelo Mestrado em Saúde, Ambiente e Trabalho/Universidade Federal da Bahia (MSAT/UFBA). Professora Assistente da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública (EBMSP).

Julia Luiza Schäfer: Psicóloga. Mestranda em Cognição Humana na PUCRS.

Juliana Braga Gomes: Psicóloga e pedagoga. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental pelo Instituto da Família de Porto Alegre (Infapa). Mestre em Ciências Médicas – Psiquiatria – pela UFRGS. Doutora em Psiquiatria e Ciências do Comportamento pela UFRGS.

Juliana Maltoni: Psicóloga. Mestranda em Psicologia na FFCLRP-USP. Colaboradora de pesquisa do LaPICC-USP.

Laisa Marcorela Andreoli Sartes: Psicóloga. Mestre e Doutora em Psicobiologia pela Unifesp. Professora Adjunta do Departamento de Psicologia da UFJF.

Lidiane Borba: Psicóloga. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental e em Terapia Sistêmica. Mestre em Psiquiatria pela UFRGS. Professora e supervisora do Instituto de Ensino, Pesquisa e Atendimento Individual e Familiar (INTCC).

Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams: Psicóloga. Mestre em Psicologia pela Universidade de Manitoba, Canadá. Doutora em Psicologia Experimental pela USP. Pós-doutorada na Universidade de Toronto, Canadá. Professora Titular da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). Pesquisadora 1-A do CNPq. Conselheira da International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect (ISPCAN).

Lucia Novaes Malagris: Psicóloga. Especialista em Psicologia Clínica pelo CFP. Terapeuta cognitiva certificada pela FBTC. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Campinas. Doutora em Ciências pela UERJ. Pós-doutorada pela PUC-Campinas. Professora Associada do IP/UFRJ.

M. Cristina Miyazaki: Psicóloga. Mestre em Psicologia pela PUC-Campinas. Doutora em Psicologia Clínica pela USP. Coordenadora do Programa de Mestrado em Psicologia e Saúde da FAMERP. Bolsista produtividade do CNPq.

Marcele Regine de Carvalho: Psicóloga. Mestre e Doutora em Saúde Mental pelo IPUB/UFRJ. Professora do Departamento de Psicologia Clínica do IP/UFRJ. Supervisora clínica na Divisão de Psicologia Aplicada do IP/UFRJ. Coordenadora do Núcleo Integrado de Pesquisa em Psicoterapia nas Abordagens Cognitivo-comportamentais (NIPPACC) do Laboratório de Pânico e Respiração (LABPR) do IPUB/UFRJ.

Marcelo Montagner Rigoli: Psicólogo. Especialista em Terapias Cognitivo-comportamentais pela Wainer & Piccoloto (WP) – Centro de Psicoterapia Cognitivo-comportamental. Mestre em Cognição Humana pela PUCRS.

Doutorando em Cognição Humana na PUCRS. Professor e supervisor clínico no Instituto de Terapias Cognitivo-comportamentais. Pesquisador e supervisor clínico do Núcleo de Estudos e Pesquisa em Trauma e Estresse (NEPTE), PUCRS.

Marcia Fortes Wagner: Psicóloga clínica. Terapeuta cognitiva certificada pela FBTC. Mestre em Psicologia Clínica pela PUCRS. Doutora em Psicologia pela PUCRS. Professora do Programa de Pós-graduação em Psicologia da Faculdade Meridional (IMED). Membro do GT Relações Interpessoais e Competência Social da ANPEPP.

Margareth da Silva Oliveira: Psicóloga. Mestre em Psicologia Clínica pela PUCRS. Doutora em Ciências pela Unifesp. Professora Titular da Faculdade de Psicologia da Escola de Humanidades da PUCRS. Sócia-fundadora da FBTC. Delegada Brasileira na ALAPCO. Coordenadora do Grupo de Pesquisa Avaliação e Atendimento em Psicoterapia Cognitivo-comportamental.

Maria Amélia Penido: Psicóloga. Doutora em Psicologia pela UFRJ. Professora da PUC-Rio.

Marilda Lipp: Psicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Mestre em Psicologia Experimental pela George Washington University. Doutora em Psicologia Experimental e Clínica pela George Washington University. Diretora do Instituto de Psicologia e Controle do Stress (IPCS). Professora convidada na Unicamp.

Marina Gusmão Caminha: Psicóloga. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental pela Unisinos, certificada pela FBTC. Coordenadora do Instituto TRI, sócia-diretora do European Center for Cognitive Behavioral Therapies (ETCC) e do InTCC-RS. Coordenadora dos cursos de Especialização em Terapia Cognitivo-comportamental e em Terapia Cognitivo-comportamental na Infância e Adolescência no InTCC.

Mário F. Juruena: Psiquiatra. Doutor em Psiquiatria pela Universidade de Londres. Professor de Psiquiatria no Departamento de Neurociências e

Comportamento da USP. Coordenador do Programa de Assistência, Ensino e Pesquisa em Estresse, Trauma e Doenças Afetivas, FMRP/USP. Professor Honorário do King's College London e Honorary Consultant Psychiatrist SLAM; Fellow Academy of Medical Sciences/Royal Society – Reino Unido.

Martha Moreira Cavalcante Castro: Psicóloga. Especialista em Clínica de Dor pela Universidade Salvador (Unifacs) e em Terapia Cognitivo-comportamental pelo Núcleo de Terapia Cognitiva da Bahia (NTCBA). Mestre em Neurociências pela UFBA. Doutora em Medicina e Saúde pela UFBA. Professora Adjunta da Graduação e da Pós-graduação da Escola Bahiana de Medicina e Saúde Pública. Professora Adjunta da UFBA. Pesquisadora e fundadora do Centro de Dor da UFBA.

Milton José Cazassa: Psicólogo. Mestre em Psicologia Clínica pela PUCRS. Doutorando em Psicologia Clínica na PUCRS. Coordenador do Ambulatório de Saúde Mental da Prefeitura de Eldorado do Sul. Psicólogo do Programa de Saúde Mental da Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil (CASSI).

Monica Duchesne: Psicóloga. Terapeuta cognitivo-comportamental certificada pela FBTC. Mestre e Doutora em Saúde Mental pela UFRJ. Coordenadora da Psicologia do Grupo de Obesidade e Transtornos Alimentares (GOTA) do Instituto de Psiquiatria (IPUB) da UFRJ, Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia Luiz Capriglione.

Nathália Soares Ribeiro: Psicóloga. Formação em Terapia Cognitivo-comportamental pelo Núcleo de Estudos Interdisciplinares em Saúde Mental (NEISME). Mestranda em Psicologia na UFJF. Pesquisadora associada ao Centro de Referência em Pesquisa, Intervenção e Avaliação em Álcool e Outras Drogas (CREPEIA).

Nazaré Almeida: Psicóloga. Especialista em Terapia cognitivo-comportamental pelo Instituto Paranaense de Terapias Cognitivas (IPTC). Mestre em Educação Tecnológica pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais (CEFET-MG).

Neide A. Micelli Domingos: Psicóloga. Especialista em Terapia Cognitivo-comportamental e em Psicologia da Saúde. Mestre em Psicologia Clínica pela PUC-Campinas. Doutora em Psicologia pela PUC-Campinas. Professora Adjunta do Departamento de Psicologia da FAMERP.

Priscila de Camargo Palma: Psicóloga. Especialista em Terapia Cognitiva e em Neuropsicologia pelo IPTC. Mestre em Psicologia pela USP-RP. Doutoranda em Psicologia na USP-RP.

Rafael Thomaz da Costa: Psicólogo. Mestre e Doutor em Saúde Mental pelo IPUB/UFRJ. Professor convidado no IPUB/UFRJ. Coordenador do NIPPACC. Pesquisador do LABPR do IPUB/UFRJ.

Ricardo Franzin: Psiquiatra. Especialista em Terapias Cognitivo-comportamentais pelo IPTC. Psiquiatra dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Terra Boa, Ubiratã e Mamborê, Paraná.

Robson Miranda Costa Gomes: Médico. Residente em Psiquiatria no Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto.

Sabrina Mazo D’Affonseca: Psicóloga. Mestre em Educação Especial pela - UFSCar. Doutora em Psicologia pela UFSCar. Professora Adjunta do Departamento de Psicologia da UFSCar.

Salmo Zugman: Psiquiatra. Mestre em Farmacologia – Sistema Nervoso Central – pela Universidade Federal do Paraná (UFPR). Diretor do IPTC.

Silvia Maria Cury Ismael: Psicóloga. Especialista em Psicologia Hospitalar pelo CFP e em Controle do Tabagismo pela Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health. Mestre e Doutora em Ciências pela FMUSP. Professora do MBA de Qualidade de Vida da Pós-graduação do São Camilo. Gerente de Psicologia e coordenadora do Programa Vida Sem Cigarro do Hospital do Coração.

Thaís Alvares Linhares Vieira: Psicóloga clínica. Especialista em Teoria Cognitivo-comportamental pela Central TCC e em Transtornos Alimentares pelo GOTA do IPUB/UFRJ.

Thaís Barbosa Benedetti: Psicóloga. Mestranda em Psicologia na FFCLRP-USP.

Vinícius Guimarães Dornelles: Psicólogo. Dialectical Behavior Therapy (DBT): Intensive Training pelo Behavioral Tech, The Linehan Institute e Fundación Foro. Formação em Terapias Baseadas em Evidências para o Transtorno da Personalidade *Borderline* pela Fundación Foro e em Terapia Comportamental Dialética pela Universidade de Lujan, Argentina. Especialista em Terapias Cognitivo-comportamentais pela WP. Mestre em Psicologia – Cognição Humana – pela PUCRS. Sócio diretor da Vincular.



APRESENTAÇÃO

Conhecer a doutora Carmem Beatriz Neufeld em uma conferência internacional sobre terapia cognitivo-comportamental (TCC) há alguns anos foi um prazer. Na época, ela era presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas (FBTC), e eu, presidente da organização canadense. Descobrimos, na ocasião, interesses mútuos em clínica e pesquisa sobre TCC em grupo. A doutora Neufeld é uma líder internacionalmente reconhecida na área que, graças a seus esforços na propagação do conhecimento e do treinamento – o que inclui este livro –, vem contribuindo de forma significativa para o avanço da prática clínica de TCC no Brasil. Em um de seus livros anteriores, *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes*, tive a oportunidade de participar com o capítulo “Terapia cognitivo-comportamental em grupo para adolescentes com transtornos de ansiedade”. Já o doutor Bernard P. Rangé é um dos pioneiros da TCC e da TCC em grupo na América Latina, sendo fundador das três mais importantes associações latino-americanas de TCC. Este livro representa o ápice do trabalho que ambos realizaram juntos quando a doutora Neufeld era aluna de pós-doutorado no laboratório do doutor Rangé na Universidade Federal do Rio de Janeiro, de 2015 a 2016.

A TCC é um tratamento baseado em evidências de primeira linha para uma ampla gama de transtornos e problemas psicológicos. No entanto, apesar de sua popularidade, relativamente pouca atenção tem sido dada às considerações únicas necessárias para se prover a TCC em formato de grupo. A terapia em grupo oferece uma abordagem custo-efetiva, permitindo que um maior número de pessoas receba tratamento por um custo de pessoal mais

baixo, se comparado ao tratamento individual. Além disso, o formato em grupo tem diversas outras vantagens em comparação à terapia individual, incluindo oportunidades para aprendizagem, maior apoio dos membros do grupo, redução do estigma e aumento do autofoco. É mais desafiador para o terapeuta desenvolver a terapia em um arranjo de grupo, já que muitos fatores devem ser considerados, como trabalhar com um coterapeuta, gerir o tempo e observar as necessidades individuais dos clientes no grupo; ao mesmo tempo, cuidadosamente se faz o balanceamento da aplicação das técnicas da TCC, com atenção ao processo em grupo. Sem conhecimento especializado no desenvolvimento da TCC em um arranjo de grupo, a terapia pode parecer muito com o tratamento individual conduzido em um grupo em que o terapeuta se move frequentemente de um membro a outro e não aplica as características únicas do arranjo de grupo ou não aproveita o poder do processo em grupo.

Terapia cognitivo-comportamental em grupos: das evidências à prática oferece um conhecimento fundamental para desenvolver a competência do terapeuta na TCC em grupo. Na primeira parte do livro, os capítulos se voltam à história da terapia em grupo como intervenção, aos aspectos técnicos da administração da TCC em grupo e aos fatores específicos do processo que precisam ser gerenciados ao conduzi-la. Na segunda parte, os capítulos são voltados a problemas específicos e se constituem como um guia sob medida para a condução da TCC em grupos nesses casos. A parte final foca em grupos-alvo específicos, incluindo pais e grupos de idosos, bem como em áreas de interesse especializadas, como *mindfulness* e aceitação, estresse e saúde.

Este livro é uma importante contribuição ao crescente trabalho na área, sendo leitura obrigatória para qualquer clínico que pratique ou venha a praticar a TCC em grupo.

Randi E. McCabe, Ph.D., C.Pych.

Past-President, Canadian Association
of Cognitive and Behavioural

Therapies (CACBT)
Director, Anxiety Treatment & Research
Clinic, St. Joseph's Healthcare Hamilton
Professor, McMaster University,
Ontário, Canadá



SUMÁRIO

PARTE I BASES DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO

1 BREVE HISTÓRICO DAS TERAPIAS EM GRUPO E DA TCCG

Bernard P. Rangé

Caroline da Cruz Pavan-Cândido

Carmem Beatriz Neufeld

2 ASPECTOS TÉCNICOS E O PROCESSO EM TCCG

Carmem Beatriz Neufeld

Juliana Maltoni

Ana Lucia Ivatiuk

Bernard P. Rangé

PARTE II GRUPOS EM DIFERENTES DEMANDAS

3 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Bernard P. Rangé

Priscila de Camargo Palma

Marcele Regine de Carvalho

Maria Amélia Penido

Fernanda Corrêa Coutinho

Angélica Gurjão Borba

4 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA DEPRESSÃO

Adriana Munhoz Carneiro

Denise Petresco David

5 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNO BIPOLAR

Bernardo Carramão Gomes

Rafael Thomaz da Costa

Mário F. Juruena

6 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNO OBSESSIVO-COMPULSIVO

Aristides Volpato Cordioli

Daniela Tusi Braga

Andressa da Silva Behenck

Juliana Braga Gomes

7 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA

Ricardo Franzin

Salmo Zugman

Ana Irene F. Mendes

Robson Miranda Costa Gomes

Carmem Beatriz Neufeld

8 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES E OBESIDADE

Monica Duchesne

Nazaré Almeida

Thaís Alvares Linhares Vieira

Carmem Beatriz Neufeld

9 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRAUMA E SITUAÇÕES DE CRISE

Marcelo Montagner Rigoli

Julia Luiza Schäfer
Christian Haag Kristensen

10 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS PARCEIROS AGRESSORES

Sabrina Mazo D’Affonseca
Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams

11 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO APLICADA A USUÁRIOS DE DROGAS

Margareth da Silva Oliveira
Laisa Marcorela Andreoli Sartes
Nathálya Soares Ribeiro
Silvia Maria Cury Ismael
Milton José Cazassa

12 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA DEMANDAS EM CONTEXTOS DE SAÚDE

Lucia Novaes Malagris
M. Cristina Miyazaki
Neide A. Micelli Domingos
Carla Rodrigues Zanin

13 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA DOR CRÔNICA

Martha Moreira Cavalcante Castro
Josiane Mota Lopes

14 TERAPIA DE GRUPO PARA PACIENTES COM TRANSTORNO DA PERSONALIDADE

Lidiane Borba
Daniela Schneider Bakos
Vinícius Guimarães Dornelles
Carmem Beatriz Neufeld

PARTE III GRUPOS ESPECIAIS EM TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO

15 TRATAMENTOS EM GRUPO BASEADOS EM *MINDFULNESS*

Isabel Weiss

Ana Regina Noto

160 TREINO DE CONTROLE DO ESTRESSE EM GRUPO: UM MODELO DA TCC

Marilda Lipp

17 DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GRUPOS

Marcia Fortes Wagner

Isabela Maria Freitas Ferreira

Carmem Beatriz Neufeld

18 ORIENTAÇÃO DE PAIS EM GRUPOS

Carmem Beatriz Neufeld

Thaís Barbosa Benedetti

Marina Gusmão Caminha

19 GRUPO DE APOIO COMO ESTRATÉGIA DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL PARA PREVENIR E PROMOVER SAÚDE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Janaína Bianca Barletta

20 GRUPOS DE TCC NA SAÚDE PÚBLICA

Conceição Reis de Sousa

Fernanda Pereira Hildebrandt

Carmem Beatriz Neufeld

21 TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COM GRUPOS DE IDOSOS: DA REMEDIAÇÃO À PROMOÇÃO DE ENVELHECIMENTO POSITIVO

Altemir José Gonçalves Barbosa

Eduarda Rezende Freitas

Carmem Beatriz Neufeld

PARTE I

BASES DA TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO



1



BREVE HISTÓRICO DAS TERAPIAS EM GRUPO E DA TCCG

Bernard P. Rangé

Caroline da Cruz Pavan-Cândido

Carmem Beatriz Neufeld

Este capítulo aborda, de forma breve, aspectos históricos das intervenções terapêuticas em grupo e das terapias cognitivo-comportamentais em grupo (TCCGs), com foco em seu desenvolvimento no Brasil. No que se refere à história das intervenções em grupo, o texto traz alguns autores a quem se atribui o início da área, as principais características das intervenções que realizavam e suas contribuições presentes até os dias atuais. Já em relação à TCCG, serão apresentados alguns aspectos históricos gerais, o contexto histórico de inserção do grupo como uma modalidade de atendimento em terapia cognitivo-comportamental (TCC), a evolução das características dos grupos ao longo das décadas e algumas preocupações apontadas por autores consagrados na área. Por último, também de forma breve, serão apresentados dados históricos sobre o desenvolvimento da TCCG no Brasil, como alguns

pioneiros, os primeiros trabalhos desenvolvidos e os tipos de grupos realizados no País, bem como seus principais resultados.

Considerando que toda pesquisa é um recorte de uma infinidade de possibilidades, e que toda a história é uma versão possível dos fatos, contada pelos autores a partir de sua própria história e dos métodos utilizados, apresentaremos aqui um dos recortes possíveis. É importante ressaltar que não se pretendeu descrever de forma aprofundada a história da terapia de grupo e da TCCG no Brasil e no mundo. Tampouco houve a pretensão de realizar uma revisão sistemática das pesquisas sobre TCCG e sua efetividade. O capítulo tem como objetivo introduzir alguns aspectos históricos importantes e apresentar um panorama dos resultados da TCCG ao longo de sua história e na atualidade, especialmente no Brasil.

BREVE HISTÓRIA DA TERAPIA EM GRUPO

Pode-se dizer que a prática de terapia em grupos tem uma história tão longa quanto a da humanidade. Nossos ancestrais se ajudavam em práticas coletivas de auxílio e suporte mútuos, rituais religiosos e de cura, entre outras. Porém, a prática da terapia psicológica em grupos organizados com o propósito de ajudar os participantes a enfrentar transtornos mentais e problemas psicológicos é bem mais recente e certamente seria de difícil compreensão para nossos antepassados (Rosenbaum, Lakin, & Roback, 1992). Assim, diferentemente da psicoterapia individual, a história da terapia de grupo não apresenta início e desenvolvimentos tão claros e precisos, havendo divergências quanto ao momento de início e aos pioneiros dessa prática (Bechelli & Santos, 2004).

Na tentativa de organizá-la, há propostas de subdivisão dessa história, a partir do início do século XX, em alguns períodos. MacKenzie (1992) divide seu livro em três momentos: 1905-1951 – anos formativos; 1952-1967 – anos de expansão teórica; 1968-1981 – anos de consolidação. De forma semelhante, Bechelli e Santos (2004) dividem seu artigo em “Período de consolidação e desenvolvimento” (1907-1950) e “Período de expansão, consolidação e amadurecimento” (1951-2000).

Como representantes do primeiro período, frequentemente citados na literatura, encontram-se Pratt (1907), Lazell (1921), Marsh (1935), Wender (1936), Burrow, entre outros (Bechelli & Santos, 2004; MacKenzie, 1992; Rosenbaum et al., 1992). A primeira intervenção em grupo de que se tem notícia, planejada com características próximas às atuais, foi proposta por Pratt, no início do século passado (Pratt, 1907). Pratt era um médico – não psiquiatra – que acreditava que o contexto de grupo poderia auxiliar os indivíduos fisicamente doentes, por meio do suporte mútuo, a recuperar e manter sua saúde. Também Lazell (1921), um psiquiatra, fazia uma espécie de conferência para seus grupos de pacientes com esquizofrenia sobre psicopatologia e comportamentos mentalmente saudáveis. Apesar de sua condição, segundo o autor, durante os grupos, os pacientes pareciam estimulados e menos apreensivos, devido ao suporte exercido pelo estar em grupo.

Na mesma direção, Marsh (1935) e Wender (1936) iniciavam seus grupos com uma espécie de palestra sobre desenvolvimento e causas da psicopatologia e sobre as formas de se manter saudável. Wender (1936) foi o primeiro psiquiatra psicanalista a realizar terapia de grupo e, por isso, tinha como parte de seus objetivos que seus pacientes desenvolvessem capacidade de *insight* e compreensão profunda de suas pulsões e necessidades (Rosenbaum et al., 1992). Segundo esses autores, Wender (1936) também foi responsável pela primeira publicação sobre técnicas de terapia de grupo.

O psicodrama, desenvolvido por Moreno a partir da segunda década do século XX, permanece como uma influência significativa na prática psicoterapêutica de grupo até os dias atuais, tanto em relação a sua proposta como em relação a sua importância histórica (Moreno, 1966, 1974; Rosenbaum et al., 1992). Moreno (1966, 1974) desenvolveu sua intervenção fora dos estabelecimentos de saúde mental, com seus atores e audiência desempenhando papéis não ensaiados, em espaços abertos, como praças públicas – o que ele denominou “teatro da espontaneidade”. Os participantes encaravam a atividade como lazer, mas Moreno enfatizava seu papel terapêutico. De acordo com o autor, os problemas e conflitos dos indivíduos estão em seus relacionamentos com pais, irmãos, esposas, filhos e amigos, e a

melhora, ou até alívio desses conflitos, pode ser obtida com as dramatizações e reconstituições com os próprios indivíduos com os quais existe o conflito ou com pessoas que possam simbolizá-los, substituí-los ou representá-los (Rosenbaum et al., 1992).

Para os pioneiros da terapia de grupo, o elemento social era o elemento essencial que faltava nas abordagens psicoterapêuticas. Individualismo e ênfase nas realizações pessoais destruíram o senso de pertencimento que é necessário para a saúde mental. Nesse contexto, a terapia de grupo era um tratamento social para o que eles consideravam a psicopatologia social. Assim, à medida que os terapeutas de diferentes abordagens – especialmente daquelas concebidas com base em questões sociais – tomavam conhecimento da possibilidade de intervenção em grupo, novas propostas fundamentadas em diferentes pressupostos rapidamente iam sendo adaptadas para intervenção grupal. São exemplos a psicologia individual de Alfred Adler, as psicanálises neo-freudianas, a Gestalt terapia, a análise transacional e a psicoterapia centrada na pessoa, assim como as abordagens comportamentais e cognitivas (Rosenbaum et al., 1992).

Ao longo da história, terapeutas como Burrow consideravam que os grupos deveriam substituir todo tipo de intervenção psicoterapêutica individual, uma vez que os fatores sociais existentes no grupo tinham mais importância que qualquer outra possível vantagem das intervenções não grupais. Foulkes também foi um grande defensor das intervenções psicoterapêuticas em grupo, destacando a importância da noção de comunidade e da expressão de sentimentos e apontando a falta destas como causa de estresse psicológico. No entanto, a maior parte, assim como Schilder, considerava os grupos uma modalidade de tratamento adjuvante à terapia individual, herança da teoria psicanalítica (Rosenbaum et al., 1992).

Atualmente, a psicoterapia em grupo é uma das possibilidades de tratamento existentes. Um paciente pode ser indicado para o tratamento em grupo juntamente com outras modalidades (Bieling, McCabe, & Antony, 2006; Rosenbaum et al., 1992). Além do grupo, modalidades como terapia de família, de casal e individual podem ser indicadas como tratamentos alternativos ou complementares. É importante que o profissional esteja

preparado para avaliar e justificar a melhor alternativa de tratamento para o paciente (Rosenbaum et al., 1992).

Segundo Rosenbaum e colaboradores (1992), a enorme proliferação das psicoterapias em grupo na atualidade não tem apenas o objetivo de atender a uma maior demanda de pacientes do que por meio de terapia individual. Os grupos também atendem às demandas das pessoas por contato social mais amplo e profundo, do qual, devido a características da nossa cultura, estão cada vez mais distantes e isoladas, o que provoca inúmeros transtornos.

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPOS

As propostas iniciais de TCC, realizadas nas décadas de 1950 e 1960, foram para aplicação individual. No entanto, poucos anos após a primeira proposta da terapia racional emotiva, idealizada por Ellis, por volta de 1955, foi iniciada também sua aplicação em grupo (Wessler, 1983, 1996).

Beck, Rush, Shawn e Emery (1987), em seu clássico livro sobre o tratamento da depressão, fizeram um relato sobre a aplicação da terapia cognitiva em grupo para esse tipo de queixa. Naquele momento, a preocupação se voltava para o acesso simultâneo de um maior número de indivíduos ao tratamento dado por um único terapeuta, que, no atendimento individual, estaria auxiliando apenas uma pessoa (Hollon & Shaw, 1979). Ao mesmo tempo, os resultados em relação à eficácia mostravam que, apesar de a TCCG apresentar indicativos de melhores resultados comparada a outras abordagens, em comparação ao tratamento individual em TCC, o grupo fornecia apenas 50% de eficácia.

Assim como na modalidade individual, as primeiras intervenções em TCC em grupo foram realizadas com pacientes deprimidos, expandindo-se posteriormente para outros transtornos mentais – de transtornos de ansiedade até esquizofrenia (Hollon & Shaw, 1979).

A partir da década de 1970, diversos estudos foram desenvolvidos a fim de avaliar a eficácia da TCCG. Inicialmente, os resultados mostravam que os efeitos da abordagem eram superiores aos de qualquer outro tipo de

intervenção, exceto a TCC individual (Bieling et al., 2006; Hollon & Shaw, 1979). Desde a segunda metade dessa década, há evidências de resultados positivos na redução da sintomatologia inicial de pacientes deprimidos, sendo esses resultados superiores a outras abordagens terapêuticas e também ao uso de antidepressivos. Como nos tratamentos em TCC individual, as pesquisas indicavam que, também no formato de grupo, as abordagens estruturadas e com tempo limitado – bem como a homogeneidade dos grupos no que se refere ao diagnóstico – pareciam oferecer as melhores perspectivas em termos de resultados para os pacientes com depressão unipolar (Hollon & Shaw, 1979).

Com o passar do tempo, os serviços de saúde públicos e privados começaram a considerar cada vez mais a eficiência, a eficácia e a efetividade dos tratamentos como critérios determinantes na escolha de sua modalidade. Assim, o fator em especial que abriu espaço para a TCCG nos cuidados com a saúde foi a diminuição dos custos do tratamento, já que se trata de uma terapia breve, em que um ou dois terapeutas são responsáveis pelos cuidados oferecidos a um grupo de 6 a 8 pacientes simultaneamente, em vez de apenas um, como acontece no tratamento individual (Bieling et al., 2006).

Ao longo desses anos, novos formatos de intervenção foram desenvolvidos, e novas avaliações realizadas, confirmando a elevada eficácia e efetividade dos grupos (Bieling et al., 2006). Após quase 40 anos de pesquisas em grupos na abordagem cognitivo-comportamental, pode-se afirmar que as evidências indicam superioridade dos grupos homogêneos em relação aos heterogêneos, dos estruturados em relação aos semi ou não estruturados, de tempo limitado, e na abordagem cognitivo-comportamental (Bieling et al., 2006; Hollon & Shaw, 1979).

É importante mencionar que, no caso de alguns problemas clínicos específicos, como transtorno de ansiedade social (TAS), a intervenção em grupo é mais apropriada que a individual, uma vez que o medo do contato e da avaliação social e a preocupação com a forma como o outro o percebe só são passíveis de avaliação e intervenção direta no contexto de grupo (Bieling et al., 2006). Além disso, a terapia em grupo conta com fatores inexistentes na terapia individual, como o *feedback* e os modelos fornecidos pelos demais

participantes; a percepção dos erros cognitivos alheios é maior que a dos seus próprios no caso de pacientes com depressão e TAS, por exemplo.

Apesar de esses aspetos do processo da terapia em grupo serem considerados desde seu início na TCC, historicamente a TCCG era considerada, do ponto de vista técnico, uma reprodução da TCC individual; ou seja, qualquer técnica ou procedimento desenvolvido para o uso com um único paciente poderia ser aplicado em um contexto grupal (Wessler, 1996). Essa característica de reprodução de protocolos individuais sofreu algumas modificações ao longo dos anos, mas continua presente em algumas intervenções.

É nesse contexto que Bieling e colaboradores (2006) apontam que ainda existem algumas omissões na literatura sobre TCCG. Os autores denominam omissões aqueles aspectos que consideram essenciais na intervenção em grupo e que não são – ou são pouco – explorados nos protocolos. De acordo com Bieling e colaboradores (2006), como os protocolos de grupo costumam ser baseados em protocolos individuais preexistentes, é comum que os autores e terapeutas não fiquem atentos ao fato de que as técnicas e estratégias estão sendo implementadas em uma interação, e não em um indivíduo; além disso, há protocolos tradicionais em que a TCCG é proposta exatamente como a TCC individual, considerando como única diferença que “. . . o público aumentou de uma única pessoa para um punhado . . .” (Bieling et al., 2006, p. 5). Os autores acrescentam que poucos são os protocolos que consideram aspectos como a interação entre os pacientes no grupo e sua interação com o terapeuta, além da interação entre os profissionais – quando são dois – e de cada indivíduo com o grupo como um todo.

Todas essas interações são mais do que ocasionais; elas envolvem oportunidades de aprendizagem significativas e troca de informações e envolvem claramente uma componente inerentemente “relacional” que raramente é abordado em protocolos tradicionais de TCCG. A abordagem tradicional de TCCG em geral não reconhece nem se aproveita do fato de que o próprio grupo pode criar um ambiente que ou suporte ou prejudique

os objetivos globais de aprendizagem e utilizando estratégias cognitivas e comportamentais. (Bieling et al., 2006, p. 5).

Bieling e colaboradores (2006) destacam que com certeza há quem reconheça essas diferenças e a modalidade de grupos como uma possibilidade única de oportunidades terapêuticas, mas apontam para a necessidade de atenção a essas omissões na literatura. Atualmente, estão disponíveis diversos protocolos de tratamento em grupo, já testados quanto a sua eficácia, para os mais variados transtornos, e pesquisas continuam sendo desenvolvidas a partir desses e de novos modelos, a fim de avançar no desenvolvimento de recursos e na efetividade dos resultados.

A TCCG NO BRASIL

A TCC E A TCCG: UMA PITADA DE UMA HISTÓRIA PESSOAL

Bernard Rangé, em 1994, ingressou como professor do Instituto de Psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IP-UFRJ), ministrando pela primeira vez no País uma disciplina e um estágio clínico em TCC. Os primeiros transtornos tratados foram os de ansiedade – que, na época, incluíam também o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) – e do humor – depressão maior (TDM), transtorno distímico (TD) e transtorno bipolar (TB) –, que constituíam mais de 50% das queixas apresentadas pelos pacientes que buscavam atendimento na Clínica-escola do Instituto de Psicologia da Universidade. Os primeiros casos atendidos envolviam pessoas com transtorno de pânico e agorafobia (TPAGO), quadros depressivos, TOC, fobia social (hoje denominada transtorno de ansiedade social – TAS) e transtorno de ansiedade generalizada (TAG). Os resultados positivos do tratamento com esse novo formato de terapia – levando os pacientes a receber alta – começaram a chamar a atenção dos alunos e profissionais da Universidade.

Um médico do Instituto de Neurologia soube dos resultados positivos da TCC por meio de sua filha – que na época era estagiária – e, por isso, convidou o professor Bernard Rangé para participar de uma equipe de

tratamento de servidores da UFRJ com problemas de alcoolismo. Dessa equipe faziam parte uma psiquiatra, uma psicóloga, uma assistente social e outros profissionais da área da saúde. A literatura da área disponível na época recomendava, para esse tipo de paciente, avaliação e tratamento cognitivo-comportamental em grupo (Holder, Longabaugh, Miller, & Rubonis, 1991; Monti, Kadden, Roseknow, Cooney, & Abrams, 1989). Diante disso, a avaliação e a intervenção cognitivo-comportamental em grupo foram planejadas, e os atendimentos dos pacientes, encaminhados pela Divisão de Vigilância à Saúde do Trabalhador (DVST), foram realizados por duas estagiárias convidadas, que acabaram desenvolvendo pesquisa de iniciação científica e seu trabalho de conclusão de curso sobre o assunto (Castro, 1997; Rodrigues, 1998).

O plano de atendimento montado incluía sessões de avaliação pré-teste, 27 sessões de atendimento e sessões de pós-teste. As escalas utilizadas envolviam avaliação do alcoolismo, da depressão, da ansiedade e da raiva. Segundo Holder e colaboradores (1991) e Monti e colaboradores (1989), o tratamento deveria dirigir-se ao fortalecimento das habilidades de enfrentamento interpessoais (treino de habilidades sociais – THS) – de modo a favorecer uma melhora na comunicação interpessoal e na assertividade – e intrapessoais – manejo de raiva, tristeza e ansiedade. Foram realizados três grupos com resultados bastante positivos, apesar de terem sofrido perturbações, como greves recorrentes de professores e funcionários (Rangé & Marlatt, 2008).

Grande parte do trabalho realizado nesses grupos consistia em THS. O conhecimento desenvolvido nesse período, além da recomendação da literatura da área, inspirou uma nova proposta: o tratamento de pacientes com diagnóstico de fobia social por meio da intervenção em grupo. Essa proposta teve seu embrião em 1993, quando, após o Congresso Internacional de Terapia Cognitivo-Comportamental (CITCC)^[NT], Samuel Turner enviou seu protocolo de tratamento de fobia social (Turner, Beidel, Dancu, & Stanley, 1989; Turner, Beidel, Cooley, Woody, & Messer, 1994) ao professor Bernard Rangé. O protocolo, que era comportamental, foi adaptado por Rangé, que seguia um referencial cognitivo-comportamental. Foram acrescentados

aspectos cognitivos de Beck (reestruturação cognitiva) e de Ellis (ataques de vergonha) aos THSs habituais de Turner. Os grupos eram de porte pequeno – não mais que seis participantes em cada –, já que os pacientes eram fóbicos sociais. O protocolo contava com THS, reestruturação cognitiva, exposição imaginária (de certa forma, inundação imaginária) e, ao fim, depois de cerca de 14 sessões, ataques de vergonha, em que os indivíduos se dedicavam a realizar atividades que lhes produziam experiências perturbadoras de vergonha intensa. Os resultados, mais uma vez, foram extremamente positivos (Rangé, 2001).

Com a entrada de mais um grupo de estagiários, houve a proposta dos próprios alunos para que fosse desenvolvido um protocolo de tratamento de depressão em grupo, com base em Hollon e Shaw (1979), como parte de seu trabalho de conclusão de curso (Hermolin, 2000; Hermolin, Rangé, & Porto, 2000; Porto, 2000).

Os professores do Instituto de Psiquiatria (Instituto de Psiquiatria da Universidade do Brasil – IPUB), cientes de que havia uma equipe de TCC no IP, começaram a enviar cada vez mais casos para serem atendidos complementarmente ao tratamento farmacológico que eles ofereciam. Ao mesmo tempo, a Diretora do IP na época, professora Maria Ignácia D’Ávila, constituiu uma comissão de professores para pensar os atendimentos da Divisão de Psicologia Aplicada (DPA), onde era atendida a população que buscava ajuda. Depois de quase um ano de trabalho, o parecer da comissão foi de que todos os atendimentos deveriam ser feitos em grupo: grupos de espera, grupos clínicos, grupos de orientação vocacional, etc.

Assim, dada a pressão dos encaminhamentos do IPUB e a determinação dessa comissão, e tendo em vista também o sucesso dos atendimentos individuais de pacientes com TPAGO, decidiu-se iniciar também atendimentos em grupo para esses dois quadros. Os grupos eram coordenados por um estagiário mais experiente e um novato e eram constituídos por 6 a 8 pacientes – um critério estabelecido mais em função do tamanho da sala de atendimento do que das características dos transtornos. Essas intervenções contavam com duas sessões de avaliação compostas por entrevistas estruturadas, além de uma bateria de testes; em seguida, ocorriam oito

sessões de tratamento, contemplando psicoeducação, aquisição de habilidades de manejo e, por fim, estratégias para prevenção de recaídas. Posteriormente, havia uma reavaliação para comparar com a avaliação inicial. Inúmeros grupos foram realizados, e ocorreram algumas pequenas modificações. Os resultados obtidos foram ainda melhores que os de atendimentos individuais (Rangé, Falcone, Shinohara, & Novaes, 2001).

Em contatos com o Dr. Aristides Cordioli, tomou-se conhecimento dos grupos de TOC que ele e seus colaboradores conduziam no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após um contato por *e-mail*, Daniela Tusi Braga, uma de suas principais colaboradoras, foi ao IP-UFRJ realizar um treinamento dos estagiários da equipe de TCC, de modo que os grupos passassem a ocorrer também na DPA. Depois do treinamento, foram organizados grupos de pacientes com TOC, independentemente do tipo, misturando-se, assim, lavadores, verificadores e ordenadores, mas não acumuladores. Os grupos eram conduzidos por dois estagiários para cerca de seis pacientes e tinham duração de 12 semanas. Os indivíduos eram avaliados por escalas como a Escala Obsessivo-compulsiva de Yale-Brown (YBOC-S) (Souza et al., 2007), e a intervenção era baseada na construção das hierarquias, exposições e prevenção de respostas de cada paciente, mais instruções de exposição e prevenção de respostas como tarefas de casa. Os resultados alcançavam os níveis de resultados do grupo de Cordioli (Rangé, Carvalho, & Levitan, 2005).

Mais uma vez, em função do interesse de estagiários, e após sucesso com as intervenções individuais em TCC com pacientes com TB, foram iniciadas intervenções em grupo para tal demanda. A recém-publicada obra de Basco e Rush (1996) fundamentou essa proposta. Os grupos foram criados nos mesmos moldes dos outros e obtiveram o mesmo sucesso. Dois dos estagiários envolvidos no atendimento dos pacientes com transtorno bipolar continuaram as pesquisas na área durante o mestrado e são coautores, junto com o professor Mário Juruena, do Capítulo 7 desta obra, sobre bipolaridade.

O primeiro grupo para tratamento de TAG realizado na DPA-UFRJ, durante projeto de iniciação científica financiado pela FAPERJ, apresentou resultados inconsistentes. O aluno que desenvolveu o projeto continuou sob

orientação do professor Bernard Rangé no mestrado e doutorado, desenvolvendo e avaliando protocolos de tratamento cognitivo-comportamental para TAG (Pereira, 2005; Pereira, 2009), e defendeu sua tese de doutorado sobre o tratamento individual de pacientes com TAG com base no conceito de intolerância à incerteza. A partir da pesquisa de doutorado de Pereira, foi proposto o trabalho de mestrado de Souza (2011), que replicou o tratamento em grupo baseado no conceito de intolerância à incerteza (Buhr & Dugas, 2002; Dugas et al., 2003). Os resultados satisfatórios obtidos nessa pesquisa fundamentaram a criação dos grupos para tratamento de TAG com base no modelo de intolerância à incerteza.

Essas foram algumas das contribuições do professor Bernard Rangé para a TCCG, ao longo desses mais de 20 anos.

ASPECTOS GERAIS DA HISTÓRIA DA TCCG NO BRASIL

A prática da TCC, apesar de jovem, já está bastante difundida e estabelecida no Brasil. O início de sua prática no País ocorreu no fim da década de 1980, quando um grupo de professores universitários entrou em contato com a abordagem por meio da participação em eventos internacionais e do acesso à literatura da área (Neufeld, Paz, Guedes, & Pavan-Cândido, 2015; Shinohara & Figueiredo, 2011). A princípio, houve aplicação exclusivamente da terapia individual, já que a modalidade em grupo ainda era recente na própria abordagem. Porém, ao longo desses mais de 30 anos, cresceu no País não só a abordagem, mas também a modalidade de intervenção em grupo, que tem-se destacado tanto nas pesquisas em TCC como na aplicação clínica, pela sua eficácia e pela positiva relação custo-benefício, ao atender um número maior de pacientes ao mesmo tempo e por um custo menor, além da facilidade no treinamento de terapeutas em relação à terapia individual (Braga, Manfro, Niederauer, & Cordioli, 2010).

Ao longo desse período, uma diversidade de propostas de grupos tem sido realizada, e protocolos de atendimento desenvolvidos, com diferentes focos, como grupos de apoio, de psicoeducação, de treinamento e/ou orientação e

terapêuticos. Essas diferentes propostas podem ser categorizadas em função de seu formato e do objetivo que pretendem atingir, que pode ser de promoção de saúde, prevenção ou tratamento. E, a depender de seu objetivo, podem ser enquadradas no espectro da atenção primária, secundária ou terciária em saúde (Neufeld, 2011).

Os primeiros grupos em TCC realizados no Brasil que tiveram seus dados publicados foram do tipo treinamento e terapêutico. No que se refere aos de treinamento, as primeiras publicações foram realizadas por Eliane Falcone, com treinamento de universitários para desenvolvimento de empatia (Falcone, 1998) e THS com essa mesma população (Falcone, 1999), e por Almir e Zilda Del Prette, em 1998, também com THS (Del Prette, Del Prette, & Barreto, 1998; Del Prette, Del Prette, Pontes, & Torres, 1998).

Ainda em 1998, uma das primeiras teses de doutorado defendidas sobre a aplicação de TCCG foi de autoria de Eliane Falcone, com a aplicação de um programa de treinamento de empatia em universitários, tema com o qual essa pesquisadora continua a trabalhar na atualidade. Tanto as pesquisas citadas como diversas outras realizadas ao longo desses quase 20 anos mostram resultados bastante positivos em relação ao treinamento de empatia, de habilidades sociais e de habilidades de vida, com diversas populações (Falcone, 1995; Gorayeb, 2002; Gorayeb, Netto, Bugliani, Pedro, & Minto, 2002; Melo & Silveiras, 2003; Neufeld & Carvalho, 2014; Silva, Z. A. P. Del Prette & Del Prette, 2000). Os dados apresentados nessas publicações apontam que é possível aprimorar essas habilidades como forma de promoção de saúde, prevenção de doenças mentais e outros problemas socioemocionais, mas também que tais treinamentos podem acompanhar as intervenções terapêuticas, como um tratamento adjuvante.

As primeiras publicações sobre grupos terapêuticos foram realizadas por Eliane Falcone, em 1989, com pacientes com ansiedade social (Falcone, 1989a, 1989b). Um desses trabalhos consiste em sua dissertação de mestrado, uma das pioneiras na área de TCCG no País (Falcone, 1989b). As pesquisas com intervenções em TCCG para indivíduos diagnosticados com TAS se desenvolveram muito ao longo desses anos, já que este é um dos transtornos para os quais a modalidade em grupo é mais indicada que a intervenção

individual (D'El Rey, Beidel, & Pacini, 2006; D'El Rey, Lacava, Cejkinski, & Mello, 2008; Penido et al., 2014).

Também pioneiro na realização de grupos terapêuticos em TCC foi Aristides Volpato Cordioli, que publicou intervenções realizadas em pacientes com transtorno de pânico (Cordioli, 1999) e com TOC (Cordioli et al., 2002; 2003; Cordioli, 2003a, 2003b). De acordo com os achados da literatura, Cordioli iniciou uma tradição de pesquisa e intervenção em grupo para pacientes com TOC. Em seu doutorado, realizou um estudo controlado em TCCG com indivíduos com esse diagnóstico (Cordioli, 2003a), um de seus primeiros estudos sobre o assunto. Essa também foi uma das primeiras teses defendidas sobre o uso de TCCG no Brasil. Ao longo desses anos, em conjunto com diversos colaboradores, o autor tem contribuído com o aprimoramento do conhecimento sobre TCCG para os pacientes com TOC (Borges et al., 2011; Braga, Cordioli, Niederauer, & Manfro, 2005; Braga et al., 2010; Meyer et al., 2010a, 2010b; Raffin, Fachel, Ferrão, Souza, & Cordioli, 2009; Sousa, Isolan, Oliveira, Manfro, & Cordioli, 2006). Ainda entre os pioneiros na realização de grupos terapêuticos, pode-se citar Bernard Rangé e colaboradores, que publicaram um estudo realizado com pacientes deprimidos (Hermolin et al., 2000). Os autores desenvolveram um protocolo para o tratamento de indivíduos com esse diagnóstico e o aplicaram em três grupos, obtendo resultados satisfatórios medidos pelas escalas Beck e por meio de uma avaliação clínica dos terapeutas.

Além de Falcone, Del Prette, Del Prette, Cordioli e Rangé, outros pioneiros no desenvolvimento de pesquisas sobre a TCCG e em sua aplicação clínica foram Cristiano Nabuco de Abreu, Francisco Lotufo Neto, Margareth da Silva Oliveira,^[NT] entre outros. Em meio a diversos outros temas, esses pesquisadores têm publicado trabalhos sobre grupos terapêuticos em TCC com pacientes com tricotilomania (Toledo, Muniz, Brito, de Abreu, & Tavares, 2015) e TOC (Ashbar et al., 2005); intervenção com população carcerária para prevenção de reincidência (Saffi & Lotufo Neto, 2013); grupos de THS com universitários (Pureza, Rusch, Wagner, & Oliveira, 2012); grupos terapêuticos para tratamento de dependência de substâncias (Oliveira & Rodrigues, 2009; Velasquez, Maurer, Crouch, Diclemente, &

Oliveira, 2013); grupos de apoio a portadores de HIV/aids (Giovetti, Calvetti, Gauer, & Oliveira, 2014) e síndrome metabólica (Ludwig, Bortolon, Bortolini, Boff, & Oliveira, 2010).

Sofrendo influência desses pioneiros ou não, vêm-se desenvolvendo no Brasil diversas pesquisas em TCCG para as mais diversas demandas, populações e objetivos. Na categoria de grupos de tratamento, que se enquadram no espectro da atenção secundária ou terciária em saúde, têm-se grupos para tratamento dos mais diversos transtornos psiquiátricos (Rangé, et al., 2006; Barbosa, Luiz, & Domingos, 2008), como TAG (D’El Rey, Greenberg, Husni, & Cejkinski, 2007), transtorno de pânico (Heldt, Blaya, Kipper, Salum, & Manfro, 2008), TDM e TB (Costa, et al., 2011; Mendes, Godoi, Ferreira, Neufeld, & Juruena, 2014), TDAH (Béle & Caminha, 2005), dependência de substâncias (Farina, Terroso, Lopes, & Argimon, 2013; Mesquita, 2013; Rangé & Marlatt, 2008; Sardinha, Oliva, D’Augustin, Ribeiro, & Falcone, 2005), gagueira (Gomes & Scrochio, 2001), transtornos alimentares (Duchesne et al., 2007) e obesidade (Neufeld, Moreira, & Xavier, 2012; Neufeld, Moreno, & Affonso, 2012; Neufeld, Affonso, & Moreno, 2014; Neufeld, Affonso, Bueno Junior, Pessa, & Rangé, 2016). O tratamento dos transtornos mentais continua sendo um desafio para os profissionais da saúde mental, tornando necessário o desenvolvimento de pesquisas e de protocolos de intervenção. A Parte II deste livro contará com capítulos sobre a aplicação de TCCG em transtornos como de ansiedade, psicóticos, alimentares, da personalidade, de controle dos impulsos, de estresse pós-traumático, de abuso de substâncias, TDM, TB e TOC.

Os grupos com foco no controle do estresse em diferentes populações e em diferentes contextos também podem ser incluídos na modalidade de grupos terapêuticos. Apesar de o estresse não necessariamente estar caracterizado como um transtorno mental, ele traz diversos impactos na vida dos indivíduos e deve ser abordado como um problema que merece intervenção terapêutica. Há, no País, pesquisadores desenvolvendo instrumentos de avaliação e protocolos de intervenção para redução do estresse com resultados bastante animadores (Murta & Tróccoli, 2009; Lipp,

Alcino, Bignotto, & Malagris, 1998; Malagris & Lipp, 2014). Na Parte III, o livro conta com um capítulo sobre esse tipo de grupo.

Por sua vez, na categoria de grupos de treinamento ou orientação – que podem se enquadrar em qualquer um dos três espectros da atenção à saúde, visto que podem ter uma função de promoção e/ou prevenção ou tratamento –, além dos já mencionados treinamento de empatia, habilidades sociais e habilidades de vida, observam-se publicações sobre o treinamento de pais (Cassiano & Neufeld, 2014; Melo & Silhares, 2003; Neufeld & Godoi, 2014; Neufeld & Maehara, 2011; Silva et al., 2000; Silhares, 1995;). Esses trabalhos tratam da apresentação de protocolos para intervenção com pais de forma preventiva, em contextos de promoção de saúde, até no contexto do tratamento de problemas comportamentais e acadêmicos de seus filhos, bem como da avaliação dos resultados de sua aplicação. Em geral, os resultados se mostram positivos no que se refere à mudança das práticas educativas parentais e na percepção dos pais sobre seus filhos e sobre suas próprias práticas. Porém, os resultados ainda apontam lacunas no que se refere à evasão dos grupos e à manutenção das mudanças, desafios ainda enfrentados na pesquisa e na intervenção clínica, seja individual, seja em grupo. Na Parte III deste livro, um capítulo tratará de grupos de treinamento de diferentes habilidades, e outro sobre orientação de pais.

Outra modalidade de intervenção em grupo que tem recebido bastante atenção é aquela destinada ao apoio no tratamento de condições médicas, como anemia falciforme (Santos & Miyazaki, 1999), dor crônica (Castro, Daltro, Kraychete, & Lopes, 2012; Kirchner, Jorge, & Reis, 2015), doença renal (Duarte, Miyazaki, Blay, & Sesso, 2009), cardiopatias (Gorayeb et al., 2015), infertilidade (Gorayeb, Borsari, Rosa-e-Silva, & Ferriani, 2012), síndrome metabólica (Malagris & Lipp, 2014) e amputações (Reis, Schwab, & Neufeld, 2014), por exemplo. Os resultados dessas intervenções apontam não só melhora da qualidade de vida e dos aspectos psicológicos dos pacientes, mas também uma contribuição importante para a melhora de sua condição médica. Tanto a Parte II como a Parte III deste livro contam com capítulos sobre grupos em contextos de saúde, como dor crônica, demandas

de saúde em geral, além de prevenção e promoção de saúde, bem como saúde pública.

Há, ainda, grupos destinados a populações específicas, que podem ser enquadrados em qualquer uma das modalidades (terapêuticos, de orientação/treinamento, apoio, psicoeducação), a depender dos objetivos propostos pelos terapeutas e do contexto em que serão realizados. Encontram-se, na literatura, intervenções com idosos (Arruda, 2005; Ferreira, Lima, & Zerbinatti, 2013), crianças e adolescentes (Batista, Daolio, Mandarini, Godoi, & Neufeld, 2014; Melo & Silvaes, 2003; Nardi, Ferreira, & Neufeld, 2015; Neufeld, 2015; Neufeld, Daolio, Cassiano, Rossetto, & Cavenage, 2014; Neufeld, Daolio, & Zaiden, 2015; Neufeld, Ferreira, & Maltoni, 2016; Santana, Silva, Gonçalves, & Melo, 2014; Palma & Neufeld, 2011), mulheres no pós-parto (Melo-de-Aguiar, Aguiar, Seidl-de-Moura, & -Mendes, 2013), vítimas de abuso sexual (Damásio, Freitas, Habigzang, & Koller, 2014; Habigzang, Hatzenberger, Dala Corte, Stroehrer, & Koller, 2006) e agressores conjugais (Cortez, Padovani, & Willians, 2005). Esta obra conta com um capítulo sobre intervenções com vítimas de violência e agressores, e outro sobre especificidades de grupos com idosos, nas Partes II e III, respectivamente.

Diversos outros formatos de grupo, com diferentes objetivos e para diferentes populações, são realizados e ainda podem ser desenvolvidos, levando em conta as novas demandas que surgem a todo momento, geradas pelas rápidas mudanças sociais e culturais que vivemos atualmente. Um exemplo disso são as intervenções em *mindfulness* e aceitação, tão características das terapias de terceira onda (Melo, 2014). Esta obra reservou um capítulo na Parte III para tratar desse tipo especial de grupo.

Devido à difusão da prática da TCCG e de seus resultados positivos e promissores, observa-se que, além de pesquisadores já consagrados na área (Cordioli, Rangé, Falcone, Del Prette, Del Prette, de Abreu, entre outros), pesquisadores mais jovens têm investido no trabalho com grupos, por meio do desenvolvimento de modelos e protocolos inovadores ou da adaptação de outros já existentes. É essa ampliação no número e na variedade de pesquisas, bem como o investimento em sua qualidade, que permite compreender cada

vez mais o processo grupal e seus efeitos, a fim de garantir que os resultados propostos de solução dos problemas de seus participantes sejam atingidos. Essa é uma preocupação constante das abordagens cognitivo-comportamentais, e este livro apresenta protocolos e modelos de tratamento para diversas demandas, populações e os resultados obtidos com sua aplicação, a fim de contribuir com o desenvolvimento da área e com a prática baseada em evidências dos profissionais que atuam em grupos em TCC.

REFERÊNCIAS

- Arruda, E. S. R. (2005). Terapia cognitiva narrativa em grupos terapêuticos de mulheres de terceira idade: Uma perspectiva sócio-clínica. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 1(1), 35-43.
- Ashbar, F., Castilho, A. R., Ito, L. M., Latorre, M. R., Moreira, M. N., & Lotufo-Neto, F. (2005). Group cognitive-behavioral therapy *versus* sertraline for the treatment of children and adolescents with obsessive-compulsive disorder. *Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry*, 44(11), 1128-1136.
- Barbosa, J. G., Luiz, A. M. A. G., & Domingos, N. M. (2008). Grupo de sala de espera em ambulatório de ansiedade: Um estudo exploratório. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 4(2), 56-72.
- Basco, M. R., & Rush, A. J. (1996). *Cognitive-behavioral therapy for bipolar disorder*. New York: The Guilford Press.
- Batista, S. V., Daolio, C. C., Mandarini, M. B., Godoi, K., & Neufeld, C. B. (2014). Intervenção com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social: Relato de uma experiência. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 248-272). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Bechelli, L. P. C., & Santos M. A. (2004). Psicoterapia de grupo: Como surgiu e evoluiu. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 12(2), 242-249.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1987). *Cognitive therapy of depression*. New York: The Guilford Press.
- Bélle, A. H., & Caminha, R. M. (2005). Grupoterapia cognitivo-comportamental em crianças com TDAH: Estudando um modelo clínico. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 1(2), 103-113.
- Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2006). *Cognitive-behavioral therapy in groups*. New York: The Guilford Press.
- Borges, C. P., Meyer, E., Ferrão, Y. A., Souza, F. P., Sousa, M. B., & Cordioli, A. V. (2011). Cognitive-behavioral group therapy *versus* sertraline for obsessive-compulsive disorder: Five-year follow-up. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 80(4), 249-250.
- Braga, D. T., Cordioli, A. V., Niederauer, K., & Manfro, G. G. (2005). Cognitive-behavioral group therapy for obsessive-compulsive disorder: A 1-year follow-up. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 112(3), 180-186.

- Braga, D. T., Manfro, G. G., Niederauer, K., & Cordioli, A. V. (2010). Full remission and relapse of obsessive-compulsive symptoms after cognitive-behavioral group therapy: A two-year follow-up. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 32(2), 164-168.
- Buhr, K., & Dugas, M. J. (2002). The intolerance of uncertainty scale: Psychometric properties of the English version. *Behavior Research and Therapy*, 40(8), 931-945.
- Cassiano, M., & Neufeld, C. B. (2014). PROPAIS II: Programa Cognitivo-Comportamental de orientação de pais visando à promoção de saúde. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 148-180). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Castro, K. C. (1997). *Efetividade da terapia cognitivo-comportamental no transtorno de dependência de substâncias* (Relatório de iniciação científica não publicado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Castro, M. M. C., Daltro, C., Kraychete, D. C., & Lopes, J. (2012). The cognitive behavioral therapy causes an improvement in quality of life in patients with chronic musculoskeletal pain. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 70(11), 864-868.
- Cordioli, A. V. (1999). Grupo de terapia cognitivo-comportamental para o transtorno do pânico. *Revista Brasileira de Psicoterapia*, 1(1), 147-156.
- Cordioli, A. V. (2003a). *Terapia cognitivo-comportamental em grupo no tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo: Um estudo controlado*. (Tese de doutorado não publicada, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).
- Cordioli, A. V. (2003b). Terapia cognitivo-comportamental em grupo no transtorno obsessivo-compulsivo: Um ensaio clínico. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 25(1), 57-58.
- Cordioli, A. V., Heldt, E., Bochi, D. B., Margis, R., Sousa, M. B., Tonello, J. F., . . . Kapczinski, F. (2002). Cognitive-behavioral group therapy in obsessive-compulsive disorder: A clinical trial. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 24(3), 113-120.
- Cordioli, A. V., Heldt, E., Bochi, D. B., Margis, R., Sousa, M. B., Tonello, J. F., ... Kapczinski, F. (2003). Cognitive-behavioral group therapy in obsessive-compulsive disorder: A randomized clinical trial. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 72(4), 211-216.
- Cortez, M. B., Padovani, R. C., & Willians, L. C. A. (2005). Terapia de grupo cognitivo-comportamental com agressores conjugais. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 22(1), 13-21.
- Costa, R. T., Cheniaux, E., Rosaes, P. A. L., Carvalho, M. R., Freire, R. C. R., Versiani, M., ... Nardi, A. E. (2011). The effectiveness of cognitive behavioral group therapy in treating bipolar disorder: A randomized controlled study. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 33(2), 144-149.
- D'El Rey, G. J. F., Beidel, D. C., & Pacini, C. A. (2006). Tratamento da fobia social generalizada: Comparação entre técnicas. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 8(1), 1-12.
- D'El Rey, G. J. F., Greenberg, P. N., Husni, M. A., & Cejkinski, A. (2007). Terapia cognitivo-comportamental de grupo no tratamento da fobia social generalizada. *Psicologia Argumento*, 25(50), 305-311.
- D'El Rey, G. J. F., Lacava, J. P. L., Cejkinski, A., & Mello, S. L. (2008). Tratamento cognitivo-comportamental de grupo na fobia social: Resultados de 12 semanas. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 35(2), 79-83.

- Damásio, B. F., Habigzang, L. F., Freitas, C. P. P., & Koller, S. H. (2014). Can a Cognitive-Behavioral Group-Therapy Training Program for the Treatment of Child Sexual Abuse Reduce Levels of Burnout and Job-Strain in Trainees? Initial Evidence of a Brazilian Model. *Paideia (Ribeirão Preto)*, 24(58), 233-241.
- Del Prette, A., Del Prette, Z. A. P., Torres, A. C., & Pontes, Â. C. (1998). Efeitos de um programa de intervenção sobre aspectos topográficos das habilidades sociais de professores. *Psicologia Escolar e Educacional*, 2(1), 11-22.
- Del Prette, Z. A. P., Del Prette, A., & Barreto, M. C. M. (1998). Análise de um Inventário de Habilidades Sociais (IHS) em uma amostra de universitários. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 14(3), 219-228.
- Duarte, P. S., Miyazaki, M. C., Blay, S. L., & Sesso, R. (2009). Cognitive behavioral group therapy is an effective treatment for major depression in hemodialysis patients. *Kidney International*, 76(4), 414-421.
- Duchesne, M., Appolinario, J. C., Rangé, B. P., Fandiño, J., Moya, T., & Freitas, S. R. (2007). The use of a manual-driven group cognitive behavior therapy in a Brazilian sample of obese individuals with binge-eating disorder. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 29(1), 23-25.
- Dugas, M. J., Ladouceur, R., Léger, E., Freeston, M. H., Langlois, F., Provencher, M. D., & Boisvert, J. M. (2003). Group cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder: Treatment outcome and long-term follow-up. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71(4), 821-825.
- Falcone, E. (1999). A avaliação de um programa de treinamento de empatia com universitários. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 1(1), 23-32.
- Falcone, E. M. O. (1989a). A eficácia do tratamento em grupo de ansiedade social. *Psicologia Clínica. Pós-Graduação e Pesquisa*, 4, 75-91.
- Falcone, E. M. O. (1989b). *A eficácia do tratamento da ansiedade social em grupo* (Dissertação de mestrado não publicada, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Falcone, E. M. O. (1995). Grupos. In B. P. Rangé (Org.). *Psicoterapia comportamental a cognitiva: Pesquisa, prática, aplicações e problemas* (pp. 159-169). Campinas: Livro Pleno.
- Falcone, E. M. O. (1998). *A avaliação de um programa de treinamento da empatia em universitários* (Tese de doutorado não publicada, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Farina, M., Terroso, L. B., Lopes, R. M. F., & Argimon, I. I. L. (2013). Importância da psicoeducação em grupos de dependentes químicos: Relato de experiência. *Aletheia*, 42, 175-185.
- Ferreira, H. G., Lima, D. M. X. S., & Zerbinatti, R. (2013). Atendimento psicoterapêutico cognitivo-comportamental em grupo para idosos depressivos: Um relato de experiência. *Revista da SPAGESP*, 13(2), 86-101.
- Giovetti, G. R. M., Calvetti, P. U., Gauer, G. J. C., & Oliveira, M. S. (2014). Avaliação do Programa Psicoeducativo para pessoas que vivem com HIV/AIDS. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 10(1), 38-46.
- Gomes, M. J. C., & Scrochio, E. F. (2001). Terapia da gagueira em grupo: Experiência a partir de um grupo de apoio ao gago. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 3(2), 25-34.

- Gorayeb, R. (2002). O ensino de habilidades de vida em escolas no Brasil. *Psicologia, Saúde & Doenças (Lisboa)*, 3(2), 213-217.
- Gorayeb, R., Borsari, A. C., Rosa-e-Silva, A. C., & Ferriani, R. A. (2012). Brief cognitive behavioral intervention in groups in a Brazilian assisted reproduction program. *Behavioral Medicine*, 38(2), 29-35.
- Gorayeb, R., Facchini, G. B., Almeida, P. L., Suguihura, A. L. M., Nakao, R. T., & Schmidt, A. (2015). Efeitos de intervenção cognitivo-comportamental sobre fatores de risco psicológicos em cardiopatas. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 31(3), 355-363.
- Gorayeb, R., Netto, J. R. C., Bugliani, M. A. P., Pedro, C. P., & Minto, E. C. (2002). Promovendo a saúde de adolescentes: Relato de uma experiência com o ensino de habilidades de vida em escolas. *Revista da SPAGESP*, 3, 135-138.
- Habigzang, L. F., Hatzenberger, R., Dala Corte, F., Stroehrer, F., & Koller, S. (2006). Grupoterapia cognitivo-comportamental para meninas vítimas de abuso sexual: Descrição de um modelo de intervenção. *Psicologia Clínica*, 18(2), 164-182.
- Heldt, E., Blaya, C., Kipper, L., Salum, G., & Manfro, G. G. (2008). Utilização de técnicas da terapia cognitivo-comportamental em grupo para pacientes com sintomas residuais do transtorno de pânico: seguimento de 2 anos. *Revista do Hospital das Clínicas e da Faculdade de Medicina de Porto Alegre*, 28(1), 10-15.
- Hermolin, M. K. (2000). *Terapia em grupo da depressão* (Trabalho de conclusão de curso não publicado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Hermolin, M. K., Rangé, B. P., & Porto, P. R. (2000). Uma proposta de tratamento em grupo para depressão. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 2(2), 171-179.
- Holder, H., Longabaugh, R., Miller, W. R., & Rubonis, A. V. (1991). The cost effectiveness of treatment for alcoholism: A first approximation. *Journal of Studies on Alcohol*, 52(6), 517-540.
- Hollon, S. D., & Shaw, B. F. (1979). Group cognitive therapy for depressed patients. In A. T. Beck, A. J. Rush, B. F. Shaw, & G. Emery, *Cognitive therapy of depression* (pp. 328-353). New York: The Guilford Press.
- Kirchner, L. F., Jorge, C. C., & Reis, M. J. D. (2015). Group cognitive-behavioral therapy for chronic pain adults: Review of Brazilian trials. *Revista Dor*, 16(3), 210-214.
- Lazell, E. W. (1921). The group treatment of dementia praecox. *Psychoanalytic Review*, 8, 168-179.
- Lipp, M. E. N., Alcino, A. B., Bignotto, M. M., & Malagris, L. E. N. (1998). O treino de controle de stress para hipertensos: Uma contribuição para a medicina comportamental. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 15(3), 59-66.
- Ludwig, M. W. B., Bortolon, C., Bortolini, M., Boff, R. M., & Oliveira, M. S. (2010). Intervenção grupal em pacientes com síndrome metabólica. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 6(1), 5-31.
- MacKenzie, K. R. (Ed.) (1992). *Classics in group psychotherapy*. New York: The Guilford Press.
- Malagris, L. E. N., & Lipp, M. E. N. (2014). Stress control training for women with metabolic syndrome. *Pinnacle Psychology*, 1(2), 266-276.
- Marsh, L. C. (1935). Group therapy in the psychiatric clinic. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 82(4), 381-393.

- Melo, M. H. S., & Silveiras, E. F. M. (2003). Grupo cognitivo-comportamental com famílias de crianças com déficits em habilidades sociais e acadêmicas. *Temas em Psicologia, 11*(2), 122-133.
- Melo, W. V. (2014). *Estratégias psicoterápicas e a terceira onda em terapias cognitivas*. Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Melo-de-Aguiar, A., Aguiar, T. M. N., Seidl-de-Moura, M. L., & Mendes, D. M. L. F. (2013). Atendimento psicoeducativo em grupo para mulheres no pós-parto: relato de experiência. *Aletheia, 41*, 174-184.
- Mendes, A. I. F., Godoi, K., Ferreira, I. M. F., Neufeld, C. B., & Juruena, M. F. (2014). Intervenções em grupo para transtornos de humor: O relato de uma experiência. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 225-247). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Mesquita, A. A. (2013). Avaliação de um programa de tratamento do tabagismo. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 15*(2), 35-44.
- Meyer, E., Shavitt, R. G., Leukefeld, C., Heldt, E., Souza, F. P., Knapp, P., & Cordioli, A. V. (2010a). Adding motivational interviewing and thought mapping to cognitive-behavioral group therapy: Results from a randomized clinical trial. *Revista Brasileira de Psiquiatria, 32*(1), 20-29.
- Meyer, E., Souza, F., Heldt, E., Knapp, P., Cordioli, A., Shavitt, R. G., & Leukefeld, C. (2010b). A randomized clinical trial to examine enhancing cognitive-behavioral group therapy for obsessive-compulsive disorder with motivational interviewing and thought mapping. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 38*(3), 319-336.
- Monti, P. M., Kadden, R. M., Rosehnow, D. J., Cooney, N. L., & Abrams, D. B. (1989). *Treating alcohol dependence: A coping skills training guide*. New York: The Guilford Press.
- Moreno, J. L. (1966). Psychiatry of the twentieth century: function of the universalia: Time, space, reality, and cosmos. *Group Psychotherapy, 19*, 146-158.
- Moreno, J. L. (1974). *Psicoterapia de grupo e psicodrama*. São Paulo: Mestre Jou.
- Murta, S. G., & Tróccoli, B. T. (2009). Intervenções psicoeducativas para manejo de estresse ocupacional: Um estudo comparativo. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva, 11*(1), 25-42.
- Nardi, P. C., Ferreira, I. M. F., & Neufeld, C. B. (2015). Programas de promoção de saúde mental em grupo para crianças. In C. B. Neufeld. (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes* (pp. 35-53). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B. (2015). *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes*. Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B., & Carvalho, A. V. (2014). Treino de Habilidades Sociais. In W. V. Melo (Org.), *Estratégias psicoterápicas e a terceira onda em psicoterapia cognitiva* (pp. 153-185). Novo Hamburgo: Sinopsys.

- Neufeld, C. B., & Godoi, K. (2014). PROPAIS I: Tópicos Cognitivo-Comportamentais de orientação de pais em contexto de atendimento clínico. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 116-147). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., & Maehara, N. P. (2011). Um programa cognitivo-comportamental de orientação de pais em grupo. In M. Caminha, & R. Caminha (Org.), *Intervenções e treinamento de pais na clínica infantil* (pp. 149-76). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Affonso, G., & Moreno, A. L. (2014). PRO-META: Programa Cognitivo-Comportamental de educação alimentar em grupo. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 44-79). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Affonso, G., Bueno Junior, C. R., Pessa, R. P., & Rangé, B. (2016). Tratamento em TCC em grupo para obesidade e sobrepeso: Foco no manejo. In I. R. Finger, & M. S. Oliveira (Orgs.), *A prática da terapia cognitivo-comportamental nos transtornos alimentares e obesidade* (pp. 351-80). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Daolio, C. C., & Zaiden, L. L. (2015). Desafios da Terapia Cognitivo-Comportamental em grupo com crianças e adolescentes. In C. B. Neufeld (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes* (pp. 17-34). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B., Daolio, C. C., Cassiano, M., Rossetto, C. P. F., & Cavenage, C. C. (2014). PRHAVIDA: Programa Cognitivo-Comportamental de habilidades de vida para crianças e adolescentes. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 80-115). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Ferreira, I. M. F., & Maltoni, J. (2016). Grupos para crianças e adolescentes em contexto escolar. In D. C. Fava (Org.), *A prática da psicologia na escola: Introduzindo a abordagem cognitivo-comportamental* (pp. 255-287). Belo Horizonte: Artesã.
- Neufeld, C. B., Moreira, C. A. M., & Xavier, G. S. (2012). Terapia cognitivo-comportamental em grupos de emagrecimento: O relato de uma experiência. *Psico*, 43(1), 93-100.
- Neufeld, C. B., Moreno, A. L., & Affonso, G. (2012). Programas cognitivo-comportamentais direcionados para obesidade e emagrecimento. In E. M. O. Falcone, A. D. Oliva, & C. Figueiredo (Orgs.), *Produções em terapia cognitivo-comportamental* (pp. 233-244). São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Neufeld, C. B., Paz, S., Guedes, R., & Pavan-Cândido, C. C. (2015). Congresso Brasileiro de Terapias Cognitivas: uma história em 10 edições. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 11(1), 57-63.
- Oliveira, M. S., & Rodrigues, V. S. (2009). Terapia cognitivo-comportamental em grupo para dependentes de nicotina. In M. M. K. Macedo (Org.), *Fazer psicologia: Uma experiência em clínica-escola* (pp. 317-328). Porto Alegre: Casapsi.
- Palma, P. C., & Neufeld, C. B. (2011). Cognitive-behavioral intervention in socio-educational group: An experience report. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 7(1), 55-61.
- Penido, M. A., Giglio, C., Lessa, L., Carvalho, M. R., Souza, W., & Rangé, B. (2014). O uso do teatro do oprimido no tratamento em grupo para transtorno de ansiedade social. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 10(1), 29-37.
- Pereira, A. L. S. (2005). *Construção de um protocolo de tratamento para o transtorno da ansiedade generalizada* (Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).

- Pereira, A. L. S. (2009). *Construção e avaliação de um protocolo de tratamento cognitivo-comportamental para o transtorno de ansiedade generalizada* (Tese de doutorado não publicada, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Porto, P. R. (2000). *Terapia em grupo para a depressão* (Trabalho de conclusão de curso não publicado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Pratt, J. H. (1907). The class method of treating consumption in the homes of the poor. *Journal of the American Medical Association*, 49(9), 755-59.
- Pureza, J. R., Rusch, S. G. S., Wagner, M., & Oliveira, M. S. (2012). Treinamento de habilidades sociais em universitários: Uma proposta de intervenção. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 8(1), 2-9.
- Raffin, A. L., Fachel, J. M. G., Ferrão, Y. A., Souza, F. P., & Cordioli, A. V. (2009). Predictors of response to group cognitive-behavioral therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder. *European Psychiatry*, 24(5), 297-306.
- Rangé, B. P. (2001). Terapia em grupo para a fobia social. In *Anais do 2º Congresso de Extensão da Universidade Federal do Rio de Janeiro*, Rio de Janeiro.
- Rangé, B. P., & Marlatt, G. A. (2008). Terapia cognitivo-comportamental de transtornos de abuso de álcool e drogas. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 30(Supl. 2), 88-95.
- Rangé, B. P., Carvalho, L., & Levitan, M. N. (2005). Tratamento em grupo para o transtorno obsessivo-compulsivo. In *Anais do 5º Congresso da Sociedade Brasileira de Terapias Cognitivas*, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
- Rangé, B. P., Falcone, E., Shinohara, H., & Novaes, L. (2001). Um programa de tratamento cognitivo-comportamental de curta duração para o tratamento do transtorno do pânico e da agorafobia. In *Anais da 31ª Reunião Anual de Psicologia*, Sociedade Brasileira de Psicologia, Ribeirão Preto.
- Rangé, B. P., Pereira, A. L. S., Borba, A. G., Rodrigues, D. M., Luz, F. G. O., Sores, I. D., & Mota, R. C. (2006). Tratamento em grupo de transtornos psiquiátricos na clínica-escola da Divisão de Psicologia Aplicada do IP/UFRJ. In E. F. M. Silveiras (Org.), *Atendimento psicológico em clínicas-escola* (pp. 185-201). Campinas: Alínea.
- Reis, A. H., Schwab, J. A., & Neufeld, C. B. (2014). Relato de experiência de terapia cognitivo-comportamental em grupo com pacientes amputados. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 16(2), 148-164.
- Rodrigues, A. G. R. (1998). *Efetividade da terapia cognitivo-comportamental no transtorno de dependência de substâncias* (Trabalho de iniciação científica não publicado, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Rosenbaum, M., Lakin, M., & Roback, H. B. (1992). Psychotherapy in groups. In D. K. Freedheim (Ed.), *History of psychotherapy* (pp. 695-724). Washington: American Psychological Association.
- Saffi, F., & Lotufo Neto, F. (2013). Assessment of a penitentiary relapse prevention program. *Estudos de Psicologia (Campinas)*, 30(3), 375-382.
- Santana, S. M., Silva, N. G., Gonçalves, D. M., & Melo, M. C. M. D. (2014). Intervenções em grupo na perspectiva cognitivo-comportamental: Experiências no contexto da clínica-escola. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 10(1), 47-53.

- Santos, A. R. R., & Miyazaki, M. C. O. S. (1999). Grupo de sala de espera em ambulatório de doença falciforme. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 1(1), 41-8.
- Sardinha, A., Oliva, A. D., D'Augustin, J., Ribeiro, F., & Falcone, E. M. O. (2005). Intervenção Cognitivo-Comportamental com grupos para o abandono do cigarro. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 1(1), 83-9.
- Shinohara, H., & Figueiredo, C. (2011). A prática da terapia cognitiva no Brasil. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 33-39). Porto Alegre: Artmed.
- Silva, A. T. B., Del Prette, A., & Del Prette, Z. A. P. (2000). Relacionamento pais-filhos: Um programa de desenvolvimento interpessoal em grupo. *Psicologia Escolar e Educacional*, 3(3), 203-215.
- Silvares, E. F. M. (1995). O modelo triádico no contexto de terapia comportamental com famílias. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 11(3), 235-241.
- Sousa, M. B., Isolan, L. R., Oliveira, R. R., Manfro, G. G., & Cordioli, A. V. (2006). A randomized clinical trial of cognitive-behavioral group therapy and sertraline in the treatment of obsessive-compulsive disorder. *Journal of Clinical Psychiatry*, 67(7), 1133-1139.
- Souza, F. C. C. (2011). *Efetividade da Abordagem cognitivo-comportamental em grupo para pacientes com transtorno de ansiedade generalizada: Um teste transcultural* (Dissertação de mestrado não publicada, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).
- Souza, F. P., Foa, E. B., Meyer, E., Niederauer, K. G., Raffin A. L., & Cordioli, A. V. (2007). Obsessive-compulsive inventory and obsessive-compulsive inventory-revised scales: Translation into Brazilian Portuguese and cross-cultural adaptation. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 30(1), 42-46.
- Toledo, E. L., Muniz, E. T., Brito, A. M., de Abreu, C. N., & Tavares, H. (2015). Group treatment for trichotillomania: cognitive-behavioral therapy versus supportive therapy. *Journal of Clinical Psychiatry*, 76(4), 447-455.
- Turner, S. M., Beidel, D. C., Cooley, M. R., Woody, S. R., & Messer, S. C. (1994). A multicomponent behavioral treatment for social phobia: Social effectiveness therapy. *Behaviour Research and Therapy*, 32(4), 381-390.
- Turner, S. M., Beidel, D. C., Dancu, C. V., & Stanley, M. A. (1989). An empirically derived inventory to measure social fears and anxiety: The Social Phobia and Anxiety Inventory. *Psychological Assessment: A Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 1(1), 35-40.
- Velasquez, M. M., Maurer, G. G., Crouch, C., Diclemente, C. C., & Oliveira, M. S. (Orgs.). (2013). *Tratamento em grupo para usuários de drogas: Um manual de terapia baseado nos estágios de mudança*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Wender, L. (1936). The dynamics of group psychotherapy and its application. *Journal of Nervous and Mental Disease*, 84, 54-60.
- Wessler, R. L. (1983). Rational-emotive therapy in groups. In A. Freeman (Ed.), *Cognitive therapy with couples and groups* (pp. 43-66). New York: Plenum Press.
- Wessler, R. L. (1996). Terapia de grupo cognitivo-comportamental. In V. E. Caballo, *Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento* (pp. 854-877). São Paulo: Santos Livraria Editora.
-

[NT] Em 1993, ao saber que o Congresso Mundial de Psiquiatria ocorreria no Rio de Janeiro e que dele participariam terapeutas e pesquisadores internacionais renomados da área de TCCs, Bernard Rangé, em conjunto com outros terapeutas e pesquisadores, decidiu organizar um congresso, o I Congresso Internacional de Terapia Cognitivo-Comportamental (CITCC), no Rio de Janeiro, em seguida ao Mundial de Psiquiatria. Convites foram enviados a todos os pesquisadores que viriam ao Congresso de Psiquiatria, oferecendo dois dias a mais de estada no Rio, em troca de uma apresentação no CITCC. Todos eles aceitaram, e o congresso foi um sucesso. A lista de pesquisadores contava com: Joseph Wolpe, psiquiatra sul-africano e um dos fundadores da terapia comportamental; David Barlow, pesquisador norte-americano de transtornos de ansiedade; Jack Maser, Diretor do Setor de Transtornos de Ansiedade do National Institute of Mental Health (NIMH); Samuel Turner, especialista em fobia social; Matig Mavissakalian, psiquiatra especializado no tratamento de TPAGO; Herbert Chappa, psiquiatra argentino de renome internacional que trabalhava com TCC; Hector Fernandez-Alvarez, psicólogo argentino, também renomado internacionalmente; Rafael Navarro, Presidente da Associação Latino-Americana de Análise e Modificação do Comportamento (ALAMOC); além do grupo de espanhóis composto por Gualberto Buena-Casal, Presidente da Associação Espanhola de Terapia Comportamental; Vicente Caballo, pesquisador em treino de habilidades sociais e em fobia social; entre outros.

[NT] A ordem de apresentação dos nomes é alfabética.

2



ASPECTOS TÉCNICOS E O PROCESSO EM TCCG

Carmem Beatriz Neufeld
Juliana Maltoni
Ana Lucia Ivatiuk
Bernard P. Rangé

Este capítulo tem como objetivo principal promover uma reflexão sobre a técnica e os processos envolvidos na terapia cognitivo-comportamental em grupo (TCCG). Além da apresentação de estudos recentes acerca da eficácia e dos fatores envolvidos nesse tipo de modalidade terapêutica, pretende-se discorrer sobre os preceitos da estrutura da TCCG. A psicoterapia em grupo vem sendo assunto cada vez mais abordado na literatura cognitivo-comportamental, em grande parte pela mesma característica que ocasionou interesse na década de 1970 (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979): seu custo-benefício. Observa-se a eficácia dessa modalidade em diversos estudos da área, para diferentes demandas, equiparando-se à modalidade individual (Bjornsson et al., 2011; Mörtberg, Clark, & Bejerot, 2011). A depender da

demanda, alguns estudos até mesmo apontam para a superioridade da TCCG em relação à TCC individual (Renjilian et al., 2001).

No entanto, de modo não muito diferente dos estudos da modalidade individual, uma característica comum dessas pesquisas é a ênfase na avaliação acerca da eficácia do tratamento/modalidade, com pouco ou nenhum foco sobre fatores e variáveis envolvidos nos desfechos positivos dos grupos, que não são exclusividade da TCC. Além disso, a TCCG apresenta diversas características distintas em relação à modalidade individual, o que torna ainda maior a necessidade de pesquisas na área para que a intervenção faça sentido e se mostre adequada ao contexto grupal. A seguir, serão apresentadas características referentes aos aspectos técnicos dessa modalidade de intervenção. Na segunda parte do capítulo, o foco será sobre o processo e os fatores envolvidos na proposição de grupos em TCC.

ASPECTOS TÉCNICOS EM TCCG

Entende-se como aspectos técnicos em TCCG todos os pontos relacionados à estrutura da intervenção. Para tanto, parte-se da premissa básica de que o grupo em TCCG é um sistema no qual são distribuídas e aplicadas técnicas específicas. Como um sistema, cada grupo reagirá de forma única à aplicação das técnicas. Esses são os aspectos de processo que serão abordados na segunda parte deste capítulo.

O primeiro passo para o desenvolvimento de um grupo em TCCG é a homogeneidade de sua composição (Neufeld, 2011). Para garantir isso, precisam ser avaliadas demandas e características de cada indivíduo, além de fatores como idade, escolaridade, cultura, entre outros. A composição do grupo deve levar em conta os objetivos e metas que poderão ser alcançados com aquela configuração específica. Um grupo composto por idosos e adolescentes, por exemplo, terá menor probabilidade de atingir plenamente seus objetivos e de proporcionar a melhor intervenção possível, uma vez que fatores terapêuticos como universalidade e compartilhamento de informações podem ser dificultados devido à grande diferença cultural e de idade.

Entretanto, como ressaltado por Neufeld (2015), a homogeneidade de objetivos é o foco principal nesse aspecto. Grupos totalmente homogêneos são pouco prováveis e até mesmo pouco desejáveis, uma vez que certa heterogeneidade é importante para que surjam diferentes pontos de vista. Porém, a homogeneidade preconizada pela TCCG refere-se a oportunizar que seus membros experimentem certo grau de pertencimento ao grupo. Portanto, se o foco do grupo, ou seja, seu objetivo, for homogêneo, desde que as características dos membros não sejam destoantes entre si, pode-se pensar em uma homogeneidade suficiente para que o processo de TCCG se concretize (Neufeld, 2015).

O mesmo se aplica a grupos voltados para demandas clínicas muito distintas. Como destacam Bieling, McCabe e Antony (2008), um alto grau de heterogeneidade pode levar o terapeuta de grupo, na verdade, a realizar várias terapias individuais ao mesmo tempo. Para a TCCG, a reunião entre indivíduos não garante a eficácia da intervenção. De forma diferente, as relações estabelecidas nesse contexto devem ser prioridade, junto com o embasamento teórico, pois atuam como variáveis no desfecho da intervenção.

Adicionalmente, a TCCG se caracteriza pela configuração em grupos tipicamente fechados, ou seja, uma vez estabelecidos os integrantes, não são permitidas novas entradas. Grupos abertos podem ser propostos em algumas modalidades, e, além disso, há alguns serviços de saúde mental que propõem grupos semiabertos (define-se um número de sessões até quando poderão ser admitidos novos membros). Cabe ressaltar, no entanto, que a literatura em TCCG tem-se focado primordialmente em grupos fechados. Os critérios para permanência e conclusão do grupo são definidos nas sessões iniciais, como o número de faltas máximas que antecedem o desligamento ou a tolerância para atrasos nas sessões (Neufeld, 2015).

Ainda nesse sentido, o contrato terapêutico e o sigilo são pontos cruciais para o bom andamento dos grupos. Neufeld (2015) ressalta que a clareza do contrato pode ser um ponto diferencial na adesão ao grupo. Aspectos relacionados até mesmo às expectativas e aos resultados que podem ser esperados com aquela intervenção devem ser abordados já no contrato. O contrato visa instalar a estrutura da TCCG, portanto, ele merece cuidado

especial dos terapeutas desde a primeira sessão e ao longo do andamento do grupo. Cabe ressaltar, no entanto, que sua apresentação não deve se dar de forma punitiva ou impositiva. A tranquilidade dos terapeutas em construir as normas em conjunto com o grupo aumenta significativamente a probabilidade de envolvimento dos participantes com elas.

ESTRATÉGIAS DE SELEÇÃO E RECRUTAMENTO

Primeiramente, a seleção da intervenção deve priorizar aquela com maior potencial de impacto para as demandas mais urgentes da população atendida (Beck & Coffey, 2005). O planejamento do programa de intervenção e a formação do grupo referem-se ao estágio pré-grupo definido por Bieling e colaboradores (2008). Assim, o objetivo e o tipo de grupo devem ser definidos, bem como número de sessões, estrutura, local, terapeutas e demanda dos participantes. Os critérios de inclusão e/ou exclusão irão variar de acordo com o grupo, sendo que, para promoção de saúde, por exemplo, não é necessária a seleção tão rigorosa dos integrantes. Entretanto, se a intenção é realizar um grupo interventivo voltado para sintomas ansiosos, por exemplo, a seleção dos participantes se fará necessária e terá um papel fundamental.

A seleção dos membros é essencial para garantir o melhor desfecho possível ao grupo. Recomenda-se pelo menos um encontro anterior com o participante para que seja feita uma avaliação a fim de concluir qual tratamento lhe é mais indicado (White & Freeman, 2003). A seleção pode incluir, então, sessões de triagem, entrevistas e utilização de instrumentos de avaliação e, posteriormente, encaminhamentos necessários (Bieling et al., 2008). Características e qualificação dos terapeutas também devem ser consideradas nessa fase, como o estilo de liderança do terapeuta (Oei & Browne, 2006).

ESTRATÉGIAS DE AVALIAÇÃO

A avaliação das intervenções em TCCG não deve ser menos importante do que as pesquisas voltadas para a modalidade individual. Apesar de ampla literatura indicar a eficácia na modalidade grupal, Tucker e Oei (2007)

apontam para a necessidade de pesquisas mais robustas, uma vez que o custo-benefício superior em relação à modalidade individual pode ser questionado devido a algumas lacunas metodológicas encontradas na área. A avaliação de um grupo pode servir como *feedback* final para os participantes, demonstrando as mudanças ao longo do grupo, mas também permitirá a verificação de sua eficácia e também o impacto de características específicas no desfecho. Por exemplo, um grupo voltado para pacientes com transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) pode ser eficaz em reduzir sintomas ansiosos, mas talvez não altere o quadro global do transtorno. A avaliação, então, deve ser condizente com o objeto do grupo em questão. A eficácia de longo prazo será analisada? Serão analisadas quais variáveis? A partir daí, a seleção de instrumentos deve ser realizada cuidadosamente. O rigor metodológico, desde a seleção até a avaliação, irá garantir resultados mais precisos acerca da eficácia do grupo e das variáveis envolvidas em uma intervenção bem-sucedida. Cabe ressaltar que toda intervenção em TCCG visa avaliar os resultados obtidos ao fim da intervenção.

ESTRUTURA DA SESSÃO

A estrutura de sessão em grupo em TCC, proposta por White e Freeman (2003), não difere demasiado da estrutura na modalidade individual. O grupo também tem suas sessões estruturadas e geralmente é baseado em protocolo e cronograma preestabelecidos. Isso não significa que as sessões não possam ser flexíveis, caso necessário, ou que os conteúdos não possam ser mais bem adaptados aos participantes em questão. Um grupo voltado para o manejo de ansiedade provavelmente incluirá nas sessões iniciais de seu protocolo exercícios de relaxamento ou respiração, enquanto temáticas que fogem dos objetivos da sessão deverão ser acolhidas ou até mesmo ser foco de alguns encontros, dentro dos limites do objetivo do grupo. Além disso, também é possível que as intervenções em TCCG prevejam sessões individuais adicionais que podem vir a ser requeridas pelos terapeutas ou pelos pacientes, dentro de um limite preestabelecido, dando suporte para outros pontos que a sessão estruturada talvez tenha mais dificuldade de aprofundar.

As sessões iniciais têm como foco o *rapport* entre os membros e terapeutas, que pode ser desenvolvido por meio de dinâmicas específicas – as famosas “quebra-gelos”, que têm como objetivo realizar o primeiro contato entre os participantes e os profissionais. A partir desse momento, é realizado o contrato de trabalho, que visa garantir todo o sigilo necessário para a atividade grupal a ser realizada e segue os princípios do Código de Ética Profissional do Psicólogo (Conselho Federal de Psicologia [CFP], 2005). O contrato terapêutico também já é estabelecido, e aqui chamamos atenção para uma questão particular dos grupos: o sigilo. Como atender essa exigência e suscitar confiança entre os membros, uma vez que a prerrogativa do sigilo ético não se aplica aos participantes? Mesmo que essa preocupação não seja verbalizada, o terapeuta deve evidenciar a importância do contrato entre os membros, propondo que os assuntos discutidos no grupo permaneçam ali. Nesse momento, a coesão grupal será um importante fator aliado, pois, além de proporcionar a confiança, também implicará a adesão ao contrato.

A psicoeducação pode ocorrer já na primeira sessão, quando o modelo cognitivo é abordado ou informações sobre a demanda, o tratamento e o prognóstico podem ser inseridas. Nesse momento, a sessão facilmente pode se transformar em uma aula expositiva, o que demandará do terapeuta atenção para o envolvimento dos membros, evitando ao máximo que a sessão assuma um tom de aula. Para isso, o profissional pode utilizar-se de questionamentos ou mesmo um *brainstorm* acerca do tema, bem como munir-se de variados recursos para impulsionar a participação do grupo, como vídeos, materiais impressos ou disparadores, como trechos de literatura e imagens. Neufeld e Maehara (2011), em seu Programa Cognitivo-comportamental para Orientação de Pais em Grupo (PROPAIS), utilizam como elemento disparador para refletir sobre a influência dos comportamentos dos pais sobre os filhos o vídeo *Children see, children do*, feito para uma campanha da National Association for the Prevention of Child Abuse and Neglect (NAPCAN).¹ Trata-se de um material relativamente simples, mas que vem se mostrando muito eficaz em fomentar as discussões acerca dos modelos parentais, por exemplo. O profissional precisa adequar os

materiais à população em questão para que façam sentido, podendo modificar alguns deles se necessário.

Não menos importante é também o momento para a verificação de expectativas e metas acerca do grupo, sendo possível ajustá-las caso seja necessário. É fundamental que o terapeuta esteja atento a expectativas irreais ou diminuídas e discuta essas questões com os demais membros, garantindo, assim, a instilação de esperança no tratamento. Esse fator deve ser mantido em foco durante as sessões iniciais. Os encontros seguintes lançarão a estrutura básica da TCC (Beck, 1997), pautando-se na verificação semanal e do humor, na revisão das tarefas de casa, no objetivo da sessão e da tarefa e no *feedback* final, em consonância com o protocolo de intervenção.

Um aspecto importante da estrutura da sessão é que todo encontro de TCCG foca na apresentação de um material ou tema específico, que é o seu objetivo. Esse ponto talvez seja um pouco diferente da sessão individual em TCC, mas é fundamental que seja observado, uma vez que é ele quem garante o seguimento do protocolo de intervenção.

A agenda da sessão é imprescindível para a utilização mais eficaz do tempo, além de propiciar o sentimento de coesão no grupo (White & Freeman, 2003). Esse momento tem confluência singular dos fatores terapêuticos, uma vez que os membros não somente tentam se ajudar, mas também aprendem com a experiência dos demais, se motivam e enxergam possibilidades que podem estar limitadas até mesmo para o terapeuta.

A duração das sessões é variável, mas em geral os protocolos operam entre 60 e 120 minutos em um encontro semanal, com duração da intervenção se estendendo, em média, entre 8 e 16 sessões. Além do terapeuta, os grupos também podem contar com um coterapeuta e um observador. Em TCCG, a presença de pelo menos um coterapeuta tem-se mostrado um fator terapêutico importante. O papel desse profissional é observar as interações e fatores que ocorrem durante a sessão, mas que podem passar despercebidos pelo terapeuta. Apesar de não ter a mesma responsabilidade imediata na condução da sessão, a divisão de tarefas ocorre igualmente fora do grupo, e a harmonia entre os dois profissionais se faz ímpar para o andamento satisfatório da intervenção (Neufeld, 2011). A observação das reações, verbais ou não, dos

membros pode auxiliar na identificação de fatores e variáveis que influenciam o desfecho do grupo. Muitos fatores processuais estão envolvidos ao mesmo tempo na sessão, tornando necessária a presença de um observador em determinados grupos.

Por exemplo, o Programa Cognitivo-comportamental de Habilidades de Vida para Crianças e Adolescentes (PRHAVIDA), grupo de promoção de saúde em TCCG, conta com observadores desde sua implementação, uma vez que a população infantojuvenil requer maior atenção devido às especificidades da fase (Neufeld, Daolio, Cassiano, Rosseto, & Cavenage, 2014). O observador é responsável pelos registros das sessões, ou seja, acontecimentos e falas relevantes dos membros ou terapeutas que apareceram ao longo do grupo, não interferindo na sessão. No entanto, seu papel também pode se estender para auxílio no manejo sutil de comportamentos inadequados no grupo, como solicitar o fim de uma conversa paralela ou o uso de eletrônicos, por exemplo. Porém, deve-se estar atento à forma como tais registros serão realizados, sendo importante comunicar ao grupo os objetivos e os conteúdos que serão anotados. Não devem ser feitas interpretações sobre os fenômenos que se desenrolam, e deve-se assegurar que as anotações tenham um roteiro com tópicos específicos e repetidos a cada registro (Serrão & Baleiro, 1999).

TAREFA DE CASA

Um dos componentes centrais da TCC (Rees, McEvoy, & Nathan, 2005), a tarefa é especialmente importante em um grupo, devido ao aprendizado proporcionado pela troca de informações com os demais membros. A aprendizagem proporcionada e adquirida por meio das tarefas é tão importante quanto o desempenho satisfatório (White & Freeman, 2003). A revisão da tarefa como parte inicial da sessão auxiliará na aprendizagem a partir da experiência de outros participantes, muitas vezes incentivando o engajamento nesses exercícios a partir do sucesso observado. Os membros podem também encorajar os demais na conclusão dos exercícios, o que pode atuar como um grande motivador (Beck, Coffey, Foy, Keane, & Blanchard, 2009) e configurar-se como um diferencial importante em relação à

modalidade individual. Considerando a percepção de identificação genuína entre os membros em relação a seus problemas, é bem provável que nesse momento os comentários advindos dos participantes sejam mais bem recebidos, independentemente de serem profícuos.

Assim como na modalidade individual (Beck, 1997), é imprescindível que a tarefa seja adequada às capacidades dos pacientes e que o tempo destinado em sessão para sanar dúvidas e trabalhar com possíveis impedimentos e dificuldades seja suficiente. Diferentemente da clínica individual, a comparação em relação ao desempenho fica evidente em um grupo, não porque haja necessariamente competição entre os membros, mas porque há diminuição na esperança quando algum exercício não é executado ou não atinge seus objetivos plenos. A atenção do terapeuta aos momentos destinados à tarefa de casa é fundamental em um grupo (Bieling et al., 2008), considerando o impacto do desempenho e a importância dos *feedbacks* entre os membros. Um paciente pode desacreditar que terá êxito em um exercício de exposição ao verificar que outro membro não encontrou as mesmas dificuldades na tarefa e, conseqüentemente, desistir do tratamento. Ao terapeuta, cabe, então, destacar que a evolução de cada indivíduo é única e encorajar a participação do grupo sobre dificuldades ou facilitadores encontrados durante o relato.

MODALIDADES DE GRUPOS EM TCC

Os grupos em TCCG podem ser divididos em grupos de prevenção e/ou promoção de saúde e de intervenção terapêutica. Ações preventivas têm como objetivo evitar o surgimento ou a expansão de determinado problema, para conseqüente redução de sua incidência ou prevalência. Para o desenvolvimento do bem-estar por meio do fortalecimento individual e coletivo, o grupo será de promoção de saúde (Luz, Murta, & Aquino, 2015). Além disso, quatro modalidades de grupos se destacam na literatura em TCCG: os grupos de apoio, os grupos de psicoeducação, os grupos de orientação/treinamento e os grupos terapêuticos.

GRUPOS DE APOIO

De acordo com Neufeld (2011), os grupos de apoio voltam-se para sintomas crônicos que passaram por intervenção ou para quem está em tratamento, sejam cuidadores, sejam pacientes. São geralmente abertos, comportando mais de 15 membros e funcionando bem em ambulatorios. Com sessões semanais, os conteúdos e demandas da sessão são instituídos pelos pacientes. O principal fator terapêutico que se observa é o apoio entre os integrantes. Apesar da vantagem em relação ao número de participantes e à flexibilidade na estrutura e na composição do grupo, é a modalidade com menos literatura em TCCG. No entanto, a TCCG de apoio demonstrou resultados promissores para indivíduos com transtorno de pânico (Dattilio & Freeman, 2004), crianças enlutadas (Register & Hilliard, 2008) pacientes amputados (Reis, Schwab, & Neufeld, 2014) e indivíduos com lesão cerebral, incluindo-se aqui a extensão dos benefícios a seus cuidadores (Backhaus, Ibarra, Parrott, & Malec, 2016).

GRUPOS DE PSICOEDUCAÇÃO

O objetivo desse tipo de grupo é oferecer informações e autoconhecimento sobre os sintomas, demandas ou transtornos dos participantes, que vão desde a natureza do problema até os tratamentos disponíveis e prognósticos. Pode também ser realizado com um número mais elevado de participantes (mais de 15), mas tem sessões mais estruturadas, semanais, pautadas na psicoeducação e na resolução de problemas. Costumam ocorrer em um período curto, entre 4 e 6 semanas (Neufeld, 2011). Delgadillo e colaboradores (2016) avaliaram resultados de 163 grupos de psicoeducação em TCC, com um total de 4.451 participantes, e concluíram que grandes grupos desse tipo são eficazes para a redução de sintomas ansiosos. Resultados positivos foram também encontrados para redução de ansiedade e depressão (Varo, Fernández, Cobos, Gutiérrez, & Aragón, 2006) e no aumento da qualidade de vida de pacientes com esquizofrenia (Bechdolf et al., 2010).

GRUPOS DE TREINAMENTO E/OU ORIENTAÇÃO

Esses grupos visam orientar e treinar os participantes para que atinjam mudanças cognitivas, comportamentais e emocionais. Os grupos são

fechados, com sessões semanais, não excedendo 15 participantes, e ocorrem em mais de oito sessões (Neufeld, 2011). Apesar das semelhanças com grupos psicoeducativos, nesse modelo as técnicas cognitivas e comportamentais são mais utilizadas, com maior foco em exercícios para casa, além de aprofundarem-se no modelo cognitivo e de reestruturação cognitiva. Os efeitos positivos do treinamento de pais podem ser observados na literatura (Caminha & Pelisoli, 2007; Cassiano & Neufeld, 2014; Neufeld & Godoi, 2014), assim como o treinamento de habilidades sociais em adultos ou crianças e adolescentes (Z. A. P. Del Prette & Del Prette, 2009; Neufeld et al., 2014a).

GRUPOS TERAPÊUTICOS

Os grupos terapêuticos trabalham com ações estruturadas voltadas para demandas específicas. Têm configuração fechada, com sessões semanais, geralmente não ultrapassando os 12 integrantes e com duração mínima de 12 sessões (Neufeld, 2011). Constituem a maioria dos estudos da literatura em TCCG, e sua eficácia vem sendo demonstrada para uma variedade de demandas, como transtorno obsessivo-compulsivo (Cordioli et al., 2003; Behenck, Gomes, & Heldt, 2016), ansiedade social (Bjornsson et al., 2011; Blanco et al., 2010; Hofmann, 2004; McEvoy, Nathan, Rapee, & Campbell, 2012; Mörtberg et al., 2011), transtornos alimentares (Pinzon et al., 2004; Renjilian et al., 2001), transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) (Barrera, Mott, Hofstein, & Teng, 2013; Beck et al., 2009), ansiedade em crianças (Lau, Chan, Li, & Au, 2009), ajustamento psicosssexual em homens (Siddons, Wooten, & Costello, 2013), TDAH em adultos (Vidal et al., 2013), transtornos do humor em idosos (Wuthrich & Rapee, 2013), depressão (Okumura & Ichikura, 2014), resolução de problemas com casais (Bélanger, Laporte, Sabourin, & Wright, 2015), perfeccionismo (Handley, Egan, Kane, & Rees, 2015), reincidência em jovens infratores em liberdade condicional (Jewell, Malone, Rose, Sturgeon, & Owens, 2015), tratamento de insônia (Koffel, Koffel, & Gehrman, 2015), ansiedade de doença (Weck, Gropalis, Hiller, & Bleichhardt, 2015) e transtorno de pânico (Behenck et al., 2016; Wesner, Gomes, Detzel, Guimarães, & Heldt, 2015).

ELABORAÇÃO DE PROGRAMAS

Para a elaboração de um programa em TCCG, Corey (2000) destaca seis aspectos essenciais, que incluem as questões pré-grupo, estágios inicial, de transição, trabalho e final e questões pós-grupo. Cabe ressaltar, no entanto, que apenas os grupos terapêuticos apresentarão todas as fases mencionadas. As outras três modalidades podem não apresentar todas as etapas.

O planejamento e a escolha da intervenção acontecerão antes do início do grupo, quando se determinarão tipo de grupo, número de sessões, objetivo, estratégias de seleção, entre outras questões pertencentes ao estágio pré-grupo. O momento inicial do grupo destina-se a realizar os primeiros contatos, o contrato terapêutico, a psicoeducação e a sondagem sobre expectativas e metas, além de focar a coesão grupal (Bieling et al., 2008). A depender da demanda, podem ser inseridas estratégias, como as voltadas para o manejo de emoções. Durante a fase de transição, os pacientes começam a perceber certos ganhos com a terapia, mas também podem voltar sua atenção para sintomas que ainda persistem ou mesmo que pioraram. Podem surgir conflitos nessa fase, entre membros e com os profissionais. Preocupações e resistências devem ser acolhidas e discutidas entre o grupo (Bieling et al., 2008).

A intervenção propriamente dita ocorrerá no estágio de trabalho. Nesse momento, é necessário encorajar o *feedback* positivo, o compartilhamento de dificuldades e o aumento do papel ativo dos membros, bem como avaliar fatores terapêuticos mais relevantes que possam estar contribuindo ou não para o desfecho do grupo (Bieling et al., 2008). O foco se volta para o objetivo do grupo e para as crenças, os pensamentos e os comportamentos disfuncionais, com a inclusão das técnicas definidas no protocolo. As habilidades adquiridas até o momento são aprimoradas, e as interações entre os participantes devem estar mais aquecidas, uma vez que se espera que a coesão grupal já esteja fortalecida nesse momento.

O encerramento do grupo, assim como nas sessões individuais, volta-se para a consolidação dos aprendizados e a prevenção de recaída, quando preocupações, dúvidas e descrença sobre a capacidade fora do grupo devem ser trabalhadas. Recursos extras podem ser entregues ao final da terapia,

como cartilhas, vídeos e o planejamento do estágio pós-grupo. Nesse último estágio, são realizados avaliação dos participantes, *follow ups* ou seguimentos, encaminhamentos e avaliação dos terapeutas sobre o percurso do grupo em relação a suas limitações e benefícios (Neufeld, 2011). A influência das questões processuais também deve ser analisada, para avaliar dificuldades ou pontos de aperfeiçoamento.

TÉCNICAS

A literatura da área não é unânime na forma de utilização e classificação das atividades de acordo com sua finalidade (Antunes, 1995; Berkenbrock, 2005; Castilho, 1998; Lima, 2005; Lucchiari, 1993; Marcellino, 2002; Milicic, 1994; Miranda, 2000; Ferreira, 2001; Serrão & Baleiro, 1999; Sugiura, Kaneko, Yamada, & Oda, 1998). Em primeiro lugar, isso se deve ao fato de que as técnicas grupais não são de uso exclusivo do psicólogo; em segundo, ao fato de que uma mesma atividade pode ser utilizada com objetivos diferentes, conforme o propósito do grupo. Cabe, mais uma vez, ao terapeuta ou coordenador desenvolver a habilidade de escolha.

Ter ciência de onde se realiza o grupo também é muito importante para a utilização de técnicas mais eficazes. Muitas vezes, o grupo necessita de uma atividade de um determinado tipo para cumprir seu objetivo. Porém, caso não se esteja atento no momento da escolha, corre-se o risco de usar uma técnica que possa fazer o trabalho desenvolvido até aquele momento ser perdido.

As técnicas utilizadas no momento da intervenção podem ser classificadas como de ordem cognitiva ou comportamental. Em suma, não diferem dos pressupostos básicos encontrados na TCC individual (Beck, 1997), mas sua utilização será adaptada para o contexto do grupo. Técnicas utilizadas no início do grupo têm como objetivo facilitar a interação entre os membros, iniciar o desenvolvimento da coesão grupal e instilar esperança. Alguns exemplos são listados a seguir.

TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO

Esse tipo de atividade, como o próprio nome sugere, deve apresentar os participantes. Em geral, é utilizado em grupos que não se conhecem, mas

pode ser realizado quando o objetivo é que os integrantes tenham um conhecimento mútuo maior entre si. Esse conjunto de atividades é realizado por todos os níveis de grupo propostos por Osório (2003), que sugere classificar os grupos de acordo com os campos em que se fará a atuação: saúde (nesse campo estaria tanto a clínica como a saúde propriamente dita), educação, instituições, comunidades ou esportes. Alguns autores que propõem atividades com essa finalidade são Castilho (1998) e Serrão e Baleiro (1999).

TÉCNICAS DE INTEGRAÇÃO

Serrão e Baleiro (1999) definem esse tipo de atividade como o momento em que os participantes podem aprender realmente a trabalhar em grupo, interagindo e descobrindo as melhores estratégias de se comportar com essas pessoas que realizarão as atividades, tornando-se capaz de exprimir os mais diversos sentimentos em relação às atividades e àqueles que estejam a sua volta, sem perder sua individualidade dentro do grupo. São atividades que podem ser realizadas em diversos tipos de grupos, mas principalmente naqueles que estão em fase inicial de atividade. Na educação, Miranda (2000) propôs atividades bem interessantes que podem ser aplicadas com essa finalidade.

TÉCNICAS DE SENSIBILIZAÇÃO

São atividades realizadas com a finalidade de aquecer e/ou preparar o grupo para uma atividade, podendo ser nomeadas dessa forma, em vez de técnicas de sensibilização, que é um termo mais utilizado pelo psicodrama, que propõe que as pessoas precisam estar preparadas para a tarefa, embora todas as abordagens e níveis de grupos (Osório, 2003) utilizem atividades com essa finalidade, alguns autores que apresentam atividades desse tipo são Antunes (1995) e Mayer (2005).

TÉCNICAS PARA FOMENTAR LIDERANÇA

Esse tipo de temática é bastante utilizado em grupos de nível educacional, institucional e comunitário (Osório, 2003) com a finalidade de

desenvolvimento ou compreensão do assunto pelos participantes do grupo. Algumas vezes, pode ser também trabalhado em grupos esportivos, embora de forma mais discreta e com a intenção de desenvolver apenas um membro, e não trabalhar a temática no grupo em si. Moscovici (1997) é um dos autores que propõe algumas atividades para trabalhar essa temática de forma estruturada e comprovada.

TÉCNICAS FOCADAS NA TAREFA

São todas as atividades principais dos encontros e procuram trabalhar as temáticas centrais para as quais o grupo foi organizado. Um exemplo de trabalho realizado nesse sentido é o de Pereira (2000), que procura relatar atividades que visem ao desenvolvimento de grupos populares, ou seja, os trabalhos comunitários. Outros, como Silva (2002), são direcionados para o desenvolvimento de atividades na Saúde. Algumas técnicas servem para trabalhos bem terapêuticos, como Milicic (1994), Virgolim (1999), Stallard (2004) e R. M. Caminha e Caminha (2011). Outros são de textos que instigam o grupo a refletir sobre a temática necessária para situações variadas (Berkenbrock, 2005; Mayer, 1997). Há também trabalhos com a intenção de desenvolver a questão da aprendizagem, no nível educacional (Ferreira, 2001; Kammi & DeVries, 2009).

TÉCNICAS DE ENCERRAMENTO

Tão importante quanto iniciar um grupo é finalizar suas atividades. Esse aspecto também envolve um conjunto de atividades que podem ser utilizadas nos diferentes níveis de grupos (Osório, 2003). Entretanto, a literatura ainda é escassa nesse sentido, tendo sempre poucas técnicas bem descritas, como as de Lucchiari (1993).

TÉCNICAS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO

A utilização desse tipo de técnica visa trabalhar o desenvolvimento de determinadas habilidades (aquelas que forem descritas como objetivos do grupo). Sua principal característica é que os participantes possam se desenvolver na situação grupal e generalizar esses comportamentos para

outros contextos. Trata-se de um tipo de grupo bastante próprio do nível institucional, o qual visa treinar um grupo de pessoas para uma determinada tarefa. Nesse aspecto, muitas são as atividades e os requisitos necessários para as atividades. Normalmente, elas estão relacionadas com uma temática específica dentro desse treinamento. Autores que relatam atividades para essa proposta são Kirby (1995), Moscovici (1997) e Lima (2005). Dentro dessa modalidade de atividades, também há autores que preferem nomeá-las e trabalhar com a questão dos jogos, como Sugiura e colaboradores (1998).

TÉCNICAS LUDOPEDAGÓGICAS

Para Serrão e Baleiro (1999), as técnicas ludopedagógicas são chamadas de jogos. A finalidade dessas atividades é, em geral, descontrair e/ou dinamizar os grupos. São utilizadas para iniciar encontros, desde que não seja o primeiro, ou, então, como uma forma de fazer o grupo se descontrair depois de uma atividade que tenha exigido muita reflexão (Marcellino, 2002). É um tipo de atividade que também pode ser utilizado em todos os níveis de grupos (Osório, 2003). Além disso, pode-se utilizar dessa forma lúdica com a intenção de desenvolver habilidades específicas necessárias à aprendizagem no nível educacional (Ferreira, 2001, Kammi & DeVries, 2009).

TÉCNICAS DE RELACIONAMENTO INTERPESSOAL

Esse conjunto de atividades em geral se preocupa com a questão de habilidades necessárias para o relacionamento entre as pessoas. Pode ser utilizado em todos os níveis de modalidades grupais (Osório, 2003), bem como em diferentes momentos, ou seja, no início, meio ou fim dos grupos, conforme a necessidade encontrada pelo coordenador. Pode também ser apenas o único tipo de tema trabalhado, como quando é organizado um grupo para desenvolver habilidades sociais, no caso do contexto da saúde ou educação, ou, então, para melhorar as relações interpessoais, no nível institucional. Apresentam propostas de atividades para essa temática: Mosovici (1997), Sugiura e colaboradores (1998), Z. A. P. Del Prette e Del Prette (2001).

O PROCESSO EM TCCG

Considerando que a TCCG adapta componentes da teoria aplicada na modalidade individual, o que faz alguns estudos apontarem para melhores ou diferentes resultados na modalidade grupal para determinados tratamentos? Renjilian e colaboradores (2001) apontam para a superioridade da intervenção grupal para perda de peso em obesos, mesmo entre os clientes que indicaram preferência pelo tratamento individual. A resposta para essas variações pode ser encontrada nas variáveis existentes provenientes das interações que ocorrem entre os membros do grupo e terapeutas. Apesar de o processo grupal ser constantemente mencionado na literatura sobre TCCG, existe uma falta de clareza quanto ao conceito e mesmo pouquíssima investigação acerca de sua influência. Se as técnicas – bem descritas na literatura – referem-se a todas as estratégias adotadas pelo arcabouço teórico para atingir o objetivo do grupo, como modificações cognitivas, comportamentais e emocionais, o processo pode ser definido como o “. . . conjunto de fatores que surgem da condução da terapia em um formato grupal . . .” (Bieling et al., 2008).

Esses fatores interagem com a intervenção cognitivo-comportamental propriamente dita, influenciando, por conseguinte, o desfecho da intervenção. Alguns desses fatores são: os efeitos dos sintomas sobre o grupo, da melhora/piora de alguns membros, interações entre membros, entre os terapeutas, entre terapeutas e o grupo, efeito da evasão e faltas, adaptabilidade do paciente ao tratamento, remoção do foco de si mesmo, aprendizado e coesão grupal, entre outros, descritos com detalhes na obra dos autores (Bieling et al., 2008). Dessa maneira, a avaliação de um grupo deve atentar para os fatores que podem contribuir ou não para o sucesso da intervenção, em vez de pautar-se apenas nas características técnicas, como número de sessões e estratégias utilizadas.

FATORES TERAPÊUTICOS DE IRWIN D. YALOM E GARY M. BURLINGAME

Além de ter intervenções eficazes comprovadas em diversos estudos, a modalidade grupal pode oferecer vantagens sobre a modalidade individual devido aos fatores terapêuticos nela envolvidos (Van Noppen, Pato, Marsland, & Rasmussen, 1998). Apesar dos elementos potencializadores únicos presentes nesse tratamento, é também preciso o preparo do terapeuta para saber lidar com esses fatores envolvidos na modalidade (Beck & Coffey, 2005). Se um terapeuta no contexto clínico individual pode voltar toda sua atenção para a demanda e as falas do cliente, em um grupo a atenção será dividida entre as falas dos membros e os comportamentos e reações que possam interferir nos objetivos da intervenção. Por exemplo, é preciso administrar o tempo destinado a cada participante e, mesmo, observar se a atenção dos demais não fica dispersa no momento em que um membro ou terapeuta se comunica, além de, claro, fazer os participantes tornarem-se ativos no processo de mudança, tanto para consigo quanto para com os demais.

Yalom e Leszcz (2008) descrevem os fatores terapêuticos envolvidos nos grupos como os elementos envolvidos no complexo processo de mudança que ocorre por meio das interações de experiências humanas. Os 11 fatores primários propostos são interdependentes e não ocorrem ou funcionam separadamente. São eles: instilação de esperança, universalidade, compartilhamento de informações, altruísmo, recapitulação corretiva do grupo familiar primário, desenvolvimento de técnicas de socialização, comportamento imitativo, aprendizado interpessoal, coesão grupal, catarse e fatores existenciais. No entanto, tomando por base o fato de que os estudos de Yalom e Leszcz (2008) se encontram ancorados nas teorias psicodinâmicas, a literatura em TCCG encontrou dados de existência de oito dos fatores mapeados por Yalom e Leszcz (2008), que serão aprofundados a seguir. Além disso, os autores da TCCG Burlingame, MacKenzie e Strauss (2004) acrescentam outros três fatores: a estrutura do contexto, o paciente e a liderança do terapeuta.

Reconhecer o impacto desses fatores é fundamental para uma melhor compreensão do processo terapêutico e o consequente aprimoramento das intervenções em grupo, e fatores terapêuticos específicos podem, então,

desempenhar um papel diferente a depender da demanda, variando ao longo da intervenção em relação ao seu aparecimento ou importância (Behenck et al., 2016). No que se refere à relação entre os preceitos da TCC e esses fatores terapêuticos, Bieling e colaboradores (2008) descrevem como eles se aplicam na intervenção em TCCG. Por exemplo, a instilação de esperança e sua manutenção ao longo do grupo é de extrema importância para manter o paciente em terapia (Yalom & Leszcz, 2008), o que poderá ser potencializado na TCCG durante a psicoeducação e o contrato terapêutico, quando o terapeuta irá discorrer sobre a eficácia e os resultados do tratamento e informará sobre a demanda e seu prognóstico. Conhecer mais sobre a dificuldade enfrentada é fundamental nesse processo de instilação de esperança (Neufeld, 2011). Em pacientes com transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), esse foi o fator terapêutico mais pontuado durante o grupo (Behenck et al., 2016).

É comum que muitos indivíduos procurem ajuda acreditando que seus problemas são raros e inéditos. Quando descobrem que outras pessoas estão passando por dificuldades parecidas, tanto em relação aos sintomas quanto às estratégias de enfrentamento, o fator referente à universalidade entra em cena. Basicamente, quando ouvem dos demais membros relatos semelhantes, se dão conta de que não estão enfrentando seus problemas particulares sozinhos, o que por si já pode servir como alívio inicial (Yalom & Leszcz, 2008). Esse senso de pertencimento gerado pode impulsionar a coesão grupal (Bieling et al., 2008). A homogeneidade buscada pela TCCG na composição dos grupos para garantir melhores resultados de intervenção irá favorecer a descoberta das dificuldades semelhantes nos demais membros do grupo (Neufeld, 2011).

Em um grupo, uma das características mais palpáveis talvez seja o compartilhamento de informações que ocorre entre os participantes. O compartilhamento pode ser feito por meio da instrução didática – com aconselhamento, sugestões, orientações, psicoeducação – e do conselho direto, em que o benefício relacionado ao fator concerne mais ao interesse mútuo do que ao conteúdo em si. Grupos de autoajuda, como o Alcoólicos Anônimos, são permeados por esse fator (Yalom & Leszcz, 2008). A psicoeducação e a prevenção de recaída, características consolidadas da TCC,

são formas de compartilhamento de informações por parte do terapeuta. A revisão das tarefas no início das sessões de TCCG também permite que os demais membros aconselhem ou orientem, momento em que também o encorajamento da participação ativa e os conteúdos trabalhados explícitos permitem concluir que a TCC contribui para esse fator grupal.

O altruísmo refere-se à ajuda oferecida entre os membros, por meio de suporte, conselhos e escuta empática, sendo o ato de ajuda tão importante quanto seu recebimento (Yalow & Leszcz, 2008). Mediante estratégias como coleta de evidências, questionamento socrático, avaliações sobre pensamentos e comportamentos disfuncionais e avaliações sobre a tarefa de casa, a TCCG proporciona a interação e a participação ativa entre os membros sobre a demanda, facilitando os comportamentos de altruísmo (Bieling et al., 2008). Nesse sentido, Beck e Coffey (2005) refletem acerca da pressão que o grupo pode exercer por meio do apoio social, uma vez que alguns membros podem se sentir pressionados para atingir os resultados dos demais. O terapeuta deve, então, estar atento a essa ocorrência e perceber se está encorajando ou pressionando seu paciente.

Behenck e colaboradores (2016) concluem que o formato grupal fornece e facilita a experimentação de comportamentos novos e mais adaptáveis, além de contribuir para a correção de distorções cognitivas ao permitir a identificação de comportamentos mais adaptativos em outros membros, que são validados pelo grupo. Cada membro serve de modelo para os demais, e novos comportamentos podem ser testados, o que talvez não acontecesse fora desse contexto de intervenção, favorecidos pelo aprendizado interpessoal e comportamento imitativo.

Nesse sentido, o grupo também permitirá que ocorra o aprendizado interpessoal, fator terapêutico complexo que surge a partir das interações entre os membros, refletindo esses padrões aprendidos ao longo da vida, mas que agora sofrem intervenção dos demais indivíduos que compõem o grupo, seja por meio de comentários, seja por meio da percepção de outros padrões de funcionamento mais bem-sucedidos (Yalom & Leszcz, 2008). Em TCC, o treino de habilidades sociais pode ser um exemplo de um grupo diretivo, desenvolvendo habilidades e corrigindo déficits. Entretanto, mesmo em um

grupo sem esse foco específico, é possível observar comportamentos mais assertivos e empáticos sendo desenvolvidos, e mesmo a socialização inerente do grupo permitirá a exposição em casos de pacientes com fobia social, por exemplo. Essa mesma característica do grupo se aplica aos comportamentos imitativos, engajando os participantes em novos comportamentos instigados por modelos que deram certo (Bieling et al., 2008).

A coesão grupal é indicada como elemento fundamental na melhora de pacientes com ansiedade social (Taube-Schiff, Suvak, Antony, Bieling, & McCabe, 2007) e demonstrou ser um fator importante para intervenção com psicóticos (Lacomte, Leclerc, Wykes, Nicole, & Baki, 2015). Remete à atração que os participantes têm pelo grupo e pelos outros membros, crucial para o desenvolvimento, a confiança, a aceitação e o apoio entre os membros (Bieling et al., 2008). Pode ser definida como análoga à relação estabelecida na terapia individual (Yalom & Leszcz, 2008). Quando um grupo demonstra coesão deficitária, é bem provável que comportamentos recorrentes, como faltas, desistências ou mesmo interações complicadas, sejam observados. Para o trabalho da coesão grupal, Beck e Coffey (2005) utilizaram, em um grupo para indivíduos com TEPT, um ritmo mais lento de intervenção, com ênfase na construção do grupo desde o início. O apoio entre os participantes também foi incentivado, com as exposições voltando-se para a compreensão individual dos princípios, em vez do foco em exercícios específicos.

Já Burlingame e colaboradores (2004) propõem outros fatores que ocorrem no grupo e que influenciarão os desfechos terapêuticos do tratamento, explicando a melhora do paciente nessa modalidade. O primeiro fator refere-se à teoria formal da mudança, que consiste basicamente nos princípios nos quais a intervenção será estruturada. Assim, será feita a escolha do protocolo a ser utilizado, do plano de sessão e dos mecanismos de mudança a partir dos estudos de eficácia e efetividade. Como fato já consolidado, a TCC configura-se como teoria baseada em evidências; portanto, a escolha do tipo de intervenção será baseada na literatura científica disponível e no melhor tratamento encontrado até o momento.

Os autores também se referem ao grupo como ambiente terapêutico e fonte de mudança, sendo observados os princípios do processo de pequenos

grupos como fatores terapêuticos, ou seja, as relações interpessoais que ocorrem quando os indivíduos estão nesse contexto de intervenção (Bieling et al., 2008) e como elas irão influenciar o desfecho do grupo. Nesse sentido, paciente e terapeuta também são vistos como fatores terapêuticos, uma vez que têm características da demanda ou do estilo de liderança dos profissionais. Nenhuma intervenção está livre da influência da personalidade dos membros, mas, no grupo, esta se potencializa devido à complexidade das interações, o que deve ser muito bem observado no momento de seleção e avaliação, com o objetivo principal de não prescrever erroneamente a TCCG como forma de tratamento. A depender da demanda, o indivíduo poderá comprometer o andamento do grupo, e, como resultado provável, nenhum dos integrantes sairá beneficiado.

Fatores estruturais do grupo são de ordem mais “prática”, envolvendo questões como duração da intervenção, número de sessões, intensidade, frequência, tamanho, local, questões culturais, entre outras variáveis que podem influenciar o desfecho do grupo. Por fim, a interconexão desses fatores estaria, então, nas mãos do terapeuta. Todos esses fatores são constatados no modo como a TCCG se organiza, considerando a estrutura das intervenções, o uso de protocolos, o trabalho com grupos homogêneos, fechados, sem desconsiderar características imprescindíveis ao profissional da TCC. Os elementos únicos presentes no grupo têm o poder de potencializar o tratamento, mas, caso o terapeuta não saiba lidar com essas interações, o desfecho positivo do grupo pode ser dificultado. Observa-se a tênue linha que separa os fatores terapêuticos da interação danosa – as ações entre os participantes devem ser mediadas de modo que esse suporte possa ser proveitoso (Beck & Coffey, 2005).

PROCESSO EM DEMANDAS ESPECÍFICAS EM TCCG

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) tem algumas características que devem ser consideradas quando se opta por um tratamento grupal. Primeiramente, trata-se de um transtorno com muitas características diferentes em relação aos tipos de obsessão e compulsões, variando muito em conteúdo e comportamentos relacionados, além de comorbidades

frequentemente associadas. Dessa maneira, a heterogeneidade pode dificultar a coesão e a universalidade do grupo. Ainda, os diferentes sintomas e gravidade podem promover o contágio entre os pacientes, bem como a percepção distorcida de sua evolução ao comparar-se a membros que evoluíram devido a especificidades de seu problema (Bieling et al., 2008). Sessões mais longas e com um número reduzido e devidamente triado de pacientes, um cronograma estruturado, mas que também possa voltar-se às demandas específicas de cada membro e com foco sobre a recaída e a pulverização de sintomas, constituem características que podem resultar em desfechos mais positivos. Van Noppen e colaboradores (1998) indicam que fatores como universalidade e altruísmo podem ajudar a promover e manter mudanças entre participantes com TOC. Em um estudo recente de Behenck e colaboradores (2016), os fatores terapêuticos mais pontuados pelos pacientes foram instilação de esperança e universalidade, seguidos de recapitulação familiar, aprendizado interpessoal, autoconhecimento e fatores existenciais, os três últimos associados a melhora na ansiedade e nos sintomas específicos do TOC.

O tratamento em grupo para transtorno de ansiedade social parece um tanto paradoxo, pois interações grupais são situações muito temidas por esses pacientes. No entanto, dois fatores terapêuticos podem potencializar o tratamento: a aprendizagem interpessoal e a universalidade. Apesar de ansiogênico, o grupo também atua como um local para o treino de exposição e o recebimento de *feedbacks* imediatos, e os participantes se beneficiam com o aprendizado interpessoal. Ainda, como pacientes com esse transtorno podem carecer de habilidades sociais, o grupo pode atuar positivamente nesse sentido. Bieling e colaboradores (2008) destacam o número reduzido de pacientes (aproximadamente seis participantes) e a necessidade de certa homogeneidade das demandas, no sentido de garantir que nenhuma característica individual seja muito destoante e aumente a ansiedade perante o grupo. Além desses fatores, Choi e Park (2006) demonstram que a aprendizagem interpessoal, a orientação, a universalidade e a coesão grupal são fatores importantes no tratamento da ansiedade social.

Na experiência dos autores deste capítulo, a adesão ao grupo é um fator importante a ser trabalhado, antes mesmo de o grupo começar. Como contamos com a experiência de um serviço público, muitos pacientes podem ter se inscrito há muito tempo ou mesmo ter tido outras expectativas a respeito da terapia. O próprio momento de triagem pode ser tão ameaçador que sua inserção no tratamento em TCCG pode ser comprometida. Assim, a partir do momento em que se tem uma lista de participantes elegíveis para a triagem, as próprias ligações devem ser pensadas e treinadas para soarem menos ameaçadoras, mais claras, com informações concretas sobre o grupo e também com um tom indiretamente motivador, uma vez que o tratamento soará extremamente ansiogênico. Os locais são sempre mais reservados, e o terapeuta sempre deixa clara a função de algum coterapeuta ou observador, além de trabalhar intensamente a coesão grupal. Assim como no TOC, o momento das exposições e das tarefas de casa pode ser muito difícil, pois, além de serem comuns tentativas que não atingiram seu objetivo, muitos podem sentir que não estão avançando ao ver o progresso dos demais. Dessa maneira, o terapeuta deve reforçar qualquer tentativa como um objetivo parcialmente atingido, bem como manejar as diferenças existentes entre cada membro, focando no compartilhamento de informações, na instilação de esperança e no desenvolvimento de técnicas de socialização.

O processo grupal no tratamento da depressão pode ser, evidentemente, como outros transtornos, dificultado pelas suas características. No entanto, sintomas característicos como anedonia, pessimismo, negativismo e cansaço podem ter um impacto maior na adesão do grupo e na universalidade. A depender do quadro em que o paciente se encontra, tarefas simples podem ser muito difíceis de ser realizadas, cabendo ao(s) terapeuta(s) foco na empatia, no encorajamento e na persistência com as tarefas e o tratamento em si (Bieling et al., 2008). Assim, instilação de esperança e altruísmo talvez sejam fatores que mereçam maior atenção nesse tipo de grupo, bem como a motivação à adesão ao tratamento. O terapeuta, portanto, deve continuamente intervir com os membros nesse sentido. Oei e Browne (2006) indicam, porém, que a liderança menor do profissional nesse tipo de grupo associou-se a resultados

positivos, bem como a maior senso de independência percebido pelos participantes.

As sessões iniciais da TCCG para abuso de substâncias recaem sobre motivação e psicoeducação sobre o tipo de uso da droga, sendo essa abordagem menos agressiva e confrontadora que as tradicionais no combate à “negação” (Bieling et al., 2008). Portanto, o estilo e a liderança do terapeuta irão influenciar os desfechos positivos desses grupos, uma vez que terapeutas mais focados na aceitação e na redução de danos inicial provavelmente encontrarão sucesso maior em contraposição a estilos mais rígidos e incisivos. Ao lidar com o abuso de substâncias, o terapeuta deve ter em mente que os objetivos do grupo seguirão os estágios do consumo e que os ganhos podem ser menos palpáveis, pelo menos inicialmente, em comparação a outros transtornos cuja etiologia dos sintomas seja diferente. Fatores como instilação de esperança, altruísmo e compartilhamento de informações certamente serão observados e reforçados ao longo dos grupos.

O tratamento do transtorno de pânico deve seguir com grupos pequenos e homogêneos, bem como precisa ser pautado na coesão grupal, dadas as recaídas características do transtorno. Além disso, o terapeuta deve ficar atento à contaminação de pensamentos, que pode ocorrer ao longo do grupo a partir do compartilhamento de experiências entre os membros (Bieling et al., 2008). Em grupos com pacientes com transtorno de pânico, Behenck e colaboradores (2016) apontam como significativamente úteis durante o curso do tratamento o altruísmo, a aprendizagem interpessoal, a orientação, a identificação, a autocompreensão e fatores existenciais. Os diferentes fatores, por sua vez, variam em relevância de acordo com o momento do grupo. Por exemplo, aprendizagem interpessoal e orientação se tornaram mais evidentes e decisivas com o início das técnicas cognitivas e com a confrontação dos medos, que ocorreram na 4ª e 10ª sessão, respectivamente.

Sabe-se que os trabalhos em grupo com transtornos alimentares e obesidade podem ser bastante efetivos, pois os membros do grupo podem servir como modelos para os outros em termos de mudança de comportamento. Além disso, a questão da heterogeneidade dos participantes pode ser um facilitador para a efetividade das atividades realizadas, bem

como da integração entre eles (Luz & Oliveira, 2013; Melo, Bergmann, Neufeld, Machado, & Conceição, 2014). No entanto, é necessário grande investimento por parte dos terapeutas quanto a motivação e comprometimento, uma vez que frequentemente os pacientes com transtornos alimentares não conseguem enxergar a gravidade do transtorno ou até mesmo o fato de que têm problemas (Bieling et al., 2008). Assim, também, indivíduos com sobrepeso ou obesidade podem ter dificuldades em vislumbrar os benefícios de longo prazo e não se engajar nas medidas do tratamento, podendo apresentar expectativas irreais acerca dele. O foco na motivação, bem como na coesão do grupo no início do tratamento, pode facilitar o comprometimento. Em nossa experiência com o grupo de reeducação alimentar PRO-META (Programa Cognitivo-Comportamental de Educação Alimentar em Grupo – Neufeld, Affonso, & Moreno, 2014), observamos que o tratamento multiprofissional é essencial, pois apenas a reestruturação cognitiva muitas vezes não será capaz de atingir os objetivos do grupo e promover mudanças palpáveis durante a terapia. Além disso, um contrato terapêutico bem estabelecido no início e o compartilhamento de informações realistas sobre a perda de peso vêm se mostrando essenciais para a adesão e resultados positivos do grupo.

De acordo com Bieling e colaboradores (2008), o tratamento em grupo para transtornos da personalidade não é uma escolha comum, dada a heterogeneidade de sintomas e a complexidade do tratamento. Os autores destacam a dificuldade desses pacientes em dar e receber *feedbacks* no grupo, mas também que a modelação a partir de experiências e comportamentos alheios, além da estimulação na participação ativa no tratamento, são fatores positivos proporcionados pelo contato com o grupo. Além disso, o suporte e a universalidade encontrados entre os membros, o formato psicoeducativo, a motivação para a terapia individual e a autoconsciência interna e externa também podem ser ganhos importantes do tratamento em grupo. No entanto, é de extrema importância que os pacientes com transtornos da personalidade concordem com a modalidade de tratamento (Bieling et al., 2008). O terapeuta que se propuser a trabalhar com esses transtornos deve ter amplo conhecimento sobre os diferentes tratamentos existentes, bem como sobre o

funcionamento de cada transtorno, devendo adaptar seu estilo de liderança e percepção acerca de fatores terapêuticos facilitadores para cada demanda.

OS TERAPEUTAS DE GRUPOS

Os desafios de um grupo vão além do atendimento individual de pessoas em grupo, considerando que os terapeutas devem equilibrar sua atenção às relações entre os membros e os objetivos da sessão, o que nos leva a concluir que o estilo do profissional será uma variável importante no desfecho do grupo (Bieling et al., 2008; Burlingame et al., 2004). Poucos estudos consideram as características de seus terapeutas nos resultados obtidos após a intervenção. Questões que vão desde a formação e o treinamento do profissional até o ajuste à teoria e as habilidades para lidar com pacientes em um contexto grupal devem ser levadas em consideração. O relacionamento terapêutico é crucial para as relações estabelecidas com o terapeuta e também entre membros, uma vez que, dependendo do estilo de liderança, elas podem ser dificultadas ou pouco expandidas.

Assim como na prática individual, esperam-se do terapeuta de grupo características básicas, como empatia genuína, intervenções baseadas em evidências, foco no questionamento socrático e no empirismo colaborativo, esclarecimento de métodos empregados e informações acerca da demanda e do tratamento, encorajamento ao *feedback*, intervenção sobre possíveis dificuldades encontradas na relação terapêutica, entre outras características básicas que não diferem das propostas tradicionais da TCC. No entanto, como mencionado, o profissional de grupo deverá compreender os fatores envolvidos nessa modalidade, além de precisar ter atenção redobrada e respostas rápidas para os acontecimentos dos encontros. Beck e Coffey (2005) assemelham o terapeuta a um treinador, que valida e tem consciência das dificuldades de cada membro, mas também incentiva e impulsiona os participantes para além de seus limites.

Limitações específicas também devem poder ser manejadas pelo profissional, como, por exemplo, características de personalidade ou demanda de um paciente diferentes das apresentadas em avaliação prévia ou mesmo a limitação causada pelo tempo e duração da intervenção. Não menos

importante é a relação que é estabelecida em um grupo que dispõe de coterapeuta. Caso haja atritos e oposições, a sintonia necessária será dificultada, e, como consequência, a intervenção e as interações serão prejudicadas. Considerando a complexidade da modalidade grupal, o treinamento dos profissionais deve ser prioridade, e as características oportunas do estilo de liderança devem ser cada vez mais investigadas e aprimoradas para garantir melhores resultados da TCCG.

Além disso, o profissional precisa ter habilidades para lidar com outras técnicas além do relato verbal, para que possa ter a participação daqueles pacientes que são poucos verbais e para dar espaço à participação de todos os membros. A facilidade para utilização de técnicas diversas e lúdicas pode auxiliar no bom andamento do grupo.

ESTRATÉGIAS DE MANEJO DE PACIENTES DIFÍCEIS

Bieling e colaboradores (2008) indicam que todo grupo pode ter problemas provenientes de três áreas: processo grupal, liderança do terapeuta e pacientes difíceis. Em relação ao último campo, cinco perfis comumente encontrados em grupos são propostos: quieto e calado, arrogante, ajudante, descrente e errante. O primeiro protótipo descreve aquele paciente mais tímido e pouco participativo, a ponto de a falta de abertura quanto ao tratamento poder prejudicar sua permanência no grupo. Assim, os autores sugerem a empatia e o reforço com as pequenas comunicações, além da extração mais sutil dos conteúdos, trazendo para o grupo a avaliação e a identificação com os acontecimentos do participante com dificuldade. Não é descartada a possibilidade de discutir os sentimentos sobre estar no grupo, exemplificando com possíveis dificuldades encontradas nesse membro.

Para lidar com o membro arrogante, Bieling e colaboradores (2008) sugerem não reforçar falas prolongadas e conter, quando necessário, comportamentos inapropriados. Exemplos dessas estratégias são desviar o olhar ou intervir no meio da fala, propondo a participação dos outros membros sobre a questão. O coterapeuta pode auxiliar o líder nesse manejo. É muito importante a intervenção com os pacientes que monopolizam o tempo do grupo, pois, além de prejudicarem a si mesmos com a interferência

na agenda da sessão, também prejudicam os demais membros, podendo enfraquecer a motivação destes para a permanência no grupo.

O estilo ajudante também costuma emitir comportamentos inadequados durante a intervenção, como oferecer diversos conselhos sobre como os membros deveriam lidar com determinada situação ou sobre como o próprio terapeuta deveria agir. Generalizações são comuns, assim como o distanciamento das próprias adversidades, momento que merece intervenção do terapeuta. Em nosso grupo de orientações voltado para pais (PROPAIS), são muito comuns regras acerca de estilos parentais ou sobre comportamentos desejados nos filhos, como indicar práticas punitivas eficazes ou expressar regras que regem as práticas educativas, como “as - crianças de hoje em dia não respeitam mais, é necessário educá-las com mais firmeza”. Já tivemos casos de participantes que trouxeram materiais como proposta de discussão para o grupo. O engajamento, evidentemente, é incentivado; no entanto, em alguns momentos, a interferência do participante pode desviar o grupo de seus objetivos e também ser danosa. Certa vez nos deparamos com uma mãe que afirmou ser muito importante para a educação do filho mostrar notícias sobre crianças que foram sequestradas por saírem de casa sozinhas ou desobedecerem aos pais. A intervenção, mais uma vez, volta-se para trazer para o grupo a questão levantada, incentivando e mediando o *feedback* dos demais membros.

O participante pessimista é descrito pelos autores como descrente. É aquele indivíduo que sempre desafia o terapeuta e o tratamento, destacando pontos que considera negativos e que são sinônimos de fracasso. O profissional não deve permitir que comentários do tipo sejam levados muito adiante, acolhendo a frustração e destacando a responsabilidade pessoal em continuar com o tratamento. Em nosso PRO-META, observamos algumas dificuldades referentes à adesão dos membros, dado o tempo e as dificuldades complexas encontradas na perda de peso. Muitas vezes, após um episódio de compulsão alimentar, por exemplo, o participante chega pessimista à sessão e foca sua atenção em sua recaída, demonstrando desesperança elevada ante a resolução de seu problema. Dessa maneira, a psicoeducação referente a demanda, tratamento e suas possibilidades, ao

prognóstico, aos diversos fatores envolvidos na perda de peso e no objetivo primário do grupo (mudanças na cognição, na emoção e no comportamento associadas à alimentação) deve ser destacada e retomada quando necessário. Além disso, estratégias como contato telefônico após faltas, foco no contrato terapêutico e regras do grupo, além do incentivo direto ao comparecimento do paciente, são adotadas (Neufeld et al., 2014b).

Já o membro errante é aquele que sempre falta, chega muito atrasado ou sai antes, fazendo sua participação ser inconsistente. Esse comportamento pode ocorrer por diversas razões, sendo necessário revisar o contrato. Bieling e colaboradores (2008) indicam que a intervenção nesse caso deve ser feita tão logo se perceba esse padrão de comportamento. Não há benefício em sua participação, nem mesmo para os demais do grupo. Em último caso, uma sessão individual pode ser realizada para relatar as dificuldades que vêm sendo observadas e indicar alternativas de tratamento mais adequadas ao perfil em questão. Nesse caso, todos os grupos devem contar com um contrato terapêutico bem definido, e as regras estabelecidas no início devem ser aplicadas rigorosamente, para que esses comportamentos não “contaminem” demais membros do grupo. Em todos os casos, o terapeuta deve intervir de maneira sutil, encorajando o grupo a refletir sobre o tema em questão. Além disso, *feedbacks* são sempre requisitados, e os conteúdos que possam surgir devem ser acolhidos e trabalhados. Apesar das dificuldades encontradas nesses membros, o terapeuta não pode perder a postura terapêutica e profissional, mesmo porque é a partir desse papel e das intervenções estabelecidas como líder que essas dificuldades poderão ser contornadas com sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este capítulo visou abordar os aspectos que julgamos mais relevantes no que tange a técnica e o processo em TCCG. No entanto, cabe ressaltar que o apresentado aqui não esgota as possibilidades de reflexão a respeito. Dessa forma, trata-se apenas de um ponto inicial de discussão que subjaz a estrutura deste livro como um todo. Aprofundamentos poderão ser encontrados nos

capítulos que se seguem e que visam lançar luz sobre aspectos específicos de demandas e transtornos que podem se beneficiar de uma intervenção grupal em TCC.

REFERÊNCIAS

- Antunes, C. (1995). *Manual de técnicas de dinâmica de grupo de sensibilização de ludopedagogia* (9. ed.). Petrópolis: Vozes.
- Berkenbrock, V. J. (2005). *Histórias para dinamizar reuniões* (2. ed.) Petrópolis: Vozes.
- Backhaus, S., Ibarra, S., Parrott, D., & Malec, J. (2016). Comparison of a cognitive-behavioral coping skills group to a peer support group in a brain injury population. *Archives of Physical Medicine and Rehabilitation*, 97(2), 281-291.
- Barrera, T. L., Mott, J. M., Hofstein, R. F., & Teng, E. J. (2013). A meta-analytic review of exposure in group cognitive behavioral therapy for posttraumatic stress disorder. *Clinical Psychology Review*, 33(1), 24-32.
- Bechdolf, A., Knost, B., Nelson, B., Schneider, N., Veith, V., Yung, A. R., & Pukrop, R. (2010). Randomized comparison of group cognitive behaviour therapy and group psychoeducation in acute patients with schizophrenia: effects on subjective quality of life. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 44(2), 144-150.
- Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive therapy of depression*. New York: Guilford Press.
- Beck, J. (1997). *Terapia cognitiva: Teoria e prática*. Porto Alegre: Artmed.
- Beck, J. G., & Coffey, S. F. (2005). Group cognitive behavioral treatment for PTSD: treatment of motor vehicle accident survivors. *Cognitive and Behavioral Practice*, 12(3), 267-277.
- Beck, J. G., Coffey, S. F., Foy, D. W., Keane, T. M., & Blanchard, E. B. (2009). Group cognitive behavior therapy for chronic posttraumatic stress disorder: An initial randomized pilot study. *Behavior Therapy*, 40(1), 82-92.
- Behenck, A. S., Gomes, J. B., & Heldt, E. (2016). Patient rating of therapeutic factors and response to cognitive-behavioral group therapy in patients with obsessive-compulsive disorder. *Issues in Mental Health Nursing*, 37(6), 392-399.
- Bélanger, C., Laporte, C., Sabourin, S., & Wright, J. (2015). The effect of cognitive-behavioral group marital therapy on marital happiness and problem solving self-appraisal. *The American Journal of Family Therapy*, 43(2), 103-118.
- Berkenbrock, V. J. (2005). *Histórias para dinamizar reuniões* (2. ed.) Petrópolis: Vozes.
- Bieling, P. J., McCabe R. E., & Antony, M. M. (2008). *Terapia cognitivo-comportamental em grupos*. Porto Alegre: Artmed.
- Bjornsson, A., Bidwell, C., Brosse, A., Carey, G., Hauser, M., Seghete, K. L. M., ... Craighead, W. E. (2011). Cognitive-behavioral group therapy versus group psychotherapy for social anxiety disorder among college students: A randomized controlled trial. *Depression and Anxiety*, 28(11), 1034-1042.

- Blanco, C., Heimberg, R. G., Schneier, F. R., Fresco, D. M., Chen, H., Turk, C. L., ... Liebowitz, M. R. (2010). A placebo-controlled trial of phenelzine, cognitive behavioral group therapy, and their combination for social anxiety disorder. *Archives of General Psychiatry*, 67(3), 286-295.
- Burlingame, G. M., MacKenzie, K. R., & Strauss, B. (2004). Small-group treatment: Evidence for effectiveness and mechanisms of change. In M. J. Lambert, A. E. Bergin, & S. L. Garfield (Eds.), *Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change* (5th ed., pp. 647-696). New York: Wiley.
- Caminha, R. M., & Caminha, M. G. (2011). *Baralho das emoções: Acessando a criança no trabalho clínico* (4. ed.). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Caminha, M. G., & Pelisoli, C. (2007). Treinamento de pais: Aspectos teóricos e clínicos. In R. M. Caminha, & M. G. Caminha, *A prática cognitiva na infância* (pp. 274-289). São Paulo: Rocca.
- Cassiano, M., & Neufeld, C. B. (2014). PROPAIS II – Programa Cognitivo-Comportamental de Orientação de Pais visando à promoção de saúde. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 148-181). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Castilho, A. (1998). *A dinâmica do trabalho em grupo*. Rio de Janeiro: Qualitymark.
- Choi, Y. H., & Park, K. H. (2006). Therapeutic factors of cognitive behavioral group treatment for social phobia. *Journal of Korean Medical Science*, 21(2), 333-336.
- Conselho Federal de Psicologia (CFP). (2005). *Código de ética profissional*. Brasília: CFP.
- Cordioli, A. V., Heldt, E., Bochi, B. D., Margis, R., Sousa, M. B., Tonello, F. J., ... Kapzinski, F. (2003). Cognitive-behavioral group therapy in obsessive-compulsive disorder: a randomized clinical trial. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 72(4), 211-216.
- Corey, G. (2000). *Theory and practice of group counseling*. California: Wadsworth Thomson Learning.
- Dattilio, F. M., & Freeman A. (2004). *Estratégias cognitivo-comportamentais de intervenção em situações de crise*. Porto Alegre: Artmed.
- Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2001). *Habilidades sociais: intervenções efetivas em grupo*. Petrópolis: Vozes.
- Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2009). *Psicologia das habilidades sociais na infância: Teoria e prática* (4. ed.). Petrópolis: Vozes.
- Delgadillo, J., Kellett, S., Ali, S., McMillan, D., Barkham, M, Saxon, D., ... Lucock, M. (2016). A multi-service practice research network study of large group psychoeducational cognitive behavioural therapy. *Behaviour Research and Therapy*, 87, 155-161.
- Ferreira, M. (2001). *Ação psicopedagógica na sala de aula: Uma questão de inclusão*. São Paulo: Paulus.
- Handley, A. K., Egan, S. J., Kane, E. R., & Rees, C. S. (2015). A randomised controlled trial of group cognitive behavioural therapy for perfectionism. *Behaviour Research and Therapy*, 68, 37-47.
- Hofmann, S. G. (2004). Cognitive mediation of treatment change in social phobia. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72(3), 392-399.
- Jewell, J. D., Malone, M. D., Rose, P., Sturgeon, D., & Owens, S. (2015). A multiyear follow-up study examining the effectiveness of a cognitive behavioral group therapy program on the recidivism of

juveniles on probation. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 59(3), 259-272.

Kamii, C., & DeVries, R. (2009). *Jogos em grupo na educação infantil*. Porto Alegre: Artmed.

Kirby, A. (1995). *150 jogos de treinamento*. São Paulo: T&D.

Koffel, E. A., Koffel, J. B., & Gehrman, P. R. (2015). A meta-analysis of group cognitive behavioral therapy for insomnia. *Sleep Medicine Reviews*, 19, 6-16.

Lacomte, T., Leclerc, C., Wykes, T., Nicole, L., & Baki, A. A. (2015). Understanding process in group cognitive behaviour therapy for psychosis. *Psychology and Psychotherapy*, 88(2), 163-177.

Lau, W., Chan, C. K., Li, J. C., & Au, T. K. (2009). Effectiveness of group cognitive-behavioral treatment for childhood anxiety in community clinics. *Behaviour Research and Therapy*, 48(11), 1067-1077.

Lima, L. de O. (2005). *Dinâmicas de grupo na empresa, no lar e na escola: Grupos de treinamento para a produtividade*. Petrópolis: Vozes.

Lucchiari, D. H. P. S. (1993). Planejamento por encontros. In D. H. P. S. Lucchiari (Org.), *Pensando e vivendo a orientação profissional* (2. ed., pp. 22-34). São Paulo: Summus.

Luz, J. M. O., Murta, S. G., & Aquino, T. A. A. (2015). Programas de promoção de saúde mental em grupo para adolescentes. In C. B. Neufeld (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes* (pp. 52-71). Porto Alegre: Artmed.

Luz, F. Q., & Oliveira, M. S. (2013). Terapia cognitivo-comportamental da obesidade: Uma revisão da literatura. *Aletheia*, 40, 159-173.

Marcellino, N. C. (2002). *Repertório de atividades de recreação e lazer* (3. ed.). Campinas: Papirus.

Mayer, C. (2005). *Dinâmica de grupo: Ampliando a capacidade de interação*. Campinas: Papirus.

McEvoy, P. M., Nathan, P., Rapee, R. M., & Campbell, B. N. C. (2012). Cognitive behavioural group therapy for social phobia: Evidence of transportability to community clinics. *Behaviour Research and Therapy*, 50(4), 258-265.

Melo, W. V., Bergmann, C., Neufeld, C. B., Machado, P. P. P., & Conceição, E. (2014). A terapia cognitivo-comportamental e a cirurgia bariátrica como tratamentos para a obesidade. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 10(2), 84-92.

Milicic, N. (1994). *Abrindo Janelas*. Campinas: Editorial Psy II.

Miranda, S. (2000). *Essa você aprende brincando: Atividades recreativas para sala de aula* (3. ed.). Campinas: Papirus.

Mörtberg, E., Clark, D. M., & Bejerot, S. (2011). Intensive group cognitive therapy and individual cognitive therapy for social phobia: Sustained improvement at 5-year follow-up. *Journal of Anxiety Disorders*, 25(8), 994-1000.

Moscovici, F. (1997). *Desenvolvimento interpessoal: Treinamento em grupo* (7. ed.). Rio de Janeiro: José Olympio.

Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.

- Neufeld, C. B. (2015). *Aspectos distintivos de las terapias cognitivo conductuales en grupos*. Anais del Congreso Español de Psicología Clínica.
- Neufeld, C. B. (Org.). (2014). *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos*. Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Affonso, G., & Moreno, A. L. (2014b) PRO-META: Programa Cognitivo-Comportamental de Educação Alimentar em Grupo. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 44-79). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Daolio, C. C., Cassiano, M., Rossetto, C. P. F., & Cavenage, C. C. (2014a). PRHAVIDA – Programa Cognitivo-Comportamental de Habilidades de Vida para crianças e adolescentes. In Neufeld C. B. (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 80-115). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., & Godoi, K. (2014). PROPAIS I – Tópicos cognitivo-comportamentais de orientação de pais em contexto de atendimento clínico. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 116-147). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., & Maehara, N. P. (2011). Um programa cognitivo-comportamental de orientação de pais em grupo. In M. G. Caminha, & R. M. Caminha (Org.), *Intervenções e treinamento de pais na clínica infantil* (pp. 149-174). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Oei, T. P. S., & Browne, A. (2006). Components of group processes: Have they contributed to the outcome of mood and anxiety disorder patients in a group cognitive-behaviour therapy program? *American Journal of Psychotherapy*, 60(1), 53-70.
- Okumura, Y., & Ichikura, K. (2014). Efficacy and acceptability of group cognitive behavioral therapy for depression: a systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 164, 155-164.
- Osório, L. C. (2003). *Psicologia grupal: Uma nova disciplina para o advento de uma era*. Porto Alegre: Artmed.
- Pereira, W. C. C. (2000). *Dinâmica de grupos populares* (16. ed.). Petrópolis: Vozes.
- Pinzon, V., Gonzaga, A. P., Cabelo, A., Labaddia, E., Belluzzo, P., & Fleitlich-Bilyk, B. (2004). Peculiaridades do tratamento da anorexia e da bulimia nervosa na adolescência: a experiência do PROTAD. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 31(4), 167-169.
- Rees, C. S., McEvoy, P., & Nathan, P. R. (2005). Relationship between homework completion and outcome in cognitive behaviour therapy. *Cognitive Behaviour Therapy*, 34(4), 242-247.
- Register, D. M., & Hilliard, R. E. (2008). Using orff-based techniques in children's bereavement groups: A cognitive-behavioral music therapy approach. *The Arts in Psychotherapy*, 35(2), 162-170.
- Reis, A. H., Schwab, J. A., & Neufeld, C. B. (2014). Relato de experiência de terapia cognitivo-comportamental em grupo com pacientes amputados. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 16(2), 148-164.
- Renjilian, D. A., Perri, M. G., Nezu, A. M., McKelvey, W. F., Shermer, R. L. & Anton, S. D. (2001). Individual versus group therapy for obesity: effects of matching participants to their treatment preferences. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(4), 717-721.
- Serrão, M., & Baleiro, M. C. (1999). *Aprendendo a ser e a conviver*. São Paulo: FTD.

- Siddons, H. M., Wootten, A. C., & Costello, A. J. (2013). A randomised, wait-list controlled trial: evaluation of a cognitive-behavioural group intervention on psycho-sexual adjustment for men with localised prostate cancer. *Psycho-Oncology*, 22, 2186–2192.
- Silva, R. C. (2002). *Metodologias participativas para trabalhos de promoção de saúde e cidadania*. São Paulo: Vetor.
- Stallard, P. (2004). *Bons pensamentos-bons sentimentos: Manual de terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes*. Porto Alegre: Artmed.
- Sugiura, T., Kaneko, N., Yamada, Y., & e Oda, T. (1998). *Introdução a jogos de treinamento para equipes*. Rio de Janeiro: Qualitymark.
- Taube-Schiff, M., Suvak, M. K., Antony, M. M., Bieling, P. J., & McCabe, R. E. (2007). Group cohesion in cognitive-behavioral group therapy for social phobia. *Behaviour Research and Therapy*, 45(4), 687-698.
- Tucker, M., & Oei, T. P. S. (2007). Is group more cost effective than individual cognitive behaviour therapy? The evidence is not solid yet. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 35(1), 77-91.
- Van Noppen, B. L., Pato, M. T., Marsland, R., & Rasmussen, S. A. (1998). A time-limited behavioral group for treatment of obsessive-compulsive disorder. *The Journal of Psychotherapy Practice and Research*, 7(4), 272-280.
- Varo, M. L. B., Fernández, M. D. O., Cobos, F. M., Gutiérrez, P. V., & Aragón, R. B. (2006). Intervención grupal en los trastornos de ansiedad en Atención Primaria: Técnicas de relajación y cognitivo-conductuales. *SEMERGEN*, 32(5), 205-210.
- Vidal, R., Bosch, R., Nogueira, M., Gómez-Barros, N., Valero, S., Palomar, G., ... Ramos-Quiroga, J. A. (2013). Psychoeducation for adults with attention deficit hyperactivity disorder vs. cognitive behavioral group therapy a randomized controlled pilot study. *The Journal of Nervous and Mental Disease*, 201(10), 894-900.
- Virgolin, A. M. R. (1999). *Toc, toc... Plim, Plim. Lidando com as emoções, brincando com o pensamento através da criatividade*. Campinas: Papirus.
- Weck, F., Gropalis, M., Hiller, W., & Bleichhardt, G. (2015). Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy for patients with hypochondriasis (health anxiety). *Journal of Anxiety Disorders*, 30, 1-7.
- Wesner, A. C., Gomes, J. B., Detzel, T., Guimarães, L. S. P., & Heldt, E. (2015). Booster sessions after cognitive-behavioural group therapy for panic disorder: impact on resilience, coping, and quality of life. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 43(5), 513-525.
- White, J. R., & Freeman, A. S. (2003). *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para populações e problemas específicos*. São Paulo: Roca.
- Wuthrich, V. M., & Rapee, R. M. (2013). Randomised controlled trial of group cognitive behavioural therapy for comorbid anxiety and depression in older adults. *Behaviour Research and Therapy*, 51(12), 779-786.
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2008). *The theory and practice of group psychotherapy* (5th ed.). New York: Basic Books.

PARTE II

GRUPOS EM DIFERENTES DEMANDAS



3



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Bernard P. Rangé
Priscila de Camargo Palma
Marcele Regine de Carvalho
Maria Amélia Penido
Fernanda Corrêa Coutinho
Angélica Gurjão Borba

Os transtornos de ansiedade incluem aqueles relacionados a medo e ansiedade excessivos e aos seus efeitos cognitivos, comportamentais e emocionais. O medo é entendido como uma resposta a uma ameaça real ou percebida, e a ansiedade é a antecipação de uma ameaça. Os transtornos de ansiedade diferem entre si em relação aos tipos situações que geram medo e ansiedade ou evitação e na ideação cognitiva associada.

Os transtornos de ansiedade trazem prejuízos significativos no funcionamento de muitas pessoas, atingindo 28,8% de prevalência de vida entre adultos norte-americanos (Kessler, Chiu, Demler, Merikangas, & Walters, 2005). O artigo brasileiro mais citado é o de Almeida-Filho e colaboradores (1997), que estimou a prevalência dos transtornos de ansiedade em três cidades brasileiras (Brasília, São Paulo e Porto Alegre), apontando uma prevalência de vida deles de 17,6, 10,6 e 9,6%, respectivamente, devendo ser incluídos também os estados fóbicos, na ordem de 16,7, 7,6 e 14,1%. Entretanto, esses dados são baseados na terceira edição do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-III).

O DSM-5 excluiu dois quadros dos transtornos de ansiedade: o transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) e o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT), que constituíram quadros específicos. Assim, restaram o transtorno de pânico (TP), a agorafobia (AGO), o transtorno de ansiedade generalizada (TAG), o transtorno de ansiedade social (TAS) e as fobias específicas (FEs). Tomando por base o funcionamento eficiente das FEs, em que raramente o indivíduo procura ajuda, e, quando o faz, acaba sendo atendido individualmente, iremos nos ater ao TP, à AGO, ao TAG e ao TAS (American Psychiatric Association [APA], 2014).

O TAG é descrito como o transtorno de ansiedade “básico”. Recebe essa classificação porque a ansiedade apresentada não se relaciona a questões específicas, como no TP, em que há medo das sensações corporais; na AGO, que envolve o medo de estar em situações em que a fuga seja difícil; e no TAS, em que há medo de ser avaliado negativamente por outras pessoas, conforme será visto a partir dos critérios diagnósticos que serão apresentados adiante para cada um desses transtornos.

Do ponto de vista do modelo cognitivo desses transtornos, o esquema básico é o de vulnerabilidade: pacientes com esses quadros se sentem ameaçados com a ideia de morrer, como no TP; de não poder ir a hospitais ou sair de locais em que estejam presos (como elevadores, aviões ou trânsito), como na AGO; de ser avaliado negativamente, como no TAS; ou de ficar muito apreensivo com duas ou mais fontes de preocupação, como desempenho profissional ou acadêmico, saúde ou segurança, como no TAG.

TRANSTORNO DE ANSIEDADE SOCIAL

Entre os transtornos de ansiedade, o TAS é um dos mais comuns (Hofmann et al., 2013; Santos Filho, 2010), com uma prevalência de 6,8% (Arnold Anteraper et al., 2014). Estima-se que a prevalência na população em geral também seja alta, em torno de 5 a 13% (Book & Randall, 2002; Nardi, 2000). Hoje, o TAS é categorizado como medo de agir de maneira a evidenciar sintomas de ansiedade, os quais podem ser alvo de avaliação e julgados de forma negativa por outras pessoas, levando à rejeição do indivíduo ou à ofensa de terceiros (APA, 2014). O medo de humilhação e constrangimento está presente em muitos pacientes com TAS, mas não em todos. Alguns apresentam medo de ofender outras pessoas ou de se expressar emocionalmente, acreditando que isso pode ser um sinal de fraqueza que acarretará rejeição social (Heimberg et al., 2014).

Os pacientes com TAS não se sentem habilitados socialmente e se percebem como incompetentes, acreditando que serão sempre alvo de rejeição e humilhação (Moscovitch, Suvak, & Hofmann, 2010). A partir disso, quando um indivíduo ingressa em uma situação social, são ativadas percepções de alta probabilidade de falhas no desempenho, e, conseqüentemente, a situação passa a ser percebida como um ambiente potencial para ser alvo de escrutínio. Essas percepções desencadeiam sintomas cognitivos, comportamentais e somáticos, e essa rede de sintomas provoca desvio da atenção do ambiente para dentro de si próprio, mantendo o ciclo de ativação ansiosa (Makkar & Grisham, 2011). Os sintomas somáticos mais encontrados são: rubor, sudorese, palpitações/taquicardia, tremor, distúrbios gastrintestinais, bloqueio da fala e dor de cabeça (Araújo, Ronzani, & Lourenço, 2010; Santos Filho, 2010).

Além desse modo de funcionamento, os pacientes com TAS caracterizam-se por serem inibidos e autocríticos, comportando-se de maneira rígida e tensa, o que acarreta prejuízos reais em seu desempenho social (Clark & Beck, 2012). Sabe-se que indivíduos com intenso medo e/ou desconforto em situações sociais e/ou de desempenho se sentem expostos e inseguros com a

impressão que os outros formarão deles, temendo um possível escrutínio (Schneier, Heimberg, Liebowitz, Blanco, & Gorenstein, 2012).

Em função da autoimagem negativa, os pacientes com TAS passam a examinar seu ambiente em busca de evidências que confirmem sua avaliação depreciativa. Ao encontrarem indícios que reafirmam a estimativa negativa de seu desempenho, todo seu foco atencional permanece sobre esses pequenos indicativos, concentrando todos os recursos atencionais na possível ameaça. Com isso, outras evidências que poderiam modificar a visão distorcida não são percebidas (Rappe & Heimberg, 1997).

Com a finalidade de auxiliar os pacientes que sofrem com o TAS, algumas formas de intervenção são recomendadas, como psicoterapias e tratamento medicamentoso. Estudos apontam que a terapia cognitivo-comportamental (TCC) tem-se mostrado muito eficaz para indivíduos com o transtorno (Hedman et al., 2011; Jorstad-Stein & Heimberg, 2009), com resultados imediatos e também duradouros. Dentro dessa perspectiva, a modalidade em grupo é a que mais vem sendo aplicada e estudada nessa população (Antón, Olivares, & Amorós-Boix, 2012), tendo mostrado também sua eficácia a curto e longo prazos (Heimberg & Becker, 2002; Rodebaugh, Holaway, & Heimberg, 2004).

Existem vários modelos teóricos eficazes para intervenções no TAS. Os modelos mais difundidos na literatura são os propostos por Clark e Wells (1995), Heimberg e Becker (2002) e Hofmann e Otto (2008), os quais serão descritos a seguir.

O modelo cognitivo-comportamental proposto por Clark e Wells (1995) sugere que a psicopatologia do TAS, assim como seu desenvolvimento, são mantidos pelos pensamentos disfuncionais ou mal-adaptativos e por processos comportamentais, bem como pelos processos de evitação que mantêm o círculo vicioso negativo. Quando o indivíduo com TAS inicia uma situação social, várias suposições negativas sobre ele mesmo são ativadas, as quais são baseadas em experiências anteriores e levam à avaliação da situação como perigosa (Clark, 2001).

Quatro processos de manutenção são destacados nesse modelo. Primeiramente, o viés de atenção vai para si próprio, e, conseqüentemente, há

redução do *feedback* externo, impossibilitando quaisquer formas de questionamento dos pensamentos automáticos. O segundo processo é o uso de informações endógenas enganosas, como sensações, sentimentos e pensamentos ansiogênicos, para interpretar a situação temida. O terceiro foca no uso excessivo de comportamentos de segurança com o objetivo de prevenir catástrofes temidas e reduzir o risco de rejeição; contudo, sua principal consequência é a manutenção do sistema de crenças negativistas, aumentando os sintomas ansiogênicos nas situações temidas. Por fim, o quarto processo é a ansiedade antecipatória e o processamento pós-evento (Stangier, Heidenreich, Peitz, Lauterbach, & Clark, 2003).

O modelo de intervenção, tanto em grupo como individual, se propõe a trabalhar com os processos de manutenção. Para alcançar tal objetivo, o paciente precisa entender de forma idiossincrática esse modelo. É preciso ensinar o indivíduo a manipular sistematicamente sua atenção e demonstrar os efeitos negativos do uso excessivo de comportamentos de segurança. Uma das formas de fazer isso é usando vídeos, ou mesmo áudios, para o paciente observar a si mesmo e, assim, planejar formas de corrigir os pontos deficitários, bem como flexibilizar os pensamentos distorcidos. Além disso, são realizados experimentos comportamentais das situações temidas, a fim de testar suas previsões catastróficas (Clark & Wells, 1995).

O modelo proposto por Heimberg e Becker (2002) parte da noção de que os indivíduos com TAS dão importância fundamental ao recebimento de avaliação positiva, mas tendem a supor que as outras pessoas são inerentemente críticas e que, com isso, poderão avaliá-los de modo negativo. Além disso, ao se encontrar em uma situação social ou mesmo de desempenho, o indivíduo faz uma representação mental de sua aparência e de seu comportamento como presumivelmente vistos pelo público e, ao mesmo tempo, concentra-se apenas nessas representações internas e em qualquer ameaça percebida.

Em conjunto com a alocação de recursos atencionais a ameaças externas e as representações mentais de sua aparência e seu comportamento, o indivíduo tende a formular uma previsão de como seu desempenho está sendo avaliado. A representação de como o indivíduo acredita que seu desempenho está

sendo avaliado, comparada ao que o ansioso social esperava (supostos padrões situacionais), fornece uma estimativa de falha no desempenho. Essa previsão negativa provoca mais ansiedade e mais respostas fisiológicas, comportamentais e cognitivas que influenciam as representações mentais, fazendo o ciclo se renovar (Rapee & Heimberg, 1997).

Um dos protocolos mais utilizados para obtenção de respostas eficazes é o protocolo de Heimberg e Becker (2002), que postula que os indivíduos com TAS apresentam crenças inadequadas em relação a si mesmos e aos outros, e, em situações sociais, essas cognições desadaptativas são ativadas (Heimberg, Brozovich, & Rapee, 2010) (o protocolo está descrito com mais detalhes na Tab. 3.1).

Tabela 3.1 Principais protocolos de TCCG citados

Protocolo	Transtorno a ser tratado	Número de participantes	Número de sessões	Temática das sessões
Heimberg e Becker (2002)	Transtorno de ansiedade social	6 pacientes	12 sessões com duração de 1h30min	• Primeira etapa: psicoeducação, visão geral do tratamento, aspectos motivacionais e construção da aliança terapêutica • Segunda etapa: identificação dos pensamentos automáticos distorcidos, emoções • Terceira etapa: reestruturação cognitiva • Quarta etapa: exposições • Quinta etapa: previsão de riscos e respostas para enfrentamento; prevenção de recaída
Hofmann e Otto (2008)	Transtorno de ansiedade social	4-6 pacientes	12-16 sessões com duração de 2h	• Primeira etapa: psicoeducação sobre o TAS, funcionamento da ansiedade e a manutenção do ciclo por meio da evitação e das estratégias de esquiva • Segunda etapa: vídeo <i>feedback</i>; exposição em frente ao espelho • Terceira etapa: prática de exposição em sessão, vídeo <i>feedback</i> • Quarta etapa: preparação para as exposições sociais fora da sessão e prevenção de recaída
Stanley e colaboradores (2003)	Transtorno de ansiedade generalizada	4-6 pacientes	15 sessões com duração de 1h30min	Psicoeducação sobre TAG, identificação e monitoramento dos sintomas, relaxamento muscular progressivo, reestruturação cognitiva e exposição gradual com hierarquia de 10 situações
Wetherell, Gatz e Craske (2003)	Transtorno de ansiedade generalizada	4-6 pacientes	12 sessões com duração de 1h30min	Psicoeducação sobre a natureza e o funcionamento da ansiedade, monitoramento dos sintomas em situação de ansiedade, treino de relaxamento, reestruturação cognitiva, exposição à preocupação mediante dessensibilização sistemática imaginária e <i>in vivo</i> e prevenção do comportamento de se preocupar excessivamente
Craske e Barlow (1993)	Transtorno de pânico		12 sessões	Psicoeducação, reestruturação cognitiva, exposição interoceptiva e ao vivo, estratégias de respiração e relaxamento e prevenção de recaída

Rangé e Borba (2008, 2016)	Transtorno de pânico	6-8 pacientes	8 sessões com duração de 2h	• Primeira etapa: psicoeducação, modelo cognitivo, aliança terapêutica, descrição da fisiologia e da psicologia do medo e ansiedade; estratégia “acalme-se” • Segunda etapa: aquisição de habilidades de manejo do medo e ansiedade por meio de estratégias cognitivas, comportamentais, corporais e assertividade • Terceira etapa: reorientação existencial e prevenção de recaída
----------------------------	----------------------	---------------	-----------------------------	--

O modelo proposto por Hofmann e Otto (2008) propõe que a ansiedade social se desenvolve e se mantém por distorções cognitivas e estratégias comportamentais que reforçam negativamente a utilização de estratégias de evitação e esquiva, contribuindo para o ciclo de ansiedade e evitação. De acordo com esse modelo, um indivíduo com TAS apresenta apreensão social ao iniciar uma situação social em função da percepção de que as expectativas sociais são elevadas e de uma crença de incapacidade ou mesmo dúvida sobre sua capacidade de suprir tais expectativas. Após essa experiência, os indivíduos passam a ter experiências de maior atenção autofocada, com foco nos sintomas, no pensamento e nas sensações ansiosas, bem como sensação de pouco controle emocional. Por sua vez, esses processos levam o paciente a antecipar a previsão de um acidente social, causando uma situação embaraçosa para si mesmo (Fang, Sawyer, Asnaani, & Hofmann, 2013), o que contribui para a utilização de estratégias de esquiva e fuga e leva a ruminação pós-evento (Clark & Wells, 1995).

Os indivíduos com TAS apresentam vários comportamentos de segurança com o objetivo de reduzir o risco de rejeição, ou mesmo de passar momentos vergonhosos. Essas tendências de utilização de comportamentos de segurança evitam que os pacientes consigam avaliar criticamente seus resultados, impedindo uma avaliação real sobre os resultados temidos *versus* os resultados alcançados e também sobre suas crenças catastróficas. Esse sistema leva à manutenção do TAS.

As intervenções baseadas nesse modelo de tratamento lançam o foco para técnicas de exposições. O objetivo das exposições é violar propositalmente as normas e os padrões sociais percebidos pelos pacientes, com a intenção de quebrar o ciclo autorreforçador negativo e a antecipação temerosa, possibilitando a reavaliação sobre a possível ameaça e sobre as possíveis

dificuldades sociais encontradas (Fang et al., 2013; Hofmann, 2000). Além disso, mudanças no foco atencional sobre os aspectos negativos consistiram em um preditor de mudanças para indivíduos com TAS sobre o medo de corar, tremer e suar ao longo das exposições (Morrison & Heimberg, 2013).

Além disso, a superestimação dos custos sociais associados a situações embaraçosas é uma característica marcante nos pacientes, e, por meio das técnicas de exposição, é possível trabalhar essa superestimação associada a acidentes sociais. Isto é, durante a exposição, o indivíduo tende a se comportar de uma maneira que faz o acidente social, ou mesmo uma situação embaraçosa, acontecer propositalmente, violando as normas sociais preestabelecidas anteriormente por ele mesmo. Essa técnica permite que o paciente experimente a situação temida e evidencie que catástrofes sociais com resultados críticos são improváveis; além disso, lhe permite perceber que é capaz de lidar com situações socialmente desafiadoras, quebrando o ciclo de autorreforço e da antecipação ansiosa. Dados de pesquisas mostram que os protocolos que incorporam exposições de situações sociais desagradáveis apresentam grande eficácia (Hofmann & Smits, 2008).

Diversos estudos têm-se dedicado a demonstrar a eficácia das intervenções em TCC em grupo (TCCG). Heimberg, Salzman, Holt e Blendell (1993) demonstraram que os pacientes mantiveram seus ganhos mesmo após o fim do tratamento, sendo realizadas avaliações posteriores a 4 e 6 anos de intervenção. Também foi constatado que a intervenção em TCC aumentou as crenças relativas à autoeficácia de pacientes com TAS, diminuindo, assim, os sintomas do transtorno e produzindo redução imediata e de longo prazo nos sintomas de ansiedade social.

EFICÁCIA DA TCCG PARA TAS

Estudos têm indicado que a intervenção em grupo é a mais indicada para o tratamento do TAS, tendo em vista que o próprio grupo proporciona um espaço para interação social. Sabe-se que os ansiosos sociais tendem a não compartilhar seus medos em função do receio do julgamento dos outros; com isso, acreditam que são os únicos que sofrem com essa gama de sintomas (Picon & Knijnenik, 2008). Com a intervenção em grupo, é possível realizar

momentos de exposição, assim como de redução do isolamento social, e o compartilhamento de experiências, evidenciando aos pacientes que eles não são os únicos que sofrem (Hofmann, 2004). Indivíduos com TAS muitas vezes acreditam ter um segredo ou material cognitivo emocional que nunca compartilharam anteriormente; imaginam que outras pessoas não passam pelos mesmos problemas que eles e que o TAS é uma característica de personalidade que não pode ser mudada. A terapia em grupo, ao permitir que o paciente escute outros com o mesmo problema, possibilita a reestruturação dessas crenças e a mudança para uma postura mais ativa no tratamento, instalando esperança e propiciando um ambiente favorável à coesão grupal (Picon & Penido, 2011).

Alguns estudos evidenciam que entre 12 e 20 sessões semanais em grupo são suficientes para a redução significativa de sintomatologia de ansiedade (Nutt & Ballenger, 2010). Sabe-se que os ganhos obtidos a partir da intervenção em grupo podem ser mantidos por até cinco anos de seguimento (Heimberg et al., 1993). Os benefícios do tratamento em grupo incluem maior facilidade em simular situações sociais e realizar exposições e dramatizações, constante exposição do próprio grupo, apoio mútuo dos participantes e aprendizagem vicária durante as dramatizações dos outros membros do grupo (Heimberg, Juster, Hope, & Mattia, 1995). Já as desvantagens potenciais do tratamento coletivo são relacionadas à possibilidade de direcionar menos atenção aos problemas e às crenças disfuncionais individuais, bem como de intensificar a probabilidade de comportamentos de esquiva e evitação do próprio grupo (Scholing & Emmelkamp, 1993).

Estudos recentes têm investigado a diferença entre as TCCs em grupo e individual em fatores específicos do modelo cognitivo, como medo de avaliação negativa, intolerância à incerteza, esquiva, atenção autofocada, processamento antecipatório e pós-evento. Em um estudo realizado por Dogaheh, Mohammadkhani e Dolatshahi (2011), que comparou a TCCG com a TCC individual para TAS, avaliando especificamente o impacto na redução do medo da avaliação negativa, os resultados indicaram que a melhora nos sintomas ocorreu nos dois grupos, porém o grupo de TCCG foi mais efetivo

em reduzir o medo de avaliação negativa. Outro estudo, realizado por Mahoney e McEvoy (2012), avaliou a mudança na variável intolerância à incerteza em pacientes com TAS submetidos a TCCG. O estudo incluiu 32 sujeitos, e os resultados encontrados indicaram melhora significativa nos sintomas de TAS e depressão, assim como redução na variável intolerância à incerteza, que apareceu associada a redução nos sintomas de TAS. Hedman e colaboradores (2013) avaliaram se mudanças nos quatro fatores de manutenção (esquiva, atenção autofocada, processamento antecipatório e pós-evento) aparecem associados a melhora no tratamento individual e em grupo do TAS. A pesquisa investigou 94 pacientes submetidos à TCC, tanto no formato individual como no grupal. Os resultados gerais indicaram melhora significativa no tratamento individual em comparação ao formato grupal. Em relação aos fatores específicos, a melhora na modalidade individual foi mediada por mudança na esquiva e na atenção autofocada, e na modalidade em grupo, por mudança nos fatores atenção autofocada e processamento pré e pós-evento.

Uma metanálise realizada por Mayo-Wilson e colaboradores (2014) comparando diferentes tratamentos para TAS concluiu que o tratamento cognitivo-comportamental individual e em grupo é mais efetivo que terapia psicodinâmica, *mindfulness* e terapia de suporte social. Outra metanálise, realizada por Bandelow e colaboradores (2015), investigando TCC para transtornos de ansiedade, encontrou o mesmo resultado, sendo a TCC individual considerada mais efetiva que placebo e lista de espera.

A TCC tem eficácia bem estabelecida tanto no tratamento individual quanto em grupo para TAS; porém, ainda assim, muitos desafios precisam ser superados. Deve-se investigar os componentes específicos do tratamento que predizem um melhor resultado, bem como quais grupos de pacientes se beneficiam mais de cada intervenção, aspectos importantes para uma prática clínica baseada em evidências.

TRANSTORNO DE ANSIEDADE GENERALIZADA

O TAG é caracterizado pela presença de ansiedade excessiva e preocupações incontroláveis (Heiden, Muris, & Molen, 2012) com diversos eventos, tanto internos como externos, sendo que a magnitude, a permanência e a frequência da ansiedade e da preocupação são incongruentes com o evento temido (APA, 2014). Outra característica marcante são os pensamentos incontroláveis sobre situações negativas comuns da vida, presentes em dois ou mais domínios de atividades, as quais geram intenso desconforto emocional (Bomyea et al., 2015). Normalmente, os sintomas aparecem combinados com várias queixas somáticas (Cuijpers et al., 2014).

Para o TAG ser diagnosticado, alguns critérios devem ser levados em consideração, como presença de ansiedade e preocupação excessiva, dificuldade de controlar a preocupação e associação com pelo menos três dos seguintes sintomas: inquietação ou sensação de nervos à flor da pele, fadiga, dificuldade de se concentrar ou sensação de branco, irritabilidade, tensão muscular e perturbação do sono. Esse conjunto de sintomas deve estar presente por pelo menos seis meses (APA, 2014). Segundo a *Classificação internacional de doenças e problemas relacionados à saúde* (CID-10), os sintomas do TAG são mais relacionados a excitação fisiológica, como tremores, sudorese, palpitações, vertigens, nervosismo, tensão muscular e desconforto epigástrico (Organização Mundial da Saúde [OMS], 1993). O TAG foi rotulado como um transtorno básico, tendo em vista que suas características fundamentais estão presentes em quase todos os transtornos emocionais (Newman, Llera, Erickson, Przeworski, & Castonguay, 2013).

O TAG vem sendo alvo de muitos estudos em função do tamanho do prejuízo na qualidade de vida dos pacientes, sendo considerado um transtorno crônico, o qual gera grande sofrimento, incapacidade e também dificuldades médicas. Normalmente, tem duração de mais de 20 anos, com taxas elevadas de recaídas (estima-se que mais de 50% dos pacientes tenham novas recaídas ao longo da vida) e alta prevalência (Cuijpers, et al., 2014; Hanrahan, Field, Jones, & Davey, 2013), afetando significativamente o funcionamento psicossocial do paciente e sua qualidade de vida (Théberge-Lapointe, Marchand, Langlois, Gosselin, & Watts, 2015).

O National Comorbidity Survey Replication (NCS-R) constatou a prevalência de 5,7% de TAG ao longo da vida em indivíduos norte-americanos; estudos europeus constataram até 6,9%; e um estudo brasileiro constatou que 19,9% da população em geral tem transtorno de ansiedade, sendo 2,3% diagnosticados com TAG (Vasconcelos, Lôbo, & Melo Neto, 2015). Já outros estudos apontam a prevalência entre 1,5 e 3% na população em geral, e a prevalência ao longo da vida pode chegar a 5% (Kessler & Wittchen, 2002; Théberge-Lapointe et al., 2015). Com relação à saúde primária, o TAG é um dos transtornos de ansiedade mais comumente observados, com prevalência entre 3,7 e 8% e de 10,3% durante 12 meses. A idade de início da condição normalmente é por volta dos 30 anos. Além disso, trata-se do transtorno mais comum em adultos acima dos 60 anos. A prevalência do TAG nesses indivíduos é de 19%, levando a grande comprometimento na qualidade de vida (Jones, Hadjistavropoulos, & Soucy, 2016). A prevalência do transtorno em mulheres é maior que em homens; aquelas têm 5,3% de prevalência ao longo da vida, estes, de 2,8% (Newman et al., 2013).

Estudos evidenciam que o TAG é um importante preditor de transtornos secundários. O transtorno depressivo maior é uma das comorbidades mais frequentes, e um estudo sugeriu que ambas as condições apresentam a mesma origem genética (Kendler, Gardner, Gatz, & Pedersen, 2007). A comorbidade com o transtorno depressivo maior é 20 vezes mais recorrente em pacientes com TAG em comparação à população em geral, e os pacientes com ansiedade generalizada apresentam 33 vezes mais risco do que a população em geral de experimentar episódios de pânico e piora de prognósticos de doenças físicas crônicas, como alterações fisiológicas cardíacas a partir de respostas emocionais exacerbadas a estímulos do ambiente. Além disso, sabe-se que a presença de comorbidades agrava o prognóstico do transtorno, acarretando mais prejuízo social e piorando a qualidade de vida (Heiden, et al., 2012; Vasconcelos, et al., 2015). Outro aspecto que merece destaque é o fator de risco relacionado ao suicídio; indivíduos com TAG correm maior risco de cometer suicídio e de tentá-lo (Newman et al., 2013).

A etiologia do transtorno engloba uma vulnerabilidade biológica e fatores ambientais. Uma metanálise com estudos entre famílias indicou que existe uma associação significativa entre TAG e vulnerabilidade biológica nos parentes de primeiro grau, apoiando o componente familiar em relação ao TAG (Hettema, Neale, & Kendler, 2001). Com relação às variáveis ambientais, acredita-se que o desenvolvimento esteja associado à ocorrência de eventos negativos e inesperados ao longo da vida, como maus-tratos ou perdas de entes queridos. Esses eventos negativos podem levar os indivíduos a questionar sua visão de mundo e desenvolver um processo de aversão ao contraste emocional devido a inconsistência e falta de previsibilidade sobre situações negativas inesperadas. Pode-se dizer que o apego inseguro e a desregulação emocional são fatores de risco importantes para o desenvolvimento de TAG (Newman et al., 2013).

Uma série de modelos tenta explicar o funcionamento do transtorno. Segundo Wells (1995), as crenças relacionadas a preocupações são normalmente negativas, as quais resultam em preocupações sobre se preocupar, e estas desempenham um papel fundamental na manutenção do transtorno. O modelo metacognitivo propõe que, inicialmente, as preocupações não são patológicas, mas parte do funcionamento normal do ser humano, e podem ser vistas como uma tentativa de planejar formas de enfrentamento e de resolução de problemas de situações ameaçadoras. Contudo, indivíduos com TAG apresentam crenças negativas a respeito de incontrolabilidade e periculosidade das preocupações, as quais apresentam grande impacto no transtorno; ou seja, a preocupação em si não é patológica, as crenças negativas passam a ser patológicas quando se tornam inflexíveis e persistentes (Heiden et al., 2012).

Uma vez ativadas as crenças sobre preocupação em se preocupar, os - pacientes experimentam elevação da ansiedade e aumento de pensamentos ansiogênicos, os quais conduzem à utilização contraproducente de estratégias de prevenção e comportamentos de segurança que reforçam as crenças sobre a incontrolabilidade das preocupações, diminuindo, assim, a confiança dos indivíduos em si mesmos e confirmando a hipótese de que se manter preocupado é perigoso (Wells, 2010). Segundo esse modelo, a avaliação

negativa da preocupação (metacognição) e as crenças negativas sobre a preocupação são centrais para o desenvolvimento da psicopatologia. Com isso, uma forma terapêutica para reduzir o prejuízo desse ciclo seria intervir sobre as crenças metacognitivas, produzindo uma diminuição das preocupações e uma reavaliação das crenças e desenvolvendo novas crenças e formas de enfrentamento saudáveis (Hanrahan et al., 2013).

Outro modelo proposto é o modelo cognitivo de intolerância à incerteza (Dugas, Gagnon, Ladouceur, & Freeston, 1998). Ele propõe que os pacientes com TAG experimentam sintomas de ansiedade quando confrontados com situações incertas ou ambíguas e, em resposta a tais situações, apresentam preocupações persistentes com as implicações da situação incerta (Dugas & Robichaud, 2007). A intolerância à incerteza está relacionada ao medo do desconhecido; o “não saber” funciona como um gatilho para preocupações, sugerindo que a preocupação com a incerteza pode ser ameaçadora, estressante e, assim, provocar reações de ansiedade que acionam interpretações tendenciosas da situação. Indivíduos que experimentam a intolerância à incerteza consideram os eventos negativos como inaceitáveis e ameaçadores, independentemente da probabilidade real de o evento ocorrer ou não (Carleton, Norton, & Asmundson, 2007).

Em resposta a situações incertas, os pacientes apresentam preocupações crônicas respaldadas na crença de que preocupar-se irá ajudá-los a lidar de maneira eficaz com os possíveis problemas, impedindo formas saudáveis de resolução de problemas e tomada de decisão (Heiden et al., 2012). Uma das formas terapêuticas é a reavaliação das crenças, reconhecendo o papel da intolerância, além de exposição imaginária sobre formas de lidar com os medos e encorajamento de exposições comportamentais a situações incertas (Hanrahan et al., 2013).

Outro modelo é o de evasão cognitiva (Borkovec & Costello, 1993), que propõe que a preocupação crônica leva à evasão cognitiva, ou seja, à utilização de estratégias para evitar pensamentos ameaçadores, como distração (Bomyea et al., 2015). A preocupação funciona como uma forma de prevenir que eventos ruins aconteçam ou mesmo de preparar-se para seu acontecimento, evitando processos emocionais desconfortáveis. A partir da

estratégia de evitação, é realizada a manutenção da preocupação, impedido que processos de extinção de resposta de ansiedade aconteçam. Tendo em vista o processamento de evitação emocional dos indivíduos diagnosticados com TAG, o tratamento proposto por esse modelo faz uso de técnicas de exposição das emoções evitadas, levando à habituação destas e, conseqüentemente, à diminuição da preocupação, proporcionando alívio do sofrimento e melhora na qualidade de vida (Newman & Llera, 2011).

Sabe-se que a TCC apresenta resultados significativos com relação à melhora de pacientes com TAG. Com isso, ela vem sendo considerada como tratamento de primeira linha, tendo em vista a possibilidade de modificar condições que são relacionadas tanto ao início como à manutenção do transtorno. Vários estudos têm mostrado que a TCC pode levar a melhoras estatisticamente significativas e grandes tamanhos de efeito em pacientes com TAG (Covin, Ouimet, Seeds, & Dozois, 2008). No momento, poucos estudos têm sido realizados sobre o tratamento em grupo. Contudo, segundo Dugas e colaboradores (2003), os participantes tratados em TCCG evidenciaram melhoras significativas, e os ganhos obtidos ao longo do processo foram mantidos durante até 24 meses.

EFICÁCIA DA TCCG PARA O TAG

Em geral, os estudos de eficácia terapêutica no formato em grupo são posteriores à consolidação do formato individual, o que significa que, à medida que os tratamentos individuais demonstram eficácia, devem ser consideradas formas de se aproveitar melhor o tempo, de tornar as terapias mais rentáveis e de contemplar um maior número de pacientes. A melhor forma de atingir esse fim é administrar o tratamento em grupo (Dugas et al., 2003). O número de pesquisas que avaliam a eficácia terapêutica dos tratamentos individuais para TAG é menor do que os estudos com outros transtornos de ansiedade. Conseqüentemente, os estudos de terapia em grupo para essa população são incipientes para conclusões substanciais.

Apesar do número escasso de estudos sobre a eficácia da terapia em grupo para o TAG, o primeiro deles incluiu 109 pacientes com TAG, que foram alocados em grupos de terapia cognitiva, comportamental, cognitivo-

comportamental, placebo e em condição de lista de espera (White et al., 1992). As quatro condições de tratamento mostraram alterações significativas quando comparadas ao grupo de lista de espera, mas poucas diferenças emergiram entre as condições de tratamento, e as taxas de recuperação foram baixas (Fisher, 2006). Passaram-se muitos anos desde o primeiro artigo de TCC em grupo até que, nas últimas duas décadas, fossem publicadas pesquisas seguindo protocolos e padrões distintos e tendo como exemplos um ensaio aberto com terapia cognitiva baseada em *mindfulness* (Evans et al., 2008), um estudo randomizado de terapia de intolerância à incerteza (Dugas et al., 2003) e um grupo de tratamento em terapia metacognitiva (Van der Heiden, Melchior, & Stigter, 2013). Embora o pequeno número de estudos sobre a eficácia terapêutica dos tratamentos em grupo para TAG não permita que se tirem conclusões robustas, pode-se afirmar que os pacientes tratados obtiveram diminuição significativa na ansiedade, na preocupação e nos sintomas depressivos aferidos nos questionários de autorrelato em todos os estudos citados. Apesar de as comparações entre estudos de tratamentos individuais e em grupos necessitarem de precaução, os artigos mostraram resultados promissores, apontando alívio dos sintomas e níveis de eficácia satisfatórios das abordagens em grupo se comparadas às abordagens individuais (Dugas et al., 2003).

Coutinho (2011) distribuiu de forma aleatória oito pacientes diagnosticados com TAG em dois grupos: o primeiro seguiu o modelo cognitivo de intolerância à incerteza, e o outro seguiu o modelo comportamental de relaxamento aplicado. Ambos receberam o mesmo número de sessões, com a mesma duração, e apenas um paciente desistiu logo na primeira sessão. O protocolo de intolerância à incerteza foi dividido em seis módulos: (i) psicoeducação e treinamento de conscientização da preocupação; (ii) reconhecimento da incerteza e exposição comportamental; (iii) reavaliação da exposição à preocupação; (iv) treinamento de resolução de problemas; (v) exposição imaginária; e (vi) prevenção de recaída. Os resultados das medidas de autorrelato, que avaliaram dificuldade de tolerar incertezas, sintomas físicos de ansiedade, preocupação e sintomas de depressão, foram semelhantes aos dos estudos publicados sobre o tema.

Algumas limitações importantes da pesquisa descrita por Coutinho (2011) incluem a dificuldade de se alcançar um número satisfatório de pacientes, apesar da enorme divulgação da pesquisa. A hipótese é a de que indivíduos com TAG desconhecem o transtorno e acreditam que suas ansiedade e preocupação excessivas são frutos de sua personalidade e do meio em que estão inseridos. Assim, não buscam tratamento especializado. Entre os sujeitos que procuraram tratamento, também foram encontradas limitações. A primeira foi o diagnóstico. Alguns pacientes que preencheram o diagnóstico primário de TAG apresentavam quadro depressivo grave e, com isso, não puderam participar da pesquisa. Outro fator impeditivo foi a relutância, por parte de alguns indivíduos, em participar de um grupo terapêutico. Ainda hoje, existem pessoas que se mostram mais confortáveis em iniciar um processo terapêutico individual. Entre aqueles que aceitavam participar do grupo, uma dificuldade foi adequar os horários para tornar possível a presença de todos os membros durante as semanas do tratamento no mesmo dia e horário. No entanto, ainda que houvesse limitações, o estudo se mostrou justificável pelo benefício que trouxe aos participantes.

Um ponto negativo levantado por alguns estudos sobre o tratamento em grupo para TAG (Dugas et al., 2003; Van der Heiden et al., 2013) indica uma possível desvantagem para a terapia de grupo, pois suas pesquisas obtiveram altas taxas de abandono em comparação ao mesmo protocolo no formato individual. Van der Heiden e colaboradores (2013) ressaltaram o fato de que o grupo formado para a pesquisa que seguiu o protocolo metacognitivo não foi previamente informado de que o tratamento teria o formato grupal, e, para os autores, isso pode ter contribuído para a alta taxa de abandono.

É fundamental o cuidado na avaliação clínica inicial, e, para isso, o terapeuta deve fazer um diagnóstico preciso com base no DSM-5, bem como verificar a adequabilidade do paciente ao modelo da TCC em grupo e suas expectativas com o tratamento. Além de fatores demográficos, como idade, cultura, linguagem, gênero e classe social, também se deve levar em consideração as principais características do transtorno. Como seus critérios são dimensionais, e as preocupações são difusas, é importante destacar particularidades nas queixas de cada indivíduo. Ou seja, é de suma

importância, já na entrevista inicial, observar os principais pontos de sofrimento do paciente e, durante o tratamento em grupo, não negligenciar as questões de cada indivíduo de forma terapêutica e incorporar todos os participantes nas técnicas ou dinâmicas sugeridas. É possível encontrar pacientes que relatam dificuldade de tolerar as incertezas; outros têm como foco principal conseguir se concentrar no momento presente; já outros se preocupam essencialmente com o fato de estarem sempre preocupados e isso poder causar problemas, como de saúde, por exemplo. Fato é que o terapeuta precisa validar o sofrimento do paciente e trabalhar no alívio dos sintomas e na reestruturação das cognições distorcidas, e, no caso específico do TAG, isso pode ter vários significados. Quando se pensa no trabalho em grupo, é importante compreender as nuances de cada indivíduo e considerá-las no processo terapêutico grupal. É possível que, quando o paciente não se sinta validado pelo grupo ou pelo terapeuta, ele acabe abandonando o tratamento.

Em geral, o formato de tratamento em grupo supõe que todos os membros participem de todas as sessões (Bieling, McCabe, & Antony, 2008), mas é perfeitamente aceitável que o terapeuta converse em particular com algum participante a fim de restaurar sua esperança ou encorajá-lo a se manter na terapia. Na maioria dos casos, o indicado é explicar ao paciente a importância de se levar aquela conversa obtida em particular para o grupo e compartilhar com todos o que foi discutido. Grupos terapêuticos com indivíduos com TAG requerem uma atenção especial às particularidades de cada paciente, sempre tendo em mente as prioridades do grupo.

Quando não se trata de uma pesquisa com protocolo fechado, ou quando os terapeutas têm maior margem de elaboração das sessões em grupo, é sugerido elaborar previamente as sessões, mantendo-se uma estrutura sequencial. O início de um grupo terapêutico deve incluir a apresentação dos participantes e dos terapeutas, seguida de psicoeducação do modelo cognitivo-comportamental e do TAG, bem como do registro de preocupações, para depois se trabalharem os níveis de cognição e as crenças positivas e negativas relacionadas à preocupação e, ainda, questionar evidências segundo as quais as preocupações podem levar a uma catástrofe real. Técnicas de *mindfulness* e resolução de problemas também costumam

apresentar alta eficácia. Utilizar técnicas de relaxamento aplicado (Dugas, Francis, & Bouchard, 2009), assim como trabalhar as ações valorizadas (Evans et al., 2008), pode ser útil para um perfil específico de pacientes com o transtorno, entre as inúmeras possibilidades de técnicas para esse perfil populacional.

TRANSTORNO DE PÂNICO E AGORAFOBIA

O TP é um transtorno crônico que influencia muito a qualidade de vida dos pacientes, tendo em vista sua repercussão prejudicial em diversos domínios, como pessoal, familiar, ocupacional e social (Ballenger, 1989; Barrera & Norton, 2009).

Segundo o DSM-5 (APA, 2014), o TP é definido pela presença recorrente e inesperada de ataques de pânico (APs). Estes são definidos como um período de intenso medo ou desconforto, em que ocorrem pelo menos quatro sintomas físicos ou cognitivos, como taquicardia, sudorese, tremores, sensações de falta de ar, dor ou desconforto torácico, náusea ou desconforto abdominal, tontura, parestesias, calafrios ou ondas de calor, desrealização ou despersonalização e medo de perder o controle, enlouquecer ou morrer. Os APs devem ser também acompanhados, por pelo menos um mês, de no mínimo uma das seguintes características: apreensão ou preocupação persistente acerca de APs adicionais ou de suas consequências e uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionada a eles (APA, 2014).

A AGO envolve medo ou ansiedade de ter um AP em situações nas quais escapar ou ter auxílio possa ser difícil, como em pelo menos duas das seguintes: usar transporte público, permanecer em espaços abertos, permanecer em espaços fechados, permanecer em uma fila ou em uma multidão e sair de casa sozinho. O desconforto desproporcional perante tais situações leva o indivíduo a enfrentá-las com intenso sofrimento, geralmente na companhia de uma pessoa de sua confiança, e/ou o conduz à evitação dessas situações, interferindo em sua mobilidade e causando prejuízos em seu funcionamento em diversas áreas da vida. É comum que pacientes

diagnosticados com AGO relatem AP ou TP prévios a esse quadro, chegando a 50% em amostras clínicas (APA, 2014).

Assim como no TP, indivíduos do sexo feminino também têm probabilidade duas vezes maior de apresentar AGO, sendo frequentes as comorbidades com transtornos de ansiedade (FEs, TP, TAS) e transtorno de estresse pós-traumático, geralmente precedentes, e com transtorno depressivo maior e transtorno por uso de álcool, posteriores ao seu surgimento (APA, 2014).

Ao vivenciar um AP, a experiência de ansiedade intensa e as ideias catastróficas do paciente acerca de morrer, enlouquecer ou perder o controle causam demasiado desconforto. Em uma espiral crescente, as avaliações cognitivas errôneas sobre o perigo aumentam a ansiedade, intensificando ainda mais os sintomas. Os pacientes acreditam que estão em perigo e não suportarão novos episódios como esse, necessitando de outras pessoas ou de comportamentos de segurança para ficar bem, o que acaba mantendo e intensificando o medo de próximas situações. Tornam-se hipervigilantes a qualquer modificação corporal, como um radar sensível e aguçado, detectando e interpretando cada sintoma físico como um sinal de ameaça, que potencializa a reação de ansiedade até uma experiência de terror. Com a repetição dos APs, surgem a ansiedade antecipatória e o medo das consequências de novos ataques, o que pode levar ao desenvolvimento das respostas de fuga e evitação que caracterizam a AGO. Cria-se, portanto, um ciclo disfuncional, em que a tentativa de afastar a ansiedade acaba por retroalimentá-la, podendo intensificar tanto as sensações físicas (e gerar novas crises) quanto o medo de sentir medo (e ocasionar muito sofrimento e evitações perante determinadas situações) (Barlow & Cerny, 1999; Rangé & Borba, 2008; De Carvalho, 2012).

Modelos cognitivo-comportamentais do transtorno de pânico e da agorafobia (TPA) destacam alguns componentes relacionados ao seu desenvolvimento e manutenção. Entre os cognitivos, destacam-se: (a) sensibilidade à ansiedade, que diz respeito a uma tendência estável e individual de interpretar catastroficamente sintomas físicos de excitabilidade e percebê-los como perigosos; (b) atenção às sensações físicas, como

hipervigilância às sensações corporais; e (c) cognições relacionadas a ameaças, como, por exemplo, pensamentos catastróficos, expectativas de perigo, superestimação do medo ao antecipar exposições e crenças subjacentes sobre controle pessoal (Bieling et al., 2008). Já entre os componentes comportamentais, sobressaem-se: respostas de fuga e evitação, que podem acarretar, por exemplo, evitação de atividades físicas; e uso de comportamentos de segurança, como andar sempre com celulares, ter água ou ansiolíticos disponíveis, sentar perto de saídas, etc.

A TCC tem sido considerada eficaz e eficiente a partir de diversos estudos, apontada, inclusive, como psicoterapia de primeira linha pela Canadian Psychiatric Association (CPA, 2006) e pela American Psychiatric Association (APA, 2016); além disso, é indicada como primeira escolha na Inglaterra, pelo National Institute for Health and Care Excellence (NICE, 2016). Evidências também indicam maior eficácia da TCC em relação a placebo, lista de espera, farmacoterapia e relaxamento aplicado; manutenção de ganhos ao longo do tempo; menores taxas de recaída quando comparada à psicofarmacologia; e impacto positivo no tratamento de comorbidades com transtornos de ansiedade e depressivos (Marchand, Roberge, Primiano, & Germain, 2009).

EFICÁCIA DA TCCG PARA TPA

Apesar de a literatura consistentemente referendar o tratamento cognitivo-comportamental para o TPA, é menor a proporção de estudos sobre sua aplicação em grupo (TCCG). Segundo Pratt e colaboradores (2014), os pacientes com TP tratados em grupo conseguem a diminuição de AP e comportamentos agorafóbicos, e cerca de 54 a 80% dos indivíduos alcançam a remissão de sintomas. Diversos estudos apontaram para a eficácia do tratamento do TP utilizando TCCG, com redução de diversas medidas relacionadas aos seus sintomas (Alaoui et al., 2013; Bergström et al., 2010; Choi et al., 2005; Fentz et al., 2012; Galassi, Quercioli, Charismas, Niccolai, & Barciulli, 2007; Heldt et al., 2003; Heldt, Blaya, Kipper, Salum, & Manfro, 2008; Penava, Otto, Maki, & Pollack, 1998; Pratt et al., 2014; Roberge, Marchand, Reinharz, & Savard, 2008; Telch et al., 1993; Rufer et al., 2010;

Wesner et al., 2013). Além do apontamento sobre a eficácia do tratamento, há estudos que verificaram que a TCCG beneficiou os pacientes com TP não apenas com a redução dos sintomas como também com a melhora da qualidade de vida (Roberge et al., 2008; Rufer et al., 2010).

A TCCG já demonstrou ser eficaz para pessoas com sintomas residuais de TP, tendo sido evidenciado que 87% dos pacientes tratados (em uma amostra de 32 participantes) continuavam utilizando as técnicas aprendidas até dois anos após o término do tratamento (Heldt et al., 2008). Pratt e colaboradores (2014) verificaram que medidas associadas à ansiedade em indivíduos com TP diminuíram após o tratamento, ao longo de três meses de acompanhamento. Esses estudos demonstraram que os pacientes podem continuar se beneficiando ao utilizarem as habilidades e estratégias aprendidas mesmo após o término da TCCG. A manutenção de ganhos após o tratamento também se mostra como possibilidade. Telch e colaboradores (1993) verificaram que 63% daqueles tratados em TCCG atingiram critérios para recuperação do quadro de TP em seis meses de acompanhamento pós-tratamento.

Quando a TCCG (14 sessões) foi comparada à TCC-padrão (14 sessões) e a um protocolo de TCC de curta duração (7 sessões), verificou-se que a TCCG e a TCC de curta duração ofereceram um melhor custo-benefício do que o protocolo-padrão, com menores custos diretos e indiretos. No pós-tratamento e no acompanhamento de três meses, não houve diferenças na eficácia clínica entre os três tipos de tratamento (Roberge et al., 2008). A TCCG também já foi comparada a um protocolo de quatro sessões de exposição virtual individual. Apesar de ambos os tratamentos terem demonstrado eficácia, a TCCG demonstrou resultados superiores em longo prazo (Choi et al., 2005). Quando comparada à TCC realizada via internet, a TCCG para TPA foi igualmente efetiva, inclusive em um período de seis meses de seguimento (Alaoui et al., 2013; Bergström et al., 2010).

Um dos protocolos mais usados é o de Craske e Barlow (1993). Além deste, foi desenvolvido um novo protocolo ao longo de processos de supervisões dos atendimentos clínicos realizados na Divisão de Psicologia Aplicada (DPA) do Instituto de Psicologia (IP) da Universidade Federal do

Rio de Janeiro (UFRJ), intitulado de tratamento cognitivo-comportamental “Vencendo o Pânico” (Rangé, 2001; Rangé & Borba, 2008, 2016), que vem sendo utilizado desde 1996.

O protocolo “Vencendo o Pânico” foi concebido para ter uma versão para terapeutas e uma para pacientes, a partir da premissa de que, assim, pudesse ser utilizado por terapeutas inexperientes em TCC. O manual do terapeuta inclui uma fundamentação teórica e instruções sobre como realizar as estratégias indicadas do início ao fim do processo terapêutico (Rangé & Borba, 2008). Já o manual do paciente é um instrumento terapêutico eficaz a ser utilizado como material de psicoeducação, aquisição de habilidades de manejo e prevenção de recaídas (Rangé & Borba, 2016).

De modo geral, em termos de manejo do grupo, todas as sessões envolvem um conjunto de procedimentos-padrão: revisão das tarefas de casa; psicoeducação sobre algum tema preestabelecido; treino das habilidades de manejo por meio da realização de exercícios práticos; *feedback* do grupo e dos terapeutas; indicação de novas tarefas de casa; e despedida da sessão. Cada uma das oito sessões propostas contém estratégias que habilitam o paciente para a sessão seguinte e reforça o aprendizado da anterior. Cada sessão tem uma agenda a ser cumprida, a qual inclui objetivo(s) específico(s), atividades passo a passo e tarefa(s) de casa.

Há um vídeo-documentário, *Vencendo o pânico* (Borba et al., 2012), que serviu ao treinamento dos terapeutas via *web* e foi disponibilizado em 2012 no YouTube.^[NT]

O protocolo “Vencendo o Pânico” aponta significativa redução dos sintomas e de crenças relacionados ao TP e à AGO, assim como aumento da mobilidade, bem-estar subjetivo, qualidade de vida e nível de felicidade na vida dos pacientes tratados.

A TCCG pode ser boa alternativa em relação à TCC-padrão individual para o TP e a AGO quando se trata de custo-benefício do tratamento: com menor número de profissionais, é possível atender, também com qualidade, um maior número de pessoas, ocasionando redução de custos (Heldt et al., 2008; Roberg et al., 2008). O trabalho em grupo também pode proporcionar segurança e apoio (Galassi et al., 2007; Heldt et al., 2008), e os ganhos

podem manter-se ao longo do tempo, assim como o aprendizado das estratégias parece se consolidar e ser recrutado após o tratamento (Heldt et al., 2008; Pratt et al., 2014; Telch et al., 1993). Verifica-se também que os resultados obtidos com o tratamento podem atingir outras esferas de funcionamento, e não apenas a remissão e/ou redução dos sintomas característicos do TPA (Roberge et al., 2008; Rufer et al., 2010). Porém, outras medidas que envolvam variáveis diferentes daquelas diretamente relacionadas aos sintomas específicos do transtorno precisam ser mensuradas em estudos de TCCG para TPA.

O protocolo “Vencendo o Pânico” consolidou-se como um instrumento terapêutico cientificamente validado para tratamento do TPAGO em grupo no Brasil, demonstrando ser capaz de gerar mudança no entendimento desses quadros, com redução de crenças e sintomas relacionados; ampliação das habilidades de manejo da ansiedade; maior enfrentamento das situações temidas; e mais atenção a uma reorientação ativa da vida.

Também cabe fazer referência à importância do cuidado em relação à composição dos grupos psicoterapêuticos. De acordo com Bieling e colaboradores (2008), quanto mais homogênea for a composição do grupo, maior a probabilidade de relacionamento entre os membros e de estes considerarem o grupo benéfico para suas necessidades. Assim, pode-se aumentar a coesão grupal e reduzir o risco de abandono do tratamento. Dessa forma, alguns fatores que devem ser considerados no momento de determinar a elegibilidade de um paciente para um grupo de TP, tendo em vista a obtenção de bons resultados, são: diagnóstico e gravidade clínica, comorbidades, *insight*, nível de motivação, abertura ao tratamento grupal, habilidades interpessoais e características de personalidade (Bieling et al., 2008).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Há diferenças significativas no que diz respeito às respostas ao tratamento em grupo de cada um dos transtornos de ansiedade. O TP e a AGO são os que apresentam as melhores taxas de resposta a tais tratamentos, seguidos pelo

TAS, que chega a resultados em torno de 90% de eficácia, e pelo TAG, que apresenta resultados em torno de apenas 60 a 70% de sucesso no tratamento. Há também distinções entre os diferentes métodos de tratamento do TAG: alguns respondem bem ao modelo de intolerância à incerteza; outros ao modelo metacognitivo; e outros, ainda, ao modelo de aceitação e compromisso. Isso sugere que nenhum dos modelos representa um entendimento adequado daquilo que se passa com esses pacientes. Uma possível razão talvez seja o fato de esses pacientes parecerem acreditar que tentam fazer “tudo certo”, o que pode ser um obstáculo para um adequado reconhecimento de ter o transtorno. Mais pesquisas certamente auxiliarão no conhecimento científico empiricamente validado, o que servirá para um tratamento mais eficaz do TAG, de modo a equipará-lo com os demais transtornos abordados neste capítulo.

Por fim, estudos futuros que considerem as preferências do paciente em relação ao tipo de tratamento a ser recebido (individual, TCCG, *on-line*, etc.) são igualmente desejáveis. Sharp, Power e Swanson (2004) verificaram o impacto das preferências por tratamento individual ou em grupo para indivíduos com transtorno de ansiedade na adesão à terapia. Os resultados demonstraram que a preferência da maioria dos pacientes foi por atendimento individual. Aqueles que preferiram tratamento individual, mas receberam-no em grupo, tiveram menor adesão. Diante disso, um apontamento importante diz respeito à necessidade de outras investigações sobre a adesão e os desfechos do tratamento relacionados à preferência do paciente e, conseqüentemente, à possível necessidade de consideração e manejo dessa condição na prática clínica. A percepção de controle do indivíduo em relação às condições de tratamento pode ser preditora de resultado, além de aumentar sua satisfação (Perreault et al., 2014).

REFERÊNCIAS

Alaoui S, Hedman E, Ljótsson B, Bergström J, Andersson E, Rück C, ... Lindefors N. (2013). Predictors and moderators of internet- and group-based cognitive behaviour therapy for panic disorder. *PLoS One*, 8(11), 79024.

- Almeida-Filho, N., Mari, J. J., Coutinho, E., França, J. F., Fernandes, J., Andreoli, S. B., & Busnello, E. D. A. (1997). Brazilian multicentric study of psychiatric morbidity: Methodological features and prevalence estimates. *The British Journal of Psychiatry*, 171, 524-529.
- American Psychiatric Association (APA). (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5* (5. ed.). Porto Alegre: Artmed.
- American Psychiatric Association (APA). (2016). *Meta-analyses and systematic reviews*. Washington: APA, Division of Clinical Psychology. Recuperado de <http://www.div12.org/psychological-treatments/disorders/panic-disorder/cognitive-behavioral-therapy-for-panic-disorder/#meta-analyses>
- Antón, M. D., Olivares, P. O., & Boix, A. M. (2012). Detección e intervención conductual-cognitiva en adultos-jóvenes con fobia social generalizada. *Anales de Psicología*, 28(1), 19-27.
- Araújo, L. F., Ronzani, T. M., & Lourenço, L. M., (2010). Análise da literatura sobre a comorbidade entre fobia social e depressão. *Revista Interinstitucional de Psicologia*, 3(2), 109-123.
- Arnold Anteraper, S., Triantafyllou, C., Sawyer, A. T., Hofmann, S. G., Gabrieli, J. D., & Whitfield-Gabrieli, S. (2014). Hyper-connectivity of subcortical resting-state networks in social anxiety disorder. *Brain Connect*, 4(2), 81-90.
- Ballenger, J. C. (1989). Toward an integrated model of panic disorder. *American Journal of Orthopsychiatry*, 59(2), 284-293.
- Bandelow, B., Reitt, M., Röver, C., Michaelis, S., Görlich, Y., & Wedekind, D. (2015). Efficacy of treatments for anxiety disorders: A meta-analysis. *International Clinical Psychopharmacology*, 30(4), 92-183.
- Barlow, D. H., Cerny, J. A. (1999). *Tratamento psicológico do pânico*. Porto Alegre: Artes Médicas Sul.
- Barrera, T. L., Norton, P. J. (2009). Quality of life impairment in generalized anxiety disorder, social phobia, and panic disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, 23(8), 1086-1090.
- Bergström, J., Andersson, G., Ljótsson, B., Rück, C., Andréewitch, S., Karlsson, A., . . . Lindefors, N. (2010). Internet-versus group-administered cognitive behaviour therapy for panic disorder in a psychiatric setting: A randomised trial. *BMC Psychiatry*, 10, 54.
- Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2008). *Terapia cognitivo-comportamental em grupos*. Porto Alegre: Artmed.
- Bomyea, J., Ramsawh, H., Ball, T. M., Taylor, C. T., Paulus, M. P., Lang, A. J., & Stein, M. B. (2015). Intolerance of uncertainty as a mediator of reductions in worry in a cognitive behavioral treatment program for generalized anxiety disorder. *Journal of Anxiety Disorders*, 33, 90-94.
- Book, S. W., & Randall, C. L. (2002). Social anxiety disorder and alcohol use. *Alcohol Research & Health*, 26(2), 130-135.
- Borba, A. G., Rangé, B. P., Maciel, K. M., Loureiro, C. P., Melo, N., Carvalho, M., ... Monteiro, G. (2010). *Video-documentário vencendo o pânico*. Rio de Janeiro: Programa de Pós-Graduação em Psicologia do Instituto de Psicologia e Central de Produção Multimídia da Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
- Borkovec, T. D., & Costello, E. (1993). Efficacy of applied relaxation and cognitive behavioral therapy in the treatment of generalized anxiety disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 61(4),

611-619.

Canadian Psychiatric Association (CPA). (2006). Clinical practice guidelines: Management of anxiety disorders. *Canadian Journal of Psychiatry*, 51(8 Suppl 2), 9S-91S.

Carleton, R. N., Norton, M. A. P. J., & Asmundson, G. J. G. (2007). Fearing the unknown: A short version of the intolerance of uncertainty scale. *Journal of Anxiety Disorders*, 21(1), 105-117.

Choi, Y. H., Vincelli, F., Riva, G., Wiederhold, B. K., Lee, J. H., & Park, K. H. (2005). Effects of group experiential cognitive therapy for the treatment of panic disorder with agoraphobia. *Cyberpsychology & Behavior*, 8(4), 387-393.

Clark, D. A., Beck, A. T. (2012). *Terapia cognitiva para os transtornos de ansiedade: Ciência e prática*. Porto Alegre: Artmed.

Clark, D. M. (2001). A cognitive perspective on social phobia. In W. R. Crozier, & L. E. Alden (Eds.), *International handbook of social anxiety: Concepts, research and interventions relating to the self and shyness* (pp. 405-430). Chichester: John Wiley & Sons.

Clark, D. M., & Wells, A. A. (1995). *Cognitive model of social phobia*. In R. G. Heimberg, M. R. Liebowitz, D. A. Hope, & F. R. Schneider, *Social phobia: Diagnosis, assessment and treatment* (pp. 69-93). New York: Guilford Press.

Coutinho, F. C. (2011). *Efetividade da abordagem cognitivo-comportamental em grupo para pacientes com transtorno de ansiedade generalizada: Um teste transcultural* (Dissertação de Mestrado não publicada, Instituto de Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).

Covin, R., Ouimet, A. J., Seeds, P. M., & Dozois, D. J. A. (2008). A meta-analysis of CBT for pathological worry among clients with GAD. *Journal of Anxiety Disorders*, 22(1), 108-116.

Craske, M. G., & Barlow, D. H. (1993). *Panic disorder and agoraphobia*. In D. H. Barlow (Ed.), *Clinical handbook of psychological disorders* (pp. 1-47). New York: Guilford Press.

Cuijpers, P., Sijbrandij, M., Koole, S., Huibers M., Berking M., & Andersson G., (2014). Psychological treatment of generalized anxiety disorder: A meta-analysis. *Clinical Psychology Review*, 34(2), 130-140.

De Carvalho, M. R. (2012). *Aspectos neurobiológicos e a psicoterapia cognitivo-comportamental no transtorno de pânico com AGO* (Tese de doutoramento não publicada, Instituto de Psiquiatria, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).

Dogaheh, E. R., Mohammadkhani, P., & Dolatshahi, B. (2011). Comparison of group and individual cognitive-behavioral therapy in reducing fear of negative evaluation. *Psychological Reports*, 108(3), 955-962

Dugas, M. J., & Robichaud, M. (2007). *Cognitive-behavioral treatment for generalized anxiety disorder: From science to practice*. New York: Routledge.

Dugas, M. J., Francis, K., & Bouchard, S. (2009). Cognitive behavioural therapy and applied relaxation for generalized anxiety disorder: A time series analysis of change in worry and somatic anxiety. *Cognitive Behaviour Therapy*, 38(1), 29-41.

Dugas, M. J., Gagnon, F., Ladouceur, R., & Freeston, M. H. (1998). Generalized anxiety disorder: A preliminary test of a conceptual model. *Behaviour Research and Therapy*, 36(2), 215-226.

- Dugas, M. J., Ladouceur, R., Léger, E., Freeston, M. H., Langolis, F., Provencher, M. D., & Boisvert, J.-M. (2003). Group cognitive-behavioral therapy for generalized anxiety disorder: Treatment outcome and long-term follow-up. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 71*(4), 821-825.
- Evans, S., Ferrando, S., Findler, M., Stowell, C., Smart, C., & Haglin, D. (2008). Mindfulness-based cognitive therapy for generalized anxiety disorder. *Journal Anxiety Disorder, 22*(4), 716-721.
- Fang, A., Sawyer, A. T., Asnaani, A., & Hofmann, S. G. (2013). Social mishap exposures for social anxiety disorder: An important treatment ingredient. *Cognitive and Behavioral Practice, 20*(2), 213-220.
- Fentz, H. N., Hoffart, A., Jensen, M. B., Arendt, M., O'Toole, M. S., Rosenberg, N. K., & Hougaard, E. (2012). Mechanisms of change in cognitive behaviour therapy for panic disorder: The role of panic self-efficacy and catastrophic misinterpretations. *Behaviour Research and Therapy, 51*(9), 579-587.
- Fisher, P. L. (2006). The efficacy of psychological treatments for generalized anxiety disorder. In G. C. L. Davey, & A. Wells (Eds.), *Worry and its psychological disorders: Theory, assessment and treatment*. West Sussex: Wiley & Sons.
- Galassi, F., Quercioli, S., Charismas, D., Niccolai, V., & Barciulli, E. (2007). Cognitive-behavioral group treatment for panic disorder with agoraphobia. *Journal of Clinical Psychology, 63*(4), 409-416.
- Hanrahan, F., Field, A. P., Jones, F. W., & Davey G. C. L. (2013). A meta-analysis of cognitive therapy for worry in generalized anxiety disorder. *Clinical Psychology Review 33*(1), 120-132.
- Hedman, E., Andersson, G., Ljótsson, B., Andersson E., Ruck, C., Montberg, E., & Lindefors, N. (2011). Internet-based cognitive behavior therapy vs. cognitive behavioral group therapy for social anxiety disorder: A randomized controlled non-inferiority trial. *Plos One, 6*(3), e18001.
- Hedman, E., Mörtberg, E., Hesser, H., Clarke, D. M., Lekander, M., Andersson, E., & Ljótsson, B. (2013). Mediators in psychological treatment of social anxiety disorder: Individual cognitive therapy compared to cognitive behavioral group therapy. *Behaviour Research And Therapy, 51*(1), 696-705.
- Heiden, C. V., Muris P., & Molen, H. T. V. D., (2012). Randomized controlled trial on the effectiveness of metacognitive therapy and intolerance-of-uncertainty therapy for generalized anxiety disorder. *Behaviour Research and Therapy, 50*(2), 100-109.
- Heimberg, R. G., & Becker, R. E. (2002). *Cognitive-behavioral group therapy for social phobia: Basic mechanisms and clinical strategies*. New York: Guilford Press.
- Heimberg, R. G., Brozovich, F. A., & Rapee, R. M. (2010). A cognitive behavioral model of social anxiety disorder: Update and extension. In S. G. Hofmann, & P. M. DiBartolo (Eds.), *Social anxiety: Clinical, developmental, and social perspectives* (pp. 395-422). New York: Elsevier.
- Heimberg, R. G., Hofmann, S. G., Liebowitz, M. R., Schneier, F. R., Smits, J. A., Stein, M. B., ... Craske, M. G. (2014). Social anxiety disorder in DSM-5. *Depression and Anxiety, 31*(6), 472-479.
- Heimberg, R. G., Juster, H. R., Hope, D. A., & Mattia, J. I. (1995). Cognitive-behavioral group treatment: Description, case presentation, and empirical support. In M. B. Stein, *Social phobia: Clinical and research perspectives* (pp. 293-321). Washington: American Psychiatric Association.
- Heimberg, R. G., Salzman, D. G., Holt, C. S., & Blendell, K. A. (1993). Cognitive-Behavioral group treatment for social phobia: Effectiveness at five-year follow-up. *Cognitive Therapy and Research, 17*(4), 325-339.

- Heldt, E., Blaya, C., Kipper, L., Salum, G., & Manfro, G.G. (2008). Cognitive-behavioral group therapy techniques in panic disorder patients with residual symptoms: 2-year follow-up. *Clinical & Biomedical Research*, 28(1), 10-15.
- Heldt, E., Manfro, G. G., Kipper, L., Blaya, C., Maltz, S., Isolan, L., ... Otto, M. W. (2003). Treating medication-resistant panic disorder: Predictors and outcome of cognitive-behavior therapy in a Brazilian public hospital. *Psychotherapy Psychosomatics*, 72(1), 43-48.
- Hettema, J. M., Neale, M. C., & Kendler, K. S. (2001). A review and metaanalysis of the genetic epidemiology of anxiety disorders. *The American Journal of Psychiatry*, 158(10), 1568-1578.
- Hofmann, S. G. (2000). Self-focused attention before and after treatment of social phobia. *Behaviour Research and Therapy*, 38(7), 717-725.
- Hofmann, S. G. (2004). Cognitive mediation of treatment change in social phobia. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72(3), 393-399.
- Hofmann, S. G., & Otto, M. W. (2008). *Cognitive-behavior therapy of social anxiety disorder: Evidence-based and disorder specific treatment techniques*. New York: Routledge.
- Hofmann, S. G., & Smits, J. A. J. (2008). Cognitive-behavioral therapy for adult anxiety disorders: A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. *Journal of Clinical Psychiatry*, 69(4), 621-632.
- Hofmann, S. G., Smits, J. A. J., Rosenfield, D., Simon, N., Otto, M. W., Meuret, A. E., ... Pollack, M. H., (2013). D-Cycloserine as an augmentation strategy with cognitive-behavioral therapy for social anxiety disorder. *American Journal of Psychiatry*, 170(7), 751-758.
- Jones, S. L., Hadjistavropoulos H. D., & Soucy, J. N. (2016). A randomized controlled trial of guided internet-delivered cognitive behaviour therapy for older adults with generalized anxiety. *Journal of Anxiety Disorders*, 37, 1-9.
- Jorstad-Stein, E. C., & Heimberg, R. G. (2009). Social phobia: An update on treatment. *Psychiatric Clinics of North America*, 32(3), 641-663.
- Kendler, K. S., Gardner, C. O., Gatz, M., & Pedersen, N. L. (2007). The sources of comorbidity between major depression and generalized anxiety disorder in a Swedish national twin sample. *Psychological Medicine*. 37(3), 453-462.
- Kessler, R. C., & Wittchen, H. U. (2002). Patterns and correlates of generalized anxiety disorder in community samples. *Journal of Clinical Psychiatry*, 63(Suppl. 8), 4-10.
- Kessler, R. C., Chiu, W. T., Demler, O., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Prevalence, severity, and comorbidity of 12-month DS M-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(2), 617-627.
- Mahoney, A. E., & McEvoy, P. M. (2012). Changes in intolerance of uncertainty during cognitive behavior group therapy for social phobia. *Journal of Behavior Therapy Experimental Psychiatry*, 43(2), 849-854.
- Makkar, S. R., & Grisham, J. R. (2011). Social anxiety and the effects of negative self-imagery on emotion, cognition, and post-event processing. *Behaviour Research and Therapy*, 49(10), 654-664.
- Marchand, A., Roberge, P., Primiano, S., & Germain, V. (2009). A randomized, controlled clinical trial of standard, group and brief cognitive-behavioral therapy for panic disorder with agoraphobia: a two-year follow-up. *Journal of Anxiety Disorders*, 23(8), 1139-1147.

- Mayo-Wilson, E., Dias, S., Mavranzezouli, I., Kew, K., Clark, D. M., Ades, A. E., & Pilling, S. (2014). Psychological and pharmacological interventions for social anxiety disorder in adults: A systematic review and network meta-analysis. *Lancet Psychiatry*, 1(5), 120-125.
- Morrison, A. S., & Heimberg, R. G. (2013). Social anxiety and social anxiety disorder. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9(1), 249-274.
- Moscovitch, D. A., Suvak, M. K., & Hofmann, S. G., (2010). Emotional response patterns during social threat in individuals with generalized social anxiety disorder and non-anxious controls. *Journal of Anxiety Disorders*, 24(7), 785-791.
- Nardi, A. E. (2000). *Transtorno de ansiedade social: Fobia social – a timidez patológica*. Rio de Janeiro: Medsi.
- National Institute for Health and Care Excellence (NICE). (2016). *Panic disorder overview*. London: NICE. Recuperado de <http://pathways.nice.org.uk/pathways/panic-disorder>
- Newman, M. G., & Llera, S. J. (2011). A novel theory of experiential avoidance in generalized anxiety disorder: A review and synthesis of research supporting a contrast avoidance model of worry. *Clinical Psychology Review*, 31(3), 371-382.
- Newman, M. G., Llera, S. J., Erickson, T. M., Przeworski, A., & Castonguay L. G., (2013). Worry and generalized anxiety disorder: A review and theoretical synthesis of evidence on nature, etiology, mechanisms, and treatment. *Annual Review of Clinical Psychology*, 9, 275-297.
- Nutt, C., & Ballenger, J. (2010). *Transtornos de ansiedade: Transtorno de pânico e transtorno de ansiedade social*. Rio de Janeiro: MedLine.
- Organização Mundial da Saúde (OMS). (1993). *Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas*. Porto Alegre: Artmed
- Penava, S. J., Otto, M. W., Maki, K. M., & Pollack, M. H. (1998). Rate of improvement during cognitive-behavioral group treatment for panic disorder. *Behaviour Research Therapy*, 36(7-8), 665-673.
- Perreault, M., Julien, D., White, N. D., Bélanger, C., Marchand, A., Katerelos, T., & Milton, D. (2014). Treatment modality preferences and adherence to group treatment for panic disorder with agoraphobia. *Psychiatric Quarterly*, 85(2), 121-132.
- Picon, P., & Knijnik, D. Z. (2008). Fobia social. In P. Knapp (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica*. Porto Alegre: Artmed.
- Picon, P., & Penido, M. A. (2011). Terapia cognitivo-comportamental do transtorno de ansiedade social. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed.). Porto Alegre: Artmed.
- Pratt, E., Dominguez, E., Rosado, S., Pailhez, G., Bulbena, A., & Fullana, M. M., (2014). Effectiveness of cognitive-behavioral group therapy for panic disorder in a specialized unit. *Actas Española de Psiquiatria*, 42(4), 176-184.
- Rangé, B. (2001). Tratamento cognitivo-comportamental para o transtorno de pânico e agorafobia: Uma história de 35 anos. *Estudos de Psicologia*, 25(4), 477-486.
- Rangé, B., & Borba, A. (2008). *Vencendo o pânico: Terapia integrativa para quem sofre e para quem trata o transtorno de pânico e a agorafobia*. Rio de Janeiro: Cognitiva.

- Rangé, B., & Borba, A. (2016). *Vencendo o pânico: Terapia integrativa para quem sofre e para quem trata o transtorno de pânico e a agorafobia* (2. ed.). Rio de Janeiro: Cognitiva.
- Rapee, R. M., & Heimberg, R. G. (1997). A cognitive-behavioral model of anxiety in social phobia. *Behaviour Research and Therapy*, 35(8), 741-756.
- Roberge, P., Marchand, A., Reinharz, D., & Savard, P. (2008). Cognitive-behavioral treatment for panic disorder with agoraphobia: A randomized, controlled trial and cost-effectiveness analysis. *Behavior Modification*, 32(3), 333-351.
- Rodebaugh, T. L., Holaway, R. M. & Heimberg, R. G. (2004). The treatment of social anxiety disorder. *Clinical Psychology Review*, 24(7), 883-908.
- Rufer, M., Albrecht, R., Schmidt, O., Zaum, J., Schnyder, U., Hand, I., & Mueller-Pfeiffer, C. (2010). Changes in quality of life following cognitive-behavioral group therapy for panic disorder. *European Psychiatry*, 25(1), 8-14.
- Santos Filho, A., (2010). *Espectro do transtorno de ansiedade social: Estudo de suas comorbidades psiquiátricas e associação com o prolapso da valva mitral* (Tese de doutorado não publicada, Universidade São Paulo, Ribeirão Preto).
- Schneier, F. R., Heimberg, R. G., Liebowitz, M. R., Blanco, C., & Gorenstein, L. A., (2012). Social anxiety and functional impairment in patients seeking surgical evaluation for hyperhidrosis. *Comprehensive Psychiatry*, 53(8), 1181-1186.
- Scholing, A., & Emmelkamp, P. M. G. (1993). Cognitive and behavioural treatments of fear of blushing, sweating or trembling. *Behaviour Research and Therapy*, 31(2), 155-170.
- Sharp, D. M., Power, K. G., & Swanson, V. (2004). A comparison of the efficacy and acceptability of group versus individual cognitive behaviour therapy in the treatment of panic disorder and agoraphobia in primary care. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 11(2), 73-82.
- Stangier, U., Heidenreich, T., Peitz, M., Lauterbach, W., & Clark, D. M. (2003). Cognitive therapy for social phobia: Individual versus group treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(9), 991-1007.
- Stanley, M. A., Beck, J. G., Novy, D. M., Averill, P. M., Swann, A. C., Diefenbach, G. J., & Hopko, D. R. (2003). Cognitive-behavioral treatment of late-life generalized anxiety disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71(2), 309-319.
- Telch, M. J., Lucas, J. A., Schmidt, N. B., Hanna, H. H., LaNae Jaimez, T., & Lucas, R. A. (1993). Group cognitive-behavioral treatment of panic disorder. *Behavior Research Therapy*, 31(3), 279-87.
- Théberge-Lapointe, N., Marchand, A., Langlois, F., Gosselin, P., & Watts, S. (2015). Efficacy of a cognitivebehavioural therapy administered by videoconference for generalized anxiety disorder. *Revue Européenne de Psychologie Appliquée/European Review of Applied Psychology*, 65(1), 9-17.
- Van der Heiden, C., Melchior, K., & Stigter, E. (2013). The effectiveness of group metacognitive therapy for generalised anxiety disorder: A pilot study. *Journal Contemporary Psychotherapy*, 43(3), 151-157.
- Vasconcelos, J. R. O., Lôbo, A. P. S., & Melo Neto, V. L. (2015). Risco de suicídio e comorbidades psiquiátricas no transtorno de ansiedade generalizada. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 64(4), 259-265.

Wells, A. (1995). Metacognition and worry: A cognitive model of generalized anxiety disorder. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 23(3), 301-320.

Wells, A. (2010). Metacognitive theory and therapy for worry and generalized anxiety disorder: Review and status. *Journal of Experimental Psychopathology*, 1(1), 133-145.

Wesner A. C., Gomes J. B., Detzel T., Blaya C., Manfro G. G., & Heldt E. (2013). Effect of cognitive-behavioral group therapy for panic disorder in changing coping strategies. *Comprehensive Psychiatry*, 55(1), 87-92.

Wetherell, J. L., Gatz, M., & Craske, M. G. (2003). Treatment of generalized anxiety disorder in older adults. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71(1), 31-40.

White, J., Keenan M., & Brooks, N. (1992). Stress control: A controlled comparative investigation of large group therapy for generalized anxiety disorder. *Behavioural Psychotherapy*, 20(2), 97-113.

LEITURA RECOMENDADA

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (1999). *Acceptance and commitment therapy: An experiential approach to behavior change*. New York: Guilford Press.

[NT] Para assistir o vídeo, acesse: <https://www.youtube.com/watch?v=rhuMQY6WlQg>.

4



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA DEPRESSÃO

**Adriana Munhoz Carneiro
Denise Petresco David**

Caracterizada pelos sintomas principais de tristeza intensa e falta de interesse/prazer pelas atividades, a depressão é um transtorno mental que afeta 350 milhões de pessoas no mundo, com perspectivas de ser a maior causa de incapacidade mundial até 2030. Aliadas a essas preocupações, encontram-se as altas taxas de recaída e recorrência, o que gira em torno de 50 a 90% dos casos (Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments [CANMAT], 2012; Fava et al., 2004; Maj, Veltro, Pirozzi, Lohr, & Magliano, 1992). Entre essas taxas, estima-se que 20 a 40% dos pacientes com depressão não respondem satisfatoriamente a medicações antidepressivas (Israel, 2010), o que traz como necessidade o

desenvolvimento de outras estratégias para administração em conjunto com o tratamento medicamentoso, como a prática psicoterápica.

As intervenções cognitivo-comportamentais se mostram importantes ferramentas para diminuição dessas taxas e partem da premissa de que a modificação de crenças disfuncionais mediante a reestruturação cognitiva pode funcionar como um importante fator para a redução dos sintomas depressivos (Beck, 1997; Wright, Basco, & Thase, 2008). No caso da depressão, o foco da terapia cognitivo-comportamental (TCC) será na tríade negativa, ou seja, tendência da pessoa deprimida a ter uma visão negativa de si mesma (percebe-se como inadequada, doente, incapaz), do presente (não percebe o valor das atividades que realiza e das relações que estabelece ou vê obstáculos insuperáveis para realizar seus objetivos de vida) e do futuro (não consegue acreditar que a situação atual possa mudar e, com isso, não faz planos para o futuro) (Beck, 1997; Beck, Rush, Shaw, & Emery 1982), e nas distorções cognitivas e nos erros sistemáticos na percepção e no processamento de informações. São comuns, na depressão, distorções das experiências do indivíduo de uma forma absolutista, moralista e irreversível. Desse modo, as intervenções focam na diminuição desses padrões distorcidos de pensamentos mediante exercícios cognitivos e treinos comportamentais (Beck, 1997; Beck et al., 1982).

A eficácia da TCC no tratamento da depressão pode ser verificada em diferentes estudos, seja administrada de forma individual (Beck & Weishaar, 2000; Friedman et al., 2009; Parikh et al., 2009), seja em grupo (Feng et al., 2012; Okumura & Ichikura, 2014; Teissmann et al., 2014). Independentemente de sua forma de intervenção, proporciona o alívio ou a remissão total dos sintomas mediante a mudança duradoura nos sistemas de significados (pensamentos disfuncionais) e nas reações emocionais e comportamentais, proporcionando autonomia ao paciente e melhora significativa da qualidade de vida.

A opção entre TCC individual (TCCI) ou em TCC em grupo (TCCG) deverá ser considerada de acordo com a gravidade dos sintomas de humor do indivíduo, o tipo de grupo e se o paciente conseguirá se beneficiar do compartilhamento das histórias para sua reflexão e aumento de estratégias de

enfrentamento, aspectos que serão discutidos com mais detalhes adiante. Contudo, vale ressaltar que ambas as abordagens são eficazes para o tratamento do transtorno depressivo maior (TDM), sendo, inclusive, recomendadas como tratamento de primeira linha (Friedman et al., 2009).

Diferentemente do que se imagina, os estudos voltados para o desenvolvimento de protocolos grupais não são recentes e mostram-se tão efetivos quanto o tratamento individual. Entre as primeiras publicações da TCCG, encontra-se o trabalho de Hollon & Shaw (1979), que descreviam uma proposta de extensão do protocolo original de A. T. Beck para o contexto grupal. No mesmo período, Lewinsohn, Muñoz, Younggreen e Zeiss (1978) desenvolveram um protocolo específico para o tratamento em grupo da depressão que incluía ensinar habilidades específicas aos participantes, como relaxamento, planejamento de atividades agradáveis e assertividade social. Esse trabalho originou outras publicações dos autores, entre elas as obras *Control your Depression* e *Coping with Depression Course*, além de novos protocolos (Muñoz, Ippen, Rao, Le, & Dweyer, 2000). Outros trabalhos notáveis de TCCG são de Muñoz & Miranda (1996), que publicaram uma proposta de TCCG para depressão com pacientes em ambiente hospitalar, e de White e Friedman (1942), que publicaram um manual de TCC para diferentes populações, entre elas os pacientes com depressão. Hoje, já podem ser facilmente recuperados mais de cem estudos nessa área, incluindo metanálises, que continuam discutindo quais seriam as condições e o protocolo ideal para tratamento da depressão em grupo (Feng et al., 2012; Okumura & Ichikura, 2014).

O trabalho em grupo tem sido referenciado como apropriado e vantajoso no tratamento da depressão por diferentes motivos, seja por proporcionar ao indivíduo o relacionamento com outras pessoas do grupo, aumentando seu contato social, pelas estratégias de enfrentamento e aprendizagem aprendidas por meio do compartilhamento de informações, seja por se constituir em uma alternativa com custo-benefício comparada à TCCI (Thrimm & Antonsen, 2014). As exposições, difíceis de recriar na clínica individual, podem ser geradas pelo grupo, o que favorece a reestruturação cognitiva. Ademais, existem benefícios como sentimentos de pertencimento, instilação de

esperança (melhora de um integrante gerar esperança nos outros membros), entre outras características, descritas adiante, que são de suma importância para o trabalho em grupo.

RESULTADOS DE EFICÁCIA ENCONTRADOS NA LITERATURA

Para embasar este tópico, foi realizado um breve levantamento bibliográfico no Pubmed sobre as publicações mais recentes em TCCG em adultos (2011-2016), que resultou em 80 artigos. Destes, foram selecionados aqueles que traziam alguma pesquisa de campo ($n = 42$), metanálise ($n = 2$) ou revisão sistemática ($n = 2$) sobre o tema para embasar este capítulo. O resultado do levantamento demonstra que a aplicabilidade e a efetividade da TCCG são estudadas em diferentes países, os quais demonstram bons resultados, e alguns estudos são descritos a seguir.

Em um dos estudos, participaram 18 pacientes do sexo feminino, com idade média de 47 anos, recrutadas de um centro geral de saúde da África, que haviam sido previamente diagnosticadas com depressão. A amostra foi dividida em um grupo que receberia TCC conforme protocolo original e outro que receberia uma versão adaptada para mulheres africanas. As sessões eram semanais, com 16 intervenções com duração de 90 minutos.

Ambos os grupos apresentaram redução significativa na pontuação de depressão (Escala de Depressão de Beck – BDI); contudo, o grupo que teve a intervenção adaptada teve um escore levemente maior no início conforme a BDI, e a redução de sintomas ao longo das intervenções foi maior do que com o tratamento habitual. Dessa forma, os autores sinalizam a importância de se pensar na elaboração de intervenções que considerem as diferenças culturais (Kohn, Oden, Muñoz, Robinson, & Leavitt, 2002).

Em outro estudo, na Islândia, a TCCG foi aplicada em 30 mulheres diagnosticadas com depressão, com idades entre 22 e 45 anos ($M = 27,73$), divididas em grupo experimental ($n = 19$) e grupo-controle ($n = 11$). As sessões foram realizadas por enfermeiras, durante quatro semanas consecutivas. As participantes eram submetidas a 2 horas de psicoterapia,

com um pequeno intervalo para lanche. Os resultados indicaram que o grupo-controle apresentou menos distresse comparado com o grupo que teve a intervenção, contudo, esta não foi estatisticamente significativa. A partir da Escala de Depressão de Beck, utilizada para mensurar a mudança pré e pós-teste, observou-se uma diminuição de sintomas no grupo que recebeu a intervenção (Bernhardsdottir, Vilhjalmsson, & Champion, 2013).

Thrimm e Antonsen (2014) investigaram a efetividade da TCCG em 143 noruegueses adultos, que participaram do tratamento entre 2002 e 2013. Todos os pacientes passaram por 12 sessões semanais, com 120 minutos cada, incluindo 15 minutos para pausa. A taxa de *dropout* foi de 17,5% (25 pacientes), e a medida de avaliação de melhora para depressão foi a BDI II. Os resultados indicaram uma redução estatisticamente significativa da depressão, com resultados na BDI II reduzindo de 28,5 para 18,5 ($d = 0,97$), e melhora mantida por até três meses após o *follow up* ($d = 1,10$). Do total, 44% dos pacientes demonstraram melhoras nos sintomas de depressão, e no *follow up* essa taxa aumentou para 57%. A efetividade foi estudada, ainda, por Nielsen (2015), que também aplicou um protocolo de 12 semanas, utilizando a BDI II como medida de resposta ao tratamento. A amostra consistiu em 48 pacientes com idades entre 20 a 67 anos ($M = 37,5$), diagnosticados com depressão, cujos resultados também indicaram uma redução de 10 pontos na BDI II após o tratamento. Além dessas pesquisas, muitas outras podem ser citadas, de diferentes nacionalidades, que demonstram que existe um efeito comprovado da TCCG visível após o tratamento de 12 semanas, observável até seis meses depois. Em contrapartida, não existem evidências de seus efeitos após esse período, indicando que uma possível solução possa ser, transcorrido esse período, submeter novamente os pacientes a um curso de mais seis meses de psicoterapia, visando diminuir suas recaídas e ajustar seus possíveis erros cognitivos (Feng et al., 2012).

No Brasil, ainda são escassas as apresentações de trabalhos de TCCG. A título de exemplificação, serão citados aqueles realizados dentro do Programa de Transtornos Afetivos (PROGRUDA) do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo (HCFMUSP). O primeiro estudo a ser

citado foi realizado por Cristiana Vallias com Priscilla Derdyck, as quais testaram dois formatos de TCCG para depressão, um com protocolo definido e outro com os temas decididos pelo próprio grupo. Participaram do estudo 11 pacientes, com idades entre 20 e 66 anos, com episódio depressivo atual. Os principais resultados indicaram que o grupo direcionado favoreceu o desenvolvimento de maiores repertórios cognitivo-comportamentais e, principalmente, no manejo dos sintomas depressivos. Lima e Derdyck (2001) relatam ainda a adesão de ambos os grupos às intervenções, à exceção das tarefas de casa, além de ressaltarem intervenções de sucesso no formato de grupos psicoeducacionais para essa população.

No que se refere aos grupos psicoeducacionais, em 1997, foi criado, no PROGRUDA, o primeiro grupo psicoeducacional brasileiro relatado em literatura científica com proposta para transtornos do humor. O grupo era fechado, com sessões de duas horas de duração realizadas mensalmente, e seu objetivo era mostrar a importância, para os pacientes, do senso de pertencimento a um grupo de pessoas que compartilham os mesmos problemas do transtorno. Todos os encontros obedeciam ao mesmo formato; o tema era apresentado por um psiquiatra e/ou um psicólogo do grupo durante uma hora, e, posteriormente, a plateia participava fazendo perguntas e contando suas experiências com a doença. A discussão possibilitava o esclarecimento de dúvidas a respeito do transtorno e do tratamento, bem como a troca de experiências de pacientes, familiares e profissionais a respeito das dificuldades em reconhecer e manejar os sintomas. Além disso, permitia entender os efeitos colaterais da farmacoterapia, aumentando, assim, a adesão e prevenindo recaídas e recorrências. Foi possível observar que, além de promover a ampliação do conhecimento de pacientes e suas famílias acerca da doença e seu tratamento, a intervenção também deu sentido à experiência vivida, engajando os pacientes no uso dessa compreensão em seu dia a dia (Roso, Moreno, & Costa, 2005). Essa proposta de grupo é praticada até hoje, porém no formato aberto, para que mais pessoas possam participar e, assim, diminuir o estigma e o preconceito em relação ao transtorno (Fig. 4.1).

PROGRAMA DO GRUPO DE DOENÇAS AFETIVAS- PROGRUDA
INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DO HOSPITAL DAS CLÍNICAS DA FACULDADE DE MEDICINA HC-FMUSP



ENCONTROS PSICOEDUCACIONAIS GRATUITOS 2016

Coordenação:
Prof. Dr. Ricardo Alberto Moreno
Psic. Denise Petresco David

Organização:
Psic. Geiza Antunes
Psic. Larissa Mendes.

Equipe médica, paciente e família: como o trabalho conjunto pode melhorar a
Qualidade de Vida na Depressão e no Transtorno Bipolar?



Programação 2016

1º SEMESTRE	2º SEMESTRE
18/03 Como diferenciar a tristeza da Depressão: reconhecendo os tipos de depressão e seus sinais. Prof. Dr. Ricardo A. Moreno Dr. Frederico N. Demétrio	12/08 Afinal, qual é a causa da Depressão e do Transtorno Bipolar? Cuidados maternos, genética e estresse. Dr. Márcio G. S. Souza Psic. Danielle S. Bio
15/04 Mudança de humor e Transtorno Bipolar: tipos de transtorno bipolar e seus sinais. Dra. Doris H. Moreno Dr. Giovanni Missio	16/09 Autoajuda na Depressão e no Transtorno Bipolar: estilo de vida. Dr. Fernando Fernandes Fisiot. Janette Canales
13/05 A Depressão começa aos poucos: sinais de alerta. Dra. Aline V. Chaves Psic. Denise P. David	07/10 O Tratamento continua depois do alívio dos sintomas: prevenção de recaídas e recorrências. Dr. Diego Tavares Psic. Geiza Antunes
10/06 Conflitos emocionais na família do paciente bipolar. Psic. Adriana M. Carneiro Psic. Larissa Mendes	11/11 Planejamento, rotinas e autocuidado: qualidade de vida ao seu alcance. Prof. Dr. Ricardo A. Moreno Dr. Volnei V. R. da Costa

Local: Instituto de Psiquiatria - HC - FMUSP, Anfiteatro Principal
Rua Dr. Ovídio Pires de Campos, 785 - São Paulo - SP

Atenção: Vagas limitadas preenchidas por ordem de chegada.
Para outras informações consulte o GRUDA - Tel. (11) 2661-6648; www.progruda.com

Horário: das 14h às 16h
Comparecer com 30 minutos de antecedência.

Estudantes: solicitar certificado no ato da inscrição. Valor do certificado: R\$ 30,00

Realização:



Apoio:

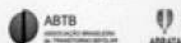


Figura 4.1 Exemplo de temas elaborados para os encontros psicoeducacionais.

Fonte: Programa de Transtornos Afetivos (PROGRUDA, 2016).

Tantos outros estudos poderiam ser citados neste tópico; contudo, buscou-se selecionar apenas alguns mais recentes que representassem, mesmo que de maneira tímida, evidências de efetividade e eficácia em diferentes culturas.

Por fim, o tratamento da depressão perpassa pela dificuldade em se ter um protocolo específico que possa auxiliar o clínico, o que muitas vezes acaba por gerar uma heterogeneidade de protocolos. A título de ilustração, alguns estudos recentes sobre TCCG se encontram descritos na Tabela 4.1.

Tabela 4.1 Descrição de estudos mais recentes sobre a efetividade da TCCG

Estudos	Temas	Sessões/tempo	Participantes	Resultados
Kohn e colaboradores (2002)	Identificação dos sintomas da depressão; reestruturação cognitiva; desenvolvimento de técnicas comportamentais para manejo dos sintomas; identificação de atividades de maestria e prazer Foram incluídas 4 sessões especificamente para essa população sobre relacionamentos saudáveis, religiosidade, espiritualidade e identidade feminina em famílias afro-americanas.	16 sessões 90 min	18 participantes (8 na TCC tradicional e 10 na TCC adaptada)	Ocorreu melhora em ambos os grupos, contudo o grupo com a terapia adaptada apresentou redução maior nas pontuações da BDI (de 34,4 para 21,8) quando comparado ao grupo com terapia não adaptada (de 30,3 para 24,4)
Bockting e colaboradores (2005)	Identificação de pensamentos e atitudes negativas; atividades para reestruturação cognitiva; trabalho com memórias (foco na redução de memórias negativistas)	8 sessões 120 min	81 participantes com depressão em remissão distribuídos em grupos de 7-12 membros	A TCC apresentou um efeito protetivo para pacientes que estavam em remissão do transtorno (<i>hazard ratio</i> [57,95%])
Ryum, Hagen, Nordahl, Vogel e Stiles (2009)	Psicoeducação para depressão e ansiedade, identificação e manejo de pensamentos e comportamentos disfuncionais; experimentos <i>in vivo</i> ; reestruturação cognitiva	8 semanas, com 2 sessões por semana 90 min	27 participantes diagnosticados com depressão (5-8 por grupo)	O principal indicador de melhora era o clima grupal. O engajamento dos pacientes era associado com a diminuição de escores nas escalas de depressão e ansiedade.
Matsunaga e colaboradores (2010)	Psicoeducação sobre TCC e depressão; automonitoramento; reestruturação cognitiva	12 sessões 90 min	43 participantes com depressão distribuídos em grupos de 5-6 pacientes por grupo	A Escala de Hamilton para Depressão indicou redução de 14,7 para 9,2, ou seja, quase 50%
Feng e colaboradores (2012)	O artigo não aborda essa parte; trata-se de uma metanálise sobre a eficácia da TCCG entre os anos 2000-2010	8-12 semanas 60 min por semana	Analisaram 48 estudos Geralmente de 6-10 pessoas	16 práticas terapêuticas apresentaram um efeito imediato moderado da terapia ($g = -0,40$ $ci = -0,68$ a $-0,11$ $p = 0,001$); após seis meses, esse efeito é menor ($g = -0,38$ $CI = -0,60$ a $-0,16$ $p = 0,001$)
Goodman e Santangelo (2011)	Psicoeducação, técnicas de reestruturação cognitiva, estratégias de <i>coping</i> , suporte social e temas específicos; a depressão pós-parto como manejo de estresse, transição para o papel de mãe, estratégias de comunicação, planejamento familiar, interação mãe-bebê	4-12 semanas 50-120 min	Revisão sistemática focada em depressão pós-parto; 11 estudos randomizados com grupo-controle	Discutem sobre a eficácia da TCC para a redução de sintomas quando baseada nesse protocolo

publicados entre 2008-2011 6-8 participantes				
Bernhardsdottir e colaboradores (2013)	Psicoeducação, TCC, reestruturação cognitiva, técnicas comportamentais de distração, relaxamento	4 sessões (TCC breve) 120 min	28 participantes (universitários) 11 receberam a intervenção	Níveis de depressão (BDI) reduziram de 8,36 para 4,16, e de ansiedade (BAI), de 17,26 para 13,74
Parker, Page e Hooke (2013)	Psicoeducação, automonitoramento, reestruturação cognitiva, ativação comportamental, manejo do estresse, hábitos de vida, relaxamento, aspectos médicos da depressão e ansiedade	10 sessões diárias 90 min por dia	8 participantes, deprimidos	Redução da depressão (DASS) inicial de 24,14 foi para 17,73 no fator depressão e de 11,28 para 9,63 no fator ansiedade
McEvoy, Burgess e Nathan (2013)	Psicoeducação para depressão e ansiedade; técnicas comportamentais, como relaxamento; técnicas de exposição; reestruturação comportamental	10 sessões semanais 120 minutos	144 participantes, deprimidos 8-10 pacientes por grupo	Redução nas escalas Beck (BDI 30,51 para 18,02; BAI 20,03 para 13,13)
Teismann e colaboradores (2014)	Psicoeducação; reestruturação cognitiva; treino de atenção focada; estratégias cognitivas e comportamentais para reestruturação de pensamento; treino de expressão escrita para externalizar sentimentos; treino de resolução de problemas	11 semanas 90 minutos	3-9 participantes	Resultados indicados pela BDI indicaram redução significativa (de 22,93 para 10,23)
Okumura e Ichikura (2014)	Inclusão de protocolos que continham no mínimo ativação comportamental, reestruturação cognitiva e técnicas de relaxamento/ <i>mindfulness</i>	5-16 sessões Maior parte uma vez por semana, 60-150 min	Artigos buscados no período de 1994-2013 (35 artigos selecionados)	A TCC foi mais eficaz quando comparada a outras intervenções para depressão, observando-se diminuição de ao menos 2,5 pontos na HAM-D
Thrimm e Antonsen (2014)	Psicoeducação (2 sessões); assertividade (2), relacionamentos interpessoais (3 sessões), atividades de maestria e prazer (1 sessão), reestruturação cognitiva (8 sessões)	16 sessões 120 min (com 15 min de intervalo)	143 participantes Grupos com 5-7 participantes	Redução nas escalas Beck: BDI II (diminuiu de 28,5 para 18,5); BAI (19,07 para 14,74)
Nielsen (2015)	Psicoeducação; técnicas cognitivas de reestruturação de pensamento (4 sessões específicas de modificação de pensamentos negativos) e técnicas comportamentais para manejo de sintomas (distração, respiração, planejamento de atividades)	12 semanas 60 min	48 participantes distribuídos em grupos de 4-6 indivíduos	Os resultados indicaram melhoras nos índices de depressão ([pré BDI = 30,7 (M=9,9); pós 20,4 (M=12,6)])

Por fim, cabe ressaltar que, conforme verificado, a TCCG já é uma prática muito difundida em outros países, mas ainda carece de publicações brasileiras. Desse modo, com base nos estudos internacionais, que demonstram a eficácia da abordagem para depressão, é possível observar que, mesmo que essa prática seja limitada a um número específico de sessões e haja um número maior de demandas para se trabalhar, os resultados são promissores no que se refere à redução dos sintomas depressivos. Todavia,

assim como Friedman e colaboradores (2009) ressaltaram, ainda existe a necessidade de se investigar os benefícios em longo prazo.

CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO EM GRUPO

A TCCG para depressão deve ser educativa e com tempo determinado. Deve-se priorizar a reestruturação cognitiva para educar o paciente a identificar e responder a padrões de pensamento disfuncionais e desenvolver estratégias comportamentais (como a programação de atividades/eventos prazerosos e relaxamento) a fim de lidar com os sintomas depressivos, os quais podem ser intensos e incapacitantes, seja em sessão, seja fora dela (Wright, 2003). Da mesma forma que na TCCI, o terapeuta deve ter uma postura colaborativa e ativa no tratamento, buscando auxiliar os pacientes a identificar pensamentos prejudiciais e a responder a eles, de maneira funcional (Neufeld, Moreira, & Xavier, 2012). Para trabalhar com TCCG, é necessário que as diretrizes de tratamento sejam previamente definidas: tipo de contrato, grupo, tamanho e duração do grupo, população, critérios de seleção, como devem ser as sessões, duração, técnicas, presença ou não de coterapeuta ou de observador, entre outros fatores, os quais serão brevemente discutidos a seguir.

ESTRUTURA DOS ATENDIMENTOS

Em primeiro plano, o terapeuta deverá definir o caráter do grupo: psicoeducacional (aberto, sem número estipulado de participantes) ou fechado (com número estruturado de sessões e com os mesmos participantes ao longo do tempo). Em ambos os grupos, existem evidências de eficácia e efetividade para indivíduos com TDM; desse modo, deve-se considerar com cautela qual seria a melhor abordagem para os pacientes e familiares, como tempo de tratamento disponível e gravidade dos sintomas, porque, principalmente em um grupo composto por pacientes com depressão, a entrada e a saída de membros podem dificultar a coesão. O grau de interesse pessoal dos participantes uns pelos outros deve ser pensado com cautela, já que o resultado terapêutico em TCCG é determinado tanto pelas estratégias

formais da TCC elaboradas pelo terapeuta quanto pelo processo grupal, resultante da interação entre os membros (Neufeld, 2011).

Existe a possibilidade de que membros do grupo solicitem uma sessão individualizada para discutir questões que não gostariam ou não poderiam colocar no grupo; desse modo, atendimentos emergenciais devem ser pensados (poderão existir sessões individuais combinadas com as de grupo?). O que a experiência clínica das autoras demonstra é que, na depressão, disponibilizar essa possibilidade aos pacientes se mostra benéfico por ser um recurso que eles solicitam, em sua maioria, em decorrência do aumento/instabilidade dos sintomas.

SELEÇÃO E ENTREVISTA INICIAL

Como sabemos, após o terapeuta definir a estrutura do grupo, é necessário determinar o perfil de cada futuro membro, a fim de verificar sua adequação para o grupo. Ao selecionar as pessoas para se juntarem ao grupo de TCCG, a intenção é trazer aquelas que se beneficiarão com esse modo de tratamento, e, para isso, a sessão de avaliação é imprescindível. Essa seleção será importante também para criar a sensação de pertencimento do participante ao grupo e para instilar esperança mediante a similaridade das histórias, diminuindo, conseqüentemente, o sentimento de solidão, de incapacidade e de estranheza resultante do pensamento de ser a única pessoa com aquele tipo de problema, pensamento muito comum na depressão.

Nessa fase, os atendimentos são realizados individualmente, e uma breve anamnese deve ser feita para obtenção de dados clínicos, como história familiar de doenças mentais, tratamentos prévios ou atuais, principais queixas do paciente e principais eventos de vida. Aliado à anamnese, recomenda-se que sejam utilizadas escalas para avaliação de sintomas de humor, como a Bateria de Depressão Beck (Escala de Depressão, Ansiedade e Desesperança de Beck – BDI), pensamentos disfuncionais (Escala de Pensamentos Depressivos – EPD) e gravidade dos sintomas depressivos (Escala de Hamilton para Depressão – HAM-D).

Ao terapeuta, a utilização de entrevistas e escalas também serve para ajudar a estipular critérios de inclusão dos participantes no que se refere à

gravidade dos sintomas. Esse item é de suma importância, tendo em vista que a TCC é indicada como efetiva para o tratamento de TDM apenas em níveis leve e moderado. O uso das escalas de autorrelato deve ser incentivado, e uma maneira rápida de trabalhar com elas é fornecê-las aos participantes antes do início do grupo e solicitar ao coterapeuta para que confira seu preenchimento e possíveis dúvidas. Essas medidas psicométricas são valiosas ferramentas para comparar a melhora do indivíduo por medidas padronizadas. Desse modo, paciente e terapeuta conseguem contabilizar a melhora quantitativamente, não apenas mediante seu relato subjetivo.

Em geral, alguns critérios de inclusão e exclusão que devem ser considerados são: idade (adolescente, adulto ou idoso), sexo, escolaridade, tempo de doença e, como já abordado, gravidade da doença. É importante pensar no tempo da doença e na gravidade, pois a intensidade dos sintomas será diferente, assim como o tempo de recuperação deles: esses pacientes comumente são aqueles que já passaram por diferentes tratamentos, diferentes médicos, e tiveram o mesmo desfecho. Assim, devem ser psicoeducados e trabalhados com muita cautela e paciência. Ainda nos critérios de exclusão, é importante colocar abuso de álcool e drogas, transtornos da personalidade e outras comorbidades, como transtorno obsessivo-compulsivo (TOC), pois sua presença pode mudar o andamento de todo o grupo. Presença de ideação suicida no participante é obrigatoriamente critério de exclusão. Ele deve ser encaminhado para tratamento individual, e deve-se acionar familiares e psiquiatras.

CONTRATO

Na entrevista, também são informados os objetivos, as vantagens e as limitações da terapia em grupo, bem como os ganhos que cada pessoa pode obter com sua participação. Após consentimento do participante, é realizado o contrato, que deve abranger informações como tipo de tratamento, semanas, horário e dia da semana, honorários, faltas e interrupção de tratamento. Considerando o grupo com pessoas com depressão, cujos sintomas também englobam desânimo e falta de interesse/prazer pelas atividades, além do isolamento social, é necessário também que o paciente indique uma pessoa

para ser o “contato de emergência”, que pode ser alguém da família ou um amigo próximo. Essa pessoa será importante para auxiliar o participante a comparecer aos grupos seguindo sua regularidade.

TIPO DE GRUPO (TAMANHO, DURAÇÃO E POPULAÇÃO, CRITÉRIOS DE SELEÇÃO)

Como abordado anteriormente, a TCCG é uma prática estruturada, que visa à educação do paciente de seus sintomas e também de mecanismos que sejam capazes de identificar seus gatilhos; por isso, é uma intervenção de tempo limitado. Não existe um consenso sobre qual seria o número adequado de sessões de TCCG para depressão; contudo, os resultados já demonstram redução significativa da sintomatologia em torno de 8 a 12 sessões, realizadas uma vez por semana, com duração de 60 a 120 minutos, com um número entre 5 e 10 membros (Feng et al., 2012; Okumura & Ichikura, 2014). Deve-se determinar um número mínimo de participantes, pelo fato de ser necessária uma massa crítica para que haja um grupo interativo, e o limite de pessoas, para que todos do grupo possam participar de forma produtiva. Por fim, cabe considerar que a resposta ao tratamento dependerá não só do tipo de depressão, mas também do número de comorbidades e da gravidade dos sintomas.

TIPO DE SESSÃO (CONTEÚDO, TÉCNICA)

Para o transtorno depressivo, o grupo deve ter pelo menos quatro componentes elementares: psicoeducação, sessões expositivas, reestruturação cognitiva e tarefas de casa. Algumas técnicas podem facilitar a aquisição de novas cognições e comportamentos e podem ser cognitivas (p. ex., reestruturação cognitiva), comportamentais (p. ex., registro de atividades) ou de *role playing*, relaxamento, controle da respiração, assertividade, exposição a situações sociais, entre outras. Também é relevante que as intervenções cognitivas ocorram sempre antes, durante e após cada exposição. Assim, um dos objetivos da terapia em grupo é fazer o paciente tornar-se o seu próprio terapeuta, para que consiga enfrentar as situações do dia a dia. Normalmente, apesar de não se ter uma estrutura fechada sobre qual seria o conteúdo

específico a ser abordado nas sessões, o esperado é que elas sejam organizadas conforme o Quadro 4.1, que cita um exemplo de como as autoras costumam organizar as sessões, em associação aos dados encontrados em levantamento de literatura descritos anteriormente.

O modelo apresentado no Quadro 4.1 é um exemplo de como as sessões devem ser estruturadas, e o Quadro 4.2 fornece um racional para os atendimentos. Como já abordado, é importante que pelo menos duas sessões intermediárias sejam sobre psicoeducação. Segundo Wright e colaboradores (2008), o aprendizado de habilidades para mudança das cognições, estados de humor e de comportamento deve instrumentalizar o paciente com conhecimentos que auxiliam na redução dos riscos de reincidência dos sintomas. Nesse sentido, devem ser oferecidos ao grupo materiais, apresentados em forma de texto, com a finalidade de contextualizar o paciente sobre o modelo de tratamento baseado na TCCG, as principais distorções cognitivas, os sintomas da depressão e as características do TDM.

Quadro 4.1 Esquema de sessão psicoterápica para pacientes com depressão

Sessão	Conteúdo	Tarefas de casa
1 e 2	Psicoeducação: - O que é depressão? - Como diferenciar depressão de tristeza? - Fatores de risco para depressão: identificando meus problemas	Leitura (Capítulos 1 e 2 do livro <i>Vença a depressão</i> (Leahy, 2015); Capítulo 1 do livro <i>A mente vencendo o humor</i> (Greenberger & Padesky, 2017)); utilização de aplicativos para controle diário do humor.
3	Como anda meu tratamento? Dúvidas e questionamentos sobre o diagnóstico, quadro clínico da depressão e sintomas.	Leitura: <i>Vença a depressão</i> (Leahy, 2015) – Capítulo 2 do livro <i>Recuperação da depressão</i> (Moreno, Bernik, Mattos, & Cordás, 2003)
4	Identificando meus pensamentos (reestruturação cognitiva); o modelo ABC.	Texto: <i>Encontrando distorções de seu pensamento</i> (elaborado pelas autoras)
5 e 6	Meus pensamentos persistentes: o que fazer quando seus pensamentos não lhe deixam? Identificando pensamentos positivos e padrões negativistas.	Registro de pensamentos disfuncionais; lista de pensamentos automáticos; capítulo <i>Combata seus pensamentos distorcidos</i> (Branch & Wilson, 2011)
7 e 8	Repensando em meus hábitos: utilizando a respiração a seu favor e praticando bons hábitos de vida; a importância das atividades em seu humor.	Texto elaborado pelas autoras sobre a importância do sono, da prática de atividades físicas e da respiração; e vídeo <i>How to meditate in one moment</i> (Borson, 2011).
9 e 10	Como as pessoas influenciam em meu humor? Minha rede de suporte social (sociabilidade); estabelecendo contatos, reafirmando amizades, fortalecendo vínculos.	<i>Caderno de exercícios e dicas para fazer amigos e ampliar suas relações</i> (Lamourère, 2013); cronograma de atividades diárias e desafios.
11	Prevenção de recaída: revisão das técnicas ensinadas; sessão de perguntas e respostas (com dinâmica).	Leitura <i>Agora que estou melhor, como faço para continuar bem?</i>

Quadro 4.2 Modelo de estrutura de sessão

Primeira sessão:

- Aplicação das escalas de avaliação, que são preenchidas pelos pacientes na sala de espera.
- Início da sessão: relembrar as regras básicas de como funciona o grupo, o que é a TCC, tarefas a serem realizadas, limite de faltas, tolerância de atraso e características específicas da TCCG.
- Dinâmica de grupo: este é um momento muito importante, por se tratar de uma das principais dificuldades relatadas pelos pacientes. O relacionamento, uma técnica inicial que pode ser utilizada para facilitar a apresentação, é a dinâmica nomeada como “quebra-gelo”, que propicia um ambiente mais favorável ao início do grupo com o conhecimento dos nomes entre a equipe e os integrantes. Para a realização dessa técnica, divide-se o grupo em duplas, e cada um dos integrantes deve apresentar seu par; antes disso, é dado um tempo para que possam conversar e falar mais sobre suas características, qualidades, entre outros assuntos.
- Estabelecimento de metas e objetivos: ao término da apresentação, é sugerido aos participantes que estabeleçam metas e objetivos que desejam alcançar com o tratamento, maximizando, assim, a motivação e a participação dos integrantes nos encontros.

Sessões intermediárias – estrutura básica:

- Aplicação de escalas ou inventários para verificação da depressão e dos sinais de alerta.
- Registro e síntese da sessão anterior: os membros do grupo compartilham seu desenvolvimento, relatando suas experiências com a lição de casa. Todos podem aprender com as experiências tiradas das atividades realizadas pelos outros; por isso, quanto mais pessoas fizerem a lição de casa, melhor, mas não deve ser obrigatório. O terapeuta, em conjunto com os participantes do grupo, faz um resumo dos principais temas abordados na sessão anterior.
- Agenda ou roteiro da sessão: contém o que será realizado na sessão; deve ser flexível, para que os participantes possam colaborar. A habilidade no desenvolvimento da agenda facilita o sentimento de coesão do grupo. Por exemplo, considerando a sessão que falará sobre pensamentos, pode-se solicitar a lista de pelo menos um pensamento automático de cada pessoa, e o mais marcante para o maior número de indivíduos será o foco da sessão.
- Discussão de tópicos do roteiro: temas ou questões propostos pelo próprio grupo que tenham relevância e estejam de acordo com o tema sugerido – por exemplo: o que é depressão, assertividade, relaxamento, doença mental, estigma e preconceito, etc.
- Estabelecimento de lições ou tarefas de casa conforme exemplo no item 2, para facilitar a aquisição ou treino de novos repertórios cognitivos e comportamentais: a lição de casa terapêutica procura colocar em prática o que foi discutido na sessão, buscando integrar a terapia e a vida cotidiana; portanto, deve ser incentivada em todas as sessões.
- Resumo final: enfatiza os tópicos mais importantes da sessão.
- *Feedback*: verifica o entendimento dos membros do grupo acerca dos conteúdos abordados e suas possíveis distorções. Exemplo: durante o *feedback* em um exercício de exposição, os participantes do grupo concluíram que, no cotidiano, existe menos limitação para se manter uma conversa do que imaginavam; assim, eles perceberam que o medo nesse contexto era exagerado.

Sessões finais:

- Avaliação das habilidades adquiridas de cada membro do grupo com a TCCG.
- Aplicação de escalas ou inventários para fazer a medição da depressão.
- *Follow-up*: agendar sessões com os participantes para avaliar a manutenção dos ganhos obtidos com a TCCG e verificar a gravidade da depressão, como o grau de distorção de pensamentos.

Como discutido anteriormente, não existe um protocolo único para TCCG para depressão. Muitas vezes, os protocolos são adequados às queixas dos participantes, e será necessário que em cada item o terapeuta elenque ao menos uma situação de cada pessoa para que possa contemplar a todos naquela sessão. Desse modo, a presença de um coterapeuta deve ser pensada.

FORMATO: PRESENÇA DE TERAPEUTA OU OBSERVADOR?

Esta é uma decisão importante ao psicólogo. Como dito anteriormente, o profissional deverá abordar os conteúdos do cronograma de forma que todos os participantes sejam atendidos em sua necessidade, dividindo o período de tempo entre eles. Para isso, é recomendável que ele convide um colega que seja da mesma orientação teórica para colaborar na preparação, observação e condução das sessões em grupo (coterapeuta). Durante as sessões, o coterapeuta será aquele que estará focado na observação do comportamento dos participantes ao longo das tarefas, contribuindo para um olhar diferente do terapeuta que está aplicando as técnicas. Servirá também de elemento coringa para os atendimentos, principalmente no caso de, durante a sessão, observar que existe algum participante com maior angústia: isso permite que esse paciente tenha um atendimento mais personalizado e que o grupo continue sem interrupções. Além disso, há a possibilidade também da presença de um observador, ou seja, uma pessoa para observar e anotar tudo o que acontece nas sessões. Quando o psicólogo não tiver recursos para fazer gravações audiovisuais, serve como um recurso adequado para colaborar na elaboração do planejamento da terapia de grupo e também avaliar sua conduta.

A PSICOEDUCAÇÃO NA DEPRESSÃO

Em grupos de TCCG para depressão, é necessário salientar a importância da psicoeducação em grupo como técnica para engajar os pacientes no tratamento, bem como ampliar o sentimento de mútua ajuda entre si. A psicoeducação consiste na transmissão de informação acerca do diagnóstico, elucidando o paciente sobre aspectos da psicopatologia da depressão. É, portanto, conteúdo imprescindível no tratamento da doença, seja mediante grupo aberto, com um número entre 12 e 20 sessões a esse respeito, seja na TCCG fechada, com ao menos duas sessões voltadas a essa prática (Figueiredo, Souza, Dell'Áglio, & Argimon, 2009; Muñoz et al., 2000).

Essa intervenção se caracteriza por fornecer ao paciente informações sobre seu diagnóstico, a etiologia, o funcionamento, o tratamento mais indicado e o

prognóstico de sua doença. Cabe também à aplicação dessa técnica esclarecer informações insuficientes ou distorcidas, tendo em vista a importância de um conhecimento amplo do indivíduo sobre seu problema (Daele, Hermans, Audenhove, & Bergh, 2012). O terapeuta pode e deve utilizar muitas maneiras de psicoeducar o paciente, além de fazer explicações nas sessões, como, por exemplo, levar revistas, indicar livros, *sites* e outros informativos sobre a depressão.

A psicoeducação acerca da psicopatologia, além de aumentar a motivação para a mudança, estimula a participação proativa do paciente na recuperação (Glick, Burti, Okonogi, & Sacks, 1994). A técnica também está associada a maior satisfação com o tratamento psicológico, maior adesão e redução de recaídas, podendo ser feita por meio de atribuição de tarefas de casa, encontros individuais ou sessões de grupo (Daele et al., 2012).

De forma geral, os temas psicoeducacionais devem ser abrangentes e incluir discussões que envolvam diferentes perspectivas, ou seja, falar da depressão sob a ótica do paciente, dos pais, dos filhos e também dos amigos, bem como dos danos laborais consequentes dos sintomas. A Figura 4.1 é um exemplo de planejamento psicoeducacional realizado anualmente no PROGRUDA, departamento do qual as autoras participam e colaboram com a manutenção das palestras.

Uma forma de melhorar o grupo psicoeducativo pode ser realizar, após a primeira sessão com os participantes, um *brainstorm* sobre o que eles gostariam de saber mais ou, ainda, quais são as dúvidas que têm a respeito de seu tratamento ou da identificação de sintomas que os incomodam no dia a dia. Desse modo, será possível agregar informações ao conteúdo programático, permitindo uma participação maior dos pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E TENDÊNCIAS FUTURAS

Este capítulo teve por objetivo apresentar a prática de TCCG para depressão, a qual reúne estudos que comprovam sua efetividade e eficácia. Cabe ressaltar que o TDM é uma doença multifacetada, e, portanto, os pacientes

podem apresentar diferentes sintomas e manifestações da mesma doença. A falta de um protocolo específico de TCCG pode ser justificada pela natureza multifacetada da doença e por questões culturais envolvidas.

Apesar da “inconsistência metodológica” em relação à ordem em que os conteúdos devem ser abordados e da falta de um consenso científico sobre os assuntos a serem abordados, a TCCG não deixa de apresentar pontos específicos e necessários, como a psicoeducação, a reestruturação de pensamentos e as estratégias comportamentais. Espera-se que a abordagem origine novas investigações, para elucidar quais seriam os parâmetros ideais que justificariam sua eficácia.

Por fim, com base em evidências práticas, não são todos os pacientes que conseguem se adaptar a estratégias em grupo. Montar um grupo equilibrado com indivíduos com depressão pode ser desafiador, portanto, terapeutas devem investir mais tempo e energia na seleção cuidadosa de pacientes para a terapia de grupo e na preparação antes da terapia, a fim de evitar o abandono. Por isso, não é indicado ao psicoterapeuta sem experiência em transtornos do humor iniciar sua prática psicoterápica diretamente em grupos para TDM.

Outros desafios na prática de TCCG para depressão estão na estabilização dos sintomas e na integração da família como supervisora do tratamento ou, ainda, em sessões de psicoeducação. Por isso, a relação entre psicólogo, coterapeuta e psiquiatra deve ser constante, com o objetivo de fazer o paciente conseguir administrar os sintomas da doença, com vistas a sua remissão.

REFERÊNCIAS

Beck, A. T., Rush, A. J., Shaw, B. F., & Emery, G. (1982). *Terapia cognitiva da depressão*. Rio de Janeiro: Zahar.

Beck, J. S. (1997). *Terapia Cognitiva: Teoria e prática*. Porto Alegre: Artmed.

Beck, A. T., & Weishaar, M. E. (2000). Cognitive therapy. In D. Wedding, & R. J Corsini (Eds.), *Current psychotherapies* (6th ed., pp. 241-272). Ithaca: F. E. Peacock.

Bernhardsdottir, J., Vilhjalmsón, R., & Champion, J. D. (2013). Evaluation of a brief cognitive behavioral group therapy for psychological distress among female Icelandic university students. *Issues in Mental Health Nursing*, 34(7), 497-504.

- Bockting, C. H. L., Schene, A. H., Spinhoven, P., Koeter, M. W. J., Wouters, L. F., Huyser, J., & Kamphuis, J. H. (2005). Preventing relapse/recurrence in recurrent depression with cognitive therapy: A randomized controlled trial. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(4), 647-657.
- Borison, T. (2011). *How to meditate in one moment* [video]. Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=F6eFFCi12v8>
- Branch, R., & Wilson, R. (2011). *Terapia cognitivo-comportamental para leigos*. Rio de Janeiro: Alta Books.
- Canadian Network for Mood and Anxiety Treatments (CANMAT). (2012). *Treating depressive disorder: Relapse and recurrence*. Recuperado de <http://www.canmat.org/cme-depression-relapse-and-recurrence.php>
- Daele, T. V., Hermans, D., Audenhove, C. V., & Bergh, O. V. (2012). Stress reduction through psychoeducation: A meta-analytic review. *Health Education & Behavior*, 39(5), 474- 487.
- Fava, G. A., Ruini, C., Rafanello, C., Finos, L., Conti, S., & Grandi, S. (2004). Six year outcome of cognitive behavior therapy for prevention of recurrent depression. *American Journal of Psychiatry*, 161(10), 1872-1876.
- Feng, C. Y., Chu, H., Chen, C. H., Chang, Y. C., Chen, T. H., Chou, Y. H. ... Chou, K. R. (2012). The effect of cognitive behavioral group therapy for depression: A meta analysis 2000-2010. *Worldviews on Evidence-Based Nursing*, 9(1), 2-17.
- Figueiredo, A., Souza, L., Dell'Áglio, J. C., & Argimon, I. L. (2009). O uso da psicoeducação no tratamento do transtorno bipolar. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 11(1), 15-24.
- Friedman, E. S., Thase, M. E., Wisniewski, S. R., Trivedi, M. H., Biggs, M. M., Fava, M. ... Rush, A. J. (2009). Cognitive therapy argumentation versus CT switch treatment: A STAR*D report. *International Journal of Cognitive Therapy*, 2(1), 66-87.
- Glick, I. D., Burti, L., Okonogi, K., & Sacks, M. (1994). Effectiveness in psychiatric care. III: Psychoeducation and outcome for patients with major affective disorder and their families. *The British Journal of Psychiatry*, 164(1), 104-106.
- Goodman, J. H., & Santangelo, G. (2011). Group treatment for postpartum depression: A systematic review. *Archives of Womens Mental Health*, 14(4), 277-293.
- Greenberger, D., & Padesky, C. A. (2017). *A mente vencendo o humor: Mude como você se sente, mudando como você pensa* (2. ed.). Porto Alegre: Artmed.
- Hollon, S. D., & Shaw, B. F. (1979). Group cognitive therapy for depressed patients. In A. T. Beck, A. J. Rush, B. F. Shaw, & G. Emery (Eds.), *The handbook of psychotherapy and behavior change: An empirical analysis* (2. ed.). New York: Wiley.
- Israel, J. A. (2010). The impact of residual symptoms in major depression. *Pharmaceuticals*, 3(8), 2426-2440.
- Kohn, L. P., Oden, T., Muñoz, R. F., Robinson, A., & Leavitt, D. (2002). Adapted cognitive behavioral group therapy for depressed low income African American women. *Community Mental Health Journal*, 38(6), 497-504.

- Lamourère, O. (2013). *Caderno de Exercícios e dicas para fazer amigos e ampliar suas relações*. São Paulo: Vozes.
- Leahy, R. (2015). *Vença a depressão antes que ela vença você*. Porto Alegre: Artmed.
- Lewinsohn, P. M., Muñoz, R. F., Youngren, M. A., & Zeiss, A. M. (1978). *Control your depression*. Englewood Cliffs: Prentice-Hall.
- Lima, C. V. O., & Derdyck, P. R. (2011). Terapia cognitivo-comportamental em grupo para pessoas com depressão. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 491-498). Porto Alegre: Artmed.
- Maj, M., Veltro, F., Pirozzi, R., Lobrache, S., & Magliano, L. (1992). Pattern of recurrence of illness after recovery from an episode of major depression: A prospective study. *American Journal of Psychiatry*, 149(6), 794-800.
- Matsunaga, M., Okamoto, Y., Suzuki, S., Kinoshita, A., Yoshimura, S., Yoshino, A. ... Yamawaki, S. (2010). Psychosocial functioning in parents with treatment-resistant depression after group cognitive behavioral therapy. *BMC Psychiatry*, 10, 22.
- McEvoy, P. M., Burgess, M. M., & Nathan, P. (2013). The relationship between interpersonal problems, negative cognitions and outcomes from cognitive behavioral group therapy for depression. *Journal of Affective Disorders*, 150(2), 266-275.
- Moreno H. D., Bernik M., Mattos P., & Cordás T. A (2003). *Recuperação em depressão*. São Paulo: Livre.
- Muñoz, R. F., & Miranda, J. (1996). *Group therapy manual for cognitive-behavioral treatment of depression*. Arlington: RAND Corporation
- Muñoz, R. F., Ippen, C. G., Rao, S., Le, H. N., & Dwyer, E. V. (2000). *Manual for group cognitive-behavioral therapy of major depression: A reality management approach*. San Francisco: Cognitive-Behavioral Depression Clinic Division of Psychosocial Medicine San Francisco General Hospital University of California.
- Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B., Moreira, C. A. M., & Xavier, G. S. (2012). Terapia cognitivo-comportamental em grupos de emagrecimento: O relato de uma experiência. *Psico*, 43(1), 93-100.
- Nielsen, M. (2015). CBT group treatment for depression. *The Cognitive Behaviour Therapist*, 8(e8), 1-11.
- Okumura, Y., & Ichikura, K. (2014). Efficacy and acceptability of group cognitive behavioral therapy for depression: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, 164, 155-164.
- Parikh, S. V., Segal, Z. V., Grigoriadis, S., Ravindran, A. V., Kennedy, S. H., Lam, R. W., & Patten, S. B. (2009). Canadian network for mood and anxiety treatments (CANMAT): Clinical guidelines for the management of major depressive disorder in adults II. Psychotherapy alone or in combination with antidepressant medication. *Journal of Affective Disorders*, 117(Suppl. 1), S15-S25.
- Parker, T. J., Page, A. C., & Hooke, G. R. (2013). The influence of individual, group, and relative self-esteem on outcome for patients undergoing group cognitive-behavioural therapy treatment. *British*

Journal of Clinical Psychology, 52(4), 450-463.

Programa de Transtornos Afetivos (PROGRUDA) (2016). *Programação psicoeducacional 2016*. São Paulo: USP. Recuperado de <https://progruda.com/>

Roso, M. C., Moreno, R. A., & Costa, E. M. S. (2005). Intervenção psicoeducacional nos transtornos do humor: A experiência do Grupo de Estudos de Doenças Afetivas (GRUDA). *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 27(2), 165.

Ryum, T., Hagen, R., Nordahl, H. M., Voegel, P. A., & Stiles, T. C. (2009). Perceived group climate as a predictor of long term outcome in a randomized controlled trial of cognitive behavioural group therapy for patients with comorbid psychiatric disorders. *Behavioural Cognitive Psychotherapy*, 37(5), 497-510.

Teismann, T., von Brachel, R., Hanning, S., Grillenberger, M., Hebermehl, L., Hornstein, I., & Willutzki, U. (2014). A randomized controlled trial on the effectiveness of a rumination-focused group treatment for residual depression. *Psychotherapy Research*, 24(1), 80-90.

Thrimm, J. C., & Antonsen, L. (2014). Effectiveness of cognitive behavioral group therapy for depression in routine practice. *BMC Psychiatry*, 14, 292-301.

White, J. R., & Friedman, A. S. (1942). *Cognitive behavioural group therapy for specific problems and populations*. Washington: American Psychological Association.

Wright, J. H. (2003). Cognitive-behavior therapy for chronic depression. *Psychiatric Annals Journal*, 33, 777-784.

Wright, J. H., Basco, M. R., & Thase, M. E. (2008). *Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: Um guia ilustrado*. Porto Alegre: Artmed.

LEITURAS RECOMENDADAS

Vinogradov, S., & Yalom, D. I. (1992). *Manual de psicoterapia de grupo*. Porto Alegre: Artes Médicas.

Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2006). *Psicoterapia de grupo* (5. ed.). Porto Alegre: Artmed.

5



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNO BIPOLAR

**Bernardo Carramão Gomes
Rafael Thomaz da Costa
Mário F. Juruena**

O transtorno bipolar (TB) é um quadro clínico grave caracterizado por recorrentes episódios de mania, mistos e depressão, que podem evoluir para cronicidade, especialmente quando não tratados. Ele é classificado de acordo com o tipo e o número de episódios que a pessoa apresenta. O tipo I é caracterizado pela presença de ao menos um episódio de mania ao longo da vida. Já no tipo II a pessoa deve apresentar um episódio de hipomania e outro de depressão maior em algum momento da vida. Na ciclotimia, há uma persistente instabilidade do humor, com critérios de hipomania e depressão presentes, sendo que nenhuma crise é suficientemente forte para ser

caracterizada como depressão maior ou episódio maníaco. Por fim, diz-se que um paciente é um ciclador rápido quando apresenta quatro ou mais episódios de humor em um mesmo ano, o que pode indicar abuso de substâncias. Quando os requisitos dos diagnósticos mencionados não são atendidos, o paciente se enquadra no transtorno bipolar sem especificação (American Psychiatric Association [APA], 2014).

É importante destacar que, para que seja feito o diagnóstico de TB, os episódios de humor precisam causar um prejuízo substancial em áreas da vida do indivíduo e não devem ocorrer unicamente na presença de condições médicas gerais ou de uso de substâncias.

Durante um episódio de mania ou hipomania, a pessoa pode apresentar humor expansivo, exageradamente alegre, chamado eufórico; ou irritadiço, características de humor disfórico. Em ambos os casos, é comum que exiba fala e pensamentos acelerados, impulsividade aumentada, elevada autoestima e necessidade de sono reduzida. Além disso, também pode apresentar agitação psicomotora, envolvimento em atividades prazerosas com alto potencial de perigo, comportamento sexual exagerado e grande distração. Tais sintomas não precisam estar presentes ao mesmo tempo, mas devem ocorrer por pelo menos uma semana ou requererem internação para que seja feito o diagnóstico de mania.

Já para se diagnosticar um episódio depressivo, é necessário que a pessoa apresente, por duas semanas ou mais, humor predominantemente triste ou irritável e perda de interesse em atividades de que costumava gostar. Somam-se a isso redução no apetite ou perda de peso, alterações no padrão de sono (hipersonia ou insônia), movimentos lentificados, fadiga, falta de energia, sentimentos de inferioridade ou culpa, dificuldade de raciocínio e tomada de decisão, diminuição da libido e pensamentos de morte ou ideias de suicídio.

Os episódios mistos são caracterizados pela presença de sintomas de mania e depressão oscilando em período curto de tempo, como, por exemplo, sintomas de pessimismo ou incapacidade (geralmente depressivos) com agitação e pensamento acelerado (sintomas de mania) em um mesmo dia (Goodwin & Jamison, 2007). É importante destacar que em todos os episó-

dios são comuns sintomas de ansiedade autonômica, como taquicardia, e ansiedade psíquica, como sentimentos de preocupação exagerados.

A prevalência do TB está estimada entre 1 e 1,5% da população (Merikangas et al., 2011), com idade de início entre a segunda e terceira décadas de vida (Dell’Osso et al., 2016). O TB é marcado pela presença de comorbidades com outros quadros médicos, ou seja, é comum que ocorra em conjunto com outros problemas de saúde. Cerca de 65% dos pacientes com TB apresentam alguma comorbidade psiquiátrica, com destaque para os transtornos de ansiedade e de déficit de atenção/hiperatividade (Goodwin & Jamison, 2007).

Especialmente com relação aos quadros de transtorno da personalidade, o mais comum observado é o da personalidade *borderline*, que ocorre em 22% dos indivíduos com TB (Frías, Baltasar, & Birmaher, 2016). Contrastando com antigas expectativas, a recuperação clínica desses pacientes não é acompanhada de recuperação funcional, ou seja, mesmo quando a pessoa melhora dos sintomas de humor, comumente ela continua a ter dificuldades no gerenciamento de sua vida. Isso pode se dever, em parte, à presença de sintomas de humor residuais (Judd et al., 2002), bem como ao prejuízo cognitivo que é observável mesmo na fase eutímica da doença (Mann-Wrobel, Carreno, & Dickinson, 2011).

Além disso, é preciso enfatizar que uma grande parte dos pacientes com TB apresenta recaídas de humor em um período de cinco anos, mesmo quando corretamente medicada (Gitlin, Swendsen, Heller, & Hammen, 1995). Essa taxa de recorrência foi calculada recentemente em 26,3% ao ano em estudos naturalísticos e em 21,9% ao ano em ensaios controlados randomizados (Vázquez, Holtzman, Lolic, Ketter, & Baldessarini, 2015). Esses dados explicam por que o TB está associado a dificuldades em áreas importantes da vida, como relacionamentos interpessoais e profissionais (Magliano et al., 2009) e, por conseguinte, a uma pior qualidade de vida (Michalak, Yatham, & Lam, 2005). Por tudo isso, o TB vem sendo apontado como um dos quadros de saúde mental com maior grau de incapacitação (Whiteford et al., 2013).

Por fim, pessoas com TB correm maior risco de cometer tentativas de suicídio em comparação àquelas da população em geral. Cerca de 15% das pessoas com TB cometem suicídio (Abreu, Lafer, Baca-Garcia, & Oquendo, 2009), e o risco para tentativa de suicídio é de 20 a 30 vezes maior entre elas em comparação às da população em geral (Pompili et al., 2013).

Diante de um quadro clínico tão complexo, é estranho pensar que as pesquisas sobre a psicoterapia para TB sejam relativamente recentes, principalmente quando comparadas a quadros clínicos como depressão e transtornos de ansiedade (Butler, Chapman, Forman, & Beck, 2006). De fato, o primeiro livro de terapia cognitivo-comportamental (TCC) a descrever tratamento para pessoas com TB data da segunda metade da década de 1990 (Basco & Rush, 1996). Scott (1995) aponta três razões para essa investida tardia: um certo ceticismo por parte de alguns terapeutas sobre a viabilidade de tratamento psicoterápico para esses pacientes; a crença firmada na era pós-lítio de que esses indivíduos experimentariam recuperação clínica e funcional entre os episódios de humor; e a ausência de estudos de psicologia no campo do TB. Como veremos a seguir, esse cenário foi completamente modificado na virada do século XXI.

ESTUDOS EM PSICOTERAPIA DE GRUPO NO TB

Nos últimos anos, o número de estudos com psicoterapia para pessoas com TB cresceu substancialmente (Salcedo et al., 2016). Tal crescimento pode ser atribuído a três fatores: reconhecimento do papel fundamental que a psicoterapia tem no TB; aumento do número de centros dedicados à pesquisa de psicoterapia no TB; disponibilidade de intervenções estruturadas que se permitem ser avaliadas em ensaios clínicos.

Ao mesmo tempo, como se pode observar na Figura 5.1, os estudos controlados sobre a aplicação da psicoterapia em grupo para pessoas com TB têm-se tornado uma tendência e, hoje, superam o número total de estudos com psicoterapia individual. Se, até a década passada, o total de estudos de psicoterapia em grupo para pessoas com TB era de apenas cinco (Gomes &

Lafer, 2007), somente em 2015 foram publicados seis estudos com psicoterapia em grupo para pessoas com TB.

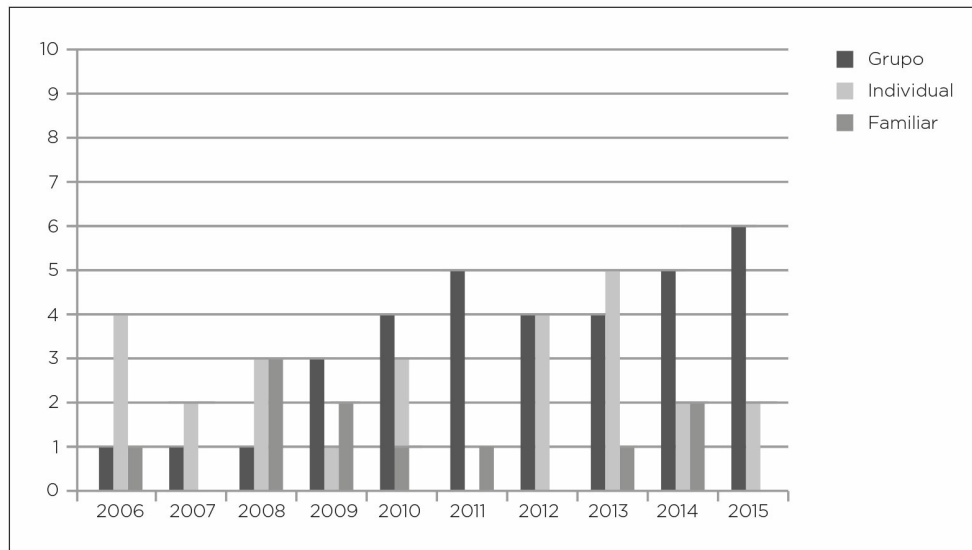


Figura 5.1 Número de estudos por ano de publicação.

Fonte: National Center for Biotechnology Information Search (NCBI, c2016).

A abordagem cognitivo-comportamental foi a primeira psicoterapia testada em um ensaio controlado para pessoas com TB (Cochran, 1984) e é hoje uma das abordagens mais estudadas para pessoas com o transtorno (Salcedo et al., 2016), seja no formato individual, seja em grupo. O formato em grupo pode favorecer a troca de experiências pessoais e comportamentos adaptativos sobre o manejo da doença, ampliando a sensação de controle dos pacientes. Além disso, a abordagem aumenta a disponibilidade de atendimento de qualidade de um número cada vez maior de pacientes, principalmente em instituições públicas, e possibilita a criação de elos sociais saudáveis entre os participantes, uma vez que é frequente o sentimento de isolamento entre pessoas com esse transtorno (Scott, 2001).

Os principais estudos controlados sobre psicoterapia são descritos na Tabela 5.1. Nela, podemos observar que algumas variáveis, como o número de sessões, os instrumentos de avaliação, a presença de grupo-controle e a presença de sessões de reavaliação, diferiram muito entre os estudos.

Tabela 5.1 Terapia cognitivo-comportamental em grupo para pacientes com transtorno bipolar

Autores	Número de sujeitos	Objetivos	Número de sessões	Escalas e inventários de avaliação	Principais resultados
Palmer, Williams, Gorsefield e Adams (1995)	6	Avaliar o bem-estar e o ajustamento social de pacientes bipolares antes e depois do tratamento com a TCC em grupo + farmacoterapia	17 sessões semanais + 6 sessões mensais	ISS SAS SCL-90	Melhora nos escores das escalas que avaliaram o humor e o funcionamento social
Patelis-Siotis, Young e Robb (2001)	49 (38 completaram o tratamento)	Avaliar o funcionamento e a qualidade de vida depois da TCC em grupo + tratamento farmacológico padrão	14 sessões semanais	SCID GAF MOS HAM-D YMS	Melhora significativa comparando pré e pós-TCC em grupo nas escalas de funcionamento global e de qualidade de vida
Williams e colaboradores (2008)	70 (68 completaram o protocolo) 53 unipolares 17 bipolares	Avaliar e comparar os efeitos da terapia cognitiva e <i>mindfulness</i> vs. grupo-controle/lista de espera	8 sessões	BDI BAI	Melhora significativa nos sintomas de depressão (as variáveis tempo e condição de interação mostraram influência significativa na mudança) e nos de ansiedade (as variáveis tempo, grupo e condição de interação se mostraram essenciais)
Castle e colaboradores (2010)	84 (72 completaram o tratamento)	Avaliar manual de terapia cognitiva em grupo em ambiente naturalístico	12 sessões semanais + 3 de reforço	SCID MADRS YMRS	Os pacientes de TCC em grupo apresentaram menor chance de recaída e permaneceram mais tempo bem durante o seguimento
Costa e colaboradores (2011, 2012)	27 (TCC em grupo + tratamento farmacológico) 14 (tratamento farmacológico) Moderadamente deprimidos ou eutímicos (34 bipolares do tipo I e 7 do tipo II)	Comparar a evolução de dois grupos: TCC em grupo + tratamento farmacológico padrão vs. grupo recebendo apenas o tratamento farmacológico padrão	14 sessões semanais	SCID BDI BAI BHS MOS YMS	Melhora significativa comparando pré e pós-TCC em grupo nas escalas de depressão, desesperança e de qualidade de vida. A variável TCC se mostrou essencial para a melhora. Não houve melhora significativa nos escores de mania, mas os pacientes já apresentavam escores subclínicos na YMS.
Gomes e colaboradores (2011)	50 eutímicos (38 bipolares do tipo I e 12 do tipo II)	Comparar a evolução de dois grupos: TCC em grupo + tratamento farmacológico padrão vs. grupo recebendo apenas o tratamento farmacológico padrão	12 meses de acompanhamento – 18 sessões	SCID HAM-D YMS	Não houve diferença entre os dois grupos no que diz respeito ao número recaídas (episódios depressivos ou maníacos). O tempo médio entre um episódio e outro foi maior no grupo de TCC.
Gonzalez-Isasi, Echeburúa, Limiñana e	40 bipolares do tipo I Pacientes refratários, com	Comparar a evolução de dois grupos de pacientes bipolares: TCC em grupo + tratamento farmacológico padrão vs. grupo	20 sessões (com sessões de reavaliação 6 meses, 1 ano e 5	STAI-S BDI YMRS MS	O grupo que recebeu TCC apresentou menos sintomas depressivos e ansiosos e melhor funcionamento

	frequentes	anos após)	
González-Pinto (2014)	recaídas, de ciclagem rápida e/ou com tentativa de suicídio no passado	recebendo apenas o tratamento farmacológico padrão	social e ocupacional que os sujeitos do grupo-controle. Os sintomas de mania também mostraram diferença significativa entre os dois grupos e favorável ao grupo de TCC, o qual apresentou menos sintomas de mania ao longo dos 5 anos. Ao longo dos 5 anos, o grupo de TCC apresentou também menos hospitalizações.

TCC, Terapia cognitivo-comportamental; BAI, Escala de Ansiedade de Beck (Beck, Epstein, Brown, & Steer, 1998); BDI, Escala de Depressão de Beck (Beck, Ward, Mendelson, & Erbaugh, 1961); BHS, Escala de Desesperança de Beck (Beck, Kouacs, & Weissman, 1975); GAF, Avaliação do Funcionamento Global (Endicott, Spitzer, Fleiss, & Cohen, 1976); HAM-D, Escala de Hamilton para Depressão (Hamilton, 1960); ISS, Escala de Estado Interno (Bauer et al., 1991); MOS, Medical Outcomes Survey; SF-36, Qualidade de vida (Ware & Sherbourne, 1992); MS, Misadjustment Scale (Echeburú, Corral, & Fernández-Montalvo, 2000; McHorney, Ware, & Raczek, 1993); SAS, Escala de Funcionamento Social (Weissman & Bothwell, 1976); SCL-90, Checklist de Sintomas 90 (Derogatis & Cleary, 1977); STAI-S, Escala de Ansiedade Traço-Estado (Spielberger, Gorsuch, & Lushene, 1970); YMS, Escala de Mania de Young (Young, Biggs, Ziegler, & Meyer, 1978).

A PSICOTERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO TB

Na esfera psicossocial, tem sido claramente documentada uma associação entre estressores e a precipitação de episódios bipolares (Frey, Fonseca, Machado-Vieira, Soares, & Kapczinski, 2007). Consequentemente, intervenções psicológicas vêm, de forma crescente, sendo reconhecidas como um componente integral do tratamento para o TB (Colom & Vieta, 2004). Estudos recentes mostram que essas intervenções psicossociais podem ser ferramentas efetivas no tratamento desses pacientes (Zaretsky, Rizvi, & Parikh, 2007).

Na ampla maioria dos ensaios clínicos que avaliaram a eficácia dessas abordagens, elas são inclusas em condição *add-on*, ou seja, uma condição adicional ao tratamento farmacológico tradicionalmente oferecido aos pacientes, embora existam algumas exceções (Swartz, Frank, Frankel, Novick, & Houck, 2009).

Assim, têm sido estudadas abordagens psicoterapêuticas específicas, incluindo a psicoeducação em grupo, o tratamento focado na família, a terapia cognitiva e a terapia interpessoal e de ritmo social (Miklowitz et al., 2006).

Os objetivos principais da TCC no tratamento do TB são os seguintes:

1. educar os pacientes sobre a abordagem do tratamento e as dificuldades comuns associadas com a doença;
2. ensinar aos pacientes um método para monitorar a ocorrência, a gravidade e o curso de sintomas maníacos e depressivos;
3. facilitar a adesão aos regimes medicamentosos prescritos;
4. fornecer estratégias não farmacológicas, especialmente habilidades cognitivas, para dar conta de problemas cognitivos, afetivos e comportamentais associados com sintomas maníacos e depressivos.

A abordagem da TCC ao tratamento do TB está baseada em muitas hipóteses subjacentes.

A *primeira suposição* é a de que os pensamentos, os sentimentos e os comportamentos das pessoas estão fortemente conectados, cada um influenciando e encadeando o outro. Mudanças no humor e alterações no processo cognitivo, com início de depressão e mania, inevitavelmente influenciam o comportamento. As respostas comportamentais podem reforçar o defeituoso processo de informações e estados afetivos que estimularam o comportamento – um tipo de profecia de autorrealização. A TCC está baseada na noção de que sentimentos, pensamentos e comportamentos são inter-relacionados, isto é, eles influenciam um ao outro. Na TCC, os pacientes são ensinados a reconhecer os padrões afetivos, cognitivos e comportamentais que pioram seus sintomas. Uma vez reconhecido o padrão, podem ser usadas técnicas da TCC para “quebrar o ciclo” por meio da modificação de respostas cognitivas ou comportamentais. Esses sintomas também podem servir como sinais para procurar seu melhor controle farmacológico (Juruena, 2012).

A *segunda hipótese* subjacente da TCC para TB é a de que pacientes que entendem o que significa ter o TB estarão aptos a desenvolver papéis mais

ativos e chegar a decisões mais informadas sobre seus tratamentos. Portanto, a educação do indivíduo é introduzida antes que as técnicas TCC sejam ensinadas.

A terceira é a de que a identificação dos sinais precoces de aviso de mania ou depressão fornece uma oportunidade para intervenção precoce e contenção dos sintomas. Educação ligada com tarefas de monitoramento de sintomas provê um veículo para identificação precoce dos sintomas.

A quarta é a de que a adição de intervenções cognitivas expande o arsenal do paciente contra as recaídas. Sintomas precoces mais leves podem não requerer medicações adicionais se eles puderem ser controlados com intervenções psicoterapêuticas.

A quinta é a de que a adesão aumentada ao medicamento permite que os indivíduos recebam benefício máximo do tratamento. A TCC é de pouco uso para pacientes bipolares quando a farmacoterapia falha.

A sexta é a de que o melhor manejo dos problemas psicossociais que estressam os pacientes com TB e exacerbam os sintomas pode ajudar na prevenção de recaídas ou recorrências de mania ou depressão.

A sétima é a de que a abordagem da TCC enfatiza o ensino de habilidades para dar conta dos sintomas e das consequências do TB. Isto é, supõe-se que nem todos os problemas serão solucionados durante as sessões de terapia. Em vez disso, os problemas apresentados são usados para facilitar o ensino de técnicas de TCC. Isso aumenta a capacidade de o paciente enfrentar os sintomas e os problemas entre as sessões. Desse modo, a terapia passa a ser mais que uma série de visitas para intervenções de crises (Juruena, 2012).

A TCC para TB difere das formas mais tradicionais de terapia cognitiva de muitas maneiras:

1. os pacientes normalmente não estão em fase aguda durante as sessões educacionais e treinamento de habilidades
2. as habilidades são ensinadas de maneira didática
3. é ensinado um número menor de técnicas cognitivo-comportamentais
4. a agenda para cada sessão é um protocolo conduzido que aborda a sintomatologia do paciente

As características psicoeducativas da TCC proporcionam, tanto para o paciente como para seus familiares e seus relacionamentos, o aprendizado sobre o que é o TB, promovendo e enfatizando o reconhecimento dos sintomas precoces, instruindo sobre o curso longitudinal e os fatores de risco de recaídas, bem como explicando e exemplificando as características do tratamento e a importância tanto do uso dos medicamentos como da psicoterapia (Juruena, 2004). A TCC aumenta a efetividade da aceitação pelo paciente e pela família do diagnóstico e do tratamento farmacológico, melhorando significativamente a adesão terapêutica. Especificamente, a TCC pode ser útil no aumento da adesão ao tratamento, melhorando a qualidade de vida e o funcionamento psicossocial do paciente bipolar, ajudando na detecção precoce dos sintomas maníacos, hipomaníacos e depressivos, prevenindo o alto índice de recaídas e recorrências com perdas afetivas, psicossociais e profissionais, bem como modificando o padrão de pensamento e o comportamento do paciente. A TCC para o TB reduz fatores de risco para oscilação do humor, por meio de:

- a. diminuição do nível subjetivo de estresse, reduzindo probabilidade de reativações
- b. favorecimento da aprendizagem de rompimento com os ciclos, reconhecendo o bom humor normal e diferenciando-o de sintomas iniciais de mania
- c. aprendizagem de pensar e agir, sistemática e metodologicamente, para conter distratibilidade e impulsividade maníaca

Tendo a TCC capacidade de prevenir recaídas em depressão unipolar, e sendo as recaídas no TB frequentemente relacionadas com a depressão bipolar, estudos descrevem psicoterapia cognitiva individual de longa duração (2 a 4 anos) para uma síndrome que os autores descrevem como disforia pós-maníaca e pós-depressiva. Nessa síndrome, os critérios para o transtorno não são preenchidos, mas os pacientes continuam com irritabilidade, impaciência, inadequação e inquietação ou angústia (Juruena, 2012). Muitos conceitos e técnicas da TCC para depressão servem bem para o tratamento do TB, assim como para identificação e mudanças nos

pensamentos automáticos, foco na psicoeducação, adesão e monitoramento de sintomas (Batista, Von Werne Baes, & Juruena, 2011).

Um problema comum no tratamento do TB é que as pessoas nem sempre tomam os medicamentos regularmente. Quando os pacientes não aderem aos regimes farmacológicos, ou seja, não tomam seus medicamentos no horário, a eficácia da farmacoterapia de manutenção é bastante comprometida (Juruena, 2004). Portanto, um dos focos da TCC no TB sem dúvida é aumentar a adesão ao tratamento farmacológico mesmo durante a fase de remissão dos sintomas, ajudando o paciente a desenvolver estratégias de monitoria e controle desse comportamento (Scott, 2001)

Na atualidade, as mais importantes diretrizes clínicas optam pela inclusão de algum tipo de intervenção psicológica, como a TCC (Juruena, 2001) e, principalmente, a psicoeducação do paciente ou do cuidador no tratamento de manutenção dos indivíduos bipolares (Goodwin & Consensus Group of the British Association for Psychopharmacology, 2003). A psicoeducação pode ser desenvolvida individualmente ou em grupo, por diferentes profissionais da saúde, desde que capacitados para lidar com as reações associadas ao tema discutido (Andrade, 1999).

A psicoeducação é a forma de intervenção psicossocial que vem sendo mais amplamente estudada, sendo um componente essencial do tratamento combinado do TB, para melhorar o *insight* sobre a doença, lidar com a estigmatização, melhorar a adesão ao tratamento, ensinar o paciente e a família a identificar os sinais precoces de uma crise, promover hábitos saudáveis, a regularidade no estilo de vida e evitar o abuso de substâncias (Perry, Tarrier, Morriss, McCarthy, & Limb., 1999). Para Colom e Vieta (2004), a psicoeducação permite ao paciente acesso a um direito fundamental: o de ser informado sobre sua doença. Constitui um potente instrumento não apenas para melhorar o desfecho dos pacientes, mas para auxiliá-los a gerenciar desespero, medos, estigma e baixa autoestima (Colom et al., 2003). Esses autores desenvolveram um manual descrevendo sua abordagem de 21 sessões (Colom & Vieta, 2006). Ela foi desenvolvida especificamente para ser aplicada em grupo e adota diversos elementos em

comum com a TCC. Por essa razão, alguns autores a definem como uma variação de TCC em grupo (Goodwin & Jamison, 2007).

Conclui-se que a TCC para o TB é mais longa do que para o tratamento da depressão, sendo dividida em três momentos. Nas sessões iniciais, a psicoeducação sobre o transtorno é o elemento principal, sendo muito importante a participação da família. Nessa fase, também deve ser introduzido o uso de gráficos do humor (Basco & Rush, 1996). Já nas sessões intermediárias, o foco se dá na reestruturação cognitiva e na solução de problemas. Nas sessões finais, é realizada a prevenção da recaída. Como descrito, a psicoeducação integra todas as fases desse tratamento. Por fim, a TCC é um modelo de tratamento que atua no controle dos sintomas do transtorno, moderando oscilações de humor e mudando comportamentos, diminuindo recaídas e melhorando o funcionamento de cada indivíduo em seu meio social.

ESTUDOS BRASILEIROS DE TCC EM GRUPO PARA PESSOAS COM TB

No Brasil, existem, até o momento, dois estudos controlados com psicoterapia cognitivo-comportamental para pessoas com TB, ambos conduzidos com abordagens grupais em serviços terciários de atendimento junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) e publicados no mesmo mês de 2011. Um deles foi realizado no Programa de Transtorno Bipolar (PROMAN) do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, como parte do mestrado de um dos autores deste capítulo (Gomes et al., 2011). O estudo incluiu, ao todo, 50 pacientes em eutímia, com TB dos tipos I e II, que foram distribuídos de forma aleatória em dois grupos: um que recebeu tratamento farmacológico para TB ($n = 27$) e outro que, além deste, participou de um total de 18 sessões em grupo de TCC ($n = 23$). Foram conduzidos, ao todo, cinco grupos de terapia, com duração de 2 horas e uma média de 4,4 pacientes por grupo. A agenda de cada sessão desse protocolo é apresentada no Quadro 5.1.

Quadro 5.1 Estrutura das sessões

Sessão 1: Apresentação dos membros e entrega do material

- Apresentação do projeto de pesquisa, dos terapeutas e dos participantes
- Definição de regras de participação no grupo (contrato psicológico) e do tempo de duração da terapia
- Entrega do material e breve descrição das sessões
- Discussão de metas de terapia
- Tarefa de casa – leitura do texto 1, “Introdução à Terapia Cognitivo-comportamental no Tratamento do TB”, do Manual de Terapia

Sessão 2: Introdução à TCC no TB

- Revisão da sessão anterior e esclarecimento de dúvidas na leitura do texto para casa
- Apresentação da TCC no TB
- Os pensamentos na regulação do nosso humor
- Comportamentos aprendidos
- Tarefa de casa – leitura do texto 2: “O Papel dos Pensamentos na Regulação do Nosso Humor” e do texto 3: “Comportamentos Aprendidos”

Sessão 3: O que é TB?

- Revisão da sessão anterior e esclarecimento de dúvidas na leitura dos textos para casa
- Definições sobre o TB: início da doença, prevalência na população, classificação atual
- Possíveis causas do transtorno
- O Modelo de Vulnerabilidade ao Estresse.
- Tarefa de casa – leitura do texto 4: “O que é Transtorno Bipolar”

Sessão 4: Tratamento farmacológico

- Revisão da sessão anterior e dúvidas
- Principais grupos de medicação, ECT e efeitos colaterais
- Vantagens e desvantagens de seguir o tratamento prescrito
- Adesão ao tratamento
- Pensamentos e medicação
- Tarefa de casa – leitura do manual com exercícios

Sessão 5: Ritmos circadianos e monitoria do humor

- Revisão da sessão anterior e esclarecimento de dúvidas na leitura dos textos para casa
- Os ritmos circadianos e seu papel no TB
- Histórico pessoal e construção do cartão de vida
- Gráfico do humor
- Tarefa de casa – gráfico do humor e leitura do texto 5: “Os Ritmos Circadianos e a Rotina”

Sessão 6: Pensamentos depressivos

- Revisão da última semana e dúvidas que possam ter restado sobre medicação e a decisão de tomar medicamentos
- Discussão sobre o exercício prático
- Iniciar discussão sobre o papel que os pensamentos exercem por meio dos exemplos coletados desde a sessão 2
- Distorções cognitivas típicas da fase depressiva
- Tarefa de casa – leitura do manual e identificação das distorções mais comuns ocorridas na semana

Sessão 7: Reestruturação cognitiva

- Respondendo às próprias distorções
- Construindo respostas alternativas a partir dos pensamentos da semana
- Tarefa de casa – identificar e responder às distorções ocorridas na semana

Sessão 8: Comportamentos depressivos

- Revisão da semana e dúvidas quanto ao exercício de identificar pensamentos automáticos
- Comportamentos depressivos e ciclo de letargia
- Sinais de início desse episódio para cada um dos membros
- Registro de atividades e técnicas de domínio e prazer
- Tarefa de casa – completar o ciclo comportamental da fase depressiva e leitura do manual

Sessão 9: Pensamentos de mania

- Revisão da última semana e da tarefa de construção do próprio ciclo letárgico
- Discussão sobre o registro de atividades dessa semana avaliadas em termos de domínio e prazer
- Pensamentos típicos da fase maníaca
- “Fissura maníaca”
- Distração e adiamento
- Outros confiáveis e sua importância na tomada de decisões
- Quantidade e qualidade de ações
- Tarefa de casa – completar a lista de pensamentos na fase maníaca; eleger outros confiáveis e, preferencialmente, falar com eles

Sessão 10: Comportamentos em mania

- Revisão da semana e da lista de pensamentos na fase maníaca
- Elegendo outros confiáveis e comunicando-os
- Comportamentos típicos da fase maníaca
- Sinais e sintomas próprios de início da mania
- Lista de diferenciação entre comportamentos maníacos vs. depressivos
- Tarefa de casa – leitura do manual

Sessão 11: Solução de problemas

- Identificando situações potencialmente solucionáveis
- Pensamentos que podem atrapalhar
- Estratégias de solução de problemas
- Tarefa de casa – leitura do manual e seleção de problemas atuais

Sessão 12: Estresse e TB

- Revisão da semana e das estratégias de solução de problemas
- O que é estresse?
- Higiene do sono
- Solução de problemas para higiene do sono
- Tarefa de casa – leitura do manual

Sessão 13: Aprendendo a relaxar

- Revisão da semana e das medidas de higiene do sono
- Exercício de relaxamento
- Tarefa de casa: leitura do manual e prática de relaxamento

Sessão 14: Comunicação assertiva

- Revisão da semana e das estratégias de solução de problemas
- Relação entre comunicação e prognóstico de TB
- Estresse e comunicação
- Conceito de assertividade
- Exercício assertivo
- Tarefa de casa: ler o manual e permanecer atento a respeito do momento em que possa ser assertivo

Sessão 15: O papel da família e da sociedade

- Revisão da semana e do conceito de assertividade
- Momentos assertivos durante a semana
- Rever exercício assertivo
- Discussão aberta sobre estigma
- Tarefa de casa – ler o manual e tentar ser assertivo de modo voluntário ao menos uma vez na semana

Sessão 16: Revisão das sessões anteriores

- Dúvidas sobre o tratamento.
- Tornando-se o seu próprio terapeuta

Sessão 17: Prevenção de recaídas 1ª parte – INTERVALO DE 15 DIAS

- Prevenção de recaídas – O que fazer?
- Cartão de Enfrentamento de Recaídas de Humor
- Tarefa de casa – ler o manual e completar o Cartão de Enfrentamento de Recaídas de Humor

Sessão 18: Prevenção de recaídas 2ª parte – INTERVALO DE 30 DIAS

- Prevenção de recaídas – O que pensar?

- Mitos sobre recaídas
- Manejo de pensamentos sobre recaídas
- Planejando o futuro

Todos os pacientes desse estudo foram acompanhados por pelo menos um ano a datar do início de cada um dos grupos de terapia, momento no qual também era iniciado o seguimento daqueles mantidos em uso de tratamento farmacológico. Os dois grupos não apresentavam, na entrada do estudo, diferenças estatísticas significativas para gênero, idade, escolaridade, subtipo bipolar, presença de comorbidades psiquiátricas e escores de humor de mania e depressão, bem como qualidade de vida.

A medida de desfecho principal desse estudo foi o tempo até o início de um novo episódio de mania ou depressão, medido em semanas, e a comparação entre os grupos foi feita por meio de análise de sobrevivência. Após um ano de seguimento, não foi observada diferença entre os grupos para tempo até o primeiro episódio (*log rank* = 0,031; $p = 0,859$), bem como para número de episódios de mania e depressão. Contudo, quando foram analisados separadamente apenas aqueles pacientes que sofreram recaídas no seguimento, o grupo que participou de TCC apresentou um período significativamente maior de remissão (medianas: TCCG = 31 vs. TP = 11,5) (Gomes et al., 2011). Com o aumento do seguimento deste para 18 meses, pôde ser observado que o grupo de TCC apresentou maior intervalo de tempo até o primeiro episódio depressivo (Breslow = 4.427; $p = 0,035$) (Gomes et al., 2011).

O estudo apresentou uma excelente adesão por parte dos pacientes, que reportaram se beneficiar muito do tratamento. Isso se reflete no baixo número de abandonos observados (apenas um paciente não pôde ser incluído por não frequentar o número mínimo de sessões). Analisando as curvas de sobrevivência e os resultados obtidos, podem ser observadas ao menos duas coisas. Um grande número de recaídas se concentrou no período de quatro semanas após o término dos grupos de terapia. Isso pode indicar a necessidade de um número maior de sessões de reforço a fim de consolidar as aprendizagens obtidas no grupo. Outro fator importante é que talvez fosse

necessário um número maior de indivíduos incluídos para comprovação das hipóteses de pesquisa. O cálculo de tamanho amostral realizado posteriormente indicou que ao menos 60 pacientes deveriam ter sido incluídos no estudo para testagem de resultados. Isso indica uma possível ocorrência de erro tipo II.

O outro estudo, uma pesquisa voltada ao mestrado de outro autor deste capítulo (Costa et al., 2011, 2012), foi desenvolvido no Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (IPUB/UFRF). Participaram 41 pacientes com TB dos tipos I e II, eutímicos ou com depressão leve, que faziam uso de estabilizador do humor e sem mudança na medicação durante todo o processo de acompanhamento. Estes foram divididos em grupos de 5 a 6 pessoas; 37 preencheram todas as escalas e seguiram o protocolo até o fim.

Da mesma forma que o estudo citado anteriormente, o objetivo foi avaliar a eficácia das intervenções de TCC em grupo concomitante à farmacoterapia e compará-la à farmacoterapia sozinha. Os pacientes foram alocados aleatoriamente para os dois grupos, mas mostraram-se similares estatisticamente no que diz respeito aos dados demográficos.

Além do número de episódios, também foram investigados os sintomas de depressão e mania, características de desesperança (propensão ao suicídio) e a qualidade de vida.

Foram realizadas 14 sessões semanais com duração de 2 horas cada. Após o término da terapia em grupo, quem ainda apresentava necessidade foi encaminhado para dar sequência com TCC individual. As atividades e intervenções programadas para cada sessão desse protocolo são descritas no Quadro 5.2.

Quadro 5.2 Estrutura das sessões

Sessão 1

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Apresentação do terapeuta e do paciente
- Fala livre sobre as queixas principais
- Introdução ao modelo cognitivo
- Contato com o psiquiatra e informações sobre os atendimentos e medicações
- Termo de compromisso e explicar as regras para o funcionamento do tratamento

- Recomendações sobre o preenchimento da Escala de Depressão de Beck (BDI), Escala de Ansiedade de Beck (BAI), Escala de Desesperança de Beck (BHS) e Questionário de Qualidade de Vida (SF-36) (O terapeuta preenche a Escala de Mania de Young [YMS])

Tarefas para a sessão seguinte:

- Textos sobre o modelo cognitivo
- Cópia da apostila com todo o material e folhas de exercício que serão usados na terapia

Sessão 2

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Discutir o texto sobre o modelo cognitivo
- Explicar as metas da TCC (psicoeducação de pacientes e familiares, monitoração do humor, redução dos fatores estressores, adesão à medicação, avaliação de pensamentos, resolução de problemas, treino de habilidades sociais, etc.)
- Espaço para as principais queixas e metas pessoais
- Avaliar possíveis pensamentos suicidas (presente e passado)
- Avaliar as expectativas com relação à terapia
- Introduzir informações contidas no texto sobre TB; explorar, no grupo, o que cada paciente conhece sobre o próprio diagnóstico e tratamentos

Tarefas para a sessão seguinte:

- Texto sobre o TB

Sessão 3

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Discussão sobre o texto “Transtorno Bipolar” e os tipos
- Definição de mania, hipomania, depressão, ciclotimia e episódio misto
- Debate sobre os tratamentos e a importância primária do medicamento
- Iniciar o preenchimento do mapeamento da vida – histórico de episódios maníacos e depressivos

Tarefas da sessão anterior:

- Texto sobre TB lido

Tarefas para a sessão seguinte:

- Completar o mapeamento da vida, tentando definir seus sintomas em cada fase
- Entregar o texto para um ou dois familiares próximos que participarão da sessão de psicoeducação

Sessão 4

Sessão de psicoeducação com familiares

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Deixar os familiares falarem livremente sobre o paciente, suas impressões sobre ele, suas expectativas dos tratamentos
- Explicar e debater o texto sobre TB e explicar os tipos
- Definição de mania, hipomania, depressão, episódio misto e eutímia
- Debate sobre os tratamentos e a importância primária do medicamento
- Enfatizar a necessidade de participação ativa dos familiares; fornecer algumas informações sobre como é recomendável agir para auxiliar em momentos de crise

Tarefas para a sessão seguinte:

- Instruções para o paciente registrar as atividades rotineiras da semana no plano de atividades 1 (incluindo sono e alimentação)
- Observar as reações/dúvidas dos familiares durante a semana

Sessão 5

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Mapeamento da vida completo
- Dúvidas e impressões sobre os textos informativos
- Falar sobre as impressões do paciente sobre a sessão com os familiares
- Ler e debater o mapeamento da vida – fala livre sobre os principais episódios de humor no passado
- Preencher quadro de sintomas
- Introduzir gráfico de humor. Enfatizar a importância de se fazer contato com terapeuta e psiquiatra caso o gráfico atinja -3, -4, -5 ou +3, +4, +5

Tarefas para a sessão seguinte:

- Registrar as atividades rotineiras da semana no plano de atividades 1 (incluindo sono e alimentação)
- Observações sobre o preenchimento do quadro de sintomas
- Começar a preencher o gráfico de humor

Sessão 6

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Atividades registradas no plano de atividades 1
- Observar se o preenchimento do gráfico de humor está sendo feito de modo correto
- Discussão sobre a importância de uma rotina (ciclo circadiano)
- Adequar o plano de atividades para ter maior equilíbrio (sono, atividade mental e física, relaxamento/lazer)
- Dicas visando hábitos saudáveis para manejar e prevenir o estresse (alimentação saudável, exercício físico, relaxamento e lazer)
- Iniciar o curtograma
- Explicar o que são os gatilhos e pedir para cada um observá-los e registrá-los no dia a dia

Tarefas para a sessão seguinte:

- Alterar, se necessário, o plano de atividades (2) e colocá-lo em prática. Enfatizar a importância da rotina no ciclo circadiano
- Finalizar o curtograma
- Observar e registrar os gatilhos
- Ver o curtograma e enfatizar a necessidade de mudar a posição de alguns itens aos poucos

Sessão 7

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Incentivar a prática do plano de atividades 2 – “ideal” – e utilizar o curtograma para inserir atividades prazerosas
- Debater a presença e o possível manejo dos gatilhos (fatores estressores internos e externos)
- Observar variações de humor no gráfico
- Observar os gatilhos que foram listados e enfatizar a importância de manejá-los, na medida do possível, aos poucos, durante o tratamento
- Apontar possíveis variações de humor e correlacionar com possíveis gatilhos
- Acompanhamento do tratamento psiquiátrico e enfatizar novamente a importância da medicação; debater efeitos colaterais do medicamento
- Preencher BDI, BAI, BHS e SF-36; terapeuta preenche a YMS

Tarefas para a sessão seguinte:

- Manter plano de atividades 2 – “ideal”
- Escolher uma atividade do curtograma para mudar de posição no quadro
- Texto sobre distorções cognitivas; ver com quais se identifica

Sessão 8

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Debater variações de humor no gráfico e possíveis gatilhos
- Observar o plano de atividades; debater tarefa do curtograma e escolher outra para dar sequência
- Identificar possíveis pensamentos distorcidos (pensamentos e crenças hiperpositivos e hipernegativos) e citar situações do dia a dia para exemplificar
- Introduzir registro de pensamento; preencher um registro durante a sessão; enfatizar a importância de testar o pensamento sempre que houver um sentimento muito intenso

Tarefas para a sessão seguinte:

- Manter plano de atividades com rotina saudável
- Escolher uma atividade do curtograma para mudar de posição no quadro
- Registro de pensamentos

Sessão 9

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Continuar testando os pensamentos e crenças hiperpositivos e negativos, a partir dos registros de pensamento trazidos
- Escolher uma situação problemática real e introduzir a estratégia de resolução de problemas (preferencialmente focar nos principais gatilhos)

Tarefas para a sessão seguinte:

- Manter plano de atividades com rotina saudável
- Escolher uma atividade do curtograma para mudar de posição no quadro
- Registro de pensamentos e/ou resolução de problemas

Sessão 10

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Debater variações de humor no gráfico e correlacionar com possíveis gatilhos
- Continuar testando os pensamentos e crenças hiperpositivos e negativos, a partir dos registros de pensamento trazidos

- Acompanhar a resolução de problemas (sessão anterior); se necessário, escolher mais uma situação problemática real e introduzir a estratégia de resolução de problemas (preferencialmente focar nos principais gatilhos)

Tarefas para a sessão seguinte:

- Manter plano de atividades com rotina saudável
- Escolher uma atividade do curtograma para mudar de posição no quadro
- Registro de pensamentos e/ou resolução de problemas

Sessão 11

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Observar a rotina equilibrada – plano de atividades e curtograma
- Registro de pensamento e/ou resolução de problemas
- Introduzir a estratégia dos cartões de enfrentamento caso haja compulsões/comportamentos impulsivos

Tarefas para a sessão seguinte:

- Manter plano de atividades com rotina saudável
- Escolher uma atividade do curtograma para mudar de posição no quadro
- Registro de pensamentos e/ou resolução de problemas
- Texto introdutório sobre assertividade e habilidades de comunicação para ler e refletir

Sessão 12

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Plano de atividades e curtograma em andamento
- Registro de pensamento e/ou resolução de problemas
- Observar e incentivar a manutenção das tarefas anteriores (rotina saudável, resolução de problemas, registro de pensamentos disfuncionais [RPD], adesão à medicação...)
- Debater o texto sobre assertividade e habilidades de comunicação
- Citar situações do dia a dia que exemplifiquem os comportamentos passivo, assertivo e agressivo
- Simular uma situação recente na qual não foi assertivo e treinar uma resposta alternativa

Tarefas para a sessão seguinte:

- Colocar em prática as habilidades de comunicação/assertividade
- Tentar ser assertivo e relatar as situações na sessão seguinte
- Manter plano de atividades e curtograma
- Registro de pensamento e/ou resolução de problemas

Sessão 13

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Observar e incentivar a manutenção de todas as tarefas anteriores
- Debater variações de humor no gráfico e correlacioná-las com possíveis gatilhos
- Debater registro de pensamento e/ou resolução de problemas
- Debater as situações trazidas de acordo com o que foi debatido anteriormente sobre assertividade e habilidades de comunicação (possível simulação)
- Observar a evolução do gráfico de humor e da BDI/BAI
- Trabalhar situações ainda problemáticas e a possibilidade de terapia individual após o grupo

Tarefas para a sessão seguinte:

- Tentar ser assertivo e relatar as situações na sessão seguinte
- Manter plano de atividades e curtograma
- Registro de pensamento e/ou resolução de problemas
- Escrever, para apresentar na próxima sessão, os aspectos positivos e negativos do tratamento

Sessão 14

Atividades desenvolvidas/tópicos importantes:

- Estratégia ESTÁVEL – enfatizar a importância da manutenção do que foi aprendido para se evitar recaídas
 - E stude o TB
 - S olucione os problemas de forma rápida e prática
 - T ome seus medicamentos na dosagem e horários corretos
 - A valie seu estado com o gráfico de humor diariamente
 - V iabilize um plano de atividades
 - E xamine seus pensamentos
 - L igue para marcar uma consulta extra quando necessário

- Testar pensamentos distorcidos OU trabalhar resolução de problemas OU trabalhar assertividade de acordo com as situações trazidas
 - Preencher BDI, BAI, BHS e SF-36; o terapeuta preenche a YMS
 - Manter conceitos da assertividade nas interações sociais
 - Manter plano de atividades equilibrado
 - Registro de pensamento, resolução de problemas e/ou cartões de enfrentamento
 - Avaliar aspectos positivos e negativos do tratamento
 - Definir passos futuros
- Tarefas/Recomendações:
- Mentalizar a estratégia ESTÁVEL
 - Manter todas as estratégias aprendidas
 - Possível encaminhamento e possibilidade de sessão de reavaliação após 3 a 6 meses

Houve boa adesão ao tratamento psicoterápico (92,59% participaram do início ao fim), e a adição da TCC em grupo ao tratamento farmacológico se mostrou efetiva. Houve redução na frequência e na duração dos episódios de humor. O grupo que participou da TCC apresentou redução significativa de sintomas de mania, depressão, desesperança e ansiedade. O mesmo não aconteceu com o grupo que apenas fez uso do medicamento e não tinha suporte psicoterapêutico.

Cálculos de regressão mostraram que as sessões de TCC foram especialmente importantes na melhora dos sintomas depressivos. Esse estudo, assim como outros anteriores, indica que a TCC se mostra menos eficaz para reduzir os sintomas de mania, e é importante destacar que os pacientes do estudo já apresentavam poucos sintomas de mania antes mesmo de iniciarem o tratamento, pois se mantinham bem medicados com estabilizadores do humor. Não havia, dessa forma, muita margem para mudanças positivas.

Também houve melhora significativa na qualidade de vida dos pacientes que participaram da TCC em grupo, e, da mesma forma, os escores dos indivíduos do outro grupo mantiveram-se muito parecidos ao se comparar o efeito das 14 semanas. Houve melhora estatisticamente significativa em quase todos os itens avaliados (7 das 8 subescalas): aspecto físico, dor, condição de saúde geral, vitalidade, aspectos sociais, aspectos emocionais e saúde mental. Observando os escores brutos, também houve aumento na capacidade funcional.

Mais uma vez, os cálculos estatísticos de regressão apresentaram a TCC como variável essencial para a mudança na qualidade de vida, a se destacar o

aumento da vitalidade, concomitante à redução dos escores de hipomania e mania.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E DIREÇÕES FUTURAS

Uma grande quantidade de revisões narrativas e sistemáticas indica que a TCC, usada em conjunto com o tratamento farmacológico, pode modificar o curso do TB, especialmente ante os sintomas depressivos (Costa et al., 2010; Jones, 2004; Khazaal, Preisig, & Zullino, 2006; Lotufo Neto, 2004; Miklowitz & Otto, 2007; Otto & Miklovitz, 2004; Prien & Potter, 1990; Vieta et al., 2005; Scott & Colom, 2008; Swartz & Swanson, 2014). Os estudos investigados nessas revisões, assim como os dois estudos práticos e pragmáticos apresentados neste capítulo, reportam resultados encorajadores, como, por exemplo, melhoras nos sintomas de humor e no funcionamento social. Há, contudo, uma diversidade muito grande entre as medidas empregadas nos estudos (qualidade de vida, sintomas de humor, tempo de remissão, número de internações), fazendo esses resultados carecerem de maior replicação.

Neste capítulo, vimos que a adição da TCC ao tratamento farmacológico favoreceu a melhora significativa da qualidade de vida dos participantes, com menor frequência, intensidade e duração de episódios de humor (em especial para os sintomas depressivos).

Entretanto, fazem-se necessários mais estudos, especialmente aplicando a TCC em grupo, para se estabelecer protocolos padronizados (mais replicados) que possam ser incluídos na rotina do atendimento desses pacientes. Igualmente importante seria avaliar a eficácia das estratégias cognitivas e comportamentais para indivíduos bipolares de ciclagem rápida e outros com história de mais de 12 episódios prévios, os quais costumam ter pior prognóstico (Scott et al., 2006). Do mesmo modo, são necessários estudos para avaliar a eficácia de intervenções grupais em pacientes em fases precoces da doença, com destaque para a população de crianças e adolescentes (Fristad, Verducci, Walters, & Young, 2009).

Vimos, também, que os pacientes bipolares apresentam uma incidência muito alta de comorbidade(s). Há poucos estudos que apresentam a eficácia das psicoterapias em bipolares com alguma comorbidade específica, como álcool e drogas (Weiss, Kolodziej, Najavits, Greenfield, & Fucito, 2000).

Pouco ainda se sabe sobre o papel que a psicoterapia em geral e a TCC em particular pode exercer em desfechos específicos, como o suicídio. Infelizmente, pouquíssimos estudos incluem avaliação de suicídio em seus desfechos, e, até o momento, não existe um protocolo de prevenção e tratamento psicoterápico para suicídio, embora, como vimos, a população bipolar apresente um risco enormemente maior de cometê-lo quando comparada à população em geral.

Em estudos futuros, sessões de reavaliação poderão confirmar se os ganhos observados com a terapia serão mantidos em longo prazo. A replicação de protocolos já testados, mais sessões de reavaliação e o aumento do número de sujeitos darão maior confiabilidade aos resultados apresentados.

No que diz respeito à quantidade e à qualidade dos estudos publicados e à eficácia dos tratamentos, houve grande evolução ao longo dos últimos 30 anos, mas ainda há muito espaço para investigações futuras. O cenário de pesquisa em psicoterapia para TB, no entanto, é bastante animador, e a TCC em grupo exerce um protagonismo importante nesse contexto.

REFERÊNCIAS

Abreu, L. N., Lafer, B., Baca-Garcia, E., & Oquendo, M. A. (2009). Suicidal ideation and suicide attempts in bipolar disorder type I: An update for the clinician. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 31(3), 271-280.

American Psychiatric Association [APA] (2014). *DSM-5: Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (5. ed.). Porto Alegre: Artmed.

Andrade, A. C. F. (1999). A abordagem psicoeducacional no tratamento do transtorno afetivo bipolar. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 26(6), 1-8.

Basco, M. R., & Rush, A. J. (1996). *Cognitive-behavioral therapy for bipolar disorder*. New York: The Guilford Press.

Batista, T. A., Von Werne Baes, C., & Juruena, M. F. (2011). Efficacy of psychoeducation in bipolar patients: Systematic review of randomized trials. *Psychology & Neuroscience*, 4(3), 409-416.

- Bauer, M. S., Crits-Christoph, P., Ball, W. A., Dewees, E., McAllister, T., Alahi, P. ... Whybrow, P. C. (1991). Independent assessment of manic and depressive symptoms by self-rating. Scale characteristics and implications for the study of mania. *Archives of General Psychiatry*, 48(9), 807-812.
- Beck, A. T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R. A. (1998). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(6), 893-897.
- Beck, A. T., Kouacs, M., & Weissman, A. (1975). Hopelessness and suicidal behaviour. *Journal of American Medical Association*, 234, 1146-1149.
- Beck, A. T., Ward, C. H., Mendelson, M., & Erbaugh, J. (1961). An inventory for measuring depression. *Archives of General Psychiatry*, 4, 561-571.
- Butler, A. C., Chapman, J. E., Forman, E. M., & Beck, A. T. (2006). The empirical status of cognitive-behavioral therapy: A review of meta-analyses. *Clinical Psychology Review*, 26(1), 17-31.
- Castle, D., White, C., Chamberlain, J., Berk, M., Berk, L., Lauder, S. ... Gilbert, M. (2010). Group-based psychosocial intervention for bipolar disorder: Randomised controlled trial. *The British Journal of Psychiatry*, 196(5), 383-388.
- Cochran, S. D. (1984). Preventing medical noncompliance in the outpatient treatment of bipolar affective disorders. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 52(5), 873-878.
- Colom, F., & Vieta, E. (2004). Melhorando o desfecho do transtorno bipolar usando estratégias não farmacológicas: O papel da psicoeducação. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 26(suppl. 3), 47-50.
- Colom, F., & Vieta, E. (2006). *Psychoeducation manual for bipolar disorder*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Colom, F., Vieta, E., Martinez-Aran, A., Reinares, M., Goikolea, J. M., Benabarre, A., ... Corominas, J. (2003). A randomized trial on the efficacy of group psychoeducation in the prophylaxis of recurrences in bipolar patients whose disease is in remission. *Archives of General Psychiatry*, 60(4), 402-407.
- Costa, R. T., Cheniaux, E., Rangé, B. P., Versiani, M., & Nardi, A. E. (2012). Group cognitive behavior therapy for bipolar disorder can improve the quality of life. *Brazilian Journal of Medical and Biological Research*, 45(9), 862-868.
- Costa, R. T., Cheniaux, E., Rosaes, P. A. L., Carvalho, M. R., Freire, R. C. R., Versiani, M., ... Nardi, A. E. (2011). The effectiveness of cognitive behavioral group therapy in treating bipolar disorder: A randomized controlled study. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 33(2), 144-149.
- Costa, R. T., Rangé, B. P., Malagris, L. E., Sardinha, A., Carvalho, M. R., & Nardi, A. E. (2010). Cognitive-behavioral therapy for bipolar disorder. *Expert Review of Neurotherapeutics*, 10(7), 1089-1099.
- Dell'Osso, B., Grancini, B., Vismara, M., De Cagna, F., Maggi, M., Molle, M., ... Altamura, A. C. (2016). Age at onset in patients with bipolar I and II disorder: A comparison of large sample studies. *Journal of Affective Disorder*, 201, 57-63.
- Derogatis, L. R., & Cleary, P. A. (1977). *SCL-90 administration, scoring and procedure manual for the revised version*. Baltimore: Johns Hopkins University School of Medicine.
- Echeburúa, E., Corral, P., & Fernández-Montalvo, J. (2000). Escala de inadaptação: Propriedades psicométricas en contextos clínicos. *Análisis y Modificación de Conducta*, 26, 325-340.

- Endicott, J., Spitzer, R., Fleiss, J., & Cohen, J. (1976). The Global Assessment Scale. A procedure for measuring overall severity of psychiatric disturbance. *Archives of General Psychiatry*, 33(6), 766-771.
- Frey, B. N., Fonseca, M. M. R., Machado-Vieira, R., Soares, J. C., & Kapczinski, F. (2004). Anormalidades neuropatológicas e neuroquímicas no transtorno afetivo bipolar. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 26(3), 180-188.
- Frías, Á., Baltasar, I., & Birmaher, B. (2016). Comorbidity between bipolar disorder and borderline personality disorder: Prevalence, explanatory theories, and clinical impact. *Journal of Affective Disorders*, 202, 210-219.
- Fristad, M. A., Verducci, J. S., Walters, K., & Young, M. E. (2009). Impact of multifamily psychoeducational psychotherapy in treating children aged 8 to 12 years with mood disorders. *Archives of General Psychiatry*, 66(9), 1013-1021.
- Gitlin, M. J., Swendsen, J., Heller, T. L., & Hammen, C. (1955). Relapse and impairment in bipolar disorder. *The American Journal of Psychiatry*, 112(11), 1635-1640.
- Gomes, B. C., & Lafer, B. (2007). Psicoterapia em grupo de pacientes com transtorno afetivo bipolar. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 34(2), p. 84-89.
- Gomes, B. C., Abreu, L. N., Brietzke, E., Caetano, S. C., Kleinman, A., Nery, F. G., & Lafer, B. (2011). A randomized controlled trial of cognitive behavioral group therapy for bipolar disorder. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 80(3), 144-150.
- González-Isasi, A., Echeburúa, E., Limiñana, J. M., & González-Pinto, A. (2014). Psychoeducation and cognitive-behavioral therapy for patients with refractory bipolar disorder: A 5-year controlled clinical trial. *European Psychiatry*, 29(3), 134-141.
- Goodwin, G. M., & Consensus Group of the British Association for Psychopharmacology. (2003). Evidence-based guidelines for treating bipolar disorder: Recommendations from the British Association for Psychopharmacology. *Journal of Psychopharmacology*, 17(2), 149-173.
- Goodwin, F. K., & Jamison, K. R. (2007). *Manic-depressive illness*. New York: Oxford University Press.
- Hamilton, M. (1960). Rating scale for depression. *Journal of Neurology, Neurosurgery, and Psychiatry*, 23, 56-62.
- Jones, S. (2004). Psychotherapy of bipolar disorder: A review. *Journal of Affective Disorders*, 80(2-3), 101-114.
- Judd, L. L., Akiskal, H. S., Schettler, P. J., Endicott, J., Maser, J., Solomon, D. A., ... Keller, M. B. (2002). The long-term natural history of the weekly symptomatic status of bipolar I disorder. *Archives of General Psychiatry*, 59(6), 530-537.
- Juruena, M. F. (2001). Terapia cognitiva: Intervenção para o transtorno afetivo bipolar. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 28(6), 322-330.
- Juruena, M. F. (2004). Transtorno bipolar. In P. Knapp (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica* (pp. 317-327). Porto Alegre: Artmed.
- Juruena, M. F. P. (2012). Cognitive-behavioral therapy for the bipolar disorder patients. In I. R. de Oliveira (Ed.), *Standard and innovative strategies in cognitive behavior therapy*. Rijeka: InTech.
- Khazaal, Y., Preisig, M., & Zullino, D. F. (2006). Psychoeducational and cognitive behavioral treatments of bipolar disorder. *Sante Mentale au Quebec*, 31(1), 125-143.

- Lotufo Neto, F. (2004). Terapia comportamental cognitiva para pessoas com transtorno bipolar. *Revista Brasileira Psiquiatria*, 26(suppl 3), 44-46.
- Magliano, L., Orrico, A., Fiorillo, A., Del Vecchio, H., Castiello, G., Malangone, C., ... Maj, M. (2009). Family burden in bipolar disorders: Results from the Italian Mood Disorders Study (IMDS). *Epidemiology and Psychiatric Sciences*, 18(2), 137-146.
- Mann-Wrobel, M. C., Carreno, J. T., & Dickinson, D. (2011). Meta-analysis of neuropsychological functioning in euthymic bipolar disorder: An update and investigation of moderator variables. *Bipolar Disorders*, 13(4), 334-342.
- McHorney, C. A., Ware, J. E., & Raczek, A. E. (1993). The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): II psychometric and clinical tests of validity in measuring physical and mental health constructs. *Medical Care*, 31(3), 247-263.
- Merikangas, K. R., Jin, R., He, J. P., Kessler, R. C., Lee, S., Sampson, N. A., ... Zarkov, Z. (2011). Prevalence and correlates of bipolar spectrum disorder in the world mental health survey initiative. *Archives General Psychiatry*, 68(3), 241-251.
- Michalak, E. E., Yatham, L. N., & Lam, R. W. (2005). Quality of life in bipolar disorder: A review of the literature. *Health and Quality of Life Outcomes*, 3, 72.
- Miklowitz, D. J., & Otto, M. W. (2007). Psychosocial interventions for bipolar disorder: A review of literature and introduction of the systematic treatment enhancement program. *Psychopharmacology Bulletin*, 40(4), 116-131.
- Miklowitz, D. J., Otto, M. W., Wisniewski, S. R., Araga, M., Frank, E., Reilly-Harrington, N. A., ... Sachs, S. S. (2006). Psychotherapy, symptom outcomes, and role functioning over one year among patients with bipolar disorder. *Psychiatric Services*, 57(7), 959-965.
- National Center for Biotechnology Information Search (NCBI). (c2016). *PubMed*. Recuperado de: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/>
- Otto, M. W., & Miklovitz, D. J. (2004). The role and impact of psychotherapy in the management of bipolar disorder. *CNS Spectrums*, 9(11), 27-32.
- Palmer, A. G., Williams, H., Gorsefield, D., & Adams, M. (1995). CBT in a group format for bipolar affective disorder. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 23(2), 153-168.
- Patelis-Siotis, I., Young, L. T., & Robb, J. C. (2001). Group cognitive behavioural therapy for bipolar disorder: A feasibility and effectiveness study. *Journal of Affective Disorders*, 65(2), 145-153.
- Perry, A., Tarrier, N., Morriss, R., McCarthy, E., & Limb, K. (1999). Randomised controlled trial of efficacy of teaching patients with bipolar disorder to identify early symptoms of relapse and obtain treatment. *British Medical Journal*, 318(7177), 149-153.
- Pompili, M., Gonda, X., Serafini, G., Innamorati, M., Sher, L., Amore, M., ... Girardi, P. (2013). Epidemiology of suicide in bipolar disorders: A systematic review of the literature. *Bipolar Disorders*, 15(5), 457-490.
- Prien, R., & Potter, W. (1990). NIMH workshop report on treatment of bipolar disorder. *Psychopharmacol Bulletin*, 26(4), 409-427.
- Salcedo, S., Gold, A. K., Sheikh, S., Marcus, P. H., Nierenberg, A. A., Deckersbach, T., & Sylvia, L. G. (2016). Empirically supported psychosocial interventions for bipolar disorder: Current state of the

research. *Journal of Affective Disorders*, 201(1), 203-214.

Scott, J. (1995). Psychotherapy for bipolar disorder. *The British Journal of Psychiatry*, 167(5), 581-588.

Scott, J. (2001). *Overcoming mood swings*. London: Robinson.

Scott, J., & Colom, F. (2008). Gaps and limitations of psychological interventions for bipolar disorders. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 77(1), 4-11.

Scott, J., Paykel, E., Morriss, R., Bentall, R., Kinderman, P., Johnson, T., ... Hayhurst H. (2006). Cognitive-behavioural therapy for severe and recurrent bipolar disorders: Randomised controlled trial. *The British Journal of Psychiatry*, 188(4), 313-320.

Spielberger, C. D., Gorsuch, R. L., & Lushene, R. E. (1970). *The state trait anxiety inventory*. Palo Alto: Consulting Psychologist Press.

Swartz, H. A., & Swanson, J. (2014). Psychotherapy for bipolar disorder in adults: A review of the evidence. *Focus*, 12(3), 251-266.

Swartz, H. A., Frank, E., Frankel, D. R., Novick, D., & Houck, P. (2009). Psychotherapy as monotherapy for the treatment of bipolar II depression: A proof of concept study. *Bipolar Disorder*, 11(1), 89-94.

Vázquez, G. H., Holtzman, J. N., Lolich, M., Ketter, T. A., & Baldessarini, R. J. (2015). Recurrence rates in bipolar disorder: Systematic comparison of long-term prospective, naturalistic studies *versus* randomized controlled trials. *European Neuropsychopharmacology*, 25(10), 1501-1512.

Vieta, E., Pacchiarotti, I., Scott, J., Sánchez-Moreno, J., Di Marzo, S., & Colom, F. (2005). Evidence-based research on the efficacy of psychologic interventions in bipolar disorders: a critical review. *Current Psychiatry Report*, 7(6), 449-455.

Ware, J. E. Jr., & Sherbourne, C. D. (1992). The MOS 36 item short- form health survey (SF-36). I Conceptual framework and itemselection. *Medical Care*, 30(6), 473-483.

Weiss, R. D., Kolodziej, M. E., Najavits, L. M., Greenfield, S. F., & Fucito, L. M. (2000). Utilization of psychosocial treatments by patients diagnosed with bipolar disorder and substance dependence. *The American Journal Addictions*, 9(4), 314-320.

Weissman, M. M., & Bothwell, S. (1976). Assessment of social adjustment by patient self report. *Archives General of Psychiatry*, 33(9), 1111-1115.

Whiteford, H. A., Degenhardt, L., Rehm, J., Baxter, A. J., Ferrari, A. J., Erskine, H. E., ... Vos, T. (2013). Global burden of disease attributable to mental and substance use disorders: Findings from the Global Burden of Disease Study 2010. *The Lancet*, 382(9904), 1575-1586.

Williams, J. M., Alatiq, Y., Crane, C., Barnhofer, T., Fennell, M. J., Duggan, D. S., ... Goodwin, G. M. (2008). Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) in bipolar disorder: Preliminary evaluation of immediate effects on between-episode functioning. *Journal of Affective Disorders*, 107(1-3), 275-279.

Young, R. C., Biggs, J. T., Ziegler, V. E., & Meyer, D. A. (1978). A rating scale for mania: Reliability, validity and sensitivity. *The British Journal of Psychiatry*, 133(5), 429-435.

Zaretsky, A. E., Rizvi, S., & Parikh, S. V. (2007). How well psychosocial interventions work in bipolar disorders? *The Canadian Journal of Psychiatry*, 52(1), 14-21.

LEITURAS RECOMENDADAS

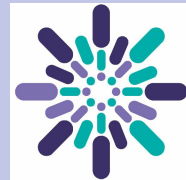
- Baune, B. T., & Malhi, G. S. (2015). A review on the impact of cognitive dysfunction on social, occupational, and general functional outcomes in bipolar disorder. *Bipolar Disorders*, 17(Suppl 2), 41-55.
- Bechi, M., Bosia, M., Spangaro, M., Buonocore, M., Cocchi, F., Pigoni, A., ... Cavallaro, R. (2015). Combined social cognitive and neurocognitive rehabilitation strategies in schizophrenia: Neuropsychological and psychopathological influences on Theory of Mind improvement. *Psychological Medicine*, 45(15), 3147-3157.
- Bonnin, C. M., Torrent, C., Vieta, E., & Martínez-Arán, A. (2014). Restoring functioning in bipolar disorder: Functional remediation. *Harvard Review of Psychiatry*, 22(6), 326-330.
- Bortolato, B., Miskowiak, K. W., Köhler, C. A., Vieta, E., & Carvalho, A. F. (2015). Cognitive dysfunction in bipolar disorder and schizophrenia: A systematic review of meta-analyses. *Neuropsychiatric Disease and Treatment*, 11, 3111-3125.
- Bowie, C. R., Gupta, M., & Holshausen, K. (2013). Cognitive remediation therapy for mood disorders: Rationale, early evidence, and future directions. *Canadian Journal of Psychiatry*, 58(6), 319-325.
- Cacilhas, A. A., Magalhães, P. V., Ceresér, K. M., Walz, J. C., Weyne, F., Rosa, A. R. ... Kapczinski, F. (2009). Validity of a short functioning test (FAST) in Brazilian outpatients with bipolar disorder. *Value Health*, 12(4), 624-627.
- Cardoso, T. A., Farias, C. A., Mondin, T. C., da Silva, G. G., Souza, L. D., da Silva, R. A., ... Jansen, K. (2014). Brief psychoeducation for bipolar disorder: Impact on quality of life in young adults in a 6-month follow-up of a randomized controlled trial. *Psychiatry Research*, 220(3), 896-902.
- Colom, F., Reinares, M., Pacchiarotti, I., Popovic, D., Mazzarini, L., Martínez-Arán, A., ... Vieta, E. (2010). Has number of previous episodes any effect on response to group psychoeducation in bipolar patients? A 5-year follow-up post hoc analysis. *Acta Neuropsychiatrica*, 22(2), 50-53.
- Colom, F., Vieta, E., Sánchez-Moreno, J., Palomino-Otiniano, R., Reinares, M., Goikolea, J. M., ... Martínez-Arán, A. (2009). Group psychoeducation for stabilised bipolar disorders: 5-year outcome of a randomised clinical trial. *Br J Psychiatry*, 194(3), 260-265.
- Depp, C. A., Mausbach, B. T., Harmell, A. L., Savla, G. N., Bowie, C. R., Harvey, P. D., & Patterson, T. L. (2012). Meta-analysis of the association between cognitive abilities and everyday functioning in bipolar disorder. *Bipolar Disorders*, 14(3), 217-226.
- First, M. B., Gibbon, M., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. W. (1996). *User guide for the structured clinical interview for DSM-IV Axis I Disorders*. Washington, DC: American Psychiatric Association.
- Geddes, J. R., & Miklowitz, D. J. (2013). Treatment of bipolar disorder. *The Lancet*, 381(9878), 1672-1682.
- Meyer, T. D., & Hautzinger, M. (2012). Cognitive behaviour therapy and supportive therapy for bipolar disorders: Relapse rates for treatment period and 2-year follow-up. *Psychological Medicine*, 42(7), 1429-1439.
- Miklowitz, D. J. (2008). Adjunctive psychotherapy for bipolar disorder: State of the evidence. *American Journal of Psychiatry*, 165(11), 1408-1419.

Reinares, M., Sánchez-Moreno, J., & Fountoulakis, K. N. (2014). Psychosocial interventions in bipolar disorder: What, for whom, and when. *Journal of Affective Disorders*, 156, 46-55.

Rosenbaum, M. (1980). A schedule for assessing self-control behaviors: Preliminary findings. *Behavior Therapy*, 11(1), 109-121.

Samalin, L., de Chazeron, I., Vieta, E., Bellivier, F., & Llorca, P. M. (2016). Residual symptoms and specific functional impairments in euthymic patients with bipolar disorder. *Bipolar Disorder*, 18(2), 164-173.

6



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNO OBSESSIVO- -COMPULSIVO

**Aristides Volpato Cordioli
Daniela Tusi Braga
Andressa da Silva Behenck
Juliana Braga Gomes**

O transtorno obsessivo-compulsivo (TOC) se caracteriza pela presença de pensamentos, impulsos ou imagens, recorrentes e persistentes, percebidos como intrusivos e indesejáveis, causando ansiedade acentuada ou sofrimento (obsessões), e pela presença de comportamentos repetitivos ou atos mentais (compulsões) que o indivíduo se sente compelido a executar em resposta a uma obsessão ou em razão de regras que devem ser rigidamente aplicadas

(American Psychiatric Association [APA], 2014). O TOC tem uma prevalência aproximada de 2 a 3% na população e costuma apresentar um curso crônico, sendo frequentemente progressivo quando não tratado (Hollander & Simeon, 2012). Acomete sobretudo indivíduos jovens no fim da adolescência, embora os primeiros sintomas possam se manifestar na infância (APA, 2014).

O TOC é considerado um transtorno mental heterogêneo, devido à diversidade de seus sintomas. Embora o conteúdo específico das obsessões e compulsões varie entre os indivíduos, certos tipos de sintomas ou dimensões são comuns: obsessões por contaminação e compulsões por limpeza; dúvidas obsessivas e verificações; obsessões por simetria e compulsões de repetição, organização e contagem; obsessões de conteúdo agressivo ou violento, sexual e religioso (pensamentos blasfemos) e compulsões relacionadas. É comum a pessoa com TOC apresentar mais de uma dimensão de sintomas. Para o diagnóstico do transtorno, é necessário que os sintomas consumam tempo (mais de 1 hora por dia), causem sofrimento e interfiram significativamente na vida do indivíduo, com prejuízos principalmente nas relações sociais e familiares e no desempenho ocupacional.

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) que envolve técnicas de exposição e prevenção de rituais ou prevenção de resposta (EPR) é o tratamento psicoterápico considerado de primeira escolha para o TOC (Koran & Simpson, 2013). Embora a resposta à TCC varie de indivíduo para indivíduo, 70% das pessoas com o transtorno que aderem ao tratamento conseguem uma melhora satisfatória. Diversos ensaios clínicos, realizados tanto com o tratamento individual como em grupo, comprovaram a efetividade da TCC no tratamento do TOC (Cordioli et al., 2002; Håland et al., 2010; Jónsson & Hougaard, 2009) e a manutenção dos resultados no prazo de dois (Braga, Manfro, Niederauer, & Cordioli, 2010) e cinco anos (Borges et al., 2011).

Além da TCC, os medicamentos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs) são tratamentos efetivos na redução dos sintomas do TOC. Seu uso é recomendado especialmente quando o paciente não adere ou não responde à TCC isoladamente, quando os sintomas do TOC são graves

ou incapacitantes, quando há predomínio de obsessões e quando o paciente apresenta comorbidades e *insight* pobre sobre o transtorno.

Um ensaio clínico randomizado comparou pacientes que realizaram a TCC em grupo (TCCG) com o tratamento com sertralina. O estudo verificou que ambos os grupos melhoraram. No entanto, no grupo dos pacientes tratados com TCCG, a redução da intensidade dos sintomas foi maior, e um número maior de indivíduos obteve remissão total dos sintomas obsessivo-compulsivos (OCs) em curto e longo prazos (Borges et al., 2011; Sousa, Isolan, Oliveira, Manfro, & Cordioli, 2006). Ainda em relação à eficácia da TCCG, uma metanálise recente analisou 12 estudos e um total de 832 pacientes tratados com TCCG para o TOC. Os autores verificaram que a TCCG foi efetiva na redução tanto dos sintomas OCs quanto na diminuição dos sintomas de depressão e ansiedade. Além disso, o mesmo estudo salienta que, quando a TCCG foi comparada a TCC individual, farmacoterapia ou tratamento combinado, a eficácia foi a mesma para os três grupos (Schwartz, Barkowski, Burlingame, Strauss, & Rosendahl, 2016). Além deste, outros estudos compararam a resposta da TCCG em relação à TCC desenvolvida individualmente, e os resultados foram semelhantes nas duas modalidades de tratamento (Anderson & Rees, 2007; Jaurrieta et al., 2008; Jónsson, Hougaard, & Bennedsen, 2011;).

O objetivo principal deste capítulo é apresentar ao leitor a TCC em grupo no tratamento dos sintomas do TOC. Será descrito o protocolo de TCCG desenvolvido em 1999 no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), cuja eficácia foi repetidamente comprovada em diversos estudos, o qual está em uso até os dias de hoje, sendo utilizado com sucesso em outros centros do País, como Recife e Florianópolis. Serão descritos detalhes práticos do protocolo: avaliação e seleção dos pacientes, estruturação e sequência das sessões, regras e cuidados a serem seguidos na condução prática dos grupos.

PROTOCOLO DE 12 SESSÕES DE TCCG PARA O TOC

O protocolo de TCCG para o TOC utilizado no HCPA é composto de 12 sessões semanais, cada uma com duração de 2 horas. É indicado que o grupo tenha entre 5 e 9 participantes. Um número inferior a cinco pessoas pode comprometer a dinâmica das sessões, e 10 ou mais podem dificultar a participação de todos nas sessões e acarretar frustrações e desistências. Além disso, os grupos, nessa abordagem, são fechados, ou seja, há um número de sessões limitado (início, meio e fim), e novos pacientes não podem entrar após o grupo ter iniciado. O protocolo (Manual da Terapia) contém, além de textos psicoeducativos, os conteúdos teóricos e práticos de cada sessão, - espaços para anotações, bem como escalas e formulários que são utilizados durante o tratamento.^[NT] Algumas questões importantes devem ser consideradas na TCCG de pacientes com TOC: avaliação diagnóstica, capacidade de *insight*, motivação para fazer o tratamento e psicoeducação antes do tratamento.

AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA DO PACIENTE E DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DO GRUPO

É fundamental avaliar o paciente individualmente antes de ingressar no tratamento em grupo. É indicado que essa avaliação seja realizada pelos próprios terapeutas. O primeiro objetivo das entrevistas de avaliação é confirmar o diagnóstico de TOC e fazer o diagnóstico diferencial com outros transtornos que apresentam sintomas semelhantes (p. ex., os demais transtornos do espectro OC, doenças neurológicas, transtornos do controle de impulsos). Deve-se, ainda, avaliar aspectos pessoais, como o *insight* quanto à doença e a motivação pessoal para realizar a TCCG, e aspectos da doença, como início e duração dos sintomas, dimensões que o paciente apresenta, tratamentos anteriores e resposta, interferência no trabalho e no funcionamento da família, gravidade dos sintomas e prejuízos na vida social e acadêmica. É recomendado que o TOC seja o problema mais perturbador e prejudicial no momento da inclusão no grupo, mesmo que haja comorbidades com outros transtornos psiquiátricos – o que é muito comum. Além disso, os sintomas devem ser, pelo menos, de intensidade moderada, com escore

mínimo de 16 pontos na Escala Obsessivo-compulsiva de Yale-Brown (YBOC-S) (Goodman et al., 1989).

Comorbidades como depressão, transtornos de ansiedade e transtornos da personalidade não são fatores de exclusão para TCCG, mas a gravidade de cada uma delas e a possibilidade de interferência no funcionamento do grupo devem ser consideradas. Se os sintomas OCs forem muito graves, contraindicam a participação. Abuso de substâncias, transtorno bipolar com sintomas não controlados, psicoses, transtornos graves da personalidade (*borderline*, esquizotípica, esquizoide), déficit cognitivo evidente e transtorno de acumulação como diagnóstico principal são critérios de exclusão. É importante, ainda, comentar que indivíduos com predomínio de obsessões de conteúdo repugnante (violento ou agressivo, blasfemo, sexual) apresentam maior dificuldade de participar da TCCG em razão da vergonha que sentem e do receio de se expor publicamente. Foi verificado, ainda, que esses pacientes, quando tratados em grupo, têm uma redução menor dos sintomas do que na TCC individual (O'Connor et al., 2005).

De forma geral, quanto mais homogêneo for o grupo de TCCG, melhor. No entanto, essa não é a regra, principalmente no TOC, em que existe uma variedade de sintomas. Podem ser tratados no mesmo grupo pacientes que apresentam as diferentes dimensões de sintomas do transtorno (p. ex., contaminação/limpeza, alinhamento/simetria, obsessões religiosas ou sexuais, dúvidas obsessivas e verificações).

MOTIVAÇÃO PARA O TRATAMENTO, *INSIGHT* E PREDITORES DE RESPOSTA À TERAPIA

Nas entrevistas iniciais, também se deve avaliar a motivação do paciente para participar da terapia em grupo, seu grau de *insight* sobre o TOC e sua capacidade para tolerar a ansiedade que ocorrerá com os exercícios de exposição e prevenção de rituais (EPR). Motivação e *insight* são condições essenciais para o aproveitamento da TCCG e comprovadamente são preditores de resposta à terapia (Raffin, Fachel, Ferrão, Souza, & Cordioli, 2009). Além desses fatores, também estão associados aos resultados positivos da TCCG a boa qualidade de vida antes do tratamento, sintomas OCs leves

ou moderados, predomínio de compulsões e evitações e adesão precoce aos exercícios de EPR (Raffin et al., 2009; Wheaton et al., 2016).

PSICOEDUCAÇÃO ANTES DO TRATAMENTO

São naturais as dúvidas e a ambivalência, mas é fundamental resolvê-las antes do início da TCCG para evitar desistências e abandonos, que podem influenciar também na reposta dos outros participantes. O grande recurso de que o terapeuta dispõe para melhorar o *insight* e a motivação ainda na fase de avaliação do paciente é a psicoeducação com foco nas seguintes questões: 1) o que é o TOC, quais as suas manifestações, quais os fatores que concorrem para sua origem e manutenção (fatores biológicos, erros de percepção e avaliação, aprendizagens e crenças erradas); por que os rituais e as evitações perpetuam o TOC (modelo cognitivo-comportamental); 2) os tratamentos do TOC: seus alcances e seus limites, vantagens e desvantagens da TCC para o TOC e como funciona; e 3) como é a TCCG, como são as sessões, as tarefas para casa e o que será exigido do paciente para que ele possa vencer o transtorno. É importante que ele expresse de forma explícita sua decisão de realizar a TCCG e seguir as regras básicas da terapia, descritas mais adiante.

CARACTERÍSTICAS E ESTRUTURA DAS SESSÕES

As sessões são estruturadas, de acordo com a agenda estabelecida no protocolo de tratamento (Manual da TCCG). Todas as sessões devem conter:

AGENDA DA SESSÃO

As sessões de TCCG têm uma agenda definida previamente e focada nos tópicos essenciais para combater os sintomas OCs. Uma das funções do terapeuta é seguir a agenda e controlar o tempo de cada atividade prevista para cada sessão, pois o tratamento é limitado a 12 encontros, embora eventualmente possam ser incluídas mais 2 a 3 sessões de reforço. É importante que todos os assuntos sejam abordados.

REVISÃO DOS SINTOMAS E DAS TAREFAS DE CASA

Geralmente, todas as sessões são iniciadas com a revisão dos sintomas e com os relatos das tarefas de casa, feitos por todos os participantes. São analisadas as dificuldades e também as conquistas obtidas na realização das tarefas. De acordo com o que foi conseguido, os terapeutas sugerem novos exercícios e valorizam o sucesso alcançado por cada um, estimulando os pacientes a avançar e auxiliando também quando houver dificuldades ou impasses.

PSICOEDUCAÇÃO

Após as revisões iniciais de cada sessão, o terapeuta ou o coterapeuta fazem uma breve explanação psicoeducativa sobre algum tópico do TOC, como pode ser visto no Quadro 6.1, que mostra os conteúdos abordados e as respectivas intervenções em cada uma das sessões. No Manual da Terapia, para cada sessão, existe um texto com o conteúdo psicoeducativo. É recomendável que os participantes o leiam com antecedência.

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Em praticamente todas as sessões, são realizados exercícios de EPR durante a própria sessão – por exemplo, tocar em objetos “sujos”, como esponja de cozinha, sabonete usado, brinquedos velhos de crianças, cédulas de dinheiro amarradas, moedas e seringa descartada (sem agulha), e não lavar as mãos depois. Também são preenchidos questionários e instrumentos, como a lista de sintomas, a Y-BOCS e o registro de pensamentos disfuncionais (RPD), quando previstos para a sessão.

ESCOLHA DAS TAREFAS DE CASA

Ao término de cada sessão, são combinados os exercícios ou tarefas para casa, que são individualizados. É fundamental planejar as primeiras tarefas de EPR focando nos rituais compulsivos e nas evitações, sempre iniciando pelos exercícios mais fáceis (lista de sintomas com grau 1 ou 2 de ansiedade, preenchida na primeira sessão). Em combinação com cada paciente, são escolhidas de 4 a 6 tarefas por semana ou mais, com base nos exercícios anteriores, ou incorporando novas tarefas a partir da lista de sintomas. É importante incentivar o paciente a realizar os exercícios até a aflição

desaparecer ou diminuir significativamente, ou pelo maior tempo possível, e orientá-lo a repetir os exercícios o maior número de vezes que puder. Além disso, deve-se sugerir exercícios que o paciente acredita ter 80% de chances de executar (regra dos 80%).

RESUMO DA SESSÃO PELO TERAPEUTA

Para a finalização da sessão, após todos terem escolhido seus exercícios de casa, o terapeuta faz um breve resumo dos tópicos mais relevantes abordados e relembra, perante o grupo, as tarefas combinadas com cada um dos participantes, verificando o quanto cada paciente se sente confortável e comprometido com elas. Esse compromisso perante o grupo é um importante fator de adesão aos exercícios.

AValiação DA SESSÃO PELOS PARTICIPANTES

Logo após o resumo da sessão pelo terapeuta, os participantes também fazem, individualmente, sua avaliação da sessão. Podem ser utilizadas perguntas como: “Qual a sua avaliação da sessão de hoje?” ou “O que ficou de mais importante para você na sessão de hoje?”. É uma breve explicação, que não deve durar mais de 1 minuto para cada participante.

AGENDA DA PRIMEIRA SESSÃO

A primeira sessão é um pouco diferente das demais, pois é a ocasião de os participantes se conhecerem, de se sentirem acolhidos, de iniciarem um vínculo com os terapeutas e com os demais membros do grupo. É uma sessão fundamental para vencerem sua ambivalência, dissiparem medos e ansiedades e se sentirem motivados. Vejamos em detalhes o que acontece na primeira sessão de TCCG, que é um pouco distinta das demais sessões que seguem uma sequência parecida; o que muda são os assuntos e as intervenções, que estão descritas no Quadro 6.1.

Quadro 6.1 Assuntos abordados e intervenções utilizadas no protocolo de TCCG para o TOC

Sessões	Assuntos	Intervenções
---------	----------	--------------

1	- O que é TOC? Prevalência, incidência e curso do transtorno. - O impacto na vida pessoal e familiar do paciente com TOC.	- Recepção dos pacientes e familiares e apresentação do grupo. - Entrega do Manual da Terapia. - Combinações sobre o funcionamento da TCCG e regras do tratamento. - Exercícios práticos: preenchimento da lista de sintomas OCs e escalas que avaliam a gravidade do TOC.
2	- Causas do TOC: neurobiológicas e psicológicas. - Relação entre obsessões, compulsões e evitações. - Modelo comportamental e cognitivo do TOC.	- Revisão das tarefas de casa e esclarecimento das dúvidas. - Revisão das listas de sintomas de grau de ansiedade 1 e 2 de cada participante. - Diário de sintomas do pior dia da semana.
3	- Os fundamentos da TCC: terapia de exposição e prevenção de rituais (EPR). - O fenômeno da habituação.	- Revisão da lista de sintomas grau de aflição 3 e diário de sintomas de cada participante. - Exercícios práticos: demonstrações e exercícios práticos de enfrentamento/exposição e prevenção dos rituais (manias). - Escolha individual das primeiras tarefas de EPR de acordo com a lista de sintomas com grau de aflição 1 e 2 (mínimo 4 sintomas).
4	- O que são pensamentos automáticos e crenças? - Quais as principais crenças erradas ou distorcidas no TOC?	- Treinamento sobre a identificação e o registro de pensamentos disfuncionais (RPD) e crenças típicas do TOC. - Escolha individual de pelo menos mais 4 exercícios de EPR de acordo com a lista de sintomas com grau de aflição 1 e 2.
5	Medos de contaminação e manias de limpeza: exagerar os riscos e a responsabilidade.	- Revisão dos exercícios de EPR, RPD. - Técnicas para correção das crenças sobre excesso de responsabilidade e avaliação exagerada do risco. - Escolha individual de ao menos mais 4 exercícios de EPR de acordo com a lista de sintomas com grau de aflição 2 ou 3.
6	Pensamentos obsessivos de conteúdos indesejáveis e perturbadores (conteúdo violento, sexual, blasfemo, religioso ou supersticioso): exagerar o poder do pensamento e a necessidade de controlá-lo.	- Revisão dos exercícios: RPD, pensamentos disfuncionais e EPR. - Questionamento socrático. - Construção de uma história breve cujo conteúdo são pensamentos de conteúdo indesejáveis. - Escolha individual de ao menos mais 4 exercícios de EPR de acordo com a lista de sintomas com grau de aflição 2 ou 3.
7	Compulsões de organização e simetria, verificações excessivas e dúvidas: pensamentos distorcidos envolvendo o perfeccionismo e a necessidade de ter certeza.	- RPD, identificação dos pensamentos negativos ou catastróficos e questionamento socrático. - Revisão dos exercícios de EPR. - Escolha individual de ao menos mais 4 exercícios de EPR de acordo com a lista de sintomas com grau de aflição 3 ou 4.
8	- Explanação para os familiares dos pacientes sobre o que é o TOC e como funciona o tratamento. - Discussão sobre o impacto do TOC nas rotinas, na vida social e nas relações familiares, interferência no trabalho e na produtividade dos	- Revisão dos exercícios: RPD, pensamentos disfuncionais e EPR. - Apresentação dos pacientes e familiares.

	pacientes e familiares.	• Depoimento dos familiares sobre os sintomas do paciente e seu impacto na vida familiar. • Escolha individual de ao menos mais 4 exercicios de EPR de acordo com a lista de sintomas com grau de aflicção 3 ou 4.
9	• O que é acumulação compulsiva e como combatê-la? • Avaliação do tratamento (o que foi conseguido ou não com a terapia).	• Revisão dos exercicios: RPD, pensamentos disfuncionais e EPR. • Exercício de descarte para acumulação compulsiva. • Treino e utilização de escalas de automonitoramento. • Escolha individual de ao menos mais 4 exercicios de EPR de acordo com a lista de sintomas com grau de aflicção 4.
10	• Preparação para alta. • O que são lapsos e recaídas?	• Revisão dos exercicios de EPR, acumulação compulsiva e das planilhas de automonitoramento. • Como prevenir recaídas.
11	• Preparação para alta: explanação sobre possíveis lapsos e recaídas; como evitá-los?	• Revisão dos exercicios de EPR, situações gatilho, lembretes e das planilhas de automonitoramento.
12	• Avaliação final da terapia; recursos da comunidade (associações de portadores, familiares e ex-pacientes), leituras adicionais, <i>websites</i> (Cordioli, 2016).	• Revisão dos exercicios de EPR, discussão sobre as dificuldades ainda existentes e os ganhos. • Debate sobre as situações gatilho e estratégias de enfrentamento e revisão das planilhas de automonitoramento. • Preenchimento do questionário de avaliação da TCCG. • Combinação de encontros de revisão.

1. ACOLHIMENTO DOS PACIENTES, FAMILIARES E APRESENTAÇÕES: 30 MINUTOS

A primeira sessão tem como objetivos principais recepcionar os pacientes e seus familiares, reforçar sua motivação para o tratamento e estabelecer um vínculo entre os participantes. Para tanto, inicia-se com uma breve apresentação de cada um (equipe, pacientes, familiares), incluindo nome, profissão, procedência. Em seguida, o coordenador faz uma breve explanação sobre o tratamento do TOC, situando a TCCG no contexto dos tratamentos e das terapias para o transtorno. São explicitadas as regras e combinações para o funcionamento do grupo, como horário e local das reuniões, número de sessões com os pacientes, número de sessões com os familiares, faltas, atrasos, interrupção do tratamento caso desejar, aplicações de escalas, etc. É ressaltada a importância da assiduidade e da pontualidade, dando

oportunidade para os pacientes e familiares esclarecerem suas dúvidas e fazerem perguntas.

2. DISTRIBUIÇÃO DO MANUAL DA TERAPIA: 10 MINUTOS

Em seguida, é distribuído o Manual da Terapia. O coordenador explica o conteúdo do manual: a sequência das sessões, os conteúdos psicoeducativos, questionários, planilhas, folhas de exercícios, folhas de registros, etc., e como usá-lo para acompanhar o andamento das sessões. Explica brevemente como as sessões se desenrolam: revisão das tarefas de casa, explanação psicoeducativa, exercícios práticos na sessão, combinações das novas tarefas de casa e avaliação da sessão pelos participantes. Explica, ainda, o papel dos participantes, do terapeuta e coterapeuta, a limitação do tempo das participações para que todos tenham a oportunidade de falar. Ressalta a importância da adesão aos exercícios de casa (como vencer os medos do TOC) e de dedicar todos os dias um tempo para os exercícios práticos, tarefas de casa e para leituras complementares na internet^[NT] ou dos livros *Vencendo o transtorno obsessivo-compulsivo* e *Medos, dúvidas e manias*, da editora Artmed, ou outros. O coordenador deve destacar a importância de trazer o Manual da Terapia em todas as sessões.

3. PSICOEDUCAÇÃO: 20 MINUTOS

Depois das explicações iniciais, e utilizando os *slides* que acompanham o Manual, o terapeuta ou o coterapeuta fazem uma breve explanação sobre o que é o TOC; quais são seus sintomas (obsessões, compulsões, evitações) e suas diferentes apresentações clínicas; a importância do transtorno: por que o TOC é uma doença grave; sua prevalência, incidência e curso ao longo da vida; impacto na vida pessoal, familiar e profissional. Sempre que possível, deve-se solicitar aos participantes exemplos pessoais sobre o que está sendo apresentado, com o intuito de explicar os conceitos de ansiedade, obsessão e compulsão, evitações e outras manobras de neutralização, o que perpetua os sintomas OCs e o que reduz.

4. EXERCÍCIO PRÁTICO: PREENCHIMENTO DA LISTA DE

SINTOMAS: 40 MINUTOS

Uma vez tendo compreendido o que é o TOC e quais são seus sintomas, o passo seguinte é a elaboração da lista de sintomas, ponto de partida para o tratamento. A lista é elaborada pelo paciente a partir de uma *check-list* (lista de sintomas do TOC) que pode ser encontrada no *site* e consta no Manual (Cordioli, 2016). Cada um dos sintomas é graduado com o objetivo de facilitar e auxiliar na terapia de exposição e prevenção de rituais. O preenchimento da lista é feito da seguinte forma:

- a. *Instruções para o preenchimento e atividade prática.* Inicialmente, o terapeuta solicita a um dos participantes a leitura das instruções para o preenchimento da lista e, inclusive, ainda perante o grupo, solicita a algum membro que leia alguns exemplos de obsessões ou compulsões e as pontue. Depois de esclarecidas as dúvidas quanto ao preenchimento, os pacientes são divididos em duplas para preencherem juntos as respectivas listas. É estimulada a troca de experiências e ajuda recíproca para realizar a tarefa. Terapeuta e coterapeuta circulam nos grupos, esclarecendo dúvidas, que são muito comuns, como, por exemplo, identificar uma obsessão e distingui-la de uma compulsão ou evitação.
- b. *Primeira tarefa de casa.* Completar o preenchimento da lista de sintomas em casa. Como não há tempo suficiente, no grupo apenas inicia-se o preenchimento, que é concluído em casa, e esta é a primeira tarefa de casa. É importante que o indivíduo acrescente na lista sintomas que possam não constar no questionário. Os pacientes têm tendência a identificar os sintomas que mais interferem em sua vida e causam sofrimento, dando pouca importância para os sintomas mais leves, mas estes são fundamentais no início do tratamento e precisam ser identificados e inseridos na lista.
- c. *Preenchimento de listas separadas de sintomas leves, moderados e graves.* Após ter preenchido toda a lista de sintomas, o paciente é orientado a transcrever para listas separadas os sintomas com grau de ansiedade 1 e 2 (leve); para uma segunda lista, os sintomas com grau de ansiedade 3 (moderada); e, por fim, os de grau de ansiedade 4

(grave/muito grave). O preenchimento de todas as listas de sintomas deve ser completado até a terceira sessão. O paciente deve, dentro do possível, solicitar ajuda dos familiares para o preenchimento das listas.

5. PREENCHIMENTO DE ESCALAS OCI-R E Y-BOCS: 10 MINUTOS

Os pacientes devem preencher o Inventário de Obsessões e Compulsões (OCI-R) e a Y-BOCS (inclusos no Manual) após a primeira sessão, com o objetivo de automonitorar a intensidade (e a possível diminuição) de seus sintomas ao longo da terapia. Como essas escalas provavelmente tenham sido preenchidas por ocasião da avaliação, eles já estão familiarizados com seu preenchimento. Entretanto, o terapeuta deve, ainda na sessão, lembrar as escalas, as instruções para seu preenchimento e esclarecer qualquer dúvida. Elas serão preenchidas em casa, como tarefa para a próxima sessão. É importante que o terapeuta, antes de passar para a tarefa seguinte, relembre e sublinhe as tarefas de casa para a próxima sessão.

6. AVALIAÇÃO DA SESSÃO PELOS PACIENTES: 10-15 MINUTOS

A última tarefa da agenda é a avaliação da sessão por parte dos pacientes (e dos familiares). Deve ser solicitada uma rápida opinião sobre o que cada participante achou da sessão ou o que ficou de mais importante, controlando o tempo e fazendo todos participarem e darem sua opinião.

Após a sessão, terapeuta e coterapeuta verificam se os objetivos foram atingidos. Os pacientes:

- Entenderam o que é o TOC e quais são os seus sintomas?
- Entenderam o que são obsessões e quais as mais comuns?
- Entenderam o que são as compulsões e qual sua relação com as obsessões?
- Reconhecem a importância de fazer a lista de sintomas e sentem-se aptos a preenchê-la em casa?
- Estão capacitados a preencher o OCI-R e a Y-BOCS?
- Estão motivados para fazer a terapia e os exercícios de casa e mostram esperança de poder se livrar dos sintomas?

- O *feedback* foi positivo?

O Quadro 6.1 mostra o conteúdo e as intervenções de cada uma das sessões.

A TCCG para o tratamento do TOC utiliza os mesmos fundamentos e as mesmas técnicas usados na terapia individual: as técnicas comportamentais de exposição e prevenção de rituais, consideradas as intervenções críticas, associadas a técnicas cognitivas, que serão brevemente descritas a seguir.

TERAPIA DE EXPOSIÇÃO E PREVENÇÃO DE RESPOSTA OU DE RITUAIS

FUNDAMENTOS DA TCCG

A terapia de EPR tem como meta a eliminação dos sintomas do TOC por meio da mudança de comportamentos. É proposto ao paciente que, de forma gradual, entre em contato direto com os objetos, locais ou situações que evita em razão de medos ou desconfortos que provocam (exposição), bem como deixe de executar os rituais ou outras manobras utilizadas com a finalidade de diminuir ou eliminar o desconforto (prevenção de rituais ou prevenção de resposta). Ao realizar esses exercícios, em um primeiro momento, há aumento instantâneo da ansiedade ou desconforto, mas, a cada nova exposição, a intensidade diminui e, com a repetição dos exercícios, desaparece por completo, em razão do fenômeno natural da habituação. Dessa forma, ocorre a eliminação dos sintomas. De acordo com o modelo comportamental, o alívio obtido com os rituais e as evitações seria o responsável por reforçar a necessidade de executar rituais e os comportamentos evitativos; dessa forma, o TOC se perpetuaria. Os exercícios de EPR têm por finalidade abolir esse reforço, substituir as memórias associadas a medos e desconfortos por outras não associadas a tais emoções desagradáveis. São novas aprendizagens. Exemplos de exercícios de exposição: entrar em casa com sapatos usados na rua, sentar no sofá de casa ou na cama com a mesma roupa que chegou da rua, utilizar banheiro público, desalinhar objetos que estejam arrumados em uma determinada ordem, etc. Exemplos de exercícios de prevenção de rituais: não lavar as mãos após tocar

em objetos considerados “contaminados”, como maçanetas ou dinheiro; não trocar imediatamente as roupas após chegar em casa; não passar álcool ou detergente nas mãos; não verificar se as louças, copos ou talheres do restaurante estão limpos; não alinhar objetos; não tentar afastar pensamentos “ruins”. Um dos segredos da TCC e da TCCG do TOC é uma escolha adequada das tarefas de casa.

A seguir, são feitas algumas orientações para que a escolha das primeiras tarefas seja bem-sucedida e o paciente tenha boas chances de realizá-las:

- a. *Começar pelos exercícios que envolvem os sintomas mais leves (gravidade 1 e 2 da lista de sintomas):* Deve-se iniciar os exercícios pelos sintomas de grau de ansiedade leve. Por meio da realização com sucesso dos primeiros exercícios de EPR, é possível começar a acreditar na própria capacidade de vencer o transtorno (autoeficácia) e na eficácia da terapia, o que contribui para o paciente ter coragem de enfrentar as tarefas mais difíceis.
- b. *Começar pelos rituais e pelas evitações:* Os rituais ou compulsões e as evitações são comportamentos voluntários e fáceis de identificar, porque em geral são visíveis, diferentemente das obsessões, que são pensamentos invasivos involuntários, nem sempre fáceis de reconhecer e visualizar. Os exercícios da TCC começam pelo enfrentamento desses dois tipos de sintomas. O primeiro passo, portanto, consiste em localizar, na lista de grau de ansiedade 1 e 2 (sintomas leves), compulsões e comportamentos evitativos e, então, planejar as devidas exposições e prevenção de rituais.
- c. *Seguir a regra dos 80%:* Incluir na lista dos exercícios de EPR aqueles que o paciente acredita ter pelo menos 80% de chances de realizar, conforme recomenda o Dr. Lee Baer, um dos primeiros a escrever um manual para a terapia de EPR para o TOC. Caso esse percentual esteja abaixo de 80%, deve-se alterar as condições de realização do exercício (número de vezes, tempo de exposição) ou dividi-las em etapas, para aumentar o percentual de chances.

MODELAÇÃO

A modelação é utilizada na terceira sessão do grupo, após a descrição da terapia de EPR. O terapeuta faz demonstrações de exercícios práticos de EPR perante o grupo, como, por exemplo, toca na sola do sapato, passa a “contaminação” para suas roupas, seu rosto, boca, toca em cédulas de dinheiro amarrotadas e não lava as mãos depois, etc. Ao longo da sessão, é estimulado que todos os participantes realizem as exposições junto com o terapeuta.

TÉCNICAS COGNITIVAS

A TCC do TOC parte do princípio de que na origem e, sobretudo, na manutenção dos sintomas OCs existem, além do reforço representado pelos rituais e pelas evitações, pensamentos distorcidos, ou seja, interpretações distorcidas ou erradas, negativas ou catastróficas das situações que as pessoas enfrentam em seu dia a dia. Tais interpretações são acompanhadas de sentimentos desagradáveis, como angústia, medo e culpa, dos quais a pessoa sente necessidade de se livrar, executando compulsões ou, então, evitando os objetos, lugares ou situações que as provocam. As compulsões e os comportamentos evitativos, em um primeiro momento, como já abordado, provocam alívio, mas acabam sendo responsáveis pelo reforço e pela manutenção dos sintomas e do TOC. As técnicas cognitivas têm por objetivo a correção dessas avaliações e interpretações distorcidas, negativas ou catastróficas, bem como das crenças erradas subjacentes aos sintomas do TOC. São crenças erradas típicas do TOC: exagerar o risco e a responsabilidade, acreditar no poder do pensamento (pensamento mágico/fusão do pensamento e ação), apresentar intolerância à incerteza e ser perfeccionista. Acredita-se que a correção dessas crenças possa contribuir para diminuir a ansiedade e auxiliar na adesão aos exercícios de EPR, principalmente quando predominam obsessões. O paciente é estimulado a lidar com seus pensamentos intrusivos como se fossem hipóteses, examinando-os quanto a sua veracidade e procurando alternativas mais efetivas para lidar com as adversidades. A seguir, são descritas algumas técnicas cognitivas utilizadas no protocolo de TCCG do TOC.

IDENTIFICAÇÃO DE PENSAMENTOS AUTOMÁTICOS E CRENÇAS DISFUNCIONAIS

A identificação de pensamentos automáticos catastróficos ou negativos que acompanham as obsessões e as compulsões auxilia os pacientes a se darem conta das crenças disfuncionais associadas aos sintomas. No protocolo de TCCG, na quarta sessão, depois da exposição psicoeducativa sobre pensamentos automáticos e crenças disfuncionais, e especialmente a partir da quinta sessão, os pacientes são orientados a preencher o registro de pensamentos disfuncionais tanto nas sessões como em tarefas de casa, para auxiliá-los a identificar tanto os pensamentos automáticos negativos ou catastróficos como as crenças disfuncionais que estão por trás dos rituais e das evitações. Uma vez que o indivíduo consiga identificar suas crenças disfuncionais, poderá ser introduzido nos exercícios cognitivos. O primeiro deles é o exame de evidências, ou questionamento socrático.

QUESTIONAMENTO SOCRÁTICO

Com base no RPD, o paciente é desafiado a questionar seus pensamentos automáticos catastróficos e crenças disfuncionais, apontando tanto as evidências a favor como aquelas contrárias ao seu pensamento. Por exemplo: “Quais são as evidências a favor de que se pode contrair HIV usando um banheiro público?”, “Quais são as evidências contrárias?”. Ou então: “Posso trazer doenças para dentro de casa se não trocar de roupas imediatamente após ter ido a um enterro?”; “Quais são as evidências a favor desse pensamento, e quais são contrárias?”, “O que é mais provável que aconteça se não trocar de roupa?”.

TÉCNICA DAS DUAS ALTERNATIVAS

É uma técnica utilizada para o paciente construir e testar uma explicação alternativa para as obsessões, que seja menos aflitiva com base em seu próprio raciocínio lógico. Tem o objetivo de corrigir as crenças erradas, separando com mais clareza e de forma simples e imediata o que são comportamentos “normais”, adaptativos, saudáveis, excessivos ou desadaptativos, melhorando, assim, o *insight* sobre os sintomas. O exercício

pode ser feito conforme o exemplo a seguir, proposto por Salkovskis (1999, tradução nossa):

Temos duas teorias (ou hipóteses) alternativas para os seus medos, e você deve concluir qual delas lhe parece mais provável.

Teoria A: você está, de fato, contaminado e pode ficar doente ou prejudicar seus familiares caso não lave suas mãos, e pelo resto da vida deverá seguir fazendo as lavagens que realiza.

Teoria B: você é uma pessoa sensível ao medo de ser contaminado devido ao TOC e reage a esse medo de uma forma que compromete sua vida: fazendo lavagens repetitivas, excessivas e desnecessárias.

Qual dessas duas alternativas lhe parece mais provável? Você já tentou lidar com esse problema de acordo com a segunda hipótese, ou seja, como se fosse um problema de preocupação ou medo excessivo ou um sintoma do TOC, e não uma possibilidade real?

TÉCNICA DA TORTA OU PIZZA DA RESPONSABILIDADE

Essa técnica pode ser útil para corrigir crenças distorcidas relacionadas ao excesso de responsabilidade, um problema muito comum no TOC. Cada fatia da torta ou pizza representa o percentual de responsabilidade atribuído a si próprio e a outros fatores (Salkovskis, 1999; Van Oppen & Arntz, 1994). As fatias correspondem ao peso relativo que diferentes fatores podem ter (ou tiveram) para que um fato ruim tenha acontecido. O exercício pode auxiliar o paciente a avaliar de forma mais realista a questão da responsabilidade, além de ajudá-lo a se dar conta de que existem muitos outros fatores que contribuem para que algo aconteça e que não estão sob seu controle. É bom lembrar, ainda, que nem todos os fatores que concorrem para um desfecho têm o mesmo peso que outros; alguns são determinantes, enquanto outros proporcionam contribuição mínima ou podem até não ter peso algum.

Depois de explicar como é o exercício, solicita-se que o paciente faça uma lista dos fatores que podem concorrer direta ou indiretamente para a ocorrência de um evento negativo. Em seguida, solicita-se que atribua

percentuais equivalentes aos pesos que, em seu entendimento, esses diferentes fatores poderiam ter tido para contribuir para o evento, incluindo na lista, por último, o seu percentual de responsabilidade. Ao fim do exercício, os pacientes se dão conta de que os 100% de responsabilidade atribuídos, antes do exercício, a si próprios passam a ser distribuídos com outros fatores, possivelmente mais determinantes, enfraquecendo a crença de excesso de responsabilidade.

SETA DESCENDENTE

Inicia-se esse exercício com a identificação de um pensamento catastrófico relacionado a um sintoma do TOC, associando a possibilidade de ocorrer uma falha ou um desastre (acidente de carro, incêndio, inundação, morte, doença), e, em seguida, com o relato das consequências imaginadas, conectadas por setas. O exercício consiste em examinar as consequências catastróficas imaginadas, no curto e longo prazos, seguidas do questionamento dos pensamentos automáticos catastróficos (descatastrofização). Para isso, perguntas como “Se isso acontecer, o que poderá acontecer em seguida?”, “E daí?” ou “O que de pior pode acontecer?” ajudam na identificação dos pensamentos e das crenças de conteúdo catastrófico. Uma vez explicitadas as consequências catastróficas imaginadas, pode-se perguntar para cada uma delas: “O que é mais provável que aconteça?”. Essa técnica é também conhecida como a técnica do “Se... Então”.

EXPERIMENTOS OU TESTES COMPORTAMENTAIS

É um exercício efetivo para corrigir avaliações erradas, crenças disfuncionais ou pensamentos obsessivos catastróficos, especialmente os de conteúdo mágico ou supersticioso, testando-os na prática. O paciente deve se expor a algo que evita ou teme, como, por exemplo, deixar a torneira pingando por algumas horas e depois verificar se o banheiro inundou, passar diante de uma funerária ou de um cemitério e ver se alguma pessoa da família veio a falecer, etc. Depois do experimento, paciente e terapeuta farão uma comparação entre o que o indivíduo imaginou que fosse acontecer e o que de fato ocorreu.

Outro exemplo: quebrar a regra de fazer um ritual um determinado número de vezes (números de sorte/azar: deixar o volume da televisão ou do rádio do carro em um número considerado de azar) e observar se acontece alguma desgraça.

RESULTADOS

Nosso grupo de pesquisa desenvolveu e testou o protocolo de TCCG em vários estudos publicados ao longo desses 17 anos. O primeiro trabalho publicado foi um ensaio clínico aberto que teve como objetivo principal desenvolver e testar o protocolo de TCCG para o TOC e verificar a adesão dos pacientes. Esse primeiro estudo mostrou um resultado promissor para a TCCG, ou seja, 78,1% dos pacientes responderam à terapia (redução > 35% nos escores da Y-BOCS), e apenas dois indivíduos (6,25%) abandonaram o tratamento (Cordioli et al., 2002). O segundo estudo publicado foi um ensaio clínico randomizado que teve como objetivo principal verificar a eficácia da TCCG em reduzir os sintomas do TOC, em reduzir a intensidade das ideias supervalorizadas e em melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Os resultados mostraram que 69,6% dos pacientes que participaram do grupo responderam à TCCG. Além disso, houve redução na intensidade das ideias supervalorizadas, bem como melhor qualidade de vida pós o tratamento; 73,9% dos pacientes continuavam melhores três meses depois do término da TCCG, mostrando que a redução dos sintomas, além de ser mantida, se acentuou ainda mais no período (Cordioli et al., 2003).

Outros trabalhos foram desenvolvidos com o objetivo de verificar a manutenção dos ganhos no longo prazo. Foi verificado que os resultados foram mantidos 1, 2 e 5 anos depois das 12 sessões de TCCG. Outro achado interessante foi o de que os pacientes que atingiram remissão completa dos sintomas não recaíram ao longo do tempo (Borges et al., 2011; Braga, Cordioli, Niederauer, & Manfro, 2005; Braga et al., 2010).

Com o objetivo de identificar fatores preditores de resposta a TCCG, Raffin e colaboradores (2009) avaliaram 181 pacientes tratados com TCCG e verificaram que aqueles que tinham melhor capacidade de *insight* respondiam

melhor à abordagem. A gravidade dos sintomas e o número de comorbidades existentes antes do tratamento, como fobia social e distímia, foram associados a pior resposta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A terapia em grupo para o TOC é tão eficaz quanto a terapia individual, porém seu custo financeiro é bem menor, e a oferta de tratamento para a comunidade, maior. Esse fato é de suma importância, tendo em vista que o número de profissionais da saúde mental com formação em TCC e com experiência em TCC para o TOC ainda é relativamente pequeno, e muitas pessoas que sofrem com a doença não têm condições financeiras de arcar com os custos de uma terapia individual.

O TOC, de modo geral, é um problema que acompanha a pessoa durante anos até que busque tratamento. É comum que, antes de procurar o grupo, já tenha participado de outros tratamentos sem sucesso e, por esse motivo, tenha perdido a esperança de um dia viver sem seus sintomas.

Uma das experiências mais emocionantes proporcionadas pelo grupo é a de conhecer outras pessoas com TOC e sintomas semelhantes aos seus, saber que não é a única pessoa no mundo com tais problemas, se sentir aceito e acolhido. Isso proporciona um sentimento muito agradável, como comentava um paciente do grupo: “Dá um alívio saber que tem outras pessoas como eu! Eu achava que era louco, me sentia estranho, esquisito e sozinho”.

Além disso, a convivência possibilita o treinamento de habilidades sociais básicas, muitas vezes prejudicadas por anos de isolamento e de doença. No grupo, os pacientes são incentivados a trocar telefones e a ir às casas uns dos outros para auxiliar na realização das tarefas propostas nas sessões da terapia.

O grupo estimula nas pessoas o desejo de ajudar aos demais. Muitas vezes, a sugestão oferecida de um colega para outro ajuda ambos: a pessoa que recebe se beneficia obtendo uma informação relevante para se livrar do TOC enfrentando seus medos, e quem oferece também se beneficia, por estar ajudando e se sentindo útil.

Por fim, é claro que o grupo apresenta limitações. A principal delas acontece quando o paciente tem assuntos mais emergentes a serem tratados do que o TOC, como no caso de separação, luto, problemas de relacionamento, dificuldades conjugais, problemas profissionais ou comorbidades psiquiátricas tão ou mais graves do que o TOC. Nessas situações, é recomendado acompanhamento individual. A TCCG oferece para o paciente a possibilidade de conseguir reduzir os sintomas OCs e, em alguns casos, até mesmo eliminá-los por completo. Quanto maior for a redução dos sintomas, menores são os riscos de recaídas.

No entanto, muitas vezes, a remissão completa não é atingida no término de 12 semanas da TCCG. Nesses casos, o paciente é estimulado a continuar, de alguma forma, o tratamento. Com frequência, o grupo representa para o paciente e seus familiares uma primeira batalha e treinamento no uso de estratégias contra o TOC, de onde o paciente sairá munido de experiências e ferramentas para lidar melhor com os próximos desafios.

A TCCG do TOC é um tratamento de referência, e sua eficácia/efetividade está exaustivamente comprovada. O protocolo aqui apresentado vem sendo utilizado com sucesso há quase duas décadas. Contudo, ainda são poucos os centros que disponibilizam tratamento em grupo para a comunidade. Espera-se que, com o tempo, mais profissionais sejam treinados e capacitados para atender a demanda de indivíduos com TOC que queiram se tratar por um custo acessível ou nenhum custo, se o tratamento for oferecido por uma instituição pública.

REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association (APA). (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5* (5. ed.). Porto Alegre: Artmed.

Anderson, R. A., & Rees, C. S. (2007). Group versus individual cognitive-behavioural treatment for obsessive-compulsive disorder: a controlled trial. *Behaviour Research and Therapy*, 45(1), 123-137.

Borges, C. P., Meyer, E., Ferrão, Y. A., Souza, F. P., Sousa, M. B., & Cordioli, A. V. (2011). Cognitive-behavioral group therapy *versus* sertraline for obsessive-compulsive disorder: Five-year follow-up. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 80(4), 249-250.

Braga, D. T., Cordioli, A. V., Niederauer, K., & Manfro, G. G. (2005). Cognitive-behavioral group therapy for obsessive-compulsive disorder: A 1-year follow-up. *Acta Psychiatrica Scandinavica*,

112(3), 180-186.

Braga, D. T., Manfro, G. G., Niederauer, K., & Cordioli, A. V. (2010). Full remission and relapse of obsessive-compulsive symptoms after cognitive-behavioral group therapy: A two-year follow-up. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 32(2), 164-168.

Cordioli, A. V. (2016). *TOC: Transtorno obsessivo compulsivo*. Recuperado de <http://www.ufrgs.br/toc/>

Cordioli, A. V., Heldt, E., Bochi, D. B., Margis, R., de Sousa, M. B., Tonello, J. F., . . . Kapczinski, F. (2002). Cognitive-behavioral group therapy in obsessive-compulsive disorder: An open clinical trial. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 24(3), 113-120.

Cordioli, A. V., Heldt, E., Bochi, D. B., Margis, R., Sousa, M. B., Tonello, J. F., . . . Kapczinski, F. (2003). Cognitive-behavioral group therapy in obsessive-compulsive disorder: A randomized clinical trial. *Psychotherapy and Psychosomatics*, 72(4), 211-216.

Goodman, W. K., Price, L. H., Rasmussen, S. A., Mazure, C., Delgado, P., Heninger, G. R., & Charney, D. S. (1989). The Yale-Brown Obsessive Compulsive Scale: II. Validity. *Archives of General Psychiatry*, 46(11), 1012-1016.

Håland, A. T., Vogel, P. A., Lie, B., Launes, G., Pripp, A. H., & Himle, J. A. (2010). Behavioural group therapy for obsessive-compulsive disorder in Norway. An open community-based trial. *Behaviour Research and Therapy*, 48(6), 547-554.

Hollander, E., Simeon, D. (2012). Transtornos de ansiedade. In R. E. Hales, S. C. Yudofsky, & G. O. Gabbard (Eds.), *Tratado de psiquiatria clínica* (5. ed., pp. 531-638) Porto Alegre: Artmed.

Jaurrieta, N., Jiménez-Murcia, S., Alonso, P., Granero, R., Segalàs, C., Labad, J., & Menchón, J. M. (2008). Individual versus group cognitive behavioral treatment for obsessive-compulsive disorder: Follow up. *Psychiatry and Clinical Neurosciences*, 62(6), 697-704.

Jónsson, H., & Hougaard, E. (2009). Group cognitive behavioural therapy for obsessive-compulsive disorder: A systematic review and meta-analysis. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 119(2), 98-106.

Jónsson, H., Hougaard, E., & Bennedsen, B. E. (2011). Randomized comparative study of group versus individual cognitive behavioural therapy for obsessive compulsive disorder. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 123(5), 387-397.

Koran, L. M., & Simpson, H. B. (2013). *Guideline Watch (March 2013): Practice guideline for the treatment of patients with obsessive-compulsive disorder*. Arlington: American Psychiatric Association.

O'Connor, K., Freeston, M. H., Gareau, D., Careau, Y., Dufour, M. J., Aardema, F., & Todorov, C. (2005). Group versus Individual Treatment in Obsessions without Compulsions. *Clinical Psychology Psychotherapy*, 12(2), 87-96.

Raffin, A. L., Fachel, J. M. G., Ferrão, Y. A., Souza, F. P., & Cordioli, A. V. (2009). Predictors of response to group cognitive-behavioral therapy in the treatment of obsessive-compulsive disorder. *European Psychiatry*, 24(5), 297-306.

Salkovskis, P. (1999). Understanding and treating obsessive-compulsive disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 37(Suppl. 1), S29-S52.

Schwartz, D., Barkowski, S., Burlingame, G. M., Strauss, B., & Rosendahl, J. (2016). Efficacy of group psychotherapy for obsessive-compulsive disorder: A meta-analysis of randomized controlled

trials. *Journal Obsessive-Compulsive and Related Disorders*, 10, 49-61.

Sousa, M. B., Isolan, L. R., Oliveira, R. R., Manfro, G. G., & Cordioli, A. V. (2006). A randomized clinical trial on cognitive-behavioral group therapy and sertraline in the treatment of obsessive-compulsive disorder. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 67(7), 1133-1139.

Van Oppen, P., & Arntz, A. (1994). Cognitive therapy for obsessive-compulsive disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 32(1), 79-87.

Wheaton, M. G., Galfalvy, H., Steinman, S. A., Wall, M. M., Foa, E. B., & Simpson, H. B. (2016). Patient adherence and treatment outcome with exposure and response prevention for OCD: Which components of adherence matter and who becomes well? *Behaviour Research and Therapy*, 85, 6-12.

[NT] O manual completo da terapia pode ser acessado no link: http://www.ufrgs.br/toc/images/pesq_e_public/publicacoes/Manual%20da%20Terapia%20Cognitivo-Comportamental%20em%20Grupo%20no%20TOC%202008.pdf

[NT] Para mais informações, acesse: www.ufrgs.br/toc.

7



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA PACIENTES COM ESQUIZOFRENIA

Ricardo Franzin

Salmo Zugman

Ana Irene F. Mendes

Robson Miranda Costa Gomes

Carmem Beatriz Neufeld

A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico grave, neuroprogressivo, com prevalência de 1% na população mundial (Jablensky, 1997), sendo ligeiramente mais frequente em indivíduos do sexo masculino (1,4:1) (McGrath, Saha, Chant, & Welham, 2008). A esquizofrenia é a doença mental que mais gera incapacidade crônica e comprometimento de anos de vida saudável (Rösler, Salize, van Os, & Riecher-Rössler, 2005), além de ser observado o envelhecimento físico acelerado e maior coexistência de

comorbidades clínicas e psiquiátricas, responsáveis pela diminuição da expectativa de vida com aumento da mortalidade (Jeste, Wolkowitz, & Palmer, 2011). Entre as comorbidades psiquiátricas mais prevalentes, observa-se a depressão (50% dos casos), o transtorno de pânico (20% dos casos), a fobia social (18%), o transtorno obsessivo-compulsivo (23%), o transtorno de estresse pós-traumático (29%) e o abuso de substâncias (47%) (Buckley, Miller, Leher, & Castle, 2009).

A esquizofrenia é composta por sintomas positivos (psicóticos), negativos, afetivos e cognitivos (Dalgarrondo, 2008), com seu início ocorrendo, geralmente, ao fim da adolescência. O surgimento dos sintomas pode variar de uma disfunção social e cognitiva, instalando-se gradualmente antes dos sintomas psicóticos, até um início abrupto dos sintomas positivos, conhecido como surto psicótico, que pode surgir após trauma, estresse ou uso de drogas (Tandon, Nasrallah, & Keshavan, 2009).

Concebia-se a esquizofrenia como uma doença neuroprogressiva e estritamente neurodegenerativa (Elkis, Kayo, Louzã Neto, & Curátolo, 2012), mas atualmente entende-se que alterações, ocorridas durante o neurodesenvolvimento, estão presentes antes do início dos sintomas psicóticos (Insel, 2010), levando a cogitar a possibilidade de que a psicose surge de um cérebro vulnerável e não completamente saudável (Meyer-Lindenberg, 2010). Dessa forma, atualmente postula-se que há a coexistência de dois processos fisiopatológicos (Jarkosg & Gilmore, 2006), o neurodegenerativo, que se instala mais tardiamente na evolução da doença, e o neurodesenvolvimental, que precede a neurodegeneração, pois os fatores previamente existentes ou adquiridos de forma precoce na infância interagem com fatores desencadeantes, modificando os neurocircuitos e determinando o surgimento dos sintomas psicóticos (Tandon et al., 2009).

Apesar de serem observadas alterações morfofuncionais em estudos de neuroimagem, não existe um achado radiológico patognomônico, sendo o diagnóstico da esquizofrenia realizado a partir da avaliação clínica. Para isso, são utilizados os critérios diagnósticos da quinta edição do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5), da Associação Americana de Psiquiatria (APA, 2014).

O tratamento adequado da esquizofrenia consiste na associação da psicofarmacoterapia, que continua sendo a primeira opção, com intervenções psicossociais, como técnicas que favorecem a adesão terapêutica, e, principalmente, a psicoterapia, com o objetivo de minimizar os sintomas e as limitações funcionais decorrentes da cronificação da doença, evitando hospitalizações e permitindo uma melhor qualidade de vida ao paciente (Buchanan et al., 2010). O tratamento combinado busca o adequado manejo clínico nas diversas fases da doença (fase aguda, fase de estabilização e fase de manutenção) (Shirakawa, 2000).

Entre as abordagens de psicoterapia já utilizadas para o tratamento da esquizofrenia, a terapia cognitivo-comportamental (TCC) vem sendo considerada um tratamento eficaz (Turner, Gaag, Karyotaki, & Cuijpers, 2014). Segundo Barreto (2015), os objetivos gerais da TCC para pacientes com esse tipo de transtorno são: (1) psicoeducar os pacientes sobre o transtorno, possibilitando-lhes autogerir os sintomas e prevenir recaídas, (2) abordar crenças disfuncionais (delirantes ou não) e (3) minimizar a angústia gerada pelos sintomas psicóticos na vida do paciente. Para cumprir os objetivos terapêuticos, é imprescindível que o paciente não se sinta julgado ou discriminado devido às suas avaliações e interpretações patológicas, por mais afastadas que sejam do pensamento comum (Turkington, Kingdon, & Weiden, 2006).

INTERVENÇÃO EM GRUPOS PARA A ESQUIZOFRENIA

A própria história da psicoterapia de grupos remonta à condução de grupos com pessoas com esquizofrenia (Neufeld, 2011). Na primeira década dos anos de 1900, Lazell (1921) já conduzia terapia de grupos com esses pacientes. Depois dele, Marsh (1931) destinou suas intervenções a grandes grupos de indivíduos psicóticos. Esses pioneiros das intervenções psicoterápicas em grupos, com enfoque psicodinâmico, conduziram grupos em hospitais psiquiátricos visando intervir em sintomas psicóticos e aumento da qualidade de vida dos pacientes no início dos anos de 1900.

A partir da década de 1960, disseminou-se o emprego de grupos operativos, com base nas obras de Melanie Klein e Bion, e de grupos utilizando o sistema de economia de fichas, com base no modelo comportamental operante em clínicas de internamento estruturadas em modelos de comunidade terapêutica. Entretanto, de forma similar ao que ocorreu no atendimento individual, as teorias psicodinâmica e comportamental clássicas não possibilitavam intervenções mais efetivas para esse público. A revolução cognitiva e o desenvolvimento atual das psicoterapias conhecidas como de terceira onda superaram esse impasse com relação às intervenções individuais, mas não com relação ao atendimento de grupos para os transtornos psicóticos (Tai & Turkington, 2009).

A eficácia da TCC individual para a esquizofrenia e a expectativa de que a TCC de grupo (TCCG) pudesse ser igualmente aplicada e eficaz a esses pacientes (Segredou et al., 2012) motivaram o desenvolvimento de intervenções de grupo de psicoeducação para pacientes e familiares (Lincoln, Wilhelm, & Nestoriuc, 2007), atendimento de grupos para população necessariamente não clínica com alucinações auditivas crônicas (Ruddle, Mason, & Wykes, 2011), reeducação metacognitiva do erro de processamento, conhecido como “salto para conclusão” (Aghotor, Pfueller, Moritz, Weisbrod, & Roesch-Ely, 2010), e treinamento de habilidades sociais (Marde et al, 1996). Recentemente, Cella, Reeder e Wykes (2016) avaliaram 25 pacientes, igualmente divididos em dois grupos, que receberam TCCG e TCC individualmente. Os participantes da TCCG avaliaram essa abordagem de forma positiva, e os terapeutas classificaram esse formato como útil e viável, correspondendo às suas expectativas profissionais. A análise exploratória sugeriu que os dois métodos têm efeitos semelhantes sobre a melhora da cognição e da memória, bem como sobre a redução dos sintomas negativos.

No Brasil, a maior parte dos pacientes com esquizofrenia não recebe tratamento regular, e a minoria que realiza tratamento adequado o faz em *settings* do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) o ambiente terapêutico ambulatorial mais frequentado (Leitão, Ferraz, Chaves, & Mari, 2006). Nesse ambiente, devido à grande

demanda de pacientes e ao escasso número de terapeutas que se sentem seguros para sua aplicação em indivíduos com esquizofrenia (Tarrier, Haddock, & McGovern, 1999), a utilização de técnicas terapêuticas grupais que otimizem e promovam o tratamento clínico adequado é escassa, porém imprescindível.

Em muitos países, como a Inglaterra, apesar de a TCC para esquizofrenia ser recomendada, por ser uma intervenção baseada em evidências, sua aplicabilidade é restrita, devido a um número reduzido de profissionais capacitados nessa modalidade de intervenção (Shafran et al., 2009). Em um estudo realizado na Noruega, que envolveu 426 grupos de psicoterapia de várias abordagens, constatou-se que a maioria dos terapeutas era composta de enfermeiros e que apenas 50% eram treinados em terapia de grupo, observando-se a necessidade de aperfeiçoamento dos profissionais para realizarem essa modalidade terapêutica (Lorentzen & Ruud, 2014). Este parece ser ainda um desafio a ser vencido pelas intervenções em grupo – maior investimento em capacitação de profissionais.

De acordo com Harper, Meyer, Johnson e Penn (2014), a aliança terapêutica é um fator determinante para o sucesso na TCCG para esquizofrenia. Observa-se que, mais do que a aplicação correta das técnicas, algumas características relacionadas aos terapeutas e aos próprios pacientes podem interferir na adesão terapêutica (Quadro 7.1).

Quadro 7.1 Fatores que interferem na adesão terapêutica na TCCG para esquizofrenia		
	Adequada adesão terapêutica	Baixa adesão terapêutica
Terapeuta	Comportamento empático	Comportamento pouco empático e desatento
Paciente	- Predomínio de sintomas positivos - Maior nível de escolaridade - Adequado <i>insight</i> sobre necessidade de tratamento	- Predomínio de sintomas negativos - Baixo nível de escolaridade - Falta de <i>insight</i> sobre necessidade de tratamento
Fonte: Adaptado de Fanning e colaboradores (2012) e Harper e colaboradores (2014).		

Sabe-se que a TCCG pode promover ao paciente com esquizofrenia melhora dos sintomas depressivos, aumento da autoestima e maior

conhecimento do próprio transtorno, proporcionando maior habilidade de manejar os sintomas (Gledhill, Lobban, & Sellwood, 1998). Além dos sintomas gerais, a TCCG mostra-se uma abordagem eficaz e viável para ser utilizada no primeiro episódio psicótico, combinando técnicas de regulação emocional e estratégias das chamadas terapias de terceira onda, como compaixão, aceitação e atenção plena, com melhora na regulação emocional, diminuição dos sintomas (especialmente ansiedade, depressão e preocupações somáticas) e aumento do autocuidado (Khoury, Lecomte, Comtois, & Nicole, 2015).

Entre os sintomas psicóticos mais abordados, as alucinações auditivas são as mais estudadas, seja no primeiro episódio psicótico, seja em pacientes em tratamento ambulatorial ou tratamento hospitalar. Os indivíduos submetidos a TCCG apresentam redução da frequência e intensidade das alucinações, bem como maior controle sobre elas, diminuindo a angústia ocasionada pelos sintomas psicóticos (Pearlman & Hubbar, 2000; Pinkham, Gloege, Flanagan, & Penn, 2004). Em um ensaio clínico, pacientes que participaram de grupos de TCCG apresentaram redução significativa na gravidade e frequência de delírios, angústia, alucinações auditivas, sintomas negativos e ansiedade após o tratamento, sendo essa melhora observada e mantida após um ano de seguimento clínico, enquanto, no grupo-controle, não houve diferença sintomatológica do pré-tratamento para o pós-tratamento (Mortan, Tekinsav, & German, 2011).

Em um recente ensaio clínico randomizado e controlado (Chadwick et al., 2016), 108 pessoas aflitas por apresentarem alucinações auditivas foram igualmente distribuídas para receber TCCG associada ao tratamento habitual ou apenas para receber tratamento habitual, o qual consistia em 2 ou 3 consultas mensais com psiquiatra e uso de medicação antipsicótica. Os participantes do grupo de TCCG associada ao tratamento habitual relataram melhora significativa de depressão após 12 sessões, sendo esse efeito mantido após seis meses de seguimento, o que sugere atenuação no impacto da experiência auditiva de voz, mudança de comportamento significativa ante as alucinações e efeitos duradouros sobre o humor. Além dos principais sintomas clínicos, 104 pacientes que participaram de um ensaio clínico (Tan

et al., 2016) foram, aleatoriamente, designados para 40 sessões de TCCG ou grupo-controle e os do grupo de intervenção apresentaram melhora significativa das habilidades sociais e das funções cognitivas, especialmente a flexibilidade cognitiva e a memória.

Como descrito anteriormente, um dos objetivos da psicoterapia é evitar hospitalizações decorrentes do surgimento de sintomas psicóticos. Veltro e colaboradores (2008) encontraram diferenças significativas do uso da TCCG quando empregada desde o início do internamento. Segundo esse estudo, a TCCG pode diminuir a taxa de readmissões hospitalares de 38 para 24% ($p < 0,02$), havendo também significativa satisfação do paciente com o tratamento durante os primeiros dois anos de intervenção ($p < 0,001$), na atmosfera da ala psiquiátrica observada no serviço onde a TCCG foi implantada desde o início do internamento até os quatro anos seguintes ($p < 0,001$).

Alguns protocolos, com o objetivo de verificar a efetividade da TCCG para tratar pacientes com esquizofrenia, foram propostos e testados em diversos estudos científicos. Seus principais temas e desfechos estão apresentados na Tabela 7.1.

Tabela 7.1 Protocolos de TCCG para esquizofrenia						
Autores/ Ano	Wykes, Parr e Landau (1999)	Wykes e colaboradores (2005)	Barrowclough e colaboradores (2006)	Roberts, Pinkham e Penn (2008)	Penn e colaboradores (2009)	Owen, Sellwood, Kan, Murray e Sarsam (2015)
Objetivo	Avaliar a efetividade da TCCG em pacientes resistentes ao tratamento farmacológico	Comparar efetividade da TCCG <i>versus</i> tratamento combinado (TCCG + psicofármacos)	Comparar efetividade da TCCG <i>versus</i> tratamento combinado (TCCG + psicofármacos)	Avaliar a efetividade da TCCG e atender às necessidades dos pacientes hospitalizados	Avaliar a efetividade da TCCG	Efetividade da TCG para pacientes psicóticos agudos, com delírios e alucinações
Estrutura	6 sessões	7 sessões	18 sessões (2 horas)	12 sessões	12 sessões	4 sessões
Temas	Desenvolver estratégias de autocontrole e de enfrentamento	Engajamento, psicoeducação sobre as vozes e o modelo cognitivo, reestruturação cognitiva das crenças delirantes e desenvolvimento de estratégias de	Psicoeducação sobre as psicoses, conceitualização cognitiva, exercícios de monitoramento e testagem de validade dos pensamentos, exercícios comportamentais, elaboração de planos de contingências para eventuais situações de	Psicoeducação sobre alucinações auditivas, discussão sobre o modelo ABC com relação às alucinações, treinamento das técnicas de manejo, desenvolvimento de estratégias para reduzir a intensidade e a frequência das	Psicoeducação sobre as vozes, análise comportamental e treino de estratégias de modulação das alucinações auditivas, desenvolvimento de estratégias de enfrentamento	Psicoeducação, normalização dos sintomas, aplicação do modelo cognitivo, avaliação de comportamentos e estratégias de enfrentamento com apresentação de técnicas de

	enfrentamento	dificuldades	alucinações			<i>mindfulness</i> e relaxamento, discussão do modelo de vulnerabilidade e suscetibilidade ao estresse
Desfecho	Melhora na percepção e na angústia gerada pelas alucinações. Aumento do número e da eficácia das estratégias de enfrentamento.	Melhora significativa do funcionamento, entretanto não houve diminuição da gravidade das alucinações.	Não houve diferença estatística no que se refere à diminuição dos sintomas positivos e nas taxas de recaída. Melhora da desesperança e da autoestima nos pacientes submetidos à TCCG.	Redução da frequência e da intensidade das alucinações auditivas em pacientes hospitalizados.	Melhora significativa de sintomas psicóticos em geral, níveis de depressão, funcionamento social e taxas de recaída.	Redução significativa do sofrimento emocional e melhora da autoconfiança.

Como exposto, apesar de ser uma abordagem relativamente nova entre as psicoterapias, a TCCG para a esquizofrenia apresenta evidência científica documentada, constituindo-se uma opção terapêutica segura e eficaz. Para ilustrar a utilização da técnica, serão apresentados dois exemplos de intervenção em grupo para esse público, um terapêutico e outro com foco em treinamento de habilidades.

TCCG PARA SINTOMAS PSICÓTICOS

A seguir, apresentamos uma intervenção de grupo, realizada no Centro Psiquiátrico Metropolitano (CPM) de Curitiba, sob responsabilidade do segundo autor deste capítulo. O tratamento psicoterapêutico teve como objetivo diminuir o sofrimento e as limitações sociais de pacientes que apresentaram resposta parcial à farmacoterapia, sendo mantido, contudo, o uso de antipsicótico de longa ação, administrado de modo injetável, por garantir adequada adesão terapêutica ao tratamento farmacológico (Silva, Lovisi, Verdolin, & Cavalcanti, 2012). O protocolo de intervenção foi elaborado a partir do proposto por Roberts e colaboradores (2008) para os sintomas positivos da esquizofrenia, sobretudo alucinações auditivas, incluindo, ainda, outros aspectos julgados importantes, como, por exemplo, delírios, para a intervenção nesse tipo de pacientes, com base na experiência clínica dos terapeutas. O protocolo consistiu em 12 sessões, e sua estrutura geral pode ser observada Tabela 7.2.

Tabela 7.2 Protocolo de TCCG para delírios e alucinações

Número da sessão	Conteúdo
Sessão 1	Contrato inicial Apresentação geral do grupo/identidade e regras de funcionamento
Sessões 2 e 3	Psicoeducação sobre delírios e alucinações Normalização dos sintomas
Sessões 4 e 5	Compartilhamento de experiências pessoais Descrição do conteúdo das vozes, delírios e interferências na rotina diária Exercícios de monitoramento durante a sessão e como tarefa de casa
Sessões 6 e 7	Socialização no modelo cognitivo Utilização do modelo ABC
Sessões 8 e 9	Identificação de fatores moduladores Desenvolvimento de estratégias de enfrentamento
Sessões 10 e 11	Exercícios comportamentais de teste de realidade e de enfrentamento Geração de explicações alternativas para as experiências dos pacientes
Sessão 12	Encerramento: avaliação e encaminhamentos

Fonte: Adaptada de Roberts e colaboradores (2008).

A TRIAGEM

De modo geral, a esquizofrenia, bem como os transtornos psicóticos, apresentam um quadro clínico bastante heterogêneo (Buchanan & Carpenter, 1994), dificultando a formação de grupos terapêuticos, os quais devem, preferencialmente, ser homogêneos, a fim de garantir a eficácia e diminuir as dificuldades das intervenções. Na formação de grupos terapêuticos para a esquizofrenia, devem ser selecionados pacientes com predomínio de delírios e/ou alucinações (sintomas positivos), que estão sendo acompanhados por psiquiatras e fazendo uso correto da medicação (Garety, Fowler, & Kuipers, 2000).

Em contrapartida, os indivíduos com predomínio de sintomas negativos, com limitações cognitivas importantes, com transtornos da linguagem que impeçam uma comunicação adequada ou com limitações decorrentes de comorbidades psiquiátricas (como abuso de substâncias ou depressão) apresentam restrições para integrar os grupos (Wykes et al. 1999). Apesar dos vários estágios do transtorno, pacientes que não se encontrem na mesma fase

da doença podem integrar um mesmo grupo, pois observa-se que as diferentes experiências podem contribuir para o aprendizado e, consequentemente, para o processo terapêutico.

AS SESSÕES INICIAIS

Os grupos devem, idealmente, ser pequenos, constituídos por seis participantes, para facilitar a continência, e por pelo menos dois terapeutas. Os encontros são realizados semanalmente, com duração de 60 a 90 minutos, e, apesar de estruturados, não devem ser demasiadamente rígidos, sendo que os terapeutas precisam ser treinados e estar aptos a administrar possíveis intercorrências.

O número de sessões introdutórias, diferentemente dos demais transtornos, geralmente é maior, podendo chegar a cinco. A primeira sessão tem como objetivo a apresentação de cada integrante e suas histórias pessoais, experiências, motivações e expectativas em participar da terapia. Os objetivos terapêuticos são claramente expostos ao grupo, salientando que a TCCG não substitui outras abordagens terapêuticas, e combinam-se os horários e as regras básicas, enfatizando que a regra fundamental é a aceitação de seu companheiro, independentemente do que este possa relatar durante as sessões (Pinkham et al., 2004). Os pacientes podem ter falta de *insight* em relação aos fenômenos pelos quais estejam passando, mas isso não os impede necessariamente de ter uma visão crítica e estigmatizante em relação aos delírios ou às alucinações apresentados por outras pessoas.

As segunda e terceira sessões são reservadas para a psicoeducação sobre os delírios e as alucinações, a normalização dos sintomas e o compartilhamento de experiências. A normalização é componente essencial do tratamento e possibilita aos pacientes criar uma narrativa positiva com relação às dificuldades que vivenciam (Kingdon & Turkington, 1991). Para motivar e facilitar a discussão, o terapeuta pode, por exemplo, relatar as experiências de personagens históricos, cujas ideias estavam avançadas para seu tempo. Um exemplo de narrativa pode se dar da seguinte forma:

. . . Galileu Galilei era um famoso cientista e foi quem inventou o telescópio. Ele ousou afirmar, com base em suas próprias observações, que os planetas orbitavam ao redor do Sol, ao contrário do que diziam os sábios da época. Entretanto, suas ideias não foram aceitas pela comunidade científica, e, por isso, ele sofreu represálias, sendo visto como “louco”, por acreditar em coisas que a maioria das pessoas discordava. Até hoje, podem ser comuns os conflitos entre alguns indivíduos e grupos maiores. Algumas vezes, os indivíduos estão certos, e, em outras ocasiões, os grupos maiores é que têm razão. Como poderemos saber ou decidir?

Nesse momento, pode ser ressaltada a importância de basearmos nossas suposições em dados empíricos.

Vinheta Clínica 7.1

SD é um paciente com evolução crônica, com limitações devidas aos seus sintomas, e refere que pensamentos, que não lhe pertencem, são transmitidos para sua mente por familiares distantes. Escuta vozes que, além de o acusarem de ter pretensões pecaminosas para com uma prima jovem, ameaçam interná-lo caso apresente comportamento descontrolado. Relata que os familiares também querem “sujaronome” de seu ramo familiar. O termo “sujaronome”, usado como substantivo pelo paciente, é um neologismo, um dos possíveis transtornos de pensamento observados na esquizofrenia (Baskak, Ozel, Atbasoglu, & Baskak, 2008). Durante a segunda sessão do grupo, demonstrou surpresa quando descobriu que outros membros também acreditavam em telepatia (Peters, Joseph, Day, & Garety, 2004). Após o terapeuta relatar que estudos foram realizados para tentar comprovar o fenômeno, SD se interessou e se comprometeu a estudar o assunto, tentando identificar se haveria relação direta com seus sentimentos e experiências. Entre as possibilidades vislumbradas, cogitou algumas hipóteses: a) estar vivenciando fenômenos reais de telepatia; b) estar apresentando os sintomas de uma doença mental; c) seus pensamentos serem reais e isso significar que ele, realmente, seria uma pessoa “pecaminosa”.

Outra importante atividade, além da psicoeducação, consiste em apresentar o *continuum* da experiência, baseando-se nos sintomas dos próprios pacientes (Verdoux & Van Os, 2002). Deve-se dar devida atenção ao grau de convicção dos indivíduos com relação às suas ideias, bem como à

angústia consequente dessas experiências. Com relação às alucinações, principalmente as auditivas, observa-se que sua frequência pode variar em intensidade e períodos, sendo que muitos relatam escutá-las predominantemente em algum momento do dia. Assim, pode-se psicoeducar sobre o modelo de vulnerabilidade ao estresse (Zubin & Spring, 1977), ressaltando a importância do desenvolvimento de habilidades de enfrentamento do estresse.

Nas quarta e quinta sessões, o terapeuta conduz os membros e os motiva a relatar suas experiências, como elas interferem em seu cotidiano, bem como a característica e o conteúdo das alucinações e delírios (Myin-Germeys, van Os, Schwartz, Stone, & Delespaul, 2001), buscando estimular as reações do grupo em relação aos temas comuns. Os membros são estimulados a monitorar os momentos em que as vozes ou delírios são mais prevalentes, bem como o conteúdo e as sensações correlacionadas.

Vinheta Clínica 7.2

AM é uma estudante de publicidade que abandonou seus estudos após o primeiro surto psicótico. Ela relata ser constantemente vigiada por dois grupos de pessoas, um composto por mafiosos que querem lhe fazer mal e outro composto por seguranças com a intenção de protegê-la. Acredita que tem uma missão especial e, quando não consegue levar a contento, permite a ocorrência de grandes desastres naturais. Relata um episódio de sua adolescência, quando, ao sair à procura de discos voadores, percebeu a aproximação de uma grande luz, a qual, ao afastar-se, deixou-lhe uma sensação de grande calma. Tinha certeza de que não havia imaginado e de que não se tratava de um disco voador, acreditando ter sido um anjo que, até os dias atuais, a protege (Kingdon & Turkington, 1991). Ao perguntar a opinião do grupo, um dos rapazes concordou com a suposição da paciente, fazendo AM se sentir emocionada e aliviada, pois finalmente alguém havia lhe escutado, sem menosprezá-la ou chamá-la de “louca”, como faziam seus familiares ao contar a mesma história.

SESSÕES INTERMEDIÁRIAS

As duas sessões seguintes, 6 e 7, são empregadas para socializar e psicoeducar os pacientes no modelo cognitivo (Morrison, 1998). O terapeuta fornece exemplos gerais, não psicóticos, de como as crenças individuais,

perante cada situação, podem influenciar suas emoções, comportamentos e reações físicas. O emprego de metáforas pode ser adequado ao nível de entendimento médio do grupo. Por exemplo, em um grupo em que dois membros coincidentemente eram funcionários da área da saúde, foi utilizado como metáfora o funcionamento do sistema imune “... *sabemos que muitas doenças não são causadas diretamente pelo germe invasor, e sim pelos anticorpos ativados que se voltam contra os tecidos do organismo. Assim, os danos são causados pela reação do anticorpo com o organismo, e não pelo agente invasor. A reação do organismo pode ser mais negativa e poderosa do que o próprio evento ativador*”. Essa analogia pode ser utilizada para explicar que as reações emocionais e comportamentais podem ser mais graves do que a simples presença dos sintomas psicóticos.

Exemplos de situações não psicóticas podem ser solicitados para serem formatados no sistema ABC, e, posteriormente, o modelo é adaptado para situações com sintomas psicóticos (Chadwick & Lowe, 1994). Pode ser solicitado, a um voluntário, para que cite um exemplo do que estava fazendo quando surgiu um sintoma psicótico, destacando-se a importância de identificar os antecedentes da situação e, posteriormente, suas consequências emocionais, cognitivas e comportamentais.

Esse trabalho propicia o ensinamento de que os sintomas não são aleatórios ou dependentes apenas de agentes externos, mas podem estar relacionados a contextos específicos. Como tarefa de casa, pode ser solicitado aos membros que avaliem suas crenças aterrorizadoras (Glaser, Kazantzis, Deane, & Oades, 2000).

Vinheta Clínica 7.3

AM comentou que tem muito medo de permanecer sozinha, principalmente no período noturno, em seu apartamento, classificando esse medo como 100% (em uma escala de 0 a 100%). Relata ao grupo que sempre dorme com a porta de seu quarto fechada, por temer que seu vizinho, que reside no apartamento superior, invada o aposento e a violenta. Relata que consegue escutá-lo ameaçando-a e dizendo que vai descer para forçá-la a “fazer sexo e outras coisas horríveis”. A paciente identificou, durante uma análise comportamental, que ouvia claramente a voz do vizinho, sempre após escutar ruídos no teto, provenientes do apartamento de cima. Um

exemplo da última semana foi, então, ilustrado segundo o modelo ABC (Chadwick & Birchwood, 1994). Ao escutar as ameaças do vizinho, pensava “preciso me proteger” e, conseqüentemente, sentia muito medo, insônia e trancava todas as portas de seu apartamento, sendo que tal situação se repetia diariamente. Nesse caso, a voz escutada pode ser considerada uma alucinação funcional, por ser desencadeada por algum som ou ruído (Nayani & David, 1996).

SESSÕES DE MANEJO

Nas duas sessões seguintes (8 e 9), prossegue-se no processo de distanciar os pacientes de seus próprios sintomas. Esse processo, de objetivar suas experiências, permite restabelecer progressivamente o autocontrole e utilizar estratégias de resolução de problemas. Solicita-se aos membros que identifiquem situações nas quais as vozes ou os pensamentos assustadores (delirantes) se tornam intensos (Yusupoff & Tarrier, 1996). As situações mais frequentemente identificadas foram as de isolamento, falta de sono, conflitos interpessoais e uso de substâncias psicoativas. Perguntas de *feedback* são realizadas frequentemente, com o objetivo de estimular a participação de membros mais apáticos, bem como possibilitar a troca de experiências.

Vinheta Clínica 7.4

O sintoma que SD escolheu monitorar foi o de ter a mente invadida por pensamentos de terceiros, que considerava pecaminosos, com o intuito de “sujar seu nome” (Chadwick & Lowe, 1994). Como resposta a esse pensamento, geralmente se trancava em seu quarto, para não realizar nada que pudesse julgar incorreto, assim como praticava alguns comportamentos de segurança (Freeman, Garety, Kuipers, Fowler, & Bebbington, 2002), como ler em voz alta, com o objetivo de impedir a entrada dos pensamentos perturbadores. As situações que passou a evitar, em ordem decrescente de ansiedade, foram: comparecer à missa dominical; passear na praça de sua cidade, exercitar-se com sua irmã, caminhando ao redor do quarteirão; sair ao portão de sua casa e assistir, com a família, ao noticiário noturno da TV.

Vinheta Clínica 7.5

As situações moduladoras identificadas por AM como agravantes de seus sintomas incluíam: isolamento de pessoas, fechar-se no quarto e falta de sono (Thomas et al., 2014). Entre as estratégias de enfrentamento eficazes, observou que conversar com o porteiro do prédio e caminhar em um parque próximo amenizavam os sintomas. Relata que gostaria de frequentar uma academia de ginástica, mas sentia-se demasiadamente ameaçada nesse ambiente. No caso de SD, os fatores moduladores de piora identificados foram encontrar familiares mais distantes e ir a locais públicos, enquanto os fatores moduladores de melhora foram ouvir música e discutir a situação política com suas duas irmãs.

A próxima etapa pode apresentar maior dificuldade em ser realizada, pois o terapeuta solicita aos membros exemplos de situações em que os sintomas melhoram. Essas informações permitem o desenvolvimento de estratégias para redução da frequência ou intensidade das vozes ou pensamentos assustadores. Muitas vezes, os pacientes, por si mesmos, já desenvolveram estratégias de manejo (Tarrier, 2002), como ouvir música, praticar atividade física, realizar técnicas de relaxamento, conversar com alguém e envolver-se em alguma outra atividade. Além do aprendizado de estratégias eficientes, essa prática também permite identificar as estratégias ineficazes, como confrontar as vozes, adotar medidas de apaziguamento ou submissão perante os perseguidores, fumar ou consumir bebidas alcoólicas. Aos exercícios de monitoração dos sintomas psicóticos pode ser incorporada a análise de efetividade das estratégias adotadas para modular os sintomas. Para contrabalançar a evitação cognitiva e promover a dessensibilização dos sintomas, orienta-se os pacientes a se concentrarem e descreverem mais detalhadamente seus sintomas. Com relação ao emprego de outras abordagens, pode-se fazer uso de técnicas de *mindfulness* (Chadwick, Hughes, Russell, Russell, & Dagnan, 2009).

SESSÕES DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS E DE REESTRUTURAÇÃO COGNITIVA

A partir dos fatores moduladores identificados, solicita-se aos pacientes, como tarefa de casa, o emprego e a avaliação de efetividade de novas estratégias para controlar seus sintomas e enfrentar situações antes evitadas.

Nos grupos, poderão ser geradas explicações alternativas para as experiências relatadas pelos pacientes (Freeman et al., 2004).

Em alguns grupos, será possível praticar apenas novas estratégias de modulação e avaliação de suas efetividades, pois muitos pacientes terão dificuldades em completar as atividades, embora todo progresso e esforço devam ser sempre reforçados. A fim de haver maior contribuição, pode-se treinar as estratégias de manejo em duplas durante o grupo. No entanto, há grupos nos quais alguns indivíduos progridem com a identificação e prática de exercícios com fatores de modulação negativos e positivos e, conseqüentemente, um novo aprendizado de acordo com seus resultados. Como outras tarefas de casa, podem ser solicitados exercícios de teste de realidade (Beck & Rector, 2000) ou de exposição e prevenção de resposta (Halperin, Nathan, Drummond, & Castle, 2000).

SESSÃO DE ENCERRAMENTO

A última sessão é reservada à avaliação, a qual consiste em revisar as estratégias de manejo experimentadas e o sucesso alcançado, e à despedida. Para o seguimento clínico, podem ser combinadas sessões de reforço. Devido à brevidade do tratamento, muito ainda faltará para ser trabalhado com cada paciente, sendo praticamente impossível, por exemplo, trabalhar diretamente com os esquemas disfuncionais de cada participante (Birchwood, 2003).

Até o momento, o tratamento realizado satisfaz tanto os pacientes do grupo como seus familiares, assim como não foi observada necessidade de reinternações por parte dos integrantes. Além disso, o acompanhamento do programa de medicação injetável de longa ação do CPM inclui sessões de grupo de psicoeducação com familiares, atividade grupal de terapia ocupacional e atendimento psicológico individual para pacientes.

Vinheta Clínica 7.6

AM identificou, como causador de sofrimento e piora dos sintomas, o esforço para permanecer acordada à noite, como comportamento de segurança contra vir a ser violentada por seu vizinho. O terapeuta propôs um exercício de teste de realidade (Turkington, Dudley, Warman, & Beck, 2004) e, com apoio do grupo, sugeriu que

AM procurasse se informar mais sobre a identidade e a rotina de seu vizinho. Descobriu-se que ele residia sozinho, era divorciado, tinha filhos e que viajava frequentemente, passando poucos dias em casa, pois trabalhava como representante comercial. Para sua surpresa, AM descobriu que, durante uma noite em que o ouviu nitidamente ameaçando-a, ele não estava em casa. Desse modo, com a ajuda do terapeuta e do grupo, AM foi estimulada a considerar explicações alternativas para a voz noturna que escutava.

Vinheta Clínica 7.7

SD gostava de conversar sobre política com suas irmãs, sendo esse um fator modulador positivo para as consequências catastróficas dos pensamentos pecaminosos inseridos em sua mente. No entanto, conversava menos com elas, pois se julgava desatualizado, e evitava assistir aos noticiários da TV. Após uma discussão no grupo, reconheceu que, se deixasse de evitar os noticiários, iria permanecer atualizado, e isso poderia ser usado como fator modulador positivo. Uma análise mais aprofundada permitiu identificar que a presença de uma locutora do sexo feminino nos noticiários da TV coincidia com a inserção dos pensamentos pecaminosos em sua mente. Por meio da psicoeducação, o terapeuta questionou ao paciente se é possível e desejável controlar os próprios pensamentos, informando-o de que pensar sobre alguma coisa é diferente de agir (Berle & Starcevic, 2005). SD foi orientado a manter atenção ao noticiário e a ignorar, em vez de bloquear ou lutar contra, o pensamento inserido em sua mente (Morrison & Wells 2000). Para surpresa de SD, a proposta de não lutar contra o pensamento e focar-se no conteúdo do noticiário foi efetiva (Barrowclough et al., 2006). Foi sugerido a SD que aplicasse o mesmo aprendizado para praticar atividade física, uma situação antes evitada, mesmo após orientação do endocrinologista, acompanhado de sua irmã.

GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES PARA PESSOAS COM ESQUIZOFRENIA

Mueser (2003), em sua proposta de modelo vulnerabilidade-estresse-habilidades para esquizofrenia, propõe que a gravidade e o curso da doença são determinados pela interação de três fatores: vulnerabilidade biológica, estresse socioambiental, habilidades de enfrentamento. Apesar de o tratamento da vulnerabilidade biológica ao estresse ser realizado com uso da farmacoterapia, sabe-se que 40% dos casos apresentam recaída (Mueser,

2003), havendo a necessidade do tratamento combinado com intervenções socioemocionais.

Adicionalmente, pessoas com esquizofrenia apresentam amplos déficits em habilidades de vida (HVs) e em habilidades sociais (HSs), com pouca competência social. Os déficits nessas HVs podem ser resultantes de sintomas da patologia que dificultam a execução das HVs e HSs, de repertório comportamental empobrecido, falta de estimulação ambiental ou mesmo de perda de habilidades após início dos sintomas (Mueser, 2003). As HVs são definidas pelo conjunto de habilidades necessárias para o enfrentamento saudável de conflitos cotidianos, como tomada de decisão, resolução de problemas, manejo de emoções e estresse, empatia, assertividade, comunicação eficaz, relacionamento interpessoal, autoconhecimento, pensamento crítico e pensamento criativo. Tais habilidades compõem um vasto repertório de relacionamento consigo mesmo e com os outros, sendo assim considerado que as HSs são parte das HVs (Neufeld, Daolio, Cassiano, Rossetto, & Cavenage, 2014).

Embasadas no modelo de vulnerabilidade-estresse-habilidades, as intervenções cognitivo-comportamentais para esquizofrenia com enfoque em treino de habilidades visam reduzir a vulnerabilidade a recaídas provocadas pelo estresse, melhorando a qualidade de vida e o funcionamento global do paciente. Os treinos em habilidades podem ser individuais ou em grupo, com algumas vantagens para as intervenções coletivas, como maior oportunidade de modelação de comportamentos, representação de papéis e a oportunidade de exercitar *in loco* as novas habilidades (Neufeld et al., 2014), além dos aspectos de custo-benefício. Diante desse modelo, e dada a realidade das demandas do Ambulatório de Reabilitação Psicossocial (AREP), propôs-se a intervenção em HVs em grupo para pessoas com esquizofrenia.

CONTEXTO

O Ambulatório de Terapia Cognitivo-Comportamental (ATCC) tem como propósito oferecer treinamento teórico-prático na abordagem cognitivo-comportamental aos médicos residentes do Programa de Psiquiatria da

FMRP-USP, bem como atendimento psicoterápico a pacientes adultos. A seguir, descreveremos o relato de experiência que ocorreu no estágio junto ao Ambulatório de Reabilitação Psicossocial, no HCFMRP-USP, durante o primeiro semestre de 2016.

O grupo foi formado por pacientes previamente selecionados e encaminhados diretamente pelos médicos assistentes do AREP. Os critérios de inclusão para o grupo foram: pacientes com esquizofrenia refratária estável, sem sintomas psicóticos agudos e que apresentavam déficits em HVs. Dessa forma, foi constituído um grupo com seis participantes para a aplicação do Programa de Treinamento de Habilidades de Vida para Pacientes com Esquizofrenia – PRHAVIDA-Esquizo.

PROCEDIMENTO

O PRHAVIDA-Esquizo contou com um terapeuta^[NT] e um coterapeuta, sendo cada dupla formada por médicos residentes do 3º ano. O processo de intervenção grupal aconteceu uma vez por semana, com duração de 1 hora, por 12 semanas consecutivas, dividido em duas fases (Tab. 7.3). O protocolo de atendimento tomou como base o Programa de Habilidades para Vida do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-Comportamental (PRHAVIDA) proposto por Neufeld e colaboradores (2014) para crianças e adolescentes em escolas, adaptando-o para a realidade do ATCC e pacientes com esquizofrenia. Todas as sessões dos grupos foram supervisionadas semanalmente pela terceira autora deste capítulo.

Tabela 7.3 Protocolo de atendimento do PRHAVIDA-Esquizo, Fases 1 e 2

FASE 1: Regulação Emocional

Número da sessão	Conteúdo
Sessão 1	<i>Rapport</i> , contrato inicial Apresentação geral do grupo/identidade e regras do grupo
Sessão 2	Estabelecimento das regras do grupo
Sessão 3	Regulação emocional: psicoeducação sobre emoções
Sessão 4	Regulação emocional: expressividade emocional
Sessão 5	Regulação emocional: percepção das emoções em si e no outro

FASE 2: Treinamento de Habilidades de Vida

Número da sessão	Conteúdo
Sessão 1	Apresentação geral do grupo/identidade e regras do grupo
Sessão 2	Direitos humanos e civilidade; pensamento crítico e criativo
Sessão 3	Psicoeducação de habilidades sociais e habilidades de vida
Sessão 4	Psicoeducação e treino de empatia
Sessão 5	Treino de empatia e expressividade emocional Psicoeducação sobre assertividade
Sessão 6	Treino de assertividade
Sessão 7	Treino de assertividade e avaliação qualitativa

As intervenções semanais tiveram o objetivo de ensinar estratégias comportamentais e cognitivas para o manejo de emoções e regulação emocional (Fase 1) e Treinamento de Habilidades de Vida (Fase 2). Na primeira sessão do grupo, os residentes foram orientados a prestar os esclarecimentos e a firmar o contrato terapêutico, sendo apresentado, posteriormente, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido para obter autorização do paciente ou de seu responsável, a fim de que os dados registrados relativos ao atendimento pudessem ser utilizados para situações de ensino e pesquisa.

A seguir, serão descritos aspectos distintivos das intervenções realizadas no grupo, por fase da intervenção.

FASE 1 – REGULAÇÃO EMOCIONAL

SESSÕES 1 E 2

As primeiras duas sessões têm como objetivo a instalação do grupo e a otimização dos fatores terapêuticos grupais (Neufeld et al., 2014). O objetivo da primeira sessão foi apresentar os membros do grupo e estabelecer as normas dos atendimentos. Os terapeutas se apresentaram aos participantes e explicaram o funcionamento do grupo: sessões semanais de 1 hora, com as primeiras enfocando a regulação emocional. Para favorecer uma maior interação entre os participantes e explicar como um grupo funciona, foi usada

a técnica do barbante (Neufeld et al., 2014), para que os membros do grupo se apresentassem. Nessa técnica, cada participante segura a ponta de um barbante, fala uma de suas preferências e o lança para que outro participante do grupo fale. Após todos terem falado, forma-se uma teia de barbante que une todos os participantes. Essa teia é utilizada como metáfora para explicar o fenômeno de grupo. Para finalizar, a teia deve ser desfeita, e, percorrendo o caminho inverso, cada participante deve lembrar a preferência de quem o lançou. Ao desfazer-se a teia, conversa-se sobre as habilidades requeridas na atividade e no grupo: atenção, concentração e memória. Na segunda sessão, foram estabelecidas, com os participantes, as regras de funcionamento do grupo, utilizando-se questionamentos como “qual a importância das regras” e “como seria uma cidade sem regras” (técnica adaptada de Neufeld et al., 2014). Por fim, as regras foram estabelecidas e expostas em um quadro: atraso de 5 minutos, respeito, sigilo, falar um de cada vez, pedir para levantar, não esquecer o cartão de consulta, não se alimentar durante as sessões e pedir ajuda se precisar.

SESSÕES 3 A 6

Na terceira sessão, deu-se início ao trabalho de regulação emocional propriamente dita. Primeiramente, focou-se na psicoeducação das emoções, discutindo-se com os participantes o que eles sabiam sobre emoções, qual o papel delas e quais eram as principais. Depois, discutiu-se que as emoções não são, por si só, boas ou ruins, mas a reação causada por elas pode ser desagradável.

A quarta sessão teve como tema expressividade emocional, e, para isso, utilizou-se o banco de expressões faciais do Dr. Paul Ekman (*Pictures of Facial Affect* [POFA]), que consiste em imagens de adultos, de ambos os gêneros, expressando as seis emoções básicas (Ekman & Friesen, 1978). A atividade foi identificar a emoção expressa em cada figura e descrever, por meio das características faciais, como fizeram para identificá-la. Após a identificação das emoções, foi solicitado a cada participante que expressasse uma emoção, e os demais deveriam identificá-la. Notou-se que os pacientes tiveram facilidade em identificar as emoções nas faces de Paul Eckman, mas

difficuldade em reproduzi-las, o que pode ser característica da patologia. Como tarefa para casa, foi sugerido que observassem e registrassem, em um diário, suas emoções ao longo da semana.

Na quinta sessão, foi verificada a tarefa de casa, percebendo-se a grande dificuldade de identificar suas próprias emoções, atribuída aos efeitos colaterais das medicações, como se “os remédios fizessem eles deixarem de sentir as emoções”. Outra questão abordada foi a queixa de que as pessoas não prestavam atenção nas suas emoções por serem “pacientes psiquiátricos”. A demanda foi acolhida pelos terapeutas, e a sessão prosseguiu com discussões sobre como as emoções afetam cada um dos participantes, bem como sobre a importância de reconhecê-las em si e nos outros.

Na última sessão da primeira fase, o tempo foi dividido em duas partes: a primeira, para trabalhar o manejo das emoções, e a segunda, para receber o *feedback* dos pacientes sobre a primeira fase do grupo. Inicialmente, foi questionado aos participantes como eles manejavam as emoções desagradáveis, como tristeza, raiva e medo. Posteriormente, foi discutido quais alternativas seriam possíveis para o manejo desses sentimentos, surgindo como ideias controlar a respiração, tentar pensar em outra coisa, sair da cena na qual a emoção surgiu, entre outras. Na sequência, foi discutido sobre o aprendizado com o grupo e se estavam conseguindo utilizar, no cotidiano, os conhecimentos adquiridos. A sessão terminou com a despedida dos terapeutas e a explicação de que, posteriormente, o grupo continuaria em uma segunda fase, com enfoque em treino de HSs e HVs.

FASE 2: TREINAMENTO DE HABILIDADES DE VIDA

SESSÕES 1 A 3

As primeiras três sessões tiveram como objetivo investir na formação de identidade do grupo e psicoeducar sobre HVs e direitos humanos. Na primeira sessão da nova fase, buscou-se fazer um trabalho de fundamentação da identidade do grupo, certificando-se de que as regras permaneceriam as mesmas. Com o intuito de favorecer a interação, foi proposta uma atividade

na qual cada participante deveria escrever duas perguntas sobre algo que teria curiosidade de saber do outro. Em seguida, as perguntas foram sorteadas, sendo respondidas por todos os integrantes; foram valorizadas todas as respostas, reconhecendo-se cada indivíduo como único.

A segunda sessão focou na discussão dos direitos humanos, tendo como base a versão popular criada por Frei Betto (Betto, 2003) com base nos 30 artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Primeiramente, explicou-se aos participantes o que eram os direitos humanos e sua origem. Depois, as frases foram sorteadas entre os integrantes de maneira aleatória, com o intuito de favorecer uma discussão e a reflexão no grupo, causando surpresa aos coordenadores, pois os participantes apontaram com clareza quais direitos estavam sendo respeitados e quais estigmas eles sofriam em decorrência da doença.

Na terceira sessão, foram introduzidos os conceitos de HVs e HSs, explicando-os aos participantes com exemplos e estimulando-os a exemplificar as situações em que se consideravam hábeis ou inábeis. A maioria dos exemplos envolvia pessoas da família e suas dificuldades em comunicar-lhes seus pensamentos, desejos e emoções, de maneira que foram introduzidos também os conceitos de posturas agressivas, passivas e assertivas. Tentou-se fazer uma reflexão entre o tipo de postura que poderia ser considerado mais hábil dentro dos exemplos trazidos pelos participantes.

SESSÕES 4 E 5

Na quarta sessão, devido à ausência de um integrante pelo falecimento de um amigo, todos os demais membros do grupo demonstraram preocupação. Como o tema a ser abordado na sessão era empatia, usou-se a situação, além de outros exemplos do cotidiano, para se discutir sobre essa faculdade e a capacidade de se colocar no lugar do outro. Para a quinta sessão, os participantes foram convidados para uma “exibição de cinema” imediatamente antes da sessão, na qual assistiram ao filme *Divertida Mente* (filme produzido pela Pixar Animation Studios e lançado pela Walt Disney Pictures, em 2015). Na discussão, foi abordado o que aprenderam sobre emoções, como posturas passivas, agressivas e assertivas, buscando usar

cenar do filme que exemplificassem cada uma delas. Discutiu-se também sobre se o comportamento do personagem havia sido hábil ou inábil e de que outra maneira ele poderia ter-se comportado.

SESSÕES 6 E 7

Na sexta sessão, foi retomado o conceito de assertividade, sendo utilizadas atividades de *role playing* de situações embaraçosas do cotidiano, devido à dificuldade de entendimento do tema. Chamou atenção dos terapeutas o quanto o tema despertou interesse do grupo, aumentando o envolvimento e participação na reflexão acerca dele. Na última sessão, foi feita uma revisão de todos os temas trabalhados nos grupos, sendo solicitado *feedback* do aprenderam, do que conseguiram aplicar em seu cotidiano, além de dicas para melhorar o grupo. Os pacientes indicaram a importância de terem um momento para conversar sobre os aprendizados que tiveram durante o tratamento.

MANEJO DO GRUPO

Com base na experiência relatada e na literatura, alguns pontos podem ser apreendidos como sugestões para o manejo mais adequado de grupos com pessoas com esquizofrenia. Pacientes com o transtorno podem apresentar características muito heterogêneas. Por exemplo, diferentes níveis de prejuízo em aspectos sociais e cognitivos podem coexistir em um mesmo grupo. Para o manejo das dificuldades cognitivas, as habilidades devem ser decompostas em passos antes de ensiná-las. Além disso, o uso da representação de papéis e da modelação como estratégias de ensino-aprendizagem de aspectos sociais pode aumentar o efeito das intervenções.

Para a utilização potencializadora dessas estratégias, a atenção constante dos terapeutas à compreensão dos temas e o uso recorrente de *feedback* dos participantes são fundamentais. Na medida em que o terapeuta investiga sobre o entendimento que cada um teve da atividade e estimula a participação de todos, a situação de grupo oportuniza aos integrantes que balizem suas percepções a partir da percepção dos demais membros.

Outro desafio adicional em grupos para essa demanda é a presença de sintomas de ansiedade durante a sessão e o impulso de não permanecer no grupo devido a esses sintomas. A utilização frequente de estratégias de regulação emocional e de treino de respiração tende a dirimir tais dificuldades. Além disso, os terapeutas devem ficar atentos ao rendimento dos pacientes e, em caso de fadiga intensa, diminuir o tempo de sessão. No programa descrito, por exemplo, em uma das primeiras sessões do grupo, aproveitou-se a oportunidade para psicoeducar sobre os sintomas positivos da esquizofrenia, uma vez que um paciente apresentava elevada agitação. Entretanto, visando atender a demanda do paciente em questão e não perder a qualidade da sessão para o grupo, o coterapeuta acompanhou o indivíduo até outra sala na tentativa de acalmá-lo, oferecendo-lhe o suporte necessário.

Uma questão importante no tratamento de pessoas com esquizofrenia é o envolvimento dos familiares/cuidadores no processo interventivo. Orientá-los tende a aumentar a adesão dos pacientes ao grupo e melhorar as relações e os cuidados dos familiares. Ainda na direção dos cuidadores, a necessidade de supervisão dos terapeutas também atua como um fator fundamental nessa demanda. A estrutura das sessões, a descrição das técnicas e a existência de protocolos facilitam o trabalho dos terapeutas iniciantes; entretanto, tais aspectos, apesar de importantes, não são suficientes para a condução de grupos. O atendimento em TCCG apresenta particularidades que requerem treinamento prévio e supervisões sistemáticas. Um resumo das sugestões de manejo é apresentado no Quadro 7.2.

Quadro 7.2 Resumo de sugestões de manejo

Sugestões para manejo de grupos de habilidades para pessoas com esquizofrenia

- Decompor as habilidades em etapas e ensinar o passo a passo de cada uma delas.
- Utilizar modelação e representação de papéis como estratégias de ensino-aprendizagem.
- Utilizar estratégias para manejo de ansiedade para que o paciente consiga permanecer no grupo durante toda a sessão.
- Ficar atento ao cansaço dos pacientes e modular o ritmo e o tempo das sessões.
- Prestar atenção à interferência dos sintomas positivos e à necessidade de intervenção específica.
- Pedir *feedback* e estimular a participação de todos os pacientes no grupo.
- Realizar psicoeducação e envolver familiares.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre os transtornos mentais, a esquizofrenia é a que mais gera incapacidade crônica e comprometimento da qualidade de vida. O paciente com a doença, até pouco tempo atrás, contava apenas com o uso de medicações para realizar o seu tratamento. Além desse restrito repertório terapêutico, esses indivíduos sempre foram estigmatizados, inclusive por profissionais da saúde mental (Kingdon et al., 2008).

Apesar das desvantagens associadas a essa patologia, as intervenções cognitivo-comportamentais têm-se mostrado eficazes tanto no manejo dos sintomas quanto na melhora da qualidade de vida desses pacientes. Embora sejam consideradas intervenções baseadas em evidências, a disseminação dessas técnicas é limitada devido ao pequeno número de terapeutas que se sentem seguros para sua aplicação em indivíduos com esquizofrenia (Tarrier et al., 1999). Devido a essa restrição de profissionais que se sentem capacitados ao atendimento desse público, as estratégias de grupo podem otimizar e promover o tratamento clínico adequado, além de proporcionar os benefícios já conhecidos na utilização de técnicas grupais. Observa-se, também, que o treino de habilidades parece aprimorar o repertório comportamental e as estratégias de enfrentamento do estresse, tendo-se mostrado útil para o desenvolvimento das HVs e, conseqüentemente, a diminuição do estresse, das recaídas e do número de (re)internações do paciente.

REFERÊNCIAS

- Aghotor, J., Pfueller, U., Moritz, S., Weisbrod, S., & Roesch-Ely, D. (2010). Metacognitive training for patients with schizophrenia (MCT): Feasibility and preliminary evidence for its efficacy. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 41(3), 207-211.
- American Psychiatry Association (APA). (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5*. (5. ed.). Porto Alegre: Artmed.
- Barreto, E. (2015). Terapia cognitiva para esquizofrenia. In A. E. Nardi, J. Quevedo, & A. G. Silva (Orgs.), *Esquizofrenia: Teoria e clínica* (pp. 183-190). Porto Alegre: Artmed.
- Barrowclough, C., Haddock, G., Lobban, F., Jones, S., Siddle, R., Roberts, C., & Gregg, L. (2006). Group cognitive-behavioural therapy for schizophrenia. *The British Journal of Psychiatry*, 189(6), 527-532.
- Baskak, B., Ozel, E. T., Atbasoglu, E. C., & Baskak, S. C. (2008). Peculiar word use as a possible trait marker in schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 103(1), 311-317.

- Beck, A.T., & Rector, N.A. (2000). Cognitive therapy of schizophrenia: A new therapy for the new millennium. *American Journal of Psychotherapy*, 54(3), 291-300.
- Berle, D., & Starcevic, V. (2005). Thought-action fusion: Review of the literature and future directions. *Clinical Psychology Review*, 25(3), 263-284.
- Betto, F. (2003). *Gosto de uva: Escritos selecionados*. Rio de Janeiro: Garamond.
- Birchwood, M. (2003). Pathways to emotional dysfunction in first-episode psychosis. *The British Journal of Psychiatry*, 18(5), 373-375.
- Buchanan, R. W., Kreyenbuhl, J., Kelly, D. L., Noel, J. M., Boggs, D. L., Fischer, B. A., & Keller, W. (2010). The 2009 Schizophrenia PORT Psychopharmacological Treatment Recommendations and Summary Statements. *Schizophrenia Bulletin*, 36(1), 71-93.
- Buchanan, R.W., & Carpenter, W.T. (1994). Domains of psychopathology: An approach to the reduction of heterogeneity in schizophrenia. *The Journal of nervous and mental disease*, 182(4), 193-204.
- Buckley, P. F., Miller, B. J., Leher, D. S., & Castle, D. J. (2009). Psychiatric Comorbidities and Schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 35(2), 383-402.
- Cella, M., Reeder, C., & Wykes, T. (2016). Group cognitive remediation for schizophrenia: Exploring the role of therapist support and metacognition. *Psychological Psychotherapy*, 89(1), 1-14.
- Chadwick, P., & Birchwood, M. (1994). The omnipotence of voices: A cognitive approach to auditory hallucinations. *The British Journal of Psychiatry*, 164(2), 190-201.
- Chadwick, P., Hughes, S., Russell, D., Russell, I., & Dagnan, D. (2009). Mindfulness groups for distressing voices and paranoia: A replication and randomized feasibility trial. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 37(4), 403-412.
- Chadwick, P. D., & Lowe, C. F. (1994). A cognitive approach to measuring and modifying delusions. *Behaviour Research and Therapy*, 32(3), 355-367.
- Chadwick, P., Strauss, C., Jones, AM., Kingdon, D., Ellett, L., Dannahy, L., & Hayward, M. (2016). Group mindfulness-based intervention for distressing voices: A pragmatic randomised controlled trial. *Schizophrenia Research*, 175(1-3), 168-173.
- Dalgalarondo, P. (2008). Síndromes psicóticas. In P. Dalgalarondo, *Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais* (2. ed., pp. 325-331). Porto Alegre: Artmed.
- Ekman, P., & Friesen, W. (1978). *The facial action coding system*. Palo Alto: Consulting Psychologists Press.
- Elkis, H., Kayo, M., Louzã Neto, M. R., & Curátolo, E. (2012). A esquizofrenia ao longo da vida. In O. Forlenza, E. C. Miguel, C. M. C. Bottino, H. Elkis, R. Fráguas, S. Scivoletto, & T. A. Cordás, *Compêndio de clínica psiquiátrica* (pp. 276-295). Barueri: Manole.
- Fanning, F., Foley, S., Lawlor, E., McWilliams, S., Jackson, D., Renwick, L., ... O'Callaghan, E. (2012). Group cognitive behavioural therapy for first episode psychosis: Who's referred, who attends and who completes it? *Early Intervention in Psychiatry*, 6(4), 432-441.
- Freeman, D., Garety, P. A., Kuipers, E., Fowler, D., & Bebbington, P. E. (2002). A cognitive model of persecutory delusions. *British Journal of Clinical Psychology*, 41(4), 331-347.

- Freeman, D., Garety, P. A., Fowler, D., Kuipers, E., Bebbington, P. E., & Dunn, G. (2004). Why do people with delusions fail to choose more realistic explanations for their experiences? An empirical investigation. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 72(4), 671-680.
- Garety, P.A., Fowler, D., & Kuipers, E. (2000). Cognitive-behavioral therapy for medication-resistant symptoms. *Schizophrenia Bulletin*, 26(1), 73-86.
- Glaser, N. M., Kazantzis, N., Deane, F. P., & Oades, I. G. (2000). Critical issues in using homework assignments within cognitive-behavioral therapy for schizophrenia. *Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavior Therapy*, 18(4), 247-261.
- Gledhill, A., Lobban, E., & Sellwood, W. (1998). Group CBT for people with schizophrenia: A preliminary evaluation. *Behavioral and Cognitive Psychotherapy*, 26(1), 63-75.
- Halperin, S., Nathan, P., Drummond, P., & Castle, D. (2000). A cognitive-behavioural, group-based intervention for social anxiety in schizophrenia. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 34(5), 809-813.
- Harper, R. K., Meyer, P. S., Johnson, D., & Penn, D. L. (2014). An investigation of the relationship between therapist characteristics and alliance in group therapy for individuals with treatment-resistant auditory hallucinations. *Journal of Mental Health*, 23(4), 166-70.
- Insel, T. R. (2010). Rethinking schizophrenia. *Nature*, 468(7321), 187-193.
- Jablensky, A. (1997). The 100-year epidemiology of schizophrenia. *Schizophrenia Research*, 28(2-3), 111- 125.
- Jarkosg, L., & Gilmore, J. (2006). Neuroprogressive theories. In: J. Lieberman, T. S. Stroup, & D. Perkins (Eds.). *Textbook of schizophrenia* (pp. 137-149). Washington: American Psychiatric Publishing.
- Jeste, D. V., Wolkowitz, O. M., & Palmer, B. W. (2011). Divergent trajectories of physical, cognitive, and psychological aging in schizophrenia. *Schizophrenia Bulletin*, 37(3), 451-455.
- Khoury, B., Lecomte, T., Comtois, G., & Nicole, L. (2015). Third-wave strategies for emotion regulation in early psychosis: A pilot study. *Early Intervention in Psychiatry*, 9(1), 76-83.
- Kingdon, D., Gibson, A., Kinoshita, Y., Turkington, D., Rathod, S., & Morrison, A. (2008). Acceptable terminology and subgroups in schizophrenia. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology*, 43(3), 239-243.
- Kingdon, D.G., & Turkington, D. (1991). The use of cognitive behavior therapy with a normalizing rationale in schizophrenia: Preliminary report. *The Journal of nervous and mental disease*, 179(4), 207-211.
- Lazell, E. W. (1921). The group treatment of dementia praecox. *Psychoanalytic Review*, 8, 168-179.
- Leitão, R. J., Ferraz, M. B., Chaves, A. N., & Mari, J. J. (2006). Cost of schizophrenia: Direct costs and use of resources in the State of São Paulo. *Revista de Saúde Pública*, 40(2), 304-309.
- Lincoln, T. M., Wilhelm, K., & Nestoriuc, Y. (2007). Effectiveness of psychoeducation for relapse, symptoms, knowledge, adherence and functioning in psychotic disorders: A meta-analysis. *Schizophrenia Research*, 96(1-3), 232-45.
- Lorentzen, S., & Ruud, T. (2014). Group therapy in public mental health services: Approaches, patients and group therapists. *Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing*, 21(3), 219-225.

- Marder, S. R., Wirshing, W. C., Mintz, J., McKenzie, J., Johnston, K., Eckman, T. A., ... Liberman, R. P. (1996). Two-year outcome of social skills training and group psychotherapy for outpatients with schizophrenia. *The American Journal of Psychiatry*, 153(12), 1585-1592.
- Marsh, L. C. (1931). Group treatment of the psychoses by the psychological equivalent of the revival. *Mental Hygiene*, 15, 328- 349.
- McGrath, J., Saha, S., Chant, D., & Welham, J. (2008). Schizophrenia: A concise overview of incidence, prevalence and mortality. *Epidemiologic Reviews*, 30(1), 67-76.
- Meyer-Lindenberg, A. (2010). From maps to mechanisms through neuroimaging of schizophrenia. *Nature*, 468(7321), 194-202.
- Mortan, O., Tekinsav, S. S., & German, K. G. (2011). A pilot study on the effectiveness of a group-based cognitive-behavioral therapy program for coping with auditory hallucinations. *Turk Psikiyatri Dergisi*, 22(1), 26-34.
- Morrison, A. P. (1998). A cognitive analysis of the maintenance of auditory hallucinations: Are voices to schizophrenia what bodily sensations are to panic? *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 26(4), 289-302.
- Morrison, A. P., & Wells, A. (2000). Thought control strategies in schizophrenia: a comparison with non-patients. *Behaviour Research and Therapy*, 38(12), 1205-1209.
- Mueser, K. T. (2003). Tratamento cognitivo-comportamental de esquizofrenia. In V. E. Caballo (Org.), *Manual para o tratamento cognitivo-comportamental dos transtornos psicológicos* (pp. 591-613). São Paulo: Santos
- Myin-Germeys, I., van Os, J., Schwartz, J. E., Stone, A. A., & Delespaul, P. A. (2001). Emotional reactivity to daily life stress in psychosis. *Archives of General Psychiatry*, 58(12), 1137-1144.
- Nayani, T. H., & David, A. S. (1996). The auditory hallucination: a phenomenological survey. *Psychological Medicine*, 26(1), 177-189.
- Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B., Daolio, C. C., Cassiano, M., Rossetto, C. P. F., & Cavenage, C. C. (2014). PRHAVIDA: Programa Cognitivo-Comportamental de habilidades de vida para crianças e adolescentes. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 80-115). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Owen, M., Sellwood, W., Kan, S., Murray, J., & Sarsam, M. (2015). Group CBT for psychosis: A longitudinal, controlled trial with inpatients. *Behaviour Research and Therapy*, 65, 76-85.
- Pearlman, L. M., & Hubbard, BA. (2000). A self-control skills group for persistent auditory hallucinations. *Cognitive and Behavioral Practice*, 7(1), 17-21.
- Penn, D. L., Meyer, P. S., Evans, E., Wirth, R. J., Cai, K., & Burchinal, M. (2009). A randomized controlled trial of group cognitive-behavioral therapy vs. enhanced supportive therapy for auditory hallucinations. *Schizophrenia Research*, 109(1-3), 52-59.
- Peters, E., Joseph, S., Day, S., & Garety, P. (2004). Measuring delusional ideation: The 21-item Peters et al. Delusions Inventory (PDI). *Schizophrenia Bulletin*, 30(4), 1005-1022.

- Pinkham, A. E., Gloege, A. T., Flanagan, S., & Penn, D. L. (2004). Group cognitive-behavioral therapy for auditory hallucinations: A pilot study. *Cognitive and Behavioral Practice*, 11(1), 93-98.
- Roberts, D. L., Pinkham, A. E., & Penn, D. L. (2008). Esquizofrenia. In P. J. Bieling, R. E. McCabe, & M. M. Antony, *Terapia cognitivo-comportamental em grupos* (pp. 320-339). Porto Alegre: Artmed.
- Rössler, W., Salize, H. J., van Os J., & Riecher-Rössler, A. (2005). Size of burden of Schizophrenia and psychotic disorder. *European Neuropsychopharmacology*, 15(4), 399-409.
- Ruddle, A., Oliver, M., & Wykes, T. (2011). A review of hearing voices groups: Evidence and mechanisms of change. *Clinical Psychology Review*, 31(5), 757-766.
- Segredou, I., Xenitidis, K., Panagiotopoulou, M., Bochtsou, V., Antoniadou, O., & Livaditis, M. (2012) Group psychosocial interventions for adults with schizophrenia and bipolar illness: The evidence base in the light of publications between 1986 and 2006. *International Journal of Social Psychiatry*, 58(3), 229-238.
- Shafran, R., Clark, D. M., Fairburn, C. G., Arntz, A., Barlow, D.H., Ehlers, A., ... Wilson, G.T. (2009). Mind the gap: Improving the dissemination of CBT. *Behaviour Research and Therapy*, 47(11), 902-909.
- Shirakawa, I. (2000). Aspectos gerais do manejo do tratamento de pacientes com esquizofrenia. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 22(1), 56-58.
- Silva, T. F. C. D., Lovisi, G. M., Verdolin, L. D., & Cavalcanti, M. T. (2012). Adesão ao tratamento medicamentoso em pacientes do espectro esquizofrênico: Uma revisão sistemática da literatura. *Journal Brasileiro de Psiquiatria*, 61(4), 242-251.
- Tai, S., & Turkington, D. (2009). The evolution of cognitive behavior therapy for schizophrenia: Current practice and recent developments. *Schizophrenia Bulletin*, 35(5), 865-873.
- Tan, S., Zou, Y., Wykes, T., Reeder, C., Zhu, X., Fude, Y., ... Zhou, D. (2016). Group cognitive remediation therapy for chronic schizophrenia: A randomized controlled trial. *Neuroscience Letters*, 626, 106-111.
- Tandon, R., Nasrallah, H. A., & Keshavan, M. S. (2009). Schizophrenia, “just the facts”. Clinical features and conceptualizations. *Schizophrenia Research*, 110(1-3), 1-23.
- Tarrier, C. B., Haddock, G., & McGovern, N. (1999). The dissemination of innovative cognitive-behavioural psychosocial treatments for schizophrenia. *Journal of Mental Health*, 8(6), 569-582.
- Tarrier, N. (2002). The use of coping strategies and self-regulation in the treatment of psychosis. In A. P. Morrison (Ed.), *A casebook of cognitive therapy for psychosis* (pp. 79-107). Abingdon: Taylor & Francis.
- Thomas, N., Hayward, M., Peters, E., van der Gaag, M., Bentall, R. P., Jenner, J., ... & García-Montes, J. M. (2014). Psychological therapies for auditory hallucinations (voices): Current status and key directions for future research. *Schizophrenia Bulletin*, 40(Suppl 4), S202-S212.
- Turkington, D., Dudley, R., Warman, D. M., & Beck, A. T. (2004). Cognitive-behavioral therapy for schizophrenia: a review. *Journal of Psychiatric Practice*, 10(1), 5-16.
- Turkington, D., Kingdon, D., & Weiden, P. J. (2006). Cognitive behavior therapy for schizophrenia. *American Journal of Psychiatry*, 163(3), 365-373.

Turner, D. T., Gaag, M. V. D., Karyotaki, E., & Cuijpers, P. (2014). Psychological interventions for psychosis: A meta-analysis of comparative outcome studies. *American Journal of Psychiatry*, 171(5), 523-538.

Veltro, F., Vendittelli, N., Oricchio, I., Addona, F., Avino, C., Figliolia, G., & Morosini, P. (2008). Effectiveness and efficiency of cognitive-behavioral group therapy for inpatients: 4-year follow-up study. *Journal of Psychiatric Practice*, 14(5), 281-288.

Verdoux, H., & Van Os, J. (2002). Psychotic symptoms in non-clinical populations and the continuum of psychosis. *Schizophrenia research*, 54(1), 59-65.

Wykes, T., Hayward, P., Thomas, N., Green, N., Surguladze, S., Fannon, D., & Landau, S. (2005). What are the effects of group cognitive behaviour therapy for voices? A randomised control trial. *Schizophrenia Research*, 77(2), 201-210.

Wykes, T., Parr, A. M., & Landau, S. (1999). Group treatment of auditory hallucinations. Exploratory study of effectiveness. *The British Journal of Psychiatry*, 175(2), 180-185.

Yusupoff, L., & Tarrier, N. (1996). Coping strategy enhancement for persistent hallucinations and delusions. In G. Haddock, & P. D. Slade (Ed.), *Cognitive-behavioural interventions with psychotic disorders* (pp. 86-102). London: Routledge.

Zubin, J., & Spring, B. (1977). Vulnerability: A new view of schizophrenia. *Journal of Abnormal Psychology*, 86(2), 103-126.

LEITURAS RECOMENDADAS

Chadwick, P., Lees, S., & Birchwood, M. (2000). The revised beliefs about voices questionnaire (BA VQ-R). *British Journal of Psychiatry*, 177(3), 229-232.

Freeman, D., Waite, F., Startup, H., Myers, E., Lister, R., McInerney, J., ... Yu, L.M. (2015). Efficacy of cognitive behavioural therapy for sleep improvement in patients with persistent delusions and hallucinations (BEST): A prospective, assessor-blind, randomised controlled pilot trial. *Lancet Psychiatry*, 2(11), 975-983.

[NT] Nosso agradecimento a todos os médicos residentes que foram terapeutas e coterapeutas no PRHAVIDA-Esquizo: Thiago Pandóssio, Júlia Amaral, Rogério Nitsch e Robson Costa.

8



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRANSTORNOS ALIMENTARES E OBESIDADE

Monica Duchesne

Nazaré Almeida

Thaís Alvares Linhares Vieira

Carmem Beatriz Neufeld

Os transtornos alimentares (TAs) são definidos por uma persistente perturbação do comportamento alimentar, levando a prejuízos clínicos, psicológicos e sociais. A anorexia nervosa (AN) é caracterizada pela recusa do indivíduo em manter seu peso corporal em nível igual ou acima do mínimo adequado para sua idade e altura, devido a um temor exacerbado de se tornar gordo. Vinculado a isso, há influência indevida do peso e/ou da

forma corporal na autoavaliação, levando à associação entre valor pessoal e magreza. Esse quadro se apresenta acompanhado de um distúrbio da imagem corporal que faz o indivíduo perceber seu corpo como mais gordo do que realmente está, o que favorece a negação da gravidade do baixo peso e a adoção voluntária de dietas progressivamente mais rígidas. A prevalência da AN entre jovens do sexo feminino é de 0,4%. Não há muitos estudos sobre a prevalência da AN no sexo masculino, mas, em populações clínicas, observa-se uma proporção de 10 mulheres para 1 homem (American Psychiatric Association [APA], 2014).

A bulimia nervosa (BN) se manifesta por recorrentes episódios de compulsão alimentar (ECAs), caracterizados pela ingestão de uma quantidade de alimento definitivamente maior do que a maioria dos indivíduos consumiria em circunstâncias semelhantes, em um período delimitado de tempo (p. ex., 2 horas). Durante esses episódios, o paciente relata sensação de perda de controle sobre o comportamento alimentar, com dificuldade tanto de parar de comer como de controlar o tipo de alimento que está sendo consumido. Para evitar o ganho de peso, após o ECA, o indivíduo emprega métodos compensatórios inadequados e recorrentes, como dietas muito restritivas ou jejum, vômito autoinduzido, exercício físico excessivo e/ou uso indevido de laxantes, diuréticos, enemas ou outras substâncias. Assim como na AN, na BN, a autoavaliação é indevidamente influenciada pela forma e peso corporais. A prevalência da BN entre jovens do sexo feminino varia de 1 a 1,5%. A prevalência-ponto é maior entre adultos, já que a BN atinge seu pico no fim da adolescência e início da idade adulta. É um transtorno mais prevalente em mulheres, com uma proporção feminino-masculino de 10:1 (APA, 2014).

O transtorno de compulsão alimentar (TCA) se caracteriza pela ocorrência de ECA menos uma vez por semana durante três meses. Embora seja fonte de grande sofrimento, no TCA, o ECA não está associado ao uso regular de comportamentos compensatórios inadequados para o controle do peso corporal (APA, 2000). Embora a obesidade não seja critério diagnóstico para o TCA, ela é uma condição frequentemente associada, sobretudo naqueles que procuram tratamento para emagrecer (Duchesne et al., 2007). De acordo

com a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1998), obesidade é um acúmulo anormal ou excessivo de gordura que representa risco para a saúde. Ela não é classificada como doença mental, mas endócrina, nutricional ou metabólica, devido à gama de fatores genéticos, fisiológicos, comportamentais e ambientais que contribuem para seu desenvolvimento (APA, 2014).

A diversidade de condições médicas associadas à obesidade, como doenças cardiovasculares, diabetes, hipertensão arterial, problemas respiratórios, distúrbios do aparelho locomotor e dislipidemias, elevou-a ao patamar de quinto maior fator de risco de morte no mundo (Duchesne, 2001; Gomes et al., 2006; Mariath et al., 2007). A Organização Mundial da Saúde (WHO, 2010), considera a obesidade um dos maiores problemas de saúde pública no mundo, caracterizando-a como uma epidemia mundial. A prevalência mundial de obesidade mais do que duplicou entre 1980 e 2014. No Brasil, esse quadro não se mostra diferente. O último levantamento oficial feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2009, apontou que mais de 50% da população brasileira estava acima do peso, ou seja, na faixa de sobrepeso e obesidade.

Este capítulo abordará o tratamento em grupo de pacientes com TAs e obesidade, bem como daqueles que não preenchem todos os critérios diagnósticos para um desses transtornos, mas que apresentam sintomas de alimentação disfuncional que causam sofrimento significativo ou prejuízo funcional em áreas importantes da vida. As abordagens teórico-práticas envolvem a terapia cognitivo-comportamental (TCC) clássica e as baseadas em *mindfulness*. Contudo, algumas abordagens que tangenciam a TCC também têm mostrado eficácia para essas condições clínicas. Entre elas, ressaltam-se a terapia comportamental dialética (TCD) e a terapia de aceitação e compromisso (TAC).

A TCD foi criada como instrumento para ensinar o paciente a desenvolver regulação emocional principalmente para o tratamento do transtorno da personalidade *borderline*, mas passou a ser utilizada para a regulação emocional em vários outros quadros clínicos e psiquiátricos (Kristeller, Baer, & Wolever, 2006). Nos TAs e na obesidade, a TCD pressupõe que a

alimentação pode promover a redução de estados emocionais desagradáveis e que esse alívio temporário funciona como um reforçador do comportamento de comer (Wiser & Telch, 1999). No tratamento desses quadros, são desenvolvidas três das quatro habilidades da TCD básica para manejo adaptativo das emoções: *mindfulness*, regulação emocional e tolerância à pressão (Telch, Agras, & Linehan, 2001). A TCD adaptada para TAs consiste em 20 sessões semanais e pode ser aplicada no formato individual ou de grupo (Safer, Telch, & Agras, 2001; Telch et al., 2001). Resultados de vários ensaios clínicos têm mostrado a eficácia das intervenções de grupo nessa modalidade de tratamento, com maior regulação emocional em situações estressantes e redução da tendência para comer (Safer et al., 2001; Telch et al., 2001).

Inspirada nas práticas meditativas de *mindfulness* e modelos teóricos comportamentais (teoria das molduras relacionais), a TAC parte do pressuposto de que o indivíduo tende a se esquivar de experiências internas aversivas, sejam elas pensamentos, emoções, sensações ou impulsos (Hayes, Wilson, Gifford, Foillette, & Strosahl, 1996). A intervenção inclui várias estratégias baseadas em *mindfulness* e a aceitação de pensamentos, imagens e medos relacionados com o peso, em contraposição à tendência habitual do paciente de esquivar-se deles. A utilização de TAC para o tratamento em grupo para TAs foi relatada em um estudo de caso clínico com pacientes com AN (Heffner, Sperry, Eifert, & Detweiler, 2002).

Outro modelo de TCC em grupo (TCCG) para obesidade é o proposto por Cooper, Fairburn e Hawker (2009) para a perda e a manutenção de peso em longo prazo, por meio do foco em fatores que influenciam o abandono das tentativas no controle do peso. Apesar de ter sessões estruturadas e prover a conceitualização cognitiva, esse modelo pode ser caracterizado como psicoeducativo, sendo seu principal objetivo o desenvolvimento de habilidades comportamentais e respostas cognitivas que auxiliam o indivíduo a perder peso. Ele não propõe a reestruturação cognitiva ou o trabalho com as crenças disfuncionais relacionadas à perda de peso.

O tratamento em formato de grupo tem sido empregado em diversos serviços especializados em obesidade e TAs. O formato de grupo pode trazer

diversos benefícios, que incluem: permitir que pacientes compartilhem experiências, diminuindo a sensação de isolamento; poder validar experiências percebidas pelos pacientes como vergonhosas em um meio terapêutico “seguro”; promover apoio; aprender estratégias de enfrentamento úteis para resolver as dificuldades apresentadas por meio da observação de modelos; praticar habilidades interpessoais de comunicação e expressão direta de sentimentos. Além disso, o formato de grupo é de baixo custo (Mac Neil, Leung, Nadkarni, Stubbs, & Singh, 2016; Polnay et al., 2014).

Todavia, o tratamento em grupo tem limitações. Alguns indivíduos requerem intervenções específicas baseadas em conceitualização, e o formato de grupo muitas vezes não permite esse tipo de tratamento mais personalizado. Outro aspecto a ser analisado é que alguns pacientes podem exercer efeito negativo sobre os demais. No caso de pessoas com AN, por exemplo, pode haver competição por quem será o mais magro ou mesmo o fornecimento de “dicas” sobre como se manter excessivamente magro. Nesse caso, o “sabotador” precisa de ajuda para parar de prejudicar os demais membros do grupo. Seus motivos devem ser analisados, discutidos com o grupo e interpretados como um sintoma de suas dificuldades. Se os comportamentos disfuncionais permanecerem, ele deve ser convidado a participar exclusivamente de sessões individuais (Fairburn, Cooper, & Shafran, 2003; Tchanturia & Sparrow, 2015).

INTERVENÇÕES EM TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO

As TCCs enfatizam o papel que os fatores cognitivos exercem no desenvolvimento e na manutenção da obesidade e dos TAs (Gamer & Bemis, 1982; Gamer, Garfinkel, & O'Shaughnessy, 1985). Seus pressupostos relacionam o emagrecimento com a aprendizagem de um sistema de funcionamento cognitivo que favoreça padrões de comportamento que levem à redução da ingestão alimentar e ao aumento da atividade física (Bowers, 2001; Shafran & Silva, 2003). A TCC realiza a modificação dos

comportamentos-alvo patológicos ou desadaptativos, por meio da definição de objetivos e protocolos claros de intervenção.

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DA OBESIDADE

A TCC foi originalmente estruturada para o formato de psicoterapia individual. Contudo, ela tem sido adaptada com sucesso à psicoterapia de grupo (Barlow, Burlingame, & Fuhrman, 2000; Bieling, McCabe, & Antony, 2008; Duchesne et al., 2007; Neufeld et al., 2016). Praticamente todos os programas de perda de peso encontrados na literatura científica têm abordagem cognitivo-comportamental. Os grupos na TCC costumam ser estruturados, manualizados, de curta duração, focados no problema e homogêneos nos diagnósticos. Os membros do grupo aprendem como reconhecer suas distorções cognitivas e reestruturar seus esquemas cognitivos disfuncionais por meio de uma variedade de exercícios estruturados, incluindo ensaio de papéis, tarefas de casa, leituras, entre outros.

Neufeld, Affonso e Moreno (2014) propuseram um programa de TCCG para pacientes obesos e com sobrepeso com duração de 12 sessões, somadas a sessões de encorajamento. As estratégias de tratamento incluem automonitoramento, pesagem semanal, psicoeducação sobre peso e alimentação, prescrição de padrão alimentar regular e estratégias de autocontrole, treino de habilidades de resolução de problemas, reestruturação cognitiva, estratégias comportamentais e de prevenção de recaídas (Quadro 8.1).

Quadro 8.1 Descrição das sessões na intervenção TCCG para obesidade

Etapas	Atividades realizadas
Entrevista inicial e pré-teste	Apresentação do programa Realização da entrevista semiestruturada Avaliação qualitativa e quantitativa
1ª sessão	Apresentação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido Psicoeducação do modelo cognitivo
2ª e 3ª sessões	Trabalhando no 1º nível de pensamentos: pensamentos automáticos
4ª e 5ª sessões	Conceituação cognitiva dos pensamentos automáticos agrupados Trabalhando no 2º nível de pensamentos: crenças intermediárias e estratégias compensatórias

6ª sessão	Fechamento da conceituação cognitiva Trabalhando no 3º nível de pensamentos: identificação das principais crenças centrais responsáveis pelos comportamentos indesejáveis (incapacidade de autocontrole e permissividade)
7ª sessão	Psicoeducação das distorções cognitivas
8ª sessão	Intervenção: trabalhando com a crença de incapacidade de autocontrole
9ª sessão	Intervenção: trabalhando com a crença de permissividade
10ª sessão	Treino de habilidades sociais voltado para o comportamento alimentar
11ª sessão	Prevenção de recaída: resumo do processo desenvolvido ao longo das sessões
12ª sessão	Avaliação qualitativa, encerramento e pós-teste
Sessões de engajamento	Verificação do andamento dos participantes após o encerramento do programa

Fonte: Adaptado de Neufeld e colaboradores (2014).

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL NO TRATAMENTO DOS TRANSTORNOS ALIMENTARES

O protocolo de TCC mais pesquisado no tratamento dos TAs foi adaptado por Fairburn (2008) e é denominado TCC-Ampliada (TCC-A). Ele adota o modelo transdiagnóstico e foca nos sintomas psicopatológicos centrais dos TAs de modo geral, em vez de trabalhar com cada diagnóstico isoladamente. O pressuposto da TCC-A é o de que a supervalorização da forma e do peso corporais e da capacidade de controlar a alimentação é o sintoma psicopatológico central para a manutenção das diferentes expressões de TAs, sendo os métodos compensatórios adotados secundários a esse sistema de crenças disfuncional. Portanto, as estratégias de tratamento são úteis tanto para o tratamento da BN quanto para o da AN, sendo as técnicas de tratamento selecionadas de acordo com a conceituação dos pacientes. A TCC-A inclui quatro estágios, descritos a seguir.

O primeiro estágio tem como objetivos iniciais criar motivação e iniciar a psicoeducação sobre os TAs, a qual, variando os temas, se estende por todo o tratamento. A psicoeducação inclui a descrição das características dos TAs, sua prevalência, riscos clínicos associados, curso, prognóstico e resultados potencialmente obtidos ao término da TCC-A. É também elaborada, em conjunto com os pacientes, uma formulação geral dos TAs, visando capacitá-los a entender os fatores envolvidos na manutenção dos transtornos e os

aspectos que devem ser tratados. Além disso, ao longo da TCC-A, o paciente é orientado a manter um diário de sua alimentação e das condições associadas. Esse registro por escrito permite uma melhor compreensão dos fatores desencadeadores de alimentação inadequada (restritiva ou compulsiva), o que facilita a escolha das técnicas a serem implementadas no tratamento.

A TCC-A pressupõe que um dos fatores associados aos ECA é a restrição alimentar. Portanto, ainda no primeiro estágio, o paciente é orientado a introduzir um padrão regular de alimentação que inclua três refeições e três lanches planejados ao dia. É também discutida a tendência a raciocinar de modo “tudo ou nada”, uma vez que ela resulta em abandono total da tentativa de manter o controle sobre a alimentação após um pequeno lapso na dieta rígida autoimposta. Por exemplo, o paciente pode pensar: “Já que saí da dieta, vou comer tudo que eu puder porque amanhã começarei um regime bem rígido”. Em geral, em vez de identificar que a dificuldade para controlar a alimentação está no grau de rigidez das regras dietéticas que o indivíduo utiliza, ele interpreta o lapso como resultante de uma deficiência pessoal para controle da alimentação e aumenta o esforço para se ater a dietas cada vez mais rígidas. Estas, por sua vez, favorecem a ocorrência de novos ECA, que, conseqüente, aumentam a preocupação com o ganho de peso, levando à intensificação da restrição alimentar, formando-se um círculo vicioso.

O segundo estágio é uma breve etapa de transição na qual os pacientes e o terapeuta avaliam os progressos obtidos com as estratégias de tratamento implementadas no primeiro estágio, identificam potenciais barreiras para futuras mudanças, revisam a conceituação e selecionam as técnicas que serão utilizadas no terceiro estágio. Em alguns casos, pode ser necessário tratar mecanismos “externos” à psicopatologia central do TA e focalizar também no perfeccionismo exacerbado, na baixa autoestima e em dificuldades interpessoais.

O terceiro estágio aborda a psicopatologia central dos TAs. É explicado ao paciente que, enquanto a maioria das pessoas se autoavalia com base no desempenho autopercebido em uma variedade de domínios da vida, indivíduos com TAs se julgam de maneira excessiva, ou mesmo exclusiva,

em termos de seu formato e de sua capacidade para se manter magros. Esses aspectos estão intrinsecamente associados à autoestima e são utilizados como indicadores de sucesso, competência, superioridade e valor pessoal. Em alguns casos, além das ideias supervalorizadas citadas, há também a hipervalorização da capacidade de controlar o comportamento alimentar em si, que passa a ser utilizado como um indicador de autocontrole na vida de modo geral. Para ajudar os pacientes a modificar seu sistema de crenças, a TCC utiliza diversas estratégias. Por exemplo, os indivíduos podem ser incentivados a criar um gráfico no “formato de pizza”, com o tamanho de cada fatia representando o grau de importância atribuído a cada aspecto de sua vida e o grau de investimento que, na prática, eles fazem em cada um dos diferentes fatores identificados. Ao fim da tarefa, aspectos associados ao peso, ao formato corporal, à alimentação e à capacidade para controlá-los representarão as maiores fatias do gráfico. Em seguida, os pacientes devem ser ajudados a analisar os efeitos de seu padrão de investimento atual em sua qualidade de vida. Algumas linhas de questionamento podem ser: “Na prática, quais foram os ganhos efetivamente obtidos após o desenvolvimento do TA? O paciente atingiu alguma meta de vida? Em contrapartida, há desvantagens em manter a atual preocupação com a perda de peso e os padrões de comportamento associados? O modo como o paciente divide o investimento nos diferentes aspectos de vida trouxe algum tipo de efeito negativo?”. Além de avaliar os resultados obtidos até o momento, o indivíduo deve analisar quais seriam as consequências no longo prazo de manter os atuais padrões de comportamento. Por exemplo, em 10 anos, como será seu padrão de vida se ele persistir com os hábitos atuais?

Essas linhas de análise objetivam identificar as principais consequências adversas da supervalorização do peso e de seu controle. Uma avaliação aprofundada conduz o paciente a concluir que, com exceção de uma sensação de vitória por ter obtido perda de peso (no caso dos pacientes com AN), os demais aspectos de sua vida estão bastante comprometidos: isolamento social, sofrimento associado à utilização dos métodos compensatórios, pensamentos obsessivos sobre alimentação, frequentes sentimentos de estar gordo, além de uma contínua insatisfação com a imagem corporal (apesar da

redução do peso). Uma vez que os pacientes tenham avaliado as implicações negativas de manter os antigos padrões de comportamento, é importante ajudá-los a reduzir o tamanho da fatia da pizza associada à forma e ao peso corporais, aumentando a importância de outros domínios para a autoavaliação e o grau de investimento em outros aspectos da vida.

Para diminuir a frequência dos ECAs, o terceiro estágio aprofunda a discussão da inter-relação dos ECAs com os métodos compensatórios. De modo geral, o uso dos métodos compensatórios favorece a ocorrência dos ECAs, uma vez que os pacientes pensam que irão neutralizar a perda de peso por meio do uso de dietas muito restritivas, exercícios e/ou métodos purgativos. Por exemplo, é explicado aos participantes que a indução de vômito aumenta a probabilidade de ocorrência dos ECAs por meio do pensamento: “Já que vou vomitar, posso comer tudo que eu quiser sem engordar”. Para incentivar a redução da indução de vômito, pode ser útil explicar que o vômito não elimina todo o alimento ingerido durante o ECA e, portanto, não impede completamente o ganho de peso. Com relação aos laxantes e diuréticos, deve ser explicado que eles também são métodos ineficazes de emagrecimento, uma vez que não impedem a absorção das calorias ingeridas durante o ECA, causando apenas perda temporária de líquidos. Ademais, são enumerados os problemas clínicos decorrentes do uso de cada método compensatório. Após a psicoeducação, os pacientes são orientados a reduzir gradualmente o uso dos métodos compensatórios.

Outro aspecto que pode estar associado aos ECAs e aos métodos compensatórios é a intolerância a humores intensos. Alguns pacientes são extremamente sensíveis a certos estados de humor e têm dificuldade para tolerá-los, ou experimentam estados de humor incomumente intensos. Os ECAs e/ou métodos compensatórios se tornam formas de lidar com esses humores, reduzindo a consciência deles ou neutralizando-os. Para abordar aspectos associados à intolerância ao humor, a TCC-A inclui psicoeducação sobre o humor: o humor intenso faz parte da experiência humana normal; os humores raramente persistem por muito tempo, e nem sempre requerem uma reação – eles podem ser apenas aceitos e tolerados.

Outra estratégia utilizada pela TCC-A para ensinar os pacientes a tolerar humores aversivos envolve solicitar que eles aprendam a “surfar no humor”, observando-o aumentar e diminuir. Ao fazer isso, os pacientes podem reestruturar a crença de que os humores aversivos sempre pioram quando não se faz nada para reduzi-los. Nas situações em que o humor do momento é tão aversivo que o paciente não consegue “surfar”, os terapeutas devem ajudá-lo a identificar e implementar métodos funcionais de mudança de humor, como, por exemplo, técnicas de relaxamento. Os pacientes podem também aprender o treinamento em resolução de problemas, com o objetivo de desenvolver a capacidade para lidar com problemas de modo geral, diminuindo as fontes de estresse que atuam como gatilho para a ocorrência dos ECAs. Nesse caso, eles são treinados a identificar os problemas assim que surgem, considerar diversas possíveis soluções, avaliar a melhor solução, implementar a solução escolhida e avaliar os resultados obtidos.

No terceiro estágio do protocolo de TCC-A, são também abordadas questões relacionadas à imagem corporal. Alguns indivíduos com TAs checam seu corpo repetidamente: apalpam seus braços, ombros ou clavículas para checar se conseguem sentir seus ossos; medem partes do corpo com fita métrica; entre outros comportamentos. Nesses casos, é importante explicar aos pacientes que o exame minucioso do corpo, geralmente, envolve o estudo repetido apenas dos aspectos da aparência que são aversivos para eles, o que tende a fazê-los magnificar supostos defeitos. Portanto, essa avaliação tendenciosa tende a manter a insatisfação corporal, além de manter o foco nas preocupações com a própria aparência. Após a identificação dos padrões de verificação corporal de cada paciente, é organizada uma hierarquia de exposição corporal, e ele é incentivado a reduzi-la gradualmente.

O quarto estágio é a etapa final do tratamento, e o foco muda para o futuro, com o objetivo de diminuir o risco de recaída. É elaborado um plano por escrito que inclui as técnicas que foram mais úteis para cada paciente, os “gatilhos” potenciais para recaída e uma lista detalhada de estratégias a serem utilizadas no caso de ocorrer uma situação de risco.

O protocolo de TCC-A inclui 17 sessões em grupo com duração de 90 minutos e mais três individuais, durante 21 semanas. Uma sessão individual

ocorre no início do tratamento com o objetivo de ajudar no engajamento do paciente e criar uma formulação personalizada. A seguinte ocorre no início do segundo estágio para revisar o progresso e avaliar as prioridades do tratamento para cada paciente, e a terceira ocorre no fim do tratamento, para planejar o futuro e evitar recaídas. Além disso, antes de cada sessão, os participantes são pesados pelo terapeuta e fazem uma breve revisão conjunta dos registros da alimentação e condições associadas (com duração de 10 minutos). Os encontros do grupo começam com a especificação dos temas que serão abordados, e, ao término da sessão, tarefas de casa individuais são delineadas de acordo com as dificuldades relatadas pelos pacientes. As sessões em grupo ocorrem semanalmente até as duas últimas, quando passam a ser quinzenais (Fairburn, 2008).

TRATAMENTO DA IMAGEM CORPORAL NA ANOREXIA NERVOSA

O BodyWise é um programa de grupo que aborda questões associadas à imagem corporal de pacientes com AN. Uma das metas principais do grupo é aumentar o nível de consciência das distorções do processamento cognitivo associadas à avaliação da imagem corporal. O programa inclui diversas estratégias para trabalhar raciocínio emocional, leitura de pensamento, pensamento “tudo ou nada”, comparações com terceiros (sempre usando padrões duplos de avaliação que desvalorizam a aparência do paciente) e magnificação. O programa de grupo é composto por oito sessões, com dois terapeutas, e normalmente inclui oito pacientes com AN por grupo (Mountford et al., 2015). Os principais temas discutidos em cada sessão são descritos no Quadro 8.2.

Quadro 8.2 Descrição das sessões na intervenção BodyWise para TAs

Nº da sessão	Temas
1ª sessão	• Explica os objetivos e os limites do grupo. • Analisa os fatores inclusos no conceito de imagem corporal. • Ajuda os pacientes a analisar quão precisas são suas percepções de seu corpo, o grau de importância atribuído à opinião de terceiros sobre sua aparência corporal, a quantidade de tempo investida em cuidar do corpo, o grau de importância do corpo para a autoavaliação e a autoestima e o impacto da imagem corporal na sexualidade.

	• Lista todos os aspectos em que a imagem corporal afeta a vida de cada paciente em termos de padrões de raciocínio, emoções, comportamentos associados e consequências sociais. • Analisa o padrão normal de relação com a imagem corporal e a importância de se caminhar nesse sentido.
2ª sessão	• Reflete sobre a diferença entre peso normal e peso não saudável. • Realiza vários exercícios para ilustrar a grande variedade de pesos e formatos existentes, com base na curva normal, para auxiliar os pacientes a se posicionar dentro do contínuo normal de peso. • Discute o pensamento “tudo ou nada” que os participantes com AN normalmente aplicam ao peso e ao formato.
3ª sessão	• Objetiva desenvolver nos pacientes uma visão crítica das imagens veiculadas pela mídia e discutir os efeitos delas sobre os ideais corporais. São apresentadas fotografias mostrando o modo como a imagem corporal mudou ao longo dos anos e o modo como os ideais de magreza se tornaram irrealísticos. Por exemplo, as modelos atuais frequentemente apresentam corpos que estão mais do que 20% abaixo do peso mínimo ideal. Também são estudados os modos como as imagens do corpo são modificadas digitalmente, além de como as modelos se parecem antes e depois do uso de maquiagem. No fim, é analisado o custo-benefício de manter um ideal irrealista de corpo em contraposição a manter um peso normal.
4ª sessão	• Explora o significado que os pacientes imprimem a “sentir-se gordo” e os encoraja a considerar significados alternativos. É explicada a diferença entre “sentir-se gordo” e <i>pensar</i> que está gordo. • É discutido que a impressão de estar gordo pode estar relacionada com diferentes estados fisiológicos (p. ex., estar com o estômago cheio) ou que ela pode ser um modo de descrever emoções negativas, quando temos dificuldades de expressá-las ou descrevê-las com outras palavras. • Os pacientes são treinados a identificar diferentes potenciais sentidos para a frase “sinto-me gordo” e iniciam treinamento para identificar pensamentos, sentimentos e comportamentos que poderiam anteriormente ser interpretados como “sentir-se gordo”. A partir desta sessão, os pacientes passam a treinar a identificação dos “gatilhos” para a ocorrência da sensação de estar gordo.
5ª sessão	• Analisa a ideia de que há distorção no modo como os pacientes percebem seu corpo. A “percepção do corpo” seria o resultado de uma representação fisiológica dele, somada à interpretação pessoal do que está sendo visto, a qual é baseada em experiências passadas e preconceitos. Para validar a ideia de que expectativas podem direcionar nossa percepção de modo a reafirmar ideias prévias, os autores exemplificam com ilusões de ótica, como a de Ebbinghaus (Roberts, Harris, & Yates, 2005) ou a do tabuleiro de damas (Adelson, 2005). • Discute alguns fatores que podem fazer uma pessoa perceber seu corpo como maior ou menor: apresentar humor negativo, comer alimentos de alta densidade energética, folhear revistas focando apenas nas imagens de corpos magros, entre outros. Por fim, são discutidas estratégias para lidar com essas situações.
6ª sessão	• Concentra-se em estudar a relação entre imagem corporal e identidade. Muitas vezes, o baixo peso e a AN já se tornaram tão intrinsecamente associados à identidade que é difícil para os pacientes se imaginarem sem TA. • Os pacientes são incentivados a pensar sobre suas características pessoais, independentemente do formato de seus corpos. Um dos exercícios consiste em fazer o grupo pensar junto em todos os aspectos que podem compor a identidade de uma pessoa, como, por exemplo, sexo, cultura, religião, lazer, etc. Em seguida, cada indivíduo desenha um gráfico de torta no qual distribui a relevância de cada um dos aspectos citados de acordo com o tempo e energia gastos com eles. Por último, cada paciente reorganiza as fatias do gráfico de modo que ele represente a dimensão que cada fatia deveria ter em uma vida mais equilibrada, de acordo com uma nova possível identidade que gostariam de desenvolver.
7ª sessão	• O objetivo é ajudar os pacientes a aumentar a aceitação do próprio corpo. Eles são incentivados a analisar quais aspectos valorizam em sua forma e tamanho corporais. • São também enfatizadas as consequências negativas do baixo peso, como sentir frio o tempo todo, ter olheiras, sentir desconforto ao sentar-se, etc. Em seguida, são explicitadas as melhoras de saúde que serão obtidas com o aumento de peso. Um último aspecto é ensinar os pacientes a apreciar as sensações agradáveis que cada parte do corpo pode proporcionar se estiver funcionando normalmente.
8ª sessão	• Revisa o progresso do grupo e as estratégias mais úteis, que devem ser mantidas e desenvolvidas.
Fonte: Adaptado de Mountford e colaboradores (2015).	

GRUPOS PARA AUMENTO DA MOTIVAÇÃO

Um aspecto importante a ser considerado no tratamento dos TAs é a grande resistência ao tratamento, principalmente das pacientes com AN, e as altas taxas de abandono. Revisões sobre terapia em grupo em TAs documentaram taxas de abandono que variaram entre 17 e 57% (Dean, Touyz, Rieger, & Thornton, 2007; Polnay et al., 2014). A baixa adesão ou recusa a se tratar pode ser exacerbada por abordagens terapêuticas que tentam reduzir comportamentos alimentares e outros sintomas disfuncionais em pacientes que não estão no estágio de prontidão para mudar (Dean et al., 2007). Abordagens terapêuticas primariamente orientadas para a ação, como a TCC, podem ser inadequadas para aqueles em estágios de pré-contemplação ou contemplação, quando ainda há muita ambivalência. Portanto, o estágio motivacional dos pacientes é um aspecto que deve ser analisado no início e ao longo dos grupos terapêuticos.

Pode ser adequado associar grupos para aumento de motivação aos protocolos habituais de tratamento. Dean e colaboradores (2007) desenvolveram uma intervenção em grupo especificamente destinada a trabalhar a motivação para o tratamento, abordando a ambivalência entre recuperação e manutenção do TA. As estratégias empregadas incluíram fomentar uma discussão centrada nas fases de mudança e realizar um exercício com a balança decisória, que analisa os benefícios e custos de manter ou melhorar o TA, com o objetivo de deslocar o equilíbrio no sentido da mudança. Outros temas discutidos incluíram o aumento do nível de consciência sobre a incompatibilidade entre os comportamentos alimentares disfuncionais e metas mais saudáveis de vida. Foram também explorados os fatores que levaram ao desenvolvimento do TA, sua história, suas características atuais e possíveis consequências futuras (Miller & Rollnick, 2002).

A intervenção foi aplicada a pacientes internados com o objetivo primário de incentivá-los a se engajar no programa de TCC padrão do hospital. Portanto, ela atuou como uma ferramenta motivacional preliminar e simultânea ao programa de tratamento, com o terapeuta apoiando os pacientes no sentido de chegarem às suas próprias conclusões focadas na mudança. Foram desenvolvidas quatro sessões em grupo, uma vez por

semana, com duração de 1 hora e meia cada. Os grupos foram abertos, com novos participantes entrando a cada semana, assim que ingressavam no hospital. Dean e colaboradores (2007) relataram que os pacientes submetidos à intervenção apresentaram aumento da motivação e maior engajamento no tratamento.

ABORDAGENS E INTERVENÇÕES BASEADAS EM *MINDFULNESS*

A maioria dos tratamentos para TAs e obesidade empiricamente praticados e amplamente pesquisados é baseada em procedimentos cognitivo-comportamentais, em função dos bons resultados obtidos com os atuais modelos de tratamento (Neufeld et al., 2014). Entretanto, Wilson (1996) levantou questionamentos acerca da magnitude da eficácia clínica da TCC, uma vez que os estudos relataram remissão total dos sintomas em cerca de 50% dos pacientes tratados, estando a metade restante em melhora parcial ou sem resposta ao tratamento (Fairburn, Marcus, & Wilson, 1993). Com o objetivo de ampliar a eficácia dos protocolos de TCC, novas técnicas passaram a ser incorporadas no tratamento em grupo, como, por exemplo, as técnicas de *mindfulness*. De modo geral, *mindfulness* é um processo definido por dois componentes centrais: a atenção para as experiências do momento presente e a aceitação delas (Cebolla, García-Campayo, & Demarzo, 2014). Portanto, intervenções baseadas em *mindfulness* trabalham na construção de um estado de atenção focado no presente que enfatiza a observação e a experimentação, em vez de a avaliação e a mudança de experiências. Entre os protocolos de intervenção de grupo baseados em *mindfulness* estão, por exemplo, a MB-EAT, ou *Mindful eating* (Kristeller & Hallett, 1999; Kristeller et al., 2006; Kristeller & Wolever, 2011; Wolever & Best, 2009), a terapia cognitiva baseada em *mindfulness* (TCBM) (Segal, Williams, & Teasdale, 2002) e a terapia focada na compaixão (TFC) (Gilbert, 2005).

O programa MB-EAT treina o aumento da consciência das experiências internas e dos padrões automáticos relacionados à alimentação, sem julgamento. Ele incorpora técnicas de meditação *mindfulness* tradicional (Kabat-Zinn, 1990) com práticas de meditação guiada que incentivam o aumento de atenção aos sentidos que se associam aos gatilhos da fome física

e da saciedade. A consciência de sinais internos físicos promove o resgate de processos inatos de regulação do apetite (Schwartz, 1975), maior discernimento nas escolhas (Finlayson, Aiken, & Nakarada-Kordic, 2007), controle da impulsividade e regulação dos processos neuronais relacionados à motivação para a resposta (Appelhans, 2009). Os participantes desenvolvem seu paladar e alcançam a saciedade com pequenas quantidades de alimentos, ao ativarem seu sistema inato de autorregulação da fome, prejudicado pelo automatismo do comer compulsivo. No MB-EAT, treina-se também a autoaceitação, a autocompaixão e o autoperdão das questões que não podem ser modificadas ou que poderão ser apenas parcialmente modificadas, em contraposição aos padrões emocionais e cognitivos de autorrecriminação predominantes em alguns pacientes com TAs e obesidade (Kristeller, Wolever, & Sheets, 2013). A estrutura do programa introduz gradualmente os elementos da prática de meditação *mindfulness* (abordando o “desapego” dos estados internos da mente, principalmente das reações impulsivas), o *mindful eating* (para regulação da consciência em relação aos alimentos), a autoconsciência e a autoaceitação. Todos os exercícios propostos na sessão são seguidos de discussão em grupo. O programa é estruturado como mostra o Quadro 8.3.

Quadro 8.3 Descrição das sessões na intervenção MB-EAT para TAs e obesidade

Sessões presenciais	Práticas de <i>mindfulness</i> em casa
Sessão 1: Introdução do modelo de autorregulação; exercício da uva-passa; introdução à prática de <i>mindfulness</i> com meditação em grupo.	Semana 1: Práticas formais de 20 minutos diários, meditações guiadas com instruções completas.
Sessão 2: Breve prática de <i>mindfulness</i> (continua todas as sessões); exercício de comer consciente (queijo e biscoitos); conceito de comer consciente; escaneamento do corpo.	Semana 2: Práticas formais de 20 minutos diários, guiadas com instruções completas. Prática em casa: comer atentamente um lanche ou uma refeição por dia (repetir para todas as sessões, com o aumento do número de refeições/lanches a ser consumido conscientemente por dia).
Sessão 3: Tema: Alimentos-gatilho. Meditação com alimentos-gatilho; exercício de comer consciente (doces e alimentos ricos em gordura, como, por exemplo, <i>brownies</i>).	Práticas formais de 20 minutos diários, guiadas com instruções completas. Prática em casa: breve prática de <i>mindfulness</i> antes das refeições.
Sessão 4: Tema: Pistas de fome – fisiológica <i>versus</i> emocional. Meditação da fome; exercício de comer: escolhas alimentares conscientes (<i>cookies versus chips</i>)	Práticas formais de <i>mindfulness</i> , com instruções mínimas.
Sessão 5: Tema: Pistas de saciedade pelo paladar – definição de tipo e nível de pistas. Meditação saciedade pelo paladar; posição de ioga.	Práticas formais de <i>mindfulness</i> , com instruções mínimas. Prática em casa: observar o sabor e a satisfação/prazer.

Sessão 6: Tema: Pistas de plenitude – definição de tipo e nível de pistas. Meditação da plenitude; refeição livre.	Prática de comer consciente guiada. Prática em casa: parar de comer quando moderadamente satisfeito; comer em um <i>buffet</i> .
Sessão 7: Tema: Perdão. Meditação do perdão.	Prática formal de livre escolha e prática formal de comer consciente. Prática em casa: comer todas as refeições e lanches conscientemente.
Sessão 8: Tema: Sabedoria interior. Meditação da sabedoria; meditação caminhando.	Prática formal de livre escolha (com ou sem áudio) ou prática formal de comer consciente. Prática em casa: comer todas as refeições e lanches conscientemente.
Sessão 9: Tema: Os outros já notaram? Para onde você irá a partir daqui? Manutenção e prevenção de recaída; refeição livre comemorativa.	Prática formal de livre escolha (com ou sem áudio) ou prática formal de comer conscientemente.
Sessões de seguimento: prática de meditação; avaliação dos progressos realizados; outras abordagens do controle de peso.	
Fonte: Adaptado de Kristeller e Wolever (2011).	

A TCBM foi desenvolvida em 2002 por Segal e colaboradores para depressão recorrente. Ela se baseia na integração da TCC para a depressão (Beck, Rush, Shaw, & Emery, 1979) com o programa de redução de estresse baseado em *mindfulness* desenvolvido por Kabat-Zinn (1990). A TCBM inclui uma variedade de práticas de *mindfulness* cujo foco é a observação, o aumento da consciência e a autoaceitação de estados mentais, como sensações corporais, emoções, impulsos, percepções e cognições. De acordo com o modelo, esses estados devem ser aceitos sem julgamento ou reação, uma vez que seriam a natureza própria da mente. Não há ênfase em estratégias estruturadas para promover alteração do conteúdo dos pensamentos (Kristeller et al., 2006; Kuyken, Padesky, & Dudley, 2010).

Baer, Fischer e Huss (2005b) desenvolveram uma adaptação da TCBM para TAs e obesidade com base em formulações teóricas que associavam os ECAs à redução de estados de humor aversivos. Essas formulações partem do pressuposto de que, em pacientes perfeccionistas e com ruminações, os ECAs levariam a um estreitamento do foco de atenção ao alimento, reduzindo a consciência do estado de humor negativo por meio do uso de substâncias, dissociação ou compulsão alimentar (Heatherton & Baumeister, 1991; Kristeller et al., 2006; Leahy, 2002). Por sua vez, a participação na TCBM deve incentivar o aumento da capacidade de observar a fome e as pistas de saciedade, o que é feito nos grupos por meio do desenvolvimento das

habilidades de *mindfulness*. A aceitação não julgadora de experiências internas e externas, bem como de estados agradáveis e desagradáveis, é treinada no programa de grupo da TCBM para TAs e obesidade visando o alcance de maior disposição para experimentar o efeito negativo que essas condições provocam, bem como para uma consideração dos pensamentos negativos apenas como eventos mentais que, da mesma forma que entram no campo da consciência, também desaparecem. Da mesma maneira, as habilidades de *mindfulness* desenvolvidas no programa aumentam a capacidade de escolher comportamentos adaptativos em circunstâncias estressantes. O objetivo final do programa é ajudar os indivíduos a estabelecer uma mudança em sua relação com seus pensamentos, sentimentos e sensações corporais (Heatherton & Baumeister, 1991; Kristeller et al., 2006; Kuyken et al., 2010). Outro aspecto considerado importante é que eles adotem uma perspectiva mais ampla de seus estados mentais, reconhecendo-os como apenas sensações e impressões, sem identificar-se com eles ou reconhecê-los como reflexo de avaliações precisas da realidade (Kuyken et al., 2010; Segal, Williams, & Teasdale, 2012; Teasdale, 1997).

A TFC foi desenvolvida por Gilbert como uma abordagem de tratamento transdiagnóstica, que visa à construção de autocompaixão e à redução do sentimento de vergonha e autocrítico (Gilbert, 2005, 2009). Para Gilbert (2009), dois problemas decorrem do autocrítico: o conteúdo negativo dos pensamentos e o tipo/intensidade das emoções dirigidas ao eu, somados à falha de um sistema autotranquilizador. Diante desse quadro, ele norteou o foco das pesquisas da TFC para a relação entre os pensamentos alternativos dos pacientes e os sentimentos de decepção, hostilidade, desprezo ou desistência, seguidos de suas intervenções experimentais de tons emocionais favoráveis e úteis para os pensamentos alternativos, novos comportamentos de enfrentamento e experiências de exposição, buscando criar uma voz interior calorosa e amorosa e sentir o impacto desse tipo de voz (Gilbert, 2009). Como resultado, Gilbert (2005) observou a associação de estados de vergonha e autocrítico a desconforto e resistência. Dessa forma, ele procurou incorporar à prática da TCC técnicas de cultivo à atitude de autobondade para indivíduos com altos níveis de vergonha e autocrítico.

Na mesma direção, Neff demonstrou que a autocompaixão pode promover mais bem-estar do que a autoestima (Neff & Vonk, 2009), consistindo em forte apoio para lidar com o fracasso (Neff, Hsieh, & Dejitterat, 2005). Em conjunto com os estudos de Germer (2009), esses autores apontam a destrutividade do autocriticismo e do autojulgamento, relacionando-os a psicopatologia e restrição psicológica. As evidências de suas pesquisas apontam que a autocompaixão, por meio de estratégias de práticas formais de *mindfulness* (p. ex., bondade amorosa e respiração carinhosa), bem como práticas informais para uso na vida diária (p. ex., autotoque calmante e escrita de carta autocompassiva), são capazes de reduzir significativamente os sintomas psicopatológicos e o sofrimento (Germer & Neff, 2013).

No âmbito dos TAs, Goss e Gilbert (2002) propuseram que o sentimento de vergonha poderia estar subjacente à restrição alimentar, aos ECAs e aos métodos purgativos. Na linha do modelo proposto pela TFC, eles sugerem que, a curto prazo, os comportamentos típicos dos TAs podem promover redução de desconforto, mas, a médio e longo prazos, intensificam o sofrimento, principalmente por não modificarem a crença de que se é diferente, inadequado, descontrolado, com defeito ou repugnante. De acordo com o modelo da TFC, o desenvolvimento da autocompaixão é a única forma de os pacientes com TAs romperem com esses ciclos não adaptativos e prevenirem a recaída (Gale, Gilbert, Read, & Goss, 2014; Kelly, Carter, Zuroff, & Borairi, 2013). O protocolo é apresentado no Quadro 8.4.

Quadro 8.4 Descrição das sessões de intervenção da TFC para TAs e obesidade

Sessão	Descrição
1 Descobrimo <i>mindfulness</i> e autocompaixão	Os participantes são introduzidos no programa com um exercício contemplativo, no qual os membros do grupo notam a diferença entre a forma como eles tratam um ente querido e como eles tratam a si mesmos quando as coisas dão errado em suas vidas. Em seguida, são ensinados os três componentes da autocompaixão: autobondade <i>versus</i> autojulgamento, humanidade compartilhada <i>versus</i> isolamento e <i>mindfulness</i> <i>versus</i> superidentificação.
2 Praticando <i>mindfulness</i>	Introdução teórica e prática de <i>mindfulness</i> e seus efeitos psicofisiológicos subjacentes.
3 Praticando meditação da bondade amorosa	Nesta sessão, os participantes aprendem a meditação bondade amorosa, repetindo frases como “Posso estar seguro” ou “Posso ser gentil comigo mesmo”, tanto nas práticas formais como nas informais de <i>mindfulness</i> .

4 Encontrando a voz compassiva	A principal lição da quarta sessão é a expansão das frases de bondade amorosa para a condição de uma conversa natural com uma parte compassiva interna, bem como da distinção entre o autocompassivo e o crítico interno.
5 Vivendo profunda e intensamente	Esta sessão é uma exploração de valores fundamentais que trazem significado para a vida dos membros do grupo. Parte-se do pressuposto de que o indivíduo só pode ser gentil e receptivo consigo de uma maneira profunda se conhece o que realmente é importante para si. É investigado também o modo como a autocompaixão pode ajudar a recuperação desses valores fundamentais.
6 Gerenciando emoções difíceis	Trabalho de aceitação <i>versus</i> luta contra as emoções difíceis de lidar.
7 Transformando relações	Os exercícios desta sessão visam à transformação da dor em relacionamentos, seja a dor empática com os outros que estão sofrendo, seja a dor da desconexão.
8 Abraçando sua vida	Esta sessão final aborda o viés da negatividade humana. Os exercícios trabalham a capacidade do indivíduo de desfrutar intencionalmente das coisas boas da vida e de suas qualidades, o que pode libertá-lo do viés da negatividade, fazendo-o aproveitar a vida mais plenamente.

Fonte: Adaptado de Germer e Neff (2013).

EVIDÊNCIAS DE TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

Há escassez de publicações que enfoquem os resultados da TCCG aplicada à obesidade. Além disso, vários estudos incluem também obesos com TCA, o que dificulta a caracterização dos resultados desse tipo de intervenção. Entretanto, alguns trabalhos relataram redução de peso após a aplicação da TCCG (Neufeld, Moreira, & Xavier, 2012; Renjilian et al., 2001; Wilfley et al., 2002). Os programas de Bieling e colaboradores (2008) voltados para TCA e obesidade são os mais destacados (Neufeld et al., 2016). Contudo, eles não apresentam descrição das sessões, o que torna difícil a replicação dos programas em outros contextos, essencial para que diferentes populações possam ter acesso a protocolos eficazes de tratamento em TCCG (Neufeld, 2011). Preenchendo a lacuna de falta de descrição dos protocolos utilizados, os estudos relatados por Neufeld e colaboradores (2012) e Neufeld e colaboradores (2016) acerca de um programa de TCCG associado a

orientações nutricionais descreveram detalhadamente as sessões de tratamento. Ao fim da TCCG, houve redução estatisticamente significativa do peso das participantes e melhora nas dificuldades interpessoais, no grau de adaptação social, na autoestima, nos níveis de ansiedade, no sentimento de bemestar e na compulsão alimentar.

INTERVENÇÕES BASEADAS EM *MINDFULNESS*

Wanden-Berghe, Sanz-Valero e Wanden-Berghe (2011) publicaram uma revisão sistemática sobre a aplicação de tratamentos baseados em *mindfulness* para os TAs, encontrando 30 artigos sobre o tema, mas incluindo apenas oito. Os autores concluíram que as intervenções baseadas em *mindfulness* para TAs podem ser efetivas. Outra revisão sistemática com metanálise sobre as intervenções baseadas em *mindfulness* para compulsão alimentar foi publicada por Godfrey, Gallo e Afari (2015). Os autores encontraram 151 estudos e elegeram para análise 19 deles, entre ensaios clínicos randomizados e estudos publicados de 1999 a 2014. Concluíram que tais intervenções são associadas a efeitos terapêuticos de magnitude grande a moderada.

Um dos primeiros trabalhos de intervenções MB-EAT, ou *mindful eating*, foi realizado por Kristeller e Hallett em 1999, um estudo não randomizado com um grupo de sete sessões, com 18 mulheres obesas que preenchiam os critérios para TCA. As autoras relataram que o melhor preditor para a melhora no controle alimentar nesse grupo foi o aumento do tempo gasto para as práticas meditativas durante a refeição. Os resultados foram de controle significativo das compulsões (reduzindo de mais de 4 para 1,5 por semana) e diminuição substancial da quantidade de alimentos consumidos durante hiperfagia. Na linha desse estudo, Kristeller e Wolever (2011) realizaram um ensaio clínico randomizado com 85 indivíduos obesos, comparando MB-EAT de nove sessões, um tratamento psicoeducacional para obesidade com base no programa Duke Diet and Fitness Center e um grupo-controle de lista de espera. Além dos pilares do MB-EAT, outros temas das intervenções baseadas em *mindfulness* foram inseridos: não julgamento, compaixão e autoaceitação. Os resultados mostraram melhoras nos sintomas e internalização de mudanças tanto no grupo de MB-EAT quanto no

psicoeducacional, mas maiores no primeiro grupo. Outros indicadores (depressão, autorregulação e perda de peso) também apresentaram melhora significativa. Kristeller e colaboradores (2013) realizaram um ensaio clínico randomizado de MB-EAT, em grupo com 12 sessões, em comparação a uma intervenção em TCC e um grupo de lista de espera. O estudo envolveu 150 indivíduos com sobrepeso ou obesos, entre os quais 66% com transtorno de compulsão alimentar periódica (DSM-IV). Os resultados mostraram que tanto o grupo submetido à intervenção MB-EAT quanto o da TCC apresentaram melhora nos sintomas de compulsão alimentar, em comparação ao grupo-controle. No *follow-up*, foi observado que 95% dos indivíduos do grupo MB-EAT e 76% dos participantes do grupo TCC não preencheram os critérios para TCA. Redução significativa de peso e diminuição das hiperfagias também foram observadas em ambos os grupos. Além disso, houve melhoras nos níveis de indicadores de depressão. Os resultados sugerem que a MB-EAT diminuiu compulsão alimentar e sintomas relacionados a um nível clinicamente significativo. Em outro estudo, Kristeller e colaboradores (2013) pesquisou uma amostra clínica e uma subclínica do TCA (DSM-IV) em um tratamento de 10 sessões, com duas sessões de acompanhamento. Além dos pilares do MB-EAT, denominados “sabedoria interna”, de fome, saciedade e escolha consciente, regulação dos comportamentos alimentares sem um sentido de luta ou de autorrecriinação, a pesquisa inseriu outros relacionados a orientações calóricas e nutricionais, denominados “sabedoria externa”. Os resultados mostraram que os pacientes com TCA obtiveram índices de melhora comparáveis àqueles sem TCA, além da melhora em outros indicadores (depressão, autorregulação e perda de peso).

Em um estudo de caso da TCBM, Baeret e colaboradores (2005b) relataram uma cessação completa das hiperfagias e grande redução da preocupação com alimentação, forma e peso, bem como aumento da consciência plena. Em um estudo-piloto não controlado subsequente com seis participantes, Baer e colaboradores (2005a) também relataram redução significativa da compulsão alimentar.

A Tabela 8.1 apresenta uma síntese das intervenções em TCCG em pacientes obesos.

Tabela 8.1 Intervenções de TCCG para pacientes com obesidade e compulsão alimentar

Intervenção	Autores	Obesidade e/ou compulsão alimentar	Nº de sessões	Temas abordados
Terapia cognitivo-comportamental de grupo (TCCG)	Bieling e colaboradores (2008)	Transtorno de compulsão alimentar	Sem descrição das sessões	Sem descrição das sessões
Terapia cognitivo-comportamental de grupo (TCCG)	Cooper e colaboradores (2009)	Obesidade	10 sessões	Automonitoramento, técnicas para administrar as barreiras para o emagrecimento, estratégias de aumento da atividade física, redução da preocupação com a imagem corporal, aumento da alimentação saudável e manutenção da perda de peso
Terapia cognitivo-comportamental de grupo (TCCG)	Radomile (2003)	Obesidade	Sem descrição das sessões	Sem descrição das sessões
Terapia cognitivo-comportamental de grupo (TCCG)	Neufeld e colaboradores (2012) Neufeld e colaboradores (2016)	Obesidade	12 sessões, mais sessões de encorajamento	Automonitoramento, pesagem semanal, psicoeducação sobre peso e alimentação, prescrição de padrão alimentar regular e estratégias de autocontrole, treino de habilidades de resolução de problemas, reestruturação cognitiva, estratégias comportamentais e de prevenção de recaídas
Terapia cognitivo-comportamental de grupo (TCCG)	Duchesne e colaboradores (2007)	Transtorno de compulsão alimentar	19 sessões	Psicoeducação, automonitoramento, pesagem semanal, estratégias para controle de estímulos, prescrição de padrão regular de alimentação, treinamento em resolução de problemas, reestruturação cognitiva e estratégias para prevenção de recaídas
Programa psicoeducacional baseado no programa Duke Diet and Fitness Center/MB-EAT	Kristeller e Wolever (2011)	Obesidade	9 sessões	Não julgamento, compaixão e autoaceitação
<i>Mindfulness-Based Eating Awareness Training</i> (MB-EAT) ou <i>Mindful eating</i>	Kristeller e Hallett (1999) Kristeller e colaboradores (2013) Kristeller e colaboradores (2013)	Transtorno de compulsão alimentar	7 sessões 10 sessões 12 sessões	“Sabedoria interna” relacionada à autopercepção de fome, saciedade e escolha consciente; regulação dos comportamentos alimentares sem um sentido de luta ou de autorrecriminação; além de orientações nutricionais denominadas “sabedoria externa”
<i>Mindfulness-Based Eating Awareness Training</i> (MB-EAT) ou <i>Mindful eating</i>	Kristeller e Hallett (1999); Kristeller e colaboradores (2006); Kristeller e Wolever (2011)	Transtorno de compulsão alimentar e obesidade	9 sessões	Modelos de regulação da ingestão de alimentos que enfatizam a interação de processos de controle psicológicos e fisiológicos, a teoria da autorregulação (Schwartz, 1975), modelos neurocognitivos e terapêuticos da meditação <i>mindfulness</i> (Goleman, 1988; Kristeller, 2007; Siegel, 2007)
Terapia cognitivo-comportamental	Baer e colaboradores	Transtornos alimentares	Sem descrição das sessões	Aumento da capacidade de observar a fome e as pistas de saciedade, por meio do desenvolvimento das habilidades de

baseada em <i>mindfulness</i> (TCBM)	(2005)	e obesidade		<i>mindfulness</i> . A aceitação de experiências internas e externas e de estados agradáveis e desagradáveis de forma não julgadora é treinada no programa de grupo da TCBM para transtornos alimentares e obesidade para o alcance de maior disposição para experimentar o efeito negativo que essas condições provocam, bem como para uma consideração dos pensamentos negativos apenas como eventos mentais que, da mesma forma que entram no campo da consciência, também desaparecem.
Terapia focada na compaixão (TFC) (<i>Compassion Focused Therapy</i>)	Goss e Gilbert (2002) Germer e Neff (2013)	Transtornos alimentares e obesidade	8 sessões	Desenvolvimento da autocompaixão como forma de rompimento com os ciclos não adaptativos de vergonha (subjacente aos sintomas de comer restritivo, compulsão e purgação como tentativas de autoproteção para regular tal sentimento) e prevenção de recaída. Considera também a validação de sentimentos de inferioridade e vergonha por parte do terapeuta como forma de consolidar as bases para a formação da mente compassiva do paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A TCC é o modelo de psicoterapia mais bem estabelecido para o tratamento individual dos TAs, com diversos estudos documentando sua eficácia (National Institute for Health and Care Excellence, 2004). Além disso, revisões sistemáticas e metanálises que analisaram ensaios clínicos randomizados controlados relataram bons resultados com a TCCG, tendo sido descrita melhora dos sintomas característicos dos TAs e da obesidade, além de melhora no grau de ajustamento social e autoestima (Hay, Bacaltchuk, & Stefano, 2009; Polnay et al., 2014). Revisões sistemáticas que analisaram os efeitos dos protocolos que incluíram estratégias de *mindfulness* também relataram melhora dos sintomas dos TAs (Godfrey et al., 2015; Wanden-Berghe et al., 2011).

Entretanto, mais pesquisas são necessárias para melhor comparar os resultados de tratamento na modalidade individual ou em grupo, incluindo uma melhor definição de quais são os bons candidatos para cada modalidade e quais temas são mais bem tratados em grupo, individualmente ou em programas mistos. Outro aspecto a ser considerado é a necessidade de avaliação continuada da motivação do paciente e o uso de sessões de encorajamento ao longo do tratamento. Por último, é útil avaliar o grau de satisfação do paciente com a modalidade de tratamento ofertada, uma vez que

esse fator influencia no engajamento, além de proporcionar uma sensação de aliança com a equipe de tratamento (Mac Neil et al., 2016).

REFERÊNCIAS

- Adelson, E. H. (2005). *Checker shadow illusion*. Retrieved from http://web.mit.edu/persci/people/adelson/checkershadow_illusion.html
- American Psychiatric Association (APA). (2000). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-IV* (4th ed.). Washington, DC: APA.
- American Psychiatric Association (APA). (2014). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (5th ed.). Washington: Author.
- Appelhans, B. M. (2009). Neurobehavioral inhibition of reward-driven feeding: Implications for dieting and obesity. *Obesity*, 17(4), 640-647.
- Baer, R. A., Fischer, S., & Huss, D. B. (2005a). Mindfulness and acceptance in the treatment of disordered eating. *Journal of Rational-Emotive and Cognitive-Behavioral Therapy*, 23(4), 281-300.
- Baer, R. A., Fischer, S., & Huss, D. B. (2005b). Mindfulness-based cognitive therapy applied to binge eating: A case study. *Cognitive and Behavioral Practice*, 12(3), 351-358.
- Barlow, S. H., Burlingame, G. M., & Fuhriman, A. (2000). Therapeutic applications of groups: From Pratt's "thought control classes" to modern group psychotherapy. *Group Dynamics*, 4(1), 115-134.
- Beck, A. T., Rush, J. A., Shaw, B. F., & Emery, G. (1979). *Cognitive therapy for depression*. New York: Guilford Press.
- Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony M. M. (Orgs.) (2008). *Terapia cognitivo-comportamental em grupos*. Porto Alegre: Artmed.
- Bowers, W. A. (2001). Cognitive model of eating disorders. *Journal of Cognitive Psychotherapy*, 15(4), 331-340.
- Cebolla, A., García-Campayo, & J., Demarzo, M. (2014). *Mindfulness y ciencia*. Madrid: Alianza Editorial.
- Cooper, Z., Fairburn, C. G., & Hawker, D. M. (2009). *Terapia cognitivo-comportamental da obesidade: Manual do terapeuta*. São Paulo: Roca.
- Dean, H. Y., Touyz, S. W., Rieger, E., & Thornton, C. E. (2007). Group motivational enhancement therapy as an adjunct to inpatient treatment for eating disorders: a preliminary study. In J. O. Prochaska, & C. C. DiClemente (1992), *The transtheoretical model of change*. New York: Basic Books.
- Duchesne, M. (2001). O consenso latino-americano em obesidade. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 3(2), 19-24.
- Duchesne, M., Appolinário, J. C., Rangé, B. P., Freitas, S., Papelbaum, M., & Coutinho, W. (2007). Evidências sobre a terapia cognitivo-comportamental no tratamento de obesos com transtorno da compulsão alimentar periódica. *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, 29(1), 80-92.

- Fairburn, C. G. (2008). Enhanced cognitive behavior therapy: The core protocol. In C. G. Fairburn (Ed.), *Cognitive behavior therapy and eating disorders* (pp. 47-193). New York: Guilford Press.
- Fairburn, C. G., Cooper, Z., & Shafran, R. (2003). Cognitive behaviour therapy for eating disorders: A “transdiagnostic” theory and treatment. *Behaviour Research and Therapy*, 41(5), 509-528.
- Fairburn, C. G., Marcus, M. D., & Wilson, G. T. (1993). Cognitive-behavioral therapy for binge eating and bulimia nervosa: A comprehensive treatment manual. In C. G. Fairburn, & G. T. Wilson (Eds.), *Binge eating: Nature, assessment, and treatment*. New York: Guilford Press.
- Finlayson, M., Aiken, L. H., & Nakarada-Kordic, I. (2007). New Zealand nurses reports on hospital care: International comparisons. *Nursing Praxis in New Zealand*, 23(1), 17-28.
- Gale, C., Gilbert, P., Read, N., & Goss, K. (2014). An evaluation of the impact of introducing compassion focused therapy to a standard treatment programme for people with eating disorders. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 21(1), 1-12.
- Gamer, D. M., & Bemis, K. M. (1982). A cognitive-behavioral approach to anorexia nervosa. *Cognitive Therapy and Research*, 6(2), 123-150.
- Gamer, D., Garfinkel P., & O’Shaughnessy, M. (1985). The validity of the distinction between bulimia with and without anorexia nervosa. *American Journal of Psychiatry*, 142(5), 581-587.
- Germer, C. K. (2009). *The mindful path to self-compassion: Freeing yourself from destructive thoughts and emotions*. New York: Guilford Press.
- Germer, C. K., & Neff, K. D. (2013). Self-compassion in clinical practice. *Journal of Clinical Psychology: In Session*, 69(8), 856-867.
- Gilbert, P. (2005). *Compassion: Conceptualisations, research and use in psychotherapy*. London: Routledge.
- Gilbert, P. (2009). *The compassionate mind: A new approach to life’s challenges*. London: Constable & Robinson.
- Godfrey, K. M., Gallo, L. C., & Afari, N. (2015). Mindfulness-based interventions for binge eating: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Behavioral Medicine*, 38(2), 348-362.
- Goleman, D. J. (1988). *The meditative mind: The varieties of meditative experience*. New York: G.P. Putnam’s Sons.
- Gomes, M. B., Giannella Neto, D., Mendonça, E., Tambascia, M. A., Fonseca, R. M., Réa, R. R., ... Dib, S. A. (2006). Prevalência de sobrepeso e obesidade em pacientes com Diabetes Mellitus do Tipo 2 no Brasil: Estudo multicêntrico nacional. *Arquivos Brasileiros de Endocrinologia & Metabologia*, 50(1), 136-144.
- Goss, K., & Gilbert, P. (2002). Eating disorders, shame and pride: A cognitive-behavioral functional analysis. In P. Gilbert, & J. Miles (Eds.), *Body shame: Conceptualization, research and treatment* (pp. 2219-255). New York: Brunner-Routledge.
- Hay, P. J., Bacaltchuk, J., & Stefano, S. (2009). Psychotherapy for bulimia nervosa and bingeing. *The Cochrane Library*.
- Hayes, S. C., Wilson, K. G., Gifford, E. V., Foilette, V. M., & Strosahl, K. D. (1996). Emotional avoidance and behavioral disorders: A functional dimensional approach to and treatment. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 64(6), 1152-1168.

- Heatherton, T. F., & Baumeister, R. F. (1991). Binge eating as escape from self-awareness. *Psychological Bulletin*, 110(1), 86-108.
- Heffner, M., Sperry, J., Eifert, G. H., & Detweiler, M. (2002). Acceptance and commitment therapy in the treatment of an adolescent female with anorexia nervosa: A case example. *Cognitive and Behavioral Practice*, 9(3), 232-236.
- Kabat-Zinn, J. (1990). *Full catastrophe living*. New York: Delta.
- Kelly, A. C., Carter, J. C., Zuroff, D. C., & Borairi, S. (2013). Self-compassion and fear of selfcompassion interact to predict response to eating disorders treatment: A preliminar investigation. *Psychotherapy Research*, 23(3), 252-264.
- Kristeller, J. L. (2007). Mindfulness meditation. In P. Lehrer, R. Wookfolk, & W. E. Simes (Eds.), *Principles and practices of stress management* (3rd ed., pp. 393–427). New York: Guilford.
- Kristeller, J. L., & Hallett, C. B. (1999). An exploratory study of a meditation-based intervention for binge eating disorder. *Journal of Health Psychology*, 4(3), 357-363.
- Kristeller, J. L., & Wolever, R. Q. (2011). Mindfulness-based eating awareness training for treating binge eating disorder: The conceptual foundation. *Eating Disorders*, 19(1), 49-61.
- Kristeller, J. L., Baer, R. A., & Wolever, R. Q. (2006). Mindfulness-based approaches to eating disorders. In R. A. Baer (Ed.), *Mindfulness-based treatment approaches* (pp. 75-91). Oxford: Academic Press.
- Kristeller, J. L., Wolever, R. Q., & Sheets, V. (2013). Mindfulness-Based Eating Awareness Training (MB-EAT) for binge eating: A randomized clinical trial. *Mindfulness*, 19(1), 49-61.
- Kuyken, W., Padesky, C. A., & Dudley, R. (2010). *Conceituação de casos colaborativa: O trabalho em equipe com pacientes em terapia cognitivo-comportamental*. Porto Alegre: Artmed.
- Leahy, R. L. (2002). A model of emotional schemas. *Cognitive and Behavioral Practice*, 9(3), 177-190.
- Mac Neil, B. A., Leung, P., Nadkarni, P., Stubbs, L., & Singh, M. (2016). A pilot evaluation of group-based programming offered at a Canadian outpatient adult eating disorders clinic. *Evaluation and Program Planning*, 58, 35-41.
- Mariath, A. B., Grillo, L. P., Silva, R. O., Schmitz, P., Campos, I. C., Medina, J. R. P., & Kruger, R. M. (2007). Obesidade e fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis entre usuários de unidade de alimentação e nutrição. *Cadernos de Saúde Pública*, 23(4), 897-905.
- Miller, W. R., & Rollnick, S. (2002). What motivates people to change? In W. R. Miller, & S. Rollnick, *Motivational interviewing: preparing people for change* (2nd ed., pp. 15-25). New York: Guildford Press.
- Mountford, V. C., Brown, A., Bamfor, B., Saiedi, S., Morgan, J. F., & Lacey, J. H. (2015). BodyWise: Evaluating a body image group for patients with anorexia nervosa. *European Eating Disorders Review*, 23(1), 62-67.
- National Institute for Health and Care Excellence (2004). *Eating disorders: Core interventions in the treatment and management of anorexia nervosa, bulimia nervosa and related eating disorders*. Leicester: British Psychological Society.
- Neff, K. D., & Vonk, R. (2009). Self-compassion *versus* global self-esteem: Two different ways of relating to oneself. *Journal of Personality*, 77(1), 23-50.

- Neff, K. D., Hsieh, Y.-P., & DeJitterat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals and coping with academic failure. *Self and Identity*, 4(3), 263-287.
- Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B., Affonso, G., & Moreno, A. L. (2014). PRO-META: Programa cognitivo-comportamental de educação alimentar. In C. B. Neufeld, *Intervenções cognitivo-comportamentais com indivíduos e grupos*. Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Affonso, G., Bueno J., C. R., Pessa, R. P., & Rangé, B. P. (2016). Tratamento em TCC em grupo para obesidade e sobrepeso: Foco no manejo. In I. R. Finger, & M. S. Oliveira (Orgs.), *A prática da terapia cognitivo-comportamental nos transtornos alimentares e obesidade* (pp. 351-380). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., Moreira, C. A. M., & Xavier, G. S. (2012). Terapia cognitivo-comportamental em grupos de emagrecimento: O relato de uma experiência. *Psico*, 43(1), 93-100.
- Polnay, A., James, V. A., Hodges, L., Murray, G. D., Munro, C., & Lawrie, S. M. (2014). Group therapy for people with bulimia nervosa: Systematic review and meta-analysis. *Psychological Medicine*, 44(11), 2241-2254.
- Randomile, R. R. (2003). Obesidade. In J. R. White, & A. S. Freeman (Orgs.), *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para população e problemas específicos* (pp. 109-136). São Paulo: Roca.
- Renjilian, D. A., Perri, M. G., Nezu, A. M., McKelvey, W. F., Shermer, R. L. & Anton, S. D. (2001). Individual versus group therapy for obesity: Effects of matching participants to their treatment preferences. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(4), 717-721.
- Roberts, B., Harris, M. G., & Yates, T. A. (2005). The roles of inducer size and distance in the Ebbinghaus illusion (Titchener circles). *Perception*, 34(7), 847-856.
- Safer, D. L., Telch, C. F., & Agras, W. S. (2001). Dialectical behavior therapy for bulimia nervosa. *The American Journal of Psychiatry*, 158(4), 632-634.
- Schwartz, G. E. (1975). Biofeedback, self-regulation, and the patterning of physiological processes. *American Scientist*, 63(3), 314-324.
- Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2002). *New Mindfulness-based cognitive therapy: A new approach to preventing for depression relapse*. New York: Guilford Press.
- Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2012). *Mindfulness-based cognitive therapy for depression* (2nd ed.). New York: Guilford Press.
- Shafran, R., & Silva, P. (2003). Cognitive-behavioral models. In J. T. Treasure, U. Schmidt, & E. van Furth (Eds.), *Handbook of eating disorders* (2nd ed., pp. 121-138). West Sussex: Wiley.
- Siegal, D. J. (2007). Mindfulness training and neural integration: Differentiation of distinct streams of awareness and the cultivation of well-being. *Social Cognitive Affective Neuroscience*, 2(4), 259-263.
- Tchanturia, K., & Sparrow, K. (2015). An introduction to brief group psychotherapy in intensive care programmes for eating disorders: Gathering research evidence. In K. Tchanturia, & K. Sparrow, *Brief group psychotherapy for eating disorders: Inpatient protocols* (pp.1-23). London: Routledge.

Teasdale, J. D. (1997). The relationship between cognition and emotion: The mind-in-place in mood disorders. In D. M. Clark, & C. G. Fairbum (Eds.), *Science and practice of cognitive behaviour therapy* (pp. 67-93). Oxford: Oxford University Press.

Telch, C. F., Agras, W. S., & Linehan, M. M. (2001). Dialectical behavior therapy for binge eating disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 69(6), 1061-1065.

Wanden-Berghe, R. G., Sanz-Valero, J., & Wanden-Berghe, C. (2011). The application of mindfulness to eating disorders treatment: A systematic review. *Eating Disorders*, 19(1), 34-48.

Wilfley, D. E., Welch, R. R., Stein, R. I., Spurrell, E. B., Cohen, L. R., Saelens, B. E., ... Matt, G. E. (2002). A randomized comparison of group cognitive-behavioral therapy and group interpersonal psychotherapy for the treatment of overweight individuals with binge-eating disorder. *Archives of General Psychiatry*, 59(8), 713-721.

Wilson, G. T. (1996). Acceptance and change in the treatment of eating disorders and obesity. *Behavior Therapy*, 27(3), 417-439.

Wiser, S., & Telch, C. F. (1999). Dialectical behavior therapy for binge-eating disorder. *Journal of Clinical Psychology*, 55(6), 755-768.

Wolever, R. Q., & Best, J. L. (2009). Mindfulness-based approaches to eating disorders. In F. Didonna (Ed.), *Clinical handbook of mindfulness* (pp. 259-288). New York: Springer.

World Health Organization (WHO). (2010). *World health statistics 2010*. Geneva: WHO.

World Healthy Organization (WHO). (1998). *Obesity: Preventing and managing the global epidemic*. Geneva: WHO.

LEITURAS RECOMENDADAS

Eldredge, K. L., Stewart Agras, W., Arnow, B., Telch, C. F., Bell, S., Castonguay, L., & Marnell, M. (1997). The effects of extending cognitive-behavioral therapy for binge eating disorder among initial treatment nonresponders. *International Journal of Eating Disorders*, 21(4), 347-352.

Germer, C., & Siegel, R. (Eds.) (2012). *Wisdom and compassion in psychotherapy*. New York: Guilford Press.

Gormally, J., Rardin, D., Black, S. (1980). Correlates of successful response to a behavioral weight control clinic. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 27(2), 179-191.

Marcus, M. D., Wing, R. R., & Hopkins, J. (1988). Obese binge eaters: Affect, cognitions, and response to behavioral weight control. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(3), 433-439.

9



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA TRAUMA E SITUAÇÕES DE CRISE

**Marcelo Montagner Rigoli
Julia Luiza Schäfer
Christian Haag Kristensen**

Neste capítulo, iremos discorrer brevemente sobre o estudo do trauma e suas consequências como um fenômeno clínico. Em seguida, uma visão geral das intervenções já propostas para essa situação será também brevemente revisada. Por último, serão descritas com mais detalhes duas intervenções possíveis, sendo estas as mais suportadas pela literatura científica.

TRAUMA E ESTRESSORES

Apesar de a história da humanidade estar repleta de descrições de reações individuais a eventos traumáticos, definir o que constitui um evento desse tipo não é uma tarefa simples, e diversos debates já envolveram essa definição. Originada do grego *traûma*, que significa “ferida”, a palavra *trauma*, no contexto psicológico, se refere a *feridas psicológicas*. Embora diversas situações ambientais sejam capazes de provocar estresse e consequências psicológicas negativas, é importante fazer uma distinção entre eventos de vida estressores e eventos traumáticos (Margis, Picon, Cosner, & Silveira, 2003). A primeira proposta de definição de eventos traumáticos foi que estes, diferentemente de outros eventos, costumam envolver algum encontro com a morte ou ameaça física para si ou outras pessoas significativas para o indivíduo. Dessa forma, eventos traumáticos e estressores se distinguiriam em sua natureza e intensidade, sendo que os primeiros são eventos inesperados e incontroláveis dos quais não é possível escapar (Foa, Zinbarg, & Rothbaum, 1992). Eventos estressores de vida são aqueles que, embora possam dar origem a efeitos psicológicos, quando removidos ocasionam uma redução do quadro psicológico desencadeado. Já eventos traumáticos são aqueles que potencialmente produzem consequências psicológicas mesmo após o término do evento em si (Margis et al., 2003).

Nesse sentido, a quinta edição do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (American Psychiatric Association [APA], 2013) define como evento traumático qualquer situação de risco real, de ameaça de morte e ferimento, ou de violência sexual, vivenciada por indivíduos por meio de experiência direta, testemunho, conhecimento de tal experiência vivida por um familiar ou amigo próximo ou exposição repetida e extrema a detalhes aversivos de um evento, como no cumprimento de deveres profissionais (sem considerar a exposição midiática). Considerando definições semelhantes de eventos traumáticos, estudos epidemiológicos estimaram que entre 40 e 90% das pessoas passarão por, pelo menos, um evento traumático ao longo da vida (Sher, 2004).

A exposição a tais eventos pode resultar em uma série de efeitos adversos para a saúde e a qualidade de vida dos indivíduos, colocando-os em risco para o desenvolvimento de psicopatologias. Estima-se que 10% daqueles que

presenciaram eventos traumáticos desenvolvem algum quadro psiquiátrico (Breslau, 2009). Porém, nem todas as pessoas confrontadas por tais situações respondem a ela da mesma forma: enquanto algumas apresentam prejuízos no funcionamento por algum tempo e se recuperam gradual e naturalmente enfrentando as consequências da situação traumática de forma efetiva, outras apresentam sofrimento prolongado significativo (Boden et al., 2013; Ehlers & Clark, 2000). Entre os diversos desfechos negativos prolongados associados à vivência de situações traumáticas, o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) é o mais frequentemente estudado, ainda que outros transtornos psicológicos, como ansiedade, depressão e uso de substâncias, também sejam constantemente associados (Breslau, 2009).

De acordo com o DSM-5 (APA, 2013), o TEPT caracteriza-se como um quadro de perturbação e sofrimento intensos como resposta à exposição a um evento traumático (Critério A). Essa resposta pode se apresentar na forma de *revivência* persistente do evento, por meio de intrusão de memórias, de sonhos ou *flashbacks* recorrentes sobre ele (Critério B); de *evitação* persistente a estímulos como pensamentos, sentimentos e atividades associados ao evento traumático, ou que provoquem recordações dele (Critério C); de *alterações negativas na cognição e no humor* (Critério D); e de alterações marcadas por *excitabilidade aumentada e reatividade*, caracterizadas por sintomas de ansiedade, dificuldades para dormir e sobressaltos exagerados que não estavam presentes antes da experiência do trauma (Critério E). Cada um desses critérios compõe o que são considerados os *clusters* de sintomas presentes no TEPT, devendo causar sofrimento significativo e/ou prejuízo funcional (Critério G) por mais de um mês (Critério F) para que o diagnóstico seja realizado, sem que a perturbação existente pelos sintomas seja devida aos efeitos fisiológicos de uma substância (Critério H) (APA, 2013).

Apesar de estudos epidemiológicos de transtornos mentais em amostras brasileiras serem escassos, uma investigação realizada com o objetivo de estudar a relação entre eventos traumáticos e a prevalência de transtornos mentais nas cidades de São Paulo e Rio de Janeiro indicou a prevalência de TEPT de 10,2% na cidade de São Paulo e de 8,7% na cidade do Rio de

Janeiro (Ribeiro et al., 2013). Os impactos da ocorrência do TEPT, tanto para os indivíduos quanto para a sociedade, são significativos, pois aqueles acometidos pelo transtorno correm risco de desenvolver outros transtornos psicológicos, especialmente do humor, de ansiedade e abuso de substâncias, e têm até 9,8 mais chances de cometer suicídio quando comparados a pessoas sem o diagnóstico (Gradus et al., 2010). Dados como esses destacam a importância de se utilizar recursos de tratamento para indivíduos diagnosticados com TEPT, uma vez que seus sintomas são persistentes a menos que intervenções pontuais sejam executadas (Difede, Olden, & Cuckor, 2014).

ABORDAGENS INICIAIS

Os primeiros relatos publicados sobre intervenções em grupo com vítimas de traumas começaram a surgir há mais de 60 anos, durante o período da II Guerra Mundial. O desenvolvimento de terapias em grupo para vítimas de trauma foi se consolidando a partir da década de 1970, devido à ocorrência de dois eventos principais: o primeiro, a criação de uma rede nacional estadunidense de centros para veteranos de guerra, e o segundo, a introdução do diagnóstico de TEPT na terceira edição do DSM, em 1980. Esses eventos aceleraram o desenvolvimento de intervenções em grupo para indivíduos expostos a traumas por meio da implementação de grupos nos centros para veteranos de guerra conduzidos pelos próprios veteranos a fim de auxiliar ex-combatentes a se reajustarem socialmente, chamados *rap groups*, e na produção científica que seguiu a inclusão do diagnóstico de TEPT no DSM, o que possibilitou o estabelecimento de aspectos comuns na gênese e manifestações de sintomas entre sobreviventes de diferentes experiências traumáticas (Foy & Larson, 2006).

Ao longo dos anos, métodos de terapia em grupo foram aplicados a uma variedade de populações de sobreviventes de traumas, e, embora os métodos de intervenções terapêuticas em grupo possam diferir em seus modelos teóricos de desenvolvimento dos sintomas e intervenção terapêutica, todos eles compartilham algumas características com o objetivo de estabelecer um

ambiente terapêutico, seguro e respeitoso. Essas características incluem 1) a composição do grupo por membros que passaram pelo mesmo tipo de evento traumático; 2) a concordância na revelação e validação da experiência traumática; 3) a normalização das respostas relacionadas ao trauma; e 4) a validação de qualquer comportamento necessário e utilizado para a sobrevivência ao trauma (Foy & Larson, 2006).

ABORDAGEM COGNITIVO- COMPORTAMENTAL: MODELOS CONCEITUAIS

Atualmente, existem três modelos cognitivo-comportamentais que são especialmente relevantes para a lógica e a aplicação de terapias em grupo para indivíduos expostos a traumas e com o diagnóstico de TEPT. Esses três modelos são a Teoria de Representação Dual de Brewin, Dalgleish e Joseph (1996), a Teoria do Processamento Emocional de Foa e Kozak (1986) e a Teoria Cognitiva de Ehlers e Clark (2000). Embora haja aspectos em comum entre esses três modelos, cada um enfatiza diferentes nuances que, em conjunto, proporcionam um entendimento ampliado do TEPT.

A compreensão do TEPT por meio desses três modelos orienta intervenções da terapia cognitivo-comportamental (TCC) em grupo aplicadas a traumas no sentido de que os elementos de tratamento comuns a esses três modelos são incorporados à maioria dessas intervenções. Esses elementos são: 1) a construção de uma narrativa verbal do trauma; 2) a modificação de avaliações negativas sobre o trauma; e 3) a ativação de memórias sensoriais ou situacionais associadas ao trauma com o objetivo de diminuir sua força e trazê-las sob o controle consciente (Foy & Larson, 2006). Portanto, a grande maioria das terapias de grupo desenvolvidas para o TEPT sob a abordagem da TCC é considerada como “focada no trauma” (Foy et al., 2001), devido a sua ênfase na reintegração da memória traumática em níveis afetivos, cognitivos e fisiológicos como meio para a redução de sintomas e ressignificação da experiência traumática. Com base na proposição de que o processo de mudança ocorre a partir da reintegração da memória traumática, as intervenções focadas no trauma diferem de intervenções que focam no

momento de vida presente dos pacientes, pois nestas os principais objetivos são reduzir o isolamento social e estimular o senso de competência individual, que, por consequência, melhorariam a adaptação e o funcionamento prejudicados pela experiência traumática (Shea, McDevitt-Murphy, Ready, & Schnurr, 2009).

Dessa forma, as estratégias utilizadas em intervenções de grupo para o TEPT podem ir desde psicoeducação sobre os sintomas de TEPT até sessões de exposição nas quais é esperado que os pacientes descrevam repetidamente os detalhes de sua experiência traumática para o grupo. A maioria dos modelos de grupos inclui treinamento de habilidades para lidar com os sintomas de TEPT (especialmente manifestações de ansiedade e excitabilidade fisiológica) e diminuí-los. Essas técnicas incluem treinamento de relaxamento, técnicas de aterramento (no caso de dissociações), identificação e modificação de pensamentos e crenças desadaptativas, assim como o uso de *role playing*, ensaio comportamental e treinamento de assertividade para melhorar o funcionamento interpessoal. Porém, é dada ênfase às técnicas de exposição imagística e reestruturação cognitiva (Shea et al., 2009).

As técnicas de exposição e reestruturação cognitiva auxiliam no processamento da experiência traumática de cada membro do grupo, de forma que a exposição repetida a memórias do trauma tende a reduzir a resposta de medo associada ao evento estressor traumático, assim como a dessensibilizar o paciente para pistas relacionadas ao trauma, ao mesmo tempo que é estimulada a correção de percepções equivocadas de perigo (Foy et al., 2001). Nos grupos em que a exposição é utilizada, cada participante tem a oportunidade de recontar sua história enquanto os outros o escutam, para que, dessa forma, os membros do grupo se auxiliem durante o processamento do trauma por meio de suas próprias experiências. Esses modelos de grupo valorizam amplamente tanto a força da narrativa pessoal da experiência traumática quanto o poder do apoio do grupo. Porém, é importante destacar que em grupos nos quais se desenvolve reconstrução narrativa do trauma pode ocorrer processamento de trauma vicário por meio da exposição a narrativas traumáticas de outros membros (Foy & Larson,

2006; Foy et al., 2001). Nesse aspecto, nem todos os indivíduos expostos a trauma podem ou devem ser incluídos em propostas de intervenção em grupo.

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO: ASPECTOS GERAIS

A TCC para trauma consiste em uma classe ampla de tratamentos e técnicas focados na diminuição de sintomas vivenciados por indivíduos que foram expostos a situações traumáticas. Ela pode se dar em dois diferentes momentos: (1) logo após o trauma, em um caráter mais emergencial, dentro de um período de dois dias a partir da ocorrência do evento; (2) transcorridos 30 dias após o evento, quando são implementados os diferentes tratamentos para TEPT. Considerando o escopo deste capítulo, serão detalhadas a intervenção imediata após o trauma e a intervenção para o TEPT. Os tratamentos aplicados ao trauma se estruturam a partir de uma conceitualização da psicopatologia pós-traumática baseada em evidências, de forma que a compreensão científica dos problemas alvos de tratamento oriente o desenvolvimento de intervenções efetivas (Cahill, Rothbaum, Resick, & Follette, 2009).

As intervenções focadas no trauma em grupo são indicadas para indivíduos que tenham sintomatologia psicológica relacionada ao evento traumático, condições de vida estáveis e disposição ou habilidade para tolerar afeto intenso. Também são indicadas para aqueles que sejam capazes de estabelecer relações de confiança, tenham experiências anteriores em grupos e que compartilham de experiências traumáticas, gênero, etnia e orientação sexual semelhantes com os outros membros. As contraindicações de tratamentos em grupo focados no trauma são para indivíduos com sintomas psicóticos ativos ou ideação suicida ou homicida, com déficits cognitivos e de linguagem, com problemas cardíacos e que possam estar passando por algum processo litigioso (Foy & Larson, 2006).

É bastante comum que tais modelos de tratamento sejam muito implementados e discutidos em terapias individuais com vítimas de trauma,

mas as intervenções em grupo parecem exercer vantagens e funções importantes. Em alguns contextos, essas intervenções podem ser mais econômicas, visto utilizarem as mesmas estratégias terapêuticas em múltiplos indivíduos ao mesmo tempo, e, em razão de sua natureza interpessoal, grupos podem servir como ótimos ambientes para restaurar a segurança, a confiança, a autoestima e a intimidade entre indivíduos após a exposição a traumas. A experiência de participação em grupos pode diminuir a sensação de isolamento e alienação, frequentemente presente nesses pacientes, além de contribuir para o reestabelecimento de conexão com os outros, uma vez que os indivíduos sentem-se compreendidos e experimentam apoio durante seus esforços na recuperação de sintomas relacionados à exposição traumática (Shea et al., 2009).

PRIMEIROS SOCORROS PSICOLÓGICOS

A intervenção aqui descrita é um resumo do que foi proposto em conjunto pelo National Child Traumatic Stress Network e o National Center for PTSD como uma medida de intervenções em crises, o *Psychological First Aid* (“primeiros socorros psicológicos” [PSP], tradução livre). O PSP é um protocolo modular destinado a auxiliar crianças, adolescentes e adultos logo após a experiência de situações calamitosas, como desastres e ataques terroristas. Ele foi pensado com o objetivo de diminuir o estresse gerado por esses eventos e promover estratégias de manejo adaptativas de curto e longo prazos. Os princípios do PSP são de que o protocolo deve ser consistente com a evidência científica disponível para esse tipo de situação e de que ele deve ser aplicável em todas as faixas etárias e em campo, respeitando as diferenças culturais. Ainda que em seu desenho inicial a proposta do PSP fosse trabalhar individualmente e com famílias, a maioria dos seus elementos acaba se dando em contextos de formação espontânea de grupos (Ruzek, Brymer, Jacobs, & Layne, 2007). Para as situações em grupo, é recomendável:

- manter as discussões circunscritas às necessidades comuns, e não individuais
- focar a discussão na resolução de problemas imediatos

- evitar que a discussão torne-se sobre reclamações e queixas
- se um indivíduo precisar de ajuda especial, oferecer-se para encontrar-se com ele após a discussão do grupo

Para atingir os objetivos propostos, o PSP é dividido em oito ações centrais:

1. Contato e Engajamento. O contato pode ser iniciado pelos sobreviventes ou pelo profissional. Estabeleça conexão de forma não intrusiva e empática. Apresente-se, diga seu nome, profissão e que está ali para ajudar. Tente achar um local confortável e com alguma privacidade, garanta confidencialidade sobre os conteúdos ali discutidos. Pergunte sobre necessidades imediatas; necessidades médicas são prioritárias.

2. Segurança e Conforto. Inicialmente, promova segurança imediata e contínua, assim como bem-estar físico e emocional. Para isso, é interessante que sejam realizadas ações ativas, em vez de uma postura passiva de espera por ajuda. Também é recomendável que essas atividades sejam familiares ao sobrevivente e que sejam práticas, trazendo resultados imediatos.

3. Estabilização. Essa etapa deve ser realizada caso seja necessário. Seu objetivo é acalmar e orientar pessoas emocionalmente sobrecarregadas ou desorientadas. Busque por sobreviventes que estejam com o olhar “vidrado” e distante, com dificuldade de se orientar, não responsivos ao estímulo verbal, com reações físicas intensas (tremores) ou reações emocionais extremas. Inicialmente, respeite a privacidade, espere alguns minutos antes de intervir. Apresente-se e faça-se disponível, tente ajudar com problemas práticos. Caso isso não funcione, use uma técnica de aterramento. Nessa técnica, explica-se para o sobrevivente que o que ele está sentindo é esperado, mas que pode ser manejado se desfocarmos dos pensamentos e focarmos no mundo externo. Para isso, convide-o a:

- sentar-se confortavelmente com os braços e pernas descruzados
- respirar profundamente e devagar

- nomear cinco objetos não ansiogênicos que pode ver ao seu redor (p. ex., cadeira, mesa, árvore, etc.)
- respirar profundamente e devagar
- nomear cinco coisas não ansiogênicas que pode ouvir ao seu redor (p. ex., pessoas conversando, pássaros, telefone tocando, etc.)
- respirar profundamente e devagar
- nomear cinco coisas não ansiogênicas que pode sentir (p. ex., própria respiração, as roupas que usa, o chão em que está sentado, etc.)
- respirar profundamente e devagar

4. Juntar Informações: Necessidades Atuais e Preocupações. Auxiliar pessoas a manifestar especificamente suas necessidades e preocupações imediatas (obtendo informações adicionais quando apropriado). Entre os principais tópicos a serem abordados, estão:

- natureza e severidade das experiências durante o trauma
- perda de alguém próximo
- preocupações com circunstâncias imediatas após o trauma e presença de ameaça atual
- separação dos entes queridos ou preocupação com sua segurança
- doenças mentais, físicas e necessidade de medicações
- perdas como casa, escola, vizinhança, trabalho, propriedade particular e animais de estimação
- sentimento extremo de culpa ou vergonha
- pensamentos de machucar a si ou a outros
- disponibilidade de apoio social
- uso prévio de álcool e drogas
- exposição prévia a trauma ou perda de entes queridos
- preocupações com o impacto desenvolvimental do evento em crianças, adolescentes e adultos

5. Assistência Prática. Nessa etapa, o objetivo é oferecer assistência prática e informações para auxiliar na satisfação de necessidades e preocupações

imediatas. Para isso, são sugeridos quatro passos simples baseados em resolução de problemas:

- identificar as necessidades mais urgentes
- esclarecer e especificar o problema
- discutir um plano de ação
- agir para atender à necessidade

6. Contato com Apoio Social. Conectar pessoas tão logo quanto possível às redes de apoio social, incluindo membros familiares, amigos, vizinhos e recursos na comunidade. O apoio social pode ser provido de diversas formas: suporte emocional, sentir-se necessário, conexão social, ser reassegurado de seu valor, suporte confiável, conselhos e informação, ajuda física e material. Para que o sobrevivente possa ter acesso a esse suporte, algumas ações são sugeridas:

- promover o acesso à rede de apoio primário (família e pessoas próximas)
- encorajar a busca imediata das fontes primárias de apoio
- discutir a busca e a oferta de ajuda em casos de emergência
- na qualidade de cuidador, ser um modelo de busca de ajuda

7. Informações sobre Estratégias de Manejo. Apoiar respostas adaptativas de *coping*, reconhecer esforços de *coping* e empoderar indivíduos; encorajar adultos, crianças e famílias para assumir um papel ativo no processo de recuperação. Oferecer informação que auxilie em lidar de forma eficaz com os aspectos psicológicos do evento traumático. Entre os principais tópicos a serem abordados, estão:

- reações esperadas ante o estresse: intrusões; evitações; excitabilidade aumentada
- estratégias de *coping* adaptativas: buscar ajuda com outras pessoas; atender a necessidades básicas (sono, alimentação e hidratação); manutenção da rotina prévia; prática de atividades prazerosas; exercícios de relaxamento; atividade física aeróbica; aceitar o sofrimento presente e lembrar-se de que é passageiro

- estratégias de *coping* desadaptativas: usar álcool e drogas; deixar de
- realizar atividades; afastar-se de amigos e familiares; trabalhar muito; não cuidar de si mesmo (sono, alimentação, etc.); culpar excessivamente outros e a si mesmo

8. Contato com Serviços de Colaboração. Por fim, é necessário colocar o sobrevivente em contato direto com serviços e fontes de ajuda para as necessidades atuais e futuras. Faça o necessário para realizar os encaminhamentos necessários; por vezes, é preciso acompanhá-lo até o profissional que irá atendê-lo. Entre os principais cenários que precisam de encaminhamento, estão: problema médico ou psicológico agudo; piora de um quadro médico ou psicológico preexistente; risco para si ou para outros; uso de álcool e outras substâncias; casos que envolvam violência doméstica ou contra menores; necessidade de uso de medicação para estabilização; quando conselho religioso é solicitado.

INTERVENÇÃO NO TRANSTORNO DE ESTRESSE PÓS-TRAUMÁTICO

Entre as diversas propostas de intervenções baseadas na TCC em grupo, diferentes adaptações já foram desenvolvidas e voltadas para veteranos de guerra (Ready et al., 2008; Schnurr et al., 2003) e veteranas de guerra (Castillo, Lacefield, Baca, Blankenship, & Qualls, 2014), militares (Resick et al., 2015), refugiados (Drozdek, Kamperman, Tol, Knipscheer, & Kleber, 2014), jovens retidos em instituições para cumprir medidas socioeducativas (Olafson et al., 2016), mulheres vítimas de violência (Echeburúa, Sarasua, & Zubizarreta, 2014) e retidas em instituições judiciárias (Bradley & Follingstand, 2003) e meninas vítimas de abuso sexual (Habigzang et al., 2009). Em geral, os estudos encontraram bons resultados após as intervenções, sendo que todos observaram redução de sintomas pós-traumáticos nos participantes.

Uma metanálise conduzida por Sloan, Feinstein, Gallagher, Beck e Keane (2013) incluiu 16 ensaios clínicos randomizados de tratamentos em grupo para sobreviventes adultos de trauma das mais variadas abordagens. O estudo

avaliou a eficácia do formato de intervenções em grupo nessas populações e indicou que os tratamentos em grupo estão associados a reduções significativas de sintomas de TEPT. Porém, apesar de essa redução resultar em efeitos de tratamento superiores em comparação a condições de lista de espera, nenhum resultado significativo foi encontrado quando diferentes tipos de intervenção em grupo foram comparados entre si.

Mais recentemente, uma revisão do National Center for PTSD foi publicada apresentando o estado atual da literatura em evidências de tratamentos em grupo para o TEPT (Sloan & Beck, 2016), focando a discussão de seus resultados em intervenções oriundas das principais abordagens individuais de tratamento para o transtorno. A revisão apresenta estudos que utilizaram diferentes adaptações, ou protocolos de intervenção, a partir da terapia de processamento cognitivo (TPC) e da terapia de exposição prolongada. Os resultados estão sintetizados e organizados na Tabela 9.1.

Tabela 9.1 Síntese dos resultados de estudos que avaliaram intervenções em grupo

Estudo	Participantes	Delineamento	Características da intervenção	Resultados
Resick e Schnicke (1992)	19 sobreviventes de violência sexual	Pré e pós; <i>follow up</i> em 3 e 6 meses; comparação TPC vs. lista de espera	TPC: 12 sessões semanais	Redução de sintomas de TEPT e depressão no pós-tratamento e manutenção após 6 meses
Schnurr e colaboradores (2003)	360 veteranos da guerra do Vietnã	Pré e pós; <i>follow up</i> 7, 12, 18 e 24 meses; comparação TGFT vs. TGFP	30 sessões semanais; 90 min.; 6 membros TGFT: exposição imagística de 2h em grupo 2 sessões de relato de trauma por participante, com gravação para tarefa	Redução de sintomas de TEPT nos dois tratamentos, sem diferença entre eles Abandono no grupo TGFT foi de 23%; no TGFP, de 9%
Chard (2005)	71 mulheres sobreviventes de abuso sexual na infância	Pré e pós; <i>follow up</i> 3 meses e 1 ano; comparação TPC-AS vs. lista de espera	17 sessões em grupo para habilidades; 9 sessões individuais com foco no trauma	Maiores reduções de sintomas de TEPT no grupo TPC-AS com manutenção após 1 ano
Ready e colaboradores (2008)	102 veteranos de guerra	Pré e pós; <i>follow up</i> 6 meses	16 a 18 sessões; 3h; 2x semana TGBE: exposição imagística adaptada de Schnurr e colaboradores. 60h de exposição (3h em grupo; 30h escutando gravação; 27h escutando relato de outros membros)	Redução na severidade de sintomas de TEPT mantida por 6 meses; abandono de 3 membros (grupo almoçava junto)
Beck, Coffey, Foy, Keane e Blanchard (2009)	33 sobreviventes de acidente automobilístico	Comparação TCCG vs. lista de espera; <i>follow up</i> de 3 meses	14 sessões semanais; 2h TCCG: exposição imagística por meio da redação individual da narrativa do trauma na sessão de	Redução na severidade de sintomas de TEPT no grupo TCCG mantida após 6 meses; abandono de 27%

grupo Exposição <i>in vivo</i> prescrita como tarefa				
Beidel, Frueh, Uhde, Wong e Mentrikoski (2011)	35 veteranos da guerra do Vietnã	Pré, durante e pós; comparação TMT vs. TE	TMT: combinação de sessões individuais de exposição prolongada e sessões em grupo para reabilitação social e emocional. TE: sessões individuais de exposição	Reduções de sintomas de TEPT em ambas as condições, sem diferenças entre os grupos O grupo TMT apresentou melhoras no funcionamento social Abandono de 22% no grupo e de 6% na exposição
Bass e colaboradores (2013)	405 mulheres sobreviventes de violência sexual na República do Congo	Pré e pós; <i>follow up</i> 6 meses; comparação TPC vs. suporte individual	1 sessão individual e 11 em grupo (adaptadas para questões culturais)	Maiores reduções de sintomas relativos a ansiedade, depressão, TEPT e prejuízos no funcionamento foram encontradas no grupo TPC
Resick e colaboradores (2015)	108 homens e mulheres militares ativos diagnosticados com TEPT	Ensaio clínico randomizado; pré e pós; <i>follow up</i> 6 e 12 meses; comparação TPC-C vs. TGFP	12 sessões; 90 min; 2x semana	Redução da severidade de sintomas de TEPT nas duas condições No grupo TPC-C, houve redução de sintomas de depressão
Castillo e colaboradores (2014)	86 mulheres veteranas de guerra	Pré e pós; <i>follow up</i> 3 e 6 meses; comparação protocolo de grupo vs. lista de espera	Protocolo de grupo de 3 módulos (cognitivo, exposição e habilidades); 16 sessões semanais; 90 min; 3 membros Exposição imagística de 4 sessões por veterana para ler sua narrativa do trauma ao grupo	Maiores reduções na severidade de sintomas de TEPT, mantidas por 6 meses Abandono de 24%

Nota: Os nomes das intervenções foram traduzidos para o português para facilitar a compreensão.
 TPC (Terapia de Processamento Cognitivo – Cognitive Processing Therapy); TGFT (Terapia em Grupo Focada no Trauma – Trauma-focused Group Therapy); TGFP (Terapia em Grupo Focada no Presente – Present-Focused Group Therapy); TPC-AS (Terapia de Processamento Cognitivo para Abuso Sexual – Cognitive Processing Therapy for Sexual Abuse); TBGE (Terapia em Grupo Baseada em Exposição – Group-based Exposure Therapy); TCCG (Terapia Cognitivo-comportamental em Grupo – Cognitive Behavioral Group Therapy); TMT (Terapia de Manejo do Trauma – Trauma Management Therapy); TE (Terapia de Exposição – Exposure Therapy); TPC-C (Terapia de Processamento Cognitivo apenas Cognitiva – Cognitive Processing Therapy cognitive-only).
 Fonte: Adaptada de Sloan e Beck (2016).

Apesar da longa história e da aparente popularidade de intervenções em grupo para sobreviventes de trauma, há uma significativa falta de estudos metodologicamente rigorosos sobre o tema. Em grande parte, a literatura consiste em ensaios clínicos abertos, ou delineamentos não randomizados, métodos que são bastante úteis nos estados iniciais do desenvolvimento de intervenções. Nesse cenário, mesmo que os estudos apresentados na Tabela 9.1 tenham demonstrado bons resultados na diminuição de sintomas de TEPT e taxas semelhantes de abandono, não há nenhum tratamento em grupo para o transtorno que seja reconhecido como baseado em evidências, o que limita, em parte, o avanço desse formato de terapia (Sloan & Beck, 2016).

Em síntese, percebeu-se, nos estudos, que a grande maioria dos tratamentos em grupo para o TEPT tem utilizado diferentes abordagens e técnicas para conduzir exposição em grupo, o que se acredita ser um elemento crítico para um tratamento efetivo. Porém, a maneira como os procedimentos de exposição são executados varia entre os protocolos, mesmo que a maioria inclua o relato em voz alta da memória traumática durante as sessões de grupo. Também foi identificado que, na tentativa de minimizar a possibilidade de traumatização vicária pela escuta dos relatos de traumas de outros membros, alguns protocolos optam pela redação da memória traumática durante as sessões, ou pela condução de sessões de exposição individuais combinadas com sessões em grupo com outros objetivos mais específicos de desenvolvimento de habilidades sociais ou emocionais. Apesar de nenhum protocolo parecer superior quando comparado a outros em termos de redução de sintomas, intervenções mais breves podem ser mais viáveis financeiramente (Sloan & Beck, 2016).

Portanto, entre as diferentes modalidades das abordagens cognitivo-comportamentais em grupo para o TEPT, optamos por apresentar neste capítulo, de forma breve, a Terapia de Processamento Cognitivo (TCP) formatada para grupos, porque, entre as modalidades revisadas, ela foi a que apresentou mais robustez quanto aos resultados, bem como é mais estruturada e breve que as demais.

A TCP consiste em um protocolo de 12 sessões temáticas que foi originalmente desenvolvido para o tratamento individual de vítimas de abuso. Após adaptações para outros contextos e para o uso também em grupo, estabeleceu-se o formato apresentado no Quadro 9.1. Uma diferença importante entre a modalidade individual e em grupo é quanto ao relato do trauma. Na modalidade individual o paciente relata o evento ocorrido, enquanto na modalidade em grupo isso não é recomendável, uma vez que os indivíduos seriam expostos a múltiplos relatos. Assim, o que é focado durante as sessões é a discussão dos impactos gerados pelo trauma na vida dos pacientes. Um aspecto central da TCP são os *stuck points*, que são os pensamentos automáticos distorcidos que impedem o indivíduo de se recuperar adequadamente do trauma. Também faz parte do protocolo uma

série de formulários e materiais de psicoeducação que são entregues para os pacientes, utilizados tanto durante as sessões como nas tarefas de casa (Chard, Resick, Monson, & Kattar, 2009). Para mais informações, é disponibilizado um curso em inglês gratuito e *on-line* pelos pesquisadores.^[NT]

Quadro 9.1 Protocolo de TCP

Sessões	Conteúdos
Sessão 1 Introdução e psicoeducação	a. Administrar a PCL-5 b. Agenda c. Psicoeducação i. Sintomas do TEPT ii. Recuperação do trauma e reação de luta ou fuga iii. Teoria cognitiva iv. Tipos de emoção d. Discussão sobre determinar o pior evento traumático i. Funcionamento da terapia ii. Objetivos do tratamento iii. Conceito de <i>stuck points</i> e. Antecipando a evitação e promovendo adesão f. Visão geral do tratamento g. Tarefa de casa: relato do impacto do trauma h. <i>Feedback</i> da sessão
Sessão 2 O significado do evento	a. Administrar a PCL-5 b. Agenda c. Discutir o impacto do trauma – impacto d. Revisão de conceitos e. Ajudar a identificar e ver a conexão entre eventos, pensamentos e sentimentos f. Introduzir o formulário ABC e preencher um juntos g. Tarefa de casa: Formulário ABC h. <i>Feedback</i> da sessão
Sessão 3 Identificação de pensamentos e sentimentos	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Revisar o ABC e diferenciar situação, pensamento e sentimento d. Discutir o ABC relacionado ao trauma e. Introduzir relato do trauma f. Tarefa de casa: relato do trauma e leitura diária dele g. <i>Feedback</i> da sessão
Sessão 4 Recordando o evento traumático	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Discussão sobre o relato do trauma e <i>stuck points</i> relacionados d. Identificar <i>stuck points</i> e. Questionamento dos <i>stuck points</i> relacionados a autculpa e outras assimilações por meio de questionamento socrático f. Explicar a diferença entre culpa e responsabilidade g. Tarefa de casa: segundo relato escrito do trauma, leitura diária do relato do trauma, ABC h. <i>Feedback</i> da sessão
Sessão 5 Segundo relato do trauma	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Discussão do segundo relato do trauma, identificação de diferenças entre o primeiro e o segundo relato d. Estimular o paciente a questionar as suposições e conclusões sobre o trauma, focar em autculpa

	e. Introduzir formulário de perguntas desafiadoras f. Tarefa de casa: questionar um <i>stuck point</i> por dia, leitura diária do relato g. <i>Feedback</i>
Sessão 6 Perguntas desafiadoras	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Revisar o formulário de perguntas desafiadoras d. Continuar terapia cognitiva para <i>stuck points</i> e. Introduzir formulário de pensamentos problemáticos f. Tarefa de casa: preenchimento do formulário, leitura diária do relato (se necessário) g. <i>Feedback</i>
Sessão 7 Padrões de pensamento problemático	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Revisar formulário de pensamentos problemáticos para acessar <i>stuck points</i> d. Introduzir formulário de questionamento de crenças com exemplo do trauma e. Introduzir a primeira das 5 áreas de problemas: questões de segurança relacionadas a si e aos outros f. Tarefa de casa: identificação diária de <i>stuck points</i>, leitura diária do relato (se necessário) g. <i>Feedback</i>
Sessão 8 Questões de segurança	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Revisar o formulário de questionamento de crenças d. Ajudar os pacientes a confrontar as crenças problemáticas e a criar pensamentos alternativos e. Introduzir a segunda das 5 áreas de problemas: questões de confiança em si mesmo e nos outros f. Tarefa de casa: continuar preenchimento de formulários g. <i>Feedback</i>
Sessão 9 Problemas de confiança	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Revisar o formulário de questionamento de crenças para trabalhar problemas de confiança relacionados ao trauma d. Discutir problemas de julgamento que podem advir de <i>stuck points</i> relacionados à confiança e. Introduzir a terceira das 5 áreas de problemas: questões de poder/controle relacionadas a si e aos outros f. Tarefa de casa: identificar <i>stuck points</i> relacionados a questões de poder/controle g. <i>Feedback</i>
Sessão 10 Problemas com poder/controle	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Discutir conexão; definir agenda entre o poder/controle e autculpa e ajudar no questionamento de crenças problemáticas d. Discutir formas de dar e retirar poder e. Introduzir a quarta das 5 áreas de problemas: questões de estima relacionadas a si e aos outros f. Tarefa de casa: identificar <i>stuck points</i>, praticar receber e dar elogios, fazer uma coisa boa para si por dia g. <i>Feedback</i>
Sessão 11 Problemas de autoestima	a. Administrar PCL-5 b. Agenda c. Discutir as reações dos pacientes ao dar/receber elogios e ao realizar atividades prazerosas d. Ajudar os pacientes a identificar questões de estima e a desafiá-las e. Introduzir a última das 5 áreas de problemas: questões de intimidade relacionadas a si e aos outros f. Tarefa de casa: identificar <i>stuck points</i> relacionados a intimidade, continuar atividades prazerosas e elogios, novo relato do impacto g. <i>Feedback</i>
Sessão 12	a. Administrar PCL-5 b. Agenda

Problemas de intimidade e significado do evento

- c. Ajudar os pacientes a identificar problemas de intimidade e *stuck points* que ainda possam estar presentes
- d. Pacientes leem o relato do impacto do trauma
- e. Revisar o curso do tratamento e os progressos alcançados
- f. Ajudar os pacientes a identificar objetivos para o futuro e a delimitar estratégias para alcançá-los

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As intervenções em TCC no formato de grupo para vítimas de trauma parecem ser uma boa opção no tratamento de indivíduos que apresentam sintomas de estresse pós-traumático — como tratamento único e também como tratamento combinado a terapia individual. Tais intervenções apresentam importante custo-benefício pelas vias da ampliação da capacidade de um menor número de terapeutas fornecer tratamento a um maior número de pacientes e da possibilidade de intervenções mais breves gerarem bons resultados.

Os tratamentos em grupo para o TEPT têm sido associados a redução de sintomas, e estudos empíricos apontam que TCCs oferecidas nesse formato são mais frequentes e mais bem apoiadas empiricamente, produzindo melhores resultados quando comparadas à ausência de tratamento. Diante do fato de que o objetivo deste capítulo não foi revisar exaustivamente todas as modalidades de TCC em grupo para trauma e/ou TEPT, não discutimos abordagens em grupo para o transtorno de estresse agudo (TEA). De fato, algumas orientações de tratamento indicam que as intervenções para o TEA devem ser feitas individualmente (Forbes et al., 2007). Também, ainda do ponto de vista das intervenções imediatas, não discutimos a abordagem do *debriefing* psicológico (derivado do *Critical Incident Stress Debriefing*) devido ao fato de evidências atuais sugerirem que tal procedimento não seja empregado como uma intervenção imediata após a ocorrência do trauma (Bisson, McFarlane, Rose, Ruzek, & Watson, 2009).

Portanto, neste capítulo, optamos por apresentar duas modalidades de intervenções para dois momentos possíveis de tratamento de vítimas de trauma em grupo, o PSP, destinado à intervenção imediata após o trauma, e a

terapia de processamento cognitivo, um tratamento de abordagem em TCC com bons resultados amparados pela literatura.

REFERÊNCIAS

- American Psychiatric Association (APA). (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (5th ed.). Washington: American Psychiatric Association.
- Bass, J. K., Annan, J., Murry, S. M., Kaysen, D., Griffiths, S., Cetinoglu, T., . . . Bolton, P. A. (2013). Controlled trial of psychotherapy for congolese survivors of sexual violence. *New England Journal of Medicine*, 368, 2182-2191.
- Beck, J. G., Coffey, S. F., Foy, D. W., Keane, T. M., & Blanchard, E. B. (2009). Group cognitive behavior therapy for chronic posttraumatic stress disorder: An initial randomized pilot study. *Behavior Therapy*, 40(1), 82-92.
- Beidel, D. C., Frueh, B. C., Uhde, T. W., Wong, N., & Mentrikoski, J. M. (2011). Multicomponent behavioral treatment for chronic combat-related posttraumatic stress disorder: A randomized controlled trial. *Journal of Anxiety Disorders*, 25(2), 224-231.
- Bisson, J. I., McFarlane, A. C., Rose, S., Ruzek, J. I., & Watson, P. J. (2009). Psychological debriefing for adults. In E. B. Foa, T. M. Keane, M. J. Friedman, & J. A. Cohen (Eds.), *Effective treatments for PTSD* (2nd ed., pp. 83-105). New York: The Guilford Press.
- Boden, M. T., Westermann, S., McRae, K., Kuo, J., Alvarez, J., Kulkarni, M. R., . . . Bonn-Miller, M. O. (2013). Emotion regulation and posttraumatic stress disorder: A prospective investigation. *Journal of Social and Clinical Psychology*, 32(3), 296.
- Bradley, R. G., & Follingstand, D. R. (2003). Group therapy for incarcerated women who experienced interpersonal violence: a pilot study. *Journal of Traumatic Stress*, 16(4), 337-340.
- Breslau, N. (2009). The epidemiology of trauma, PTSD, and other posttrauma disorders. *Trauma, Violence & Abuse*, 10(3), 198-210.
- Brewin, C. R., Dalgleish, T., & Joseph, S. (1996). A dual representation theory of posttraumatic stress disorder. *Psychological Review*, 103(4), 670-686.
- Cahill, S. P., Rothbaum, B. O., Resick, P. A., & Follette, V. M. (2009). Cognitive-behavioral therapy for adults. In E. B. Foa, T. M. Keane, M. J. Friedman, & J. A. Cohen (Eds.), *Effective treatments for PTSD* (2nd ed., pp. 139-222). New York: The Guilford Press.
- Castillo, D. T., Lacefield, K., Baca, J., Blankenship, A., & Qualls, C. (2014). Effectiveness of group-delivered cognitive therapy and treatment length in women veterans with PTSD. *Behavioral Sciences*, 4(1), 31-41.
- Chard, K. M. (2005). An evaluation of cognitive processing therapy for the treatment of posttraumatic stress disorder related to childhood sexual abuse. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 73(5), 965-971.
- Chard, K. M., Resick, P. A., Monson, C. M., & Kattar, K. A. (2009). *Cognitive processing therapy therapist group manual: Veteran/military version*. Washington, DC: Department of Veterans' Affairs.

- Difede, J., Olden, M., & Cukor, J. (2014). Evidence-based treatment of post-traumatic stress disorder. *Annual Review of Medicine*, 65, 319-332.
- Drozdek, B., Kamperman, A. M., Tol, W. A., Knipscheer, J. W., & Kleber, R. J. (2014). Seven-year follow-up study of symptoms in asylum seekers and refugees with PTSD treated with trauma-focused groups. *Journal of Clinical Psychology*, 70(4), 376-387.
- Echeburúa, E., Sarasua, B., & Zubizarreta, I. (2014). Individual *versus* individual and group therapy regarding a cognitive-behavioral treatment for battered women in a community setting. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(10), 1783-1801.
- Ehlers, A., & Clark, D. M. (2000). A cognitive model of posttraumatic stress disorder. *Behaviour Research and Therapy*, 38(4), 319-345.
- Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. *Psychological Bulletin*, 99(1), 20-35.
- Foa, E. B., Zinbarg, R., & Rothbaum, B. O. (1992). Uncontrollability and unpredictability in post-traumatic stress disorder: An animal model. *Psychological Bulletin*, 112(2), 218-238.
- Forbes, D., Creamer, M., Phelps, A., Bryant, R., McFarlane, A., Devilly, G. J., ... Newton, S. (2007). Australian guidelines for the treatment of adults with acute stress disorder and post-traumatic stress disorder. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*, 41(8), 637-648.
- Foy, D. W., & Larson, L. C. (2006). Group therapies for trauma using cognitive-behavioral therapy. In V. M. Follette, & J. I. Ruzek (Eds.), *Cognitive-behavioral therapies for trauma* (2nd ed., pp. 388-404). New York: The Guilford Press.
- Foy, D. W., Schnurr, P. P., Weiss, D. S., Wattenberg, M. S., Glynn, S. M., Marmar, C. R., & Gusman, F. (2001). Group psychotherapy for PTSD. In J. P. Wilson, M. J. Friedman, & J. D. Lindy (Eds.), *Treating psychological trauma and PTSD* (pp. 183-202). New York: The Guilford Press.
- Gradus, J. L., Qin, P., Lincoln, A. K., Miller, M., Lawler, E., Sørensen, H. T., & Lash, T. L. (2010). Posttraumatic stress disorder and completed suicide. *American Journal of Epidemiology*, 171(6), 721-727.
- Habigzang, L. F., Stroehrer, F. H., Hatzenberger, R., Cunha, R. C., Ramos, M. da S., & Koller, S. H. (2009). Cognitive Behavioral group therapy for sexually abused girls. *Revista de Saúde Pública*, 43(Sup. 1), 70-78.
- Margis, R., Picon, P., Cosner, A. F., & Silveira, R. D. O. (2003). Relação entre estressores, estresse e ansiedade. *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, 25(1), 65-74.
- Olafson, E., Boat, B. W., Putnam, K. T., Thieken, L., Marrow, M. T., & Putnam, F. W. (2016). Implementing trauma and grief component therapy for adolescents and think trauma for traumatized youth in secure juvenile justice settings. *Journal of Interpersonal Violence*, pii: 0886260516628287. [Epub ahead of print].
- Ready, D. J., Thomas, K. R., Worley, V., Backscheider, A. G., Harvey, L. A., Baltzell, D., & Rothbaum, B. O. (2008). A field test of group based exposure therapy with 102 veterans with war-related posttraumatic stress disorder. *Journal of Traumatic Stress*, 21(2), 150-157.
- Resick, P. A., & Schnicke, M. K. (1992). Cognitive processing therapy for sexual assault victims. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 60(5), 748-756.

- Resick, P. A., Wachen, J. S., Mintz, J., Young-McCaughan, S., Roache, J. D., Borah, A. M., . . . Peterson, A. L. (2015). A randomized clinical trial of group cognitive processing therapy compared with group present-centered therapy for PTSD among active duty military personnel. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 83(6), 1058-1068.
- Ribeiro, W. S., de Jesus Mari, J., Quintana, M. I., Dewey, M. E., Evans-Lacko, S., Vilete, L. M. P., . . . Ferri, C. P. (2013). The impact of epidemic violence on the prevalence of psychiatric disorders in Sao Paulo and Rio de Janeiro, Brazil. *PloS One*, 8(5), e63545.
- Ruzek, J. I., Brymer, M. J., Jacobs, A. K., & Layne, C. M. (2007). Psychological first aid. *Journal of Mental Health Counseling*, 29(1), 17-49.
- Schnurr, P. P., Friedman, M. J., Foy, D. W., Shea, M. T., Hsieh, F. Y., Lavori, P. W., . . . Bernardy, N. C. (2003). Randomized trial of trauma-focused group therapy for posttraumatic stress disorder: Results from a Department of Veterans Affairs cooperative study. *Archives of General Psychiatry*, 60(5), 481-489.
- Shea, M. T., McDevitt-Murphy, M., Ready, D. J., & Schnurr, P. P. (2009). Group therapy. In E. B. Foa, T. M. Keane, M. J. Friedman, & J. A. Cohen (Eds.), *Effective treatments for PTSD* (2nd ed., pp. 306-326). New York: The Guilford Press.
- Sher, L. (2004). Recognizing post-traumatic stress disorder. *QJM*, 97(1), 1-5.
- Sloan, D. M., & Beck, J. G. (2016). Group treatment for PTSD. *PTSD Research Quarterly*, 27(2), 1-4.
- Sloan, D. M., Feinstein, B. A., Gallagher, M. W., Beck, J. G., & Keane, T. M. (2013). Efficacy of group treatment for posttraumatic stress disorder symptoms: A meta-analysis. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 5(2), 176-183.

10



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA E SEUS PARCEIROS AGRESSORES

Sabrina Mazo D’Affonseca

Lúcia Cavalcanti de Albuquerque Williams

Neste capítulo, abordaremos um exemplo expressivo de vítimas de violência interpessoal: a mulher que sofre violência de seu parceiro íntimo. A Organização Mundial da Saúde (OMS) define a violência entre parceiros íntimos (VPI) como comportamentos emitidos pelo parceiro íntimo, ou ex-parceiro, que causam danos físicos, sexuais ou psicológicos, incluindo agressão física, coerção sexual, abuso psicológico e comportamentos

controladores (World Health Organization [WHO], 2014). A violência entre parceiros íntimos pode ocorrer entre casais homoafetivos ou heterossexuais e não requer a existência de intimidade sexual entre eles.

Embora a VPI seja frequente, apenas uma pequena porcentagem das vítimas busca ajuda especializada. Em uma pesquisa realizada pela OMS (WHO, 2005) com mulheres vítimas de VPI em diferentes países, constatou-se que de 20 a 60% delas nunca relataram a violência sofrida e que poucas buscaram ajuda institucional, incluindo serviços de cuidado em saúde. Mesmo entre as mulheres que necessitavam de cuidados médicos devido à agressão sofrida (48% das entrevistadas), uma parcela expressiva (12%) não buscou esse serviço.

Há vários aspectos consistentemente associados à VPI que constituem fatores de risco para o fenômeno. Em uma visão ecológica, na esfera social, tais fatores incluem baixo poder aquisitivo e normas sociais que refletem a dominância masculina (Rothman, Butchart, & Cerdá, 2003); em contraste, na esfera individual, há maior probabilidade de os agressores terem testemunhado violência entre seus pais quando crianças, apresentarem histórico de vitimização de abuso infantil e terem sido criados em lares com valores patriarcais rígidos (levando-os a adotar valores patriarcais em seus relacionamentos), bem como de apresentar uso abusivo de álcool e drogas (Rothman et al., 2003).

A violência acarreta consequências de curto e longo prazos para a saúde física, emocional e social das vítimas. Além das lesões físicas que podem requerer atenção médica no curto prazo, a pessoa pode apresentar outras consequências ao longo do ciclo de vida, como deficiências (físicas e sensoriais), sintomas de depressão (probabilidade duas vezes maior em comparação a mulheres sem histórico de VPI) (WHO, 2014), problemas de saúde, problemas reprodutivos, comportamentos sexuais de risco e uso abusivo de tabaco, álcool (probabilidade duas vezes maior em comparação a mulheres sem histórico de VPI) (WHO, 2014) e outras drogas. Tais comportamentos estão associados a problemas de coração, infarto, câncer, doenças sexualmente transmissíveis, aids e outras doenças crônicas, além de tentativas de suicídio, as quais podem levar à morte precoce da mulher. Não

fica difícil, portanto, notar o impacto que a violência tem nos serviços de saúde. Ademais, os sistemas de justiça e os serviços de assistência social também serão impactados, sem contar os efeitos indiretos na economia decorrentes das faltas, períodos de licença de funcionárias, da perda de produtividade e de capital humano (WHO, 2014).

Tal quadro realça a importância de ações que visem prevenir a ocorrência da VPI para minimizar seus impactos na saúde de todos os envolvidos, uma vez que, além da mulher que sofre violência, quando ela é mãe, os filhos expostos a esse ambiente de tensão e agressão também apresentam consequências relacionadas a tal exposição (Brancalhone, Fogo, & Williams, 2004; Brancalhone & Williams, 2003; Casanueva, Martin, & Runyan, 2009; Holden, Geffner, & Jouriles, 1998; Holt, Buckley, & Whelan, 2008; Humphreys, 2007; Jarvis, Gordon, & Novaco, 2005; O’Leary, Slep, & O’Leary, 2000; Williams & Araújo, 2009). Cumpre destacar que os efeitos da exposição à VPI variam de acordo com a idade da criança,^[NT] o gênero^[NT] e o grau de exposição (Sternberg, Baradaran, Abbot, Lamb, & Guterman, 2006). As características emocionais exercem um impacto significativo no desenvolvimento infantil (Patias, Bossi, & Dell’Aglia, 2014), sendo que as pesquisas têm indicado que os problemas mais acentuados ocorrem quando, além de testemunhar a VPI, a criança também sofre algum tipo de violência (Jarvis et al., 2005). Assim, a exposição a múltiplas formas de violência aumenta o risco de a criança apresentar problemas de comportamento (Sternberg et al., 2006). Tal fato é alarmante, especialmente quando se constata que casos de maus-tratos infantis (como sofrer violência física, psicológica, sexual ou negligência praticada por pais) são mais comuns em lares nos quais ocorre VPI (Appel & Holden, 1998; Capaldi, Kim, & Pears, 2009; Jarvis et al., 2005; McWhirter, 2013; O’Leary & Woodin, 2006; Williams, Padovani, & Brino, 2009). Adicionalmente, cabe lembrar que o fato de a criança presenciar VPI entre os pais constitui um exemplo de vitimização por violência psicológica.

Quando se fala em prevenção de VPI, há que se ter a perspectiva de promover relacionamentos íntimos embasados no respeito mútuo que não utilizem de comportamentos abusivos e violentos entre o casal, o que envolve

mudanças em diferentes níveis: individuais, comunitárias e sociais. Vários esforços já foram realizados no sentido de prevenir tal fenômeno. O primeiro passo, em diversos países, envolveu reformas legais, criminalizando tal ato, assim como treinamento policial e o estabelecimento de serviços voltados para as vítimas e seus filhos (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002; Rothman et al., 2003).

Em alguns países latino-americanos e asiáticos, houve a criação de delegacias especializadas voltadas às mulheres, no intuito de melhorar a denúncia e a ação nos casos de violência contra essa população (Rothman et al., 2003). Embora o Brasil tenha, desde 1985, a conquista da criação das Delegacias de Defesa das Mulheres, elas eram realidade em apenas 21,7% dos municípios brasileiros em 2013 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística [IBGE], 2013), e somente em 2006 tivemos a promulgação da Lei nº 11.340/2006 (Brasil, 2006), popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, que trouxe avanços no combate à VPI que serão discutidos neste capítulo.

Em relação aos serviços voltados às vítimas, Krug e colaboradores (2002) e Rothman e colaboradores (2003) destacam a presença de casas-abrigo, centros de intervenção em situações de crise, treinamentos com equipe de saúde, linhas de telefone para denúncia e apoio às vítimas, aconselhamento psicológico e programas para orientação legal para as vítimas em diferentes países. Cabe lembrar, ainda, que, no Brasil, apenas 2,5% das cidades têm casas-abrigo para mulheres em situação de violência, sendo que, das existentes, apenas 29,7% realizavam atividades profissionalizantes para elas (IBGE, 2013), o que nos leva à hipótese de que um número ainda mais reduzido ofereça intervenções voltadas ao atendimento psicológico a essas mulheres que vivenciam situações graves de crise.

Além dessas iniciativas, há agências, coalizões e fóruns internacionais voltados a promover suporte às vítimas de VPI, como, por exemplo, Women Against Violence Europe, Communities Against Violence Network (CAVNET) e United Nations Interagency Campaign on Women's Human Rights in Latin America and the Caribbean (Rothman et al., 2003). Vale destacar, ainda, que, apesar do aumento expressivo de serviços em diferentes

países de apoio e defesa às vítimas, são relativamente poucas as iniciativas voltadas aos agressores. Considerando que muitos agressores continuam a aterrorizar suas parceiras mesmo após o rompimento da relação, ressalta-se a importância de uma atuação não só para a vítima, mas também para o agressor, para que este possa refletir sobre suas ações e crenças, o que pode levar à prevenção da ocorrência de futuras agressões (Rothman et al., 2003).

Cientes da repercussão que a VPI tem na vida de todos os envolvidos, o que se tem notado são iniciativas pontuais de pesquisadores, profissionais, ativistas e membros de organizações não governamentais que buscam oferecer apoio social, jurídico e psicológico a mulheres e, mais recentemente, aos agressores. Entre essas iniciativas, o Laboratório de Análise e Prevenção da Violência (Laprev) da UFSCar se destaca por buscar, desde sua fundação, em 1998, promover pesquisa, ensino e extensão na área de prevenção da violência intrafamiliar e escolar (D’Affonseca, Priolo Filho, & Williams, 2016; Williams et al., 2009). Entretanto, grande parte da produção de conhecimento produzido em tal laboratório se pautou em intervenções individuais com mulheres, crianças e adolescentes vítimas de violência, assim como com agressores conjugais (D’Affonseca et al., 2016; Pereira, D’Affonseca, & Williams, 2012; Williams et al., 2009; Williams, Santini, & D’Affonseca, 2014), em parte devido à demanda das atividades de extensão e ensino, mas também devido a dificuldades em se obter espaço físico, adesão e horários compatíveis para a condução de outros formatos de intervenção, e até mesmo devido à gravidade e à urgência de alguns dos casos atendidos.

Considerando os benefícios da intervenção em grupo (troca de experiências entre os participantes, criação de vínculos sociais e laços de amizade, reconstrução da confiança no outro, oportunidade de vivenciar modelos adequados de solução de problemas), foram realizadas intervenções nessa modalidade com diferentes populações-alvo:

- a. mulheres vítimas de VPI (Maia, Padovani, & Williams, 2010)
- b. crianças vítimas de maus-tratos e/ou cujas mães sofriam VPI (D’Affonseca & Williams, 2003)

- c. adolescentes gestantes de baixo poder aquisitivo que também sofriam VPI (Gravena & Williams, 2004)
- d. adolescentes em conflito com a lei (Padovani & Williams, 2005)
- e. mães de adolescentes em conflito com a lei (Gallo & Williams, 2010)
- f. agressores conjugais (Cortez, Padovani, & Williams, 2005)

Neste capítulo, indentificamos o que as pesquisas dizem a respeito da intervenção em grupo com mulheres vítimas de VPI e com seus agressores, compartilhando a experiência do Laprev com tal população.

PSICOTERAPIA EM GRUPO COM MULHERES VÍTIMAS DE VPI

Um dos pilares da prevenção à VPI reside na intervenção com as mulheres vítimas para, de um lado, minimizar o impacto do abuso sofrido na saúde física, social e emocional da mulher e, de outro, fortalecê-la para que consiga interromper o ciclo de violência vivenciado em seu relacionamento. Entre as possibilidades de intervenção, têm-se descrito, na literatura, o atendimento psicoterapêutico individual (p. ex., Pereira et al., 2013; Santini & Williams, 2016; Williams et al., 2009; Williams et al., 2014), grupal (Matos, Machado, Santos, & Machado, 2012) e a terapia de casal (Lundy & Grossman, 2001).

Poucos estudos documentam o processo terapêutico com essa população, e, em um número mais reduzido, encontram-se estudos que comparam a eficácia dos diferentes tipos de intervenção. Em uma tentativa de verificar se a intervenção individual, em grupo ou a combinação dos dois (individual e em grupo) produziria maiores ganhos para mulheres vítimas de VPI, alguns achados parecem indicar que a intervenção em grupo combinada com a intervenção individual apresenta maiores ganhos terapêuticos (Echeburúa, Sarasua, & Zubizarreta, 2014), fornecendo pistas sobre delineamentos promissores.

Apesar disso, o tipo de intervenção voltado para mulheres vítimas de VPI mais citado na literatura refere-se ao formato grupal (Matos et al., 2012), que teve origem em casas-abrigos dos Estados Unidos nas décadas de 1960-1970, em tentativas de otimizar o atendimento às abrigadas (Tutty & Rothery,

2002). Entre as vantagens apresentadas para esse formato de intervenção, destacam-se o potencial para diminuir o isolamento das mulheres, a possibilidade que lhes é oferecida de compartilhar e validar suas experiências, recebendo e dando apoio e suporte, a troca de informações, além da possibilidade de perceber que outras mulheres passam por situações semelhantes àsquelas vivenciadas pela participante e que, portanto, o problema não é único e individual (Matos et al., 2012).

Em relação ao conteúdo da intervenção, nota-se um certo consenso em abordar o tema a partir de uma perspectiva feminista, ou seja, em uma posição que defenda os direitos da mulher como igualitários e ainda que condene a violência, retire a responsabilidade da vítima pela agressão e demonstre como a sociedade perpetua essa violência (Matos et al., 2012). Assim, ao longo da intervenção, aconselha-se abordar com as mulheres como as crenças associadas aos papéis de gênero, relativas ao que é socialmente esperado como papel social de um homem e de uma mulher, contribuem para os episódios de violência no relacionamento íntimo (Matos et al., 2012). Com isso em vista, elaboramos, desde o primeiro ano de atividades no Laprev, um instrumento que mede crenças a respeito da violência contra a mulher com base em falas ouvidas na Delegacia da Mulher por vítimas, agressores e policiais (Williams, 2010a), o qual foi validado por Ferrari, Priolo-Filho e Brino (no prelo).

Além disso, é primordial identificar tentativas de negação e/ou minimização da violência por parte da vítima, demonstrando como as dinâmicas violentas entre os casais se estabelecem e se mantêm ao longo do tempo. Outro ponto importante a ser trabalhado com tais mulheres refere-se às razões que as mantêm/mantiveram em um relacionamento violento, de modo que, ao ter clareza da influência de diferentes variáveis, elas consigam diminuir seus sentimentos de culpa em relação à situação vivenciada no relacionamento íntimo (Matos et al., 2012; Sinclair, 2010).

É importante notar que, quando realizamos uma intervenção psicoterapêutica com a mulher que sofre VPI, independentemente da abordagem utilizada e da modalidade de terapia (grupo, individual, comunitária), o objetivo central não se resume em reduzir sintomas como

depressão, baixa autoestima e ansiedade, por exemplo, ou, ainda, em desenvolver habilidades sociais ou de resolução de problemas sociais. Perfazendo toda a intervenção, há um objetivo central prioritário: o de avaliar a segurança e a integridade física da mulher, ensinando-a a se proteger. Tal objetivo se faz necessário quando analisamos o risco a que tal mulher está exposta, lembrando que os feminicídios, ou assassinatos de mulheres, no Brasil não são, em sua maior parte, ocasionados por um estranho, e sim pelo parceiro ou ex-parceiro (ver Williams, 2010b para um estudo de caso sobre femicídio).

É primordial elaborar com as participantes um plano de segurança logo no início do processo terapêutico (Matos et al., 2012). Ou seja, desde o início da intervenção é necessário criar condições para que a mulher proteja a si e a seus filhos. Para isso, fornecer informações sobre os serviços de proteção a vítimas de violência existentes na comunidade e orientações sobre como agir caso ocorra alguma agressão é um ponto-chave que deve ser trabalhado desde o início da intervenção.

Ao se discutirem medidas de segurança e proteção, é importante identificar a presença de crenças disfuncionais podem colocar a mulher em risco. Por exemplo, crenças como “não posso levar desaforo para casa”, “preciso me impor no relacionamento”, “não vou deixar de colocar meu ponto de vista em uma discussão”, “ele não é capaz de fazer mal a ninguém” podem aumentar a probabilidade de a mulher se colocar em situação de risco, como emitir comportamentos de enfrentamento ao agressor, o que pode aumentar a chance de um desfecho violento. Logo, cabe ao facilitador identificar tais crenças e discutir com a participante as consequências geralmente vivenciadas por ela em situações de conflito. Em seguida, devem-se trabalhar técnicas de reestruturação cognitiva, visando obter uma maior flexibilização de pensamentos. Outra abordagem seria desenvolver uma leitura mais acurada do contexto, de forma que a mulher consiga identificar sinais de risco no ambiente (p. ex., estado emocional do companheiro, nível de tensão entre o casal, etc.), de modo a esperar um momento mais tranquilo para expressar seu ponto de vista, seu desagrado e, assim, construir uma solução mais eficaz para a situação e, mais importante, sem violência.

Portanto, faz parte da análise de segurança e proteção investigar o risco vivenciado pela mulher (ver Maia & Williams, 2010, para questionário que mede fatores de risco para violência fatal), por exemplo, indicado quando a mulher tiver medo do parceiro, se ele lhe fizer ameaças de morte ou possuir arma em casa, analisando com a mulher a necessidade de opções temporárias emergenciais, como ida com os filhos a uma casa-abrigo, mudança para casa de parentes ou até mesmo viagens, em comum acordo com a Delegacia de Defesa da Mulher, para respaldo da lei. Do mesmo modo, é preciso ensinar a participante a discriminar situações e contingências que aumentam a probabilidade de o parceiro agredi-la, como no costumeiro caso de abuso de álcool ou drogas pelo companheiro, de forma que ela possa se comportar de modo seguro diante de tal fato.

Muitas mulheres que vivenciam relacionamentos violentos apresentam conflitos relativos ao relacionamento íntimo. Dessa forma, seria relevante, ao longo do processo, levá-las a refletir sobre os diferentes aspectos envolvidos em um relacionamento, assim como sobre os condicionamentos que mantêm a mulher em uma relação abusiva, permitindo-lhes compreender e expressar seus sentimentos relativos à situação vivenciada. Tal estratégia contribui não só para diminuir a ansiedade e a angústia experimentadas como também favorece o empoderamento das mulheres. Com isso, sugere-se trabalhar com formas de resolução de problemas sociais, para que consigam tomar suas próprias decisões e fazer suas próprias escolhas (Matos et al., 2012).

Em uma revisão da literatura internacional a respeito da eficácia da terapia de grupo para mulheres vítimas de VPI, Matos e colaboradores (2012) identificaram que a maioria dos estudos documenta o sucesso desse tipo de intervenção, ressaltando a prevenção de episódios de violência e os ganhos na qualidade de vida das participantes, que passam a ter mais controle sobre suas próprias vidas, além de aumento da autoestima, das competências pessoais e sociais e diminuição dos sintomas de depressão e de sentimentos de raiva. Contudo, a maioria dos estudos tem limitações metodológicas relativas ao número de participantes, geralmente reduzido; ausência de grupos-controle para comparação dos ganhos observados em uma parcela dos estudos; falta de medidas de longo prazo para verificar se os ganhos obtidos ao término da

intervenção se mantêm ao longo do tempo; e medidas inadequadas utilizadas para verificar a eficácia da intervenção.

Entre os fatores comuns encontrados nos estudos revisados, destacam-se quatro: (1) a perspectiva feminista a respeito da violência íntima do parceiro; (2) intervenções focadas na mulher; (3) ênfase no desenvolvimento pessoal, na autonomia e na autoestima; e (4) abordagem das emoções experimentadas pela participante. Quanto aos objetivos ou atividades, destacam-se: reduzir o isolamento da mulher; estabelecer um plano de segurança pessoal; fortalecer autoestima e autoconceito; discutir o ciclo de violência e os condicionantes da violência contra a mulher; treinar a assertividade e a resolução de problemas sociais (Matos et al., 2012). Vale destacar que a maioria das intervenções se caracteriza como psicoeducacional, com orientação cognitivo-comportamental, adotando um modelo feminista, sendo que o número de sessões variou entre 8 e 10, com uso combinado de diferentes técnicas, entre elas biblioterapia, *role-playing* e treino de relaxamento (Matos et al., 2012).

Entre alguns pontos importantes a serem avaliados para a realização do grupo com mulheres vítimas, destacam-se: (a) avaliar a existência de recursos básicos, como moradia, alimentação e transporte, visto que muitas podem ter fugido de casa para buscar proteção, além de (b) identificar possíveis variáveis que podem interferir na participação (não ter onde deixar os filhos; ter dificuldade de locomoção), de modo a criar estratégias que maximizem sua participação, como oferecer um local e um profissional para ficar com as crianças durante o período da intervenção, já que não é indicada a presença dos filhos durante a sessão de atendimento em grupo, para não inibir a participação da mãe nas atividades, assim como para não expor a criança a conteúdos inapropriados, garantindo-se o sigilo (Matos et al., 2012).

Há poucos trabalhos publicados no Brasil que descrevem intervenções em grupo com mulheres vítimas de VPI. No Laprev, publicamos (Maia et al., 2010) uma atividade de extensão realizada com quatro mulheres com história de VPI (física e psicológica) recrutadas por terem notificado tal violência na Delegacia de Mulher de São Carlos. A intervenção ocorreu ao longo de oito encontros, com duração média de 2 horas por sessão, sendo empregadas

diferentes técnicas e temas: (a) dinâmica de apresentação do grupo; (b) psicoeducação sobre os tipos de violência e o ciclo da violência (Walker, 2009);^[NT] (c) estabelecimento de um plano de segurança e proteção; (d) análise de crenças sociais e mitos que perpetuam a VPI; (e) reflexão sobre planejamento familiar; (f) treino de relaxamento; (g) treino de habilidades sociais; (h) *role-playing*; (i) auto-observação; (j) análise do impacto da violência na saúde mental das participantes e em seus filhos; (k) estabelecimento de redes de apoio; e (l) estratégias para lidar com sintomas de ansiedade e depressão.

No primeiro encontro, após a apresentação de todas as participantes, foi aplicado o questionário a respeito das crenças da violência doméstica (Ferrari, Priolo-Filho, & Brino, no prelo; Williams, 2010a), e, em seguida, os facilitadores explicaram o funcionamento do grupo, bem como estabeleceram com as participantes as regras do grupo. Após esse primeiro momento, cada integrante foi convidada a compartilhar sua história de vida com as demais.

A partir do segundo encontro, e rotineiramente nas sessões subsequentes, no início das sessões, eram coletados os relatos das participantes sobre os acontecimentos relevantes da semana e, em seguida, realizados treinos de relaxamento muscular progressivo e de respiração antes de se abordarem os temas da sessão. O segundo encontro buscou discutir medidas de segurança e proteção existentes, a importância de se estabelecer um plano de segurança e estratégias para evitar episódios de violência (identificação dos antecedentes de episódios violentos), bem como procedimentos a serem adotados caso ocorressem novos episódios de agressão. Nesse encontro, foram ainda discutidas as crenças sociais e os mitos que perpetuam a violência em relacionamentos íntimos.

O terceiro encontro foi voltado para a análise de emoções e sentimentos, em especial, raiva, culpa, medo e tristeza. As participantes foram convidadas a refletir sobre seus sentimentos e os efeitos emocionais da violência sobre sua autoestima. Somado à identificação e à expressão dos sentimentos, foi realizado um treino de assertividade: era requisitado que as participantes fizessem, ao longo da semana, como tarefa de casa, atividades relacionadas a habilidades assertivas.

A família e os filhos foram os temas principais do quarto encontro. Durante a sessão, os facilitadores solicitaram que as participantes refletissem sobre os impactos percebidos/imaginados que a exposição à violência dos pais poderia ter para a criança/adolescente, destacando os efeitos danosos no desenvolvimento cognitivo, físico e socioemocional (Pereira, Santos, & Williams, 2009). Elas também foram convidadas a refletir sobre a importância de os pais oferecerem um ambiente saudável e de proteção que garanta os direitos das crianças e adolescentes, como previsto no Estatuto da Criança e Adolescente (Brasil, 2002).

Considerando os efeitos da VPI para a saúde física e emocional, tanto da participante quanto dos filhos, o quinto encontro objetivou aprofundar a discussão sobre a violência. Para tanto, inicialmente foi apresentado um filme educativo sobre violência contra a mulher (Um lugar chamado Lar, 1999, da TV Cultura); em seguida, as participantes foram solicitadas a debater o filme com base em suas experiências pessoais. Ao longo do debate, os facilitadores apresentavam informações baseadas em pesquisas sobre o agressor conjugal, o relacionamento violento e o ciclo da violência, sublinhando a necessidade de se romper o isolamento por meio da busca dos serviços disponíveis na comunidade. Além de informações sobre as características e os efeitos da violência para o relacionamento e sua dinâmica, as participantes foram convidadas a refletir sobre o que poderia ser modificado na realidade por elas vivenciada, sendo, então, apresentadas informações sobre resolução de problemas sociais.

O sexto encontro abordou os papéis de gênero, além de discutir-se em grupo o papel do ciúme no relacionamento (analisando o que seriam exemplos de comportamentos ciumentos saudáveis e corriqueiros vs. o ciúme patológico, que evidencia uma prática excessivamente violenta de controlar o comportamento da parceira ou do companheiro). A sessão se encerrou com a discussão do casamento como uma escolha pessoal à qual devemos nos dedicar para que ele não seja marcado por conflitos violentos.

No sétimo encontro, discutiram-se os temas depressão e suicídio, enfatizando-se os sinalizadores do comportamento depressivo e suicida, bem como quando e onde buscar ajuda profissional. Outro ponto abordado no

encontro foi a questão da sexualidade, em especial a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis e aids, com a apresentação e posterior discussão do filme *Mancha de batom*^[NT].

Por fim, no oitavo encontro, foi realizado o encerramento do grupo, avaliando-se qualitativamente, com as participantes, a intervenção e os ganhos pessoais ao longo do processo. Embora as avaliações tenham sido positivas e sinalizassem verbalizações sugerindo mudanças comportamentais em situações cotidianas, os pesquisadores destacam dificuldades de adesão das participantes ao grupo de atendimento, que variou de 62,5 a 87,5%, o que reflete a necessidade de se aprimorar o grupo ou mesmo o modelo de atendimento, a fim de adequá-lo às necessidades das participantes (Maia et al., 2010).

Desde o início de nossa experiência com mulheres vítimas de VPI, notamos que tal população trazia com frequência, para o contexto terapêutico, a preocupação com a educação dos filhos; não apenas para comentar sobre o impacto da VPI no comportamento das crianças, mas também para pedir sugestões de como aprimorar as práticas parentais e prevenir problemas de comportamento nos filhos. Foi dentro desse contexto que elaboramos o Projeto Parceria, um programa composto por dois módulos: o primeiro, voltado para a mulher analisar sua condição, sintomas e aprender a prevenir a VPI, e o outro, para o ensino de práticas de educação positiva dos filhos, sem o emprego de coerção ou violência. Cada módulo abarca oito sessões, e os respectivos manuais encontram-se disponíveis *on-line* (Williams, Maldonado, & Padovani, 2008a; Williams, Maldonado, & Araújo, 2008b). Embora o Projeto Parceria tenha tido diversos estudos avaliativos (p. ex., Pereira et al., 2013; Santini & Williams, 2016; Williams et al., 2014), até hoje ele foi testado apenas no módulo individual. Acreditamos, entretanto, não ser difícil apresentá-lo no modo grupal, o que é facilitado pelo fato de os materiais se encontrarem disponíveis.

PSICOTERAPIA EM GRUPO COM AGRESSORES DE VPI – PROGRAMAS INTERNACIONAIS

Realizar intervenção com o agressor é um ponto importante quando lidamos com a VPI, e esse tem sido um dos pilares de prevenção em diversos países (Krug et al., 2002; Rothman et al., 2003). Ou seja, somados a programas preventivos de suporte a vítimas, programas voltados a reorientar os comportamentos violentos e as atitudes e crenças dos agressores surgem como uma possibilidade promissora para reduzir o número de casos de VPI (Hamilton, Koehler, & Lösel, 2013; Rothman et al., 2003).

Os programas de intervenção com agressores, em geral, utilizam o formato de grupos terapêuticos e educacionais voltados a perpetradores de VPI (Rothman et al., 2003). A maioria dos programas existentes utiliza o formato grupal para discutir questões de gênero e ensinar habilidades de lidar com o estresse e a raiva, além de fazer os agressores aprenderem a se responsabilizar por seus atos e identificar e expressar os sentimentos de forma adequada (Krug et al., 2002).

Dados de pesquisas norte-americanas que avaliaram os programas de intervenção voltados ao agressor indicam que eles são pelo menos modestamente bem-sucedidos em prevenir futuros abusos (Gondolf, 2002), especialmente quando os participantes completam o programa. Isto é, em uma revisão realizada por Gondolf (2002), notou-se que os agressores que completaram o programa tinham uma probabilidade dois terços menor de agredir a parceira quando comparados àqueles que abandonaram o programa (evasão de 22 a 42% dos participantes). Deve-se frisar que o mesmo pesquisador informa que, embora a agressão física diminua após a realização do programa, abusos não físicos, como a violência verbal, por exemplo, continuam prevalentes (72% dos homens que completaram o programa utilizavam agressão verbal após 15 meses).

Em uma tentativa de analisar os programas existentes, a OMS (Rothman et al., 2003) rastreou aqueles voltados ao agressor existentes em diferentes países. Um total de 74 programas de 38 países participaram da coleta de dados, sendo o Brasil um deles. Do total de programas, 56 foram classificados como programas voltados ao agressor, sendo que a maior parte (43%) ocorria em países desenvolvidos. Com relação ao número de casos atendidos pelos programas, notou-se uma variação grande entre o número de

agressores participantes (variando de 7 a 2.000 participantes por ano), sendo que a maioria (70%) atendia menos de cem agressores anualmente (Rothman et al., 2003).

O recrutamento dos participantes era variado. A maioria dos programas era atrelada ao Sistema Judiciário, no sentido de que, se um homem fosse acusado de VPI, era obrigado a realizar a intervenção, e, se não atendesse às exigências do programa, haveria um novo julgamento, sendo possíveis novas penalidades. A despeito dessa estratégia, 83% dos integrantes dos programas analisados participavam por vontade própria (Rothman et al., 2003).

Apesar da diversidade das características dos participantes nos diferentes países, a maioria dos agressores que frequentava os programas tinha média de idade de 33 anos (variando de 12 a 82 anos), sendo a maioria homens (Rothman et al., 2003). Quase todos os programas excluía a participação de indivíduos com transtornos psiquiátricos, dependentes químicos, alcoolistas, agressores sexuais, suicidas, pessoas violentas com os facilitadores e aqueles que aparentavam não ter medo da lei (Rothman et al., 2003).

Gondolf (2002) aponta que há vários modelos para se trabalhar com o agressor conjugal, mas três se destacam pela prevalência: (1) o modelo cognitivo comportamental, que atribui os episódios de violência a comportamentos aprendidos que têm uma função expressiva e instrumental – logo, o foco está no ensino de formas alternativas de se lidar com as situações de conflito entre o casal a partir de um processo de reestruturação cognitiva; (2) o modelo psicodinâmico, que se centra na personalidade e na disposição emocional do agressor, visando favorecer o reconhecimento e a reconciliação com emoções latentes que precipitam impulsos abusivos; e (3) o modelo feminista, segundo o qual a violência é originada devido a valores patriarcais sobre os papéis da mulher na sociedade, sendo que o objetivo está em reorientar o modo como o homem expressa seu poder e controle em seu relacionamento íntimo.

Entretanto, pode-se argumentar como Gondolf (2002) que o modelo cognitivo-comportamental pode ser facilmente adaptado para incorporar pressupostos feministas, não sendo mutuamente exclusivos. De fato, na pesquisa conduzida pela OMS (Rothman et al., 2003), a maioria dos

programas (72%) atribuiu a diferença de poder entre homens e mulheres na sociedade como um fator de risco para VPI. Uma parcela menor (27%) considerava que o abuso infantil, a exposição a violência doméstica e o estresse eram fatores que deveriam ser considerados quando se buscava prevenir a VPI, sendo que alguns integravam os modelos para conduzir seu programa (Rothman et al., 2003). Entre os tópicos abordados na intervenção, notou-se pouca variação entre os diferentes programas. Na maioria dos programas existentes, havia discussão a respeito de como as normas sociais sobre gênero afetavam o modo como os homens se comportavam em um relacionamento íntimo; discutia-se sobre as diferenças entre relações íntimas saudáveis e não saudáveis; formas de se resolver conflitos sem o uso da violência; o quanto as crenças culturais do agressor contribuem ou minimizam o uso de violência no relacionamento íntimo; e técnicas de controle da raiva. Alguns programas também incluíam tópicos relativos a estilos parentais não violentos; aspectos legais da VPI; efeitos das drogas e do uso abusivo de álcool no humor e no potencial para violência; efeitos de experiências traumáticas na infância no comportamento adulto; efeitos do estresse no comportamento do indivíduo; doenças sexualmente transmissíveis e sua relação com um relacionamento saudável; de que forma o preconceito contra raça/etnia, classe social e outras formas de opressão afetam o comportamento; como a fé e a espiritualidade afetam o comportamento e o potencial para usar violência; autoestima; pensamentos suicidas e o medo constante do agressor em relação ao mundo ao seu redor (Rothman et al., 2003). A maioria dos programas (62%) tinha objetivos mais amplos do que modificar o comportamento violento do agressor, entre eles transformar as atitudes e os comportamentos dos agressores, bem como os das famílias, da comunidade e da sociedade, em relação à violência e aos papéis de gênero. Os demais tinham como meta alterar o comportamento agressivo dos participantes, em alguns casos para preservar a harmonia familiar e, em outros, para priorizar a segurança da vítima (Rothman et al., 2003).

Em um levantamento internacional de programas de tratamento voltados ao agressor conjugal existentes na União Europeia (UE), Hamilton e colaboradores (2013) notaram que, dos 54 programas existentes em 19 países

(apenas quatro países da União Europeia não tinham programas para agressores: Bulgária, Estônia, Hungria e Romênia), a maioria (70%) utilizava o modelo cognitivo-comportamental, seguido por uma abordagem feminista (54%) e psicodinâmica (31%). Cumpre destacar que 54% dos programas adotavam a combinação de vários modelos de tratamento, sendo que a maior parcela (41%) dos tratamentos combinava técnicas cognitivo-comportamentais e feministas.

Nos Estados Unidos, o programa de intervenção ao agressor de VPI mais utilizado é o Projeto de Intervenção à Violência Doméstica, também conhecido como Modelo de Duluth.^[NT] Segundo Hamilton e colaboradores (2013), o modelo Duluth foi o mais utilizado pelos programas existentes na União Europeia. Ademais, esses autores informam que 19% dos programas foram realizados em órgãos associados à Justiça Criminal, como prisões, ou eram parte de um serviço de reinserção social; 38% ocorreram em centros de cuidados residenciais; 32%, na comunidade; e 11%, em hospitais ou centros de saúde. A duração média de uma sessão de tratamento foi de quase 2 horas ($M = 112$ min, $dp = 64$), e houve um número médio de 26 sessões totais em um tratamento completo ($dp = 17$), administrado ao longo de, em média, 29 semanas ($dp = 20$).

A média de idade dos participantes variou (mínima de 18 anos e máxima não especificada). Entre os 54 programas analisados na Europa, um era exclusivo para agressoras do sexo feminino, e o restante era voltado exclusivamente para agressoras ou uma combinação de homens e mulheres. Quase todos os programas (91%) misturavam, em sua composição, agressores reincidentes e aqueles que haviam sido encaminhados pela primeira vez. Dois programas eram voltados exclusivamente para agressores que tinham tido seu primeiro encaminhamento, e dois para reincidentes (Hamilton et al., 2013).

Em relação a avaliações do processo e resultados alcançados, notou-se que, em geral, os programas utilizavam medidas que combinavam treinamento da equipe e supervisão ao longo do tratamento e medidas de *feedback*, tanto do cliente quanto da equipe, de modo a verificar a adesão a um protocolo de tratamento predefinido. Nenhum dos programas da amostra

analisada utilizava um delineamento com grupo-controle e amostras randomizadas. As medidas utilizavam diferentes variáveis: reincidência do abuso, coletada por fontes oficiais ou autorrelato (16); mudanças psicológicas, como aumento da consciência e habilidades cognitivas para lidar com a raiva (15); e mudanças comportamentais, como melhora em habilidades de comunicação e em assumir a culpa pelos atos (15). Em geral, os dados eram triangulados a partir de múltiplas fontes de informação, como oficiais de justiça que acompanhavam o caso, autorrelato dos agressores e relato das vítimas (Hamilton et al., 2013). Ou seja, observou-se uma grande variedade de programas voltados aos agressores e uma escassez de avaliações com rigor metodológico (Akoensi, Koehler, Löesel, & Humphreys, 2012).

Buscando identificar a efetividade dos programas para agressores na Europa, Akoensi e colaboradores (2012) realizaram uma revisão sistemática de 12 estudos que avaliavam os programas voltados para agressores. No total, 1.586 agressores conjugais participaram de programas específicos, sendo que o tamanho da amostra dos estudos variou de 9 a 322 participantes. Embora os resultados indicassem efeitos positivos após o tratamento, os pesquisadores identificaram problemas metodológicos relativos às avaliações realizadas, os quais não permitem atribuir os achados à intervenção conduzida, concluindo que as avaliações do programas voltados aos agressores existentes na Europa deveriam melhorar as formas de avaliação e ser mais adaptados às características dos participantes (Akoensi et al., 2012).

PSICOTERAPIA EM GRUPO COM AGRESSORES DE VPI – PROGRAMAS NACIONAIS

Com a promulgação da Lei Maria da Penha (Brasil, 2006) decorrente do esforço conjunto de movimentos feministas, vítimas e mulheres por um aparato legal e específico contra a impunidade no cenário nacional de violência doméstica e familiar (Piovesan & Pimentel, 2011; Viegas, 2016), foram notados vários avanços em relação ao combate à violência contra a mulher. Entre algumas das inovações, destacam-se: (1) mudança de paradigma no enfrentamento da violência contra a mulher, que passou a ser

concebida como uma violação dos direitos humanos; (2) incorporação da perspectiva de gênero para tratar da violência contra a mulher, o que leva à consideração das condições peculiares das mulheres em situação de violência doméstica e familiar e à previsão da criação de Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, com competência cível e criminal, bem como atendimento policial especializado para essa população, em particular nas Delegacias de Atendimento à Mulher; (3) incorporação da ótica preventiva, integrada e multidisciplinar (Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, segurança pública, assistência social, saúde, educação, - trabalho e habitação), por meio de um conjunto articulado de ações da União, Estados, Distrito Federal, Municípios e de ações não governamentais; (4) fortalecimento da ótica repressiva, proibindo, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, atribuição de penas de cesta básica ou outras de prestação pecuniárias, bem como a substituição de pena que implique o pagamento isolado de multa (Piovesan & Pimentel, 2011).

Cabe comentar que, quando iniciamos as atividades de intervenção na Delegacia de Defesa da Mulher, em 1998, era corriqueira a utilização da penalidade “pagamento de uma cesta básica” ao agressor conjugal que tivesse ferido a integridade física da parceira. Tal prática, além de não coibir o ato violento, banalizava as agressões, reforçando crenças errôneas de que atos de violência à parceira não seriam uma grave violação de seus direitos.

Com relação às punições previstas na Lei atual, destaca-se o artigo 45, o qual versa que o juiz poderá determinar o comparecimento obrigatório do agressor a programas de recuperação e reeducação (Brasil, 2006). Tal proposta foi alterada recentemente pelo Projeto de Lei do Senado nº 9 (Projeto de Lei do Senado nº 9/2016), que estabelece a medida protetiva de obrigatoriedade de frequência a centro de educação e reabilitação do agressor (Senado Federal, 2016).

Em nossa experiência clínica, tal medida é bem-vinda. O agressor de VPI, assim como o alcoolista, tem grande dificuldade em aceitar que tenha um problema (geralmente culpa a parceira), e sua adesão inicial ao tratamento é um dos maiores desafios terapêuticos, pois, além de culpar a mulher pelo ato

violento ocorrido, ele frequentemente minimiza ou racionaliza a agressão praticada.

Cumprir destacar que, mesmo antes da promulgação da Lei Maria da Penha (Brasil, 2006) e do Projeto de Lei nº 9/2016 do Senado, aprovado recentemente (Senado Federal, 2016), havia iniciativas para o atendimento ao homem agressor, buscando prevenir a reincidência de episódios de violência íntima do parceiro. Merece destaque o trabalho do Laprev, que desde 1998 oferecia atendimento psicoterapêutico a esse público (Williams et al., 2009), cujo modelo de psicoterapia cognitivo-comportamental em grupo será detalhado em breve.

Adicionalmente, cabe destacar o Núcleo de Atendimento à Família e aos Autores de Violência Doméstica (NAFAVD), no Distrito Federal, inaugurado em 2003, que também oferecia atendimento psicológico individual a agressores e que atualmente centra suas atividades em grupos de reflexão a agressores, utilizando uma abordagem psicossocial. Os atendimentos realizados pelo NAFAVD eram voltados para homens encaminhados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e ocorriam em dois momentos. Um deles era o atendimento individual, com a finalidade de coletar informações a respeito da história de vida e do encaminhamento para o serviço, além de expor as condições de participação e registrar o compromisso em cumprir as regras indicadas pelo NAFAVD. O segundo momento, o atendimento em grupo, ocorria ao longo de 12 sessões com cerca de 1 hora de duração, nas quais eram discutidas questões sociais relativas à violência doméstica e familiar (Monteiro, 2014).

Cada encontro abordava um tema diferente. O primeiro previa a apresentação dos participantes e das atividades voltadas ao entendimento e acordo das regras. Nos segundo e terceiro encontros, discutia-se a respeito da violência contra a mulher; nos quarto e quinto encontros, o tema era a Lei Maria da Penha (Brasil, 2006); nos sexto e sétimo, os papéis de gênero presentes em nossa cultura; no oitavo, nono e décimo, o reconhecimento e a expressão de sentimentos; no décimo primeiro, formas de comunicação entre o casal; e o último encontro objetivava obter um *feedback* dos participantes a

respeito do grupo, além de uma avaliação individual sobre as mudanças pessoais ocorridas ao longo do período (Monteiro, 2014).

Todos os encontros eram divididos em dois momentos. No primeiro, intitulado “Jornal da semana”, os participantes eram convidados a compartilhar fatos ou situações marcantes que ocorreram ao longo da semana; no segundo, era trabalhado o tema proposto no encontro, utilizando-se diferentes estratégias: apresentação de filmes, discussão, *role-playing*, relato de experiências, etc., buscando a participação e o envolvimento de todos nas atividades e na discussão dos temas (Monteiro, 2014). Identificam-se, portanto, em tal grupo reflexivo, várias técnicas cognitivo-comportamentais, ainda que não apareça a preocupação com a coleta de dados exaustiva com instrumentos padronizados para demonstrar os efeitos de tal informação.

A intervenção psicoterapêutica do Laprev, assim como no caso das mulheres, era primordialmente voltada para atendimentos psicoterapêuticos cognitivo-comportamentais individuais aos agressores, conforme descrito em Padovani e Williams (2005). Fizemos, entretanto, uma experiência de atendimento em grupo com oito homens, sendo sete deles notificados na Delegacia de Defesa da Mulher por VPI (Cortez et al., 2005). A intervenção foi realizada pelos dois primeiros autores, propositalmente de ambos os sexos: Mirian Cortez (na época, estagiária do quinto ano de graduação em Psicologia) fornecia, nas sessões, um modelo feminino de liderança e assertividade, e Ricardo Padovani (na ocasião, cursando mestrado) dava o modelo masculino de práticas não violentas ao gênero oposto. O procedimento de recrutamento foi conduzido no Fórum Criminal de São Carlos pelos terapeutas, que convidavam os participantes ao saírem das audiências, e por encaminhamento do juiz da vara criminal (Cortez et al., 2005). Convém esclarecer que, ainda que o juiz tivesse recomendado a intervenção, o participante que se recusasse a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido não poderia participar do grupo terapêutico.

Em um primeiro momento, eram conduzidos encontros individuais para coleta de dados pessoais, investigação do atual estado emocional e de saúde,

histórico familiar e dinâmica do relacionamento conjugal, obtidos a partir de um roteiro de entrevista (Williams, 2010c). Também foram coletados dados com as parceiras em sessões individuais, sem a presença do parceiro agressor, sobre o nível de violência sofrida. Em um segundo momento, foi realizada a psicoterapia em grupo. Foram conduzidas oito sessões semanais, de 2 horas de duração cada (com intervalo de 15 minutos), ao longo de dois meses. Cada encontro previa um tema e atividades específicas, bem como a coleta de autorrelato semanal do participante sobre frequência e intensidade das agressões naquele período (Cortez et al., 2005).

Além da apresentação dos participantes e do estabelecimento das regras do grupo no primeiro encontro, os participantes discutiram sobre violência e os tipos de violência e aprenderam técnicas de relaxamento, que, uma vez aprendidas, eram repetidas em todas as sessões. No segundo encontro, iniciou-se uma discussão sobre a responsabilidade pelos seus atos agressivos, a explicação do Ciclo da Violência proposto por Walker (2009), a progressão da violência e o relacionamento violento, de modo que os participantes notassem que os atos de violência não eram explosões incontroláveis de comportamento, mas padrões de comportamento previsíveis que poderiam aprender a dominar, conforme proposto por Healey, Smith e O'Sullivan (1998). Ainda nesse encontro, os participantes preencheram um instrumento para avaliar a extensão de agressões físicas, sexuais, psicológicas e ferimentos por parte de ambos os parceiros, bem como suas habilidades em lidar com conflitos – a Escala de Táticas de Conflito Revisada (Conflict Tactics Scale Revised – CTS2) (Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman, 1996). Na época, recebemos autorização do professor Murray Strauss para traduzir a CTS2, sendo tal instrumento posteriormente validado por Moraes, Hasselmann e Reichenheim (2002). Cabe mencionar que a CTS2 foi o mesmo instrumento utilizado para a companheira medir as agressões do parceiro.

No terceiro encontro, os participantes descreveram sua família de origem e a educação recebida na infância e na adolescência, levando-os a refletir sobre os impactos da exposição à violência que tiveram no passado. Além disso, os participantes foram convidados a discorrer sobre suas concepções acerca dos

papéis de gênero (p. ex., o que, em seu entendimento, competiria ao homem e à mulher fazer). Diante disso, os terapeutas questionavam alguns mitos sobre a mulher que poderiam contribuir para os episódios de violência no relacionamento, bem como atitudes comumente empregadas por homens no sentido de negar e minimizar seus atos, culpando as mulheres pela situação vivenciada (Cortez et al., 2005).

O quarto encontro foi focado na identificação e na expressão de pensamentos e sentimentos, especialmente a raiva e os pensamentos que precedem tal emoção. Após psicoeducação sobre o modelo cognitivo-comportamental,^[NT] os participantes foram convidados a descrever situações vivenciadas por si próprios, identificando seus pensamentos, comportamentos e sentimentos. O objetivo era demonstrar como os pensamentos irracionais contribuíam para o sentimento de raiva. Assim, examinar os pensamentos e sentimentos anteriores ao comportamento violento os ajudaria a compreender que seu comportamento não ocorreu simplesmente porque “perderam a cabeça”. Logo, era preciso se esforçar para que reconhecessem e modificassem os respectivos padrões de pensamento e raiva associados, como proposto por Healey e colaboradores (1998). Nesse sentido, os participantes foram convidados a identificar os pensamentos “quentes”, ou seja, aqueles que elevavam a tensão, e os pensamentos “frios”, que reduziam a tensão. A identificação desses pensamentos e de sensações corporais associadas ao sentimento de raiva seria uma pista à qual eles deveriam ficar atentos, de modo a evitar situações futuras de violência (Cortez et al., 2005).

Entre algumas alternativas de comportamento em situações em que o indivíduo identifica os pensamentos quentes e o sentimento de raiva, foi ensinada a técnica do *time-out* (para “esfriar a cabeça”), que permite que o participante saia temporariamente da situação, interrompendo ruminações internas e substituindo-as por pensamentos mais realistas ou não catastróficos e retornando após se acalmar. Ao mesmo tempo, durante esse período, o agressor é aconselhado a aplicar técnicas de relaxamento ou realizar atividades que possibilitem diminuir sua excitação fisiológica, como caminhar, correr ou andar de bicicleta, e, conseqüentemente, readquirir o controle de suas emoções. É importante destacar que se deve orientar o

paciente a fazer uso adequado do *time-out*, diminuindo a probabilidade de ele ser utilizado como uma forma de se esquivar de alguma discussão. Nesse sentido, em nossas intervenções do Laprev, explicávamos à companheira a utilização da técnica para que ela compreendesse que se tratava de um esforço do parceiro em se acalmar, não devendo ser interpretado erroneamente (Padovani & Williams, 2005). Somado a esse aspecto, há que se ter clareza de que o uso adequado do *time-out* requer um determinado período de tempo para que se readquira o controle, e, ao voltar para a situação, se reveja os pontos que estavam sendo discutidos em um momento de comum acordo com o parceiro. Não se deve utilizar o período de *time-out* para assistir à televisão ou consumir álcool e/ou outras drogas (Healey et al. 1998).

O quinto e sexto encontros buscaram rediscutir com os participantes os papéis de gênero, os quais, em geral, costumam ser estereotipados (Cortez et al., 2005). Tais dinâmicas objetivam promover relações mais igualitárias entre os gêneros, pautadas no respeito mútuo.

No quinto encontro, também se iniciou o treino de assertividade, uma dificuldade para muitos agressores (Faulkner, Stoltenberg, Cogen, Nolder, & Shooter, 1992; Healey et al., 1998), apresentando-se informações sobre os tipos de comportamentos sociais – agressivo, assertivo e passivo – e os efeitos para os envolvidos na interação social (A. Del Prette & Del Prette, 2001). Posteriormente, foi realizado *role-playing* com os participantes para que treinassem comportamentos assertivos. Dando continuidade ao treinamento iniciado no quinto encontro, a sexta sessão incluiu dinâmicas voltadas a fazer e negar pedidos, bem como solicitar de maneira assertiva (e não agressiva) mudança de comportamentos na parceira (Cortez et al., 2005).

No sétimo encontro, discutiu-se sobre depressão e suicídio, visto que muitos agressores apresentam sintomas de depressão e pensamentos suicidas (Hamberger & Holtzworth-Munroe, 1999), sendo recomendado abordar tais aspectos nas intervenções (Faulkner et al., 1992). Nesse encontro, também foi realizada uma avaliação das mudanças conseguidas com o grupo ao longo dos encontros (Cortez et al., 2005). Por fim, no oitavo encontro, foi solicitado que os participantes avaliassem o tratamento recebido e sua participação ao

longo dos encontros, e os facilitadores elaboraram em conjunto com os participantes um planejamento para a manutenção dos ganhos obtidos (Cortez et al., 2005).

Os dados obtidos na CTS2 antes, após a intervenção e nos seguimentos (F1 – 2 a 3 meses; F2 – de 5 a 6 meses; e F3 – um ano após o término do grupo) indicaram redução das agressões ao longo do tempo, tanto na visão dos participantes quanto na de suas parceiras, o que parece sugerir que a abordagem com o agressor se apresenta como solução eficaz para prevenir a VPI (Cortez et al., 2005).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A intervenção em grupo com os agressores foi tão bem recebida pela comunidade que o Judiciário local e o Município de imediato passaram a nos encaminhar homens para os grupos de atendimento. Nessas ocasiões, explicávamos que éramos um laboratório de ensino, pesquisa e extensão com poucos profissionais e que não tínhamos condições de atender a demanda da cidade. Entretanto, colocávamo-nos à disposição para capacitar psicólogos da rede de serviços da cidade, no sentido de torná-los aptos a conduzir grupos com agressores, o que infelizmente jamais ocorreu, devido à baixa frequência de contratação de psicólogos por órgãos municipais e ao fato de os profissionais existentes terem uma enorme demanda que não envolvia atendimento ao homem que praticava VPI, mesmo após o advento da Lei Maria da Penha.

Convém também prestar outro esclarecimento sobre a logística de adesão ao grupo: no início, realizamos uma tentativa-piloto de realizar o grupo com homens denunciados por VPI na Delegacia da Defesa da Mulher. Como não encontramos adesão suficiente (apenas um interessado), solicitamos auxílio do Judiciário. No entanto, mesmo conseguindo um número adequado de participantes para o grupo, deparamo-nos com outro desafio – a falta de disponibilidade de tempo comum entre os participantes para realizar o grupo, em decorrência de trabalharem em períodos distintos. A solução encontrada – e motivada pelo fato de termos apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do

Estado de São Paulo (FAPESP) sob forma de bolsa de Iniciação Científica para Mirian Cortez – foi conduzir o grupo na Universidade aos domingos pela manhã, quando tivemos franca adesão dos participantes.

Apesar dos avanços obtidos com a Lei Maria da Penha (Lei n. °11.340/2006), não há, na realidade brasileira, clareza sobre qual profissional deveria atuar com o agressor conjugal e qual deveria ser sua capacitação. O instituto Serviço de Educação e Responsabilização para Homens Autores de Violência contra a Mulher (SerH) elaborou um “Documento base para a elaboração de parâmetros técnicos para os serviços de educação e responsabilização de homens autores de violência doméstica contra mulheres” (Acosta & Soares, 2012). Seu objetivo é definir e padronizar as atividades de rotina dos grupos de reflexão para homens autores de violência de gênero e doméstica, buscando contribuir para a qualidade, a eficiência e a clareza das ações desenvolvidas no âmbito dos serviços de educação e responsabilização de homens autores de violência doméstica contra mulheres (SerH), a serem implantadas nos Estados e municípios, com base na Lei Maria da Penha (Acosta & Soares, 2012).

Apesar de ser bem-vinda a iniciativa de estabelecer e divulgar parâmetros técnicos para a realização de grupos reflexivos, seria importante investir em avaliações desses grupos e publicações que demonstrem a eficácia desse modelo de atendimento para os homens agressores no Brasil. Nota-se, portanto, que ainda carecemos de pesquisas sobre caminhos viáveis para se intervir com homens agressores na realidade brasileira. Em comparação à realidade de outros países, estamos na primeira onda de estudos, ou seja, conduzindo estudos qualitativos e descritivos que almejam ter maior compreensão sobre agressores e vítimas, bem como sobre como o sistema de Justiça e os programas de intervenção funcionam, sem uma sofisticação metodológica como a observada em outros países, nos quais há pesquisas utilizando delineamentos experimentais e quase-experimentais e medidas de comparação dos resultados (MacLeod, Pi, Smith, & Rose-Goodwin, 2008).

Cumprе destacar que, mesmo com os avanços metodológicos utilizados por pesquisadores nos Estados Unidos para avaliar a eficácia dos programas de intervenção com agressores, ainda não há consenso na literatura sobre o

efeito dos programas na diminuição da probabilidade de agressões futuras (MacLeod et al., 2008). Existe a hipótese de que a existência de vários formatos e modelos de implementação das intervenções com agressores, além dos diferentes componentes presentes no programa e da forma como os grupos de comparação são constituídos, dificultem a obtenção de dados sólidos sobre a efetividade desses programas (MacLeod et al., 2008).

O que fazer, então? Longe de sermos pessimistas, acreditamos no potencial das técnicas cognitivo-comportamentais para a intervenção com vítimas e autores de violência – técnicas com respaldo na literatura clínica e comunitária. Portanto, precisamos continuar trilhando tal caminho, ampliando o mercado de trabalho para psicoterapeutas competentes que abracem a causa da violência contra a mulher.

REFERÊNCIAS

- Acosta, F., & Soares, B. (2012). *Ser H: Documento base para a elaboração de parâmetros técnicos para os serviços de educação e responsabilização de homens autores de violência doméstica contra mulheres*. Brasília: ISER.
- Akoensi, D., Koehler, J., Lösel, F., & Humphreys, D. (2012). Domestic violence perpetrator programs in Europe part II: A systematic review of the state of evidence. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(10), 1206-1225.
- Appel, A. E., & Holden, G. W. (1998). Co-occurring spouse and child abuse: Implications for CPS practice. *APSAC Advisor*, 11(1), 11-14.
- Bogat, G. A., De Jonghe, E., Levendosky, A. A., Davidson, W. W., & von Eye, A. (2006). Trauma symptoms among infants exposed to intimate partner violence. *Child Abuse and Neglect*, 30(2), 109-125.
- Brancalhone, P. G., Fogo, J. C., & Williams, L. C. A. (2004). Crianças expostas à violência conjugal: Avaliação do desempenho acadêmico. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 20(2), 113-117.
- Brancalhone, P., & Williams, L. (2003). Crianças expostas à violência conjugal: Uma revisão de área. In M. Marquezine, M. Almeida, S. Omote, & E. Tanaka, *O papel da família junto ao portador de necessidades especiais* (pp. 123-130, Coleção Perspectivas multidisciplinares em Educação Especial). Londrina: Eduel.
- Brasil. (2006). *Lei n.º 11.340, de 7 de agosto de 2006*. Cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres e da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher; dispõe sobre a criação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; altera o Código de Processo

Penal, o Código Penal e a Lei de Execução Penal; e dá outras providências. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/111340.htm

Brasil. (1990). *Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990*. Estatuto da Criança e Adolescente (ECA). Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm

Capaldi, D. M., Kim, H., & Pears, K. (2009). The association between partner violence and child maltreatment: A common conceptual framework. In D. J. Whitaker, & J. R. Lutzker, *Preventing partner violence: Research and evidence-based intervention strategies* (pp. 93-111). Washington: APA.

Casanueva, C., Martin, S. L., & Runyan, D. (2009). Repeated reports of child maltreatment among intimate partner violence victims: Findings from the National Survey of Child and Adolescent Well-Being. *Child Abuse and Neglect*, 33(2), 84-93.

Cortez, M. B., Padovani, R. C., & Williams, L. C. A. (2005). Terapia de grupo cognitivo-comportamental com agressores conjugais. *Estudos de Psicologia*, 22(1), 13-21.

D'Affonseca, S., & Williams, L. (2003). Clubinho: Intervenção psicoterapêutica com crianças vítimas de violência física intrafamiliar. *Temas em Desenvolvimento*, 12(67), 33-43.

D'Affonseca, S., Priolo Filho, S., & Williams, L. (2016). Intervenção psicoterapêutica com famílias em situação de violência: Relato de atividade de extensão. *Revista Brasileira de Extensão Universitária*, 7(1), 43-49.

Del Prette, A., & Del Prette, Z. (2001). *Psicologia das relações interpessoais e habilidades sociais: Vivências para o trabalho em grupo*. Petrópolis: Vozes.

Echeburúa, E., Sarasua, B., & Zubizarreta, I. (2014). Individual versus individual and group therapy regarding a cognitive-behavioral treatment for battered women in a community setting. *Journal of Interpersonal Violence*, 29(10), 1783-1801.

Faulkner, K., Stoltenberg, C., Cogen, R., Nolder, M., & Shooter, E. (1992). Cognitive-behavioral group treatment for male spouse abuse. *Journal of Family Violence*, 7(1), 37-55.

Ferrari, I. M. S. F., Priolo-Filho, S., & Brino, R. F. (no prelo). Questionário sobre violência intrafamiliar: Confiabilidade de um instrumento sobre crenças. *Psicologia: Teoria e Prática*.

Gallo, A. E., & Williams, L. C. A. (2010). Ensino de habilidades parentais a mães de adolescentes em conflito com a lei. In L. C. A. Williams, J. M. D. Maia, & K. S. A. Rios (Orgs.), *Aspectos psicológicos da violência: Pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental* (p.p. 407-427). Santo André: ESETec.

Gondolf, E. W. (2002). *Batterer intervention systems: Issues, outcomes, and recommendations*. Thousand Oaks: Sage.

Gravena, A., & Williams, L. (2004). Intervenção com gestantes adolescentes de baixo poder aquisitivo: Prevenção de maus tratos e negligência. *Temas sobre Desenvolvimento*, 13(75), 14-20.

Hamberger, L., & Holtzworth-Munroe, A. (1999). Partner violence. In F. M. Dattilio, & A. Freeman (Eds.), *Cognitive behavioral strategies in crisis intervention*. London: Guilford Press.

Hamilton, L., Koehler, J. A., & Lösel, F. A. (2013). Domestic violence perpetrator programs in Europe part I: A survey of current practice. *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, 57(10), 1189-1205.

- Healey, K., Smith, C., & O'Sullivan, C. (1998). *Batterer Intervention: Program approaches and criminal justice strategies*. Washington: U.S. Department of Justice.
- Holden, G. W., Geffner, R., & Jouriles, E. (1998). *Children exposed to marital violence: Theory, research and applied issues*. Washington: American Psychological Association.
- Holt, S., Buckley, T., & Whelan, S. (2008). The impact of exposure to domestic violence on children and young people: A review of the literature. *Child Abuse & Neglect*, 32(8), 797-810.
- Humphreys, C. (2007). *Domestic violence and child protection: Challenging directions for practice* (Vol. 13). Sydney: Australian Domestic and Family Violence Clearinghouse.
- Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). (2013). *Perfil dos municípios brasileiros 2013*. Recuperado de www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2013/defaulttabzip_ods.shtm
- Jarvis, K. L., Gordon, E., & Novaco, W. (2005). Psychological distress of children and mothers in domestic violence emergency shelters. *Journal of Family Violence*, 20(6), 389-402.
- Knapp, P. (2004). *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica*. Porto Alegre: Artmed.
- Knapp, P., & Beck, A. (2008). Fundamentos, modelos conceituais, aplicações e pesquisa da terapia cognitiva. *Revista Brasileira Psiquiatria*, 30(Supl II), S54-S64.
- Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A., & Lozano, R. (2002). *World report on violence and health*. Geneva: WHO.
- Lundy, M., & Grossman, S. (2001). Clinical research and practice with battered women: What we know, what we need to know. *Trauma, Violence & Abuse*, 2(2), 120-141.
- MacLeod, D., Pi, R., Smith, D., & Rose-Goodwin, L. (2008). *Batterer intervention system in California: An evaluation*. San Francisco: Judicial Council of California/Administrative Office of the Courts.
- Maia, J. M. D., Padovani, R. d., & Williams, L. C. (2010). Atendimento em grupo de mulheres agredidas pelo parceiro. In L. C. Williams, K. Rios, & J. Maia, *Aspectos psicológicos da violência: Pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental* (pp. 458-476). Santo André: ESETEC.
- Maia, J. M. D., & Williams, L. C. A. (2010). Questionário de avaliação de risco à vida. In L. C. A. Williams, J. M. Maia, & K. A. Rios, *Aspectos psicológicos da violência: Pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental* (pp. 571-572). Santo André: ESETEC.
- Matos, M., Machado, A., Santos, A., & Machado, C. (2012). Intervenção em grupo com vítimas de violência doméstica: Uma revisão de sua eficácia. *Análise Psicológica*, 30(1-2), 79-91.
- McWhirter, E. H. (2013). Vocational psychology, offenders and ex-offenders, and social justice: A critical psychology perspective. *The Counseling Psychologist*, 41(7), 1041-1051.
- Meltzer, H., Doos, L., Vostanis, P., Ford, T., & Goodman, R. (2009). The mental health of children who witness domestic violence. *Child and Family Social Work*, 14(4), 491-501.
- Monteiro, A. (2014). *Grupos de reflexão para autores de violência doméstica e familiar: Avanço ou retrocesso* (Monografia de Especialização, Faculdade de Educação, Universidade de Brasília, Brasília).
- Moraes, C. L., Hasselmann, M. H., & Reichenheim, M. E. (2002). Adaptação transcultural para o português do instrumento "Revised Conflict Tactics Scales (CTS2)" utilizado para identificar a violência entre casais. *Caderno Saúde Pública*, 18(1), 163-175.

- O'Leary, K. D., Slep, A. M. S., & O'Leary, S. G. (2000). Co-occurrence of partner and parent aggression: Research and treatment implications. *Behavior Therapy*, 31(4), 631-648.
- O'Leary, K. D., & Woodin, E. M. (2006). Bringing the agendas together: Partner and child abuse. In J. R. Lutzker (Org.), *Preventing violence: Research and evidence-based intervention strategies* (pp. 239-258). Washington: APA.
- Padovani, R., & Williams, L. (2005). Proposta de intervenção com adolescentes em conflito com a lei: Um estudo de caso. *Interação em Psicologia*, 9(1), 117-123.
- Patias, N. D., Bossi, T. J., & Del'Aglío, D. D. (2014) Repercussões da exposição à violência conjugal nas características emocionais dos filhos: Revisão sistemática da literatura. *Temas em Psicologia*, 22(4), 901-915.
- Pence, E., & Paymar, M. (1993). *Education groups for men who batter: The Duluth model*. New York: Springer.
- Pereira, P., D'Afonseca, S. M., & Williams, L. C. (2013). A Feasibility Pilot Intervention Program to Teach Parenting Skills to Mothers of Poly-Victimized Children. *Journal of Family Violence*, 28(1), 5-15.
- Pereira, P., Santos, A., & Williams, L. C. (2009). Desempenho escolar da criança vitimizada encaminhada ao Fórum Judicial. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 25(1), 19-28.
- Piovesan, F., & Pimentel, S. (2011). A Lei Maria da Penha na perspectiva da responsabilidade internacional do Brasil. In C. H. Campos (Org.), *Lei Maria da Penha: Comentada em uma perspectiva jurídico-Feminista* (pp. 101-118). Rio de Janeiro: Lumen Juris.
- Rothman, E., Butchart, A., & Cerdá, M. (2003). *Intervening with perpetrators of intimate partner violence: A global perspective*. Geneva: WHO.
- Santini, P. M., & Williams, L. C. A. (2016). Efeitos de procedimentos para maximizar o bem-estar e a competência parental em mulheres vitimizadas. *Estudos de Psicologia*, 33(4), 711-721.
- Senado Federal. (2016). *Projeto de Lei do Senado nº 9, de 2016*. Altera a Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), para estabelecer a medida protetiva de frequência a centro de educação e reabilitação do agressor. Recuperado de <https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/124675>
- Sinclair, D. (2010). Por que a mulher permanece em um relacionamento violento. In L. C. A. Williams, J. M. D. Maia, & K. S. A. Rios (Orgs.), *Aspectos psicológicos da violência: Pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental*. (pp. 69 – 91). Santo André: ESETec.
- Sternberg, K. J., Baradaran, L. P., Abbot, C. B., Lamb, M. E., & Guterman, E. (2006) Type of violence, age, and gender differences in the effects of family violence on children's behavior problems: A meta-analysis. *Developmental Review*, 26(1), 89-112.
- Straus, M. A., Hamby, S. L., Boney-McCoy, S., & Sugarman, D. B. (1996). The revised Conflict Tactics Scales (CTS2): Development and preliminary psychometric data. *Journal of Family Issues*, 17(3), 283-316.
- Tutty, L. M., & Rothery, M. (2002). Beyond shelters: Support groups and community-based advocacy for abused women. In A. R. Roberts (Ed.), *Handbook of domestic violence intervention strategies: Policies, programs, and legal remedies* (pp. 396-418). Oxford: Oxford University Press.

Viegas, V. A. B. (2016). *Os avanços alcançados pela Lei Maria da Penha à luz dos Direitos Humanos*. Recuperado de http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=17052

Walker, L. (2009). *The battered woman syndrome*. New York: Spring.

Williams, L. C. A. (2010a). Questionário sobre crenças a respeito de violência doméstica. In L. C. A. Williams, J. M. D. Maia, & K. S. A. Rios (Orgs.), *Aspectos psicológicos da violência: Pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental* (pp. 599-603). Santo André: ESETec.

Williams, L. C. A. (2010b). Lições de Gravelina: Violência fatal contra a mulher. In L. C. A. Williams, J. M. D. Maia & K. S. A. Rios (Orgs.), *Aspectos psicológicos da violência: Pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental* (pp. 92-110). Santo André: ESETec.

Williams, L. C. A., & Araújo, E. (2009). Habilidades maternas de mulheres que sofrem violência do parceiro: Uma revisão. In R. Wielenska, *Sobre comportamento e cognição: Desafios, soluções e questionamentos* (pp. 96-109). Campinas: ESETEC.

Williams, L. C. A., Maldonado, D. P. A., & Araújo, E. A. C. (2008a). *Educação positiva dos seus filhos: Projeto parceria* (Cartilha, módulo 2). São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Psicologia. Recuperado de <http://www.ufscar.br/laprev>

Williams, L. C. A., Maldonado, D. P. A., & Padovani, R. D. (2008b). *Uma vida livre da violência: Projeto parceria* (Cartilha, módulo 1). São Carlos: Universidade Federal de São Carlos, Departamento de Psicologia. Recuperado de <http://www.ufscar.br/laprev>

Williams, L. C. A., Padovani, R., & Brino, R. (2009). *O empoderamento da família para enfrentar a violência doméstica*. São Carlos: EDUFSCar/OPAS.

Williams, L. C., Santini, P. M., & D'Affonseca, S. M. (2014). The parceria project: A Brazilian parenting program to mothers with a history of intimate partner violence. *International Journal of Applied Psychology*, 4(3), 101-107.

Williams, L. C.A. (2010c). Entrevista inicial com mulheres vítimas de violência. In L. C. A. Williams, J. M. D. Maia, & K. S. A. Rios (Orgs.), *Aspectos psicológicos da violência: Pesquisa e intervenção cognitivo-comportamental*. (pp. 549-559). Santo André: ESETec.

World Health Organization (WHO). (2005). *WHO multi-country study on women's health and domestic violence against women*. Geneva: WHO.

World Health Organization (WHO). (2014). *Global status report on violence prevention 2014*. Geneva: WHO.

[NT] Crianças que não conseguem desenvolver relações de confiança em idade precoce têm maior probabilidade de desenvolver problemas emocionais e comportamentais, visto que elas são privadas de importantes experiências de socialização (Sternberg et al., 2006).

[NT] Meninos têm maior probabilidade de desenvolver problemas externalizantes, como, por exemplo, agressividade e desobediência. Em contraste, meninas têm maior probabilidade de desenvolver problemas internalizantes, como, ansiedade e depressão (Meltzer, Doos, Vostanis, Ford, & Goodman, 2009). Além disso, mães em um ambiente com a presença de VPI tendem a realizar atribuições mais negativas em relação aos comportamentos de seus filhos homens e são mais propensas a considerar os efeitos negativos da exposição à VPI para suas filhas, temendo que sejam vítimas do mesmo fenômeno no futuro (Bogart, De Jonghe, Levendosky, Davidson, & von Eye, 2006).

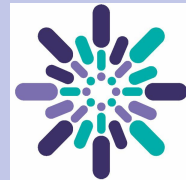
[NT] Loren Walker, em 1979, identificou que existem três fases distintas localizadas em um ciclo de violência íntimo-afetiva: (1) a construção da tensão, em conjunto com o aumento da percepção de perigo; (2) o ápice de tensão, em que as agressões chegam ao incidente mais violento; e, por fim, (3) a etapa do arrependimento (Walker, 2009).

[NT] Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=o7NmE9b8ojY>.

[NT] O modelo Duluth foi criado em 1981, na cidade Duluth, Minnesota, EUA, por ativistas que buscavam uma solução política à insatisfação com a resposta da justiça após um feminicídio brutal. O projeto parte do pressuposto que a prevenção à violência contra a mulher requer uma intervenção comunitária coordenada entre os vários sistemas, de modo que o agressor seja culpabilizado por seus atos e que a responsabilidade pela segurança da mulher deva ser compartilhada por toda a sociedade (Pence & Paymar, 1993)

[NT] A inter-relação entre cognição, emoção e comportamento está implicada no funcionamento normal do ser humano e, em especial, na psicopatologia. Os eventos ativam os pensamentos, que geram, como consequência, as emoções e os comportamentos. Ou seja, não é o evento em si que gera as emoções e os comportamentos, e sim o que nós pensamos sobre o evento. Há uma interação recíproca de pensamentos, sentimentos, comportamentos, fisiologia e ambiente; logo, a mudança em qualquer um desses componentes pode iniciar modificações nos demais (Knapp, 2004; Knapp & Beck, 2008).

11



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO APLICADA A USUÁRIOS DE DROGAS

**Margareth da Silva Oliveira
Laisa Marcorela Andreoli Sartes
Nathália Soares Ribeiro
Silvia Maria Cury Ismael
Milton José Cazassa**

PANORAMA DO CONSUMO DE SUBSTÂNCIAS PSICOTRÓPICAS NO BRASIL E NO MUNDO

O consumo de substâncias psicoativas permanece um grave problema de saúde pública. Segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (United Nations Office on Drugs and Crime [UNODC], 2016), mais

de 29 milhões de pessoas no mundo apresentam transtornos relacionados ao uso de substâncias ilícitas. Somente as drogas lícitas, álcool e tabaco, são responsáveis por 9,3 milhões de óbitos a cada ano.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) (World Health Organization [WHO], 2014) aponta para o fato de que o consumo nocivo de álcool provoca 3,3 milhões de mortes ao ano e é responsável por 5,1% da carga global de doenças. No Brasil, especificamente, comparando-se o primeiro e o segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas (LENAD), observou-se um aumento de 10% no número de indivíduos que fazem um consumo de cinco doses ou mais de álcool por ocasião e de 11% no número daqueles que consomem álcool pelo menos uma vez por semana (Laranjeira et al., 2012).

O uso de tabaco, por sua vez, é considerado a principal causa evitável de doença e morte, sendo responsável por cerca de 6 milhões de mortes anualmente, número que ultrapassa a soma das mortes decorrentes da aids, do consumo de cocaína, heroína e álcool, de suicídio e acidentes de trânsito (Ismael, 2007; WHO, 2013). Nos dias atuais, estima-se a existência de 1,3 bilhão de fumantes no planeta (CDC Foundation, 2015; WHO, 2013). No levantamento de 2012, 20,8% da população brasileira entrevistada se declararam fumantes (Laranjeira, Pinsky, Zaleski, & Caetano, 2007; Laranjeira et al., 2012). O Brasil tem-se destacado mundialmente no controle do tabagismo, tendo desenvolvido a “Convenção Quadro de Controle do Tabaco” (Instituto Nacional de Câncer, 2011), considerada o primeiro “Tratado de Saúde Pública Mundial” que prevê o controle da disseminação do tabaco no mundo.

No que diz respeito ao uso do *crack*, a Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) (Bastos & Bertoni, 2013), constatou que 370 mil indivíduos fazem uso regular dessa substância e/ou similares no Brasil, representando 35% do uso de drogas ilícitas (exceto maconha) nos municípios investigados.

Diante desse panorama, este capítulo discutirá as implicações teóricas e práticas da terapia cognitivo-comportamental em grupo (TCCG) para o tratamento de transtornos relacionados ao uso de substâncias psicoativas.

CRITÉRIOS DIAGNÓSTICOS PARA DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

O conhecimento dos critérios diagnósticos para uso de substâncias é essencial para uma comunicação efetiva entre os profissionais que atuam nesse campo e para um planejamento adequado do tratamento. Os critérios diagnósticos para uso de substâncias do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5) estão apresentados no Quadro 11.1.

Quadro 11.1 Critérios diagnósticos do DSM-5 para transtorno por uso de substâncias

DSM-5 Transtornos por Uso de Substâncias

O baixo controle sobre o uso da substância é o primeiro grupo de critérios (Critérios 1-4):

1. O indivíduo pode consumir a substância em quantidades maiores ou ao longo de um período maior de tempo do que pretendido originalmente.
2. O indivíduo pode expressar um desejo persistente de reduzir ou regular o uso da substância e pode relatar vários esforços malsucedidos para diminuir ou descontinuar o uso.
3. O indivíduo pode gastar muito tempo para obter a substância, usá-la ou recuperar-se de seus efeitos.
4. A fissura se manifesta por meio de um desejo ou necessidade intensos de usar a droga que podem ocorrer a qualquer momento, mas com maior probabilidade quando em um ambiente onde a droga foi obtida ou usada anteriormente.

O prejuízo social é o segundo grupo de critérios (Critérios 5-7):

5. O uso recorrente de substâncias pode resultar no fracasso em cumprir as principais obrigações no trabalho, na escola ou no lar.
6. O indivíduo pode continuar o uso da substância apesar de apresentar problemas sociais ou interpessoais persistentes ou recorrentes causados ou exacerbados por seus efeitos.
7. Atividades importantes de natureza social, profissional ou recreativa podem ser abandonadas ou reduzidas devido ao uso da substância.

O uso arriscado da substância é o terceiro grupo de critérios (Critérios 8 e 9):

8. Pode tomar a forma de uso recorrente da substância em situações que envolvem risco à integridade física.
9. O indivíduo pode continuar o uso apesar de estar ciente de apresentar um problema físico ou psicológico persistente ou recorrente que provavelmente foi causado ou exacerbado pela substância.

Os critérios farmacológicos são o grupo final (Critérios 10 e 11):

10. A tolerância é sinalizada quando uma dose acentuadamente maior da substância é necessária para obter o efeito desejado ou quando um efeito acentuadamente reduzido é obtido após o consumo da dose habitual.
11. Abstinência é uma síndrome que ocorre quando as concentrações de uma substância no sangue ou nos tecidos diminuem em um indivíduo que manteve uso intenso prolongado.

Fonte: Baseado em APA (2014).

Cabe citar que o DSM-5 trouxe alterações importantes em relação ao DSM-IV-TR, sendo uma delas a exclusão da divisão entre abuso e dependência de substâncias. Os critérios foram agrupados como transtornos por uso de substâncias, e o quadro passou a ser classificado de acordo com

um *continuum* de gravidade: dois ou três critérios indicam um transtorno leve; quatro ou cinco indicam um transtorno moderado; e seis ou mais critérios indicam um transtorno grave (American Psychiatric Association [APA], 2014, 2002; WHO, 1993).

MODELOS COGNITIVO-COMPORTAMENTAIS DA DEPENDÊNCIA DE ÁLCOOL E OUTRAS DROGAS

Não existe um modelo teórico que contemple toda a complexidade do fenômeno da dependência de álcool e outras drogas. Segundo Silva (2013), os melhores modelos devem fornecer uma explicação satisfatória da maioria dos fenômenos da dependência de substâncias; maior intersecção e menor número de contradições entre si; explicação tanto do desenvolvimento como da manutenção da dependência; suporte teórico às intervenções e técnicas neles apoiadas; e maior número de evidências científicas que os comprovem. Considerando esses critérios, serão abordados, neste tópico, dois dos principais modelos da dependência de substâncias psicoativas: o modelo cognitivo de Aaron Beck e o modelo cognitivo-comportamental de prevenção de recaída, de G. Alan Marlatt.

MODELO COGNITIVO PARA O USO DE SUBSTÂNCIAS DE AARON BECK

Na terapia cognitiva (TC), considera-se que não é a situação em si que irá influenciar como nos sentimos ou nos comportamos, mas o modo como a interpretamos. De acordo com Beck, Wright, Newman e Liese (1993), a razão pela qual as pessoas passam a apresentar dependência de substâncias está associada à formação de uma crença de que o uso da substância traz um alívio em relação a frustrações, problemas e sentimentos negativos; isto é, o uso de substâncias representa uma estratégia compensatória. Tais crenças podem ser de expectativas positivas (antecipatórias) e/ou facilitadoras (permissivas). As crenças antecipatórias precedem as crenças permissivas e têm conteúdo relacionado à expectativa de que o uso da substância produzirá

recompensa e prazer (p. ex., “beber me deixa relaxado”), enquanto as crenças permissivas estão relacionadas a considerar o uso como aceitável, apesar de suas consequências (p. ex., “só um copo de cerveja não irá me fazer mal”). Essas crenças são ativadas a partir de situações externas (p. ex., passar perto de locais onde o uso ocorre, encontrar com amigos usuários) ou internas (p. ex., estados emocionais negativos). O modelo cognitivo de dependência está representado na Figura 11.1.

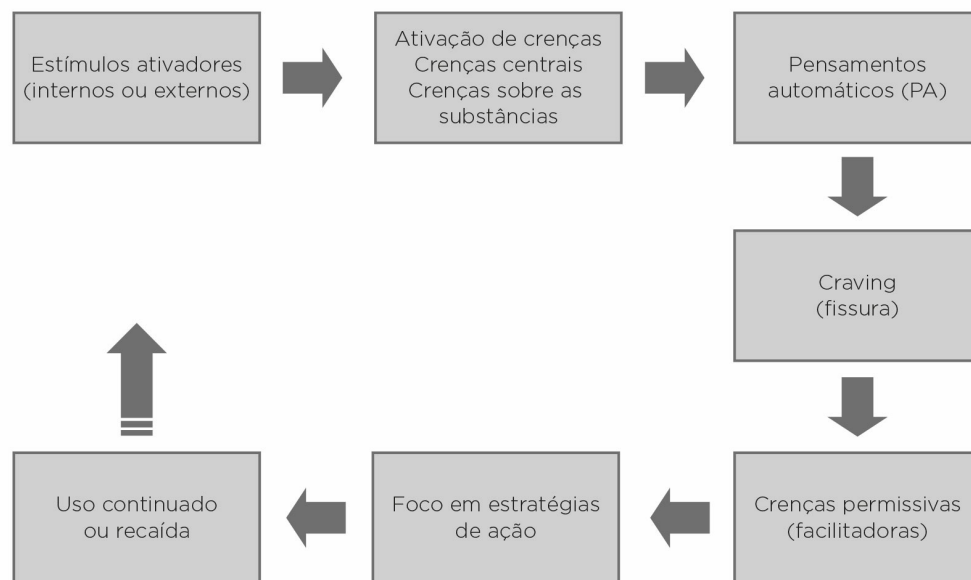


Figura 11.1 Modelo cognitivo da dependência.

Fonte: Beck e colaboradores (1993).

Um exemplo do modelo apresentado seria o de um indivíduo que tem uma discussão com a esposa, tendo ativada sua crença de não ser querido. São gerados pensamentos automáticos, como “não faço nada certo”, “não mereço ser amado”, “ninguém me compreende”, e são evocadas emoções de frustração, tristeza e irritação. Esse evento provoca fissura e pensamentos como “preciso beber para me acalmar”, “só uma cerveja para me aliviar agora”, “vou passar no bar para conversar com alguém”. O indivíduo sai de casa para ir ao bar e faz uso do álcool, o que pode reforçar suas crenças positivas a respeito da substância, contribuindo para a manutenção desse ciclo.

Portanto, a TC tem como principal objetivo reduzir as reações emocionais excessivas e os comportamentos desadaptativos por meio da modificação de pensamentos e crenças disfuncionais, mediante a chamada reestruturação cognitiva. Especificamente no caso da TC para uso de substâncias, há dois objetivos principais que irão nortear a atuação do psicólogo: 1) reduzir a intensidade e a frequência do desejo (fissura/*craving*) de consumir a substância a partir do enfraquecimento das crenças disfuncionais; 2) ensinar técnicas específicas ao paciente para manejar a fissura. As principais técnicas utilizadas na TC para o uso de substâncias são: avaliar as vantagens e desvantagens de utilizar a substância; auxiliar o paciente a lidar com os problemas e emoções desagradáveis sem recorrer às substâncias a fim de obter alívio; reestruturar a vida do paciente para que ele busque outras atividades prazerosas que não envolvam o uso da substância; mostrar como a visão que o paciente tem de si mesmo e de suas capacidades o faz reagir de forma disfuncional ante obstáculos (principalmente para aqueles pacientes que têm baixa tolerância à frustração) e direcioná-lo a encarar tais obstáculos como problemas a serem resolvidos; e, por fim, promover o desenvolvimento de habilidades sociais (Beck et al., 1993).

MODELO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL DE PREVENÇÃO DE RECAÍDA

Desenvolvido por Marlatt (1978), o modelo de prevenção de recaída (PR) constitui um tratamento cognitivo-comportamental com foco na fase de manutenção da mudança do comportamento aditivo, que tem como principais objetivos a prevenção tanto da ocorrência de lapsos iniciais, depois de estabelecido um compromisso com a mudança, quanto de qualquer lapso que possa se agravar até a total recaída (Marlatt & Donovan, 2009). Essa abordagem é baseada no modelo de aprendizagem social (Bandura, 1977), segundo o qual o comportamento de uso de substâncias psicoativas é aprendido, isto é, o indivíduo inicia o consumo quando tem modelos que demonstram expectativas positivas em relação ao uso. A continuação do consumo, por sua vez, é resultado das propriedades reforçadoras da substância para o indivíduo, no sentido de gratificação (p. ex., a pessoa bebe

em busca da sensação de bem-estar – reforço positivo), e para evitar alguma situação ou sensação desconfortável (p. ex., o indivíduo bebe para lidar com uma situação em que é necessário falar em público ou mesmo para evitar os sintomas de abstinência – reforço negativo) (Romanini, Dias, & Pereira, 2010).

Antes de esmiuçar os modelos linear e dinâmico da recaída, é necessário definir brevemente alguns conceitos importantes para sua compreensão:

- *Situações de alto risco*: são eventos internos (emoções positivas ou negativas) ou externos (fatores ambientais e relações sociais, como passar em frente ao bar em que costuma beber ou sair com um amigo que faz uso de substância) que aumentam a chance de ocorrência de um lapso ou recaída. Elas diferem das situações ativadoras descritas no modelo cognitivo de Beck, uma vez que para Beck e colaboradores (1993) as situações ativadoras são neutras e somente eliciam crenças disfuncionais em relação ao uso (i.e., o uso está associado à avaliação cognitiva que o sujeito faz da situação, e não à situação em si).
- *Lapso*: constitui um uso isolado, ou seja, não chega a configurar uma recaída.
- *Recaída*: retorno ao padrão de uso original, intenso e frequente.

O modelo linear de recaída, representado na Figura 11.2, demonstra duas respostas possíveis ante a situação de risco. A partir de uma resposta positiva, o indivíduo não faz o uso da substância, e, por consequência, ocorre aumento em seu nível de autoeficácia, diminuindo a probabilidade de uma recaída. Caso o indivíduo tenha uma resposta de enfrentamento negativa e decida realizar o consumo, os efeitos são contrários: há diminuição na sensação de autoeficácia, e iniciam-se pensamentos relacionados às vantagens do uso, ou seja, há a presença de expectativas positivas quanto ao uso da substância, dando início ao lapso. O lapso pode gerar o chamado efeito da violação da abstinência (EVA), que ocorre quando o indivíduo infringe regras impostas por ele mesmo quanto ao comportamento aditivo, levando-o a experimentar efeitos como a culpa, a autorresponsabilização e a percepção de perda de

controle. Esse efeito intensifica a chance de aumento do uso da substância e evolução para a recaída.

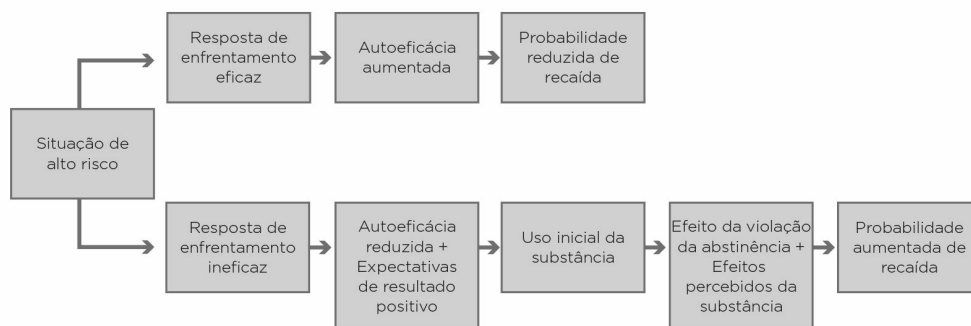


Figura 11.2 Modelo linear do processo de recaída.

Fonte: Marlatt e Gordon (1985).

O modelo dinâmico de recaída foi desenvolvido para abarcar a complexidade desse fenômeno. Enquanto o modelo linear contemplava apenas duas respostas possíveis a partir da exposição à situação de risco, o modelo dinâmico passa a considerar uma série de fatores que podem influenciar esse processo, como explicam Marlatt e Donovan (2009).

A resposta do indivíduo pode ser descrita como um sistema de auto-organização, incorporação de fatores de risco distais (p. ex., anos de dependência, história familiar, apoio social e psicopatologia comórbida), processos cognitivos (p. ex., autoeficácia, expectativas de resultado, EVA, motivação) e habilidades de enfrentamento cognitivas e comportamentais (Marlatt & Donovan, 2009).

Esse modelo possibilitou que várias configurações de riscos de recaída fossem consideradas. Como representado na Figura 11.3, as linhas pontilhadas referem-se às influências proximais, enquanto as linhas sólidas correspondem às influências distais. Há uma relação recíproca entre os quadros conectados, isto é, eles permitem uma interação entre as habilidades de enfrentamento, as cognições, o afeto e o comportamento de uso de substâncias. O grande círculo ao fundo representa as situações de alto risco, que desempenham um papel fundamental na relação entre os fatores de risco e o consumo de substâncias (Witkiewitz & Marlatt, 2004).

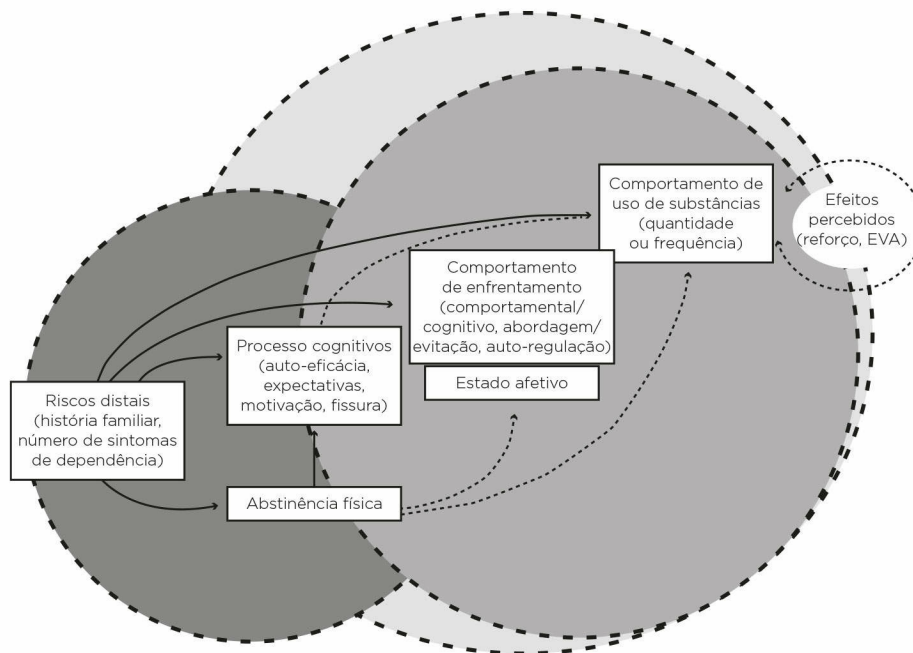


Figura 11.3 Modelo dinâmico do processo de recaída.

Fonte: Witkiewitz e Marlatt (2004).

Portanto, é fundamental que o terapeuta cognitivo-comportamental, em colaboração com o paciente, identifique e avalie as situações de risco, bem como promova o sentimento de autoeficácia para uma efetiva manutenção da abstinência (Rangé & Marlatt, 2008). Para esse fim, é fundamental estimular as habilidades de enfrentamento, a melhora do suporte social, o afeto positivo generalizado e as expectativas de resultado negativas em relação ao uso da substância psicoativa (Jungerman, 2013; Orchowski & Johnson, 2012). As principais estratégias do modelo de PR para a manutenção da mudança do comportamento são:

- *Reconhecer o comportamento dependente como um problema.* Nesse caso, torna-se fundamental trabalhar aspectos motivacionais por meio do Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento (Prochaska, DiClemente, & Norcross, 1992), que será discutido adiante.
- *Realizar o treinamento de habilidades sociais (HSs).* Alguns estudos apontam déficits em HSs em dependentes de substâncias psicoativas (Caballo, 2003; Del Prette & Del Prette, 2001). Esse treinamento

possibilita que o indivíduo desenvolva habilidades (p. ex., assertividade) para recusar a substância e se envolva de forma efetiva em relações sociais, sem fazer o consumo para conseguir iniciar uma conversa, por exemplo.

- *Realizar mudanças no estilo de vida.* De acordo com Beattie e Longabaugh (1997), o apoio social funcional é um forte preditivo dos resultados do uso de álcool e do bem-estar psicológico. Assim, as mudanças no estilo de vida por meio da reestruturação da rotina, das atividades e da rede de suporte social são de suma importância para a manutenção da mudança de comportamento.

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA: PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

As sessões da TCCG proporcionam um ambiente onde os membros são encorajados a desenvolver habilidades de enfrentamento (cognitivas e comportamentais) efetivas, a partir da aplicação de técnicas específicas, visando atingir objetivos específicos no que concerne à remissão sintomatológica (Neufeld, Moreira, & Xavier, 2012). Os grupos podem variar de 2 a 10 pessoas, sendo o ideal de 4 a 8 membros. É importante ressaltar que as pessoas têm autonomia para iniciar ou encerrar a participação quando desejarem. Os grupos devem ocorrer pelo menos uma vez por semana, com duração de 90 minutos. Os facilitadores do grupo devem ser profissionais da saúde orientados para as tarefas (p. ex., bem organizados e focados) e para o processo (flexíveis, cuidadosos, empáticos e habilidosos para iniciar e manter a interação do grupo produtiva), bem como devem ter amplo conhecimento sobre a TCC e o uso de substâncias (Liese, Beck, & Seaton, 2002).

As abordagens utilizadas na TCCG para uso de substâncias são semelhantes às utilizadas na terapia individual. A TCCG para dependência foca na psicoeducação, no aprendizado e na implementação de estratégias de enfrentamento para o manejo das situações de risco, PR e manutenção da abstinência. Dessa forma, são utilizadas as seguintes técnicas:

desenvolvimento de habilidades para lidar com a fissura; resolução de problemas quanto a possíveis gatilhos para a recaída; treinamento em HSs; psicoeducação sobre os próprios padrões de uso de substâncias; identificação e modificação de distorções cognitivas; manejo de pensamentos negativos; elaboração de planos para emergências; e aumento da participação em atividades prazerosas (Monti, Kadden, Rohsenow, Cooney, & Abrams, 2002).

Assim como a TCC individual, a TCCG deve seguir uma agenda. Segundo Liese e colaboradores (2002), os encontros podem ser organizados da seguinte maneira:

1. *Apresentação do facilitador (5 minutos)*: o facilitador se apresenta, explica sobre o grupo e sobre o modelo cognitivo.
2. *Apresentação dos membros do grupo (de 20 a 40 minutos)*: os membros do grupo se apresentam, e o facilitador começa a relacionar os problemas relatados com o modelo cognitivo.
3. *Mudança de pensamentos e crenças sobre o comportamento dependente (de 20 a 40 minutos)*: o modelo cognitivo é usado para que os membros comecem a se conscientizar dos pensamentos e crenças que os levam a fazer o uso da substância, e as técnicas para mudança de pensamentos e crenças são trabalhadas.
4. *Treinamento em habilidades de enfrentamento (de 10 a 20 minutos)*: são ensinadas técnicas de enfrentamento para os problemas atuais relatados pelos membros.
5. *Estabelecimento de metas e tarefas de casa (de 10 a 20 minutos)*: cada membro é encorajado a estabelecer metas de curto e longo prazos e a comprometer-se com as tarefas de casa para atingir esses objetivos.
6. *Encerramento (de 5 a 10 minutos)*: os membros do grupo são convidados a refletir sobre o que foi trabalhado na sessão.

Entre os maiores desafios da terapia em grupo, está a manutenção da participação do paciente nos grupos em detrimento do abandono do tratamento. Oliveira e Argimon (2015) sugerem que tarefas de casa, por exemplo, podem gerar alguma resistência em adolescentes, sendo indicado

propor essas atividades durante o tempo de realização do grupo. Destacam que alguns focos precisam estar presentes em um programa de TCCG de adolescentes usuários de drogas, como a empatia, a colaboração mútua, o foco comum aos integrantes do grupo (uso de drogas), metas compartilhadas, o estabelecimento de vínculo (contrato de parceria), a construção de *links* entre as sessões, a identificação de situações de risco, a promoção de mudança no estilo de vida (recurso da balança decisória), a prevenção de recaída e o treinamento de habilidades (*role-playing*), tudo objetivando o comprometimento com o tratamento e o atingimento da mudança comportamental.

Assim, os facilitadores do grupo devem encorajar os membros que não alcançaram a abstinência a participar das sessões e, sempre que necessário, no contexto, verificar a necessidade de adoção de medidas de redução de danos (Marlatt, 1996). Dessa forma, os indivíduos são tratados com respeito incondicional, independentemente do uso persistente de substâncias, e trabalha-se para que possam avançar em seus estágios de mudança. O facilitador deve explicar aos membros do grupo que a meta final é a abstinência, mas que a perspectiva da redução de danos pode ser um importante passo no processo de tratamento (Liese et al., 2002).

Diferentemente do que ocorre em modelos psicodinâmicos ou métodos de grupos interacionais, os terapeutas cognitivo-comportamentais evitam focar nos conflitos interpessoais entre os membros dos grupos. As diferenças individuais entre os participantes são trabalhadas para que as pessoas possam aprender novas habilidades e, assim, são vistas como benéficas e produtivas (Orchowski & Johnson, 2012). No entanto, é necessário considerar que os integrantes do grupo podem estar em diferentes estágios motivacionais.

Por exemplo, alguns membros podem não reconhecer seus problemas com o uso de substâncias e a necessidade de tratamento, buscando o serviço por ordens familiares, médicas ou jurídicas; outros podem estar começando a reconhecer os problemas decorrentes do uso, enquanto outros, ainda, podem já estar se preparando para a mudança de comportamento ou mesmo já adotando algumas ações para modificar o consumo. Existem casos em que as pessoas buscam o tratamento apenas para a manutenção da abstinência.

Portanto, os terapeutas devem estar familiarizados com o Modelo Transteórico de Mudança de Comportamento (Prochaska et al., 1992), a fim de abordar adequadamente tais diferenças. Esse modelo será abordado com mais detalhes a seguir.

TERAPIA DE GRUPO E TERAPIA INDIVIDUAL PARA DEPENDÊNCIA QUÍMICA: QUAIS AS VANTAGENS E DESVANTAGENS?

Não têm sido constatadas diferenças significativas entre a terapia cognitivo-comportamental (TCC) para tratamento do uso de substâncias em grupo e individual (Davis et al., 2015; Magil & Ray, 2009; Sobell, Sobell, & Agrawal, 2009). Porém, são verificados poucos estudos que comparam a terapia para usuários de substâncias nesses diferentes formatos. A maioria das pesquisas tem-se concentrado em comparar a terapia em grupo a outras abordagens de tratamento (p. ex., TCCG vs. abordagem psicodinâmica), também em grupo. Por exemplo, em uma revisão da literatura (Orchowski & Johnson, 2012), foi verificado um menor índice de abandono e maiores medidas de abstinência na TCCG e no grupo de treinamento de habilidades de enfrentamento para tratamento de usuários de álcool, em comparação ao tratamento habitual (não sistemático) (Burtscheidt et al., 2001). O estudo de Bowen e colaboradores (2014) constatou que os usuários de substâncias em tratamento de grupo tanto de prevenção de recaída baseada em *mindfulness* quanto de prevenção de recaída padrão tiveram menor risco de recaída, e, entre aqueles que fizeram uso de substância, houve menos dias de uso, em comparação àqueles que receberam o tratamento habitual (programa de 12 passos e psicoeducação).

Alguns autores listam os seguintes obstáculos para uma adequada comparação entre tratamentos em grupo e individual: a heterogeneidade intrínseca às características grupais (maior suporte social em relação à terapia individual, a possibilidade de o grupo apresentar formato fechado ou aberto e incluir homens e mulheres); o fato de os pacientes terem de esperar semanas até que os grupos de tratamento sejam formados; e a maior dificuldade para

avaliar o terapeuta como um fator para o resultado. Além disso, alguns defendem que o grupo deve ser considerado uma unidade de análise, diferentemente do que ocorre em tratamentos individuais (Kadden et al, 2003; McRoberts, Burlingame, & Hoag, 1998).

Observa-se que a TCCG tem sido adotada por seu baixo custo e significativa efetividade. No entanto, é necessário considerar outros fatores do próprio quadro de uso de substâncias que fazem a modalidade em grupo ser indicada para essa população, como as vivências compartilhadas auxiliam os usuários a compreender como situações ou comportamentos específicos podem ser arriscados, interromper o isolamento social que normalmente ocorre com o uso da substância, experimentar uma sensação de aceitação e incentivo e aprender novos padrões de relações interpessoais (Krueger, 1979). Kadden e colaboradores (2003) acrescentam, ainda: sua ampla utilização na reabilitação do alcoolismo; o potencial efeito facilitador do ambiente social de um grupo sobre as mudanças cognitivas, afetivas e de comportamento; o sistema de apoio que os grupos oferecem para novos pacientes em recuperação; e a potencial redução de custos do tratamento em grupo em comparação com o individual.

MODELO TRANSTEÓRICO DE MUDANÇA DE COMPORTAMENTO

William R. Miller, no prefácio da obra *Tratamento em grupo para usuários de drogas: um manual de terapia baseado nos estágios de mudança* (Velasquez, Maurer, Crouch, & DiClemente, 2013), afirma que o Modelo Transteórico de Mudança do Comportamento (MTT), que incorpora a entrevista motivacional (EM) como estilo clínico, representou uma inovação de substantivo impacto no tratamento de dependentes químicos. Fumar, beber, usar outras drogas e jogar compulsivamente passaram, a partir do MTT, a ser encarados como comportamentos aditivos com mais semelhanças do que diferenças, em especial ao considerar as ideias de estágios, processos e níveis de mudanças.

O MTT, chamado, em sua língua materna, de *Transtheoretical Model of Intencional Behavior Change*, surgiu no fim da década de 1970, estabelecendo enfoque no processo de mudança comportamental e nos estágios motivacionais pelos quais as pessoas passam ao realizar quaisquer mudanças em suas vidas (DiClemente, 2003, 2015). O MTT oferece um modelo explicativo acerca desse processo de mudança e dos estágios motivacionais aí presentes, visando facilitar e orientar o trabalho do terapeuta sobre como intervir de acordo com o estágio motivacional no qual o cliente se encontra (Diehl, Cordeiro, & Laranjeira, 2011).

É importante observar que a motivação, nesse contexto, é entendida como multidimensional e ligada a diversificados sistemas humanos, eventos e influências. Não se trata simplesmente de uma chave que se possa ligar ou desligar (DiClemente, 2003). Assim, os estágios motivacionais são:

1. Pré-contemplação: estágio no qual a pessoa nega ter qualquer problema e não apresenta motivação para a mudança.
2. Contemplação: estágio da ambivalência. Começo da conscientização sobre a necessidade de mudar, passando a considerar os prós e os contras da mudança.
3. Preparação: fase de aumento do comprometimento e de preparação para a implementação de plano de ação.
4. Ação: etapa na qual a pessoa coloca em prática ações concretas na direção da mudança.
5. Manutenção: fase na qual a pessoa necessita empreender esforços para manter o novo padrão de comportamento conquistado (Diclemente, 2003, 2015).

Os mecanismos da motivação para a mudança presentes no modelo do MTT incluem as noções de “autoeficácia” (percepção que uma pessoa tem acerca de sua própria capacidade para realizar uma tarefa) e “processos de mudança” (processos cognitivos e/ou processos comportamentais), os quais exercem importante influência nas tomadas de decisão do sujeito (Diclemente, 2003; Velicer, DiClemente, Rossi, & Prochaska, 1990).

Para o mapeamento dos estágios motivacionais, foi criada a escala URICA (University of Rhode Island Change Assessment Scale), desenvolvida por McConaughy, Prochaska e Velicer, em 1983, e adaptada e validada para a realidade brasileira por Szupszynski e Oliveira no ano de 2008. A Escala de Processos de Mudança (EPM), por sua vez, foi desenvolvida por Prochaska, Velicer, DiClemente e Fava (1988). A EPM permite conhecer quais processos de motivação para a mudança estão ativados no indivíduo: os cognitivos ou os comportamentais. A EPM também foi adaptada e validada para o Brasil por Szupszynski e Oliveira (2008).

GRUPOS CLÍNICOS E AS ETAPAS DO TRATAMENTO

Velasquez e colaboradores (2013) desenvolveram um manual de terapia em grupo para usuários de drogas que apresenta 29 sessões e oferece uma estrutura integrativa para compreender, mensurar e intervir na motivação para a mudança de comportamento. Trata-se de um modelo que foi adotado pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA) para o desenvolvimento de materiais visando à cessação do tabagismo e também por outros órgãos governamentais. Os autores asseguram que o clínico experiente será capaz de selecionar as sessões mais apropriadas para compor um protocolo adaptado ao grupo que estiver atendendo, sendo esse um protocolo flexível para atender às demandas do tratamento. Aconselham, nesse caso, que os grupos sejam compostos por 8 a 12 pessoas, ocorrendo de 1 a 3 vezes por semana e com sessões de 60 a 90 minutos, a depender do tamanho do grupo.

A primeira etapa do tratamento consiste na avaliação do participante e visa identificar o estágio motivacional no qual se encontra. Para a identificação do estágio motivacional, recomendam-se três maneiras: 1) entrevista clínica; 2) régua de prontidão; e/ou 3) questionário da URICA. Para tanto, é importante que o cliente tenha em mente que essa avaliação visa oferecer o atendimento mais adequado, de modo que seja convidado a expressar com honestidade sua percepção sobre a relação que tem com as drogas (Velasquez et al., 2013).

Esse protocolo foi adaptado para o Brasil para oito sessões, quatro direcionadas para processos cognitivos e quatro voltadas para processos comportamentais, pensadas para serem realizadas duas vezes por semana, ao

longo de quatro semanas. Essa intervenção foi modelada para locais de internação e tratamentos ambulatoriais, tendo mantido preservados os 10 processos de mudança trabalhados no protocolo de 29 sessões (Quadro 11.2) (Szupszynski, 2012).

Quadro 11.2 Estrutura das sessões da versão brasileira adaptada do manual norte-americano

Sessão	Tema	Processo de mudança
Sessão 1	Estágios motivacionais do MTT Explicação dos estágios do Modelo de Mudança	Ampliação da consciência
Sessão 2	Um dia na vida do uso de drogas - Aumentar a consciência dos clientes com relação a quantidade e frequência de seu uso de substâncias - Conscientização dos malefícios do abuso de drogas	Ampliação da consciência
Sessão 3	Relacionamentos interpessoais - Reflexão de que o uso de drogas pode afetar outras pessoas - Discussão sobre como as pessoas expressam preocupações quanto à utilização de substância	Alívio emocional, autorreavaliação e reavaliação circundante
Sessão 4	Autoeficácia, tentação e resolução de problemas - Identificar situações tentadoras para o uso de substância - Avaliar sua confiança para conseguir não usar drogas - Aprender a resolver problemas	Autoeficácia e aprendizado sobre tentação
Sessão 5	Treino de habilidades para recusar drogas - Desenvolvimento de habilidades de recusa - Compreensão de quão importante é gratificar comportamentos positivos	Contracondicionamento, gerenciamento de reforço e controle de estímulos
Sessão 6	Gerenciando desejos e impulsos - Gerenciamento de pensamentos - Avaliação de novas atividades - Resolução de problemas	Contracondicionamento, gerenciamento de reforço e controle de estímulos
Sessão 7	Plano de ação - Revisão de técnicas para evitar o uso de álcool e outras drogas - Construção de um plano de ação	Autodeliberação, deliberação social e relações de ajuda
Sessão 8	Revisão e encerramento Resumo e fixação dos pontos principais abordados	Autoeficácia e prevenção de recaída

Fonte: Rodrigues (2013) e Szupszynski (2012).

A seguir, serão apresentadas as oito sessões especificando os temas trabalhados em cada encontro. Também serão disponibilizadas vinhetas visando exemplificar essa proposta de trabalho desenvolvido a partir do protocolo de TCCG com base no MTT.

SESSÃO 1 – ESTÁGIOS MOTIVACIONAIS DO MTT

- a. **Abertura:** Contrato de trabalho – estabelecer contrato visando criar e manter ambiente de respeito e sigilo entre os participantes do grupo.
- b. Apresentação dos participantes – convidar todos a se apresentar no grupo.
- c. **Dinâmica 1:** Definir o que é motivação e mapear as motivações dos integrantes do grupo – o que motiva cada um a mudar?

“Eu me dei conta do que eu estava fazendo, estava destruindo minha saúde. Motivação... família, eu tenho filho, e hoje meu dou conta... quando eu estava no uso eu não me importava muito... me importava, mas não a ponto de querer ajudar, visitar. Hoje sim, quero ser um bom exemplo, um bom pai, uma pessoa que ele possa se espelhar no futuro. Isso para mim é uma grande motivação, meu filho. Também minha mãe e minha esposa.”

- d. **Dinâmica 2:** Definindo o que é mudança, psicoeducação sobre os estágios de mudança (pré-contemplação, contemplação, preparação, ação e manutenção) e como as pessoas mudam – trabalhando a consciência sobre a mudança como um processo, e não como algo estanque, bem como sobre as variáveis relacionadas à mudança e à resistência à mudança.

“Assim, mudança... acho que primeiro tem que identificar o que mudar, tem que se conhecer um pouco. Daí vem a ajuda do grupo também porque às vezes a pessoa não se percebe. Por isso que eu acho importante o tratamento no grupo.”

Após a psicoeducação sobre os estágios motivacionais, pode-se trabalhar com trechos de histórias de pessoas para que os participantes do grupo busquem identificar em que estágio motivacional a pessoa da história se encontra, como o trecho a seguir:

“M. está acima do peso. Realizou alguns abdominais na última semana e está conversando com alguns amigos para saber como funciona a rotina da academia que frequentam. Na segunda, quando iria na academia, acabou tirando uma soneca. Em que estágio motivacional M. se encontra?”

Também se pode provocar uma reflexão aos participantes do grupo sobre qual estágio estão neste momento em relação aos estágios motivacionais. É interessante convidar todos a fazer uma reflexão individual, após entrega de material de apoio que contenha todos os estágios motivacionais, para que os participantes possam circular onde percebem estar em termos motivacionais. Após essa etapa de reflexão individual, todos são convidados a compartilhar no grupo sua autoavaliação, para apreciação de todos os participantes.

“Eu botei ação também, mas colocaria junto um pouquinho da preparação, porque aqui ó, tenho um plano para abandonar o uso.”

- e. **Fechamento:** No fim da sessão, um resumo dos principais conceitos trabalhados pode ser entregue a todos em um material previamente compilado pelo terapeuta, e recomenda-se que seja lido em conjunto no grupo antes do término do primeiro encontro. Por fim, solicita-se o *feedback* dos participantes sobre a sessão grupal, pedindo pontos de destaque para eles.

“O que mais me chamou atenção foi quando a gente falou da motivação e mudança. Se eu não tiver motivado, não vou mudar, e se não mudar, vou usar droga de novo. E vou continuar na mesma. Então eu acho que o foco principal dentro da recuperação é esse aí. Motivação pra mudar, e mudando tu vai ter outras consequências que não seja o uso.”

SESSÃO 2 – UM DIA NA VIDA DO USO DE DROGAS

- a. **Abertura:** A TCCG prevê a retomada da sessão anterior, assim como no modelo individual, objetivando realizar junto ao grupo um breve resumo do que foi visto no primeiro encontro.
- b. **Dinâmica 1:** Um dia na vida do uso de drogas – os participantes são convidados a lembrar como era um dia de uso e compartilhar as experiências verbalmente, com o intuito de ampliar a consciência sobre os prejuízos do uso.

“Nunca parei pra pensar. [...] Eu pensava só como que eu ia fazer pra conseguir mais dinheiro, quem eu ia roubar, quem não ia roubar. E assim

era o dia inteiro, né. Não pensava no sentimento dos outros. Não pensava em mim como eu tava. Tava uma caveira ambulante e não tava nem aí. Não importava o que os outros falavam pra mim. Importava o que eu pensava.”

- c. **Dinâmica 2:** Um dia na vida – após ouvir o relato dos participantes, convida-se o grupo para realizar um exercício chamado “Um dia na vida”. Cada um deve descrever em uma folha de papel como é um dia típico do uso de drogas, o que era mais comum nesse dia, aquilo que mais representa o período de ativa no uso das drogas. Devem descrever o uso desde a hora que levantam pela manhã até o meio-dia. Depois, devem descrever o uso das 12 às 18 horas. E, por fim, pede-se que descrevam o uso das substâncias das 18 horas até a hora de irem para a cama.

“Aqui eu me dei conta que eu não conseguia manter o serviço, não conseguia manter uma vida normal. Não conseguia... aqui eu posso ver que não conseguia nem me manter em casa, eu morava sozinho, né. E nem ajudar meu filho. E eu tava achando que conseguia.”

- d. **Dinâmica 3:** Exercício para mapeamento dos prejuízos a partir do uso das drogas – distribui-se material de apoio contendo a consigna que pergunta: quais os prejuízos que a droga pode trazer? Tabaco/Maconha/Cocaína/*Crack*. Objetiva promover a reflexão e a ampliação da consciência sobre os impactos do uso das drogas na vida da pessoa.

“O usuário de *crack*, assim, muitos se envolvem com comportamentos violentos, né. Então não é só o físico, dentro do organismo. Leva uma facada, um tiro, um soco.”

- e. **Fechamento:** Discute-se sobre a proposta inicial da sessão, os objetivos atingidos, as conclusões, tudo visando auxiliar no processo de conscientização acerca das consequências do uso das drogas na vida.

“Eu não gosto de relembrar do passado, mas às vezes é bom a gente lembrar de onde veio pra não voltar, né.”

SESSÃO 3 – RELACIONAMENTOS INTERPESSOAIS

a. **Abertura:** Retomada da sessão anterior.

b. **Dinâmica 1:** Relacionamentos – Dinâmica da história de uma vida. Convida-se os participantes a contarem uma história, qualquer história, da vida de uma pessoa. Um integrante do grupo começa, e todos passam a completar a história. Após seu término, os participantes são convidados a refletir sobre a história contada pelo grupo e sobre a importância dos relacionamentos na vida. Deve-se ressaltar que a história depende da parte de outros, o que reflete a vida e pode interferir na parte de cada um da história. São indicadas, para esse momento, potenciais conclusões sobre a importância das relações, sobre a possibilidade de mudança na vida, quanto ao aprendizado constante com a experiência, a construção da maturidade, a importância do desenvolvimento da tolerância e paciência, a constante construção na vida.

“Às vezes, eu não percebo que estou machucando minha família, que estou afastando ela. Daí eu tô preocupado com o companheiro, que tá aqui comigo aqui, que a família dele se afasta... daí eu fico pensando, poxa a minha também se afasta, e eu não enxergo isso.”

c. **Dinâmica 2:** Exercício “Mapa relacional” – entrega-se uma folha de papel aos participantes, convidando-os a preenchê-la com o nome das pessoas com as quais se relacionam. Depois, pede-se que desenhem um alvo e que no círculo central sejam colocadas as iniciais das pessoas mais próximas, mais íntimas. Após, solicita-se que, nos outros elos, sejam dispostas as iniciais das pessoas de acordo com o grau de aproximação relacional. Por último, solicita-se que sublinhem o nome das pessoas com quem acreditam que o relacionamento pode melhorar ou com quem desejam melhorar o relacionamento. Os participantes são convidados a discutir sobre o que perceberam sobre o exercício.

“Pra mim não foi tão simples porque... eu também convivo mais é com a minha família. Eu citei tio, avós, amigos, mas convivo mais com a minha família, né, mas não é muito fácil. Tanto é que coloquei aqui que eu tenho

que me aproximar mais justamente da minha família, porque convivo com eles, mas quando eu tava na drogadição não tava fácil. Tava bem difícil a convivência, por isso eu quero me aproximar mais deles, principalmente dos meus filhos.”

- d. Dinâmica 3:** Exercício “Quem está preocupado?” – Mapear o nome das pessoas que estão preocupadas com o uso de drogas do participante do grupo. Elencar quais eram essas preocupações e de que forma essas pessoas demonstravam isso. Também levantar o fato de o próprio indivíduo já ter se preocupado com o próprio uso de drogas e quais foram essas preocupações.

“Pessoas preocupadas, tem várias, dá pra citar um monte. Dezenas. As preocupações delas, principalmente da minha família, é de eu ser morto, de me tornar um dependente crônico, o que me tornei mesmo, de deixar de ser um bom marido, de ser um bom filho, um bom genro, um bom - padrinho, um irmão, amigo, e me tornar um ladrão insano e adquirir doenças em geral... e da minha falência como ser humano, a minha decadência total, né.”

- e. Fechamento:** Fechamento do grupo, retomando o objetivo inicial, de tratar dos relacionamentos e do impacto do uso de drogas nas relações interpessoais. Além disso, abordar como as pessoas podem expressar preocupações, as quais nem sempre se manifestam de uma maneira amistosa ou tolerante, visando ampliar a compreensão e a empatia com os familiares e amigos.

SESSÃO 4 – AUTOEFICÁCIA, TENTAÇÃO E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- a. Abertura:** Retomada dos assuntos abordados no último encontro. Introdução do trabalho sobre autoeficácia, tentação e resolução de problemas. O que são tentações e gatilhos em relação às drogas? Qual a relação entre confiança e tentação?

“Eu acho que meu maior gatilho é minha explosão, eu faço as coisas sem pensar... me estresso muito. Vivo estressado. As vezes que eu recaí foram sempre na minha explosão. Ela não queria saber, brigava com o cara, não queria conversar, saía batendo porta. Não tinha aquele momento de parar e refletir e tentar conversar. [...] Daí eu já brigava com ela, saía de casa. [...] Como eu sou dependente químico, eu ia pra droga.”

- b. **Dinâmica 1:** Exercício “Situação de tentação/gatilhos” – Fornecer material de apoio com alternativas de situações potencialmente causadoras de tentação. Orientar os participantes a marcar um X nas situações que causam maior tentação para o uso de drogas. Em seguida, orientar a categorizar os gatilhos nos seguintes *clusters*: estados emocionais negativos, problemas físicos, pressão social e vontade de usar. Propor o debate sobre o trabalho.
- c. **Dinâmica 2:** Exercício “Resolvendo meus problemas” – Orientar a listar em três colunas o problema (situação-gatilho), as soluções possíveis e as consequências positivas e negativas das soluções. Aqui se propõe uma espécie de listagem de prós e contras para cada solução em potencial.

“Eu botei brigas, daí, sem controle. Aí, quais as possíveis soluções? Enfrentar, conversar, parar de pensar, ter controle. As consequências positivas são... a primeira, enfrentar de mente aberta, conversar é aceitação, parar de pensar é uma ação, ter controle é um movimento contrário. As consequências negativas que eu posso levar: ter um descontrole, fuga, uso, raiva, briga, sem aceitação.”

- d. **Fechamento:** Resumo da sessão.

“Nesse último exercício eu vi, eu pude – não só no meu, identifiquei nos outros também – separar ou identificar qual a solução melhor pra mim. Porque tem algumas, que nem tu falou, algumas de repente soluções boas que vão trazer boas consequências e vão trazer consequências negativas que de repente vão ser maiores que as positivas. De repente isso aí vai me causar mais frustração e vai me levar mais rapidamente ao uso de drogas. Então tem que cuidar bem qual solução mais assertiva posso tomar.”

SESSÃO 5 – TREINO DE HABILIDADES PARA RECUSAR DROGAS

- a. **Abertura:** Retomada da sessão anterior. Introdução aos temas das habilidades de recusa ao uso das drogas e da importância de recompensar a si mesmo pelos sucessos conquistados. Convida-se, a partir disso, os participantes a compartilhar a experiência de cada um sobre recusar o uso de drogas.

“Tava sozinho e tava indo embora; no caminho pra casa, indo embora, pensei: mas vou, não vou, eu não vou... daí quando vejo que falta poucos metros, falo ‘ah, quer saber, eu vou’. Não consigo dizer não.

Terapeuta: E você já conseguiu dizer não?

Paciente: Já, muitas vezes.

Terapeuta: E como foi? Como você se sentiu depois?

Paciente: Me senti super bem.”

- b. **Dinâmica 1:** Propor que o grupo se divida em duplas para a realização de um *role-playing*. O material de apoio aborda uma consigna que propõe a prática da recusa em uma situação de tentação ao uso vivenciada com um amigo. Após o exercício, convida-se o grupo a discutir sobre o assunto e problematizar as semelhanças e diferenças com o que acontece na realidade.
- c. **Dinâmica 2:** Propor o exercício “Gratificando meu sucesso”, elencando-se coisas que se pode fazer para gratificar o próprio êxito. Aborda-se a importância e o entendimento de que a recompensa pelo sucesso pode reforçar o comportamento de recusa da droga.

“Posso me recompensar contando pra alguém próximo de mim, que esteja me apoiando, que vai ver que o apoio tá dando resultado e, de repente, vendo a felicidade que a pessoa vai ter, vai me motivar a continuar. Botei também um momento de prazer, lazer também pode ser, dar uma volta. Botei também... eu acho que a maior recompensa que eu posso ter quando nego uma droga é o sentimento bom que gera dentro de mim, né. É... -

porque bens materiais isso aí nunca... eu sempre acabei tendo e não valorizava. Então, não sei. É o sentimento em mim de alegria, de autoconfiança, em saber que o processo está dando certo.”

d. Fechamento: Resumo e avaliação do encontro.

SESSÃO 6 – GERENCIANDO DESEJOS E IMPULSOS

a. Abertura: Retomada do encontro anterior e dos assuntos tratados, ressaltando-se a importância de estabelecer limites e adotar posicionamentos de recusa. Introdução ao tema que será abordado na sessão, que é relacionado ao “Gerenciamento dos desejos e impulsos”. Os participantes são convidados a falar daquilo que entendem por essas palavras e a trazer exemplos de bons e maus gerenciamentos dos desejos e impulsos. O gerenciamento adequado dessas variáveis deve resultar na abstinência, na prática de recusa, no aumento da autoeficácia e no estabelecimento de gratificações positivas.

“Um mau gerenciamento é bater a fissura e não procurar recursos, não pedir ajuda, não falar com ninguém, simplesmente fugir de casa. Impulsivamente buscar o uso.”

b. Dinâmica 1: Exercício com base em material de apoio que convida o participante a refletir. Na consigna, consta ao participante: “Eu posso gerenciar desejos e impulsos”. O primeiro passo é exercitar reconhecer o desejo e o impulso e dizer em voz alta “Estou tendo o impulso para usar drogas”. Após a identificação do desejo e do impulso, deve-se identificar os pensamentos negativos e buscar questioná-los. No que estou pensando agora? Este pensamento pode me causar problemas? Se estivesse num lugar diferente, eu estaria tomando essas decisões? O terceiro passo é a busca de relembrar o mapeamento de prós e contras sobre o uso de drogas (o que é bom e o que é ruim em usar drogas?). O quarto passo é o de encorajar a si próprio, relembrando todos os sucessos já conquistados, todo o esforço já empreendido nessa busca pela abstinência. A quinta etapa é a de mapear três sucessos nessa relação com as drogas. Por fim,

deve-se mapear pessoas com as quais se pode conversar e pedir ajuda. Após terminar as anotações, os participantes são convidados a compartilhar suas experiências.

- c. **Dinâmica 2:** Esse exercício convida os membros do grupo a refletir sobre atividades alternativas, bem como a escrever novas atividades que podem realizar sem o uso de drogas. Trata-se da busca da construção de um planejamento que possa ser operacionalizado para a concretização da mudança. A partir dessa atividade, deve-se pensar nos entraves em potencial para sua realização e, por fim, em como se pode trabalhar para que se consiga realizar a atividade.

“E outra situação e atividade nova que eu já fui bastante, só que deixei de ir, é numa igreja, né. Daí o que poderia me atrapalhar de ir numa igreja é achar que eu não preciso ir naquele dia. Ah, eu tô bem, essa semana foi tudo bem, hoje eu não preciso ir na igreja. Então, o que eu faço pra lidar com essa possível... que me atrapalha. Pensar no quanto me fortalece e me beneficia ir numa igreja. Pensar no depois que eu fui na igreja e como eu saio da igreja, e quanto é bom ir na igreja.”

- d. **Fechamento:** Encerramento do grupo com a potencialização das conscientizações mais expressivas relacionadas ao tema.

SESSÃO 7 – PLANO DE AÇÃO

- a. **Abertura:** Retomada do último encontro, convidando o grupo a relembrar quais foram os temas trabalhados. Introdução ao tema da sessão atual, que é plano de ação. Convidar todos a expressar sua compreensão sobre o que seja plano de ação. Trata-se de um plano a ser empreendido na construção dessa mudança comportamental, devendo atender a alguns requisitos, como ser executável, avaliar riscos e oportunidades, ser factível, avaliar pontos de apoio e suporte, promover o autoconhecimento e a manutenção da meta da abstinência.
- b. **Dinâmica 1:** O primeiro exercício é sobre “Meu plano de ação”, e sugere-se oferecer material de apoio. Convida-se o participante, após a leitura de uma consigna a ser inserida no material de apoio, a refletir e escrever

sobre como irá lidar com tentações quando elas ocorrerem. Propor que busquem mapear seis estratégias a serem traçadas como caminhos para a evitação de uma recaída.

“Se eu começar a sentir tentação, irei fazer o seguinte: identificar o porquê da tentação, pensamentos negativos que podem estar me dando essa tentação. Pedir ajuda para familiares, junto com a minha espiritualidade, o poder superior, né. Medir prós e contras sobre o uso ativo. Pensar naqueles dias de uso intenso e pensar nos dias de hoje, pesar, fazer uma balança. Distrair, tentar mudar pensamentos. Correr para um grupo de autoajuda e, se necessário, medicação.”

- c. **Dinâmica 2:** O segundo exercício é sobre: onde posso conseguir ajuda? Os participantes são convidados a mapear os locais onde podem conseguir ajuda nos diversos círculos sociais que permeiam a realidade cotidiana, como família, trabalho, religião, serviços de saúde, lazer, escola e amigos. Devem colocar o nome de pessoas com as quais possam contar em momentos de dificuldade ou fissura.

“É bom reavivar isso, que sozinho não tem como, né? Que na minha ação eu vou ter que contar com pessoas, assim como eu conto hoje.”

- d. **Dinâmica 3:** Levantamento de necessidades – convida-se o participante a mapear o que está sob controle na sua vida e o que será preciso melhorar nos seguintes domínios: corpo, lazer, social, família, trabalho, educação, carreira, financeiro, mundo, dignidade, situação e espiritualidade. Todas essas reflexões intentam auxiliar o indivíduo a construir seu plano de ação, sendo importante integrar tais áreas da vida.
- e. **Fechamento:** Avaliação do encontro e síntese dos tópicos trabalhados.

SESSÃO 8 – REVISÃO E ENCERRAMENTO

- a. **Abertura:** Revisão de todos os sete encontros anteriores. Utiliza-se material de apoio para que registrem tudo o que lembram sobre cada sessão. Avalia-se se ocorreram mudanças na motivação e na percepção sobre o contexto de uso de drogas. Na finalização do trabalho, é realizado

um *feedback* individual a cada membro do grupo por parte do facilitador, e abre-se o espaço para o *feedback* dos participantes sobre o trabalho.

“Quero dizer que foi de grande valia pra mim. Foi mais um aprendizado na minha vida, não só em questão de tratamento sobre dependência química, mas uma lição de vida.”

TCCG PARA TABAGISMO

Esta sessão trará uma proposta de tratamento em grupo com base na TCC. Sabe-se o quanto é difícil parar de fumar sem ajuda. O fumante geralmente é um paciente que tem baixa autoestima e nunca acredita ser capaz de largar o cigarro. O uso da TCCG é um modelo de atendimento que tem tido sucesso na abordagem desses pacientes, e, quando os grupos são formados dentro de uma empresa ou instituição de saúde, o sucesso chega a 65 a 70% em um ano de abstinência.

Em relação ao trabalho em grupos com esses pacientes, a literatura traz vários achados, mas que focam basicamente na utilização de medicação ou reposição de nicotina. Ainda são utilizadas somente técnicas de controle comportamental, em vez da TCC propriamente dita, na condução desses indivíduos. Nesses estudos, o sucesso do tratamento varia de acordo com o desenho metodológico, mas, em sua maioria, o índice de sucesso varia de 25 a 40% em um ano de abstinência (Ismael, 2007).

Nessa modalidade de tratamento, os grupos têm formação espontânea, ou seja, os pacientes procuram pelo grupo de tratamento caso manifestem vontade de parar de fumar. Os grupos são formados com, no mínimo, sete participantes, e no máximo 12. Trata-se de um grupo fechado, com um roteiro que tem começo, meio e fim. A duração é de nove sessões, sendo seis sessões semanais, duas quinzenais e uma mensal, totalizando três meses e meio de tratamento. Cada sessão tem um tempo médio de 1 hora e 15 minutos.

Chegando ao ambulatório, os pacientes eram cadastrados e recebiam um questionário que permitia verificar os dados sociodemográficos, quanto tempo como fumante, quantidade média de cigarros fumados diariamente,

tentativas para parar de fumar, dependência física da nicotina (Teste de Fagerström), dependência psicológica (Razões para Fumar) e condicionamentos ou comportamentos associados ao cigarro (Fagerström & Schneider, 1989; Ismael, 2007; Souza, Crippa, Pasian, & Martinez, 2009).

O tratamento em grupo é fundamental, pois nele é possível que os indivíduos exercitem o processo de identificação com outros pacientes; ou seja, eles percebem que suas dificuldades são as mesmas de outras pessoas, e as trocas entre os grupos fortalecem as decisões e amenizam o sofrimento emocional na cessação do cigarro. Ainda, o processo de diferenciação não é menos importante, uma vez que, ao perceber que outros pacientes podem ter dificuldades diferentes ou mesmo piores, a autoestima do fumante, que geralmente é muito baixa, pode ser manejada.

DESCRIÇÃO DA INTERVENÇÃO PSICOLÓGICA

Fiore (2008), Ismael (2007), Labbadia e Ismael (1995) e Labbadia, Ismael e Fernandes (1995).

Sessão 1: É realizado o acolhimento dos pacientes. Cada participante realiza uma breve apresentação pessoal, trazendo o motivo pelo qual veio ao grupo. Realiza-se uma breve sensibilização para contextualizar o tabagismo no Brasil e as formas de tratamento. Colocam-se os pacientes cientes do processo de tratamento (como serão as sessões, tempo e duração, necessidade de avaliação médica para uso de medicação, dúvidas a respeito do programa), dando-se, assim, início ao tratamento. Trabalham-se com o grupo as ambivalências que permeiam o processo, os benefícios de parar de fumar, o que é dependência física e psicológica e como funcionam os gatilhos (condicionamento). Entre a primeira e a segunda sessão do programa, os pacientes são atendidos pelo médico, para poder prescrever a medicação a ser utilizada durante o tratamento.

Sessão 2: As sessões sempre são iniciadas com os participantes trazendo questões importantes vivenciadas na semana anterior. Realiza-se, nesse momento, o *feedback* do questionário inicial respondido por eles para definir o perfil de cada fumante, explicando detalhadamente os itens referentes à

dependência física e psicológica e os condicionamentos estabelecidos. Estabelece-se com cada um o critério de cessação de acordo com o número de cigarros fumados e de acordo com a terapia medicamentosa estabelecida. Discute-se com cada indivíduo as mudanças a serem realizadas (observadas no questionário inicial). Aqui já se fala brevemente sobre algumas técnicas de controle comportamental, além de se trabalhar o conceito de assertividade. Caso os pacientes apresentem algum pensamento automático ou disfunções cognitivas, estes já são trabalhados dentro do contexto da TCC. O processo de cessação gradual pode ser iniciado no dia seguinte à segunda sessão, e, se a cessação for abrupta, combina-se uma data com o paciente entre a segunda e terceira sessão para parar de fumar.

Sessão 3: As sessões sempre são iniciadas com questões importantes vivenciadas na semana anterior. Discute-se, com cada um, como estavam sendo feitas as mudanças a serem realizadas (observadas no questionário inicial) e como estavam seguindo o processo de parada do cigarro. Sempre é reforçado o uso das técnicas de controle e trabalhadas as disfunções cognitivas trazidas pelos sujeitos durante o processo. A técnica do reforço positivo quanto aos progressos efetuados pelos pacientes é utilizada o tempo todo, além do levantamento de algumas situações de risco que podem levar a recaída.

Sessão 4: Nesta sessão, pretende-se que o grupo todo, ou pelo menos 80% dele, já esteja abstinente do cigarro. Verifica-se como os pacientes se sentem nesse processo do ponto de vista físico e psicológico, assim como em relação a algumas situações comportamentais difíceis de serem trabalhadas.

Das sessões 5 a 8, assim como o retorno de 30 dias após a oitava: Trabalha-se a abstinência do cigarro, as dificuldades em relação a buscar recursos de enfrentamento para lidar com as situações do dia a dia, trabalhando-se com os pensamentos disfuncionais e buscando-se alternativas por meio do diálogo socrático.

Nesse período, é focada, a todo momento, a prevenção de recaída. Para isso, é fundamental trabalhar a ansiedade e o estresse e como lidar com essas

situações e pensar nas situações de risco que podem levar à recaída, como, por exemplo, o uso de bebida alcoólica. Ao fim do tratamento, é realizada uma avaliação final com cada paciente do grupo, a fim de verificar e orientar a manutenção do processo, uma vez que, segundo a literatura, o indivíduo só é considerado ex-fumante após um ano de abstinência do cigarro.

RESULTADOS

Em geral, os grupos terminam com 80 a 100% de pacientes abstinentes na oitava sessão. A recaída é esperada, mas, quando se associa a TCCG ou mesmo a TCC individual, ela vem acontecer após os três meses de tratamento, podendo a maioria dos pacientes ficar abstinente até o sexto mês. A partir daí até 12 meses do tratamento, pode ocorrer de 30 a 40% de recaída, indicando um sucesso muito maior do que aquele citado quando somente se usam medicação e algumas técnicas comportamentais sem terapia.

Na pesquisa de doutorado de Ismael (2007), utilizando medicação e TCCG, o sucesso foi de 49,5% em um ano de abstinência. Essa porcentagem de sucesso foi um pouco menor do que se consegue no tratamento que não envolve um protocolo de pesquisa, pois, no grupo habitual, respeita-se o perfil de fumante e a forma como ele determina o processo de cessação do tratamento, além de, dentro do possível, as dificuldades de cada paciente, sem prejudicar o andamento do grupo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E TENDÊNCIAS

Conforme abordado ao longo do capítulo, a TCCG configura-se como uma intervenção psicológica em grupo com base na TCC, sendo absolutamente favorável à criação de um contexto facilitador do processo transformacional ao participante. A vivência oportunizada pela TCCG pretende estimular a ampliação da consciência e do repertório comportamental, bem como contribuir para a generalização dos aprendizados assimilados a outros contextos. O espaço do compartilhamento grupal atua como importante ferramenta para a fixação dos conceitos trabalhados, na medida em que os

exemplos que se manifestam no grupo servem como reforçadores dos conteúdos propostos.

A TCCG vem demonstrando ser um modelo bastante promissor para o tratamento dos quadros de dependência química. O grupo com base no modelo da TCC permite que os participantes percebam variáveis intervenientes em seus processos motivacionais de forma clara e em uma linguagem bastante simples e compreensível. O conhecimento acerca do modelo cognitivo, incluindo as noções de crença central, esquemas cognitivos, pensamentos automáticos, distorções cognitivas, estratégias compensatórias, entre outras, tende a instrumentalizar os participantes a um melhor enfrentamento das situações disparadoras de fissura.

A aplicação da TCCG proporciona ao participante a experimentação de uma sensação de aceitação e incentivo, impactando para o aumento da autoeficácia e o fortalecimento da prevenção de recaída. A TCCG configura um espaço facilitador do aprendizado de novos padrões de relações interpessoais. O sistema de apoio que os grupos oferecem para pacientes em recuperação, a ampliação da adesão ao tratamento e a potencial redução de custos com o tratamento em grupo compõem um cenário que aponta para a aplicabilidade e a efetividade da TCCG para o tratamento de usuários de drogas.

REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association (APA). (2002). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais:DSM-IV-TR* (4. ed.). Porto Alegre: Artmed.

American Psychiatric Association (APA). (2014). *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais: DSM-5* (5. ed.). Porto Alegre: Artmed.

Bandura, A. (1977). *Social learning theory*. New York: General Learning Press.

Bastos, F. I., & Bertonini, N. (2013). *Perfil dos usuários de crack e/ou similares no Brasil*. Rio de Janeiro: Fiocruz.

Beattie, M. C., & Longabaugh, R. (1997). Interpersonal factors and post-treatment drinking and subjective well-being. *Addiction*, 92(11), 1507-1521.

Beck, A., Wright, F. D., Newman, C. F., & Liese, B. S. (1993). *Cognitive therapy of substance abuse*. New York: Guilford Press.

- Bowen, S., Witkiewitz, K., Clifasefi, S. L., Chawla, N., Hsu, S. H., & Carroll, H. A. (2014). Relative efficacy of mindfulness-based relapse prevention, standard relapse prevention, and treatment as usual for substance use disorders: A randomized clinical trial. *Journal of the American Medical Association Psychiatry*, 71(5), 547-556.
- Burtscheidt, W., Wolwer, W., Schwarz, R., Strauss, W., Loll, A., Luthcke, H., ... Gaebel, W. (2001). Out-patient behaviour therapy in alcoholism: Relapse rates after 6 months. *Acta Psychiatrica Scandinavica*, 103(1), 24-29.
- Caballo, V. E. (2003). *Manual de avaliação e treinamento das habilidades sociais*. São Paulo: Santos.
- CDC Foundation. (2015). *The Global Adult Tobacco Survey Atlas*. Recuperado de http://gatsatlas.org/#section_read
- Davis, M. L., Powers, M. B., Handelsman, P., Medina, J. L., Zvolensky, M., & Smits, J. A. J. (2015). Behavioral therapies for treatment-seeking cannabis users: A meta-analysis of randomized controlled trials. *Evaluation & The Health Professions*, 38(1), 94-114.
- Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2001). *Inventário de habilidades sociais: Manual de aplicação, apuração e interpretação*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- DiClemente, C. C. (2003). *Addiction and change: How addictions develop and addicted people recover*. New York: Guilford Press.
- DiClemente, C. C. (2015). Change is a process not a product: Reflections on pieces to the puzzle. *Substance Use & Misuse*, 50(8-9), 1225-1228.
- Diehl, A., Cordeiro, D. C., & Laranjeira, R. (Orgs.). (2011). *Dependência química: Prevenção, tratamento e políticas públicas*. Porto Alegre: Artmed.
- Fargeström, K. O., & Schneider, N. G. (1989). Measuring nicotine dependence: A review of the Fagerström Tolerance Questionnaire. *Journal of Behavioral Medicine*, 12(2), 159-182.
- Fiore, M. C. (Ed.). (2008). *Treating tobacco use and dependence: 2008 Update: Clinical Practice Guideline*. Rockville: U.S Department of Health and Human Services.
- Instituto Nacional de Câncer. (2011). *Convenção-quadro para o controle do tabaco*. Rio de Janeiro: INCA.
- Ismael, S. M. C. (2007). *Efetividade da terapia cognitivo-comportamental na terapêutica do tabagista* (Tese de doutorado não publicada, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Jungerman, F. S. (2013). Prevenção de recaída. In N. A. Zanelatto, & R. Laranjeira (Eds.), *O tratamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais: Um guia para terapeutas* (Cap. 7, pp. 122-134). Porto Alegre: Artmed.
- Kadden, R., Carroll, K., Donovan, D., Cooney, N., Monti, P., Abrams, D., ... Hester, R. (2003). *Cognitive-behavioral coping skills therapy manual: A clinical research guide for therapists treating individuals with alcohol abuse and dependence*. Washington: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism.
- Krueger, D. W. (1979). Clinical considerations in the prescription of group, brief, long-term, and couples psychotherapy. *Psychiatric Quarterly*, 51(2), 92-105.
- Labbadia, E. M., & Ismael, S. M. C. (1995). Uma visão psicológica do tabagista. In M. F. P. Oliveira, & S. M. C. Ismael (Orgs.), *Rumos da psicologia hospitalar em cardiologia*. São Paulo: Papyrus.

- Labbadia, E. M., Ismael, S. M. C., & Fernandes, N. D. (1995). Atendimento multiprofissional ao tabagista. *Revista da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo*, 5(5 Supl A), 6-11.
- Laranjeira, R., Madruga, C. S., Pinsky, I., Caetano, R., Mitsuhiro, S. S., & Castello, G. (Orgs.) (2012). *Segundo levantamento nacional de álcool e drogas: Lenad*. São Paulo: Unifesp.
- Laranjeira, R., Pinsky, I., Zaleski, M., & Caetano, R. (Org.) (2007). *I Levantamento Nacional sobre os Padrões de Consumo de Álcool na População Brasileira*. Brasília: Secretaria Nacional Antidrogas.
- Liese, B. S., Beck, A., & Seaton, K. (2002). The cognitive therapy addictions group. In D. W. Brook, & H. I. Spitz (Eds.), *The group therapy of substance abuse* (Chap. 3, pp. 37-58). New York: Haworth Press.
- Magill, M., & Ray, L. A. (2009). Cognitive-behavioral treatment with adult alcohol and illicit drug users: a meta-analysis of randomized controlled trials. *Journal of Studies on Alcohol and Drugs*, 70(4), 516-527.
- Marlatt, G. A. (1978). Craving for alcohol, loss of control, and relapse: A cognitive-behavioral analysis. In P. E. Nathan, G. A. Marlatt, & T. Lobert (Eds.), *New directions in behavioral research and treatment* (pp. 271-314). New York: Plenum Press.
- Marlatt, G. A. (1996). Harm reduction: Come as you are. *Addictive Behaviors*, 21(6), 779-788.
- Marlatt, G. A., & Donovan, D. M. (Org.) (2009). *Prevenção de recaída: Estratégias de manutenção no tratamento de comportamentos adictivos* (2. ed.). Porto Alegre: Artmed.
- Marlatt, G. A., & Gordon, J. R. (1985). *Relapse prevention: Maintenance strategies in the treatment of addictive behaviors*. New York: Guilford Press.
- McRoberts, C., Burlingame, G. M., & Hoag, M. J. (1998). Comparative efficacy of individual and group psychotherapy: A meta-analytic perspective. *Group Dynamics: Theory, Research and Practice*, 2(2), 101-117.
- Monti, P. M., Kadden, R. M., Rohsenow, D. J., Cooney, N. L., & Abrams, D. B. (2002). *Treating alcohol dependence: A coping skills training guide* (2nd ed.). New York: Guilford Press.
- Neufeld, C. B., Moreira, C. A. M., & Xavier, G. S. (2012). Terapia cognitivo-comportamental em grupos de emagrecimento: O relato de uma experiência. *Psico*, 43(1), 93-100.
- Oliveira, M. S., & Argimon, I. I. L. (2015). Terapia cognitivo-comportamental em grupo: adolescentes e dependência química. In C. B. Neufeld (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes*. Porto Alegre: Artmed.
- Orchowski, L. M., & Johnson, J. E. (2012). Efficacy of group treatments for alcohol use disorders: A review. *Current Drug Abuse Reviews*, 5(2), 148-157.
- Prochaska, J. O., DiClemente, C. C., & Norcross, J. C. (1992). In search of how people change: Applications to addictive behaviors. *American Psychologist*, 47(9), 1102-1114.
- Prochaska, J. O., Velicer, W. F., DiClemente, C. C., & Fava, J. Measuring processes of change: Applications to the cessation of smoking. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 56(4), 520-528.
- Rangé, B. P., & Marlatt, G. A. (2008). Terapia cognitivo-comportamental de transtornos de abuso de álcool e drogas. *Revista Brasileira de Psiquiatria*, 30(Supl. 2), 88-95.

- Rodrigues, V. S. (2013). *Programa de tratamento para usuários de cocaína/crack baseado no modelo transteórico de mudança* (Tese de doutorado não publicada, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).
- Romanini, M., Dias, A. C. G., & Pereira, A. S. (2010). Grupo de prevenção de recaídas como dispositivo para o tratamento da dependência química. *Disciplinarum Scientia Serie: Ciências da Saúde*, 11(1), 115-132.
- Silva, C. J. (2013). A dependência química e o modelo cognitivo de Aaron Beck. In N. A. Zanelatto, & R. Laranjeira (Eds.), *O tratamento da dependência química e as terapias cognitivo-comportamentais: Um guia para terapeutas* (Cap. 7, pp. 122-134). Porto Alegre: Artmed.
- Sobell, L. C., Sobell, M. B., & Agrawal, S. (2009). Randomized controlled trial of a cognitive-behavioral motivational intervention in a group versus individual format for substance use disorders. *Psychology of Addictive Behaviors*, 23(4), 672-683.
- Souza, E. S. T., Crippa, J. A. S., Pasian, S. R., & Martinez, J. A. B. (2009). Escala de razões para fumar modificada: Tradução e adaptação cultural para o português para uso no Brasil e avaliação da confiabilidade teste-reteste. *Jornal Brasileiro de Pneumologia*, 35(7), 683-689.
- Szupszynski, K. P. D. R. (2012). *Estudo dos processos de mudança em usuários de substâncias psicoativas ilícitas* (Tese de doutorado não publicada, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).
- Szupszynski, K. P. D. R., & Oliveira, M. S. (2008). Adaptação brasileira da University of Rhode Island Change Assessment (URICA) para usuários de substâncias ilícitas. *Psico-USF*, 13(1), 31-39.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2016). *World Drug Report 2016*. New York: United Nations. Recuperado de https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf
- Velasquez, M. M., Maurer, G. G., Crouch, C., & DiClemente, C. C. (2013). *Tratamento em grupo para usuários de drogas: Um manual de terapia baseado nos estágios de mudança*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Velicer, W. F., DiClemente, C. C., Rossi, J. S., & Prochaska, J. O. (1990). Relapse situations and self-efficacy: An integrative model. *Addictive Behaviors*, 15(3), 271-283.
- Witkiewitz, K., & Marlatt, G. A. (2004). Relapse prevention for alcohol and drug problems: That was zen, this is tao. *American Psychologist*, 59(4), 224-235.
- World Health Organization (WHO). (1993). *Classificação de transtornos mentais e de comportamento da CID-10: Descrições clínicas e diretrizes diagnósticas*. Porto Alegre: Artmed.
- World Health Organization (WHO). (2013). *WHO Global Report: Mortality attributable to tobacco*. Geneva: WHO.
- World Health Organization (WHO). (2014). *Global status report on alcohol and health*. Geneva: WHO. Recuperado de http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112736/1/9789240692763_eng.pdf

12



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA DEMANDAS EM CONTEXTOS DE SAÚDE

**Lucia Novaes Malagris
M. Cristina Miyazaki
Neide A. Micelli Domingos
Carla Rodrigues Zanin**

A Política Nacional de Humanização (PNH) enfatiza que “. . .os usuários de saúde possuem direitos garantidos por lei, e os serviços de saúde devem incentivar o conhecimento desses direitos e assegurar que eles sejam cumpridos em todas as fases do cuidado, desde a recepção até a alta. . .” (Brasil, 2013, p. 11). Além disso, valoriza o acolhimento, que envolve a construção de relações de confiança, compromisso e vínculo entre as partes

envolvidas. Diversas são as formas pelas quais esses direitos podem ser garantidos e preservados, sendo uma delas o atendimento em grupos para pacientes e familiares ou cuidadores. Este capítulo apresentará os grupos de sala de espera, grupos que abordam problemas prevalentes de saúde e que envolvem pacientes com doenças crônicas não transmissíveis (DCNTs), como exemplo do trabalho do terapeuta cognitivo-comportamental que atua em contextos de saúde.

GRUPOS DE SALA DE ESPERA

A sala de espera é um local onde um grupo de pessoas com problemas semelhantes de saúde aguarda para ser atendida. Esse momento pode ser transformado em uma prática ativa: enquanto aguardam, as pessoas podem compartilhar objetivos comuns, como receber esclarecimentos sobre a doença e o tratamento e realizar troca de informações, que são importantes estratégias para auxiliar o manejo da doença. Assim, a sala de espera passa a ser um “. . . espaço social, profissional e das relações interpessoais que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva e humana . . .” (Brasil, 2006, p. 5).

A educação em saúde, um dos objetivos da sala de espera, envolve atividades que visam à prevenção do desenvolvimento de comportamentos de risco, assim como à adesão ao tratamento de doenças já estabelecidas (Nakao & Gorayeb, 2015).

Várias especialidades podem desenvolver atividades nesse contexto, e a psicologia é uma delas. Trata-se de uma atividade em grupo, que está em consonância com o que preconiza a PNH do Ministério da Saúde (Brasil, 2010). Nesse sentido, trata-se de uma ação coletiva de caráter educativo, na qual o indivíduo pode obter esclarecimentos e orientações sobre saúde, doenças e mudança de hábitos. A importância dada ao ambiente se evidencia na afirmação de que “. . . a construção do espaço deve propiciar a possibilidade do processo reflexivo, garantindo a construção de ações a partir da integralidade e da inclusão, na perspectiva da equidade. . .” (Brasil, 2006, p. 12).

A sala de espera pode promover uma participação mais ativa dos indivíduos, inclusive dos familiares ou cuidadores que acompanham os pacientes. Pode potencializar debates sobre situações do dia a dia e, assim, possibilitar reflexões críticas que contribuam para a melhora da qualidade de vida (Rosa, Barth, & Germani, 2011). É um espaço capaz de facilitar a aproximação entre a comunidade e os serviços de saúde, onde os profissionais podem acolher, informar, contribuir para a melhora da qualidade das relações entre instituição-usuário e do atendimento. Além disso, nesse espaço, o profissional pode contribuir para humanizar serviços que, por vezes, funcionam de um modo muito burocrático (Rodrigues, Dallanora, Rosa, & Germani, 2009).

Teixeira e Veloso (2006) definem sala de espera como um local dinâmico, onde os pacientes que aguardam por atendimento, conversam com outros pacientes, contam suas experiências e também aprendem com as experiências dos demais. É importante salientar que, embora se possa pensar em atividades de grupo de sala de espera, em princípio, este é um agrupamento, e não um grupo, pois as pessoas nem sempre têm um vínculo estabelecido. No entanto, o grupo pode se estabelecer a partir da atividade de educação em saúde realizada pelos profissionais. Frequentemente, a sala de espera é um local onde o paciente tem sua única fonte de suporte social, pois, além de poder trocar experiências, compartilha dúvidas e sofrimento e pode dividir suas angústias, bem como adquirir novas estratégias de enfrentamento e esperança.

Para que se alcancem os objetivos de uma atividade de sala de espera, é importante conhecer as especificidades do ambiente institucional, pois a ação precisa ser “personalizada” para o grupo a que se destina. Outro aspecto importante a ser destacado é que as atividades desenvolvidas em um grupo de sala de espera são pontuais, isto é, objetivas, fechadas e específicas para aquele momento. Muitas vezes, há uma programação com vários temas que são discutidos a cada sala de espera, isto é, um tema em cada encontro, sem que haja necessidade de ocorrerem em sequência. Há que se ressaltar, também, que se trata de um grupo aberto, sem contrato terapêutico e opcional, ou seja, o usuário tem liberdade para participar ou não.

A seguir, será descrita uma experiência específica realizada no Instituto de Atenção à Saúde São Francisco de Assis (HESFA), uma unidade de saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro.

A maior parte dos usuários da sala de espera aguarda consulta nas especialidades de cardiologia e/ou clínica médica e tem uma doença crônica, como hipertensão e diabetes. Em geral, os pacientes vão acompanhados por familiares. Como estudos realizados com essa população evidenciam presença de estresse crônico e altos níveis de ansiedade, optou-se por iniciar as atividades com esses temas. Ressalta-se que a base teórica da atividade é a cognitivo-comportamental, sabendo-se da efetividade dessa abordagem no tratamento de doenças crônicas (Malagris & Almeida, 2012).

De acordo com o plano estabelecido, os membros da equipe abordam os pacientes que aguardam atendimento, apresentam-se e propõem uma discussão sobre os temas ansiedade ou estresse, de acordo com o tema do dia, perguntando: “Você já ficou estressado e/ou ansioso?”.

Dessa forma, são realizados esclarecimentos em linguagem acessível e de modo empático, favorecendo a forma de se expressar dos pacientes. Como parte da atuação, a equipe criou *banners* (Figs. 12.1 e 12.2) sobre os temas, que servem como material ilustrativo durante a interação.



ANSIEDADE

Psicologia UFRJ – Clínica e Pesquisa – Dra. Lucia Novaes



Costuma se sentir ansioso a maior parte do tempo?
Acha que a ansiedade tem interferido no seu dia a dia e em sua saúde?

Afinal...Você sabe o que é ansiedade?

A ansiedade é uma característica normal do ser humano que antecede momentos de **perigo real ou imaginário**, marcada por **sensações corporais desagradáveis**. Na medida certa ela pode ajudá-lo a se preparar para uma situação, porém quando em excesso pode trazer consequências negativas para a nossa saúde.

Sintomas da Ansiedade

Físicos	Mentais
Dor no peito	Insônia
Dor de cabeça	Irritação
Tontura	Tensão
Formigamento	Inquietação
Palpitações	Perda de concentração

Causas da Ansiedade

Sintomas de ansiedade estão na maioria das vezes relacionados a uma preocupação, que pode ser:

Preocupação produtiva: nos ajuda a encontrar soluções.

Preocupação improdutiva: não ajuda a resolver o problema e traz prejuízos.

Consequências da Ansiedade Excessiva

A ansiedade crônica muitas vezes vem acompanhada de estresse. Ela pode fazer surgir ou agravar problemas de saúde como:



Os efeitos de longo prazo da ansiedade sobre...

Controle da Ansiedade



RESPIRAÇÃO
Controle a sua respiração. A ansiedade aumenta a sua frequência cardíaca.

ACEITAR A INCERTEZA
Não podemos prever e controlar tudo o que vai acontecer no futuro. Ter algumas incertezas faz parte da vida.

CONVERSAR
Pessoas que têm relações sociais próximas tendem a apresentar menores níveis de ansiedade.

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL
Alimentos ricos em magnésio (leite, amêndoas e sementes de girassol e de abóbora) ajudam nosso corpo no controle da ansiedade.

ESCREVER
Ajuda a direcionar os problemas, aliviando os sintomas da ansiedade.

Fonte: DUGAS, M. J.; ROBOCHAUD, M. Tratamento Cognitivo-Comportamental para o Transtorno de Ansiedade Generalizada: da ciência para a prática. Rio de Janeiro: Editora Cognitiva, 2009. 269 p.
KAPCZINSKI, F.; MARGIS, R. Transtorno de Ansiedade Generalizada. In: KNAUF, P. (org.) Terapia Cognitivo-Comportamental na Prática Psiquiátrica. Porto Alegre: Artmed, 2005. p. 209-216.

Figura 12.1 Informações sobre ansiedade fornecidas aos pacientes do grupo de sala de espera.

Fonte: Baseada em Dugas e Robichaud (2009) e Kapczinski e Margis (2005).



Figura 12.2 Informações sobre estresse fornecidas aos pacientes do grupo de sala de espera.

Fonte: Baseada em Lipp e Malagris (2011).

Durante a atividade, os pacientes têm a oportunidade de tirar dúvidas e recebem esclarecimentos, dentro das possibilidades do local e do campo de atuação da psicologia. Aos usuários também é oferecida uma cartilha, que reúne informações sobre o tema com linguagem apropriada e formas e estratégias de manejo, objetivando uma psicoeducação cognitivo-comportamental (D. Dobson & Dobson, 2010). Uma das seções do material chama-se “Vamos brincar com o que aprendemos?” e inclui atividades lúdicas como “caça-palavras” e “labirinto” para fixação da aprendizagem. Ao fim, a cartilha oferece sugestão de material de leitura compatível com o nível socioeconômico e educacional da população para aqueles que desejarem ampliar o conhecimento.

O grupo de sala de espera é um tipo de atividade realizado com frequência por psicólogos que atuam em contextos de saúde e é compatível com a PNH.

Entretanto, estudos a respeito de seu impacto sobre o comportamento do paciente e de cuidadores, uma necessidade, ainda são escassos.

GRUPOS PSICOEDUCATIVOS PARA DOENÇAS CRÔNICAS NÃO TRANSMISSÍVEIS BASEADOS NO MODELO COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

Doenças crônicas não transmissíveis são a principal causa de morbimortalidade no Brasil. Doenças cardiovasculares, neoplasias, doenças respiratórias crônicas e diabetes foram responsáveis, em 2009, por 80,7% das mortes por DCNTs no País (Schmidt et al., 2011). Essas patologias constituem, portanto, a principal carga sobre o sistema de saúde e um dos grandes desafios deste século. Seu manejo requer não só envolvimento governamental e do sistema de saúde como também de diferentes segmentos da sociedade (Duncan et al., 2012).

Pacientes que têm diagnóstico de uma (ou mais) DCNTs são os principais usuários do sistema de saúde e frequentemente apresentam comorbidade com transtornos mentais, como depressão e ansiedade, para os quais a terapia cognitivo-comportamental (TCC) é considerada efetiva. A associação entre DCNT e transtorno mental tem impacto negativo sobre a qualidade de vida do indivíduo e a progressão da doença. Além disso, aumenta os custos do tratamento, uma vez que esses pacientes apresentam baixa frequência de comportamentos de autocuidado e de adesão ao tratamento. Assim, a utilização do modelo biopsicossocial de saúde e o atendimento por equipes multi e interdisciplinares têm sido enfatizados no fornecimento de cuidados a pacientes com DCNT (Naylor et al., 2012).

O atendimento em grupos, abertos ou fechados, é uma das mais importantes intervenções psicossociais disponíveis para pacientes com DCNT atendidos em contextos de saúde. Intervenções em grupo, além de “. . . abordar relevantes questões enfrentadas pelos pacientes, permitem que estes obtenham suporte emocional de pessoas que passam por experiências semelhantes e utilizem essas experiências para reduzir o medo de um futuro

desconhecido. . .” (Spira, 1997, p. 3). Exemplos de grupos realizados com pacientes com DCNT serão apresentados a seguir.

GRUPO PARA PACIENTES COM DIABETES MELITO TIPO 1 (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) E PAIS OU CUIDADORES

O tratamento do diabetes melito (DM), uma das doenças crônicas mais comuns da infância, requer estreita colaboração entre paciente, familiares e profissionais da saúde. Além de aumentar o risco para complicações como neuropatia, retinopatia e insuficiência renal, a DM está também associada a uma vulnerabilidade aumentada para transtornos mentais, como ansiedade e depressão, tanto na criança quanto no cuidador (Coutinho et al., 2014).

O grupo de atendimento para crianças com DM e seus cuidadores é oferecido no Ambulatório de Diabetes do Hospital de Base da Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. Uma equipe interdisciplinar (psicóloga, médico, professor de educação física, nutricionista e enfermeira), coordenada por uma terapeuta cognitivo-comportamental, fornece, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), atendimento em grupo fechado, realizado em 10 sessões, com avaliação pré e pós-intervenção (Quadro 12.1).

Quadro 12.1 Atendimento em grupo interdisciplinar para crianças com DM e cuidadores

1ª sessão (psicóloga)

Avaliação inicial: Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes (CBCL/6-18) e Formulário para Professores (TRF) (Achenbach & Rescorla, 2010; Rocha, Pereira, Arantes, & Silveiras, 2010); levantamento de habilidades independentes em relação ao diabetes (forma para os pais) (Wysocki et al., 1992); controle glicêmico pelo exame da hemoglobina glicada e descompensações, extraídos do prontuário do paciente e da ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes, a ser preenchida semanalmente sob a forma de diário pelos pais e pacientes; Parental Bonding Instrument (PBI) (Hauck et al., 2006); impacto do diabetes na família (Anderson et al., 2009); medida do ajuste emocional de pacientes com diabetes (Dunn, Smartt, Beeney, & Turtle, 1986).

Estabelecimento do contrato terapêutico (faltas, pontualidade, participação nas atividades). Explicações sobre recebimento de certificado de participação ao fim do programa.

Avaliação de comportamentos durante a sessão: realizar as atividades propostas; não interromper o outro enquanto trabalha ou fala; trazer a tarefa de casa; autoavaliação da criança e discussão dos comportamentos durante a sessão; dinâmica da bexiga com características pessoais; lanche.

2ª sessão (psicóloga)

Importância do reforço sobre o comportamento; dinâmica de grupo: treino em resolução de problemas; tarefa de casa: identificar e registrar comportamentos (adequados e/ou inadequados e atitudes dos pais); ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

3ª sessão (psicóloga)

Importância do comportamento e suas consequências (uso de jogos e dinâmica de grupo); discussão de exemplos reais de ídolos da criança (p. ex., TV, esporte) e a importância do planejamento na vida dessas pessoas, suas responsabilidades e necessidade de seguir regras. Relação entre direitos e deveres (obrigação e diversão). A importância dos limites. Tarefa de casa: identificar e registrar

comportamentos (adequados e ou inadequados e atitudes dos pais diante desses comportamentos); ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

4ª sessão (psicóloga e médico endocrinologista)

O médico endocrinologista ensina aspectos relevantes da doença; hipo e hiperglicemia e a importância de seu manejo adequado (uso de pranchas educativas). A psicóloga reforça a importância de seguir regras para administração da insulina para obter uma melhor adesão ao tratamento e controle metabólico. Tarefa de casa: registro dos comportamentos adequados e inadequados com relação à mensuração da glicemia e atitude dos pais diante desses comportamentos; ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

5ª sessão (psicóloga e médico endocrinologista)

O médico ensina aos participantes, utilizando materiais lúdicos, a importância da administração da insulina. A terapeuta reforça a importância de seguir as orientações para manter a adesão ao tratamento. Tarefa de casa: registro dos comportamentos adequados e inadequados com relação à mensuração da glicemia, aplicação da insulina e atitudes dos pais diante desses comportamentos; ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

6ª sessão (psicóloga e enfermeira)

Enfermeira orienta sobre aplicação da insulina e administração da bomba de insulina. A terapeuta discute estratégias para melhor manejo de comportamentos relacionados ao seguimento de regras. Tarefa de casa: registro dos comportamentos adequados e inadequados com relação à mensuração da glicemia, aplicação da insulina e administração da bomba e atitudes dos pais diante desses comportamentos; ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

7ª sessão (psicóloga e nutricionista)

A nutricionista orienta sobre a importância dos alimentos adequados para o controle do diabetes e a contagem de carboidratos por meio de dinâmica de grupo. A psicóloga discute estratégias para lidar com diversas situações relacionadas à dieta. Tarefa de casa: registro dos comportamentos adequados e inadequados com relação à mensuração da glicemia, aplicação da insulina e dieta alimentar e atitudes dos pais diante dos comportamentos; ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

8ª sessão (psicóloga e professor de educação física)

Professor de educação física orienta sobre a prática adequada da atividade física para melhor controle da doença. Discussão e levantamento das atividades que os pacientes têm preferência por desempenhar. Tarefa de casa: registro dos comportamentos adequados e inadequados relacionados à mensuração da glicemia, aplicação da insulina, dieta alimentar e atividade física, atitudes dos pais diante dos comportamentos; ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

9ª sessão (psicóloga)

Dinâmica de perguntas e respostas para identificar dificuldades e facilidades no seguimento ao tratamento. São abordadas questões relacionadas às trazidas nas tarefas de casa. Tarefa de casa: aplicar os procedimentos discutidos no grupo nas situações ocorridas durante a semana e trazê-las registradas na próxima sessão; ficha de comportamentos de autocuidado e de complicações do diabetes; lanche.

10ª sessão (psicóloga)

Avaliação do desempenho do grupo durante a semana no enfrentamento das situações-problema; apresentação do desempenho individual de cada um no grupo e de todas as metas trabalhadas e desenvolvidas. Entrega do certificado de participação. Reaplicação dos instrumentos utilizados na 1ª sessão. Comemoração final – lanche.

Além das 10 sessões, a cada retorno médico, pacientes e cuidadores são abordados pela psicóloga e discutem dificuldades/facilidades no manejo adequado da doença e na resolução de problemas. Quando são identificados problemas nesses retornos, paciente e cuidador são reencaminhados ao grupo (apenas para aquelas sessões que abordam as questões que constituem problema para o paciente/cuidador). Quando isso é insuficiente, paciente e cuidador são encaminhados para atendimento psicológico individual.

Os dados obtidos nas avaliações estão sendo analisados como tese de doutorado da psicóloga responsável pelo grupo. Uma análise preliminar

indica que, quando há adesão ao grupo (80% de participação nas sessões), há mudanças importantes no comportamento da criança e dos pais, que se refletem nas medidas diretas do DM (p. ex., hemoglobina glicada). A adesão ao grupo, entretanto, é um dos principais desafios do tratamento. Apesar disso, um estudo anterior, realizado com pacientes renais crônicos na instituição, mostrou que a TCC em grupo é efetiva (Duarte, Miyazaki, Blay, & Sesso, 2009), e um resultado semelhante é esperado para o grupo de DM para crianças/adolescentes e pais.

GRUPO PARA PACIENTES COM SÍNDROME DO INTESTINO IRRITÁVEL

A síndrome do intestino irritável (SII) é um transtorno gastrointestinal crônico que causa desconforto ou dores abdominais recorrentes e modificações na frequência de evacuação (Mizputen et al., 2006). Pode haver inchaço abdominal, alteração das fezes, eliminação excessiva de gases ou dificuldade em eliminá-los e sensação de evacuação incompleta (Passos et al., 2012).

Um estudo aponta sintomas como cansaço fácil, pouca energia e sintomas predominantemente dolorosos e destaca como sintomas psicológicos tensão, nervosismo, desânimo, dificuldade para dormir, interferência dos sintomas no desempenho sexual e pouca energia (Spiegel et al., 2004). Nogueira, Lima, Zanin e Netinho (2006) identificaram em pacientes com SII sintomas leves de depressão, sintomas moderados de ansiedade e presença de estresse, ressaltando a necessidade de intervenção psicológica para a aquisição de novo repertório cognitivo e comportamental para o manejo das demandas emocionais e melhora da qualidade de vida.

O objetivo do tratamento dos pacientes com SII é o alívio e controle dos sintomas físicos e psicológicos com o intuito de resgatar a qualidade de vida. A psicoterapia individual ou em grupo tem demonstrado um impacto positivo na vida dos pacientes (Gimenes & Bohm, 2010), bem como a relação empática entre estes e o médico. Pesquisas mostram que uma relação cordial e respeitosa, com explicações claras e compreensíveis acerca da natureza funcional e dos resultados de longo prazo, pode levar a uma maior adesão ao tratamento (Regino & Zuleta, 2005).

Pesquisadores (Mikocka-Walus, Gordon, Stewart, & Andrews, 2012; Passos, 2012) apontam que a terapia medicamentosa é ineficaz se os problemas psicossociais não forem tratados. Considerando essa afirmação, a ideia de que variáveis comportamentais estão envolvidas na SII fica fortalecida, tornando-se alvo de estudos por parte de psicólogos e equipes de saúde.

Um estudo realizado por Nogueira e colaboradores (2006) com pacientes com SII em psicoterapia de grupo na abordagem cognitivo-comportamental demonstrou redução dos sintomas de depressão, de ansiedade e de estresse após reavaliação, sugerindo impacto positivo da terapia cognitivo-comportamental no tratamento de pacientes com SII. Para a realização do grupo, elaborou-se um protocolo de atendimento, o qual inclui uma avaliação com instrumentos validados e amplamente utilizados no Brasil – Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HADS) (Botega, Bio, Zomignani, Garcia, & Pereira, 1995); Inventário de Sintomas de Stress para Adultos de Lipp (ISSL) (Lipp, 2000); Escala Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP) (Seidl, Trócli, & Zannon, 2001); Qualidade de Vida (SF-36) (Ciconelli, Ferraz, Santos, Meinão, & Quaresma, 1999); e Escala Visual Analógica (EVA) (Pereira & Sousa, 1998) – e um programa de tratamento psicológico de 12 sessões envolvendo estratégias e técnicas psicológicas da abordagem cognitivo-comportamental. O Quadro 12.2 apresenta detalhadamente o programa desenvolvido em cada sessão.

Quadro 12.2 Programa de atendimento psicológico a pacientes com SII

Sessão	Atividade
1	Apresentação; explicação sobre objetivos do atendimento; estrutura das sessões; contrato e aplicação dos inventários. Escala Hospitalar de Ansiedade e Depressão (HAD); Inventário de Sintomas de Stress de Lipp (ISSL); Escala de Modos de Enfrentamento de Problemas (EMEP); Qualidade de Vida (SF-36); Escala Visual Analógica (EVA).
2	Sessão livre para discussão de queixas emocionais. Clarificação. Acolhimento.
3	Socialização do paciente na TCC. Discussão sobre o problema de saúde. Acolhimento. Estabelecimento das metas terapêuticas.
4	Aprendizagem e aplicação do treino de relaxamento e distração cognitiva. Importância da automonitoração dos sintomas físicos da SII. Tarefas. Estabelecimento de agenda.
5	Resumo da semana e das tarefas. Psicoeducação (exercícios físicos, alimentação adequada e manejo das demandas emocionais). Reforço das estratégias terapêuticas (treino de relaxamento e distração e automonitoramento). Discussão sobre os tópicos da agenda. Introdução ao registro de pensamentos disfuncionais (RPD) e automonitoramento (AM).

6	Resumo da semana e das tarefas. Sessão livre para discussão de queixas emocionais. Aconselhamento. Acolhimento. Reforço das estratégias terapêuticas (treino de relaxamento e distração, AM e RPD).
7	Resumo da semana e das tarefas. Discussão sobre os tópicos da agenda. Verificação e aplicação das estratégias de enfrentamento. Introdução do treino de resolução de problemas (TRP). Reforço das estratégias terapêuticas (treino de relaxamento e distração, automonitoramento e RPD). Introdução ao treino em habilidades sociais (THS) e assertividade. Resumo da sessão.
8	Resumo da semana e das tarefas. Reforço das estratégias terapêuticas (treino de relaxamento e distração, automonitoramento, RPD e estratégias de enfrentamento e resolução de problemas, habilidades sociais e assertividade). Resumo da sessão.
9	Orientações com a nutricionista.
10	Resumo da semana e das tarefas. Discussão sobre as questões alimentares. Reforço das estratégias terapêuticas (treino de relaxamento e distração, automonitoramento, RPD e estratégias de enfrentamento e resolução de problemas, habilidades sociais e assertividade). Resumo da sessão.
11	Resumo da semana e das tarefas. Reforço das estratégias terapêuticas (treino de relaxamento e distração, automonitoramento, RPD e estratégias de enfrentamento e resolução de problemas, habilidades sociais e assertividade). Resumo da sessão.
12	Resumo da semana e das tarefas. Sessão livre para queixas emocionais. Aplicação dos inventários. <i>Feedback</i> da intervenção.

O manejo das demandas emocionais para uma melhora da qualidade de vida dos pacientes com SII é fundamental. A psicoterapia individual ou de grupo tem demonstrado um impacto positivo na vida dos pacientes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O atendimento em grupo é uma estratégia efetiva para os pacientes e para o sistema de saúde, em termos de benefícios, tempo e custo. O tipo e a estrutura dos grupos podem variar de acordo com as necessidades e as possibilidades do local onde o atendimento é realizado. O uso da TCC em grupos no sistema de saúde tem sido avaliado, e seus resultados têm-se mostrado efetivos (Duarte et al., 2009). Mais estudos ainda são necessários para avaliar diferentes tipos e componentes das intervenções cognitivo-comportamentais em grupo para diferentes populações e problemas de saúde.

REFERÊNCIAS

- Achenbach, T. M., & Rescorla, L. A. (2010). *Mental health practioners' guide for the Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA)* (7th ed.). Burlington: University of Vermont, Research Center for Children, Youth & Families.
- Anderson, B. J., Holmbeck, G., Iannotti, R. J., McKay, S. V., Lochrie, A., Volkening, L. K., & Laffel, L. (2009). Dyadic measures of the parent-child relationship during the transition to adolescence and

glycemic control in children with type 1 diabetes. *Journal of Clinical Nursing*, 18, 1703-1710.

Botega, N. J., Bio, M. R., Zomignani, M. A., Garcia, C., & Pereira, W. A. B. (1995). Transtornos do humor em enfermagem de clínica médica e validação de escala de medida (HAD) de ansiedade e depressão. *Revista de Saúde Pública*, 29(5), 359-363.

Brasil. Ministério da Saúde. (2006). *HumanizaSUS : Documento base para gestores e trabalhadores do SUS* (3. ed.). Brasília: Ministério da Saúde. (Série B. Textos Básicos de Saúde).

Brasil. Ministério da Saúde. (2010). *Política Nacional de Humanização: Cadernos Humaniza SUS* (Textos Básicos de Saúde, Série B, Vol. 2). Brasília: MS. Recuperado de http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cadernos_humanizasus_atencao_basica.pdf

Brasil. Ministério da Saúde. (2013). *Política Nacional de Humanização – PNH: Humaniza SUS*. Brasília: MS. Recuperado de http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_humanizacao_pnh_folheto.pdf Ciconelli, R. M., Ferraz, M. B., Santos, W., Meinão, I., & Quaresma, M. R. (1999). Tradução para língua portuguesa e validação do questionário genérico de avaliação de qualidade de vida SF-36. *Revista Brasileira de Reumatologia*, 39(3), 143-50.

Coutinho, D. C., Lino, E. M., Russoni, A. C., Domingos, N. A. M., Gusman, D. P., Malerbi, F. E. K., ... Miyazaki, M. C. O. S. (2014). Diabetes melito tipo 1: Sintomas de depressão em crianças e cuidadores. *Arquivos de Ciências da Saúde*, 21(3), 67-71.

Dobson, D., & Dobson, K. S. (2010). *A terapia cognitivo-comportamental baseada em evidências*. Porto Alegre: Artmed.

Duarte, P. S., Miyazaki, M. C. O. S., Blay, S. L., & Sesso, R. (2009). Cognitive-behavioral group therapy is an effective treatment for major depression in hemodialysis patients. *Kidney International*, 76(4), 414-421.

Dugas, M. J., & Robichaud, M. (2009). *Tratamento cognitivo-comportamental para o transtorno de ansiedade generalizada: Da ciência para a prática*. Rio de Janeiro: Cognitiva.

Duncan, B. B., Chor, D., Aquino, E. M. L., Bensenor, I. M., Mill, J. G., Schimdt, M. I., ... Barreto, S. M. (2012). Doenças crônicas não transmissíveis no Brasil: Prioridade para enfrentamento e investigação. *Revista de Saúde Pública*, 46(supl. 1), 126-134.

Dunn, S. M., Smartt, H. H., Beeney, L. J., & Turtle, J. R. (1986). Measurement of emotional adjustment in diabetic patients: Validity and reliability. *Diabetes Care*, 9(5), 480-489.

Gimenes, L. S., & Bohm, C. H. (2010). Análise funcional da dor na síndrome do intestino irritável. *Temas em Psicologia*, 18(2), 357-366.

Hauck, S., Schestatsky, S., Terra, L., Knijnik, L., Sanchez, P., & Ceitlin, L. H. F. (2006). Adaptação transcultural para o português brasileiro do Parental Bonding Instrument (PBI). *Revista de Psiquiatria do Rio Grande do Sul*, 2(2)8, 162-168.

Kapczinski, F., & Margis, R. (2005). Transtorno de ansiedade generalizada. In P. Knapp (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental na prática psiquiátrica* (pp. 209-216). Porto Alegre: Artmed.

Lipp, M. E. N. (2000). *Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp: ISS-L*. São Paulo: Casa do Psicólogo.

Lipp, M. E. N., & Malagris, L. E. N. (2011). Estresse: Aspectos históricos, teóricos e clínicos. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., cap. 39,

pp. 617-632). Porto Alegre: Artmed.

Malagris, L. E. N., & Almeida, R. A. (2012). A contribuição da Terapia cognitivo-comportamental nas doenças crônicas. In E. M. O. Falcone, A. D. Oliva, & C. Figueiredo (Orgs.), *Produções em terapia cognitivo-comportamental* (pp. 297-306). São Paulo: Casa do Psicólogo.

Mikocka-Walus, A. A., Gordon, A. L., Stewart, B. J., & Andrews, J. M. (2012). The role of antidepressants in the management of inflammatory bowel disease (IBD): A short report on a clinical case-note audit. *Journal of Psychosomatic Research*, 72(2), 165-167.

Mizputen, S. J., Mendes, A., Magalhães, A. F. N., André, E. A., Alves, J. G., & Silveira, L. S. (2006). História dos critérios diagnósticos da síndrome do intestino irritável. In F. A. Quilici, C. F. Francesconi, M. C. F. Passos, M. T. Haddad, & S. J. Mizputen (Orgs.), *Síndrome do intestino irritável: uma visão integrada* (pp. 51-90). São Paulo: Segmento Farma.

Nakao, R. T., & Goaryeb, R. (2015). Educação em saúde. In R. Gorayeb (Org.), *A prática da psicologia no ambiente hospitalar* (pp. 401-427). Novo Hamburgo: Sinopsys.

Naylor, C., Parsonage, M., McDaid, D., Knapp, M., Fossey, M., & Galea, A. (2012). *Long-term conditions and mental health: The cost of comorbidities*. London: The Kings Fund and Centre for Mental Health. Recuperado de <https://www.kingsfund.org.uk/publications/long-term-conditions-and-mental-health>

Nogueira, G. S., Lima, C. V., Zanin, C. R., & Netinho, J. G. (2006). Avaliação psicológica pré e pós intervenção em grupo de pacientes com síndrome do intestino irritável. *Arquivos de Ciências da Saúde*, 13(2), 25.

Passos, M. C. F. (2012). Síndrome do intestino irritável: Diagnóstico e tratamento. *Revista GED: Gastroenterologia Endoscopia Digestiva*, 31(2), 71-74.

Pereira, L. V., & Sousa, F. A. E. F. (1998). Mensuração e avaliação da dor pós-operatória: Uma breve revisão. *Revista Latino Americana de Enfermagem*, 6(3), 77-84.

Regino, W. O., & Zuleta, M. G. (2005). Síndrome de intestino irritable: Diagnóstico y tratamiento farmacológica. Revisión concisa. *Revista de Gastroenterología del Perú*, 25(2), 189-197.

Rocha, M. M., Pereira, R. F., Arantes, M. C., & Silveiras, E. F. M. (2010). *Guia para profissionais da saúde mental sobre o Sistema Achenbach de Avaliação Empiricamente Baseada (ASEBA)*. São Paulo: Universidade de São Paulo.

Rodrigues, A. D., Dallanora, C. R., Rosa, J. D., & Germani, A. R. M. (2009). Sala de espera: Um ambiente para efetivar a educação em saúde. *Revista Vivências: Revista Eletrônica de Extensão da URI*, 5(7), 101-106.

Rosa, J., Barth, P. O., & Germani, A. R. M. (2011). A Sala de espera no agir em saúde: Espaço de educação e promoção à saúde. *Perspectiva*, 35(129), 121-130.

Schmidt, M. I., Duncan, B. B., Silva, G. A., Menezes, A. M., Monteiro, C. A., Barreto, S. M., ... Menezes, P. R. (2011). Chronic non-communicable diseases in Brazil: Burden and current challenges. *Lancet*, 377(9781), 1949-1961.

Seidl, E. M. F., Trócoli, B. T., & Zannon, C. M. L. C. (2001). Análise fatorial de uma medida de estratégias de enfrentamento. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 17(3), 225-234.

Spiegel, B. M. R., Gralnek, I. M., Bolus, R., Chang, L., Dulai, G. S., Mayer, E. A. & Naliboff, B. (2004). Clinical determinants of health-related quality of life in patients with irritable bowel syndrome. *Archives of Internal Medicine*, 164(16), 1773-1780.

Spira, J. L. (1997). Understanding and developing psychotherapy groups for medically ill patients. In J. L. Spira (Ed.), *Group therapy for medically ill patients* (pp. 3-55). New York: The Guilford Press.

Teixeira, E. R., & Veloso, R. C. (2006). O grupo em sala de espera: território de práticas e representações em saúde. *Texto Contexto Enfermagem*, 15(2), 320-325.

Wysocki, T., Meinhold, P. A., Abrams, K. C., Barnard, M. U., Clarke, W. L., Bellando, B. J., & Bourgeois, M. J. (1992). Parental and professional estimates of self-care independence of children and adolescents IDDM. *Diabetes Care*, 15(1), 43-52.

LEITURA RECOMENDADA

Marshall, M., Carter, B., Rose, K., & Brotherton, A. (2009). Living with type 1 diabetes: perceptions of children and their parents. *Journal of Clinical Nursing*, 18(12), 1703-1710.

13



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA DOR CRÔNICA

Martha Moreira Cavalcante Castro
Josiane Mota Lopes

A dor é uma das experiências mais complexas que o homem vivencia. Desde que foi incluída como quinto sinal vital, assegura que todas as pessoas adoecidas tenham acesso a medidas eficazes que possam garantir seu controle (Araujo & Romero, 2015).

A International Association for the Study of Pain (IASP), Subcommittee on Taxonomy, define dor como “. . .uma experiência sensorial e emocional desagradável, associada a uma lesão tecidual real, potencial ou descrita nos termos dessa lesão”. (International Association for the Study of Pain [IASP], 2012). A partir dessa definição, a dor pode ser compreendida como uma experiência complexa, subjetiva, associada a relações afetivo-emocionais e modulada pela cognição e pelas experiências anteriores (Loeser & Treede,

2008). Dessa forma, os componentes emocionais e comportamentais envolvidos na experiência dolorosa crônica são bastante significativos, na medida em que cada sujeito lida com seu sofrimento conforme sua idade, gênero, maturidade emocional e contexto cultural. Como todo indivíduo apresenta uma reação ao adoecer, quando a dor se cronifica, deixa de ser apenas um sintoma e passa a ser definida como doença. Há uma carga de sofrimento significativa, além de um deslocamento do indivíduo de sua posição diante da vida com relação a sua família, relação com o trabalho, vida social, afetiva, lazer e tantas outras mais bem explicitadas ao longo deste capítulo.

Por resultar de complexos mecanismos envolvidos em seu aparecimento, a dor pode ser classificada de acordo com a duração e as estruturas envolvidas. Quanto à duração, pode ser definida como aguda e crônica. A dor aguda é aquela que decorre de uma lesão e desaparece quando esta é curada. Apresenta-se bem delineada, com tempo de duração específico, com alterações neurovegetativas gerais e sintomas de ansiedade. Já a dor crônica é aquela que persiste além da cura da lesão e decorre de processos patológicos crônicos que a tornam contínua e persistente. Pode durar meses ou anos, sendo geralmente vaga, mal delineada e agravada por processos ambientais de estresse ou psicológicos. É causa frequente de incapacidade funcional e gera alterações no cotidiano do indivíduo com relação à família, ao trabalho e à vida social. Altera também o apetite, o sono e o desempenho sexual (Catalano & Hardin, 2004).

Quanto às estruturas envolvidas, a dor pode ser assim categorizada: a) por nocicepção, quando apresenta elevada síntese de substâncias algio gênicas e intensa estimulação das fibras nervosas ascendentes, constituindo-se em fator importante para que a integridade do indivíduo possa ser preservada, uma vez que funciona como sinal de alerta, determinando a possível ocorrência de lesão no organismo, e geralmente está relacionada a traumas, infecções ou inflamações; b) por desafferentação ou neuropática, quando decorre de lesão parcial ou total das vias nervosas do sistema nervoso periférico ou central, como, por exemplo, após acidente vascular cerebral, neuropatia diabética e herpes-zóster (Pinheiro, Uchida, Mathias, Perez, & Cordeiro, 2014).

Como a maioria das pessoas experimenta uma grande variedade de dores ao longo da vida, é necessário determinar sua localização; bem como se é específica e bem definida, ou difusa; a qualidade da dor (p. ex., formigamento, queimação, ardor, pontadas, aperto, perfuração, cortante, entre outras); sua intensidade, se leve, moderada, grave ou insuportável; e a frequência, se contínua, ininterrupta ou episódica.

Para compreender o processo de dor, faz-se necessário conhecer alguns aspectos básicos envolvidos no processamento nociceptivo. O sistema nervoso percebe variações do ambiente e organiza respostas. A geração de um impulso nociceptivo doloroso se dá a partir do estímulo nocivo (que pode ser de origem mecânica, térmica ou química) e da resposta inflamatória que o acompanha, resultando na liberação de substâncias químicas (bradicinina, histamina, prostaglandinas, entre outras). Essas substâncias estimulam as terminações nervosas, despolarizando a membrana neuronal e traduzindo o estímulo nociceptivo em estímulo elétrico, que é conduzido, então, pelas fibras nervosas C e A- delta até a medula espinal. Da medula espinal, a informação dolorosa é encaminhada para o tronco cerebral, o tálamo, o sistema límbico e as áreas corticais pelos tratos espinotalâmicos e espinorreticulares. O trato espinotalâmico exerce uma função discriminativa da dor, enquanto o trato espinorreticular está relacionado às respostas neurovegetativas, à modulação da dor e a aspectos afetivos associados à nocicepção (dimensão afetivo-motivacional). Logo, é no sistema reticular do tronco cerebral que são atribuídas as respostas de fuga ou ataque (respostas neurovegetativas) presentes no processo doloroso. Por sua vez, no tálamo, a informação dolorosa é localizada espacialmente e projetada em estruturas dos sistemas límbico, motor e cortical. Das conexões do impulso doloroso com as estruturas do sistema límbico define-se o caráter desagradável e emocional da dor. Essa ampla representação em áreas corticais e subcorticais resulta na interpretação do fenômeno doloroso em todos os seus domínios sensitivo-discriminativo, afetivo-motivacional, cognitivo-avaliativo e na ampla gama de respostas envolvidos nesse processo (Rocha et al., 2007).

O sistema supressor da dor modula o sistema nociceptivo, sendo composto por elementos neuronais presentes na medula espinal, no tálamo e em

estruturas subcorticais. Os neurotransmissores inibitórios mais importantes desse sistema são as encefalinas (peptídeos opioides endógenos) e a serotonina. A partir da ativação do sistema supressor da dor, há aumento na síntese desses neurotransmissores, que, por meio de tratos descendentes, se projetam na substância cinzenta da medula espinal. O sistema supressor da dor é ativado por estímulos discriminativos (sensibilidade normal) que, durante as atividades diárias do cotidiano, alcançam o sistema nervoso central (SNC), pela dor e por aspectos emocionais e cognitivos que ainda não estão completamente esclarecidos. Assim, a dor é o resultado do desequilíbrio entre os sistemas nociceptivo e supressor de dor.

De todos os princípios relacionados a geração, transmissão, interpretação e modulação da dor, percebe-se que ela não é somente um impulso vindo unicamente da estimulação nociceptiva. Há uma interação bastante íntima entre as muitas qualidades sensoriais (tato, temperatura), a sensibilidade sensorial (visão, audição) e a dolorosa, como sistemas responsáveis pelos aspectos cognitivos e afetivos do indivíduo. As intervenções analgésicas farmacológicas, educacionais, psicológicas, fisioterápicas, de relaxamento e outras têm o objetivo de reduzir a oferta de substâncias álgicas na periferia, interferindo nos processos de transmissão, interpretação e modulação do processo doloroso (Melzack & Wall, 1965).

A prevalência de dor crônica no mundo é de aproximadamente 40% (Ferreira & Speciali, 2015). O aumento crescente pode estar relacionado a maior longevidade da população, crescentes estudos na área possibilitando mais diagnósticos e incentivo ao desenvolvimento de tecnologias que proporcionem mais sobrevida a pessoas com diagnósticos crônicos. Aproximadamente 30% da população brasileira relata a presença de dor intensa em algum momento da vida.

A dor e as razões para sua ocorrência variam de acordo com a faixa etária. No adulto, admite-se que 90% dos homens e 95% das mulheres apresentam cefaleia pelo menos uma vez ao ano, assim como aumento, com a progressão da idade, de dores provenientes de angina por esforço, artralgias, neuropatias e doenças oncológicas. Estima-se que 80 a 85% dos indivíduos com mais de

65 anos apresentem, pelo menos, um problema significativo de saúde que os predisponha à dor (Araujo & Romero, 2015).

Essa prevalência é justificada, nos estudos, pelo fato de as funções nociceptivas do sistema nervoso estarem comprometidas, bem como pelo aumento da sobrecarga de afecções nessa faixa etária. As lombalgias são uma das causas mais comuns de incapacidade. Aproximadamente 80% das pessoas desenvolveram, desenvolvem ou desenvolverão lombalgia incapacitante em algum momento da vida. A literatura mostra que a lombalgia ocorre em 70% dos indivíduos e torna-se crônica em 10 a 15% dos trabalhadores. Na prática clínica em dor crônica, vê-se um aumento progressivo de pessoas que sofrem de quadros álgicos intensos e crônicos. Isso pode estar ocorrendo em razão do crescente avanço da medicina, do reconhecimento cada vez maior de novas condições álgicas e dos novos hábitos de vida (Ferreira & Speciali, 2015).

Uma vez cronificada, a dor faz o sujeito ser separado de suas atividades de vida diárias e passar a ter um sofrimento significativo na vida, o que propicia o aparecimento de sintomas e transtornos psíquicos, sendo os mais prevalentes os de ansiedade e depressão. As reações ansiosas são geralmente ampliadas quando emergem os quadros dolorosos, acompanhadas de sentimentos de medo e insegurança diante do desconhecimento do diagnóstico. Por sua vez, quando a causa do fenômeno doloroso não é superada, tornando-se um processo crônico, sentimentos como desesperança, impotência e desespero podem ceder lugar a outros sintomas depressivos ou à depressão doença.

Observa-se que o paciente com dor aguda demonstra facilmente seu sofrimento e busca alívio imediato para seu mal, enquanto aquele que sofre de dor crônica se adapta a ela sem perceber, pois esta passa a fazer parte do cotidiano seu e de sua família. Por meio da acomodação à dor, o indivíduo consegue lidar no meio social sem aparentar a intensidade dolorosa, o que resulta, muitas vezes, no questionamento da autenticidade do sofrimento (Pinheiro et al., 2014).

O paciente com dor apresenta respostas comportamentais, e a mais frequente delas é o sintoma depressivo caracterizado como um estado afetivo

de tristeza. O termo “depressão”, na linguagem corrente, pode designar tanto um estado afetivo normal, sendo utilizado como sinônimo de tristeza em resposta a situações estressantes adversas e traduzindo a ideia de um sintoma. Este pode ser, na verdade, um agrupamento de sintomas, caracterizando uma síndrome, que inclui não apenas alterações do humor (tristeza, apatia, irritabilidade), mas também alterações cognitivas, psicomotoras e vegetativas, etc. Nesse caso, a depressão, na qualidade de uma doença, afeta de forma significativa as relações do indivíduo no trabalho, no lazer e nos relacionamentos interpessoais, bem como os vínculos familiares e afetivos.

O diagnóstico dos estados depressivos deve, antes de tudo, averiguar se os sintomas depressivos são primários ou secundários a doenças físicas e/ou ao uso de drogas e medicamentos. Para isso, o *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5) contempla alguns itens referentes a esses critérios diagnósticos. Dessa forma, a dor crônica pode vir como um sintoma da depressão; coexistência entre elas, apesar de poderem aparecer sem estar interligadas umas às outras; ou, ainda, a depressão pode ser uma complicação do quadro álgico (Pinheiro et al., 2014).

A dor crônica é um fenômeno complexo, sócio-histórico-cultural. Para entendê-la, há que se levar em consideração que sua significação perpassa a visão, o olhar do outro. Ela provoca mudanças em diversos âmbitos da vida do sujeito, e a família é um dos sistemas em que isso fica muito evidente.

A família tem grande participação na construção do significado dessa dor, assim como em todo o processo de tratamento. Ela é a principal fonte de suporte social, sendo a primeira referência de significação das experiências humanas (Casaes, 2007; Delgado, 2005).

O não reconhecimento da existência da dor é fator gerador de sofrimento psíquico para quem é acometido por ela. A forma como essa dor será significada por seus familiares vai interferir não só nas suas relações como também em como o sujeito se sente, se percebe e no sentido que dará ao tratamento.

É a partir da família que a dor vai ganhando significados, que os comportamentos de dor vão sendo criados e reforçados, favorecendo o processo de significação (Carvalho, 1999). Quando surge o adoecimento, a

família se torna um esteio de suma importância, no sentido de se constituir em fonte de vínculo afetivo, apoio e segurança.

A família, ao constatar que a doença é crônica, tende a passar por um processo de desorganização, em que novas limitações serão impostas. A postura da família vai interferir na adaptação dessa nova realidade da pessoa com dor crônica, de forma positiva ou não (Angerami, 2003).

A presença de uma doença crônica exige grande flexibilidade por parte do indivíduo e de sua família. A dor crônica provoca mudanças na rotina, na divisão das responsabilidades, no papel social e emocional, e, em alguns casos, o indivíduo deixa de exercer suas atividades cotidianas. Essa interrupção gera sofrimento tanto para quem tem a dor quanto para os familiares (Delgado, 2005).

A cronicidade, por sua característica de duração ao longo tempo, para a vida toda, acaba gerando uma sensação de adaptação ao adoecimento por parte da família, que, em algumas situações, acaba desqualificando o sofrimento do paciente, gerando, assim, dificuldades na relação.

A invisibilidade do fenômeno doloroso dificulta sua significação pela família e pelo meio social, provocando, assim, uma negação da dor, o que traz repercussões na forma de se comportar e agir em quem a sente, fazendo essa dor não ser mais compartilhada: torna-se propriedade individual. O silêncio, o não compartilhamento da dor, gera sofrimento e isolamento social.

Por ser uma doença crônica e de trajetória incerta, a dor gera incapacidade para a vida, que não se resume apenas ao ambiente de trabalho, interferindo na capacidade produtiva, mas estende-se para as atividades da vida diária e a participação social.

O trabalho é o local onde o indivíduo constrói sua identidade, é reconhecido por seus pares, sendo, assim, gerador de prazer e pertencimento a uma sociedade. No entanto, quando o indivíduo é acometido por um adoecimento crônico, e não encontra a rede de apoio que tinha em seu ambiente de trabalho, encara fatores como desesperança, medo e raiva diante das limitações no desenvolvimento de sua atividade e ante a impossibilidade de uma cura, provocando reflexões – “Quem sou eu agora, e o que ainda posso fazer?”.

As perdas provocadas pela dor crônica geram também perdas de si. O indivíduo não perde só a autoestima; perde também sua identidade. Percebe-se como uma pessoa limitada e com restrições em um mundo em que, para ser reconhecida, precisa ser saudável e capaz; aquele que está fora do padrão de normalidade culturalmente instituído, não é valorizado (Charmaz, 1983). Trazendo essas questões para o mundo do trabalho, aquele que não produz, não atinge as metas estabelecidas, é marginalizado e visto por seus pares como pessoa inútil. Essa falta de apoio dos colegas de trabalho e a deslegitimação da dor trazem sofrimento e uma sensação de não pertencimento àquele meio social que antes o acolhia.

Para Dejours (1988, p. 33), “. . . a falta de trabalho torna-se, em si, um sinônimo de doença”, pois o trabalho define quem a pessoa é e contribui para que ela se reconheça.

O trabalho transforma o trabalhador; permite que ele progrida, se aprimore, se realize (Dejours, 1988). Ele é tão central na vida do indivíduo que se sobrepõe às demais experiências cotidianas e passa a ditar as relações de convívio familiar e social.

O trabalho é central na vida dos trabalhadores. Gera prazer ao indivíduo ao permitir que este se sinta capaz e pertencente a uma rede social; ao mesmo tempo, gera sofrimento, a partir do momento em que o indivíduo percebe que não consegue produzir como antes ou quando as relações interpessoais e o não reconhecimento pelos pares trazem implicações para a vida laboral e familiar. O trabalho traz atividades regulares, desenvolve as relações sociais, é forma de legitimação e reconhecimento na sociedade. A perda desse lugar gera a perda do “quem sou eu”; a identidade construída agora é a do adoecimento (Rocha, 2007).

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA PESSOAS COM DOR CRÔNICA

O paciente com dor que é tratado em grupo terapêutico precisa desenvolver algumas habilidades: reconhecer os pensamentos automáticos e emoções; aceitar as possíveis mudanças ocorridas no processo terapêutico;

compreender o modelo cognitivo; ter um foco específico; estabelecer uma boa aliança terapêutica e relação de confiança na vida e nos vários processos interpessoais que podem interferir na terapia.

Em geral, prefere-se que haja o terapeuta principal para conduzir o grupo e um coterapeuta para oferecer suporte e estar atento às interações grupais. Os grupos costumam ter o formato fechado, e as sessões podem durar de 90 minutos a 2 horas. A estrutura da sessão envolve a ponte com a sessão anterior; a agenda; os resumos após a explicação dos conceitos; e as tarefas, em geral reservadas aos 10 minutos finais das sessões (Bieling, McCabe, & Antony, 2008).

A terapia em grupo pode reduzir significativamente a dor e permitir que os pacientes tenham funcionamento satisfatório na vida diária, mesmo com a permanência do quadro algico (Redondo et al., 2004). Outras vantagens da TCC em grupo incluem as interações entre os indivíduos e a função encorajadora, permitindo a revelação de sentimentos e pensamentos a outras pessoas que compartilham circunstâncias de vida semelhantes (Thorn & Kuhajda, 2006).

É importante compreender o significado que os pacientes dão à experiência de dor como fator de adaptação. Para isso, é relevante ressaltar qual o papel das crenças para o indivíduo com dor crônica, assim como sua influência na percepção final da dor e nas estratégias de enfrentamento usadas por ele. As crenças podem envolver conceitos próprios sobre o que é dor, seu significado e a compreensão pessoal da experiência dolorosa. Do mesmo modo, quando o paciente acredita que pode ter controle sobre sua vida, percebe menos a intensidade da dor, mostra maiores níveis de atividade e utiliza estratégias de enfrentamento mais adaptativas, e isso reflete maior nível de adaptação. Em contrapartida, o indivíduo que se vê indefeso ante a impossibilidade de controlar a dor crônica apresenta aumento da frequência e da intensidade dos episódios dolorosos (Brox et al., 2003; Martel & Ortiz, 2001).

Para a confecção desse protocolo de acompanhamento psicoterápico em grupo para pacientes com dor crônica, foram consultados os seguintes manuais: *Cognitive Therapy with Chronic Pain Patients* (Winterowd, Beck,

& Gruener, 2003); *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para populações específicas* (White & Freeman, 2003) e *Psychological Approaches to Pain Management: A Practitioner's Handbook* (Gatchel & Turk, 1996). Isso se deu com o propósito de padronizar os critérios referentes ao número de sessões, número de participantes e as principais técnicas utilizadas pela terapia cognitivo-comportamental (TCC) para os pacientes com dor crônica.

Concebida como um fenômeno complexo, de etiologia diversa, a dor abrange e atinge diversas áreas da vida do indivíduo, e, para entendê-la, é preciso levar em consideração a subjetividade que nela está inserida.

Dessa forma, a interpretação das pessoas acerca de seu sofrimento passou a ser fundamental na compreensão do fenômeno doloroso. É importante levar em consideração as respostas emocionais diante da dor, uma vez que elas influenciam a percepção do indivíduo sobre a experiência dolorosa, além de contribuir para uma motivação e adesão positiva ou negativa perante um tratamento.

Turk (2003) relata estudos que apontam a TCC como eficaz no tratamento desses pacientes, uma vez que seu objetivo é favorecer intervenções nos campos cognitivo, emocional e comportamental. É uma abordagem que tem como objetivo a aplicação clínica de seus conceitos e técnicas.

A TCC no tratamento da dor crônica busca auxiliar os pacientes a se tornarem capazes de avaliar o impacto que seus pensamentos e emoções negativos de dor provocam na manutenção de comportamentos inadequados, auxiliando-os a desenvolver estratégias que contribuam para lidar com a cronicidade da dor.

A TCC em grupo (TCCG) traz muitas vantagens, como contato com pessoas que têm problemas similares, aprendizado decorrente desse contato, compreensão maior do papel que a dor exerce sobre o comportamento e o pensamento, aprendizagens sobre como lidar com seus próprios recursos de enfrentamento (Willians et al., 2002).

Para a realização da intervenção em grupo, é necessária uma preparação cuidadosa, como treinamento de terapeuta e coterapeuta. No momento da intervenção, um terapeuta principal deve conduzir o grupo, e o coterapeuta é

o suporte para o desenvolvimento das atividades, ficando sempre atento às interações grupais. O grupo é fechado, com duração de 120 minutos, e as sessões são estruturadas.

A TCCG para pacientes com dor pode contribuir para o controle do quadro álgico, reduzir os sintomas ansiosos e depressivos, assim como melhorar a qualidade de vida do indivíduo. A seguir, será ilustrada a intervenção cognitivo-comportamental em grupo para pessoas com dor crônica. As sessões serão abordadas e detalhadas a partir de um estudo realizado em um Centro de Dor.

O estudo que será apresentado seguiu a orientação da Declaração de Helsinki de 1989, assim como a Resolução nº 196/1996 sobre pesquisas envolvendo seres humanos do Conselho Nacional de Saúde. O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Maternidade Climério de Oliveira (CEP/MCO/UFBA) Parecer/Resolução nº 90/2007. A participação no estudo foi voluntária, iniciando-se somente após a assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido pelo paciente. Os nomes dos participantes apresentados a seguir são todos fictícios.

Esse protocolo foi criado em 2009 como estudo tipo ensaio clínico randomizado com grupos paralelos intitulado *Pacientes com dor crônica: avaliação clínica, qualidade de vida e eficácia da terapia cognitivo-comportamental* (Castro, 2009).

AS SESSÕES DE TCCG PARA PESSOAS COM DOR CRÔNICA (CASTRO, 2011)

SESSÃO I – ENTREVISTA DOS PACIENTES PARA O GRUPO TERAPÊUTICO

Os indivíduos que irão participar do grupo são convidados, nesse primeiro momento, para uma entrevista inicial que tem por objetivo estabelecer um vínculo com os pacientes, conhecer o processo de adoecimento, a história da dor e dos tratamentos a que se submeteram e verificar a expectativa acerca desse trabalho em grupo. Nesse primeiro momento, também são definidos os contratos com relação à duração do grupo, a quantidade de sessões semanais

e o horário, e promove-se a familiarização dos indivíduos com as regras, assim como com o número de faltas possíveis para a continuação no trabalho.

SESSÃO II – PSICOEDUCAÇÃO ACERCA DA TCC E DA DOR CRÔNICA

Nesta sessão, explica-se o conceito de dor crônica para que os pacientes aprendam a lidar mais efetivamente com as circunstâncias que tendem a favorecer o aumento da dor, e faz-se uma explicação sobre a TCC, esclarecendo sua modalidade de tratamento, que é focal, diretiva e educativa. É importante ressaltar que, com a atividade em grupo, não se espera a cura para a dor, mas que os pacientes mantenham comportamentos adaptativos à dor nos meses seguintes. É utilizado um modelo que explica a TCC *versus* dor a partir do que os pacientes trazem. Assim, mostra-se a seguinte relação:

Dor crônica → comportamento de esquiva → depressão → baixa autoestima

O principal ponto que deve ser trabalhado nesse esquema é como as mudanças nos comportamentos alteram a autoestima e a dor. Assim, a intervenção precisa ser focalizada tanto no comportamento quanto nos pensamentos e sentimentos.

Após essa explicação, solicita-se o *feedback* dos pacientes. Uma participante relatou:

A gente tem consciência que precisa fazer alguma coisa, precisa mudar, o problema é dar esse estalo e realmente ter atitude de mudar, porque a gente sabe que ficar deitado não vai resolver, se ficar chorando não vai resolver . . . então chega um momento que dá um estalo e a gente tem que partir para uma atitude, a gente tem que fazer alguma coisa. Consciência que a gente tem que mudar, a gente tem o tempo todo, eu creio que sim, eu penso assim, essa força chegar é o problema. E essa força está no pensamento. (Fátima, 46 anos).

Ao fim da sessão, o paciente leva como tarefa de casa o registro diário de atividades, dor e humor, enfatizando-se que a automonitoração ajuda o

terapeuta e o indivíduo a avaliar quais são as atividades que alteram o escore de dor e do humor, assim como proporciona ao participante alternativa para modificar hábitos rotineiros, pensamentos e sentimentos problemáticos (Fig. 13.1).

Data	Dor	Humor	Atividades desenvolvidas

Figura 13.1 Registro diário de atividades, dor e humor.

SESSÃO III – TREINO DO REGISTRO DE PENSAMENTOS DISFUNCIONAIS (RPD) E TREINO DE RELAXAMENTO

Nesta sessão, explica-se como a TCC compreende o pensamento, ensinando os pacientes a identificar o que são e como são medidos os estados de humor. Em uma folha de exercícios, pede-se que eles identifiquem várias questões relacionadas ao modelo RPD, como ilustrado na Figura 13.2. Com a explicação do RPD, introduz-se o conceito de tríade cognitiva para pessoas com dor crônica, ressaltando-se a importância do paciente em relação a sua dor e ao seu tratamento. Na Figura 13.2, é ilustrado o RPD de Lúcia. Ao término da atividade, foi realizado o relaxamento passivo em conjunto com o treino de respiração diafragmática.

Situação	Pensamento	Emoção	Alternativa	Resultado
Arrumando a casa	Não vou conseguir superar essa dor 70%	Triste 90%	Entendo que não posso fazer todas as coisas, posso fazer algumas e pedir socorro	Tento limpar como posso, peço ajuda ao marido. Pensamento – 30% Emoção – 40%

Figura 13.2 Registro de pensamentos disfuncionais (RPD) de Lúcia, 61 anos.

SESSÃO IV – COMPORTAMENTO DISFUNCIONAL

Neste momento, realiza-se psicoeducação quanto ao conceito de crenças centrais e intermediárias, a partir de um exemplo dos pacientes. Também a partir desse exemplo, explica-se sobre distorções cognitivas, exemplificando-as.

SESSÃO V – TREINAMENTO EM RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS (TRP)

A técnica é explicada a partir de um exemplo dado pelos pacientes, esclarecendo-se que, quando utilizada efetivamente, ajuda a reduzir ainda mais a vulnerabilidade aos comportamentos dolorosos, a partir da melhora da habilidade para enfrentar situações que poderiam desencadear crises álgicas. Define-se, então, com os pacientes, quais os passos para o TRP.

1. Identificar o problema.
2. Todas as maneiras de lidar com o problema devem ser consideradas. O paciente deve gerar tantas soluções quantas forem possíveis. Algumas podem parecer sem sentido, mas devem ser incluídas na lista de alternativas. Quanto mais soluções forem geradas, maior a probabilidade de que uma boa solução apareça.
3. Encontrar a provável efetividade e viabilidade de cada solução.
4. Escolher uma alternativa ou uma combinação delas.
5. Definir os passos para a solução escolhida.
6. A solução deve ser executada.
7. Avaliar a efetividade da solução. Caso não seja alcançado o objetivo, retornar ao passo 2 e recomeçar.

Esses passos são ilustrados na Figura 13.3, com a atividade realizada em um dos grupos.

• Problema	Voltar ao trabalho mesmo sentindo dores
• Soluções possíveis	• Diminuir a carga horária • Tirar 10 min a cada hora trabalhada • Quando não suportar, pedir atestado médico • Intensificar a fisioterapia e aumentar os remédios
• Efetividade e viabilidade	A mais viável é tirar 10 min a cada hora trabalhada
• Escolha da alternativa	Tirar 10 min a cada hora trabalhada
• Passos para a solução	Falar com o chefe sobre essa necessidade
• Execução	Tirar 10 min e fazer massagem, relaxar e descansar
• Avaliação da efetividade	Foi efetivo, estou sentindo alívio quando paro e descanso, embora não seja possível ainda parar 10 min a cada hora trabalhada porque não vou parar por conta própria, mas quando o chefe me autoriza eu paro.

Figura 13.3 Resolução de problemas de Fátima, 46 anos.

Ao aplicar a técnica de resolução de problemas com Fátima, fica claro o quanto, para ela, é importante pensar em estratégias que possam ajudá-la a lidar com os desafios do retorno ao trabalho mesmo estando com quadro de dor intensa. No início, quando a paciente relata seu retorno ao trabalho, teme não conseguir o controle da dor e mostra-se muito angustiada ao falar do assunto. No entanto, à medida que são levantadas pelas participantes do grupo todas as possibilidades para lidar com a dor, Fátima mostra-se aliviada. Estudiosos afirmam que no trabalho em grupo observa-se o quanto as interações são úteis para modelar respostas apropriadas do paciente que está exibindo comportamentos dolorosos negativos relacionados ao afeto. O grupo também tem uma função encorajadora, permitindo a revelação de sentimentos e pensamentos (Thorn & Kuhajda, 2006).

SESSÃO VI – MOMENTO DE REFLEXÃO ACERCA DOS CONCEITOS E TÉCNICAS APRESENTADOS

Este momento é realizado no intuito de revisar todas as técnicas aprendidas até o momento e os ganhos e dúvidas referentes ao tratamento. Ao fim, é realizada uma dinâmica de grupo; avalia-se o desenvolvimento da atividade, seu significado e como cada um percebeu esse trabalho. É realizada a técnica da distração, com ênfase na importância da percepção da dor no corpo, e ensinam-se os pacientes a controlá-la utilizando seus próprios recursos. Com a distração, o paciente passa a focar sua atenção a situações outras ao seu redor, retirando, assim, a atenção de seu corpo.

SESSÃO VII – TÉCNICA DA ASSERTIVIDADE

Neste momento, explica-se ao grupo o conceito de comportamento assertivo, comportamento não assertivo e comportamento agressivo. Essa técnica pode ser realizada com a ajuda de outra, o *role-playing*, em que paciente e terapeuta encenam uma situação para a emissão do comportamento assertivo. Esta cena é exemplificada a seguir.

Descrição da situação como aconteceu:

Rita – Estava em uma loja e vi uma blusa que estava com duas etiquetas, uma com o valor de R\$ 27,90 e a outra com o valor de R\$ 29,90. Resolvi levar a blusa porque estava na promoção. Chegando no caixa, a atendente pegou a etiqueta de R\$ 27,90, rasgou e jogou fora e disse que o valor era R\$ 29,90. Eu tempestivamente gritei com ela: “Ponha meu papel que você jogou no chão aí agora, ousada, pegue meu papel, sua mal-educada . . . Você não tem educação, não tem condições de atender ninguém. . .”.

A partir desse relato, foi realizado o *role-playing*, com a paciente sendo assertiva:

Terapeuta (T) – A senhora vai pagar em cartão ou cheque?

Rita (R) – Cartão.

T – O preço era R\$ 27,90 na promoção, mas ela já saiu da promoção, e o preço é R\$ 29,90.

R – Ô, filha, infelizmente eu vou pagar R\$ 27,90, até mesmo porque você sabe que o código do consumidor respalda que o cliente vai pagar pelo menor preço.

T – Tá aqui a etiqueta de R\$ 29,90, e aquela que eu rasguei era antiga porque quem fez a reposição esqueceu de tirar.

R – Então eu vou passar aqui no seu balcão e pegar a de R\$ 27,90, e você pede a alguém que tem autonomia para resolver para mim.

T – Eu acabei de falar para a senhora que foi um erro de quem fez a reposição, e o preço é R\$ 29,90.

R – Mas eu não vou pagar por esse erro; o preço estava R\$ 27,90, então a partir do momento em que eu peguei a mercadoria nesse valor eu já tenho um parâmetro, é para isso que tem preço, para que quando o cliente pegue já tenha o preço. Se eu só tivesse R\$ 27,90?

T – Como eu não tenho poder para decidir isso, vou chamar meu supervisor.

R – Não tem problema, o importante é resolver e eu pagar o valor que está na etiqueta. Agora, por favor, pegue o valor que está no chão porque eu preciso mostrar ao supervisor.

T – Pego.

Supervisor – Ok, o erro foi nosso, você vai pagar R\$ 27,90.

R – Agora, um momento. Eu gostaria de te dar um *feedback*. Seu serviço está de péssima qualidade, essa atendente que vocês estão colocando em linha de frente está comprometendo totalmente a imagem da loja. Vocês têm que dizer a elas que elas são as anfitriãs de uma casa e que têm que tratar bem os clientes. Se coloque em meu lugar, você chega em uma casa para comprar uma mercadoria e a pessoa rasga o preço e joga no chão, você não ficaria chateado?

Supervisor – Obrigado pelo seu *feedback*, vou chamar a atenção da funcionária.

Ao término da dramatização, Rita fala: “Estou me sentindo bem, foi a atitude dela que me deixou transtornada. Tenho que exercitar muito para agir assim”.

Ao fim da dramatização, explica-se ao grupo que a assertividade requer treino e que realmente não é fácil, mas que os outros comportamentos nos causam muito mais sofrimento. Com esse *role-playing*, demonstrou-se o quanto a reconstrução da cena utilizando elementos assertivos possibilita uma avaliação de maior qualidade das dificuldades e proporciona uma melhor adaptação do indivíduo na comunicação com o mundo ao qual pertence.

SESSÃO VIII – RELAÇÃO ENTRE DOR E TRABALHO

Nesta sessão, é desenvolvida uma atividade para avaliar o que o paciente fazia (atividade laboral) antes da dor, em comparação ao que ele pode fazer mesmo com a presença dela. A partir disso, elabora-se uma lista de possíveis engajamentos em atividades sociais e de lazer.

Os pacientes se veem desconectados da realidade cotidiana do trabalho quando são afastados de suas atividades laborais e passam a lidar com a rotina restrita de tratamentos, medicações e seus efeitos adversos. Muitas vezes, é a partir desse contexto que surgem os sintomas ansiosos e depressivos que passam a caminhar em “mão dupla” com o quadro álgico.

Solicita-se, então, que os pacientes falem o que faziam, com base no que mostra a Figura 13.4.

Trabalho	Antes da dor	Depois da dor
Joana	Caixa (digitava bastante) Lavava roupas Arrumava o quarto	Digita pouco Faz por etapas Comprou panelas de teflon (não precisa fazer força para limpar)

Figura 13.4 Exemplo de Joana.

A partir do levantamento do que faziam no trabalho, é realizada, em conjunto, a técnica de resolução de problemas que foi ensinada anteriormente, para encontrar soluções para as dificuldades que os pacientes enfrentam no processo laboral. O que é reforçado nessa atividade é a importância de continuar executando as funções, adaptando-se, no entanto, à nova realidade.

SESSÃO IX – QUEM SOU EU, COMO PERCEBO MINHA DOR

Esta sessão aborda a relação existente entre alteração do padrão do sono e dor. Reavalia-se a percepção que os pacientes têm da dor, bem como a repercussão desta em suas vidas. Nesta sessão, faz-se uso da técnica do relaxamento com visualização. Esse é um momento em que é possível proporcionar ao paciente o contato com sua dor por meio da visualização da forma dada para essa dor. A partir da reestruturação cognitiva, é possível ressignificar o processo doloroso.

SESSÃO X – EU, MINHA FAMÍLIA E A DOR

O ambiente próximo ao paciente tem um papel importante na expressão individual da dor, assim como o contexto específico no qual a dor está inserida influencia sua percepção. A manutenção dos comportamentos de dor

depende dos reforços recebidos do ambiente externo, que podem contribuir para que eles permaneçam mesmo quando os indivíduos não estão sentindo dor ou quando a intensidade se situa dentro de um limiar suportável. Nesta sessão, trabalha-se o impacto da percepção que os pacientes têm das atitudes de seus familiares diante de seu adoecimento e também como a dor pode interferir em sua sexualidade. Essa intervenção é realizada com o auxílio do RPD.

As falas nos grupos são muito ricas em sentidos e significados; assim, podemos observar como é a relação dos pacientes que se encontravam no grupo com a família.

Fátima descreve o quanto a dor interferia em sua relação familiar e social:

A dor interferiu, eu me tornei uma pessoa agressiva. Muitas vezes por ter coisas para fazer ou as pessoas não entenderem que a gente está sentindo dor e não pode esconder, afeta, afetou minha vida com meus filhos e a vida social. Quando a gente tá com dor tudo cansa, eu mesmo não suporto ir à praia porque o sol me irrita. Com relação a trabalho em casa, a gente precisa de ajuda, então eu passei a cobrar, exigir, porque quando eu não tinha ajuda eu me aborrecia muito. Passei a não sair, não deixei de conviver com a família, mas eu evitava ir às festas, reuniões. Com relação ao sexo, foi um problema, porque meu marido não entendia, e a cobrança é normal. E a gente não se sente a mesma de antigamente, e, no meu caso, os problemas do dia a dia acabaram em separação, não foi somente a dor, mas contribuiu.

A partir desse relato, pode-se perceber como a dor desestrutura o indivíduo em todas as dimensões. A TCC busca, então, por meio de suas técnicas, desenvolver novos recursos, avaliando e reestruturando as crenças disfuncionais para que os pacientes possam (con)viver apesar da dor.

Para a preparação da última sessão, solicita-se que os pacientes elaborem um plano de manutenção e metas a curto, médio e longo prazos.

SESSÃO XI – O FUTURO E A PREVENÇÃO DE RECAÍDAS

Nesta sessão de finalização, faz-se a leitura dos planos de manutenção de cada um dos integrantes do grupo, estabelecendo-se, assim, suas metas e desenvolvendo as questões ao se solicitar o acréscimo de novas estratégias que poderão ser utilizadas no futuro. Depois, é feito um *feedback* de todo o processo grupal, para que os pacientes possam verbalizar o que mudou em suas vidas. Rita, uma paciente que apresentava alguns comportamentos agressivos, descreveu o quanto o grupo a ajudou a ter comportamentos mais assertivos. Em seu relato, diz:

Na quinta-feira, me aborreci com meu filho, que chegou atrasado na escola para fazer prova e o portão estava fechado. Ele voltou dizendo que tinha que fazer segunda chamada. Fiquei muito chateada, briguei com ele e o coloquei de castigo. Pensei e falei com ele que a responsabilidade era dele e que isso era um reflexo da atitude dele e que agora ele que ia ver um jeito de resolver a situação, passei a bola. Melhorei, não foi? Porque antes eu não teria uma reação dessas.

Após a conclusão das sessões, solicita-se que os pacientes façam para os familiares presentes exposição envolvendo psicoeducação acerca de dor crônica, tratamentos, comorbidades e as repercussões da dor em sua vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dor crônica é uma doença que afeta a esfera biopsicossocial do indivíduo e desestrutura sua rotina, alterando e impossibilitando, muitas vezes, o desempenho de atividades básicas, como higiene pessoal, e atividades da vida diária, como o cuidado com a rotina da casa. Ela modifica as relações com o trabalho e com os vínculos sociais, afetivos e familiares. Dessa forma, é necessário um olhar cuidadoso da equipe que acompanha indivíduos com dor crônica, com uma avaliação detalhada da dor. Essa avaliação envolve o exame físico, a história da doença, a busca de antecedentes familiares e pessoais significativos para o quadro, a investigação por meio de exames laboratoriais e de imagem, a identificação das diferentes qualidades da dor,

assim como a investigação de todos os aspectos emocionais e culturais envolvidos nesse adoecimento.

Uma das orientações mais enfatizadas pela equipe que trabalha com indivíduos que sofrem de dor crônica é a prática regular de exercícios físicos. A psicoeducação, prática de ensinar o indivíduo sobre sua dor e a importância do tratamento, é um veículo efetivo para que o sujeito colabore e seja um agente efetivo na mudança de seu padrão de comportamento doloroso. A prática de atividades físicas favorece a liberação de endorfinas, sendo visível o bem-estar físico e mental quando o indivíduo fica ativo no processo, além de proporcionar maior disposição nas atividades, no humor, no padrão de sono e nas relações afetivas e sociais.

À equipe, cabe orientar o paciente no cuidado com os sintomas, bem como garantir a realização do tratamento visando seu bem-estar físico e psicológico e formar uma boa aliança terapêutica, a fim de alimentar a confiança mútua. Na equipe, cabe ao psicólogo avaliar cuidadosamente o processo de dor e acolher o sofrimento do paciente, buscando fortalecer sua identidade, autoestima e autonomia, a fim de que este possa dar novo significado e redirecionar sua vida para além da dor.

REFERÊNCIAS

Angerami, V. A. (Org.). (2003). *E a psicologia entrou no Hospital...* São Paulo: Pioneira Thomson Learning.

Araujo, L. C., & Romero, B. (2015). Pain: Evaluation of the fifth vital sign. A theoretical reflection. *Revista Dor*, 16(4), 291-296.

Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (Orgs.). (2008). *Terapia cognitivo-comportamental em grupos*. Porto Alegre: Artmed.

Brox, J. I., Sørensen, R., Friis, A., Nygaard, Ø., Indahl, A., Keller, A., ... Reikerås, O. (2003). Randomized clinical trial of lumbar instrumented fusion and cognitive intervention and exercises in patients with chronic low back pain and disc degeneration. *Spine*, 28(17), 1913-1921.

Carvalho, M. M. M. J. (Org.). (1999). *Dor: Um estudo multidisciplinar* (2. ed.). São Paulo: Summus.

Casaes, N. R. R. (2007). *Suporte social e vivência de estigma: Um estudo entre pessoas com HIV/AIDS* (Dissertação de mestrado não-publicada, Universidade Federal da Bahia, Salvador).

Castro, M. M. C. (2009). *Pacientes com dor crônica: Avaliação clínica, qualidade de vida e eficácia da terapia cognitivo-comportamental* (Tese de doutorado não-publicada, Programa de Pós-Graduação em Medicina e Saúde, Universidade Federal da Bahia, Salvador).

- Castro, M. M. C. (2011). Contribuições da terapia cognitivo-comportamental em grupo para pessoas com dor crônica. In: B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., p. 608-616). Porto Alegre: Artmed.
- Catalano, E. M., & Hardin, K. N. (2004). *Dores crônicas: Um guia para tratar e prevenir* (cap. 1, pp. 21-29). São Paulo: Summus.
- Charmaz, K. (1983). Loss of self: A fundamental form of suffering in the chronically ill. *Sociology of Health & Illness*, 5(2), 168-195.
- Dejours, C. (1988). *A loucura do trabalho: Estudo de psicopatologia do trabalho*. São Paulo: Cortez.
- Delgado, J. A. (2005). *Que é o “ser da família”?* Texto contexto: Enfermagem, 14(n. spe.), 86-94.
- Ferreira, K. S., & Speciali, J. G. (2015). Epidemiology of chronic pain in the office of a pain specialist neurologist. *Arquivos de Neuro-Psiquiatria*, 73(7), 582-585.
- Gatchel, R. J., & Turk, D. C. (1996). *Psychological approaches to pain management: A practitioner's handbook*. New York: Guilford Press.
- International Association for the Study of pain (IASP). (2012). *Pain terminology*. Retirado de <http://www.iasp-pain.org/Taxonomy>
- Loeser, J. D., & Treede, R. H. (2008). The Kyoto protocol of IASP basic pain terminology. *Pain*, 137(3), 473-477.
- Martel, L. C., & Ortiz, M. T. A. (2001). Importancia de las creencias em la modulación del dolor crônico: Concepto y evaluación. *Apuntes de Psicología*, 19, 453-470.
- Melzack, R., & Wall, P. D. (1965). Pain mechanisms: A new theory. *Science*, 150(3699), 971-979.
- Pinheiro, R. C., Uchida, R. R., Mathias, L. A. S. T., Perez, M. V., & Cordeiro, Q. (2014). Prevalência de sintomas depressivos e ansiosos em pacientes com dor crônica. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 63(3), 213-219.
- Redondo, J. R., Justo, C. M., Moraleda, F. V., Velayos, Y. G., Puche, J. J., Zubero, J. R., ... Pareja, M. A. (2004). Long-term efficacy of therapy in patients with fibromyalgia: A physical exercise-based program and a cognitive-behavioral approach. *Arthritis and Rheumatism*, 51(2), 184-192.
- Rocha, A. P. C.; Kraychete, D. C.; Lemonica, L.; Carvalho, L. R.; Barros, G. A. M.; Garcia, J. B. S., & Sakata, R. K. (2007). Dor: Aspectos atuais da sensibilização periférica e central. *Revista Brasileira de Anestesiologia*, 57(1), 94-105.
- Rocha, S. R. A. (2007). Depressão relacionada aos distúrbios osteomusculares no trabalho bancário. In Mendes, A. N. (Org.), *Psicodinâmica do trabalho: Teoria, método e pesquisa* (cap. 9, pp. 205-230). São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Thorn, J. A., Kuhajda, M. (2006). Group cognitive therapy for chronic pain. *Journal of Clinical Psychology*, 62(11), 1355-1366.
- Turk, D. C. (2003). Cognitive-behavioural approach to the treatment of chronic pain patients. *Regional Anesthesia and Pain Medicine*, 28(6), 573-579.
- White, J. R., & Freeman, A. S. (2003). *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para populações e problemas específicos*. Roca: São Paulo.

Williams, D. A., Cary, M. A., Groner, K. H., Chaplin, W., Glazer, L. J., Rodriguez, A. M., & Clauw, D. J. (2002). Improving physical functional status in patients with fibromyalgia: a brief cognitive behavioural intervention. *The Journal of Rheumatology*, 29(6), 1280-1286.

Winterowd, C., Beck, A. T., & Gruener, D. (2003). *Cognitive therapy with chronic pain patients*. Springer: New York.

14



TERAPIA DE GRUPO PARA PACIENTES COM TRANSTORNO DA PERSONALIDADE

Lidiane Borba

Daniela Schneider Bakos

Vinícius Guimarães Dornelles

Carmem Beatriz Neufeld

A psicoterapia de grupo teve sua expansão teórica nas décadas de 1950 e 1960, atingindo sua consolidação na década de 1970 e amadurecimento nos anos de 1980 e 1990 (Bechelli & Santos, 2004). Mesmo sendo concebida inicialmente como um tratamento de longo prazo, baseado principalmente na abordagem psicodinâmica e interpessoal, atualmente várias abordagens vêm incluindo intervenção grupal. Nesses contextos, os grupos psicoeducacionais são considerados predominantes, realizados muitas vezes como o primeiro estágio do tratamento, em formato intensivo e de tempo limitado (MacKenzie, 2001).

Embora não existam dados claros sobre o início da terapia de grupo para pacientes com transtorno da personalidade (TP), os primeiros registros são de tratamentos realizados em unidades de internação (Kibel, 1981). Esses estudos relatam, ainda, que a maioria dos pacientes reunia critérios para o transtorno da personalidade *borderline* (TPB) e que muitas das intervenções incluíam como terapeutas enfermeiras psiquiátricas (Budman, Demby, Soldz, & Merry, 1996; Miller, Eisner, & Allport, 1994; Nehls, 1991).

Os TPs são definidos e diagnosticados com base no funcionamento interpessoal e nos déficits a eles relacionados (MacKenzie, 2001). Ainda que os pacientes com TP tenham como características padrões persistentes, invasivos e rígidos, tais padrões podem manter-se inconscientes ao longo de uma vida inteira (Azima, 1996). Nesse sentido, a psicoterapia de grupo tem sido considerada de grande valor no tratamento desses transtornos, pois permite que as dificuldades interpessoais sejam observadas no grupo e abordadas mais direta e rapidamente que na terapia individual (Yalom, 2006).

Além disso, quando os pacientes estão em grupo, eles apresentam seus padrões de conduta característicos, e os membros refletem os efeitos desses padrões sobre os relacionamentos interpessoais dos indivíduos. Assim, os comportamentos desadaptativos podem ser examinados na situação de grupo, e os pares podem fornecer *feedback* ao paciente (Piper & Rosie, 1998). Nesse momento, os participantes têm a oportunidade de ouvir como as pessoas se sentem diante de determinadas atitudes, só que em um contexto estável, onde quem oferece esse retorno também está sendo treinado a fazê-lo da melhor forma.

Yalom (2006) tem proporcionado importante contribuição para a terapia de grupo por meio da descrição dos fatores terapêuticos. Esses fatores estão presentes nos grupos, independentemente do diagnóstico, e desempenham um papel importante também nos TP. São eles: instilação da esperança; universalidade; compartilhamento de informações; altruísmo; desenvolvimento de técnicas de socialização; comportamento imitativo; coesão grupal; recapitulação corretiva do grupo familiar; e catarse. A terapia cognitivo-comportamental (TCC) concorda com a maioria desses fatores, com exceção dos dois últimos, uma vez que essa abordagem tem como foco o

momento presente e prevê que seus membros possam compartilhar informações pessoais já em uma etapa inicial do tratamento (Bieling, McCabe, & Antony, 2006).

Diversas vantagens vêm sendo apontadas na literatura acerca dos benefícios da terapia em grupo para TP. Ao proporcionar mais relações interpessoais, o grupo diminui a intensidade da transferência entre paciente e terapeuta, tornando o papel do terapeuta menos central na psicoterapia de grupo quando comparada à terapia individual (Budman et al., 1996). Dessa forma, o grupo pode contribuir para um clima mais produtivo, uma vez que os pacientes tendem a ser mais tolerantes quando os comentários são recebidos de outros membros, e não do terapeuta.

Outra vantagem importante da terapia de grupo está na oportunidade que o paciente tem de se envolver em diferentes funções dentro da diversidade do grupo e observar os comportamentos dos demais membros. A pressão do grupo pode ajudar, ainda, a prevenir alguns comportamentos impulsivos e estimular condutas mais positivas e pró-sociais (Budman et al., 1996). Ao se envolverem em comportamentos empáticos e solidários, os pacientes tendem a melhorar também a própria autoestima (MacKenzie, 2001). Além das vantagens citadas, Freeman e Stewart (2006) destacam razões importantes para a intervenção em grupo, descritas no Quadro 14.1.

Quadro 14.1 Benefícios da terapia de grupo no tratamento dos transtornos da personalidade

1. O grupo tende a encorajar os pacientes a estabelecer uma participação mais ativa no próprio tratamento, facilitando, assim, o engajamento terapêutico.
2. As interações comportamentais dos pacientes com seus pares no ambiente de grupo, assim como as respostas interpessoais, permitem maior clareza para realização do diagnóstico.
3. Ao compartilhar suas percepções e reações no grupo, os pacientes sentem que não estão sós em seu sofrimento e que outras pessoas têm problemas de natureza semelhante.
4. O grupo pode fornecer suporte e apoio aos participantes que se encontram isolados ou que possam estar enfrentando alguma situação traumática.
5. O formato de grupo é especialmente adequado para a realização de psicoeducação, em que as informações podem ser apresentadas em tópicos específicos aos membros que compartilham os mesmos sintomas.
6. Os participantes podem testar seus pensamentos automáticos e experiências comportamentais em um ambiente relativamente seguro.
7. O contexto grupal permite que os pacientes pratiquem suas habilidades sociais e adquiram modelos com os demais membros do grupo e terapeutas.
8. A terapia de grupo tende a motivar os pacientes a seguir em terapia individual.
9. O grupo pode auxiliar seus membros a se tornarem mais conscientes de suas experiências e mais atentos à origem de pensamentos e sentimentos, de forma que consigam visualizar essas questões da forma mais objetiva possível.
10. Os pacientes podem praticar novos comportamentos e habilidades no ambiente do grupo antes de testá-los na “vida real”.

Ainda que a psicoterapia de grupo conte com as vantagens descritas, essa modalidade tem sido pouco testada no tratamento dos TPs, com exceção do TPB, quadro em que tem sido extensivamente mais estudada (Matusiewicz, Hopwood, Banducci, & Lejuez, 2010). Mesmo escassos, os ensaios clínicos apontam resultados positivos para a psicoterapia de grupo aplicada aos demais TPs, como transtorno da personalidade evitativa (Renneberg, Goldstein, Phillips, & Chambless, 1990; Springer, Lohr, Buchtel, & Silk, 1996).

TERAPIA DO ESQUEMA EM GRUPOS PARA TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE

A terapia do esquema (TE) foi originalmente desenvolvida por Young (1999) para o tratamento dos TPs. Trata-se de uma terapia integrativa, combinando estratégias cognitivas, comportamentais, psicodinâmicas e experienciais, que traz como principais conceitos os esquemas iniciais desadaptativos (EIDs), os estilos de enfrentamento esquemáticos e os modos de esquemas (Arntz & Jacob, 2013; Young, Kloslo, & Weishaar, 2003).

Nos últimos anos, diversas pesquisas têm evidenciado a eficácia clínica da TE no tratamento dos TPs (Bamelis, Evers, Spinhoven, & Arntz, 2014; Dickhaut & Arntz, 2014; Farrell, Shaw, & Webber, 2009; Giesen-Bloo et al., 2006, Nadort et al., 2009; Renner et al., 2013), especialmente no que tange ao TPB (Farrell et al., 2009; Giesen-Bloo et al., 2006; Nadort et al., 2009; Nordahl & Nysaeter, 2005). Quanto à modalidade de tratamento, muitos estudos têm priorizado o formato de grupo (Dickhaut & Arntz, 2014; Reiss, Lieb, Arntz, Shaw, & Farrell, 2014; Renner et al., 2013; Roelofs et al., 2016; Schaap, Chakhssi, & Westerhof, 2016; van Vresswijk, Spinhoven, Eurelings-Bontekoe, & Broersen, 2014; Videler, Rossi, Schoevaars, van der Feltz-Cornellis, & van Alphen, 2014), destacando suas vantagens com relação a custo, duração do tratamento, interações entre pares, senso de pertencimento,

aprendizagem vicária e oportunidade de prática experiencial ao vivo (Farrell et al., 2009).

A PRÁTICA DA TE EM GRUPOS

A TE em grupo pode ser considerada a terceira fase ao longo do desenvolvimento da abordagem de esquemas (Edwards & Arntz, 2012), surgindo como uma excelente proposta no sentido de agregar efetividade, custo-benefício e maior disponibilidade de tratamento. O uso do formato de grupo nesse modelo terapêutico tem suas origens nos trabalhos de Farrell e Shaw (1994) com pacientes com TPB, a partir dos quais técnicas específicas da TE foram adaptadas ao formato grupal, como é o caso da reparentalização limitada e da reestruturação imagística, visando a expansão das intervenções em grupo (Farrell & Shaw, 1994; Farrell et al., 2009).

O modelo da TEG desenvolvido por essas autoras é conceitualmente consistente com a TE individual. Uma diferença importante reside na adaptação de intervenções padrões da TE, como é o caso da reestruturação imagística e do *role-playing* de modos esquemáticos, de forma a contemplar o grupo como um todo. Nesse modelo, dois coterapeutas são necessários para manter o vínculo com os pacientes, visto que a relação terapeuta-paciente é um componente central na TE. O papel do terapeuta é ativo e diretivo, com base no estágio desenvolvimental e nas necessidades específicas do grupo em questão. Diferentemente de grupos tradicionais de terapia cognitiva (TC) e de treinamento de habilidades, na TE em grupo, a relação entre os membros participantes é utilizada para catalisar e aumentar os ingredientes ativos da TE (reparação parental limitada, trabalho experiencial e quebra de padrões comportamentais disfuncionais).

Neste sentido, entende-se que o grupo pode oferecer alguns elementos extras que atingem de forma mais profunda os esquemas disfuncionais, como, por exemplo: (1) suporte e validação mútua entre membros do grupo, (2) possibilidade de experimentar de forma segura a expressão de emoção e novos comportamentos, (3) apego mútuo capaz de reestruturar representações de apego inseguro, (4) confrontações empáticas entre membros, (5) reparação parental limitada expandida, a partir da configuração “dois pais e uma família

inteira”, e, por fim, (6) uma oferta maior de participantes para a vivência de técnicas experienciais (Farrell, Shaw, & Reiss, 2012).

A estrutura geral do protocolo de grupo envolve um estágio inicial de psicoeducação sobre o funcionamento esquemático do paciente e o diagnóstico em questão, incluindo uma discussão sobre as origens dos sintomas em termos das necessidades infantis e adolescentes não satisfeitas. Nessa etapa, validação emocional e empatia são proporcionadas entre os membros do grupo e pelo terapeuta, favorecendo o vínculo e a reparação parental limitada. No contexto de grupo, a reparação é intensificada pela presença de um segundo terapeuta e dos membros do grupo. A coesão do grupo é fortalecida por meio da ideia de “família” e “lar seguro”.

A segunda fase do grupo foca na mudança dos modos esquemáticos. Em termos do modelo dos modos, em cada situação, o terapeuta e o grupo precisarão encontrar maneiras para lidar com as diferentes necessidades a serem contempladas, sem que ninguém se sinta sacrificado. O trabalho com o modo protetor desligado, por exemplo, visa aumentar a consciência emocional de forma a transpor esse modo. À medida que os pacientes aprendem a tolerar emoções ameaçadoras ou desconfortáveis, o modo criança vulnerável pode ser acessado pelo grupo e pelo terapeuta, rumo a uma experiência reparadora.

O modo criança vulnerável é explorado por meio do trabalho de imagens, o qual deve ser iniciado com todos os membros gerando a cena do local seguro para, posteriormente, visualizarem a cena que compreende a criança vulnerável. Após permanecerem nessa cena por alguns minutos, todos abrem seus olhos, e o trabalho com cada um se inicia, conforme demanda. No momento em que um membro do grupo volta à cena infantil e tem sua necessidade identificada, o grupo trabalha criativamente para suprir essa falta. Outras experiências, como a validação emocional, bem como o respeito e a gentileza compartilhados entre os participantes, são igualmente geradoras de correção emocional significativa nesse modo.

O grupo precisa ser um local seguro para o modo criança zangada/impulsiva se expressar. Contudo, se, por um lado, o modo criança zangada precisa ventilar a raiva no grupo sem gerar abandono em função de

comportamentos inapropriados, por outro, esses mesmos comportamentos precisam ser pontuados e considerados quanto aos seus efeitos no grupo. Isso porque, quando a expressão de raiva ocorrer, alguns membros podem se sentir capazes de permanecer por perto, enquanto outros sentirão a necessidade de se posicionar atrás de uma barreira protetiva. Nesses casos, o modo criança vulnerável dos pacientes precisa ser protegido pelo terapeuta. *Role-playings* entre membros do grupo podem ser realizados, nos quais um terapeuta geralmente faz o papel do pai punitivo ou crítico enquanto o outro contrapõe com um pai bom/validante.

Outro fator curativo oportunizado pelo grupo é a construção de um modo adulto saudável, por meio de modelos de funcionamento, *feedbacks* e práticas de habilidades. O aprendizado vicário tem um papel fundamental nesse ponto, uma vez que muitas situações de enfretamento de distorções e reações emocionais disfuncionais por parte de algum membro servem como fontes de motivação no grupo como um todo. Nesse sentido, os pacientes muitas vezes referem se impactar mais com a exposição a outros colegas agindo em modos disfuncionais do que ao receber o *feedback* verbal das consequências de suas atitudes disfuncionais quando no mesmo modo (Farrell et al., 2012).

Por fim, além do modelo de grupo exposto, Broersen & van Vreeswijk (2012) apresentam um programa breve de TE em grupo (SCBT-g), desenvolvido para um grupo misto de pacientes com *cluster* B e C. Diferentemente do modelo introduzido por Farrell e Shaw (1994), este foca primeiramente nas técnicas cognitivas e comportamentais da TE e é descrito como compartilhando aspectos tanto da terapia comportamental clássica quanto da terapia interpessoal em grupo. Por conter menos técnicas experienciais e processos baseados no grupo, esse protocolo é visto como uma forma de TCC que utiliza conceitos da TE. Uma proposta de um protocolo da TE em grupo pode ser contemplada no Quadro 14.2.

Quadro 14.2 Protocolo da TE em grupo para transtornos da personalidade	
Número da sessão	Conteúdo
Sessão 1	• Contrato inicial • Apresentação geral do grupo/identidade e regras de funcionamento

Sessões 2 e 3	• Psicoeducação sobre o funcionamento esquemático do paciente (EIDs e estilos de enfrentamento) e o diagnóstico
Sessões 4 e 5	• Discussão sobre as origens dos sintomas (dados da história, com foco nas necessidades infantis e adolescentes não satisfeitas) • Psicoeducação sobre os modos esquemáticos
Sessões 6 e 7	• Trabalho com modos esquemáticos: foco nas estratégias cognitivas
Sessões 8 e 9	• Trabalho com modos esquemáticos: foco nas estratégias experienciais
Sessões 10 e 11	• Trabalho com modos esquemáticos: foco nas estratégias comportamentais
Sessão 12	• Encerramento: manutenção de ganhos e prevenção de recaída

Fonte: Adaptado de Broersen e van Vreeswijk (2012) e Farrell e colaboradores (2012).

PESQUISAS DE EVIDÊNCIAS DA TE EM GRUPOS PARA TP

Quase duas décadas depois da apresentação do modelo de TE em grupo, Farrell e colaboradores (2009) testaram a hipótese de que a combinação de uma abordagem de grupo somada ao atendimento individual seria mais efetiva na redução dos sintomas do TPB quando comparada à terapia de formato apenas individual. O programa da TE em grupo consistiu em 30 sessões semanais de 90 minutos cada, ao longo de oito meses. Os resultados evidenciaram uma diferença significativa entre os grupos, em favor da TE. Mais especificamente, o grupo que recebeu essa modalidade de tratamento apresentou escores significativamente menores ao fim das 30 sessões de TE em grupo, tanto nas medidas dos sintomas de TPB quanto nos sintomas psiquiátricos globais.

Outro estudo, embora piloto, também avaliou a combinação de TE individual e em grupo no tratamento de pacientes com TPB (Dickhaut & Arntz, 2014). Dois grupos de indivíduos com esse transtorno foram submetidos semanalmente, ao longo de dois anos, a TE individual e a TE em grupo. A única diferença entre os grupos era a formação do terapeuta, no intuito de verificar os efeitos de treinamento. As sessões individuais foram delineadas de acordo com o protocolo de Arntz e van Genderen (2009) e objetivaram, ainda, dar suporte às sessões de grupo. Já a modalidade em grupo se baseou no formato utilizado por Farrell e Shaw (2012). Sintomas oriundos do diagnóstico em questão, bem como os EIDs e os modos

esquemáticos, foram avaliados a cada seis meses, durante 2 anos e meio. As manifestações do TPB reduziram significativamente, e 77% da amostra se mostrou recuperada após 30 meses.

Utilizando apenas o formato grupal como modalidade de intervenção, Renner e colaboradores (2013) investigaram o efeito da TE em grupo em uma população de adultos jovens com TP ou traços de TP. Participaram do estudo 26 adultos com um diagnóstico primeiro do *cluster* B ou C ou, ainda, apenas com características de TP. O protocolo de TE em grupo utilizado foi o desenvolvido por Broersen e van Vreeswijk (2012), o qual consiste em 18 sessões semanais estruturadas, com ênfase na psicoeducação e nas técnicas cognitivas. Os achados indicaram uma queda substancial dos sintomas de estresse gerais do pré-tratamento ao pós-tratamento. Os EIDs, modos esquemáticos e estilos de enfrentamento diminuíram; contudo, o decréscimo nos EIDs não se manteve significativo quando se controlou os sintomas de estresse. O achado de manutenção da estabilidade dos EIDs já foi igualmente constatado em estudos anteriores, reforçando a máxima de que é preciso longos períodos de tratamento para que se obtenha uma mudança mais profunda. Os dados, todavia, revelam evidências preliminares da eficácia da TE em grupo nessa população.

O estudo realizado por Videler e colaboradores (2014) é o primeiro a investigar o efeito da TE em grupo em pacientes idosos com transtorno do humor crônico ou transtorno de adaptação com comorbidade com TP ou traços de TP. A amostra contou com 31 participantes de 60 a 78 anos, os quais foram submetidos a 18 sessões semanais de TE em grupo, de 90 minutos cada, seguidas de duas sessões de seguimento. No primeiro estágio (sessões 1-9), os pacientes eram educados sobre os seus três principais esquemas e modos disfuncionais e, no segundo (sessões 10-20), eram estimulados a responder a situações que ativassem seus esquemas de uma maneira mais adaptativa. Os achados confirmaram a eficácia da TE em grupo para a população de indivíduos idosos, tanto na redução do nível dos sintomas quanto na mudança dos EIDs. Ademais, observou-se que as mudanças na gravidade dos esquemas do início ao meio do tratamento predisseram a melhora sintomatológica final.

É importante observar a diferença de grupos etários considerados nos estudos referidos (Renner et al., 2013; Videler et al., 2014), uma vez que os EIDs podem diferir em termos de maturação e rigidez conforme a idade. Apesar de os dois estudos terem constatado a eficácia da abordagem de esquemas em grupos de curta duração em populações com TP ou traços de TP, o tamanho de efeito do estudo de Renner e colaboradores (2013) se mostrou superior. Os autores propõem que uma maior flexibilidade e potencial de mudança dos EIDs de adultos jovens poderiam explicar esses achados.

Van Vresswijk e colaboradores (2014) investigaram a relação entre a TE em grupo de curta duração e mudanças na sintomatologia, nos esquemas e nos modos em uma amostra heterogênea formada por pacientes com problemas de eixo I de longo prazo e/ou características de TP. A TE em grupo de curta duração envolveu 18 sessões semanais de 90 minutos cada, seguidas por duas sessões de seguimento no primeiro e segundo mês após o término do tratamento. Os achados indicaram que 46,8% dos participantes se recuperaram quanto aos seus sintomas iniciais, e 12% demonstraram melhora. Nesse sentido, de forma semelhante aos estudos anteriores (Renner et al., 2013; Videler et al., 2014), a TE em grupo de curta duração pôde ser associada a uma melhora clinicamente significativa em uma população com problemas de eixo I de longo prazo e/ou características de TP. O domínio esquemático “orientação para o outro” foi um preditor significativo do sucesso do tratamento. Os resultados sugeriram, ainda, que as mudanças nos esquemas ocorrem em conjunto com as mudanças nos sintomas, por meio de um processo de reforçamento mútuo.

Reiss e colaboradores (2014) examinaram os efeitos de tratamentos de internação para uma população de 92 pacientes com diagnóstico de TPB por meio de três estudos-piloto. Os programas combinaram modalidades individuais e grupais, consistentes com a TE para essa população. Os resultados mostraram que a TE na modalidade de internação pôde reduzir sintomas do TPB grave.

Nessa mesma direção, Schaap e colaboradores (2016) investigaram a efetividade da TE no tratamento de adultos com TPs, internados em uma

unidade psiquiátrica, que não responderam a abordagens anteriores. O programa multidisciplinar de tratamento em grupo contou com duas sessões semanais, com duração de 1h25min cada, ao longo de 12 meses. Teve como foco as mudanças nos EIDs, modos esquemáticos, estilos de enfrentamento desadaptativos, estilos parentais experimentados e bem-estar mental. A TE em grupo seguiu as mesmas fases de tratamento e objetivos da terapia individual. Na fase de avaliação, os EIDs, modos esquemáticos, estilos de enfrentamento desadaptativos e suas origens infantis são identificados, ao mesmo tempo que os pacientes são psicoeducados quanto ao modelo da TE. Os resultados evidenciaram uma melhora significativa no estresse psicológico geral dos participantes após o tratamento com TE em grupo, bem como a manutenção desses escores ao fim de seis meses. Além disso, pôde ser observada melhora substancial nos EIDs, modos esquemáticos, estilos de enfrentamento desadaptativos e estratégias evitativas.

Recentemente, um estudo de caso naturalístico testou a possibilidade de aplicação da TE em grupo em adolescentes com TP ou traços de TP (Roelofs et al., 2016). Os pacientes ($n = 4$) completaram questionários sobre qualidade de vida, sintomas de psicopatologia, modos esquemáticos, EIDs e estilos de enfrentamento esquemáticos. O programa de TE em grupo seguiu o protocolo descrito por Farrell e Shaw (2012), com a inclusão de um grupo de pais e/ou cuidadores. As sessões de grupo foram semanais, sendo complementadas por sessões individuais semanais ou quinzenais. Foi constatada melhora significativa tanto na qualidade de vida quanto nos sintomas psicopatológicos em alguns pacientes. No que se refere às mudanças na quantidade de modos e esquemas disfuncionais, estas foram positivas em todos os pacientes. Os dados, apesar de preliminares, oferecem suporte à aplicabilidade da TE em grupo nessa população.

De maneira geral, pode-se dizer que há um crescente corpo de evidências mostrando que a TE em grupo pode ser um tratamento promissor para pacientes com TP (Dickhaut & Arntz, 2014; Renner et al., 2013; Reiss et al., 2014; Roelofs et al., 2016; Schaap et al., 2016; van Vresswijk et al., 2014; Videler et al., 2014). Inclusive, um estudo recente apresenta dados incipientes de que essa abordagem também possa beneficiar jovens com TP (Roelofs et

al., 2016). Entre as vantagens do formato grupal, pode-se citar a facilitação do reconhecimento dos problemas de cada membro, permitindo validação, suporte e confrontação. Além do mais, os pacientes tendem a experimentar essas respostas vindas de outros membros do grupo como mais genuínas do que quando apresentadas pelo terapeuta. Em função disso, alguns autores propõem que a terapia de grupo possa catalisar o processo de mudança da TE, levando a transformações mais rápidas e profundas que o formato individual (Farrell & Shaw, 2012).

Contudo, alguns cuidados devem ser tomados na condução desse modelo terapêutico, como é o caso do foco nas necessidades individuais de cada participante, de forma balanceada entre todos os membros, da mesma forma que um pai faria com um grupo de irmãos. Além disso, algumas limitações são apontadas, incluindo uma menor flexibilidade nas alterações no horário, o que poderia aumentar o número de desistências ou de pacientes dispostos a participar. Ademais, é preciso levar em consideração que o modelo de grupo apresentado por Farrell e Shaw (1994) foi desenvolvido especificamente para indivíduos com TPB, o que requer estudos futuros considerando as adaptações necessárias para outros grupos de pacientes.

TERAPIA COMPORTAMENTAL DIALÉTICA E AS SUAS INTERVENÇÕES EM GRUPO

As intervenções desenvolvidas em formatos de grupo, dentro da terapia comportamental dialética (DBT), constituem-se em elementos fundamentais dentro desse tratamento. Isso se justifica pelo entendimento de que a desregulação emocional, assim como as demais condições clínicas para as quais a DBT tem base em evidências, ocorrem ou são mantidas por um déficit importante de repertório de habilidades (Linehan, 2015; Miller, Rathus, & Linehan, 2007). Ou seja, as intervenções em grupo na DBT têm o objetivo de desenvolver competências que estejam deficitárias nos pacientes, por meio do treinamento de habilidades específicas, para, assim, desenvolver todo um novo repertório de comportamentos que operem de forma mais

efetiva no ambiente, proporcionando cada vez mais interações baseadas em reforçamento positivo (Swales & Heard, 2009).

Contudo, cabe salientar que essas intervenções não precisam ser desenvolvidas obrigatoriamente em grupo. Em algumas situações, elas podem ser aplicadas de forma individual. Por exemplo, um treinamento de habilidades com um paciente com desregulação emocional pode ser realizado individualmente, quando este, por alguma razão, não consegue participar do grupo. No entanto, é notório que o desenvolvimento da intervenção em grupo acaba sendo benéfico para os pacientes pela ajuda mútua entre eles. Quando um indivíduo não está com “humor” para participar do grupo, os demais estarão. Durante a condução do grupo, o desenvolvimento das habilidades acaba criando uma contingência de reforçamento natural para a prática de comportamentos habilidosos pelos membros do grupo, proporcionando uma visão de que o paciente não está sozinho e não é o único que tem os problemas em questão (Linehan, 2015).

Existem diferentes modalidades de intervenções em grupo dentro da DBT, como, por exemplo: 1) o grupo de habilidades para pacientes adultos, 2) o grupo para familiares, 3) o grupo para comportamentos aditivos, 4) o grupo avançado de DBT, 5) o grupo compreensivo de *mindfulness*, 6) o grupo para pacientes internados e 7) o grupo de adolescentes. Todas essas diferentes organizações de grupo são baseadas no grupo de habilidades para os pacientes adultos, envolvendo ou a seleção de habilidades específicas e/ou o acréscimo de algumas habilidades ao grupo original ou, ainda, alterações na organização do formato do treinamento de habilidades (Linehan, 2015).

Neste capítulo, serão apresentados quatro desses modelos: 1) o grupo de habilidades para pacientes adultos, 2) o grupo de familiares, 3) o grupo para comportamentos aditivos e 4) o grupo de habilidades multifamiliar para adolescentes. A escolha desses quatro formatos deve-se a três aspectos específicos: 1) esses quatro modelos englobam todas as habilidades da DBT; 2) abarcam a maior parte das diferentes populações clínicas atendidas pela abordagem; e 3) atendem aos objetivos propostos para este capítulo.

O GRUPO DE HABILIDADES PARA PACIENTES ADULTOS

O grupo de habilidades para pacientes adultos da DBT pode se apresentar como um dos diferentes modos de tratamento do que se denomina DBT *standard* (que é composta por terapia individual, grupo de habilidades, *coaching* telefônico e consultoria dos terapeutas), assim como uma abordagem única de tratamento. Cabe salientar que esses dois formatos apresentam resultados importantes de efetividade em ensaios clínicos randomizados (Linehan, 2015). Ou seja, para o atendimento de pacientes com desregulação emocional, é preferível que seja feito apenas o grupo de habilidades do que a terapia individual sem a presença do treinamento de habilidades da DBT.

As pequenas diferenças que serão observadas entre a aplicação do grupo de habilidades sozinho ou como parte da DBT *standard* referem-se aos papéis desenvolvidos dentro do grupo. Sobre isso, antes de ver as diferenças entre como isso se dá, é fundamental entender os diferentes papéis desempenhados em um grupo de habilidades.

Assim, em geral existem dois terapeutas com funções bem específicas. O líder do grupo é quem coordena seu andamento e está preocupado com o cronograma e com a execução das tarefas. Ou seja, ele tem de estar atento holisticamente ao grupo e aos seus movimentos e não focar tanto nas necessidades individuais de cada participante. Muitas vezes, chega-se a colocar que esse seria o “cara mau” do grupo, pois ele teria de estar sempre primando pelo andamento da agenda. Já o colíder está mais preocupado com o andamento de cada participante; é ele quem irá conversar com cada membro e verificar suas dificuldades. Se algum paciente entrar em crise, é o colíder quem irá trabalhar com ele. Ou seja, o colíder faria a função do “cara bom” do grupo (Linehan, 2015; Rathus & Miller, 2015).

Dessa forma, as diferenças entre a DBT *standard* e o grupo de habilidades como tratamento único reside na figura do líder do tratamento. Na DBT *standard*, essa figura será desenvolvida pelo terapeuta individual, que será responsável pelas ligações telefônicas para manejar crises, pela generalização das habilidades e por determinar quantas vezes o paciente irá repetir o grupo de habilidades. No grupo de habilidades como tratamento único, o líder do

grupo é quem ficará responsável pela execução desses procedimentos (Linehan, 2015).

Além disso, cabe salientar que o grupo de habilidades para pacientes adultos pode ser executado tanto no formato de um grupo aberto quanto fechado. Contudo, observa-se que o formato aberto apresenta duas grandes vantagens: 1) a entrada de novos membros necessitando/querendo aprender novas habilidades acaba “forçando” o grupo a se manter na tarefa; e 2) novos participantes acabam revigorando o grupo e/ou permitem novas tensões dialéticas que acabam reconfigurando as normas do grupo (Linehan, 2015).

Com relação ao grupo de habilidades em si, este é composto por quatro grandes competências que serão trabalhadas com os pacientes: 1) *mindfulness*, 2) efetividade interpessoal, 3) regulação emocional e 4) tolerância ao mal-estar. O Quadro 14.3 lista todas as habilidades que compõem cada um dos quatro grupamentos de competências. Contudo, a ordem em que essas habilidades são oferecidas aos pacientes pode ser modificada de acordo com a necessidade dos provedores do tratamento. No entanto, se forem observados os estudos desenvolvidos após 2006 com pacientes com TPB, encontraremos a seguinte organização: 1) duas semanas de orientação e *mindfulness*; 2) seis semanas de tolerância ao mal-estar; 3) duas semanas de orientação e *mindfulness*; 4) sete semanas de regulação emocional; 5) duas semanas de orientação e *mindfulness*; e 6) cinco semanas de efetividade interpessoal (Harned et al., 2008; Linehan et al., 2006).

Quadro 14.3 Listas das habilidades da DBT por módulos

1 Habilidades de *mindfulness*

1.1 Habilidades centrais de *mindfulness*

1.1.1 “Mente sábia”

1.1.2 Habilidades de “o que fazer” (observar, descrever, praticar)

1.1.3 Habilidades de “como fazer”

1.2 Outras perspectivas em *mindfulness*

1.2.1 Práticas de *mindfulness*: uma perspectiva espiritual (incluindo “mente sábia” e praticando bondade amorosa)

1.2.2 Métodos habilidosos: equilibrando a “mente do ser” e a “mente do fazer”

1.2.3 “Mente sábia”: caminho do meio

2 Habilidades de efetividade interpessoal

2.1 Alcançando objetivos habilidosamente

2.1.1 Estabelecendo prioridades

2.1.2 Objetivos efetivos

- 2.1.2.1“*DEAR MAN*” (*Describe, Express, Assert, Reinforce, Stay Mindful, Appear Confident, e Negotiate* – Descrever, Expressar, Pedir Assertivamente, Reforçar, Estar *Mindful*, Aparentar estar confiante e Negociar)
- 2.1.3 Efetividade nos relacionamentos
 - 2.1.3.1“*GIVE*” (*Be Gentle, Act Interested, Validate, e Use an Easy Manner* – Seja Gentil, Demonstre Estar Interessado, Valide, Seja Leve)
- 2.1.4 Efetividade quanto ao autorrespeito
 - 2.1.4.1“*FAST*” (*Be Fair, No Apologies, Stick to Values, Be Truthful* – Seja Justo, Não se Desculpe, Esteja Atento aos Seus Valores, Seja Verdadeiro)
- 2.1.5 Calculando a intensidade de pedir algo ou de dizer não para algum pedido
- 2.2 Habilidades suplementares de efetividade interpessoal
 - 2.2.1 Construindo relacionamentos e acabando com relacionamentos destrutivos
 - 2.2.1.1Habilidades para encontrar novos amigos em potencial
 - 2.2.1.2*Mindfulness* dos outros
 - 2.2.1.3Como acabar com relacionamentos
 - 2.2.2 Habilidades de caminho do meio
- 2.3 Dialéticas
- 2.4 Validação
- 2.5 Estratégias de modificação comportamental

3 Habilidades de regulação emocional

- 3.1 Entendendo e nomeando as emoções
- 3.2 Modificando as respostas emocionais
 - 3.2.1 Verificando os fatos
 - 3.2.2 Ação oposta
 - 3.2.3 Solução de problemas
- 3.3 Reduzindo vulnerabilidade à mente emocional
 - 3.3.1 “*ABC PLEASE*”
- 3.4 Manejando emoções realmente difíceis
 - 3.4.1 *Mindfulness* das emoções atuais
 - 3.4.2 Manejando emoções extremas

4 Habilidades de tolerância ao mal-estar

- 4.1 Habilidades de sobrevivência a crises
 - 4.1.2 Prós e contras
 - 4.1.3 “*TIP*” modificando a fisiologia corporal
 - 4.1.4 Distração com “mente sábia” “*ACCEPTS*”
 - 4.1.5 Acalmando-se com os sentidos
 - 4.1.6 Melhorando o momento
- 4.2 Habilidades de aceitação radical
 - 4.2.1 Aceitação radical
 - 4.2.2 Transformando a mente
 - 4.2.3 Boa vontade
 - 4.2.4 Meio sorriso
 - 4.2.5 Mãos dispostas
 - 4.2.6 *Mindfulness* dos pensamentos atuais
- 4.3 Habilidades suplementares de tolerância ao mal-estar para comportamentos aditivos
 - 4.3.1 Dialética da abstinência
 - 4.3.2 “Mente limpa”
 - 4.3.3 Reforçamento comunitário
 - 4.3.4 Destruindo pontes e construindo novas
 - 4.3.5 Rebelião alternativa e negação adaptativa

Fonte: Sayago e Dornelles (2015, p. 482-483).

Ainda sobre as quatro competências básicas desenvolvidas no grupo de habilidades para adultos, cabe salientar que elas também estão organizadas

dentro do paradoxo central de todas as intervenções da DBT, que é *aceitação* vs. *mudança*. Assim, podemos identificar que as competências de *mindfulness* e de tolerância ao mal-estar configuram o eixo de *aceitação*, enquanto regulação emocional e efetividade interpessoal representam o polo da *mudança* no grupo de habilidades da DBT (Linehan, 2010a).

Além disso, é fundamental esclarecer que o grupo de habilidades não se configura como um grupo terapêutico, e sim como aulas de habilidades com agenda de tópicos e tarefas preestabelecidas para cada sessão. A duração das sessões varia entre 2 e 2,5 horas (Linehan, 2010a, 2010b).

O GRUPO DE FAMILIARES DA DBT

O grupo de familiares da DBT consiste em uma abordagem de 12 encontros que busca oferecer psicoeducação e treinamento de algumas habilidades específicas. O objetivo desse grupo é o de auxiliar os familiares de pacientes com desregulação emocional a compreender melhor seus entes queridos, assim como capacitá-los para lidar da forma mais efetiva possível com eles, promovendo, assim, um ambiente familiar o mais harmônico e validante possível (Regalado, Pechon, Stoewsand, & Gagliesi, 2011).

Os conteúdos que são abordados dentro desse grupo visam cobrir pontos importantes do tratamento da desregulação emocional e oferecer um grupamento de ferramentas que sejam, ao mesmo tempo, simples para os familiares utilizarem e efetivas ao lidar com o caos das relações intrafamiliares. Assim, os conteúdos abordados são os seguintes: 1) psicoeducação da desregulação emocional e como os familiares normalmente se sentem ao lidar com essa demanda; 2) *mindfulness*; 3) respostas emocionais; 4) validação; 5) compreendendo comportamentos (análise funcional do comportamento); 6) efetividade interpessoal; 7) limites pessoais; 8) enfrentando comportamentos de risco; e 9) aceitação radical. Os encontros ocorrem semanalmente sempre com 2 ou 2,5 horas de duração (Regalado et al., 2011).

Outra forma de desenvolver um grupo de familiares de DBT seria montando uma intervenção exatamente no mesmo formato do grupo de habilidades para pacientes adultos acrescentando, tão somente, algumas

habilidades específicas para os familiares ou, ainda, inserindo essas habilidades específicas para os parentes dentro de qualquer uma das modalidades de grupos previstas pela DBT, dependendo das necessidades dos pacientes e de seus familiares que estão sendo abordadas (Linehan, 2015). Essas habilidades específicas são as seguintes: 1) Dentro da estratégia DEARMAN: 1.1) estratégias para aumentar a probabilidade de comportamentos desejados; 1.2) estratégias para reduzir ou parar comportamentos indesejados; 1.3) dicas para usar estratégias de modificação comportamental efetivamente; 1.4) identificando estratégias de modificação comportamental efetivas. 2) Ao utilizar a estratégia GIVE: 2.1) validação; 2.2) uma forma de orientar a validação; 2.3) identificando a validação. 3) Quando for utilizada a estratégia FAST: 3.1) se recuperando da invalidação; e 3.2) identificando a autoinvalidação (Linehan, 2015).

O GRUPO PARA PACIENTES COM COMPORTAMENTOS ADITIVOS

O grupo para pacientes com comportamentos aditivos da DBT segue a mesma estrutura de qualquer um dos grupos de habilidades desenvolvidos por essa terapia, acrescentando habilidades específicas para lidar com os referidos comportamentos. Essas habilidades são as seguintes: 1) Dentro do módulo de orientações gerais: 1.1) visão geral de quando a crise é uma adição; e 1.2) listas das adições mais comuns. 2) Nas habilidades de *mindfulness*: 2.1) mente limpa; e 2.2) características dos padrões comportamentais da mente aditiva e da mente limpa. 3) Dentro das habilidades de tolerância ao mal-estar: 3.1) abstinência dialética; 3.2) planejamento de prevenção à recaída; 3.3) destruindo pontes e construindo novas; e 3.4) rebelião alternativa e negação adaptativa. 4) Nas habilidades de efetividade interpessoal: 4.1) reforçamento comunitário (Linehan et al., 1999, 2002).

Um aspecto importante é que a população para a qual o tratamento para comportamentos aditivos foi desenvolvido originalmente era de pacientes com TPB e transtornos relacionados ao uso de substâncias. Isso denota um ponto muito interessante dessa intervenção – o fato de ela ser efetiva para

uma comorbidade realmente muito frequente, não se tratando de um tratamento específico para apenas uma das morbidades (McMain, Sayrs, Dimeff, & Linehan, 2007)

O GRUPO DE HABILIDADES PARA ADOLESCENTES

Esse grupo de habilidades foi originalmente desenvolvido para o tratamento de adolescentes com intensa desregulação emocional e alto risco de suicídio, assim como de seus familiares. O formato dessa intervenção segue exatamente as mesmas competências desenvolvidas dentro do grupo de habilidades para adultos, somando uma competência adicional denominada “trilhando o caminho do meio”, que reúne as seguintes habilidades: 1) dialéticas; 2) dilemas dialéticos da adolescência; 3) validação; 4) modificação comportamental (Rathus & Miller, 2015; Miller et al., 2007).

Outra semelhança que o grupo de habilidades para adolescentes (ou “grupo de habilidades multifamiliar”) mantém com o grupo de habilidades para adultos é o cronograma do treinamento, assim como a preferência pelo formato aberto. As únicas questões nas quais serão observadas diferenças nesses casos serão: 1) o tempo de intervenção, que, no formato de adolescentes, passa a ter 16 semanas (diferentemente do grupo com adultos, de 24 ou 48 semanas); e 2) a inclusão da competência “trilhando o caminho do meio”. Assim, o cronograma de execução dessa intervenção observa a seguinte ordem: 1) orientação e *mindfulness* (1 semana); 2) tolerância ao mal-estar (3 semanas); 3) orientação e *mindfulness* (1 semana); 4) efetividade interpessoal (3 semanas); 5) *mindfulness* (1 semana); 6) regulação emocional (3 semanas); 7) *mindfulness* (1 semana); e 8) trilhando o caminho do meio (3 semanas) (Rathus & Miller, 2015; Miller et al., 2007).

As principais diferenças que podem ser observadas nessa sistemática de grupo em relação ao grupo de habilidades para adultos é a presença de dois cuidadores por adolescentes. Sugere-se que o tamanho do grupo envolva, no máximo, 5 adolescentes e 10 cuidadores (dois de cada adolescente), finalizando um número total de 15. Caso não seja possível a presença dos dois cuidadores do jovem, convida-se justamente aquele cuidador com o qual o paciente tem mais conflitos. A ideia presente aqui envolve o fato de que o

aprendizado das habilidades concomitantemente entre o adolescente e seu cuidador qualificará os processos desse relacionamento, bem como de que a prática dessa intervenção em conjunto proporcionará uma excelente oportunidade para que ambos possam desfrutar de um maior tempo de atenção terapêutica em conjunto (Miller et al., 2007; Rathus & Miller, 2015).

Cabe salientar, contudo, que o grupo de adolescentes é comumente utilizado no formato de DBT *standard* para pacientes adolescentes. Esse modelo de tratamento apresenta diferentes modos que têm ação sinérgica para dar conta das cinco funções básicas do tratamento em DBT: 1) aumentar a motivação; 2) desenvolver habilidades; 3) generalizar habilidades; 4) promover modificação ambiental; e 5) manter os provedores do tratamento motivados e efetivos (Linehan, 2010a; Rathus et al., 2007). Dessa forma, sendo os adolescentes uma população com necessidades específicas de sua fase do desenvolvimento, foram desenvolvidos os modos de tratamentos adaptados para cumprir as cinco funções básicas com esses pacientes. Assim, os modos se organizam da seguinte maneira: 1) terapia individual; 2) grupo de adolescentes ou grupo multifamiliar de adolescentes; 3) *coaching* telefônico; 4) *coaching* telefônico para familiares; 5) terapia familiar DBT; 6) consultoria de casos (Miller et al., 2007; Rathus & Miller, 2015).

Observando todo o escopo de intervenções em grupo da DBT, é notório concluir que essa abordagem detém um amplo arsenal de intervenções em grupos, que teve origem nos trabalhos iniciais com pacientes com TPB cronicamente suicidas e com condutas autolesivas sem intencionalidade suicida. Hoje, essas intervenções podem ser aplicadas, com base em evidências, em diversas condições clínicas, como TPB, bulimia nervosa, transtorno de compulsão alimentar periódica, transtorno depressivo maior, transtorno do humor bipolar, transtorno do déficit de atenção/hiperatividade, transtorno relacionado ao uso de substâncias (álcool), violência conjugal, entre outras. Ou seja, trata-se de um modelo terapêutico que vem, cada vez mais, desenvolvendo abordagens de tratamento efetivas em grupo para um número cada vez mais expressivo de condições clínicas, possibilitando, assim, que uma gama cada vez maior de pacientes possa receber tratamentos baseados em evidências (Linehan, 2015).

VANTAGENS, DESAFIOS E ESPECIFICIDADES DA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO PARA OS TRANSTORNOS DA PERSONALIDADE

A terapia de grupo apresenta muitas vantagens no tratamento de pacientes com alguns TP's. O ambiente grupal se configura como uma excelente oportunidade de destacar as dificuldades de relacionamento, frequentemente encontradas em indivíduos com TPB e transtorno da personalidade esquiva (TPE), por exemplo. Ao mesmo tempo, o contexto grupal fornece um meio ideal para resolver ou atenuar essas deficiências, além de ajudar a diluir a relação transferencial, promovendo a identificação com outros pacientes (Horwitz 1977a, 1977b; Munroe-Blum, 1992). Essa vantagem da terapia de grupo é apontada por Gabbard (2006) como benéfica não só para o paciente, mas também para o terapeuta.

Considerando as dificuldades de comunicação no tratamento individual devido ao sofrimento em tolerar a proximidade, o grupo pode ser útil para estimular a participação, permitindo que o paciente possa participar no seu próprio ritmo. Apesar da possibilidade de o grupo gerar frustrações em alguns momentos, ele também pode fornecer uma variedade de gratificações atrativas e prazerosas, como sentimento de aceitação e oportunidade de ajudar os demais, reforçando, assim, a autoestima.

A modalidade de grupo é particularmente útil por proporcionar validação, reduzindo o isolamento e aumentando o apoio social, contribuindo de forma importante no tratamento dos pacientes com TPB (Linehan, 1993; Gunderson, 2001). Ademais, os membros do grupo podem oferecer a esses pacientes uma visão expandida do que é possível nas relações humanas (Roller & Nelson, 1999).

Monroe-Blum e Marziali (1995) descobriram resultados equivalentes entre a psicoterapia de grupo e a individual, concluindo que, por razões de custo-eficácia, a terapia de grupo é o tratamento de escolha. O tratamento realizado em formato de grupo e de tempo limitado pode ser particularmente promissor a esse respeito, pois, além de ser menos oneroso que a terapia individual,

apresenta potencial para alcançar um número maior de indivíduos (Blum, Pfohl, John, Monahan, & Black, 2002; Gunderson, 2001). Entretanto, a literatura sugere que os pacientes tendem a se beneficiar mais quando são inseridos em grupos cujos integrantes com TPB apresentam melhor funcionamento (Horwitz, 1977a, 1977b), e em outros TP após desenvolverem habilidades básicas interpessoais na terapia individual.

Apesar das inúmeras vantagens descritas até o momento, a psicoterapia de grupo para pacientes com TP pode ser bastante desafiadora, uma vez que se trata de transtornos cujos prejuízos envolvem o funcionamento de múltiplos domínios (Matusiewicz et al., 2010). Embora os TPs tenham características comuns entre si, como padrões inflexíveis e duradouros de cognição e problemas interpessoais, eles também apresentam algumas especificidades, que podem influenciar o trabalho em grupo.

Formar e conduzir um grupo de pacientes com TP paranoide (TPP) pode ser difícil devido à desconfiança e à suspeita deles em relação à intenção dos outros como humilhante ou ameaçadora, características desse transtorno (Beck, Freeman, & Davis, 2005). Do mesmo modo, pacientes com tal diagnóstico costumam se mostrar resistentes a regras e estrutura, necessárias ao trabalho em grupo, porque as interpretam como restrições a sua liberdade (Freeman & Stewart, 2006). No transtorno da personalidade esquizoide, ocorre o mesmo quanto à dificuldade de formar grupo com indivíduos do mesmo diagnóstico, até porque dificilmente buscam tratamento. Trata-se de um transtorno que resulta da ausência de crenças positivas quanto à proximidade das pessoas, além de crenças positivas sobre estar só.

Dificuldades ainda maiores são encontradas no tratamento do TP esquizotípica, uma vez que a capacidade desses pacientes de se relacionar adequadamente é prejudicada pelo grave desconforto social, crenças estranhas e pensamento mágico, típicos desse diagnóstico. A participação desses pacientes em grupos com múltiplos diagnósticos não é indicada devido às altas chances de serem rejeitados, ridicularizados e incompreendidos, aumentando seu sofrimento (Freeman & Stewart, 2006).

O tratamento em grupo, assim como os demais, demanda motivação, e, quando falamos de pacientes com TP antissocial, isso tende a ser difícil, uma

vez que indivíduos com esse perfil tendem a se motivar apenas em seu próprio interesse, e a falta de motivação para o tratamento pode se tornar um obstáculo à inclusão do trabalho em grupo. Assim como os pacientes com TPP, indivíduos antissociais tendem a desconfiar dos outros e evitar revelar vulnerabilidades, pois presumem que serão maltratados. Tais pressupostos limitam a formação vínculo e o estabelecimento de metas terapêuticas.

A TCC em grupo (TCCG) para o TPB pode impor alguns desafios no que se refere a instabilidade emocional, controle de impulsos e dificuldade em estabelecer aliança colaborativa em decorrência dos problemas com medo do abandono. Contudo, esses pacientes desejam se relacionar, por isso tendem a se beneficiar do grupo, diferentemente daqueles com TP esquizoide, que não têm motivação (Beck et al., 2005).

Por sua vez, os pacientes com TP histriônica acreditam que dependem do outro para ter cuidado, bem como para ser amado por todos e por tudo o que fazem. São propensos ao exagero e a reações emocionais e comportamentais intensas. Muitas vezes, deixam de buscar tratamento para o transtorno, mas o fazem para outros sintomas de depressão, intensa insatisfação ou ansiedade. O estilo interpessoal desses pacientes constitui uma barreira a sua inclusão, pois são provavelmente incapazes de atender às necessidades dos outros. Entretanto, havendo motivação, a TCCG pode ser útil para proporcionar *feedbacks* sobre o estilo de comunicação e para encenar novas habilidades (Freeman & Stewart, 2006).

Outro transtorno bastante desafiador para a modalidade grupal é o TP narcisista. Por serem pacientes autofocados, com visões grandiosas de si, acabam buscando tratamento em virtude de sintomas de depressão e ansiedade. É difícil incluir esses indivíduos no grupo porque eles não têm empatia pelos demais e não gostam de revelar suas falhas e defeitos, fatores essenciais para a construção de vínculo terapêutico. Mesmo assim, quando atingem progresso na terapia individual, podem se beneficiar da TCCG, em virtude da oportunidade de construir habilidades, desenvolver reações empáticas e atingir reconhecimento dos outros por ajudá-los (Freeman & Stewart, 2006).

A TCCG para o TP evitativa envolve exposição gradual, em que os pacientes são encorajados a se aproximar de situações temidas ou evitadas. Utiliza-se a reestruturação cognitiva, que, nesse tratamento, é usada principalmente para facilitar a disponibilidade de participar de exercícios de exposição. Além disso, algumas abordagens da TCCG incluem um componente de treinamento de habilidades interpessoais, com base no pressuposto de que os indivíduos com TPE não têm as habilidades sociais necessárias para interagir de forma adequada (Matusiewicz et al., 2010).

Pacientes com TP dependente podem se beneficiar da TCCG desde que tenham adquirido habilidades básicas em terapia individual. Essa modalidade pode ser bastante útil para reduzir a dependência do terapeuta e estimular a confiança nos colegas, e não em uma pessoa apenas, como geralmente ocorre com esses pacientes. Além disso, o convívio com os demais pode proporcionar modelos para o desenvolvimento de habilidades de independência.

O principal desafio da TCCG para pacientes com TP obsessivo-compulsiva é a falta de motivação e de tolerância a diferentes formas dos outros de pensar e resolver os problemas. Além disso, o intenso desejo de evitar erros pode frequentemente levar esses indivíduos a desistir do tratamento e de completar tarefas, devido aos altos padrões de sucesso e perfeição.

Por fim, o atendimento em grupos em geral é desafiador para os terapeutas, principalmente os iniciantes. No entanto, considerando a literatura explorada, a terapia em grupos pode ser considerada na intervenção de TPs em geral. Os dados da literatura indicam que as diferentes abordagens grupais têm demonstrado ganhos no tratamento de pacientes com TPB e TPE. Em sua maioria, os dados apontam a modalidade grupal como um importante tratamento complementar aos tratamentos individuais. Nesse sentido, este capítulo encerra-se com o convite ao treinamento de terapeutas para intervenções em modalidade de grupos, de forma a atender a demandas específicas que têm obtido melhora significativa em intervenções grupais comparadas a intervenções individuais.

REFERÊNCIAS

- Arntz, A., & Jacob, G. (2013). *Schema therapy in practice: An introductory guide to the schema mode approach*. London: Wiley-Blackwell.
- Arntz, A., & van Genderen, H. (2009). *Schema therapy for borderline personality disorder*. Chichester: Wiley.
- Azima, F. J. C. (1996). Psicoterapia de grupo com transtornos de personalidade. In H. I. Kaplan, & B. J. Sadock (Orgs.), *Compêndio de psicoterapia de grupo* (3. ed.). Porto Alegre: Artes Médicas.
- Bamelis, L. L. M., Evers, S. M. A. A., Spinhoven, P., & Arntz, A. (2014). Results of a multicenter randomized controlled trial of the clinical effectiveness of schema therapy for personality disorders. *American Journal of Psychiatry*, 171(3), 305-322.
- Bechelli, L. P. C., & Santos M. A. (2004). Psicoterapia de grupo: Como surgiu e evoluiu. *Revista Latino-Americana de Enfermagem*, 12(2), 242-249.
- Beck, A. T., Freeman, A., & Davis, D. (2005). *Terapia cognitiva dos transtornos da personalidade* (2. ed.). Porto Alegre: Artmed.
- Bieling, P. J., McCabe, E. R., Antony, M. (2006). *Cognitive-behavioral therapy in groups*. New York: Guilford Press.
- Blum, N., Pfohl, B., John, D. S., Monahan, P., & Black, D. W. (2002). STEPPS: A cognitive-behavioral systems-based group treatment for outpatients with borderline personality disorder: A preliminary report. *Comprehensive Psychiatry*, 43(4), 301-310.
- Broersen, J., & van Vreeswijk, M. (2012). Schema therapy in groups: A short-term schema CBT protocol. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (Eds.), *The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research and practice* (pp. 373-381). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Budman, S. H., Demby, A., Soldz, S., & Merry, J. (1996). Time-limited group psychotherapy for patients with personality disorders: Outcomes and dropouts. *International Journal of Group Psychotherapy*, 46(3), 357-377.
- Dickhaut, V., & Arntz, A. (2014). Combined group and individual schema therapy for borderline personality disorder: A pilot study. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 45(2), 242-251.
- Edwards, D., & Arntz, A. (2012). Schema therapy in historical perspective. In: M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nardot (Eds.), *The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research, and practice*. London: Wiley-Blackwell.
- Farrell, J. M., & Shaw, I. A. (2012). *Group schema therapy for borderline personality disorder: A step-by-step treatment manual with patient workbook*. New York: Wiley-Blackwell.
- Farrell, J. M., Shaw, I. A., & Reiss, N. (2012). Group schema therapy for borderline personality disorder patients: Catalyzing schema and mode change. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (Eds.), *The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research and practice* (pp. 341-358). Chichester: Wiley-Blackwell.
- Farrell, J. M., Shaw, I. A., & Webber, M. A. (2009). A schema focused approach to group psychotherapy for outpatients with borderline personality disorder: A randomized controlled trial.

Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry, 40(2), 317-328.

Farrell, J. M., & Shaw, I. (1994). Emotional awareness training: A prerequisite to effective cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. *Cognitive and Behavioral Practice*, 1(1), 71-91.

Freeman, A., & Stewart, J. L. (2006). Personality disorders. In P. J. Bieling, E. R. McCabe, & M. Antony M, *Cognitive-behavioral therapy in groups*. New York: Guilford Press.

Gabbard, G. (2006). *Psiquiatria psicodinâmica na prática clínica* (4. ed.). Porto Alegre: Artmed.

Giesen-Bloo, J., van Dick, R., Spinhoven, P., van Tilburg, W., Dirksen, C., van Asselt, T., ... Arntz, A. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: randomized trial of schema-focused therapy vs transference-focused psychotherapy. *Archives of general psychiatry*, 63(6), 649-658.

Gunderson, J. G. (2001). *Borderline personality disorder: A Clinical Guide*. Washington: American Psychiatric Publishing.

Harned, M. S., Chapman, A. L., Dexter-Mazza, E. T., Murray, A., Comtois, K. A., & Linehan, M. M. (2008). Treating cooccurring Axis I disorders in chronically suicidal women with borderline personality disorder: A 2-year randomized trial of dialectical behavior therapy *versus* community treatment by experts. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 76(6), 1068-1075.

Horwitz, L. (1977b). Group psychotherapy of the borderline patient. In P. Hartocollis (Ed.), *Borderline personality disorders: The concept, the syndrome, the patient* (pp. 399-422). New York: International Universities Press.

Horwitz, L. (1977a). A group-centered approach to group psychotherapy. *International Journal of Group Psychotherapy*, 27(4), 42-43.

Kibel, H. D. (1981). A conceptual model for short-term inpatient group psychotherapy. *The American Journal of Psychiatry*, 138(1) 74-80.

Linehan, M. L. (1993). *Skills training manual for treating borderline personality disorder*. New York: Guilford Press.

Linehan, M. M. (2010). *Terapia cognitivo-comportamental para o transtorno da personalidade Borderline*. Porto Alegre: Artmed.

Linehan, M. M. (2010). *Vencendo o transtorno da personalidade Borderline com a terapia cognitivo-comportamental*. Porto Alegre: Artmed.

Linehan, M. M. (2015). *DBT® skills training manual*. New York: Guilford Press.

Linehan, M. M., Comtois, K. A., Murray, A. M., Brown, N. Z., Gallop, R. J., Heard, H. L., ... Lindenboim, N. (2006). Two-year randomized trial + follo-up of dialectical behavior therapy vs. therapy by experts for suicidal behavior and borderline personality disorder. *Archives of General Psychiatry*, 63(7), 757-766.

Linehan, M. M., Dimeff, L. A., Reynolds, S. K., Comtois, K. A., Shaw-Welch, S., Heagerty, P., & Kivlahan, D. R. (2002). Dialectical behavior therapy *versus* comprehensive validation plus 12-step for the treatment of opioid dependente women meeting criteria for borderline personality disorder. *Drug and Alcohol Dependence*, 67(1), 13-26.

Linehan, M. M., Schmidt, H., Dimeff, L. A., Craft, J. C., Kanter, J., & Comtois, K. A. (1999). Dialectical behavior therapy for patients with borderline personality disorder and drug-dependence.

American Journal on Addictions, 8(4), 279-292.

MacKenzie, K. R. (2001). Group psychotherapy. In W. J. Livesley, *Handbook of personality disorders*. New York: Guilford Press.

Matusiewicz, A. K., Hopwood, C. J., Banducci, A. N., & Lejuez, C. V. (2010). The effectiveness of cognitive behavioral therapy for personality disorders. *Psychiatric Clinics of North America*, 33(3), 657-685.

McMain, S., Sayrs, J. H. R., Dimeff, L. A., & Linehan, M. M. (2007). Dialectical behavior therapy for individuals with borderline personality disorder and substance dependence. In L. A. Dimeff, & K. Koerner (Eds.), *Dialectical behavior therapy in clinical practice: Applications across disorders and settings*. New York: Guilford Press.

Miller, C. R., Eisner, W., & Allport, C. (1994). Creative coping: A cognitive-behavioral group for borderline personality disorder. *Archives of Psychiatric Nursing*, 8(4), 280-285.

Miller, A. L., Rathus, J. H., & Linehan, M. M. (2007). *Dialectical behavior therapy with suicidal adolescents*. New York: Guilford Press.

Monroe-Blum, H., & Marziali, E. (1995). A controlled trial of short-term group treatment of borderline personality disorder. *Journal of Personality Disorders*, 9(3), 190-198.

Munroe-Blum, H. (1992). Group treatment of borderline personality disorder. In J. F. Clarkin, E. Marziali, & H. Munroe-Blum, *Borderline personality disorder: Clinical and empirical perspectives* (pp. 288-299). New York: Guilford Press.

Nadort, M., Arntz, A., Smit, J. H., Giesen-Bloo, J., Eikelenboom, M., Spinhoven, P., ... van Dyck, R. (2009). Implementation of outpatient schema therapy for borderline personality disorder with versus without crisis support by the therapist outside office hours: A randomized trial. *Behaviour Research and Therapy*, 47(11), 961-973.

Nehls, N. (1991). Borderline personality disorder and group therapy. *Archives of Psychiatric Nursing*, 5(3), 137-146.

Nordahl, H. M., & Nysaeter, T. E. (2005). Schema Therapy for patients with borderline personality disorder: A single case series. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 36(3), 254-264.

Piper, W. E., & Rosie, J. S. (1999). Group treatment of personality disorders: The power of the g in the intensive treatment of personality disorders. *Psychotherapy in Practice*, 4(4), 19-34.

Rathus, J. K., & Miller, A. L. (2015). *DBT skills manual for adolescents*. New York: The Guilford Press.

Regalado, P., Pechon, C., Stoewsand, C., & Gagliesi, P. (2011). Familiares de personas con trastorno límite de la personalidad: estudio pre-experimental de una intervención grupal. *Revista Argentina de Psiquiatría*, 22, 245-252.

Reiss, N., Lieb, K., Arntz, A., Shaw, I., & Farrell, J. (2014). Responding to the treatment challenge of patients with severe BPD: Results of three pilot studies of inpatient schema therapy. *Behavioral and Cognitive Psychotherapy*, 42(3), 355-367.

Renneberg, B., Goldstein, A. J., Phillips, D., & Chambless, D. L. (1990). Intensive behavioral group treatment of avoidant personality disorder. *Behavior Therapy*, 21(3), 363-377.

- Renner, F., van Goor, M., Huibers, M., Arntz, A., Butz, B., & Bernstein, D. (2013). Short-term group schema cognitive-behavioral therapy for young adults with personality disorder features: Associations with change in symptomatic distress, schemas, schema modes and coping styles. *Behaviour Research and Therapy*, 51(8), 487-492.
- Roelofs, J., Muris, P., van Wesemael, D., Broers, N. J., Shaw, I., & Farrell, J. (2016). Group-schematherapy for adolescents: Results from a naturalistic multiple case study. *Journal Child Family Studies*, 25(7), 2246-2257.
- Roller, B., & Nelson, V. (1999). Group psychotherapy treatment of borderline personalities. *International Journal of Group Psychotherapy*, 49(3), 369-385.
- Sayago, C. W., & Dornelles, V. G. (2015). Terapia comportamental dialética: Estrutura e estratégias de tratamento. In P. Lucena-Santo, J. Pinto-Gouveia, & M. S. Oliveira (Orgs.), *Terapias comportamentais de terceira geração: Guia para profissionais*. Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Schaap, G. M., Chakhssi, F., & Westerhof, G. J. (2016). Inpatient schema therapy for nonresponsive patients with personality pathology: Changes in symptomatic distress, schemas, schemas modes, coping styles, experienced parenting styles, and mental well-being. *Psychotherapy*, 53(4), 402-412.
- Springer, T., Lohr, N. E., Buchtel, H. Á., & Silk, K. R. (1996). A preliminary report of short-term cognitive-behavioral group therapy for inpatients with personality disorders. *Journal of Psychotherapy Practice and Research*, 5(1), 57-71.
- Swales, M. A., & Heard, H. L. (2009). *Dialectical behavior therapy*. New York: Routledge.
- Van Vreeswijk, M. F., Spinhoven, P., Eurelings-Bontekoe, E. H. M., & Broersen, J. (2014). Changes in symptom severity, schemas and modes in heterogeneous psychiatric patient groups following short-term schema cognitive-behavioral group therapy: A naturalistic pretreatment and post-treatment design in an outpatient clinic. *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 21(1), 29-38.
- Videler, A. C., Rossi, G., Schoevaars, M., van der Feltz-Cornellis, C. M., & van Alphen, S. P. J. (2014). Effects of schema group therapy in older outpatients: A proof of concept study. *International Psychogeriatrics*, 26(10), 1709-1717.
- Yalom, I. D. (2006). *Psicoterapia de grupo: Teoria e prática*. Porto Alegre: Artmed.
- Young, J. E. (1999). *Cognitive therapy for personality disorders: A schema-focused approach*. Sarasota: Professional Resource Exchange.
- Young, J. E., Klosko, J. S., & Weishaar, M. E. (2003). *Schema therapy: A practitioner's guide*. New York: Guilford Press.

LEITURAS RECOMENDADAS

- Budman, S. H., Cooley, S., Demby, A., Koppenaal, G., Koslof, J., & Powers, T. (1996). A model of Time-effective group psychotherapy for patients with personality disorders: The clinical model. *International Journal of Group Psychotherapy*, 46(3) 329-355.
- Farrell, J. M. (2012). Introduction to group schema therapy. In M. van Vreeswijk, J. Broersen, & M. Nadort (Eds.), *The Wiley-Blackwell handbook of schema therapy: Theory, research and practice* (pp. 337-339). Chichester: Wiley-Blackwell.

Gunderson, J. G., & Links, P. S. (2008). *Borderline personality disorder: A clinical guide* (2nd ed.). Washington: American Psychiatric Publishing.

PARTE III

GRUPOS ESPECIAIS EM TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL EM GRUPO



15



TRATAMENTOS EM GRUPO BASEADOS EM *MINDFULNESS*

Isabel Weiss
Ana Regina Noto

Mindfulness se moveu de um antigo e obscuro conceito budista para uma forte tendência em psicoterapia nas últimas décadas (Davis & Hayes, 2011). Compreendida como uma habilidade metacognitiva que consiste em manter a atenção plena e aberta ao momento presente, pode ser desenvolvida por meio de práticas de meditação e busca ampliar o nível de consciência das percepções de sentidos, pensamentos e sentimentos. Ao fixar intencionalmente a atenção nas experiências internas e externas do momento presente, com abertura e curiosidade, a pessoa assume uma posição de observador consciente de suas próprias experiências e percepções (Baer, 2003).

Com um volume considerável de evidências científicas na promoção de saúde e bem-estar, a aplicação de *mindfulness* na prevenção e no tratamento de várias condições físicas e mentais é crescente. O primeiro protocolo terapêutico baseado em *mindfulness* foi desenvolvido na década de 1980, por J. Kabat-Zinn, em um contexto hospitalar nos Estados Unidos. A iniciativa nasceu da integração entre a filosofia e a prática budista com as práticas psicológica e médica ocidentais. Denominado *Mindfulness-Based Stress Reduction* (MBSR – Redução de Estresse Baseada em *Mindfulness*), o primeiro protocolo foi elaborado para ser aplicado em grupo, com o objetivo de reduzir o estresse entre pacientes com dor crônica. Embora não tenha sido observada a redução da dor, os pacientes foram beneficiados de muitas outras formas, como a diminuição do estresse e a melhora da qualidade de vida (Kabat-Zinn, 2004).

Com a ampliação do interesse científico e clínico sobre as práticas de *mindfulness*, novos protocolos foram sendo criados e adaptados para outras condições de saúde, porém todos mantendo a estrutura de intervenção em grupo. Alguns deles incluíram elementos das abordagens cognitivas, como o *Mindfulness-Based Cognitive Therapy* (MBCT – Terapia Cognitiva Baseada em *Mindfulness*) e o *Mindfulness-Based Relapse Prevention* (MBRP – Prevenção de Recaída Baseada em *Mindfulness*).

A atitude de abertura e aceitação é uma das principais diferenças de *mindfulness* em comparação à terapia cognitiva tradicional. Enquanto as técnicas cognitivas tradicionais visam identificar e reestruturar os pensamentos considerados disfuncionais, as práticas de *mindfulness* visam à aceitação, à gentileza e ao não julgamento das percepções. Assim, o objetivo não é a reestruturação cognitiva, mas a aceitação das percepções e a ampliação das formas de relacionamento da pessoa com suas sensações, pensamentos e sentimentos (Bowen, Chawla, & Marlatt, 2015).

Meditação *mindfulness* (MM) e intervenções baseadas em *mindfulness* (MBIs) têm sido empregadas no tratamento de uma vasta gama de transtornos mentais e problemas físicos, muitas vezes dentro de protocolos clínicos, como os já citados anteriormente, assim como a Terapia de Aceitação e Compromisso e a Terapia Comportamental Dialética, que não serão

abordadas aqui. No entanto, vale ressaltar que a MM, como a Vipassana e a meditação Zen, é mais voltada para a compreensão da verdadeira natureza do *self* e do mundo, a fim de se alcançar a liberdade do sofrimento, entendido como uma incorreta compreensão da realidade, enquanto as MBIs são orientadas para a clínica, tendo como principal objetivo promover o alívio de sintomas físicos ou psicológicos, como dores crônicas e depressão, por exemplo (Chiesa & Malinowski, 2011).

As MBIs que serão descritas neste capítulo têm em comum suas bases na terapia cognitivo-comportamental (TCC) e a busca pela liberdade de padrões habituais de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Seus facilitadores precisam ser experientes em TCC, assim como na condução de grupos, e ter prática clínica no tratamento do transtorno em questão – MBSR (estresse), MBRP (comportamentos aditivos), MBCT (depressão), entre outros.

O principal paradigma dos programas baseados em *mindfulness* se situa em um processo de investigação da experiência direta presente (sensação ou emoção, mais frequentemente), diferenciando-a dos desdobramentos (histórias e julgamentos) e reações (que podem ser físicas, cognitivas ou emocionais), lançando as bases da consciência e da não reatividade (saída do piloto automático, ou padrões anteriores automáticos). Passar pelo processo se torna essencial para uma futura condução de grupos, uma vez que, como nos diz Kabat-Zinn (2004), uma parte de nossa visão é moldada pelas circunstâncias de vida – nossas crenças pessoais e valores –, e outra será desenvolvida por meio da própria prática pessoal de meditação, permitindo que tudo se torne nosso professor – nosso corpo, nossas atitudes, nossa mente, nossa dor, nosso prazer, outra pessoa, nossos erros, nossas falhas, nosso sucesso, a natureza... resumindo, todos os nossos momentos. E é essa nova visão que servirá de base ao facilitador para a manutenção das práticas ao longo de sua vida, assim como para auxiliar o paciente a explorar sua experiência do momento por meio do inquérito (*inquiry*) que se segue após cada prática. É essencial que o facilitador de grupos seja familiarizado com essa perspectiva para auxiliar que o outro a desenvolva (Fig. 15.1).

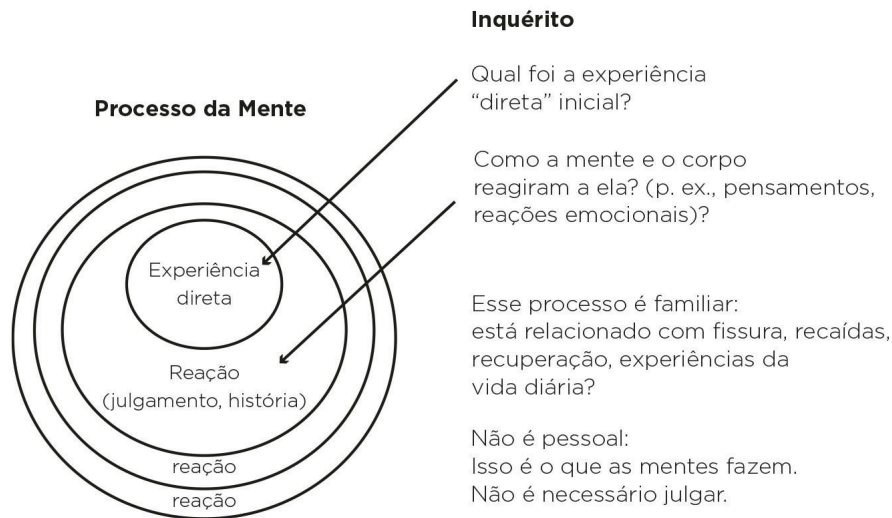


Figura 15.1 Processo de investigação.

Fonte: Bowen e colaboradores (2010, p. 9).

Os treinamentos, em geral, acontecem sob a forma de retiros com duração de uma semana, nos quais o participante tem a oportunidade de experimentar um mergulho mais intenso nas práticas, o que facilita a imersão e o aprendizado. No entanto, muitas vezes, essa modalidade não é viável no dia a dia dos pacientes, que têm dificuldade em se distanciar do trabalho e dos afazeres do cotidiano. Ainda assim, é muito importante que o facilitador de grupos tenha passado por vários retiros (incluindo aqueles de formação nos protocolos) antes de começar a conduzi-los. Esses requisitos estão contemplados, inclusive, no manual internacional de boas práticas das MBIs como intervenções clínicas terapêuticas e preventivas, seguindo parâmetros internacionais de excelência, baseados em evidências (UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations, 2016).

Os protocolos de *mindfulness* mais tradicionais, como MBSR, MBCT e MBRP, são estruturados, com planejamento sequencial prévio das principais metas e práticas propostas para cada uma das oito sessões semanais. A maioria das práticas consiste em vivências pessoais individuais. Porém, os exercícios experienciais meditativos são seguidos de uma breve discussão coletiva despertada pelo *inquiry*, focada no compartilhamento das experiências individuais vivenciadas durante a prática. Cada participante é

encorajado a dar seu depoimento sobre suas sensações corporais, pensamentos, sentimentos experienciados.

O número de participantes de cada grupo pode variar entre 6 e 12. Um grupo muito maior resulta em menor chance de cada participante compartilhar suas experiências, ou pode comprometer o tempo destinado para as práticas em si. Um grupo muito menor resulta em menor oportunidade de os participantes aprenderem a partir das experiências dos demais (Bowen et al., 2015). O compartilhamento em grupo oferece uma importante oportunidade de apoio e validação dos aprendizados acumulados durante o processo.

Meditar, segundo Kabat-Zinn (2004), é o processo de observar a mente e o corpo intencionalmente, abrindo-se para as experiências do momento e aceitando-as como são. Em geral, a meditação em grupo é mais potente, atingindo maiores níveis de aprofundamento (Demarzo & Campayo, 2015). No entanto, o exercício da meditação formal individual em casa é essencial para se atingir esse estado da mente humana a que nos referimos, *mindfulness*. Em um estudo randomizado, Campanella, Crescentini, Urgesi e Fabbro (2014) demonstraram, inclusive, que a soma dos efeitos do treinamento de oito semanas de *mindfulness*, dentro de um contexto psicoterapêutico em indivíduos saudáveis, com as práticas diárias em casa pode ocasionar mudanças até mesmo em perfis de personalidade medidos por escalas como a *Temperament and Character Inventory*, de Cloninger, Przybeck, Svrakic e Wetzell (1992), especialmente no fator maturidade em nível intrapessoal.

A prática de *mindfulness* permite criar um espaço de consciência entre o estímulo desafiador e a resposta comportamental e desenvolver a atitude de aceitação e curiosidade, a fim de explorar a experiência do momento. Nesse espaço de consciência, novas respostas podem surgir e romper com o *piloto automático* associado aos comportamentos disfuncionais. Além disso, as práticas estimulam reconhecer, sentir e aceitar o desconforto quando ele surge, buscando compreender essa experiência, em vez de tentar eliminá-la (Bowen et al., 2015). Também instrumentaliza os pacientes com estratégias alternativas de enfrentamento, na medida em que atua em um componente

crítico no processo de mudança de comportamento, que é a habilidade para responder diferentemente na presença de afetos negativos, assim como de outros estados internos (Gifford et al., 2004; Prochaska, 2010). Esse conjunto de fatores amplia a possibilidade de controle do impulso e melhora a relação da pessoa com suas dificuldades.

Este capítulo, portanto, irá tratar da modalidade *mindfulness* em grupos, como adjunto ao tratamento de adições, ansiedade, depressão, estresse, dores, hipertensão, doenças inflamatórias, insônia, entre outros problemas.

MINDFULNESS E SAÚDE: QUAIS OS BENEFÍCIOS?

Existem evidências científicas substanciais dos resultados de *mindfulness* para várias questões de saúde física e mental. As práticas de *mindfulness* demonstraram efeito na redução de estresse, melhora da qualidade de vida e do bem-estar, redução de sintomas de ansiedade e depressão, melhora da qualidade do sono e na habilidade de controle de impulsos. Assim, essa prática tem apresentando benefícios significativos para pacientes diagnosticados com depressão, transtorno bipolar, insônia, dependência de substâncias, transtornos alimentares, entre outros problemas (Bowen et al., 2014; Segal et al., 2010; Weber et al., 2010; Winbush, Gross, & Kreitzer, 2007). Também tem-se mostrado efetiva para a redução de estresse e promoção de bem-estar na população em geral, em ambiente ocupacional e educacional. Essa ampla gama de benefícios tem despertado o interesse e a curiosidade científica. Muito provavelmente, as práticas de *mindfulness* atuam na regulação de aspectos primários da saúde humana, que se traduzem em benefícios em vários aspectos da vida.

Em perspectiva biológica, as práticas de *mindfulness* diminuem os níveis de cortisol e contribuem para o tratamento da hipertensão arterial (Wallace, Silver, Mills, Dillbeck, & Wagoner, 1983) e de outros problemas cardiovasculares (Zamarra, Schneider, Besseghini, Robinson, & Salerno, 1996), bem como demonstram melhorar a resposta imunológica (Davidson et al., 2003).

Na perspectiva da saúde mental, por meio das práticas de *mindfulness*, os participantes desenvolvem capacidade de observar sensações, pensamentos e emoções com abertura. Essa habilidade metacognitiva ajuda a evitar que a pessoa embarque em pensamentos automáticos, preocupações excessivas diante do futuro (geradores de ansiedade), ruminação de pensamentos de eventos negativos do passado (que favorecem a depressão) ou outros padrões de julgamento diante de outras pessoas ou eventos da vida. Desenvolvendo esse foco de atenção curiosa ao presente, os praticantes ganham qualidade de vida e bem-estar, que se traduz, por exemplo, em melhora das relações interpessoais e qualidade do sono (Winbush et al., 2007).

São contundentes as evidências de efetividade e eficácia dos programas MBCT, MBRP e MBSR no tratamento de depressão maior, abuso de substâncias, dores crônicas e estresse, respectivamente, demonstradas na última década em ensaios clínicos randomizados (Bowen et al., 2014; Fulwiller, Brewer, Sinnott, & Loucks, 2015; Kuyken et al., 2015) e revisões de literatura (Davis & Hayes, 2011; Souza et al., 2015; Visted, Vøllestad, Nielsen, & Nielsen, 2015) publicados em periódicos de renome. Tais evidências vêm dando sinais de que esses programas vieram para ficar, dando suas contribuições nos campos da medicina e psicoterapias.

Como programas para o pós-tratamento, têm mostrado resultados para diversas outras manifestações relacionadas ao controle de impulsos, como controle alimentar, agressividade e dependências de forma geral.

CARACTERIZAÇÃO DO TRABALHO COM *MINDFULNESS* EM GRUPOS

Enquanto as técnicas cognitivas tradicionais são voltadas para a modificação do conteúdo dos pensamentos (a exemplo dos pensamentos disfuncionais automáticos), a prática de *mindfulness* procura mudar o relacionamento da pessoa com seus pensamentos, tornando-se, assim, mediadora da mudança (Roemer & Orsillo, 2010). Essas práticas vêm sendo incorporadas aos tratamentos convencionais, tanto na medicina quanto na psicologia, devido ao forte arcabouço de pesquisa indicando eficácia e efetividade de protocolos

que as envolvam, contribuindo para o desenvolvimento da habilidade para tolerar sintomas de desconforto e dor, ampliando o repertório de recursos para lançar mão nessas condições.

As práticas de *mindfulness* passaram a fazer parte da medicina comportamental a partir do programa de redução de estresse de Kabat-Zinn, em 1982, e despertaram o interesse dos clínicos fora da medicina comportamental a partir da década de 1990 (Vandenberghe & Sousa, 2006). Os tratamentos aliam práticas formais e informais, nos quais os pacientes são treinados para vivenciar situações do cotidiano de forma plenamente consciente (sem julgar ou racionalizar), como ao se alimentar, ao caminhar até o trabalho, ao conversar com alguém e ao observar uma paisagem presente em seu dia a dia (Roemer & Orsillo, 2010).

A natureza das práticas é basicamente a mesma em todos os programas, nos quais se distingue o tipo de âncora (respiração, sensações e movimentos corporais). Como o próprio nome sugere, o papel da âncora é trazer a consciência de volta ao momento presente com aceitação, abertura e curiosidade à experiência (Demarzo & Campayo, 2015). Em geral, a esquiva de conteúdos aversivos leva à ruminação e ao aumento involuntário da atenção seletiva para tais conteúdos (Garland, Froeliger, & Howard, 2013), favorecendo o círculo vicioso do sofrimento, enquanto o treino de *mindfulness* reduz esses processos (Segal et al., 2013).

As principais práticas formais de *mindfulness* presentes nos programas mais importantes são: prática da uva-passa, *mindfulness* baseado na respiração, *body scan* ou escaneamento corporal, *mindfulness* caminhando, *mindfulness* nos movimentos corporais e prática dos 3 minutos (Demarzo & Campayo, 2015).

Existem critérios de inclusão e exclusão relacionados aos pacientes que participarão do treinamento. É importante que os indivíduos estejam assintomáticos, ou seja, que os sintomas que motivaram sua procura por tratamento estejam sob controle – e vale lembrar que os programas são complementares aos tratamentos. Os pacientes podem e devem ser encaminhados aos grupos após indicação do clínico que os acompanha, e é

válido manter contato com ele ao longo das oito sessões, se assim for necessário.

Alguns critérios de exclusão descritos no programa MBSR também são adotados pelos demais programas: tendência ao suicídio, psicoses, transtorno de estresse pós-traumático, transtornos de ansiedade social (dificuldade em permanecer em grupos) e dependência de drogas ativa. Portanto, uma boa avaliação de triagem é recomendada antes da indicação aos grupos (Santorelli, 2014).

Os principais e mais conhecidos protocolos clínicos baseados em *mindfulness* serão apresentados aqui em relação à descrição das sessões e à estrutura e ao planejamento das sessões.

O PROGRAMA *MINDFULNESS*-BASED STRESS REDUCTION (MBSR – REDUÇÃO DE ESTRESSE BASEADA EM *MINDFULNESS*)

Onde quer que você vá, esteja lá. (Kabat-Zinn, 2004)

As bases dos programas baseados em *mindfulness* que hoje são conhecidos vieram da Universidade de Massachusetts (UMass), no fim da década de 1970, a partir da experiência de Kabat-Zinn e sua equipe na Stress Reduction Clinic com pacientes que sofriam de dores crônicas (Kabat-Zinn, 2004).

Apresentar alguma resposta ao tratamento, nesses casos, é muito desafiador, uma vez que, em geral, o paciente já fez várias tentativas sem sucesso. No entanto, a proposta do treinamento de oito semanas apresentou amplos resultados, com mais de 16 mil pacientes atendidos em sua clínica durante todos esses anos (Kabat-Zinn, 2004). Além disso, mais de 400 hospitais hoje, no mundo, oferecem o treinamento em MBSR (Kozasa, Little, & Souza, 2015).

As bases do programa se situam na ideia de perceber que a mente tende a reagir automaticamente e desenvolver habilidades para lidar efetivamente com as *variações do tempo* na vida de cada um, o que é considerado como a arte de viver consciente (Kabat-Zinn, 2004).

O programa resgata a possibilidade de a pessoa ouvir seu próprio corpo e sua própria mente e começar a acreditar mais em sua própria experiência, que é a maior fonte de informação sobre sua vida, podendo torná-la mais alegre e rica do que é. Viver intencionalmente momento a momento: esse é o caminho da consciência, o caminho de *mindfulness*, segundo Kabat-Zinn (2004).

A prática da meditação *mindfulness* é um convite no sentido de se prestar atenção nas sensações do corpo no momento, ancorando a experiência na respiração: inspiração e expiração. Parece estranho pensar que a observação da respiração pode ajudar alguém a lidar com suas dores crônicas, por exemplo, mas essa prática, na verdade, é um convite a resgatar a atenção àquilo está acontecendo aqui e agora, incluindo as emoções, o que pode impedir que sejam tomadas atitudes impulsivas e desastrosas. Estas, muitas vezes, acontecem em razão de pilotos automáticos que dominam nosso comportamento, restringindo nossas possibilidades de reagir de forma diferente ou de não reagir (Kabat-Zinn, 2004).

O sentido de impermanência, muitas vezes negado na experiência cotidiana, está na base de *mindfulness*, já que emoções, sentimentos e pensamentos são passageiros e são sentidos como imperativos, o que impede que passem. Parar e respirar, tomando consciência do que está acontecendo no momento presente, permite perceber que, na maior parte do tempo, a mente transita entre passado e futuro, e não permanece no presente. Assim, não se percebe o que se passa no momento, o que cria condição favorável para se agir no piloto automático (Kabat-Zinn, 2004).

Paradoxalmente, meditar não envolve tentar chegar a algum lugar ou sentir algo específico. Em vez disso, envolve permitir a si mesmo ser e estar exatamente onde se está. A ideia, por exemplo, não é conduzir ao relaxamento – este pode ser alcançado com a prática contínua –, mas observar o corpo e a mente intencionalmente, deixando que as experiências aconteçam no momento, aceitando-as como são (Kabat-Zinn, 2004).

Kabat-Zinn (2004) afirma que estar apenas parcialmente consciente - durante um longo período de tempo, somente passando pela vida, sem se aprofundar na experiência do momento presente, pode à perda de experiências mais preciosas, como se conectar com pessoas que se ama ou

com o pôr do sol em um fim de tarde. Ainda, para além disso, significa poder desenvolver muitos problemas de saúde, uma vez que o corpo emite sinais de cansaço, fadiga, insatisfação, carências e não se está totalmente consciente disso, e sim sob a tirania de pensamentos e comportamentos autodestrutivos que, segundo Kabatt-Zinn (2004), estabelecem as bases do adoecimento e podem ser letais.

Dentro dessa perspectiva, os sintomas físicos e psíquicos são mensagens do corpo sobre como as coisas estão indo e quais são suas necessidades. Ouvir e compreender se torna vital para a saúde e a qualidade de vida (Kabat-Zinn, 2004).

O programa MBSR, portanto, foi desenvolvido nessas bases, a partir da própria experiência pessoal de meditação de seu criador. Inicia-se com um *workshop*, em que as pessoas têm sua primeira experiência com *mindfulness*. O programa requer oito semanas, com encontros semanais de 2 horas cada e um retiro de 8 horas. Inclui práticas formais e informais de meditação *mindfulness* (Kozasa et al., 2015).

Aprender a lidar com seus sentimentos e emoções, cuidar melhor de si mesmo, viver integralmente e trazer a consciência para o momento atual são as principais características do programa. O Quadro 15.1 apresenta a base principal das oito sessões.

Quadro 15.1 Base principal das oito sessões do programa MBSR

Sessões	Características
1	Tomada de consciência (<i>Awareness</i>) Introdução ao escaneamento corporal
2	Atenção e a mente Introdução à meditação sentado
3	Lidando com pensamentos Introdução à ioga
4	Estresse: responder vs. reagir Introdução do <i>PARAR</i> espaço para respirar (meditação de 1 minuto)
5	Lidando com emoções e sensações difíceis Meditação sentado
6	<i>Mindfulness</i> e a comunicação Meditação da montanha
7	<i>Mindfulness</i> e compaixão Meditação da bondade amorosa (<i>Loving-kindness</i>)
8	Desenvolvendo sua própria prática Discussão sobre como cada um desenvolverá sua própria prática após o término do treinamento

Observações importantes: em todas as sessões, os participantes são estimulados a realizar práticas informais de *mindfulness* no dia a dia. É importante ressaltar que, muitas vezes, os obstáculos são numerosos na introdução à prática da meditação, como, por exemplo, sensação de sono, distração, pensamentos negativos sobre a prática. Eles são discutidos ao longo do treinamento, e é natural que aconteçam. Aceitar a presença desses obstáculos e continuar na prática faz parte do treinamento. Cada participante do treinamento recebe um CD com todas as práticas guiadas gravadas e é estimulado a praticá-las em casa por pelo menos seis dias na semana, durante cerca de 20 a 60 minutos por dia. Discussões sobre o estresse, propriamente dito, também fazem parte do treinamento.

Segundo o Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society (2014), o MBSR tem sido recomendado como complementar ao tratamento de diversas doenças, como ansiedade, estresse, asma, câncer, doenças crônicas diversas, transtornos alimentares, problemas gastrintestinais, cardiovasculares, de pele, de sono, entre outros (Kozasa et al., 2015).

O PROGRAMA *MINDFULNESS*-BASED *COGNITIVE THERAPY* (MBCT – TERAPIA COGNITIVA BASEADA EM *MINDFULNESS*)

O programa MBCT foi desenvolvido por Segal e colaboradores (2013) para ajudar os pacientes a lidar com estados de humor negativos persistentes, mais especificamente a depressão recorrente. O programa tem-se mostrado efetivo não somente para depressão, mas também para ansiedade e outros problemas emocionais.

Segal e colaboradores (2013) propuseram o treino de habilidades envolvendo o controle atencional (por meio da meditação *mindfulness*) como importante auxílio na prevenção da recaída nos quadros de depressão maior. As práticas passaram a integrar o protocolo da TCC, uma vez que a teoria sobre o processamento de informação em casos de depressão maior explica a

tendência de pacientes com esse transtorno recaírem em estados de disforia, o que reativa padrões de pensamentos negativos presentes em episódios da doença, precipitando, portanto, a recaída.

Trata-se de um programa de oito sessões em grupo, muito embasado no programa desenvolvido por Kabat-Zinn (2004), mas que incorpora elementos da TCC para facilitar a visão em perspectiva dos pensamentos, permitindo enxergar “pensamentos como apenas pensamentos, não como fatos”. O treinamento em *mindfulness* permite que os indivíduos observem seus pensamentos e sentimentos sem julgamento e passem a vê-los simplesmente como eventos mentais que vêm e vão, em vez de encará-los como aspectos de si mesmos ou como reflexões acuradas da realidade. Essa atitude perante as cognições que têm uma relação direta com a depressão acaba por evitar que o paciente se envolva em uma espiral de pensamentos negativos, que o conduzem à ruminação, típica de quadros depressivos (Segal et al., 2013).

Muitos estudos clínicos envolvendo avaliação neurocognitiva corroboram esses resultados (Garland, Gaylord, Boettiger, & Howard, 2010; Howells, Ives-Deliperi, Horn, & Stein, 2012; Kumar, Feldman, & Hayes, 2008; Lazar et al., 2005). O ensaio clínico de Moore e Malinowski (2009) demonstrou que *mindfulness* está intimamente relacionado com a melhora na *performance* atencional e com o aumento na flexibilidade cognitiva, o que proporciona bem-estar. Na prática, essa melhora representa proporcionar o espaço mental necessário para se detectar avaliações cognitivas insalubres e incorretas que antes não eram percebidas e levavam a atitudes e emoções equivocadas, que, por sua vez, afetavam negativamente o bem-estar.

Consciência (*awareness*) *mindful* é o coração do programa MBCT (Segal et al., 2013); portanto, é preciso compreender as ideias centrais do programa, que estão apresentadas no Quadro 15.2.

Quadro 15.2 Ideias centrais do programa MBCT

As emoções não são o problema. O problema é a maneira como eu reajo a elas.

A reação automática natural de tentar se livrar dos sentimentos negativos irá mantê-lo preso a esses sentimentos.

A ruminação é produto da mente tentando (de forma ineficaz) livrar-se dos sentimentos desagradáveis.

A mente pode operar de forma que conduza às ruminações, o que leva à prisão às engrenagens mentais que conduzem ao sofrimento. Mas podemos aprender a sair dessas engrenagens.

Cultivando um estado mental que nos permita estar presente é um bom antídoto contra esse *modus operandi* da mente e uma porta aberta a uma nova forma de se viver.

O treinamento em *mindfulness* nos permite aprender a reconhecer em que engrenagem mental estamos operando e como sair dela para operar no modo ser e estar presente.

MBCT é um tratamento clinicamente comprovado e envolve a nossa mais profunda capacidade de viver de forma rica e intensa.

MBCT funciona nos ensinando a ser mais *mindful*, gentil e compassivo.

Fonte: Segal e colaboradores (2013, p. 28-29).

Cada sessão apresenta um tema específico, como mostra o Quadro 15.3.

Quadro 15.3 Tema específico de cada sessão do programa MBCT

Sessões	Temas
1	Piloto automático
2	Lidando com barreiras
3	<i>Mindfulness</i> da respiração
4	Ficando no presente
5	Aceitar e deixar ir
6	Pensamentos não são fatos
7	Qual a melhor maneira de tomarmos conta de nós mesmos
8	Usando o que foi aprendido para lidar com os humores no futuro

Fonte: Demarzo, Barros e Oliveira (2015).

Os objetivos e práticas principais de cada sessão do programa estão descritos no Quadro 15.4.

Quadro 15.4 Objetivos e práticas principais de cada sessão do programa

Sessões	Objetivos	Principais práticas
1	<i>Mindfulness</i> nos oferece um caminho para sairmos do piloto automático.	• Uva-passa • Escaneamento corporal
2	Exploração das primeiras experiências com meditação e suas barreiras. Introdução da visão em perspectiva em relação a sentimentos e pensamentos.	• 10 minutos de meditação sentado • <i>Mindfulness</i> da respiração

3	Observar a conexão entre respirar e voltar ao presente (ideia da âncora). Identificar <i>mindfulness</i> no dia a dia, percebendo como a aceitação e o não julgamento podem contribuir para vivenciar experiências do cotidiano de forma diferente e curiosa.	• <i>Mindfulness</i> da respiração • <i>Mindfulness</i> dos movimentos • Prática dos 3 minutos de respiração
4	Experienciar emoções, sensações e pensamentos de uma forma diferente da habitual – não reagindo a eles, permitir estar na experiência em perspectiva.	• Meditação sentado – prática dos sons e pensamentos • Meditação caminhando – prática dos 3 minutos de respiração
5	Permitir que as coisas sejam o que elas já são, sem julgamento ou tentativas de torná-las diferentes.	• Leitura do poema de Rumi <i>A casa de hóspedes*</i> e discussão no grupo • Exploração de padrões habituais envolvidos em situações de desconforto na mente e no corpo, utilizando o espaço para respirar como estratégia: tomada de consciência do que está acontecendo aqui e agora → redirecionar a atenção para a respiração → expandindo a atenção novamente para todo o corpo “Está ok! Seja o que for, já está aqui. Deixe-me sentir isso!”
6	Libertar-se do modo de ruminação ao perceber alterações de humor como estados passageiros da mente, e os pensamentos como eventos mentais. “Pensamentos são somente pensamentos.”	• Meditação sentado – consciência da respiração, corpo, sons e pensamentos/sentimentos • Prática dos 3 minutos de respiração
7	Responder de forma mais habilidosa aos humores negativos aprendendo a reconhecer nosso padrão pessoal de acionadores ou gatilhos pessoais.	• Meditação sentado (idem sessão 6) e prática dos 3 minutos de respiração • Fazer um balanço entre atividades prazerosas e exaustivas do dia a dia, gerando uma reflexão e uma lista daquelas que poderá manter ou excluir de sua rotina
8	Planejar uma nova forma de se viver. Manter e estender uma forma mais <i>mindful</i> de se viver requer intenção clara e planejamento.	• Escaneamento corporal • Meditação de conclusão com os participantes desejando o bem a si mesmos e aos demais

* O “ser humano” é uma casa de hóspedes.

Toda manhã uma nova chegada. / A alegria, a depressão, a falta de sentido, como visitantes inesperados. / Receba e entretenha a todos / Mesmo que seja uma multidão de dores / Que violentamente varrem sua casa e tiram seus móveis. / Ainda assim trate seus hóspedes honradamente. / Eles podem estar te limpando para um novo prazer. / O pensamento escuro, a vergonha, a malícia, encontre-os à porta rindo. / Agradeça a quem vem, porque cada um foi enviado / Como um guardião do além.

Rumi (Mestre Sufi do séc. XII)

Fonte: Segal e colaboradores (2013).

O PROGRAMA *MINDFULNESS-BASED RELAPSE PREVENTION* (MBRP – PREVENÇÃO DE RECAÍDA BASEADA EM *MINDFULNESS*)

Para pacientes com problemas de controle do comportamento, Bowen e colaboradores (2015) desenvolveram um protocolo específico para prevenção de recaída, denominado MBRP (*Mindfulness-Based Relapse Prevention*). O

MBRP visa auxiliar no manejo da fissura e ampliar a autoconsciência diante dos gatilhos (emocionais ou ambientais) que despertam o impulso ao comportamento aditivo. O MBRP foi desenvolvido para pacientes dependentes de álcool e outras drogas, mas também é aplicável para diversas outras manifestações relacionadas ao controle de impulsos, como controle alimentar, agressividade e dependências de forma geral.

No Brasil, o *Guia prático de MBRP para clínicos* (Bowen et al., 2015) foi traduzido para o português, sendo os primeiros estudos brasileiros sobre MBRP iniciados na Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) para os pacientes dependentes.

O MBRP, para os pacientes dependentes, auxilia na autoconsciência diante dos gatilhos (emocionais ou ambientais) que despertam o impulso ao comportamento de uso. Essa consciência ampliada cria a oportunidade de escolha de novas respostas diferentes do piloto automático, diminuindo a probabilidade de recorrência do comportamento indesejado.

Além disso, o MBRP promove a aceitação da fissura. As práticas de *mindfulness* estimulam reconhecer, sentir e aceitar o desconforto quando ele surge, fomentando a aceitação dessa experiência, em vez de tentar evitá-la. A abordagem compassiva de aceitação e curiosidade, além disso, auxilia no gerenciamento da culpa e da vergonha frequentemente vivenciadas diante da dificuldade de controlar o comportamento.

O programa de MBRP é composto de oito sessões semanais, com 2 horas de duração cada, para 6 a 10 participantes. Todas as sessões incluem de 20 a 30 minutos de meditação guiada – como, por exemplo, escaneamento corporal, prática de meditação sentada e meditação caminhando –, além do treino de habilidades experienciais (mergulhar na experiência, sem julgamentos), dos princípios da prevenção de recaída e do treino de práticas informais de meditação, como o exercício do PARAR (P = pare, A = analise, R = respire, A = amplie, R = responda), que podem ser incluídos no dia a dia. Os participantes recebem os exercícios por escrito para que descrevam suas experiências diárias com a meditação, focando principalmente na experiência da fissura e do estado de humor, além de um CD com as práticas guiadas gravadas com a instrução da facilitadora dos grupos (Bowen et al., 2014).

Cada sessão apresenta um tema específico, como mostram a Figura 15.2 e o Quadro 15.5.

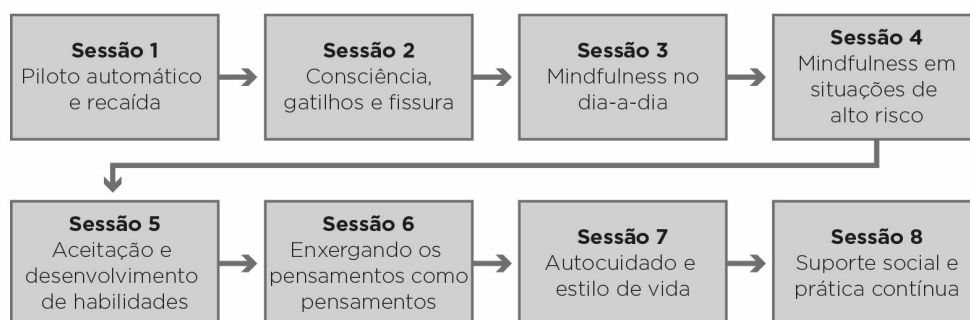


Figura 15.2 Temas específicos de cada sessão.

Fonte: Bowen e colaboradores (2015).

Quadro 15.5 As oito sessões de MBRP com as respectivas práticas e objetivos principais

Sessões	Objetivos e práticas principais de cada sessão
1	Apresentar a noção de <i>piloto automático</i> , ou seja, a tendência de agir automaticamente, sem plena consciência do que está sendo feito. Com a prática de <i>escaneamento corporal</i> , o foco da atenção é dirigido às sensações corporais.
2	Aprender a identificar gatilhos e vivenciar a fissura com aceitação. O foco é centrado na maneira como a reação é sentida no corpo, especialmente nas sensações, nos pensamentos e emoções que acompanham a fissura.
3	Apresentar a prática de <i>PARAR</i> , como forma de ampliação do espaço entre estímulo e resposta, ancorada na respiração. A prática é uma alternativa que pode ser utilizada em situações da <i>vida diária</i> .
4	Explorar riscos individuais de recaída e maneiras de enfrentar a intensidade de sentimentos que surgem em situações de alto risco. É utilizada a prática da atenção focada na respiração.
5	Praticar a aceitação de sentimentos e sensações indesejados como um primeiro passo em direção à mudança. <i>PARAR</i> para agir com habilidade tanto em situações de alto risco quanto na vida diária.
6	Ampliar a consciência dos pensamentos como <i>simples pensamentos</i> e as formas de se relacionar com eles. Explorar o papel do pensamento no ciclo de recaída.
7	Identificar sinais internos e externos de <i>aviso de recaída</i> e como reagir quando surgem. Discutir estilo de vida, equilíbrio, autocompaixão e a importância de atividades que contribuem para o bem-estar.
8	Revisar e refletir sobre as habilidades práticas aprendidas, bem como explorar possibilidades de um plano individual de continuidade das práticas e potenciais sistemas de apoio.

Fonte: Bowen e colaboradores (2015).

A EXPERIÊNCIA BRASILEIRA NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) COM GRUPOS DE TABAGISTAS

Em 2010, a pesquisadora Isabel Cristina Weiss de Souza começava uma busca por melhores recursos clínicos que pudessem ajudar os pacientes a superar ou a lidar melhor com suas queixas. Como terapeuta cognitivo-comportamental, com experiência clínica de quase duas décadas, achava instigante ouvir dos pacientes: “Estou melhor, mas seria tão bom fazer minha mente calar!”. Percebia que os já consagrados recursos da TCC não eram suficientes nesse sentido. Foi quando se deparou com o programa de MBRP, naquele momento por meio de buscas pela internet, o que a motivou a buscar a formação nos Estados Unidos, no ano seguinte, e a desenvolver um projeto de pesquisa de doutorado na Unifesp.

A pesquisadora traz, aqui, um pouco da experiência que obteve na pesquisa clínica envolvendo MBRP como adjunto ao tratamento do tabagismo no SUS com enfoque na adaptação do programa à realidade brasileira. Trata-se de um estudo-piloto pragmático randomizado envolvendo análises quantitativa e qualitativa, com colaboração da Dra. Sarah Bowen, pesquisadora da Universidade de Washington, uma das idealizadoras do programa de MBRP.

O programa de tratamento do tabagismo do SUS, desenvolvido pelo Ministério da Saúde do Brasil em parceria com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), acontece em grupos desde seu início. O paciente ingressa em uma reunião de sensibilização em grupo e assim permanece em todas as etapas, com exceção das consultas médicas com vistas à terapia de reposição de nicotina (TRN), que são individuais. As reuniões em grupo do protocolo do Inca são: sensibilização, quatro reuniões de aconselhamento cognitivo-comportamental e seis reuniões de manutenção de prevenção de recaída (o que proporcionou ao grupo-controle ser ativo).

Os pacientes eram randomizados entre grupo MBRP, que recebia, além do tratamento padrão do SUS, as oito sessões de MBRP, e grupo-controle ativo, que recebia exclusivamente o tratamento do SUS.

“No princípio é estranho... eu vou falar do jeito que entendi o escaneamento corporal... é você se autoconhecer por dentro através da respiração.” (Relato de paciente sujeito da pesquisa, na 4ª sessão de MBRP – R G104)

Sem dúvida, era uma incógnita para todos nós envolvidos na pesquisa a maneira como os pacientes do SUS receberiam o convite para participar de uma pesquisa clínica envolvendo meditação. Até onde temos conhecimento, essa foi a primeira pesquisa, nessa linha, desenvolvida no SUS em nosso país. No entanto, a receptividade foi grande: 80% dos pacientes que foram convidados a participar da pesquisa consentiram, e, entre aqueles que foram randomizados para receberem MBRP, apenas 20% não concluíram as oito sessões.

A satisfação dos participantes foi avaliada em grupos focais, e as manifestações foram muito positivas, como se lê a seguir:

Tá sendo muito bom pra mim. O meu problema psiquiátrico, sabe? Já tá ótimo. Já... parei até de usar remédio. (Relato na 6ª sessão de MBRP – T, G 120. Paciente tratava de fibromialgia com psiquiatra fora do serviço de tabagismo, e a melhora foi sentida nos sintomas, a ponto de o médico suspender sua medicação antidepressiva.)

A participação em grupo também foi avaliada como muito positiva. Conforme já mencionado, o tratamento do tabagismo acontece, todo ele, dentro dessa modalidade. Portanto, ao mencionar os benefícios, os pacientes falaram de modo geral, já que são muito satisfeitos com os cuidados que recebem no SUS. Mas, em relação às sessões de MBRP especificamente, relataram o amplo bem-estar que sentiram e a falta que o grupo irá fazer para que mantenham suas práticas no dia a dia após o treinamento de oito semanas.

Vai fazer muita falta... a gente vinha pra cá como quem vai para sua terapia... é muito bom... um tempo para falar da gente e receber atenção... eu antes me sentia sufocada e não sabia o que fazer. Hoje já respiro e sei que passa... receber o apoio do grupo é muito bom! (Relato de Z na 8ª sessão de MBRP, G 90)

Fazer parte da nossa vida! Porque nós não temos... não sei se é por causa da nossa faixa etária, não sei a idade de todo mundo, mas acho que todo mundo aqui passa dos 30, 40, 50, e tal... então a gente tem um outro tipo

de vida, uma outra responsabilidade, então o que que acontece... nós precisamos ser... é... Vamos dizer, não é mandada, é... ter espaço pra encaixar isso... a gente no nosso natural, vai ser difícil a gente encaixar, mesmo sabendo que vai ser bom, porque a gente tem muita responsabilidade... (Relato de R na 8ª sessão de MBRP, G 104)

RESULTADOS PRELIMINARES DE MBRP NO BRASIL

O estudo levantou indicadores positivos de viabilidade que sugerem a pertinência e o potencial do MBRP para implementação da prevenção de recaídas, como intervenção adjunta ao protocolo do Inca, tradicionalmente utilizado para tratamento de tabagistas no Brasil. Foram observados indicativos de aceitação e envolvimento dos pacientes ao MBRP, bem como o potencial de integração ao sistema de tratamento tradicional. Porém, também foram observados pontos de fragilidade que merecem atenção: o programa de MBRP adiciona mais oito sessões semanais de 2 horas de duração a um protocolo já intenso. Em geral, observamos dificuldades dos participantes em cumprir todo o protocolo proposto. Boa parte deles trabalha ou tem atividades de rotina que dificultam o comparecimento. Pensar, talvez, em alternativas ao protocolo que possam facilitar o acesso, como o uso de ferramentas tecnológicas, a exemplo do que já vem acontecendo em alguns países, pode facilitar a integração de MBRP ao tratamento-padrão, que se mostrou eficaz. Ainda não foram feitos estudos de sustentabilidade do programa no sistema de saúde. Esse aspecto também merece atenção de futuros estudos.

O resultado da efetividade do MBRP para tabagistas no Brasil está em fase final de análise para publicação. As avaliações preliminares indicam resultados positivos para a manutenção de abstinência para os participantes do protocolo comparados a um grupo-controle. Outro aspecto que merece consideração é a complexidade do processo formativo em *mindfulness*. Para que um profissional esteja apto a conduzir grupos, é necessário que seja um meditador, tenha uma formação em abordagem cognitivo-comportamental e

busque a formação em programas como o MBRP, por exemplo. Ainda existem poucos centros de formação no Brasil.

O MBRP-Brasil (Centro Brasileiro de Pesquisa e Formação em MBRP, 2016) tornou-se referência no País em pesquisa e formação profissional, com supervisão constante da Profa. Sarah Bowen. Porém, existe a necessidade de definição de critérios de boas práticas em *mindfulness*, uma vez que, disseminando-se no País, corre o risco de ser confundida apenas com mais uma técnica, em detrimento de sua representação real de ser um novo olhar sobre os sintomas e a recuperação, tornando-se parte de uma linha das terapias comportamentais de terceira geração. Essa exigência de cuidados na formação, embora muito necessária para garantir qualidade, é ainda um dos principais desafios do processo de disseminação no sistema público.

Focamos aqui no tratamento do tabagismo apenas como um exemplo do que se pode oferecer como tratamento em grupo de abordagens cognitivo-comportamentais baseadas em *mindfulness*, uma vez que ele vem sendo testado no Brasil nos últimos anos. Contudo, como citado no decorrer do capítulo, é ampla a aplicabilidade de *mindfulness* em grupos nos diversos transtornos de saúde, assim como são inúmeros os benefícios, os quais atingem um amplo escopo de possibilidades.

CONSIDERAÇÕES FINAIS E TENDÊNCIAS FUTURAS

Neste capítulo, procuramos deixar evidente a importante interface que existe entre o treinamento em *mindfulness* e os procedimentos da TCC em geral. Na literatura, vemos referência ao fato de que o treinamento pode resultar em uma prolongada exposição a sensações, emoções e pensamentos, resultando em uma dessensibilização a respostas condicionadas e em redução de comportamentos evitativos, sendo estes últimos, muitas vezes, responsáveis por manter os círculos viciosos relativos a depressão, ansiedade, fissura por drogas, compulsões e outros problemas (Segal et al., 2013).

Nos últimos anos, têm sido fortes as evidências científicas que contribuem para justificar a adoção de protocolos baseados em *mindfulness* como

complementares a tratamentos diversos em pacientes assintomáticos e como forma de prevenção de recaídas em geral e potencialização de tratamentos.

O treinamento em *mindfulness* difere em aspectos importantes da TCC tradicional, como, por exemplo, ao não incluir avaliação de pensamentos distorcidos – em vez disso, os pacientes são treinados para observar o caráter impermanente de seus pensamentos ao deixá-los ir (*let go*). Outra diferença importante pode ser observada em relação ao fato de que na TCC em geral se tem uma meta clara no tratamento, enquanto no treinamento em *mindfulness* não existe propriamente um objetivo – pratica-se uma atitude paradoxal até que ela deixe de acontecer, sem esforço, simplesmente observando o que acontece em cada momento, sem julgamento. Diferencia-se significativamente, também, pelo fato de o facilitador de *mindfulness* precisar estar engajado em sua própria prática regular, ao passo que, em TCC, não é esperado necessariamente que o profissional se engaje nas habilidades que está treinando (Baer, 2003).

No entanto, apesar das diferenças, esse casamento tem dado certo, com excelentes resultados em pesquisas e na clínica. Na Inglaterra, o National Institute for Clinical Excellence (NICE) recomenda a adoção como “a” intervenção para se prevenir recaídas na depressão entre aqueles pacientes que já apresentaram três episódios da doença (Crane & Kuyken, 2013).

A disseminação e a implementação desses protocolos nos serviços de saúde dependem de uma série de estágios de pesquisas anteriores que contemplem desde pesquisa básica até os estudos de eficácia e efetividade, pensando na adaptação e validação a diferentes populações e *settings*, como preconiza o National Institute of Health (NIH) (Onken, Carroll, Shoham, Cuthbert, & Riddle, 2014). No Brasil, vemos o início de um caminho, uma vez que as pesquisas com MBRP vêm avançando. Sabemos que o caminho é longo e os obstáculos são muitos, a começar pela formação do facilitador de grupos, que não é algo simples e exige prática contínua.

Mindfulness emergiu como um importante construto no campo da saúde nas últimas duas décadas. Vale ressaltar que os resultados de pesquisas clínicas ainda são preliminares e que ainda se fazem necessários estudos que investiguem fatores ligados a abandonos, possíveis efeitos adversos ou

populações contraindicadas (Hanley, Abell, Osborn, Roehrig, & Canto, 2016).

O importante movimento de expansão na literatura vem motivando as pesquisas a avançar cada vez mais, o que pode contribuir para uma futura implementação de protocolos de grupos baseados em *mindfulness* em serviços de saúde.

REFERÊNCIAS

- Baer, R. A. (2003). Mindfulness training as a clinical intervention: A conceptual and empirical review. *Clinical Psychology: Science and Practice*, 10(2), 125-143.
- Bowen, S., Chawla, N., & Marlatt, G. A. (2010). *Mindfulness-based relapse prevention for addictive behaviors: A clinician's guide*. New York: Guilford.
- Bowen, S., Chawla, N., & Marlatt, G. A. (2015). *Prevenção de recaída baseada em mindfulness para comportamentos aditivos: Um guia para o clínico*. Rio de Janeiro: Cognitiva.
- Bowen, S., Witkiewitz, K., Clifasefi, S. L., Grow, J., Chawla, N., Hsu, S. H., . . . Larimer, M. E. (2014). Relative efficacy of mindfulness-based relapse prevention, standard relapse prevention, and treatment as usual for substance use disorders: A randomized clinical trial. *JAMA Psychiatry*, 71(5), 547-556.
- Campanella, F., Crescentini, C., Urgesi, C., & Fabbro, F. (2014). Mindfulness-oriented meditation improves self-related character scales in healthy individuals. *Comprehensive Psychiatry*, 55(5), 1269-1278.
- Center for Mindfulness in Medicine, Health Care and Society. (2014). *Stress reduction: Mobilize your own inner resources for learning, growing, and healing*. Recuperado de <http://www.umassmed.edu/cfm/Stress-Reduction/>
- Chiesa, A., & Malinowski, P. (2011). Mindfulness-based approaches: Are they all the same? *Journal of Clinical Psychology*, 67(4), 404-424.
- Cloninger, C. R., Przybeck, T. R., Svrakic, D. M., & Wetzel, R. D. (1992). *The Temperament and Character Inventory (TCI): A guide to its development and use* (Version 9). St. Louis: Center for Psychobiology of Personality.
- Crane, R. S., & Kuyken, W. (2013). The implementation of mindfulness-based cognitive therapy: Learning from the UK health service experience. *Mindfulness*, 4, 246-254.
- Davidson, R. J., Kabat-Zinn, J., Schumacher, J., Rosenkranz, M., Muller, D., Santorelli, S. F., . . . Sheridan, J. F. (2003). Alterations in brain and immune function produced by mindfulness meditation. *Psychosomatic Medicine*, 65(4), 564-750.
- Davis, D. M., & Hayes, J. A. (2011). What are the benefits of mindfulness? A practice review of psychotherapy-related research. *Psychotherapy*, 48(2), 198-208.
- Demarzo, M. M. P., Barros, V. V., & Oliveira, M. B. (2015). Terapia cognitiva baseada em mindfulness. In P. Lucena-Santos, J. Pinto-Gouveia, & M. S. Oliveira, (Orgs.), *Terapias*

comportamentais de terceira geração: Guia para profissionais (pp. 127-150). Novo Hamburgo: Sinopsys.

Demarzo, M. M. P., & Campayo, J. G. (2015). *Manual prático mindfulness: curiosidade e aceitação*. São Paulo: Palas Athena.

Fulwiller, C., Brewer, J. A., Sinnott, S., & Loucks, E. B. (2015). Mindfulness-based interventions for weight loss and CVD risk management. *Current Cardiovascular Risk Reports*, 9, 46.

Garland, E. L., Gaylord, S. A., Boettiger, C. A., & Howard, M. O. (2010). Mindfulness training modifies cognitive, affective, and psychological mechanisms implicated in alcohol dependence: Results from a randomized controlled pilot trial. *Journal of Psychoactive Drugs*, 42(2), 177-192.

Garland, E. L., Froeliger, B., & Howard, M. O. (2013). Mindfulness training targets neurocognitive mechanisms of addiction at the attention-appraisal-emotion interface. *Frontiers in Psychiatry*, 4, 173.

Gifford, E. V., Kohlenberg, B. S., Hayes, S. C., Antonuccio, D. O., Piasecki, M. M., & Rasmussen-Hall, M. L. (2004). Acceptance-based treatment for smoking cessation. *Behavior Therapy*, 35(4), 689-705.

Hanley, A. W., Abell, N., Osborn, D. S., Roehrig, A. D., & Canto, A. I. (2016). Mind the gaps: Are conclusions about mindfulness entirely conclusive? *Journal of Counseling & Development*, 94(1), 103-113.

Lazar, S. W., Kerr, C. E., Wasserman, R. H., Gray, J. R., Greve, D. N., Treadway, M. T., & Fischl, B. (2005). Meditation experience is associated with increased cortical thickness. *Neuroreport: For Rapid Communication of Neuroscience Research*, 16(17), 1893-1897.

Howells, F. M., Ives-Deliperi, V. L., Horn, N. R., & Stein, D. J. (2012). Mindfulness based cognitive therapy improves frontal control in bipolar disorder: A pilot EEG study. *BMC Psychiatry*, 12, 15.

Kumar, S., Feldman, G., & Hayes, A. (2008). Changes in mindfulness and emotion regulation in an exposure-based cognitive therapy for depression. *Cognitive Therapy and Research*, 32, 734-744.

Kabat-Zinn, J. (2004). *Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness*. New York: Random House Publishing.

Kozasa, E. H., Little, S., & Souza, I. C. W. (2015). Programa de redução de estresse baseado em mindfulness. In P. Lucena-Santos, J. Pinto-Gouveia, & M. S. Oliveira, (Orgs.), *Terapias comportamentais de terceira geração: Guia para profissionais* (pp. 104-126). Novo Hamburgo: Sinopsys.

Kuyken, W., Hayes, R., Barrett, B., Byng, R., Dalgleish, T., Kessler, D., . . . Byford, S. (2015). Effectiveness and cost-effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy compared with maintenance antidepressant treatment in the prevention of depressive relapse or recurrence (PREVENT): A randomised controlled trial. *Lancet*, 386(9988), 63-73.

Moore, A., & Malinowski, P. (2009). Meditation, mindfulness and cognitive flexibility. *Consciousness and Cognition*, 18(1), 176-186.

Centro Brasileiro de Pesquisa e Formação em MBRP. (2016). Recuperado de <http://www.mbrpbrasil.com.br/>

Onken, L. S., Carroll, K. M., Shoham, V., Cuthbert, B. N., & Riddle, M. (2014). Reenvisioning clinical science: Unifying the discipline to improve the public health. *Clinical Psychological Science*, 2(1), 22-

Palouse Mindfulness. (2016). *Week 1: Simple awareness introduction to the body scan*. Recuperado de <https://palousemindfulness.com/MBSR/week1.html>

Prochaska, J. J. (2010). Failure to treat tobacco use in mental health and addiction treatment settings: A form of harm reduction? *Drug and Alcohol Dependence*, 110(3), 177-182.

Roemer, L., & Orsillo, S. M. (2010). *A prática da terapia cognitivo-comportamental baseada em mindfulness e aceitação*. Porto Alegre: Artmed.

Santorelli, S. F. (2014). *Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR): Standards of practice*. Worcester: The Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society.

Segal, Z. V., Bieling, P., Young, T., MacQueen, G., Cooke, R., Martin, L., ... Levitan, R. D. (2010). Antidepressant monotherapy vs sequential pharmacotherapy and mindfulness-based cognitive therapy, or placebo, for relapse prophylaxis in recurrent depression. *Archives of General Psychiatry*, 67(12), 1256-1264.

Segal, Z. V., Williams, J. M. G., & Teasdale, J. D. (2013). *Mindfulness-based cognitive therapy for depression* (2nd ed.). New York: Guilford Press.

Souza, I. C. W., Barros, V. V., Gomide, H. P., Miranda, T. C. M., Menezes, V. P., Kozasa, E. H., & Noto, A. R. (2015). Mindfulness-based interventions for the treatment of smoking: A systematic literature review. *The Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 21(3), 129-140.

UK Network for Mindfulness-Based Teacher Training Organisations. (2016). *Setting standards for - mindfulness-based teaching*. Retrieved from <http://www.mindfulnessteachersuk.org.uk/>

Vandenberghe, L., & Sousa, A. C. A. (2006). Mindfulness nas terapias cognitivas e comportamentais. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 2(1), 32-41.

Visted, E., Vøllestad, J., Nielsen, M. B., & Nielsen, G. H. (2015). The Impact of group-based mindfulness training on self-reported mindfulness: A systematic review and meta-analysis. *Mindfulness*, 6(3), 501-522.

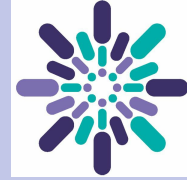
Wallace, R. K., Silver, J., Mills, P. J., Dillbeck, M. C., & Wagoner, D. E. (1983). Systolic blood pressure and long-term practice of the transcendental meditation and TM-sidhi program: Effects of TM on systolic blood pressure. *Psychosomatic Medicine*, 45(1), 41-46.

Weber, B., Jermann, F., Gex-Fabry, M., Nallet, A., Bondolfi, G., & Aubry, J. M. (2010). Mindfulness-based cognitive therapy for bipolar disorder: A feasibility trial. *European Psychiatry*, 25(6), 334-337.

Winbush, N. Y., Gross, C. R., & Kreitzer, M. (2007). The effect of mindfulness-based stress reduction on sleep disturbance: A systematic review. *Explore*, 3(6), 585-591.

Zamarra, J. W., Schneider, R. H., Besseghini, I., Robinson, D. K., & Salerno, J. W. (1996). Usefulness of the transcendental meditation program in the treatment of patients with coronary artery disease. *The American Journal of Cardiology*, 77(10), 867-870.

16



O TREINO DE CONTROLE DO ESTRESSE EM GRUPO: UM MODELO DA TCC

Marilda Lipp

O principal objetivo deste capítulo é fornecer ao leitor proficiência no uso de princípios cognitivo-comportamentais para o tratamento do estresse emocional em grupo. Será apresentada uma descrição pormenorizada do modelo de intervenção desenvolvido no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos do Stress da PUC-Campinas, cuja eficácia mutativa foi comprovada em várias pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado e trabalhos de conclusão de pós-doutorado. Devido a sua praticidade e curta duração, esse modelo, intitulado treino psicológico de controle do estresse (TCS), tem sido utilizado em várias instituições públicas, como Secretarias de Segurança Pública dos Estados de Mato Grosso, Tocantins e Sergipe e Tribunais de Justiça do Trabalho, bem como em

instituições hospitalares, principalmente para tratamento coadjuvante de hipertensos.

Este capítulo apresenta inicialmente noções essenciais para quem deseja trabalhar com o estresse emocional, identificando suas causas e consequências. A seguir, o TCS é apresentado em detalhes, sessão por sessão, com as informações necessárias para ser implementado em grupo. Como exemplo, é fornecido o relato de como ele foi realizado com um grupo de hipertensos, inclusive com verbalizações de pacientes que permitem avaliar a evolução das mudanças cognitivo-comportamentais que ocorreram. Ademais, o capítulo discute pesquisas clínico-experimentais que testaram a eficácia do TCS, para que o leitor possa avaliar seu embasamento científico.

O ESTRESSE E SUA CONCEITUALIZAÇÃO

A quinta edição do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-5) (American Psychiatric Association [APA], 2013) inclui classificações do estresse, como estresse agudo, estresse pós-traumático e transtornos de adaptação. Uma vez que as duas primeiras classificações estão sendo discutidas no capítulo sobre traumas e situações de crise, este capítulo abordará somente o transtorno de adaptação, comumente designado de “estresse”, definido pelo DSM-5 como “. . . a presença de sintomas emocionais ou comportamentais em resposta a um estressor identificável . . .” (APA, 2013, p. 287). O diagnóstico pode ser feito com ou sem depressão e/ou ansiedade, com perturbação da conduta ou, ainda, de modo inespecífico. De modo geral, quando se utiliza a terminologia “estresse”, estamos nos referindo ao transtorno de adaptação, e não ao estresse agudo ou pós-traumático.

Como definição, estresse é um estado de desequilíbrio do funcionamento desenvolvido diante de situações de desafio que levam o organismo a utilizar seus recursos psicobiológicos para lidar com eventos que exijam uma ação mobilizadora. É uma tentativa de vencer um desafio, de sobreviver a uma ameaça, real ou imaginária. Essencialmente, apresenta, em sua gênese, a necessidade do organismo de lidar com algo que ameaça sua homeostase ou

equilíbrio interno. Quando os recursos do momento são insuficientes devido a vulnerabilidade pessoal, ausência de estratégia de enfrentamento ou, ainda, gravidade ou intensidade do estressor presente, o organismo pode ser afetado em sua plenitude, com consequências graves para sua saúde física ou mental.

A reação do estresse é um processo complexo, com componentes psicobioquímicos já geneticamente programados no ser humano desde o seu nascimento, a fim de ajudá-lo a preservar sua vida. Foi o estresse, por meio de sua ação adrenérgica, que capacitou o homem a ficar vivo e se adaptar às mudanças pelas quais tem passado. É ele que permite a luta contra os estressores de cada época. Em doses moderadas, a adrenalina produzida aumenta a motivação, fornece energia e vigor e pode resultar em alta produtividade. Em doses excessivas, tem a capacidade de destruir e desequilibrar o funcionamento físico e mental (Lipp & Malagris, 1995, 2001).

ESTRESSORES

Os estressores podem ser classificados como externos e internos. Os primeiros são as circunstâncias da vida e do mundo que exigem da pessoa uma resposta de adaptação. Os outros são constituídos por eventos internos, nem sempre acessíveis às pessoas ao redor, mas que têm um enorme poder de afetar o funcionamento humano, entre eles as características de personalidade e as crenças irracionais, como proposto por Ellis (1973). Desse modo, o estresse pode ocorrer diante de estressores inerentemente negativos, como no caso de dor, fome, frio ou calor excessivo, ou devido à interpretação que se dá ao evento desafiador. Consequentemente, um mesmo evento pode desencadear ou não uma reação de estresse em pessoas diferentes, dependendo da interpretação que cada uma dá ao ocorrido, como vem postulando Lazarus desde 1966. Sugere-se que as atividades cognitivas usadas pelo indivíduo para interpretar eventos ambientais são fundamentais no processo do estresse, que se manifesta como o produto da intensa interação entre fatores externos e internos e a sensibilidade pessoal (Everly & Lating, 2013).

PREVALÊNCIA

O DSM-5 (APA, 2013) indica que a porcentagem de pessoas em tratamento psicológico com o diagnóstico de transtorno de adaptação varia entre 5 e 20%. Porém, pesquisas nacionais indicam que de 3 a 4 brasileiros em cada 10 têm sintomas significativos de estresse. O percentual de pessoas com esse diagnóstico aumentou significativamente, de 32%, em 1996 (Lipp, Pereira, & Muniz, 1996), para 35%, em 2015 (Lipp, 2015), usando o mesmo instrumento de avaliação.

O índice de afastamento por doenças relacionadas ao estresse nos trabalhadores brasileiros cresceu 28% no primeiro semestre de 2011, comparado ao primeiro semestre de 2010, de acordo com os dados do Boletim Estatístico da Previdência Social (Brasil 2011). A Previdência, no período de janeiro a junho de 2011, desembolsou R\$ 147 milhões em auxílio-doença para portadores de doenças relacionadas ao estresse emocional. Estima-se que o custo direto, contado em dias perdidos, seja de 27,2 dias de trabalho/ano por cada empregado com depressão, que frequentemente é um dos sintomas do estresse excessivo. Se o custo indireto desse transtorno for considerado, verifica-se que o empregado depressivo perde 5,5 horas por semana de tempo produtivo se comparado àquele que não tem depressão, o qual perde em torno de 1,5 hora semanal.

Depressão e estresse se confundem e tornam o diagnóstico diferencial muito difícil em certos momentos. Na verdade, a depressão, como sintoma do estresse, está relacionada às condições de adaptação do momento. Estresse, depressão e ansiedade estão tão interligados que se pode considerar que formam uma equação, em que as três variáveis devem ser consideradas em conjunto (Lipp, 2015).

EVOLUÇÃO DE MODELOS DE TRATAMENTO EM TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL

O dinamismo da evolução das terapias cognitivas pode ser comprovado ao se analisarem as múltiplas contribuições insurgentes ao longo dos anos em várias partes do mundo. Dos modelos tradicionais, puramente behavioristas,

considerados pioneiros na área, passando por autores como Ellis (1958) e Beck (1963), que acrescentaram outras dimensões ao modelo original, finalmente chegaram ao momento atual, representado pela “terceira onda” das terapias cognitivo-comportamentais (TCCs), exemplificada pelas teorias dos esquemas (Young, 2003), dialética (Linehan, 2010), de aceitação e compromisso (Hayes, 2004), metacognitiva (Wells, 2003) e cognitiva processual (Oliveira, 2013), isso para citar somente algumas. Verifica-se, nesse quadro evolutivo, o aparecimento de modelos específicos para tratamento de transtornos mentais mais desafiadores, como depressão resistente (Fava, 1999), transtornos da personalidade (Young, 2003), fobias (Rangé, 2008), transtorno da personalidade *borderline* (Linehan, 2010), transtorno de pânico (Rangé, 2008), entre outros, de grande relevância e importância para a atuação de clínicos sempre em busca de ferramentas e compreensão subjacentes às disfunções e aos transtornos que acometem seus pacientes. O mesmo ocorreu na área do estresse emocional, com a inovação do treino de controle do estresse (Lipp, 1984).

O TCS COMO MODELO COGNITIVO PARA TRATAMENTO EM GRUPO

Devido à associação do estresse com doenças tanto fisiológicas como mentais, torna-se útil entender como prevenir e tratar o estresse emocional, tão prevalente na população. Como o estresse é produto da intensa interação entre fatores externos e internos, e a sensibilidade a ele decorre, na grande maioria dos casos, da interpretação cognitiva atribuída aos eventos, o tratamento medicamentoso não é eficaz para eliminá-lo; o máximo que consegue obter é uma redução da sintomatologia, uma vez que a causa continua a existir. Assim, é indispensável o tratamento psicológico que produza uma reestruturação cognitiva e que expanda o repertório comportamental e emocional da pessoa para lidar com os estressores. Logicamente, o tratamento médico é igualmente importante em casos de sintomatologia já estabelecida.

Em 1984, foi publicado um artigo (Lipp, 1984) sobre um modelo de tratamento do estresse designado “treino de controle do estresse”, elaborado com base no treino de inoculação de estresse, de Meichenbaun (1985), na terapia racional-emotiva, de Ellis (1973), e em dados e observações de vários anos de pesquisa clínica sobre estresse e estilos de vida estressantes.

Analisando os componentes e procedimentos que formam esse sistema de tratamento, verifica-se que sua base teórica e prática pertence ao âmbito da TCC. Com base em pesquisas no Laboratório de Estudos Psicofisiológicos da PUC-Campinas, o TCS foi aprimorado, e, em 1995, Lipp e Malagris publicaram um guia para o tratamento cognitivo-comportamental do estresse em adultos, trabalho que foi refinado em 2001 pelas mesmas autoras (Lipp & Malagris, 2001). A pedra fundamental do TCS é a identificação e a modificação das fontes internas de estresse por meio de uma reestruturação cognitiva. O pressuposto do TCS é o de que modos estereotipados, inflexíveis e ilógicos de pensar poderiam ser fontes geradoras de conflitos, de estresse e de distúrbios emocionais e/ou transtornos mentais capazes de produzir doenças psicofisiológicas, dependendo das vulnerabilidades genéticas existentes, ideia essa ventilada por Everly e Lating (2013).

O PROTOCOLO DA TCC PARA TRATAMENTO DO ESTRESSE

O protocolo de TCS inclui de 8 a 12 sessões semanais, cada uma com duração de 2 horas. O número máximo recomendado de participantes é 10, de modo a se permitir tempo suficiente para a discussão de todos os tópicos. Não se permite a entrada de novos participantes após o início, e aqueles que faltarem a mais de duas sessões são eliminados do grupo e convidados a fazer o tratamento no formato individual.

O protocolo consiste em tratamento focal de duração breve, de caráter psicoeducativo, que inclui biblioterapia na forma de leitura de textos inclusos em dois livros (*Stress ao longo da vida* e *Sentimentos que causam stress*), os quais são fornecidos ao paciente e cobrem o tópico discutido no dia. Desse modo, quando se aborda um tema como, por exemplo, ansiedade e seu

controle, o texto fornecido é sobre ansiedade. Uma pasta plastificada é fornecida no início das sessões para o arquivo gradual dos textos. Solicita-se que o participante guarde e leia periodicamente o material fornecido, mesmo após a conclusão do tratamento, para garantir a continuidade das mudanças terapêuticas.

PRÉ-TRATAMENTO

O pré-tratamento ocorre antes da primeira sessão grupal. Realiza-se uma avaliação psicológica individual com o objetivo de confirmar o diagnóstico de estresse, mapear e conduzir uma análise funcional dos estressores internos e externos presentes e averiguar quais estratégias de enfrentamento são utilizadas pelo respondente.

O diagnóstico diferencial de estresse e de outra patologia nem sempre é fácil. Naturalmente, o diagnóstico do estresse é não exclusivo, sendo possível encontrá-lo em pessoas psicóticas, depressivas, suicidas, enfermas, e como uma comorbidade. Devido ao fato de o estresse ter o potencial de agravar outras patologias, toda vez que ele se encontrar presente, deve ser tratado concomitantemente às outras dificuldades. Não é adequado tratar somente o outro problema, pois, muitas vezes, sem que o estresse seja eliminado, a probabilidade de o quadro subjacente melhorar torna-se menor.

Uma boa fonte de informação para um diagnóstico diferencial é o Manual do Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (Lipp, 2000), que oferece uma breve revisão de como o estresse pode ser avaliado. O Inventário de Sintomas de Stress para Adultos (ISSL) é um teste brasileiro, validado em 1994 por Lipp e Guevara e padronizado por Lipp (2000). Trata-se do único teste de estresse para adultos referenciado pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP). Pode ser administrado em cerca de 10 minutos e tem sido utilizado em dezenas de pesquisas e trabalhos clínicos e organizacionais na área do estresse. Permite diagnosticar precisamente a condição, determinar em qual fase do estresse a pessoa se encontra e se, para ela, o problema se manifesta por meio de sintomatologia na área física ou psicológica, o que pode viabilizar uma atenção preventiva em momentos de maior tensão. Como já abordado, o diagnóstico diferencial de estresse e de outra patologia pode

ser difícil. Os detalhes e testes usados nessa avaliação podem ser encontrados em Lipp (2015).

CRITÉRIOS DE INCLUSÃO NO GRUPO

Constituem critérios de inclusão no grupo ter o diagnóstico de estresse, demonstrar motivação para mudar, ter capacidade intelectual para entender os procedimentos, concordar com os objetivos do tratamento e não estar em surto psicótico. Caso a avaliação psicológica indique ausência de estresse ou a presença de alguma condição impeditiva do tratamento em grupo, o paciente deve ser direcionado para uma terapia individual.

OBJETIVOS DO TCS EM GRUPO

De modo geral, por meio de mudanças cognitivas, o tratamento objetiva mudar padrões de comportamentos potencialmente nocivos em quatro áreas que se constituem os pilares do TCS: nutrição contra o estresse, relaxamento da tensão mental e física, exercício físico e regulação emocional. Especificamente, o TCS objetiva levar o participante do grupo a:

1. entender o que é o estresse e identificar seus sintomas de modo que passe a perceber quando sua sobrecarga de tensão está chegando a um ponto crítico
2. reconhecer fontes de estresse em potencial (internas e externas) e tentar eliminar as que forem passíveis de mudança
3. reestruturar a maneira de pensar e de ver o mundo, de forma a eliminar algumas fontes internas ligadas ao modo típico de reagir aos desafios
4. lidar com a ansiedade a fim de eliminar essa fonte interna
5. ser assertivo, sem experimentar desconforto ou se estressar
6. aprender a reduzir a excitabilidade emocional e física por meio da prática de respiração profunda e relaxamento
7. adquirir técnicas de manejo do estresse para serem utilizadas em situações conflitivas que não possam ser evitadas
8. utilizar o estresse a seu favor para atingir adequados níveis de produtividade e criatividade

9. reconhecer os próprios limites e aprender a respeitá-los
10. estabelecer prioridades e melhorar a qualidade de vida em geral

TERAPEUTA E COTERAPEUTA

Embora o grupo possa ser conduzido por somente um terapeuta, o ideal é que se possa contar com a participação de um coterapeuta, que se encarrega da verificação das tarefas de casa, auxilia nos exercícios de relaxamento, anota o desenvolvimento das sessões e cuida dos agendamentos. O coterapeuta auxilia também na psicoeducação que é realizada durante o tratamento.

PLANEJAMENTO DAS SESSÕES

As sessões são previamente planejadas, obedecendo a uma ordem pré-determinada no protocolo do TCS, sintetizado no Quadro 16.1; permite-se, no entanto, discussão atenciosa de assuntos trazidos pelos membros do grupo. Como se trata de uma terapia focal de tempo limitado, o tópico previsto para a sessão tem de ser abordado necessariamente conforme agendado, ainda que se abra espaço para a discussão de outras preocupações trazidas pelos participantes.

PROCEDIMENTOS DO TCS EM GRUPO

Após a constatação do diagnóstico de estresse e sua sintomatologia, o próximo passo é levar cada participante a identificar as fontes externas e internas de estresse presentes. A seguir, é necessário que a pessoa se disponha a tomar medidas para eliminar os estressores encontrados. Muitas vezes, as fontes externas são essenciais e não podem ser eliminadas, como uma doença na família, por exemplo. Outras vezes, a pessoa reconhece que o estresse vem do modo como ela se relaciona com o mundo ao seu redor, de suas suspeitas exageradas, de seu negativismo, e sabe que precisa mudar seu modo de ser, mas não consegue fazê-lo sem ajuda terapêutica. O que fazer nessas situações em que a fonte principal de estresse não pode ser mudada, pelo menos não de imediato?

O estresse dificilmente é causado por uma única fonte. Na maioria das vezes, sofremos o efeito cumulativo de inúmeros estressores que se somam

para criar o estado de tensão mental e física. Quando não se consegue eliminar a fonte principal, o TCS envolve tentar eliminar outras fontes, mesmo que não tão importantes, porque a carga tensional a elas associada é subtraída da quantidade total do estresse que estamos experimentando, e nosso organismo fica sujeito a níveis menores de tensão no total. Se a causa do estresse não pode ser eliminada, leva-se o paciente a entender que precisa aceitá-la e abrir espaço em sua vida para ela.

A aceitação deve ser utilizada como estratégia de manejo do estresse somente após uma análise muito bem feita sobre se, de fato, o estressor é inevitável e importante. Se o for, o psicoterapeuta deve ajudar o paciente a aceitar sua inevitabilidade enquanto não se pode fazer nada. Aceitar o inevitável é parte do manejo do estresse, de modo a não se gastar energia e tempo naquilo que, pelo menos no momento, não pode ser mudado.

Em situações em que se torna necessário aceitar o estressor que não é possível eliminar, soluções criativas para com ele lidar se tornam eficazes. Nesse caso, estamos nos referindo a estratégias de enfrentamento, ou *coping*: rir, dramatizar, usar o bom humor, prever antecipadamente como será a interação com ele, distanciar-se emocionalmente, deixar fluir a força interior (que sempre existe dentro de cada um e que nos ampara e impulsiona para a frente), planejar como lidar com o estressor e tentar ver seu lado positivo. Acima de tudo, deve-se lembrar que, se um determinado estressor não pode ser eliminado, é porque ele está proporcionando alguma coisa positiva à vida do indivíduo. Deve-se levar o paciente a capitalizar emocionalmente esses aspectos que agregam valor ao estressor, inclusive a tratá-lo com carinho, pois, se ele é tão importante para ser mantido, deve receber a atenção necessária.

Para buscar a solução do problema, é importante analisar as cognições, ou seja, o modo de pensar do paciente e o quanto isso pode prejudicá-lo. Identificadas as cognições estressantes e perturbadoras, o próximo passo é questionar sua validade.

PSICOEDUCAÇÃO (15 MINUTOS)

O TCS tem caráter educativo, de modo que em todos os encontros o terapeuta esclarece e informa os presentes sobre conceitos cognitivos e técnicas que são abordadas. O porquê das tarefas de casa também é elucidado na hora em que são repassadas e também na sessão seguinte, quando são verificadas. Utilizam-se biblioterapia e discussão aberta dos pensamentos disfuncionais, que podem estar atuando como fontes internas de estresse. O paciente é levado a assumir uma postura ativa em seu tratamento.

TAREFAS DE CASA (20 MINUTOS)

As tarefas de casa semanais são planejadas pelo terapeuta de acordo com o protocolo do TCS. Cada encontro se inicia com a verificação da tarefa de casa e a discussão das possíveis dificuldades encontradas, reforçando-se os sucessos e oferecendo alternativas para as dificuldades. Os comentários elogiosos dos colegas, incentivados pelo terapeuta, se constituem em um poderoso reforço para quem cumpriu a tarefa da semana e incentivam aqueles que não as cumpriram a tentar fazê-lo. É solicitado que cada um continue a monitorar seguidamente suas observações no dia a dia, mesmo que a tarefa da semana seja outra, de modo que haja uma somatória gradual de observações e medidas mutativas.

VIVÊNCIAS (15 MINUTOS)

Exercícios práticos, como sessões de *role-playing* dramatizando as situações mais difíceis encontradas pelos presentes, são realizados com a participação voluntária de outros membros. Esses exercícios são de grande utilidade para acelerar a compreensão de como os estressores atuam na forma de gatilhos para a reação do estresse e, principalmente, para expandir o repertório comportamental daqueles que não têm estratégias de enfrentamento.

INÍCIO DE CADA ENCONTRO (15 MINUTOS)

Após verificação da tarefa de casa, o terapeuta informa o tópico do dia e solicita que o grupo fale de suas vivências sobre o assunto. Ele guia a discussão direcionando as experiências de vida trazidas pelos participantes para o tópico previsto como tema do dia.

FEEDBACK DOS PARTICIPANTES (10 MINUTOS)

Em todas as sessões do grupo, os participantes são incentivados a expressar sua opinião a respeito do que foi abordado e de como poderão utilizar o que foi discutido até o momento em seu dia a dia.

FINALIZAÇÃO DE CADA ENCONTRO (10 MINUTOS)

Ao término de cada sessão, o terapeuta faz um breve resumo do que foi discutido, elogia o grupo pela dedicação ao tratamento, explica a próxima tarefa de casa e incentiva que os participantes continuem com as tarefas anteriores.

DINÂMICA DO ENCONTRO (35 MINUTOS)

A sessão é conduzida tendo por tópico o assunto do dia de acordo com o protocolo terapêutico sintetizado no Quadro 16.1. A descrição das sessões, apresentada no Quadro 16.2, exemplifica como esse conteúdo é repassado no grupo.

Quadro 16.1 Síntese dos componentes do treino de controle do estresse

I. Avaliação pré-tratamento

- Avaliação do nível e da sintomatologia do estresse
- Avaliação de estressores externos e autoproduzidos
- Avaliação das estratégias de enfrentamento utilizadas pelo avaliado

II. O TCS inclui:

- Psicoeducação sobre estresse, estressores e sintomas de estresse
- Sintomas fisiológicos do estresse excessivo
- Sintomas psicológicos do estresse excessivo
- Estratégias de enfrentamento: como lidar com o estresse para redução da excitabilidade física gerada pelo estresse (respiração profunda e relaxamento)
- Fontes externas de estresse e limites pessoais
- Como lidar com mudanças e a importância do exercício físico e da alimentação
- Estratégias de enfrentamento: como lidar com o estresse para redução da excitabilidade emocional (reestruturação cognitiva)
- Crenças irracionais e como geram estresse e ansiedade
- Mudança no estilo cognitivo. As crenças irracionais como estressores e causas da ansiedade.
- Inassertividade, irritabilidade e raiva
- Autocontrole emocional; qualidade de vida: o que a afeta e como melhorá-la
- Plano de prevenção de recaída, avaliação e fechamento

Quadro 16.2 Plano de tratamento das 12 sessões

Pré-tratamento

Entrevista inicial, testagem e avaliação. A sessão visa estabelecer o nível de estresse (aplicar o ISSL) e a fase em que a pessoa se encontra. Procede-se ao levantamento das fontes externas de estresse, ou seja, eventos maiores que tenham ocorrido recentemente, estressores existentes na área profissional, afetiva, da saúde e social de modo livre, deixando a pessoa falar livremente, mas guiando o relato para a identificação dos estressores.

O objetivo é determinar se a pessoa se beneficiaria do TCS, se ela se dispõe a proceder a mudanças em seu estilo de vida e se é uma boa candidata ao tipo de tratamento oferecido. Se o caso não for estresse, a pessoa é encaminhada para outro tratamento. Se parecer atender aos critérios, ela é aceita no grupo.

Tratamento

Comum a todas as sessões: tarefa de casa, exercícios práticos e avaliação do encontro feita pelo terapeuta e membros do grupo. É fornecida uma folha de resposta para anotação da tarefa de casa.

SESSÃO 1

Explicam-se as normas que regerão os encontros, enfatizando-se que, devido ao número pequeno de encontros, não é permitido faltar mais do que duas vezes. É explicado que o grupo é psicoeducativo, com um planejamento pré-agendado incluindo temas pertinentes. A importância da tarefa de casa é enfatizada.

Tema do dia: Passam-se princípios básicos sobre o que é estresse e estressores. Fala-se da importância dos hábitos de vida saudáveis e da armadilha de hábitos inadequados. Nesta sessão, é importante analisar se a pessoa está mesmo disposta a mudar alguns hábitos de vida que possam estar prejudicando-lhe.

Tarefa de casa: Identificação de situações estressantes e de como os participantes lidaram com elas. É distribuída uma folha de observação com três colunas, para anotarem: “estressor”, “o que fiz diante dele” e “como me senti diante do que fiz”.

SESSÃO 2

Pede-se registro de eventos estressantes que ocorreram durante a semana anterior e estratégias utilizadas. O material trazido pelos membros é discutido em grupo. O encontro visa analisar as fontes internas presentes na forma de inassertividade e crenças irracionais que possam existir. Avaliam-se também estratégias mentais utilizadas geralmente em momentos de tensão.

Tema do dia: Sintomas fisiológicos do estresse excessivo e a importância do exercício físico e da alimentação (Usar o livro *Stress ao longo da vida* como roteiro, p. 79-85, Lipp, Malagris, & Novais, 2007).

A identificação da sintomatologia do estresse, embora essencial, não é suficiente para que um plano terapêutico possa ser delineado pelo psicólogo. Torna-se necessário identificar as fontes de estresse às quais a pessoa está sujeita. As fontes externas de estresse são facilmente identificadas pelo próprio paciente, que muitas vezes já vem ao consultório com uma lista de situações e pessoas que o estão preocupando. Muitas dessas fontes escapam ao controle do psicólogo e do próprio paciente, mas sua identificação é importante, pois servirá para que estratégias de enfrentamento, adequadas a sua natureza, sejam desenvolvidas, após uma tentativa de se eliminar as que estejam dentro do controle do paciente. O trabalho do psicólogo ganha relevância maior quando os estressores internos são identificados. Por estressores internos estamos nos referindo a valores inadequados, distorções cognitivas, expectativas infundadas, padrões de comportamento competitivos, agressivos e ligados a premência de tempo, falta de assertividade, tendência à ansiedade ou à depressão e padrões de respostas emocionais ligados a experiências passadas. Somente após o diagnóstico dos sintomas e a identificação das fontes externas e internas de estresse é que o plano terapêutico para o estresse deve ser elaborado.

Tarefa de casa: Registrar sintomas físicos que notaram em si mesmos em momentos de tensão.

Biblioterapia: Sugere-se a leitura de parte do livro *Stress ao longo da vida* (Lipp et al., 2007, p. 19-22).

SESSÃO 3

Verifica-se se a pessoa manteve registro dos sintomas fisiológicos durante os eventos estressantes da semana. Isso fornece uma amostragem do comprometimento dela diante do tratamento e a seriedade do problema que está enfrentando.

Tema do encontro: Sintomas psicológicos do estresse.

O encontro termina com um exercício de relaxamento e respiração profunda.

Tarefa de casa:

- Praticar o exercício de relaxamento e respiração profunda, anotando como se sentia antes e após sua realização.
- Registrar sintomas psicológicos que notaram em si mesmos em momentos de tensão.

Biblioterapia: Sugere-se a leitura de parte do livro *Stress ao longo da vida* (Lipp et al., 2007, p. 23-26).

SESSÃO 4

Verifica-se tarefa de casa e discute-se o que foi trazido pelo grupo.

Tema do dia: Estratégias de enfrentamento para redução da excitabilidade fisiológica causada pelo estresse (técnicas de como lidar com o estresse).

Discutem-se os 21 passos para lidar com o estresse presentes no livro *Stress ao longo da vida* (Lipp et al., 2007, p. 109-110).

O encontro termina com um exercício de relaxamento e respiração profunda.

Tarefa de casa: 1. Praticar o exercício de relaxamento e respiração profunda, anotando como se sentia antes e após sua realização.

Biblioterapia: É dada a apostila “Como controlar o stress”, inclusa no Manual do Inventário de Sintomas do Stress.

SESSÃO 5

Temas do dia: 1. Fontes externas de estresse e 2. Limites pessoais.

Discute-se o conceito do limite pessoal para tensão e explica-se por que o primeiro passo para controlar o estresse é saber reconhecer seus sintomas e os estressores. Fontes externas são discutidas até o paciente entender a necessidade de ou eliminá-las, ou se adaptar a elas. Técnicas de relaxamento e respiração profunda são praticadas na sessão.

Tarefa de casa:

- Praticar o exercício de relaxamento e respiração profunda.
- Identificar os estressores externos e a resposta física e emocional que teve ao lidar com eles, identificando seu limite pessoal.

Biblioterapia: Sugere-se a leitura de parte do livro *Stress ao longo da vida* (Lipp et al., 2007, p. 33-34).

SESSÃO 6

Tema do dia: 1. Como lidar com mudanças.

Discute-se como o pensamento afeta o modo de lidarmos com as mudanças e como lidar com elas sem se estressar, enfatizando a necessidade de se manter a mente aberta para tudo na vida. Explica-se que toda mudança gera estresse, mas que o pensamento e a interpretação afetam o nível de estresse a ser experimentado.

Realiza-se exercício de relaxamento e respiração profunda.

Tarefa de casa:

- Praticar o exercício de relaxamento e respiração profunda.
- Anotar mudanças que já ocorreram na vida e como o indivíduo as interpretou e sentiu. Imaginar como poderia ter pensado e como se sentiria se esse pensamento fosse mais positivo.

Biblioterapia: Sugere-se a leitura de parte do livro *Stress ao longo da vida* (Lipp et al., 2007, p. 94-103).

SESSÃO 7

Temas do dia: 1. Influência do fator cognitivo. 2. Ansiedade. 3. Estratégias de enfrentamento para redução da excitabilidade emocional causada pelo estresse (técnicas de como lidar com o estresse).

Discutir como o pensamento inadequado pode levar a uma série de sentimentos negativos, como raiva, mágoa, ansiedade, etc.

Tarefa de casa: Anotar como interpretou situações que ocorreram e como os sentimentos que teve foram influenciados por essa interpretação.

Biblioterapia: Sugere-se a leitura de parte do livro *Sentimentos que geram stress* (Lipp, 2009).

SESSÃO 8

Tema do dia: Crenças irracionais. Enfatiza-se como os pensamentos geram estresse e ansiedade.

Exercício de *role-playing* sobre reestruturação cognitiva.

Tarefa de casa: Anotar crenças irracionais que tenha identificado em si mesmo.

Biblioterapia: Sugere-se a leitura de parte do livro *Sentimentos que geram stress* (Lipp, 2009).

SESSÃO 9

Tema do dia: Continuação de reestruturação cognitiva.

Exercício de *role-playing* sobre reestruturação cognitiva de uma crença trazida pelo grupo.

Tarefa de casa: Anotar crenças irracionais identificadas em si mesmo.

SESSÃO 10

Tema do dia: Assertividade, irritabilidade e raiva.

Discute-se a diferença entre inassertividade, assertividade e agressividade. Discute-se como a irritação e a raiva podem surgir quando a pessoa está estressada.

Exercício: Exemplos dados pelo grupo de cada uma dessas situações e de alternativas.

Tarefa de casa: Anotar situações em que a inassertividade levou a irritabilidade e raiva.

Biblioterapia: Sugere-se a leitura de parte do livro *O TCC da raiva* (Lipp & Malagris, 2010).

SESSÃO 11

Temas do dia: 1. Autocontrole emocional e 2. Qualidade de vida.

Discute-se a importância de se aprender a controlar as emoções por meio de mudanças cognitivas. Discute-se o conceito de qualidade de vida e como esta é afetada pela falta de estratégias de manejo do estresse.

Exercício de respiração profunda e relaxamento.

Tarefa de casa: Anotar o que mais gostaria de discutir no grupo e o que mudou em sua vida com o que aprendeu nas sessões.

SESSÃO 12

Fechamento. Reavaliação do quadro sintomatológico do estresse aplicando-se o ISSL, que é corrigido na hora pelo coterapeuta de modo a se verificar se os objetivos do grupo foram preenchidos. Reflexão sobre o tratamento e mudanças realizadas. Todos do grupo têm a oportunidade de brevemente dar o parecer sobre o TCS que foi conduzido. Elaboração de um plano de prevenção de recaída. Terapeuta e coterapeuta parabenizam o grupo pelas mudanças alcançadas.

Tarefa de casa: Continuar a fazer os exercícios de mudança de pensamentos estressantes, praticar relaxamento e as outras estratégias de enfrentamento desenvolvidas.

PLANO DE PREVENÇÃO DE RECAÍDA

Um plano de prevenção de recaída é sempre elaborado antes da sessão final com base nas dificuldades de enfrentamento que o grupo demonstrou ter diante de certas situações mais desafiadoras. A prevenção de recaída é essencial, pois hábitos novos não destroem os antigos com facilidade, e é necessário que se garanta a prática de novos comportamentos a fim de que eles sejam realmente incorporados ao repertório do paciente. Quando os problemas transcendem o âmbito do estresse, a psicoterapia em TCC é recomendada como uma alternativa.

O Quadro 16.1 apresenta uma síntese dos procedimentos clínicos do TCS em grupo.

Adaptações do TCS têm sido realizadas dependendo da necessidade da população a ser atendida, como, por exemplo, a que foi realizada para pacientes hipertensos (Lipp, 2007). Essa adaptação é descrita a seguir.

O TREINO PSICOLÓGICO DE CONTROLE DO STRESS PARA HIPERTENSOS (TCS-H)

O TCS-H é uma adaptação do treino de controle do estresse de Lipp, que pode ser utilizado por todos, com ou sem pressão alta, e é composto de quatro pilares: relaxamento, alimentação contra estresse, exercício físico e promoção da estabilidade psicológica. A fim de entender o valor do TCS-H, é importante lembrar como o estresse pode afetar a pressão arterial. Sabe-se que qualquer variação no débito cardíaco ou na resistência periférica é suficiente para produzir mudanças na pressão arterial. A ação do estresse assume relevância, pois, por meio da estimulação do sistema nervoso simpático, ele causa liberação de catecolaminas, que, por sua vez, produzem constrição dos vasos sanguíneos, fazendo a resistência periférica aumentar. Ao mesmo tempo, o estresse afeta também o ritmo cardíaco e a quantidade de sangue expelida pelo coração a cada batimento, isto é, o débito cardíaco. Esses aumentos, no entanto, não necessariamente significam hipertensão, pois, na maioria das vezes, trata-se somente de certa reatividade pressórica que o organismo controla, fazendo a pressão voltar ao normal logo após o evento que causou o estresse ser afastado. Entretanto, nos casos em que o estresse não tem término, ou é de grande intensidade e importância para a pessoa, ou, ainda em situações em que se esteja sujeito a inúmeros estressores, a autorregulação não ocorre, e a pressão continua alta. Alguns especialistas acreditam que, se houver grande reatividade com muita frequência, a hipertensão poderá se desenvolver ou se agravar (hipótese da reatividade). Por isso é tão importante que todo hipertenso aprenda a controlar o estresse emocional.

Os objetivos do TCS para hipertensos são:

1. reduzir a excitabilidade física e mental do hipertenso ante confrontos estressantes que ocorrem no decorrer de sua vida
2. eliminar/reduzir fontes internas de estresse na forma das características psicológicas identificadas, como pressa excessiva, perfeccionismo, inassertividade e raiva

3. adquirir estratégias de enfrentamento das fontes externas de estresse da vida diária
4. promover a noção de que a responsabilidade pela própria vida é indelegável, e, portanto, compete a cada um cuidar de sua saúde
5. promover adesão ao tratamento farmacológico
6. promover melhora do nível de qualidade de vida por meio de uma mudança de hábitos de vida

PROTOCOLO DO TCS PARA HIPERTENSOS (TCS-H)

Sessão 1: Apresentação dos membros do grupo, com cada um relatando algo sobre sua vida relacionado principalmente a sua saúde. Explicação de como a saúde pode ser afetada pelo estresse. Fazer a relação entre os sintomas que o grupo apresenta e o estresse. Explicação dos fundamentos do tratamento que será feito. Discute-se a importância dos hábitos de vida e a necessidade de mudar para viver com qualidade. Dinâmica: o teste da vida.

Tarefa de casa: Fazer uma lista do que poderia mudar para melhorar a saúde.

Sessão 2: Verificar o que as pessoas trouxeram como metas para mudar e melhorar a saúde. Registrar o que cada membro do grupo estabeleceu como objetivo para, no fim do tratamento, poder verificar mudanças que venham a ocorrer em função da terapia. Pedir que assinem um autocontrato para mudança. Explicar que o nosso modo de agir depende de como percebemos (interpretamos) um determinado evento. Dar noções do modelo ABC.

Explicar o que é estresse. Explicar os quatro pilares do controle do estresse (relaxamento, exercício físico, alimentação contra estresse e os princípios psicológicos pertinentes).

Dinâmica: Demonstração de como o estresse afeta nossa respiração. Exercício de respiração profunda e relaxamento.

Tarefa de casa: Fazer relaxamento todos os dias.

Sessão 3: Lembrar o autocontrato de cada um. Lembrar o modelo ABC.

Cuidados nutricionais necessários. Discutem-se fatores de risco: hipertensão, glicemia elevada, colesterol, triglicerídeos, circunferência

abdominal.

Discutir como o estresse, principalmente o estresse social, pode afetar o funcionamento humano. Verificar se lembram de quais são os pilares do controle do estresse. Levar o grupo a refletir sobre o que deve mudar em sua vida (os hábitos inadequados) para lidar melhor com o estresse. Exercício de respiração profunda e relaxamento.

Tarefas de casa: (1) Fazer relaxamento todos os dias e (2) anotar o que estava ocorrendo quando se sentiu estressado, colocando como se sentiu e como reagiu. Colocar o que resultou do modo de reagir (modelo ABC).

Sessão 4: A importância do exercício físico. Discussão de como as interações sociais podem criar estresse porque às vezes são interpretadas de modo negativo. Os participantes falam sobre seus estressores sociais e sua maneira típica de lidar com o estresse. Discutir a raiva e a técnica da ação responsável. A assertividade como técnica de controle do estresse. Exercícios de respiração profunda e relaxamento.

Tarefas de casa: (1) Fazer relaxamento todos os dias, (2) anotar como as relações interpessoais foram interpretadas positiva e negativamente durante a semana, além de como se sentiu nessas situações.

Sessão 5: Perguntar sobre o uso de exercício físico, alimentação e relaxamento durante a semana. Discutir o que causa estresse nas pessoas. Fontes externas e internas de estresse: o modo de pensar, a pressa, crenças e valores. Exercícios de respiração profunda e relaxamento. Exercícios do boneco de pano e *role-playing* da pressa.

Tarefa de casa: Fazer relaxamento todos os dias.

Sessão 6: Verificar tarefa de casa sobre exercício físico, alimentação e relaxamento durante a semana. Explicar novamente como o que se pensa afeta o organismo. Discutir como o medo de perder o amor dos outros, a vontade de ser sempre aceito e o temor de parecer “fraco” podem afetar o organismo. A necessidade de prestar atenção às mensagens do corpo. As prioridades da vida. Enfatizar os quatro pilares. Verificar como estão os

planos de mudança de cada um e o que estão fazendo para realizá-los. Exercício de respiração profunda e relaxamento.

Tarefa de casa: Fazer relaxamento todos os dias.

Sessão 7: Perguntar sobre exercício físico, alimentação e relaxamento durante a semana. Incentivar o grupo a descrever episódios de estresse e raiva criados pelo modo de pensar de cada um e seus efeitos no corpo. Como teriam reagido se tivessem pensado diferente? Discutir hábitos de vida em mais detalhes. Quais hábitos já mudaram? Como estão seus fatores de risco? Exercício de respiração profunda e relaxamento.

Tarefa de casa: Fazer relaxamento todos os dias e observar interpretações de fatos que o afetam.

Sessão 8: O que mudou na vida dos participantes em virtude do que aprenderam no grupo? O que pretendem mudar? Quais pilares do controle do estresse estão usando? Rever conceitos de estresse, afetividade, assertividade e fatores de risco, bem como os hábitos de vida. Enfatizar que cada pessoa tem responsabilidade sobre sua vida e sua saúde. A doença crônica é “uma fera” que tem de ser mantida na jaula. Esclarecer dúvidas. Exercícios de respiração profunda e relaxamento. Fechamento.

Em geral, o hipertenso mostra picos de pressão arterial em momentos de estresse (Lipp & Malagris, 2001), mas esses picos podem ser reduzidos com o TCS-H, como pode ser visto na Figura 16.1. Pode-se constatar que pacientes hipertensos do grupo que recebeu o TCS no estudo de Lipp (2007) tiveram menor reatividade da pressão arterial média após o tratamento do estresse em vários momentos da sessão experimental, que envolvia interações interpessoais conflituosas e estressantes, sendo que cada conjunto de duas barras representa a reatividade da pressão arterial média em cada cena estressante. Note-se que o primeiro par de barras, designado “LB” (com valores idênticos), se refere a uma linha de base e representa somente a reação de estar no laboratório esperando o experimento começar. O último par de barras se refere ao período imediato ao fim do estudo, quando os pacientes tratados mostram redução da pressão arterial, o que mostra que estavam sabendo controlar as emoções de modo mais eficaz.

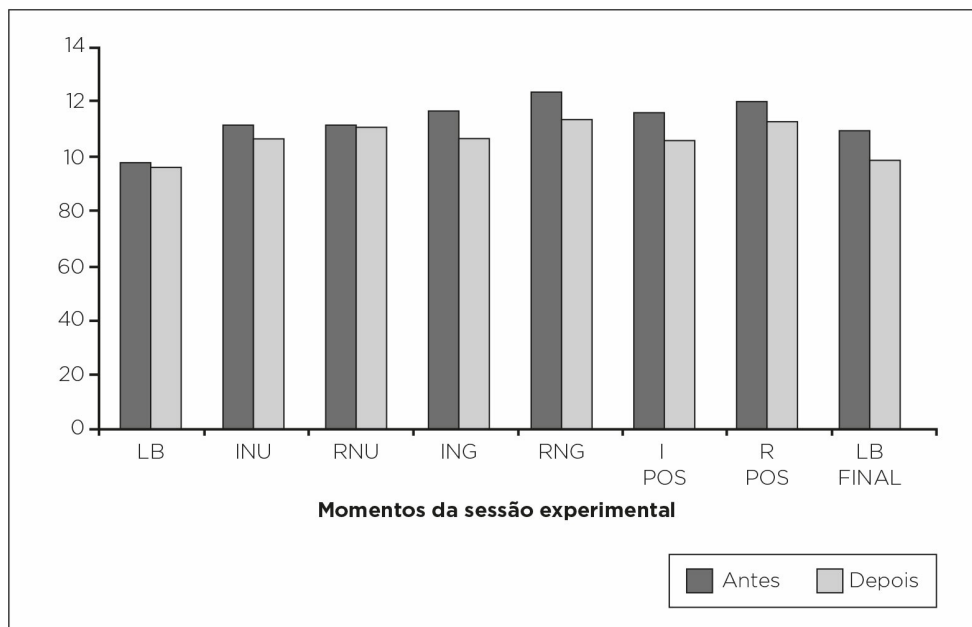


Figura 16.1 Resultados do TCS em hipertenso pré e pós-intervenção.

LB: linha de base; INU: instruções das cenas neutras; RNU: respostas das cenas neutras; ING: instruções das cenas negativas; RNG: respostas das cenas negativas; I POS: instruções das cenas positivas; R POS: respostas das cenas positivas.

Além da medida fisiológica da eficácia do TCS, verbalizações dos participantes registradas durante o treino confirmam esse dado. Vários grupos de hipertensos já passaram por esse tratamento. No caso em pauta, o grupo foi constituído por 10 mulheres, na faixa etária de 45 a 55 anos, de nível socioeconômico baixo, que faziam tratamento para hipertensão em um hospital-escola do interior de São Paulo. A partir da terceira sessão de treinamento, as participantes começaram a verbalizar mudanças no seu modo de agir e sentir, como segue (com nomes fictícios):

Mariana: “Meu marido está surpreso comigo, diz que o grupo está me fazendo bem, porque não me alterei quando a vizinha veio reclamar por meu cachorro latir muito. Antes eu teria brigado com ela e dito uns desaforos e depois ia ficar passando mal, assim, evitei ter que tomar mais remédios para me acalmar.” (Na sessão 4)

Fátima: “Falei para minha filha lavar os pratos, ela sempre deixa tudo para mim e faço, mas reclamo muito. Dessa vez fui lá e disse: ‘Filha, o grupo

está me ensinando a defender meus direitos. Não vou lavar mais essa louça, pois já cozinhei e fiz tudo hoje. Vamos fazer sempre assim, quem cozinha não lava a louça. Hoje é seu dia’. Não me alterei... e não me estressei.” (Na sessão 5)

Nair: “Nossa, nem posso acreditar, esse grupo está me dando um jeito. Olha, antes cada vez que minha patroa dizia para eu passar uma roupa de novo, eu achava que ela estava me dando a bronca e minha pressão chegava a subir. Ontem ela fez isso e eu pensei diferente do que costumava pensar. Falei para mim mesma: ela tem o direito de querer a roupa do jeito dela. Estou aqui para trabalhar e não vou me incomodar. Disse para ela: ‘Pois não!’ E fiz o que ela pedia sem fazer cara feia. Não é que ela me agradeceu? Mudei meu pensamento e deu certo, não fiquei nervosa.” (Na sessão 7)

Odete: “Ainda acho difícil não me estressar, mas já entendi que ficar estressada por ter que cuidar de minha mãe doente não vai adiantar mesmo. Ela é importante pra mim, já fez muito quando estava boa. Fiquei pensando: ‘ainda bem que posso ajudar, estou mais tranquila’.” (Na sessão 8)

Suely: “Este grupo me ajudou muito a ver como o pensamento negativo do estresse funciona, estou mudando, vou ter que continuar praticando isso e já estou ensinando para meu filho esse jeito de ser.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estresse é uma realidade que não pode ser ignorada devido aos efeitos deletérios que provoca no funcionamento tanto físico como mental das pessoas. A TCC oferece um modelo de tratamento, no formato do treino de controle do estresse, que pode facilmente ser utilizado em situações individuais ou grupais, com todos os tipos de pacientes. Por se tratar de um tratamento focal, de curta duração, que leva entre 8 e 12 sessões, o TCS é bastante apropriado para situações de atendimento em que a demanda é grande.

Sua eficácia já foi comprovada em várias pesquisas, inclusive em diversas dissertações de mestrado e teses de doutorado (Barros, 2015; Bignotto, 2010; Brasio, 2000; Torrezan, 1999). Tem sua utilidade também comprovada, quando realizado em grupo, com população não clínica. Por exemplo, o TCS foi usado com sucesso com casais (Vilela, 2001), com mulheres chefes de família (Tanganelli, 2001), com gestantes (Torrezan, 1999) e com pais de crianças autistas (Moxotó & Malagris, 2015). Resultados positivos foram registrados quando adaptado para uso em grupo em empresas e instituições governamentais (Sadir & Lipp, 2013). O protocolo tem sido utilizado também em populações clínicas, como, por exemplo, com pacientes com retocolite ulcerativa inespecífica (Brasio, 2000), hipertensos (Lipp, 2007; Malagris et al., 2009), pessoas com doenças coronarianas, síndrome metabólica e diabéticas (Malagris, 2004; Malagris & Lipp, 2014), com hepatite (Barros, 2015), entre outras.

Por se tratar de um tratamento psicoeducativo de base cognitivo-comportamental que tem como principal pilar a reestruturação cognitiva como método de se atingir uma regulação emocional capaz de lidar com os desafios encontrados, torna-se necessário que o psicólogo que o implemente seja capaz de entender e utilizar, com eficiência, os princípios da TCC. Munido desse conhecimento, a realização do grupo no treino psicológico de controle do estresse passa a ser um método de grande utilidade para uso, em grupo, com pacientes com sintomas de estresse de todos os níveis educacionais.

REFERÊNCIAS

American Psychiatric Association (APA). (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (5th ed.). Washington: APA.

Barros, J. C. (2015). *Stress e hepatite C: Eficácia do treino de controle do stress em pacientes com terapia com inibidores de protease* (Tese de doutorado, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).

Beck, A. (1963). Thinking and depression. I. Idiosyncratic content and cognitive distortions. *Archives of General Psychiatry*, 9, 324-333.

Bignotto, M. M. (2010). *A eficácia do treino de controle do stress infantil* (Tese de doutorado, Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas).

- Brasil. Ministério da Previdência Social. (2011). *Boletim estatístico da Previdência Social*, 16(7). Recuperado de http://www.previdencia.gov.br/arquivos/office/3_110825-143916-892.pdf
- Brasio, K. M. (2000). *Eficácia do treino de controle de stress na retocolite ulcerativa inespecífica* (Tese de Doutorado, Universidade Católica de Campinas, Campinas).
- Ellis, A. (1958). Rational psychotherapy and individual psychology. *Journal of Individual Psychology*, 13, 38-44.
- Ellis, A. (1973). *Humanistic psychology: The rational-emotive approach*. New York: Julian.
- Everly, G., Jr., & Lating, J. M. (2013). *The clinical guide to the stress response* (3rd ed.). New York: Springer.
- Fava G. A. (1999). Well-being therapy: Conceptual and technical issues. *Psychotherapy Psychosomatics*, 68(4), 171-179.
- Hayes, S. C. (2004). Acceptance and commitment therapy, relational frame theory, and the third wave of behavioral and cognitive therapies. *Behavior Therapy*, 35(4), 639-655.
- Lazarus, R. S. (1966). *Psychological stress and the coping process*. New York: McGraw-Hill.
- Linehan, M. (2010). *Terapia cognitivo comportamental para transtorno da personalidade Borderline: Guia do terapeuta*. Porto Alegre: Artmed.
- Lipp, M. E. N. (1984). Stress e suas implicações. *Estudos de Psicologia*, 1(3-4), 5-19.
- Lipp, M. E. N. (2000). *Inventário de sintomas de stress para adultos de Lipp*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Lipp, M. E. N. (2007). Controle do stress e hipertensão artéria sistêmica. *Revista Brasileira de Hipertensão*, 14(2), 89-93.
- Lipp, M. E. N. (2009). *Sentimentos que causam stress* (Vol. 1). São Paulo: Papirus.
- Lipp, M. E. N. (2015). Terapia cognitivo-comportamental do stress. In C. B. Neufeld, E. M. O. Falcone, & B. Rangé (Orgs.), *ProCOGNITIVA: Programa de Atualização em Terapia Cognitivo-Comportamental: Ciclo 2* (pp. 101-155). Porto Alegre: Artmed Panamericana.
- Lipp, M. E. N., Guevara, H. (1994). Validação empírica do inventário de sintomas de stress. *Estudos de Psicologia*, 11(3), 43-49.
- Lipp, M. E. N., & Malagris, L. E. N. (1995). Manejo do estresse. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapia comportamental e cognitiva: Pesquisa, prática, aplicações e problemas* (pp. 279-292). Campinas: Psy II.
- Lipp, M. E. N., & Malagris, L. E. N. (2001). O stress emocional e seu tratamento. In B. Rangé (Org.), *Terapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a Psiquiatria* (pp. 475-489). Porto Alegre: Artmed.
- Lipp, M. E. N., Malagris, L. E. N. (2010). *O treino cognitivo de controle da raiva*. Rio de Janeiro: Cognitiva.
- Lipp, M. E. N., Malagris, L. E. N., & Novais, L. E. (2007). *Stress ao longo da vida*. São Paulo: Autores.
- Lipp, M. E. N., Pereira, I. C., & Muniz, F. (1996). Incidência de stress e hipertensão na população de São Paulo. *Anais do I Simpósio sobre Stress e suas Implicações: Um encontro internacional*.

Campinas: PUCCAMP.

Malagris, L. E. N. (2004). *A via L-arginina-óxido nítrico e o controle do stress em pacientes com hipertensão arterial sistêmica* (Tese de doutorado, Faculdade de Ciências Médicas, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro).

Malagris, L. E. N., Brunini, T. M. C., Moss, M. B., Silva, P. J. A., Espósito, B. R., & Ribeiro, A.C.M. (2009). Evidências biológicas do treino de controle do stress em pacientes com hipertensão. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 22(1), 1-9.

Malagris, L. E. N., & Lipp, M. E. N. (2014). Stress control training for women with metabolic syndrome. *Pinnacle Psychology*, 1, 266-276.

Meichenbaun, D. (1985). *Stress inoculation training*. New York: Plenum Press.

Moxotó, G. F. A., & Malagris, L. E. N. (2015). Avaliação de treino de controle do stress para mães de crianças com transtornos do espectro autista. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 28(4), 772-779.

Oliveira, I. R. (2013). Trial-based cognitive thereapy (TBCT): A new cognitive-behavior therapy approach. In I. R. Oliveira, T. Schwartz, & S. M. Stahl (Eds.), *Integrating psychotherapy and psychopharmacology: A handbook for clinicians*. New York: Routledge.

Rangé, B. (2008). Tratamento cognitivo-comportamental para o transtorno de pânico e agorafobia: Uma história de 35 anos. *Estudos de Psicologia*, 25(4), 477-486.

Sadir, M. A., & Lipp, M. E. N. (2013). Influência do treino do controle do estresse nas relações interpessoais no trabalho. *O Mundo da Saúde (CUSC)*, 37, 131-140.

Tangalelli, M. S. L. (2001). *Mulher chefe de família: Perfil, estudo e tratamento do stress* (Tese de Doutorado, Universidade Católica de Campinas, São Paulo).

Torrezan, E. A. (1999). *O efeito do controle de stress no resultado da gravidez* (Tese de doutorado, Universidade Católica de Campinas, São Paulo).

Vilela, M. V. (2001). *O stress no relacionamento conjugal*. (Tese de doutorado, Universidade Católica de Campinas, São Paulo).

Wells, A. (2003). *Perturbações emocionais e metacognição*. Lisboa: Climepsi.

Young, J. E. (2003). *Terapia cognitiva para transtornos da personalidade: Uma abordagem focada no esquema*. Porto Alegre: Artmed.

LEITURAS RECOMENDADAS

Cannon, W. B. (1939). *The wisdom of the body*. New York: Norton.

Lipp, M. E. N., Bignotto, M. M. P., & Sadir, M. A. (2005). Crenças irracionais como fontes internas de stress emocional. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 1(1), 29-34.

17



DESENVOLVIMENTO DE HABILIDADES EM GRUPOS

**Marcia Fortes Wagner
Isabela Maria Freitas Ferreira
Carmem Beatriz Neufeld**

Estudos no campo das habilidades para a vida têm sido o foco de muitos pesquisadores, a partir da formulação da hipótese de que indivíduos mais habilidosos podem vivenciar interações sociais mais satisfatórias, o que, por sua vez, é essencial para a prevenção e/ou redução de transtornos psicológicos. Nesse sentido, inúmeras investigações nessa área vêm originando a produção de um consistente referencial teórico e prático nos últimos anos.

Este capítulo tem por objetivo apresentar as habilidades de vida e as habilidades sociais, bem como estudos atualizados sobre o treinamento dessas habilidades, mostrando dados de evidência de sua eficácia e sua

relevância na busca de comportamentos mais saudáveis, que, conseqüentemente, são fundamentais ao bem-estar e à qualidade de vida do indivíduo. Também objetiva-se apresentar algumas diretrizes sobre a aplicação desses treinamentos em grupos clínicos ou não clínicos, finalizando com um relato de um programa de treinamento de habilidades sociais. Espera-se que este capítulo possa trazer subsídios aos profissionais e estudantes de psicologia e áreas afins, para que possam utilizar tal conhecimento em sua prática clínica, bem como auxiliar no desenvolvimento de futuras pesquisas.

HABILIDADES DE VIDA E HABILIDADES SOCIAIS

As habilidades de vida (HVs) são entendidas como as habilidades necessárias para desempenhar comportamentos adaptativos e positivos para um enfrentamento saudável das situações da vida cotidiana (World Health Organization [WHO], 1997). De acordo com o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF, 2003), essas habilidades podem ser agrupadas em três categorias: as habilidades cognitivas, que dizem respeito à análise e ao uso de informações; as pessoais, que auxiliam no desenvolvimento pessoal e no autoconhecimento; e as interpessoais, que englobam as habilidades de comunicação e interação eficazes. Dessa forma, percebe-se que as HVs estão relacionadas com o desenvolvimento social, pessoal, intelectual, emocional e físico do indivíduo (Hosseinkhanzadeh & Yeganeh, 2013).

Segundo a OMS (1997), as HVs são divididas em 10 classes: autoconhecimento, pensamento crítico, tomada de decisão, resolução de problemas, pensamento criativo, relacionamento interpessoal, empatia, lidar com as emoções, comunicação eficaz e lidar com o estresse. Entende-se que essas habilidades fazem parte do contexto de promoção de saúde mental, uma vez que contribuem para a competência psicossocial, auxiliando na interação e no envolvimento social e, conseqüentemente, no bem-estar e na qualidade de vida do indivíduo (WHO, 1997).

A literatura enfatiza a importância das HVs desde a infância, pois elas são vistas como fatores de proteção para uma trajetória de desenvolvimento saudável da criança (Del Prette, Rocha, & Del Prette, 2011). No entanto, essas habilidades podem ser aprendidas e aprimoradas em qualquer etapa da vida, permitindo ao indivíduo sempre aperfeiçoar o conhecimento sobre si e seus relacionamentos interpessoais (WHO, 1997). Conger e Mullen (1981) afirmam que a aprendizagem das HVs ocorre quando o indivíduo compreende seus objetivos, consegue ter uma clara descrição de seu novo comportamento e compreende em quais condições esse comportamento é aceitável. Segundo Mohammadi, Aghdam, Kiyani e Sattarzadeh (2011), o indivíduo que tem um amplo repertório de HVs é capaz de aceitar a responsabilidade de seu papel social e enfrentar os desafios e problemas da vida diária de forma eficaz, sem causar danos a si mesmo ou às outras pessoas que estão a sua volta.

Entre as HVs, estão as habilidades sociais (HSs), ou comportamento socialmente habilidoso, termo que exige um olhar cuidadoso às inúmeras definições que a literatura oferece. De acordo com a conceituação clássica de Caballo (1996), HS diz respeito a um conjunto de comportamentos de um indivíduo expresso de forma apropriada à situação, mantendo respeito às demais pessoas envolvidas, o que pode ocasionar a resolução de problemas imediatos, bem como minimizar futuros problemas. Já Z. A. P. Del Prette e Del Prette (1999) vinculam a área das HSs a um universo mais amplo das relações interpessoais, voltando-se a assertividade, habilidades de comunicação, resolução de problemas, cooperação e outras derivadas dos rituais sociais. Assertividade, nesse sentido, é a habilidade de expressar pensamentos e sentimentos, sem prejudicar os próprios direitos, e preservar o direito dos outros. Em uma escala de um *continuum*, a assertividade pode ser vista como um equilíbrio entre as posições passiva e agressiva, pois a pessoa assertiva expressa o que sente de forma segura e tranquila, sem precisar agredir ou se omitir (Z. A. P. Del Prette & Del Prette, 1999). Assim, é possível afirmar que, quando um indivíduo se comporta de forma assertiva, propicia a resolução de problemas interpessoais, além de aumentar sua

autoeficácia e autoestima, melhorar a qualidade dos relacionamentos e promover tranquilidade (Falcone, 2002).

As HSs podem ser agrupadas de maneira ampla e específica, a partir de seu conteúdo e funcionalidade, como propõem Z. A. P. Del Prette e Del Prette (2001): 1) HSs de comunicação – fazer e responder perguntas; pedir e dar *feedback*; iniciar e manter conversação; gratificar e elogiar; 2) de civilidade – dizer “por favor”; agradecer; apresentar-se; cumprimentar; despedir-se; 3) assertivas – manifestar opinião, concordar; discordar; fazer, aceitar e recusar pedidos; desculpar-se e admitir falhas; interagir com autoridade; estabelecer relacionamento afetivo/sexual; encerrar relacionamento; expressar raiva, pedir mudança de comportamento; e lidar com críticas; 4) empáticas – parafrasear, refletir sentimentos e expressar apoio; 5) HSs de trabalho – coordenar grupo; falar em público; resolver problemas, tomar decisões e mediar conflitos; habilidades sociais educativas; e 6) HSs de expressão de sentimentos positivos – fazer amizade; expressar solidariedade e cultivar o amor.

Nesse contexto, as HSs devem ser diferenciadas de competência social. As HSs são classes de comportamentos que somente podem ser classificadas na medida em que contribuem para a competência social. Esta, por sua vez, é a capacidade da pessoa de apresentar um comportamento que possa atingir os objetivos em uma situação interpessoal e manter uma relação equilibrada e positiva com o interlocutor (Z. A. P. Del Prette & Del Prette, 1999). McFall (1982) afirma que os comportamentos socialmente competentes estão relacionados a um sentido avaliativo, tendo em vista qualificar a proficiência com que são ou deveriam ser emitidos.

TREINAMENTO DE HABILIDADES DE VIDA EM GRUPO E SUA APLICABILIDADE

A literatura vem apontando a importância do desenvolvimento de treinamentos de habilidades de vida (THVs), uma vez que estes podem trazer benefícios para a própria pessoa e para suas relações com pares e familiares, contribuindo, assim, para seu autoconhecimento e interação social (Hatfield,

2002). Eles podem ser desenvolvidos em diferentes contextos, como unidades básicas de saúde, centros comunitários, instituições de ensino, entre outros ambientes que possam ser promotores de saúde para a população (WHO, 1997).

O THV pode ser desenvolvido para diferentes demandas, sendo visto tanto como promotor de saúde física e mental como intervenção para sintomatologias específicas (Sharifi et al., 2016). Hatfield (2002) enfatiza que o THV pode ter efeitos positivos sobre o relacionamento familiar e o sentimento de generosidade das pessoas. Ainda, afirma que a maioria das pesquisas indicou que o THV pode proporcionar aperfeiçoamento das habilidades comunicativas e sociais como uma das dimensões importantes do desempenho da família.

O THV pode ser realizado na modalidade individual e grupal. Grupos de treinamento visam auxiliar os participantes a identificar pensamentos, emoções e comportamentos, bem como orientar e treinar para mudanças nas formas de agir, pensar e sentir. Portanto, os grupos de treinamento têm tanto a função de psicoeducar como de treinar, sendo essas duas etapas parte do exercício de mudança na cognição e no comportamento (Neufeld, 2011).

É importante ressaltar que o grupo é benéfico na medida em que ele se torna o melhor acesso para o indivíduo praticar os novos comportamentos aprendidos no treinamento. O paciente pode usar o *feedback* e a crítica do grupo para moldar novos comportamentos; os comportamentos dos outros servem como modelo para desempenhar novas capacidades; e o grupo também é visto como um lugar em que pode desenvolver habilidades de expressividade e comunicação (Conger & Mullen, 1981; Neufeld, 2011). Os estudos voltados para THV em grupo ainda são recentes na literatura; no entanto, já há evidências de efeitos positivos (Hosseinkhanzadeh & Yeganeh, 2013; Mohammadi et al., 2011).

Conger e Mullen (1981) ressaltam que o grupo tem um maior efeito em seus membros quando estes desenvolvem um forte sentimento de confiança mútua e um interesse em ajudar uns aos outros por meio das atividades propostas. O grupo fornece tanto aceitação como desafio e busca um

equilíbrio essencial entre estas duas direções: aceitação da melhora das habilidades já existentes e o desafio de desenvolver novas capacidades.

Devido a essa diversidade de treinamento para diferentes ambientes e demandas, a seguir serão apresentados alguns exemplos mais atuais encontrados na literatura de diferentes tipos de treinamentos que vêm sendo realizados. A Tabela 17.1 apresenta de forma geral esses estudos.

Tabela 17.1 Treinamentos de habilidades de vida para diferentes demandas

Autores/ Ano	Mohammadi e colaboradores (2011)	Bahrani e Molajabari (2013)	Hosseinkhanzadeh e Yeganeh (2013)	Chinaveh (2013)	Abbasi e colaboradores (2014)	Khooshab e colaboradores (2016)	Shari colab (2016)
Objetivo	Investigar o efeito do THV na funcionalidade da família de pessoas com epilepsia	Examinar o efeito do THV na saúde mental de mães de crianças com necessidades especiais	Avaliar o efeito do THV na satisfação conjugal	Examinar os efeitos do treinamento de resolução de problemas nas habilidades de enfrentamento e no ajustamento psicológico entre estudantes universitários	Examinar a eficácia do THV na qualidade de vida de mães de crianças com síndrome de Down	Examinar o efeito de um programa de THV no estresse parental em mães de crianças cegas	Deter efeito qualic de côi escler
Habilidades envolvidas	10 HVs propostas pela OMS	• Autoconhecimento • Resolução de problemas • Manejo de estresse • Comunicação eficaz	10 HVs propostas pela OMS relacionando-as com o contexto conjugal	Resolução de problemas	10 HVs propostas pela OMS	10 HVs propostas pela OMS	Não e no est
Estrutura	Não especificado no estudo	12 sessões (1h cada)	8 sessões (2h cada)	6 sessões (2h cada)	12 sessões (2 sessões por semana, 1h cada)	5 sessões (2h cada)	Não e no est
Desfecho	O tratamento farmacológico, em conjunto com o THV, pode auxiliar na redução de comportamentos destrutivos secundários, como obstinação e agressividade, contribuindo para relações saudáveis no ambiente familiar.	O THV mostrou efeito estatisticamente positivo no aumento da saúde mental das mães.	O THV foi eficaz na satisfação conjugal. Auxiliou as mulheres a identificar as razões subjacentes para os problemas e a ampliar suas estratégias de enfrentamento, bem como ajudou os casais a transmitir suas mensagens de forma eficaz e com maior precisão.	Os participantes do grupo experimental obtiveram aumento de mudanças e atitudes positivas em estratégias de enfrentamento e habilidades de resolução de problemas; consequentemente, houve melhora no ajustamento psicológico.	Os resultados mostraram que, após o THV, os escores de saúde física e mental e as relações sociais das mães do grupo experimental foram significativamente maiores em comparação ao grupo-controle, contribuindo para a qualidade de vida daquelas.	Redução significativa do estresse parental após a intervenção. Considerada uma intervenção eficiente, de custo-eficácia e de técnicas simples para o manejo de estresse parental.	Os pa do gru exper apres média de qu vida signif maior comp grupo pós-te

No estudo realizado por Mohammadi e colaboradores (2011), foi investigado o efeito do treino de HVs na funcionalidade da família de pessoas

com epilepsia na cidade de Tabriz (Irã). Participaram do estudo 30 indivíduos de 18 a 32 anos, membros da Associação de Epilepsia de Tabriz, divididos em dois grupos: 15 indivíduos para o grupo experimental e 15 para o grupo-controle. Neste, foi encontrado como resultado que o tratamento farmacológico, em conjunto com o THV, pode auxiliar na redução de comportamentos destrutivos secundários, como obstinação e agressividade. Os autores concluem que o THV pode contribuir para a saúde mental e para o bom desempenho nas relações dentro do ambiente familiar.

Em razão de a mãe ser, na maioria dos casos, o cuidador principal de crianças com distúrbios ou incapacidades, vários estudos com THV têm sido realizados com esse público-alvo (Abbasi, Sajedi, Hemmati, & Rezasoltani, 2014). Khooshab, Jahanbin, Ghadakpour e Keshavarzi (2016) elaboraram um trabalho com o objetivo de examinar o efeito de um programa de treino de HVs no estresse parental em mães de crianças cegas. O estudo contou com 52 mães, sendo 26 para o grupo experimental e 26 para o grupo-controle. O treinamento foi em grupo, contendo cinco sessões semanais de 2 horas cada. A intervenção contou com os seguintes temas baseados nas orientações da OMS (1997) e do UNICEF (2003): autoconhecimento (incluindo autoestima e inteligência emocional); manejo de emoções e estresse; resolução de problemas e tomada de decisão (incluindo pensamento crítico e criativo); e empatia e relacionamento interpessoal. Como resultado, foi encontrada uma redução significativa do estresse parental após a intervenção, a qual não ocorreu no grupo-controle. Os autores chegaram à conclusão de que foi obtido um efeito positivo do treinamento na redução de níveis de estresse das mães com filhos com deficiência visual.

Abbasi e colaboradores (2014) desenvolveram um estudo com o objetivo de examinar a efetividade do THV na qualidade de vida de mães de crianças com síndrome de Down. Participaram do estudo 36 mães randomizadas em dois grupos: experimental (18) e controle (18). O grupo experimental recebeu o THV de 12 sessões (duas sessões por semana de 60 minutos cada). Os resultados mostraram que, depois do THV, os escores de saúde física, saúde mental e relações sociais das mães do grupo experimental foram significativamente maiores em comparação aos do grupo-controle. Assim, os

autores concluem que o THV pode ser efetivo na qualidade de vida de mães de crianças com síndrome de Down. A literatura também mostra resultados positivos do THV para a saúde mental de mães de crianças com necessidades especiais (Bahrami & Molajabari, 2013).

Além da relação mãe-criança, há também estudos de THV na esfera conjugal. Hosseinkhanzadeh e Yeganeh (2013) realizaram um estudo com o objetivo de avaliar o efeito do THV na satisfação conjugal. Fizeram parte do estudo 40 mulheres casadas, sendo 20 do grupo experimental e 20 do grupo-controle. O treinamento foi realizado em oito sessões de 2 horas cada. O programa de THV incluiu as seguintes habilidades, relacionando-as com o contexto conjugal: tomada de decisão, resolução de problemas, pensamento crítico e criativo, comunicação eficaz, habilidades interpessoais, autoconhecimento, empatia, manejo de emoções e estresse. Como resultado, foi encontrado que o THV pode auxiliar as mulheres a identificar as razões subjacentes para seus problemas e a ampliar suas estratégias de enfrentamento para lidar com os conflitos. Também foi identificado que as HVs podem ajudar os casais a transmitir suas mensagens de forma eficaz e com maior precisão. Assim, os autores concluíram que o THV melhora a satisfação conjugal.

Ainda no âmbito conjugal, Sharifi e colaboradores (2016) desenvolveram um estudo com o objetivo de determinar o efeito do THV na qualidade de vida de cônjuges com esclerose múltipla. Fizeram parte do estudo 40 cônjuges de ambos os sexos randomizados em grupo experimental e controle. Os resultados indicaram que houve diferenças significativas entre a média dos escores na qualidade de vida no pós-teste, no qual o grupo experimental apresentou médias maiores, mostrando, assim, que o THV teve efeitos positivos na qualidade de vida dessa amostra.

Há também programas que objetivam trabalhar HVs específicas, como, por exemplo, a habilidade de resolução de problemas. Chinaveh (2013) realizou um estudo com o objetivo de analisar os efeitos do treinamento de resolução de problemas para aumentar as habilidades de enfrentamento e ajustamento psicológico entre estudantes universitários iranianos. Participaram desse estudo 347 estudantes de 18 a 36 anos. O treinamento

seguiu o modelo de D’Zurilla e Nezu (2007) e foi realizado durante seis sessões semanais de 2 horas cada, contendo um limite de 15 pessoas por grupo. O conteúdo trabalhado envolveu etapas como definição de problemas e metas, identificação de diferentes alternativas de soluções, prevenção e manejo de consequências, desenvolvimento e prática de planos de ação e aplicabilidade em diferentes situações. Como resultado, foi encontrado que os participantes do grupo experimental obtiveram melhora no ajustamento psicológico e nas respostas de enfrentamento em comparação ao grupo-controle.

TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS EM GRUPOS E SUA APLICABILIDADE

O treinamento de habilidades sociais (THS) é uma intervenção específica voltada à área das HSs. Segundo os estudos de Caballo (2003), o THS tem como foco o ensino de habilidades interpessoais, visando desenvolver a competência individual e interpessoal em situações sociais. Está voltado à prevenção primária na infância, diminuindo a probabilidade do aparecimento de repertório deficitário de HSs no decorrer do ciclo vital (Z. A. P. Del Prette & Del Prette, 1999), bem como à prevenção secundária na idade adulta, no surgimento de comportamentos de esquivas de situações sociais e déficits associados. Para Falcone (2002), programas preventivos necessitam focalizar-se no desenvolvimento da assertividade, da empatia e da solução de problemas, objetivando o incremento das competências sociais dos sujeitos envolvidos.

De acordo com Gresham (2009), para a avaliação das HSs em uma intervenção grupal, deve ser realizada uma avaliação funcional do comportamento, entendida como “. . . um conjunto de métodos de coleta de informações sobre eventos antecedentes, comportamentos e consequências com o objetivo de determinar a razão (função) do comportamento . . .” (Gresham, 2009, p. 25). Assim, a etapa de avaliação das HSs visa identificar o repertório deficitário, as cognições e as emoções disfuncionais que trazem prejuízos, e o terapeuta tem um importante papel nesse processo de modelar e

ampliar o repertório social do indivíduo, a fim de modificar os eventos antecedentes e consequentes.

Para Z. A. P. Del Prette e Del Prette (2009), eventos antecedentes estão centrados nos comportamentos e em outros elementos da situação de interação do indivíduo, facilitando ou dificultando alguns desempenhos sociais, além de estimularem a formação de cognições e sentimentos diante da situação específica, sendo vistos como derivados das consequências e com poder de influenciar o comportamento. Já os eventos consequentes demonstram de que maneira o ambiente social reage aos comportamentos do indivíduo, considerando as consequências reforçadoras e aversivas em relação aos comportamentos considerados adequados ou inadequados.

Inúmeras são as formas de avaliar as HSs de um indivíduo, e, entre os testes e inventários padronizados mais utilizados no Brasil, é possível destacar o Inventário de Habilidades Sociais – IHS (Z. A. P. Del Prette & Del Prette, 2001). Adicionalmente, há outros meios para compor a avaliação, como observação direta, entrevistas, fichas de autorregistro e questionários. Todos têm importante função na busca de informações no THS (Z. A. P. Del Prette & Del Prette, 1999).

O campo do THS está em significativo crescimento no Brasil, com grupos de pesquisa que apresentam produção regular e interesses voltados à cultura brasileira. Programas de THS com avaliação antes e depois da intervenção trazem dados de evidência de sua eficácia no desenvolvimento das HSs e da competência social (Pureza, Rusch, Wagner, & Oliveira, 2012).

Na área clínica, o THS vem sendo investigado ao longo dos anos no tratamento de alguns transtornos mentais. A seguir, serão apresentados estudos recentes que evidenciaram a eficácia do THS na esquizofrenia e no transtorno de ansiedade social (TAS). Posteriormente, a Tabela 17.2 demonstra esses estudos de forma geral. No que diz respeito à esquizofrenia, Granholm, Holden, Link, McQuaid e Jest (2013) realizaram um estudo com 79 sujeitos com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo, com idades entre 45 e 78 anos, no qual combinaram terapia cognitivo-comportamental com THS grupal e resolução de problemas. Após a intervenção de 36 sessões

semanais, foram constatadas melhoras significativas na motivação, nos sintomas de depressão e ansiedade, na autoestima e na satisfação com a vida.

Tabela 17.2 Treinamentos de habilidades sociais em grupo para população clínica

Autores/Ano	Rocha e colaboradores (2012)	Granholm e colaboradores (2013)	Beidel e colaboradores (2014)	Wagner e colaboradores (2014)
Objetivo	Avaliar os efeitos do THS para o tratamento de fobia social	Determinar se THS e TCC são eficazes na melhora do funcionamento na esquizofrenia	Analisar o impacto do THS para o tratamento do TAS	Apresentar os resultados de um programa de THS no TAS
Habilidades envolvidas	Autoconhecimento e resolução de problemas	Resolução de problemas	Conversação, assertividade e falar em público	Resolução de problemas
Estrutura	12 sessões semanais (2h cada)	32 sessões semanais (2h cada)	12 sessões semanais (1h cada)	10 sessões semanais (2h cada)
Desfecho	Intervenção foi eficaz para o tratamento de fobia social, pois os participantes passaram da condição clínica para a não clínica	Melhora do funcionamento dos sujeitos com esquizofrenia, redução de sintomas, maior motivação, autoestima e satisfação com a vida	Decréscimos significativos em duas medidas de ansiedade social e várias medidas de comportamento social observado	Melhoras no repertório de HSS, na interação grupal, além de aumento da assertividade em situações difíceis

No âmbito dos transtornos de ansiedade, o THS grupal pode apresentar-se como intervenção complementar, como na intervenção realizada por Rocha, Bolsoni-Silva e Verdu (2012) com universitários entre 19 e 31 anos com TAS, em que foram discutidas, em 12 sessões semanais, alternativas socialmente habilidosas para as dificuldades, exposições teóricas dialogadas sobre o tema do encontro, bem como avaliações funcionais e treino de repertório dos participantes. Ao fim da intervenção, os participantes deixaram de apresentar dificuldade na habilidade de falar em público e ampliaram seu repertório social.

Outra intervenção grupal de THS abrangeu 106 adultos com TAS, com idade média de 36,39 anos, envolvendo interações e *role playing* voltados à expressão de desaprovação ou crítica, assertividade, confronto e expressão da raiva, interação com sexo oposto, conflitos ou rejeição, perda interpessoal, recepção de elogios e comunicação (Beidel et al., 2014). Os achados mostraram que o THS é um componente importante do sucesso do tratamento do TAS na medida em que possibilita benefícios aos sujeitos, como a redução da angústia e o ensino de comportamentos pró-sociais. Wagner, Pereira e

Oliveira (2014) implementaram um THS grupal de 10 sessões de 2 horas semanais no tratamento do TAS, com avaliação pré e pós-intervenção, em uma amostra de 32 adultos de ambos os sexos, com média de idade 25,75 anos e variação entre 19 e 41 anos. Os resultados apontaram melhora significativa nos sintomas clínicos, com mudanças comportamentais após a intervenção.

DIRETRIZES PARA TREINAMENTO DE HABILIDADES DE VIDA EM GRUPOS

A partir dos dados da literatura, é possível afirmar que o THV pode ser desenvolvido para diferentes demandas e contextos, tanto para aprimorar as habilidades já existentes como para incentivar o desenvolvimento de novas capacidades. Assim, o THV pode aumentar a consciência dos indivíduos sobre pontos fortes e fracos, proporcionando maior autoconhecimento, e permite que eles usem suas habilidades para resolver problemas e melhorar aspectos da vida (Abbasi et al., 2014). Um THV efetivo facilita o alcance de atitudes mais resilientes e compreensíveis, melhorando a interação com o ambiente e com as pessoas e, conseqüentemente, proporcionando mais qualidade de vida (Abbasi et al., 2014).

Os participantes podem se beneficiar do formato grupal, uma vez que permite que identifiquem outras pessoas que também têm problemas semelhantes, o que ajuda a reduzir o estresse e o humor deprimido. Além disso, os participantes observam os comportamentos dos demais, permitindo aprendizagens sobre diferentes formas para lidar com uma mesma situação, estimulação de mudanças e aceitação da realidade (Abbasi et al., 2014; Malekpour, Farahani, Aghaei, & Bahrami, 2006).

Devido à amplitude de demandas que o THV em adultos pode alcançar, para que o treinamento seja efetivo, é necessário atentar para alguns cuidados. É aconselhável, inicialmente, planejar o objetivo do treinamento e a qual público-alvo será direcionado. Após essa etapa, deve-se criar um programa que atenda esse objetivo, mantendo foco nas metas e na conexão entre as sessões. O número de sessões pode variar de acordo com a demanda.

Na literatura, há programas de 5 até 12 sessões; sua duração também varia, de 60 minutos a 2 horas, aproximadamente. Dessa forma, as questões de tempo e duração devem atender à necessidade do público e do objetivo do treinamento.

É importante também que o programa seja estruturado, que os temas das sessões e suas atividades sejam planejados com antecedência, permitindo também que haja espaços para possíveis conteúdos relacionais que apareçam durante as sessões. “Eventos que ocorrem na sessão podem e devem ser trabalhados, mas cabe aos terapeutas julgar sua pertinência naquele momento” (Neufeld, 2011, p. 747). Um dos pontos mais relevantes é que os assuntos tratados sejam condizentes com o ambiente e a cultura em que os participantes estão inseridos; assim, os exemplos utilizados devem fazer parte de seu cotidiano, para uma melhor compreensão e empatia com a situação.

Para tornar as sessões mais motivadoras, sugere-se que sejam propostas diferentes atividades, para que o programa não se torne cansativo. Além disso, o terapeuta deve sempre verificar se as atividades não estão constrangendo ou incomodando de forma excessiva os pacientes, porque isso poderá desmotivar sua participação. Também é importante incentivar, sempre que possível, a ajuda mútua de todos; a coesão grupal é essencial para auxiliar o funcionamento do treinamento. Deve-se lembrar que alguns dos principais ganhos do treinamento em formato grupal são a compreensão, por parte do participante, de que há outras pessoas que passam por situações semelhantes, a aprendizagem com as experiências dos demais e a possibilidade de praticar suas novas habilidades nesse grupo.

Apesar desses dados de efeitos positivos, são necessárias mais pesquisas na área de THV em grupos com adultos, com o intuito de explorar esse campo de estudo, trazendo outros programas tanto com HVs específicas como que abarcam todas as habilidades para diferentes demandas. Não se pode perder de vista que as HVs podem ser desenvolvidas e aprimoradas em qualquer ciclo da vida; por isso, novos estudos poderiam investigar outros possíveis benefícios que esse tipo de treinamento pode proporcionar nas diferentes etapas da vida adulta.

DIRETRIZES PARA O TREINAMENTO DE HABILIDADES SOCIAIS COM GRUPOS CLÍNICOS

O THS para grupos clínicos pode variar de acordo com o tempo de duração e o número de participantes. Um programa de THS aplicado e recomendado é o desenvolvido em sessões semanais de 2 horas de duração, ao longo de 8 a 12 semanas, com 8 a 12 participantes, o qual tem o foco em direitos interpessoais, estilos de comunicação assertivo, passivo e agressivo, reestruturação cognitiva de crenças irracionais e ensaio comportamental (Caballo, 2003).

Programas de THS focalizam sua atenção em ensinar os indivíduos a identificar seus déficits nas HSs ou nos comportamentos em seus relacionamentos interpessoais, nos quais exista a necessidade de modificações, mantendo o foco no tratamento de algumas HSs específicas que estejam sendo realizadas de forma desadaptativa (Caballo, 1996). A grande meta do THS é melhorar o funcionamento do indivíduo em situações sociais e de desempenho, tendo em vista uma probabilidade de aumento das reações positivas dos outros e o desenvolvimento da competência social e da autoeficácia do indivíduo ante as demandas da vida.

Segundo Caballo (2003), algumas técnicas são recomendadas para auxiliar no THS, como ensaio comportamental ou representação de papéis, modelação, instruções, retroalimentação e reforço e tarefas para casa:

- No ensaio de comportamento, o indivíduo é estimulado a representar pequenas cenas problemáticas de sua vida real, com o objetivo de aprender a modificar comportamentos não adaptativos, substituindo-os por outras formas mais adaptativas, com o auxílio dos demais membros do grupo.
- A modelação consiste em expor o indivíduo a um modelo representado pelo terapeuta ou outro participante do grupo que demonstre corretamente o comportamento que está sendo trabalhado, propiciando aprendizagem de uma outra forma de abordar determinada situação.
- Instruções referem-se a proporcionar aos participantes informação sobre o comportamento social, explicando e psicoeducando sobre os exercícios e

ensaios de comportamento que serão desenvolvidos.

- Retroalimentação e reforço visam a aquisição de novos comportamentos, com recompensas sucessivas e aumento de comportamentos adaptativos específicos no indivíduo, reforçando de forma verbal, mas também não verbal, por meio da expressão do rosto, gestos de confirmação com a cabeça, aplausos, palmadas nas costas e a autorrecompensa, na qual os indivíduos dizem ou fazem algo agradável a si próprios quando praticam bem suas habilidades. A retroalimentação pelo facilitador, demais membros do grupo e por áudio ou vídeo tem como objetivo expressar de forma positiva uma informação ao paciente, buscando a melhora de uma habilidade.
- Tarefas para casa podem ser compreendidas como uma forma de praticar na vida real as habilidades aprendidas no decorrer das sessões grupais. As sessões de THS geralmente se iniciam e terminam com a discussão das tarefas de casa, e, com o avanço do tratamento, o grau de dificuldade de cada tarefa vai aumentando de forma gradativa, sendo planejadas para alcançar os objetivos do tratamento.

RELATO DE UM PROGRAMA DE THS

Uma intervenção de THS grupal denominada “Programa de Desenvolvimento de Habilidades Interpessoais” foi desenvolvida com 32 estudantes universitários de instituições de ensino superior do Estado do Rio Grande do Sul, de ambos os sexos, que apresentavam sintomas de TAS. A intervenção, descrita de forma mais detalhada por Wagner e colaboradores (2014), foi realizada em um total de 10 sessões grupais com variação de 5 a 8 participantes, com frequência semanal e duração de 120 minutos. Para auxiliar no diagnóstico da presença de sintomas de TAS e constatar a eficácia do programa na busca de mudanças comportamentais significativas, foi realizado um processo de avaliação pré e pós-intervenção nos participantes, com o uso do Questionário de Ansiedade Social para Adultos (CASO) (Caballo et al., 2010), cuja versão brasileira está sendo conduzida por Wagner (2011). O CASO tem 30 itens a serem respondidos, de acordo com o

número que melhor represente o grau de mal-estar, tensão ou nervosismo que cada uma das situações descritas provoca (ou provocaria), por meio de escala tipo Likert de 5 pontos: nenhum ou muito pouco (escore 1), pouco (escore 2), médio (escore 3), bastante (escore 4), muito ou muitíssimo (escore 5). Os estudos brasileiros de fidedignidade do CASO (Wagner, 2011) demonstraram que o instrumento apresenta elevada consistência interna, com um coeficiente Alpha de Cronbach com valor $\alpha = 0,93$, e uma estrutura de cinco fatores: Fator 1 – Falar em público e interação com pessoas em posição de autoridade, Fator 2 – Interação com o sexo oposto, Fator 3 – Interação com pessoas desconhecidas, Fator 4 – Expressão assertiva de incômodo, desagrado ou tédio, e Fator 5 – Estar em evidência e fazer papel de ridículo.

Da amostra total de 32 participantes, 71,9% ($n = 23$) dos sujeitos eram do sexo feminino, e 28,1% ($n = 9$) do sexo masculino, com variação de idade entre 19 e 41 anos, sendo a média de idade de 25,75 anos ($DP = 8,05$). Em relação ao estado civil e à atividade, a maior parte da amostra, 68,8% ($n = 22$), afirmou ser solteira, e 50% ($n = 16$) relataram ter um emprego. Nos resultados da aplicação do Critério de Classificação Econômica Brasil, a maior parte da amostra, 62,5% ($n = 20$), estava inserida na Classe B2; 15,6% ($n = 5$), na C1; enquanto 9,4% tanto na classe B1 ($n = 3$) quanto na C2 ($n = 3$); e 3,1% ($n = 1$), na classe D.

Os conteúdos desenvolvidos foram: autoconhecimento e habilidades de apresentação, relacionamento interpessoal e habilidades de conversação, habilidades de expressão de afeto e empatia, habilidades de assertividade, habilidades de conflito, lidar com o estresse, pensamento crítico e criativo, tomada de decisão e resolução de problemas. A intervenção ocorreu sob a coordenação de uma psicóloga e de uma estagiária de psicologia. Os participantes foram informados dos objetivos da atividade, da aplicação dos instrumentos e da preservação do sigilo de suas identidades, bem como assinaram um termo de consentimento livre e esclarecido. A seguir, é apresentado o relato dos 10 encontros:

- **Primeira sessão:** Apresentação dos coordenadores, explicação do objetivo do grupo, descrição das atividades. Após a realização de técnica de

apresentação/integração interpessoal, os participantes identificaram o grau de ansiedade nesse momento, e foram trabalhados os conceitos de HSs e THS. Ao fim, foi feita a aplicação da ficha sociodemográfica e do CASO (Caballo et al., 2010; Wagner, 2011).

- ***Segunda sessão:*** Conceitos e sintomas de ansiedade, psicoeducação sobre o TAS, com espaço para livre expressão, quando os participantes foram convidados a se manifestar sobre os momentos nos quais sentiram ansiedade e quais estratégias utilizaram para lidar com a situação. Após, foram ensinadas técnicas de controle da ansiedade, como respiração diafragmática e relaxamento muscular progressivo. A tarefa de casa foi treinar a respiração diafragmática e o relaxamento muscular progressivo, utilizando-os nas situações ansiogênicas que surgissem.
- ***Terceira sessão:*** Comportamentos envolvidos nas HSs e a importância da comunicação não verbal, como olhar, contato visual, expressão facial, postura corporal, gestos, distância/contato físico, aparência pessoal, volume e velocidade da fala. O grupo assistiu a uma vinheta de filme, identificando comportamentos não verbais e debatendo sobre quais os mais adequados, com sugestões de possíveis comportamentos no lugar dos não adequados. Como tarefa, foi solicitada a observação e a anotação da comunicação não verbal nas vivências diárias e suas consequências.
- ***Quarta sessão:*** Conceitos de agressividade, passividade e assertividade retirados dos estudos de Caballo (2003) e debate sobre comportamentos agressivos, passivos e assertivos. Os participantes, divididos em duplas, receberam fichas com exemplos de situações e formas diferentes de reagir a elas. Após, escolheram a mais adequada e representaram o comportamento. Ao fim, foi dada como tarefa uma Folha de Autorregistro das Habilidades Sociais para monitoramento de seus comportamentos diários durante a semana.
- ***Quinta sessão:*** Temas trabalhados: como iniciar e manter uma conversação, atenção aos elementos não verbais, livre informação, autorrevelação, elogiar, pedir e expressar opinião e expressão de sentimentos positivos. Em duplas, a partir de temas sugeridos por sorteio, definiu-se um assunto de interesse mútuo para uma conversa, procurando

evitar pausas prolongadas. Por fim, foi feita uma reflexão sobre o desempenho de cada um, possíveis erros de comunicação e abordagens. Outra atividade realizada: em duplas, olhando nos olhos e de frente um para o outro, deveriam fazer um elogio sincero de algo que admirou no companheiro; este deveria aceitar e agradecer; e vice-versa. Como tarefa, foi estabelecida, pelos participantes, uma situação específica na qual poderiam treinar as estratégias desenvolvidas no grupo, descrevendo por escrito a atividade e avaliando seu desempenho.

- **Sexta sessão:** Foco na defesa dos direitos, a partir de debate sobre os direitos do ser humano. Foi solicitado que recordassem de uma situação na qual já tenham se sentido desrespeitados em seus direitos, descrevendo-a em uma folha. A sessão transcorreu com a participação voluntária dos participantes na autorrevelação das situações, e, a partir de um *role playing* (ou dramatização) das cenas, foram construídas, em conjunto, estratégias de resolução de problemas para as situações ocorrerem de forma mais adequada, com conversação e comportamentos mais assertivos.
- **Sétima sessão:** Expressão dos sentimentos e reações ante situações geradoras de estresse, com aprendizado de habilidades de conflito. Foram ensinadas técnicas de como desarmar um argumento e expressar opiniões pessoais, desenvolvendo estratégias e maneiras de lidar assertivamente em tais momentos; como reconhecer sentimentos e expressão de afeto/empatia; como convidar uma pessoa para uma atividade; e tomada de consciência das dificuldades de ser empático em situações positivas e negativas.
- **Oitava sessão:** Pensamento crítico e criativo, tomadas de decisão e resolução de problemas, buscando estimular as capacidades de questionamento, reflexão, análise, ausência de julgamento prévio das ideias, busca de alternativas, ouvir as pessoas e pedir esclarecimento quando uma afirmação não for clara. Em relação à tomada de decisão e à resolução de problemas, foram investigadas as estratégias de avaliação das possíveis “situações-problema”, com delineamento de diferentes estratégias de resolução, eleição de maneiras e adoção de critérios, por

meio da utilização de capacidades pessoais e recursos do meio. Um dos objetivos é o incremento da consciência dos indivíduos a respeito de sua responsabilidade ante a resolução de seus problemas, a partir da avaliação das diferentes opções de soluções, de acordo com os critérios estabelecidos e escolha da alternativa que garanta maior chance de consequências positivas.

- **Nona sessão:** Trabalho de prevenção de recaída, revisando conceitos importantes trabalhados nas sessões e técnicas como cartões de enfrentamento, respiração diafragmática e relaxamento muscular progressivo. Foi realizada uma dinâmica de falar em público, na qual os participantes foram estimulados a preparar um pequeno texto de seu domínio para apresentar ao grupo, tendo como pré-requisitos o domínio do assunto e a linguagem verbal e não verbal. Após, o próprio grupo teceu considerações sobre a atividade, o desempenho individual e sugestões de possíveis mudanças comportamentais.
- **Décima sessão:** Reavaliação, com a reaplicação dos instrumentos da primeira sessão. Como encerramento, foi realizado um resumo dos principais conceitos trabalhados na intervenção e o *feedback* final de cada participante.

Para verificar a eficácia da intervenção, foi desenvolvida a análise dos dados da avaliação pré e pós-intervenção. Após a análise dos dados, foram evidenciadas diferenças na média grupal dos escores do CASO ao término da intervenção em comparação aos escores do início. Os resultados são descritos na Tabela 17.3.

Os resultados da Tabela 17.3 mostraram uma redução significativa dos níveis de ansiedade social dos participantes, detectando mudanças nos comportamentos vinculados ao quadro clínico do TAS, o que pode ser comprovado na pontuação total e dos cinco fatores do CASO. Os resultados do Programa de Desenvolvimento de Habilidades Interpessoais apontam que os pacientes obtiveram melhoras em seu repertório de HSs e na interação grupal, bem como aumento da assertividade em situações difíceis. Além da melhora nos escores totais do CASO pós-intervenção, os participantes

trouxeram relatos qualitativos de que passaram a executar mais comportamentos assertivos em situações difíceis, demonstrando que o THS pode realmente trazer benefícios, sendo uma boa escolha no tratamento do TAS.

Tabela 17.3 Médias e desvios-padrão do CASO pré e pós-intervenção

Instrumento CASO	Pré-intervenção		Pós-intervenção		<i>P</i>	Pontos de corte
	M	DP	M	DP		
F1	21,19	5,51	14,53	5,56	< 0,001	21,87
F2	19,94	5,04	14,09	4,59	< 0,001	20
F3	17,25	5,64	12,59	4,33	< 0,001	17,71
F4	21,53	4,72	14,15	4,33	< 0,001	19,56
F5	22,66	3,38	16,87	4,17	< 0,001	20,44
Total	102,56	13,65	72,25	17,78	< 0,001	95,59

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O campo das intervenções voltadas ao desenvolvimento de habilidades para a vida vem demonstrando ser fundamental na prática psicológica em diferentes contextos e demandas. Aprender e praticar algumas habilidades voltadas ao contexto social pode melhorar o desempenho dos indivíduos.

Cabe ao profissional que trabalha na área da psicologia escolher uma intervenção eficaz que possa ser utilizada para auxiliar de forma efetiva o tratamento de um problema. Os estudos científicos comprovam que o THV e o THS constituem-se como tratamentos de escolha, com bons resultados para diversos problemas psicológicos e em quadros clínicos específicos.

Tais intervenções podem ser utilizadas como um programa de prevenção ou diminuição de dificuldades futuras, instrumentalizando o indivíduo no aprendizado de estratégias e habilidades tanto interpessoais como intrapessoais mais adaptativas e que tragam melhores resultados em sua vida diária. Dessa forma, torna-se possível alcançar um padrão de comportamento mais saudável, proporcionando a melhora da competência interpessoal e individual.

REFERÊNCIAS

- Abbasi, S., Sajedi, F., Hemmati, S., & Rezasoltani, P. (2014). The effectiveness of life skills training on quality of life in mothers of children with Down syndrome. *Iranian Rehabilitation Journal*, 12(4), 29-34.
- Bahrami, G. G., & Molajabari, F. (2013). The effect of training life skills on mental health of mothers having exceptional children. *European Journal of Experimental Biology*, 3(2), 1-5.
- Beidel, D. C., Alfano, C. A., Kofler, M. J., Rao, P. A., Scharfstein, L., & Wong, N. (2014). The Impact of social skills training for social anxiety disorder: A randomized controlled trial. *Journal of Anxiety Disorders*, 28(8), 908-918.
- Caballo, V. E. (1996). Treinamento em habilidades sociais. In V. E. Caballo, *Manual de técnicas de terapia e modificação do comportamento* (pp. 361-398). São Paulo: Santos Livraria Editora.
- Caballo, V. E. (2003). *Manual de avaliação e treinamento das habilidades sociais*. São Paulo: Livraria Santos Editora.
- Caballo, V. E., Salazar, I. C., Irurtia, M. J., Arias, B., Hofmann, S. G., & The CISO-A Research Team. (2010). Measuring social anxiety in 11 countries: Development and validation of the social anxiety questionnaire for adults. *European Journal of Psychological Assessment*, 26(2), 95-107.
- Chinaveh, M. (2013). The effectiveness of problem-solving on coping skills and psychological adjustment. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 84, 4-9.
- Conger, D. S., & Mullen, D. (1981). Life skills. *International Journal for the Advancement of Counselling*, 4, 305-319.
- D’Zurilla, T. J., & Nezu, A. M. (2007). *Problem-solving therapy: A positive approach to clinical intervention* (3rd ed.). New York: Springer.
- Del Prette, Z. A. P. & Del Prette, A. (2001). *Inventário de habilidades sociais: Manual de aplicação e interpretação*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (1999). *Psicologia das habilidades sociais: Terapia e educação*. Petrópolis: Vozes.
- Del Prette, Z. A. P., & Del Prette, A. (2009). *Psicologia das habilidades sociais: Diversidade teórica e suas implicações*. Petrópolis: Vozes.
- Del Prette, Z. A. P., Rocha, M. M., & Del Prette, A. D. (2011). Habilidades sociais na infância: Avaliação e intervenção com a criança e seus pais. In C. S. Petersen, & R. Wainer, *Terapias cognitivo-comportamentais para crianças e adolescentes: Ciência e arte* (pp. 46-61). Porto Alegre: Artmed.
- Falcone, E. O. (2002). Contribuições para o treinamento de habilidades de interação In H. J. Guilhardi, M. B. B. P. Madi, P. P. Queiroz, & M. C. Scoz (Orgs.), *Sobre comportamento e cognição: Contribuições para a construção da teoria do comportamento* (pp. 91-104). Santo André: ESETEC.
- Granholm, E., Holden, J., Link, P. C., McQuaid, J. R., & Jest, D. V. (2013). Randomized controlled trial of cognitive behavioral social skills training for older consumers with schizophrenia: Defeatist performance attitudes and functional outcome. *American Journal Geriatric Psychiatry*, 21(3), 1-17.
- Gresham, F. M. (2009). Análise do comportamento aplicado às habilidades sociais. In Z. Del Prette, & A. Del Prette, *A psicologia das habilidades sociais: Diversidade teórica e suas implicações*. Petrópolis:

Voices.

Hatfield, A. (2002). *Family education: Theory and practice*. San Francisco: Jossey-Bass.

Hosseinkhanzadeh, A. A., & Yeganeh, T. (2013). The effects of life skills training on marital satisfaction. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 84, 769-772.

Khooshab, E., Jahanbin, I., Ghadakpour, S., & Keshavarzi, S. (2016). Managing parenting stress through life skills training: A supportive intervention for mothers with visually impaired children. *International Journal of Community Based Nursing and Midwifery*, 4(3), 265-273.

Malekpour, M., Farahani, H., Aghaei, A., & Bahrami, A. (2006). The impact of life skills training on reducing stress in mothers of mentally retarded children and normal children. *Research on Exceptional Children*, 20(2), 661-676.

McFall, R. M. (1982). A review and reformulation of the concept of social skills. *Behavioral Assessment*, 4(1), 1-33.

Mohammadi, A., Aghdam, G. A., Kiyani, R., & Sattarzadeh, L. (2011). Investigating effect of life skills training on family functioning of epileptic people's in Tabriz. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 30, 2316-2318.

Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.

Pureza, J. R., Rusch, S. G. S., Wagner, M., & Oliveira, M. S. (2012). Treinamento de habilidades sociais em universitários: Uma proposta de intervenção. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 8(1), 2-9.

Rocha, J. F., Bolsoni-Silva, A. T., & Verdu, A. C. M. A. (2012). O uso do treino de habilidades sociais em pessoas com fobia social na terapia comportamental. *Perspectivas em Psicologia*, 3(1), 38 -56.

Sharifi, E., Amingheshlaghi, Mirmehdi, S., Sohrabi, F., Delavar, A., & Rahmani, A. (2016). The effects of life skills training on quality of life of spouses with multiple sclerosis in Isfahan. *International Journal of Advanced Biotechnology and Research*, 7(1), 358-361.

United Nations Children's Fund (UNICEF). (2003). *Life skills: Definition of terms*. New York: UNICEF. Recuperado de http://www.unicef.org/lifeskills/index_7308.html

Wagner, M. F. (2011). *Evidências psicométricas do questionário de ansiedade social para adultos (CASO-A30)*. (Tese de doutorado não publicada, Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).

Wagner, M. F., Pereira, A. S., & Oliveira, M. S. (2014). Intervención sobre las dimensiones de la ansiedad social por medio de un programa de entrenamiento en habilidades sociales. *Psicología Conductual*, 22(3), 423-440.

World Health Organization (WHO). (1997). *Life skills education for children and adolescents in schools*. Geneva: Programme on Mental Health World Health Organization.

18



ORIENTAÇÃO DE PAIS EM GRUPOS

**Carmem Beatriz Neufeld
Thaís Barbosa Benedetti
Marina Gusmão Caminha**

A escassez de estudos brasileiros sobre orientação de pais em grupos em uma perspectiva cognitivo-comportamental tem-se mostrado uma importante lacuna na literatura (Neufeld & Godoi, 2014). Além disso, não costuma haver homogeneidade sobre esse tema, visto que a literatura apresenta várias especificidades a respeito da orientação de pais (OP). Os estudos são, geralmente, focados em OP para manejo de transtornos e contextos específicos (Neufeld & Maehara, 2011). Mesmo que escassos, os estudos brasileiros apresentam uma tendência semelhante aos internacionais e ressaltam a importância da qualidade do relacionamento entre pais e filhos no desenvolvimento das crianças e adolescentes (Carvalho & Gomide, 2005). A

literatura evidencia a relação entre os estilos parentais e a gênese posterior de problemas comportamentais infantis. Em função disso, diferentes intervenções com pais têm sido desenvolvidas para auxiliá-los na prevenção e na promoção de saúde de seus filhos (Batista & Weber, 2014; Bolsoni-Silva, Silveira, & Marturano, 2008; Carvalho & Gomide, 2005).

Os programas de OP têm-se tornado uma estratégia bastante utilizada para auxiliar as famílias no desenvolvimento de novas habilidades educativas, discussão de princípios, questões de relacionamento e promoção de melhor qualidade no relacionamento entre pais e filhos (Bolsoni-Silva & Marturano, 2002; Bolsoni-Silva et al., 2008). Os estilos parentais consistem em um conjunto de práticas educativas que os pais ou cuidadores adotam na relação com seus filhos, com o propósito de educar, socializar e controlar os comportamentos das crianças/adolescentes (Reppold, Pacheco, Bardagi, & Hutz, 2002). Os estudos a respeito dos estilos parentais analisam os comportamentos dos pais em relação aos filhos e suas influências em aspectos comportamentais, emocionais e intelectuais destes últimos, visto que comportamentos característicos dos pais trazem consequências para o desenvolvimento dos filhos (Darling, 1999; Weber, Selig, Bernardi, & Salvador, 2006).

Salvo, Silvaes e Toni (2005) pesquisaram quais práticas educativas do Inventário de Estilos Parentais (IEP) são preditoras de quais problemas de comportamento e competência social descritos pelo Inventário de Comportamentos para Crianças e Adolescentes (CBCL). Os resultados demonstraram que a falta do uso adequado da atenção para os filhos e do estabelecimento das regras (monitoria positiva) por parte paterna leva a déficits na sociabilidade da criança; a falta da monitoria positiva materna prediz o comportamento agressivo, e sua presença, a sociabilidade. O comportamento moral, definido como desenvolvimento de virtudes e transmissão de valores, materno apareceu como prática previsora de atividades e competência social, e essa prática, acompanhada da monitoria positiva, leva ao desenvolvimento de comportamentos pró-sociais. Foi observado também que a monitoria negativa materna foi preditora de problemas de atenção e comportamentos internalizantes. Além disso, quando unida à disciplina

relaxada materna, ambas foram preditoras de ansiedade/depressão medidas pelo CBCL. A falta de monitoria positiva e a monitoria negativa materna foram preditoras de comportamentos externalizantes. Os autores concluíram que práticas educativas específicas podem prever o comportamento da criança.

O conceito de parentalidade positiva vem ganhando destaque a partir do uso de competências para apoiar e encorajar o desenvolvimento da criança, na contramão da punição dos comportamentos inadequados (Lopes, Catarino, & Dixe, 2010). Os pais, nessa abordagem, são orientados a abandonar práticas coercitivas e promover educação e regulação emocional, buscando, com isso, ajudar os filhos no desenvolvimento de estratégias para resolução de problemas e habilidades sociais.

Bolsoni-Silva (2003) ressalta, ainda, que as habilidades sociais educativas parentais, como conversar, questionar e manifestar opiniões, bem como habilidades relacionadas à expressividade de todos os tipos de emoções, têm relação inversa com problemas de comportamentos dos filhos. Dessa forma, torna-se necessário intervir no contexto familiar modificando os fatores que atuam sobre a criança, para, assim, contribuir para a eficácia do tratamento (Caminha & Pelisoli, 2007; Melo & Silvaes, 2003).

PROGRAMAS DE ORIENTAÇÃO DE PAIS EM GRUPO

Coelho e Murta (2007) analisaram os efeitos de uma intervenção grupal estruturada para pais com o intuito de desenvolver, além das habilidades típicas parentais, outras, como, por exemplo, habilidades sociais e estratégias relacionadas ao enfrentamento de estressores externos. Participaram da intervenção sete pais/mães na faixa etária entre 31 e 50 anos convidados a partir da triagem de seus filhos em uma clínica-escola de psicologia na Universidade Católica de Goiás. Os filhos eram convidados a participar de um programa de habilidades sociais na abordagem cognitivo-comportamental, e, como critério de inclusão, tanto os pais quanto os filhos participavam dos respectivos programas. O programa de orientação de pais

foi composto de 20 sessões de 90 minutos, de frequência semanal. Os participantes foram divididos em dois grupos, um vespertino, composto por três mães, e o grupo noturno, com dois pais e duas mães. Os resultados foram analisados a partir do relato dos participantes nas entrevistas da observação clínica e dos escores obtidos pela aplicação do CBCL, e foi observado que, ao fim da intervenção, as práticas educativas parentais negativas diminuíram, e as positivas aumentaram consideravelmente. Os pais observaram uma mudança positiva dos filhos, como nas atividades acadêmicas e nas habilidades sociais.

Outro estudo, realizado em uma clínica-escola da Universidade Federal de Sergipe, objetivou descrever as características de funcionamento de um grupo de orientação de mães que estavam na lista de espera para os atendimentos de seus filhos. O grupo foi composto de quatro mães entre 30 e 58 anos, e foram realizados oito encontros, de frequência semanal e duração de 1h30min cada. O grupo tinha uma função de apoio, com a finalidade de orientar as mães acerca das dificuldades que as fizeram procurar o atendimento para seus filhos. Em geral, as demandas se remeteram a dificuldades de aprendizagem, problemas emocionais, problemas na escola e ansiedade. Os dados obtidos demonstraram que o grupo oportunizou um processo de mudança, o qual propiciou troca de experiências e novas perspectivas para lidar com as dificuldades que as mães estavam vivenciando a partir da mudança de seus próprios comportamentos. Vale ressaltar que os princípios da psicologia comportamental foram bastante úteis no aconselhamento de manejo de situações específicas, considerando a facilidade de compreender e aplicar esses princípios no dia a dia, assim como seus resultados obtidos, que geraram satisfação por parte das mães (Pardo & Carvalho, 2011).

Melo e Silveiras (2003) realizaram uma intervenção envolvendo grupo de pais e a escola de crianças com déficits sociais e acadêmicos, com idade média de 7 anos. O grupo de pais foi iniciado no mesmo período do atendimento infantil, e a intervenção foi analisada de acordo com as percepções dos pais e das professoras das crianças, sendo comparado a um grupo de crianças que não foram atendidas. Na intervenção, foram ensinadas habilidades como observar o comportamento dos filhos, dar instruções claras

e consistentes, orientar a respeito do reforçamento positivo para comportamentos desejáveis, além de resolver problemas conjugais ou financeiros, devido ao contexto da população em questão. A intervenção relacionada aos pais foi avaliada com o instrumento CBCL, que demonstrou, ao fim do grupo, melhora na percepção dos comportamentos das crianças, por perceber os comportamentos de seus filhos mais positivamente.

O programa “Promoção de Qualidade de Interação Familiar” (PQIF) foi criado por pesquisadoras da Universidade Federal do Paraná a partir das pesquisas para a elaboração do instrumento Escalas de Qualidade de Interação Familiar (EQIF) e da literatura específica sobre treinamento de pais. Esse programa conta com oito encontros semanais que abordam os temas: aprendizagem, relacionamento afetivo e envolvimento, regras e limites, reforçamento e punição, voltando no tempo, autoconhecimento e modelo. As pesquisadoras verificaram a eficácia do programa em um estudo com 93 pais e mães de crianças/adolescentes, participantes de oito grupos em diferentes localizações de uma cidade no Estado do Paraná. Os resultados obtidos demonstraram que os objetivos do programa foram alcançados, apresentando boa adesão (média de 87,9% de presença) e um nível positivo de satisfação na ficha de avaliação dos participantes, que diminuíram o uso da punição física e adquiriram novos padrões de comportamentos, como, por exemplo, maior demonstração de afeto parental e envolvimento com os filhos (Weber, Brandenburg, & Salvador, 2006).

Serra-Pinheiro, Guimarães e Serrano (2005) avaliaram uma intervenção de treinamento de pais em grupo para pais de crianças com transtorno de oposição desafiante (TOD). Os pacientes foram provenientes da população que busca atendimento no setor de Psiquiatria da Infância e Adolescência do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Para serem incluídos no grupo de pais, os filhos tinham que preencher os critérios do *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* (DSM-IV) para TOD e ser avaliados por um psiquiatra. O programa teve duração de 10 sessões semanais, com 2 horas cada, e foi embasado no protocolo de Russell Barkley, o qual abordou as características dos pais e das crianças que modulam o comportamento, e teve por objetivos aumentar e melhorar a

qualidade de tempo e atenção à criança com medidas específicas, como melhorar a obediência utilizando-se de técnicas de atenção e sistema de fichas, utilizar o *time-out*, técnicas para melhorar o comportamento da criança na escola com o sistema de fichas e em lugares públicos e resolução de problemas futuros. Ao fim da intervenção, obteve-se uma diferença estatisticamente significativa do índice médio na escala de TOD na primeira avaliação (16,2%) e na última (8,2%). Vale ressaltar que a maioria dos pacientes manteve os critérios para TOD; entretanto, a gravidade dos sintomas foi reduzida em 48,75%.

Fernandes, Luiz, Miyazaki e Marques Filho (2009) buscaram avaliar os efeitos de um programa de orientação de pais em grupo na modificação dos comportamentos de pais/cuidadores e de crianças com diagnóstico de transtornos psiquiátricos. A intervenção foi baseada no Programa de Intervenção Comportamental em Grupo para Pais (PICGP) de crianças e pré-adolescentes, estruturado por Marinho, Caballo e Simon (2005), e adaptada às necessidades da população e instituição. Esse estudo foi realizado em uma cidade do interior do Estado de São Paulo e reuniu oito cuidadores (seis mães e um casal de avós) em 10 sessões semanais de 90 minutos. Na avaliação, foram utilizados uma ficha de entrevista clínica, o Inventário de Habilidades Sociais e o Inventário de Stress de Lipp e o CBCL. A testagem ocorreu no início, após a intervenção e depois de dois meses do término do programa. Os autores constataram uma diferença estatisticamente significativa nas médias da testagem antes do início do programa em comparação ao fim da intervenção, indicando uma redução significativa dos problemas internalizantes e externalizantes apresentados pelas crianças após a participação de seus cuidadores no programa. Entretanto, os comportamentos-problema se mantiveram classificados como clínicos após a intervenção.

Um programa de treinamento de habilidades sociais voltado para a promoção dessas habilidades em pais teve por finalidade melhorar o relacionamento entre eles e seus filhos e prevenir problemas nessa interação e nos comportamentos destes últimos. Participaram do programa quatro casais de funcionários de uma universidade pública no interior do Estado de São

Paulo, que não apresentavam queixas clínicas. O programa foi composto de 10 sessões, durante duas vezes por semana e com duração de 1h30min, aproximadamente. Ao fim da intervenção, notou-se redução nos problemas de relacionamento com os filhos e no uso de punições, bem como melhora nas habilidades interpessoais nos relacionamentos entre pais e filhos, como expressão de carinho e atenção e uso de reforçamento positivo (Silva, Del Prette, & Del Prette, 2000).

Em relação aos programas internacionais de orientação de pais, um dos programas citados se refere ao Parent Management Training-Oregon Model (PMTO), que objetiva substituir processos coercitivos por modos parentais positivos. Essa intervenção foi desenvolvida com crianças com problemas de conduta de acordo com o pressuposto da interação social e de uma perspectiva ecológica, ou seja, para ocorrer mudança no comportamento dessas crianças, é necessário alterar a forma como o ambiente social reage a elas (Patterson, 1974). Um estudo realizado na Noruega buscou avaliar a eficácia do PMTO após a intervenção e após seis meses do término do grupo. Participaram do estudo 137 crianças com problemas de conduta entre 3 e 12 anos e seus pais, que foram aleatoriamente designados para o grupo de intervenção ou grupo de comparação. Em geral, os resultados apresentaram um impacto positivo na percepção dos pais em relação aos comportamentos externalizantes, à competência social e às práticas parentais positivas tanto após a intervenção como seis meses depois (Kjobli, Hukkelberg, & Ogden, 2013).

O SPACE Program (Supportive Parenting for Anxious Childhood Emotions) é um programa norte-americano de orientação de pais cujos filhos apresentam alguma demanda de ansiedade. Durante a intervenção, é apresentada uma psicoeducação da ansiedade na infância, focalizada totalmente na alteração comportamental dos pais em relação à criança. Em um estudo realizado na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, com pais de 10 crianças com idade entre 9 e 13 anos diagnosticadas com algum transtorno de ansiedade, foi implementado o SPACE Program em 10 sessões de frequência semanal, sendo que os filhos não estavam em atendimento psicológico infantil por recusa própria. Esse estudo apresentou melhora

significativa na ansiedade da criança apenas por meio da modificação dos comportamentos dos pais, bem como motivação da criança para o tratamento individual (Lebowitz, Omer, Hermes, & Scahill, 2014).

O Incredible Years consiste em um programa de treinamento de pais em grupo embasado na teoria da aprendizagem social, cujo objetivo é estabelecer uma relação harmoniosa entre pais e filhos, desenvolver habilidades nos pais para promover o desenvolvimento emocional da criança, fundar-se na aprendizagem e na aplicação consistente de práticas educativas eficazes e melhorar a comunicação dentro das famílias e com os professores. Esse programa foi aplicado durante 16 semanas em 35 pais que foram monitorados e identificados pelo assistente do Centro Juvenil Montreal como pais que adotavam comportamentos negligentes com seus filhos. A intervenção resultou em melhora nas práticas parentais positivas, bem como na percepção dos pais a respeito dos comportamentos problemáticos das crianças (Letarte, Normandeau, & Allard, 2010).

O Triplo P – Positive Parenting Program (Sanders & Epstein, 2000) tem como objetivo promover a capacidade de manejar de forma positiva os comportamentos-problema, desenvolvendo harmonia na família e estabilidade nas relações entre pais e filhos. Dividido em cinco diferentes níveis, o programa inicia com uma intervenção mais focada em orientações gerais, realizada por meio de contato telefônico, até chegar ao quinto nível, no qual a intervenção já se dá de forma mais intensiva (inclusive com visitas domiciliares e intervenções grupais e individuais) e com foco nos principais problemas apresentados (Quingostas, 2011).

Em um modelo bem comportamental, o Responsive Parenting Program (Hall, 1984) é dividido em quatro etapas, que visam definir o comportamento-alvo; medir sua duração e ocorrência; intervir, utilizando as consequências disponíveis; e avaliar a eficácia do procedimento. Trabalhando com grupos de pais, é um programa estruturado que busca modificar os comportamentos dos filhos por meio dos princípios da aprendizagem social. Os pais são treinados de forma a serem os próprios agentes de mudança desses comportamentos.

Os estudos nacionais e internacionais relacionados à orientação de pais estão resumidos nas Tabelas 18.1 e 18.2, respectivamente.

Tabela 18.1 Estudos nacionais relativos à orientação de pais

Autores/ Ano	Silva e colaboradores (2000)	Melo e Silveiras (2003)	Serra-Pinheiro, Guimarães e Serrano (2005)	Weber e colaboradores (2006)	Coelho e Murta (2007)	Fernandes e colaboradores (2009)
Objetivo	Melhorar o relacionamento familiar e prevenir problemas nessa relação e nos comportamentos dos filhos, promovendo estratégias educativas	Verificar a efetividade de uma intervenção ampliada para a escola e a família de crianças que manifestavam dificuldades acadêmicas e de relacionamento	Investigar o efeito de treinamento de pais (TP) em grupo para crianças com transtorno de oposição desafiante (TOD)	Aferir a eficácia do programa “Promoção da Qualidade de Interação Familiar” (PQIF)	Descrever uma experiência de treinamento de pais e seus efeitos	Avaliar os efeitos de um programa de orientação de pais em grupo de crianças com diagnóstico de transtornos psiquiátricos
Temas abordados	- Leitura do ambiente social - Comportamentos considerados adequados e inadequados dos filhos - Autocontrole na expressão inadequada de sentimentos negativos - Expressão de sentimentos positivos de carinho e afeto - Conceitos de assertividade, não assertividade e agressividade - Ordens claras e curtas	Intervenção com os responsáveis: - Observação do comportamento dos filhos - Fornecimento de instruções claras e consistentes - Consequenciar diferencialmente os comportamentos - Reforçamento positivo para comportamentos que denotassem iniciativa, autonomia (p. ex., contato físico, elogio, atenção, etc.) e outros socialmente desejáveis	- Qualidade do tempo e atenção dispensados à criança com medidas específicas - Técnicas de atenção e no sistema de fichas para melhorar a obediência e o comportamento na escola e em outros lugares públicos - Como utilizar o <i>time-out</i>	- Aprendizagem - Relacionamento afetivo e envolvimento - Regras e limites - Reforçamento - Punições “Voltando no tempo” - Autoconhecimento e modelo	- Reforço - Punição - Regras - Empatia - Expressão da raiva e mudança de comportamento - Convívio social - Habilidade social no casamento - Responsividade na interação pais e filhos - Culpa - Modelo de estilos parentais	Intervenção comportamental
Estrutura	10 sessões, 2x por semana (1h30)	22 sessões quinzenais (1h)	10 sessões semanais (2h)	8 sessões semanais	20 sessões semanais (1h30)	10 sessões semanais (1h30)
Desfecho	O THS apresentou redução nos problemas de relacionamento com os filhos, redução do uso de punições e melhora nas habilidades interpessoais nos relacionamentos entre pais e filhos, como expressão de carinho e atenção e	A intervenção demonstrou, ao fim do grupo, melhora na percepção dos comportamentos das crianças, por perceberem os comportamentos de seus filhos mais positivamente.	O TP foi eficaz em reduzir a gravidade dos sintomas de TOD e transtorno da conduta (TC). Vale ressaltar que a maioria dos pacientes manteve os critérios para TOD, entretanto, a gravidade dos sintomas foi reduzida em 48,75%.	Os objetivos do programa foram alcançados, observando-se mudanças nos pais e nos filhos. Os pais diminuíram o uso da punição física e adquiriram novos padrões de comportamentos, como, por exemplo, maior demonstração de afeto parental e	A intervenção propiciou diminuição das práticas parentais negativas e aumento considerável das práticas parentais positivas. Os objetivos da intervenção foram alcançados.	A diminuição dos problemas de comportamento apresentados por crianças foi significativa, pois essas dificuldades ainda necessitam de intervenção psicológica, pois não estão de acordo com o esperado para crianças da mesma faixa etária, co

uso de reforçamento positivo.

envolvimento com os filhos.

base no instrutor utilizado (o CE). Desse modo, o programa de orientação pode ter contribuído para a redução da gravidade desse comportamento problema.

Tabela 18.2 Estudos internacionais relativos à orientação de pais

Autores/ Ano	Letarte e colaboradores (2010)	Kjobli e colaboradores (2013)	Lebowitz e colaboradores (2014)
Objetivo	Avaliar a eficácia de um programa de treinamento de pais para melhorar as práticas parentais	Avaliar a eficácia do programa Parent Management Training-Oregon Model (PMTO) após a intervenção e seis meses após o término do grupo	Apresentar os resultados de uma intervenção de pais em grupo de filhos com algum transtorno de ansiedade
Temas abordados	• Desenvolver uma relação pai-filho mais harmoniosa • Práticas efetivas aplicadas de forma consistente • Resolução de problemas • Habilidades de comunicação	• Competências parentais positivas em pais de crianças com problemas de conduta. • <i>Role-play</i> para treinar as práticas parentais.	• Psicoeducação da ansiedade na infância • Habilidades parentais • Ensino e modelagem de autorregulação • Como lidar com o comportamento disruptivo (mudança comportamental dos pais)
Estrutura	16 sessões semanais (2h)	12 sessões semanais (2,5h)	10 sessões semanais
Desfecho	A intervenção propiciou melhora nas práticas parentais positivas e na percepção dos pais a respeito dos comportamentos problemáticos dos filhos.	A intervenção apresentou um impacto positivo na percepção dos pais em relação aos comportamentos externalizantes, à competência social e a práticas parentais positivas tanto após a intervenção como seis meses depois.	O estudo apresentou melhora significativa da ansiedade da criança apenas por meio da alteração dos comportamentos dos pais, e as crianças ficaram mais motivadas para o tratamento individual.

O PROGRAMA DE ORIENTAÇÃO DE PAIS DO LAPICC-USP

O Programa de Orientação de Pais (PROPAIS I) do Laboratório de Pesquisa e Intervenção Cognitivo-comportamental (LaPICC-USP) consiste em um programa com os pais e/ou cuidadores das crianças que são atendidas no estágio de Terapia Cognitivo-comportamental Infantil no serviço-escola do Centro de Psicologia Aplicada (CPA) da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto (FFCLRP-USP). Para os filhos serem atendidos

nesse estágio, é condição que os pais participem do PROPAIS I. Esse programa foi criado no ano de 2009 e, desde seu início, é aplicado por estagiários do 4º e do 5º ano em Abordagem Cognitivo-comportamental em grupos do LaPICC-USP (Neufeld & Maehara, 2011). O PROPAIS I é um programa embasado na abordagem cognitivo-comportamental e aborda como temas noções de comportamento, como, por exemplo, reforçamento e punição; o desenvolvimento infantil; regras e limites; práticas e estilos parentais; consequenciar comportamentos adequados e inadequados; funcionamento dos aspectos cognitivos; manejo de emoções; e resolução de problemas. O objetivo do programa se respalda nas queixas e demandas trazidas pelos pais com base em intervenções indicadas pela literatura (Neufeld & Godoi, 2014). O PROPAIS I é composto de 11 sessões de 50 minutos, e sua estrutura de acordo com os temas pode ser visualizada no Quadro 18.1.

Quadro 18.1 Estrutura geral do programa PROPAIS I

Sessões	Atividades desenvolvidas
Pré-grupo	Entrevista com os pais; pré-teste
1ª	• Apresentação do grupo; ênfase na coesão grupal; dinâmica de apresentação: rodada de perguntas; realização do contrato terapêutico
2ª	• Regras e limites: formas de estabelecê-los; discussão sobre a importância e as noções de comunicação eficaz entre pais e filhos
3ª	• Noções de desenvolvimento infantil; como os filhos reagem às ações dos pais; psicoeducação sobre leis do comportamento
4ª	• Consequências para o comportamento adequado: reforçamento
5ª	• Consequências para comportamentos inadequados; o problema da punição e os estilos parentais; habilidades sociais educativas envolvidas em estabelecer regras
6ª	• Relacionamento afetivo e envolvimento; reflexão sobre a qualidade da relação com os filhos
7ª	• Psicoeducação sobre modelo cognitivo: como lidar com os pensamentos, emoções e comportamentos no educar – introdução a distorções cognitivas
8ª	• Distorções cognitivas e sua influência na educação dos filhos: foco nas distorções que fazem no cotidiano
9ª	• Modelo de resolução de problemas; conceitos cognitivos aprendidos no grupo
10ª	• Treino de manejo de emoções em situações difíceis; técnicas de relaxamento
11ª	• Retomada dos conceitos aprendidos e das dúvidas presentes • Encerramento • Avaliação qualitativa
	• Pós-teste

É esperado que os participantes do PROPAIS I ampliem suas percepções relacionadas aos comportamentos dos filhos e de seus próprios comportamentos, se instrumentalizem de estratégias para resolver problemas, melhorem suas percepções em relação aos pensamentos na interação com seus filhos e as distorções e, por fim, que o programa proporcione qualidade no relacionamento e comunicação com os filhos (Neufeld & Maehara, 2011). No ano de 2011, o LaPICC-USP expandiu o PROPAIS I, com os mesmos objetivos, porém integrando a estratégia de promoção de saúde para a prevenção de problemas de desenvolvimento infantil às famílias em escolas e organizações. Essa nova configuração foi denominada PROPAIS II, e os temas remeteram mais ao cotidiano das famílias, com maior caráter psicoeducativo, que, diferentemente das 11 sessões no programa original, foram ajustados em 6 sessões de 50 minutos. Considerando o novo contexto ao qual foi aplicado, vale ressaltar que nesse programa não era necessária a existência de demanda por atendimento psicológico clínico infantil prévio ou concomitante para a inclusão dos pais nos grupos (Cassiano & Neufeld, 2014). Os dois grandes diferenciais dos PROPAIS são seu embasamento na terapia cognitivo-comportamental e sua generalidade, ou seja, não têm foco em um sintoma ou transtorno, e sim na qualidade da relação, no fortalecimento de laços.

O Quadro 18.2 apresenta o cronograma do PROPAIS II.

Quadro 18.2 Estrutura geral do programa PROPAIS II

Sessões	Atividades desenvolvidas
Pré-teste	• Aplicação dos instrumentos: EQIF, CBCL e CCEB
1ª e 2ª	• Estabelecimento de vínculo e coesão grupal • Levantamento de dificuldades e identificação de perfis e modos de educar • Psicoeducação de habilidades sociais educativas parentais, desenvolvimento infantil
3ª e 4ª	• Psicoeducação e treino de observação sobre leis do comportamento e técnicas de comunicação eficaz • Treinos de automonitoramento (comportamentos e emoções)

	• Início de psicoeducação do modelo cognitivo
5ª e 6ª	• O modelo cognitivo no cotidiano e a identificação de distorções cognitivas • Manejo de emoções desconfortáveis • Avaliação final
Pós-teste	• Reaplicação dos instrumentos mensurados
Fonte: Cassiano e Neufeld (2014).	

Visto que a literatura apresenta, em sua grande maioria, estudos que focalizam programas de orientação de pais com o enfoque mais comportamental (Olivares, Méndez, & Ros, 2005), e uma vez que são raros os estudos que abrangem aspectos cognitivos na intervenção com pais, Caminha e Pelisoli (2007) relevam a importância de se abordar pensamentos/crenças e sentimentos nesses programas. Isso porque, na medida em que não há reestruturação cognitiva por parte dos pais sobre seus papéis, dificilmente haverá uma mudança que se mantenha no longo prazo (Caminha, 2011). Por exemplo, pais que acreditam estar prejudicando seus filhos ao estabelecerem regras e limites dificilmente conseguirão mudar seus próprios padrões comportamentais em relação a essa construção, fundamental no alicerce da educação. Dessa forma, não há mudança nos padrões de seus filhos. Diante dessa realidade, sugere-se a intervenção também cognitiva com esses pais, alcançando-lhes ferramentas que possibilitem uma mudança efetiva (Caminha, 2011).

Outro importante e recente aspecto no que tange ao trabalho com pais diz respeito ao conceito de educação parental. Em uma proposta diferenciada do treino parental, que visa modificar os comportamentos das crianças, a educação parental tem como principal foco o propósito educativo e preventivo, ou, ainda, uma resposta a situações de crise. Assim, enquanto o treino é voltado para situações nas quais as crianças/adolescentes já apresentam problemas, a educação parental visa atingir todos os pais/cuidadores, com ou sem problemas comportamentais (Pelisoli, Caminha, & Rodrigues, 2016; Quingostas, 2011).

Nessa perspectiva, foi desenvolvido o TRI Escola de Pais, com base no modelo de regulação emocional de Caminha e Caminha (2016). A

intervenção com pais de crianças de 0 a 6 anos busca instrumentalizá-los para que entendam, aceitem e validem as emoções das crianças à medida que elas vão se apresentando, ajudando os filhos a encontrar um modo assertivo de expressá-las no contexto familiar e social. O curso, além de orientar sobre o manejo das emoções, visa também proporcionar ferramentas que auxiliem os pais no manejo comportamental e cognitivo dos filhos. O objetivo principal dentro de uma perspectiva de educação parental seria justamente prevenir problemas relacionados a ansiedade e depressão ao longo da vida, já que estes estão amplamente vinculados a problemas de regulação emocional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Intervenções com pais têm sido uma importante base no trabalho que visa à prevenção, ao desenvolvimento da regulação emocional ou mesmo à modificação de problemas comportamentais nas crianças e nos adolescentes. A orientação de pais, seja no modelo de treino parental, seja na educação parental, parece trazer resultados satisfatórios, já que são eles os principais modelos e cuidadores desses sujeitos em pleno desenvolvimento, necessitando diariamente de referências e amplo investimento afetivo. O papel da família é considerado fundamental no processo socioemocional dos jovens e ela necessita da atenção de profissionais da saúde para concretizar ações preventivas eficazes ou ajudar no manejo de situações de crise.

Embora a literatura nacional ainda seja escassa, é possível encontrar inúmeras propostas internacionais no que tange ao trabalho voltado para pais. As intervenções em grupo mostram-se muito eficazes e acabam por alcançar um número maior de famílias.

O exercício da parentalidade nos dias atuais parece sofrer de inúmeros problemas, com efeitos diretos nas crianças em fase de estruturação psíquica. Profissionais dispostos a intervir e ajudar essa população no sentido de construir práticas de parentalidade positiva são de extrema importância para a composição de interações familiares mais saudáveis.

REFERÊNCIAS

- Batista, A. P., & Weber, L. N. D. (2014). Análise de programas direcionados a comportamentos exteriorizados na infância e adolescência. *Psicologia Argumento*, 32(78), 157-168.
- Bolsoni-Silva, A. T. (2003). *Habilidades sociais educativas, variáveis contextuais e problemas de comportamento: Comparando pais e mães de pré-escolares* (Tese de doutorado, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Bolsoni-Silva, A. T., & Marturano, E. M. (2002). Práticas educativas e problemas de comportamento: Uma análise à luz das habilidades sociais. *Estudos de Psicologia (Natal)*, 7(2), 227-235.
- Bolsoni-Silva, A. T., Silveira, F. F., & Marturano, E. M. (2008). Promovendo habilidades sociais educativas parentais na prevenção de problemas de comportamento. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 10(2), 125-142.
- Caminha, M. G. (2011). Treinamento de pais: Aplicações clínicas. In M. G. Caminha & R. M. Caminha, *Intervenções e treinamento de pais*. Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Caminha, M. G., & Pelisoli, C. (2007). Treinamento de pais: Aspectos teóricos e clínicos. In M. G. Caminha, & R. M. Caminha, *A prática cognitiva na infância* (pp. 274-289). São Paulo: Roca.
- Caminha, R. M., & Caminha, M. G. (2016). *Baralho da regulação e proficiência emocional*. Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Carvalho, M. C. N. D., & Gomide, P. I. C. (2005). Práticas educativas parentais em famílias de adolescentes em conflito com a lei. *Estudos de Psicologia*, 22(3), 263-275.
- Cassiano, M., & Neufeld, C. B. (2014). PROPAIS II – programa cognitivo-comportamental de orientação de pais visando à promoção de saúde. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp. 148-180). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Coelho, M. V., & Murta, S. G. (2007). Treinamento de pais em grupo: Um relato de experiência. *Estudos de Psicologia*, 24(3), 333-341.
- Darling, N. (1999). *Parenting style and its correlates: ERIC digest*. Recuperado de www.ericdigests.org/1999-4/parenting.htm/
- Fernandes, L. F. B., Luiz, A. M. A. G., Miyazaki, M. C. D. O. S., & Marques Filho, A. B. (2009). Efeitos de um programa de orientação em grupo para cuidadores de crianças com transtornos psiquiátricos. *Estudos de Psicologia*, 26(2), 147-158.
- Hall, M. C. (1984). Responsive parenting: A large-scale training program for school districts, hospitals and mental centers. In R. F. Dangel, & R. A. Polster (Eds.), *Parent training* (pp. 67-92). New York: Guilford Press.
- Kjobli, J., Hukkelberg, S., & Ogden, T. (2013). A randomized trial of group parent training: Reducing child conduct problems in real-world settings. *Behaviour Research and Therapy*, 51(3), 113-121.
- Lebowitz, E. R., Omer, H., Hermes, H., & Seahill, L. (2014). Parent training for childhood anxiety disorders: The SPACE program. *Cognitive and Behavioral Practice*, 21(4), 456-469.
- Letarte, M. J., Normandeau, S., & Allard, J. (2010). Effectiveness of a parent training program “Incredible Years” in a child protection service. *Child Abuse & Neglect*, 34(4), 253-261.
- Lopes, M. S. O. C., Catarino, H., & Dixe, M. A. (2010). Parentalidade positiva e enfermagem: Revisão sistemática da literatura. *Revista de Enfermagem Referência*, 3(1), 109-118.

- Marinho, M. L., Caballo, V. E., & Simon, M. A. (2005). Um programa estruturado para o treinamento de pais. In V. E. Caballo, & M. A. Simon (Orgs.), *Manual de psicologia clínica infantil e do adolescente: Transtornos específicos* (pp. 417-443). São Paulo: Santos.
- Melo, M. H., & Silveiras, E. F. (2003). Grupo cognitivo-comportamental com famílias de crianças com déficits em habilidades sociais e acadêmicas. *Temas em Psicologia*, 11(2), 122-133.
- Neufeld, C. B., & Godoi, K. (2014). PROPAIS I – tópicos cognitivo-comportamentais de orientação de pais em contexto de atendimento clínico. In C. B. Neufeld (Org.), *Intervenções e pesquisas em terapia cognitivo-comportamental com indivíduos e grupos* (pp.116-147). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B., & Maehara, N. P. (2011). Um programa cognitivo-comportamental de orientação de pais em grupo. In M. G. Caminha, & R. M. Caminha, *Intervenções e treinamento de pais na clínica infantil* (pp. 149-176). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Olivares, J., Méndez, F. X., & Ros, M. C. (2005). O treinamento de pais em contextos clínicos e da saúde. In V. E. Caballo, & M. A. Simon (Orgs.), *Manual de psicologia clínica infantil e do adolescente: Transtornos específicos* (pp. 365-385). São Paulo: Santos.
- Pardo, M. B. L., & Carvalho, M. M. S. B. (2011). Grupo de orientação de mães no contexto de uma clínica-escola. *Paidéia*, 21(48), 93-100.
- Patterson, G. R. (1974). Interventions for boys with conduct problems: Multiple setting, treatments, and criteria. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 42(4), 471-481.
- Pelisoli, C., Caminha, M. G., & Rodrigues, S. G. (2016). Atualização em treino e educação parental. In R. M. Caminha, M. G. Caminha, & C. Dutra, *A prática clínica com crianças e adolescentes*. Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Quingostas, A. (2011). *Um programa de educação/treino parental – parentalidade positiva – pais atentos – pais presentes*. (Dissertação de mestrado não publicada,. Universidade Técnica de Lisboa, Lisboa).
- Reppold, C. T., Pacheco, J., Bardagi, M., & Hutz, C. S. (2002). Prevenção de problemas de comportamento e desenvolvimento de competências psicossociais em crianças e adolescentes: Uma análise das práticas educativas e dos estilos parentais. In C. S. Hutz, *Situações de risco e vulnerabilidade na infância e na adolescência: Aspectos teóricos e estratégias de intervenção* (pp. 7-51). São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Salvo, C. G. D., Silveiras, E. F. D. M., & Toni, P. M. D. (2005). Práticas educativas como forma de predição de problemas de comportamento e competência social. *Estudos em Psicologia*, 22(2), 187-195.
- Sanders, M. G., & Epstein, J. L. (2000). Building school-family-community partnerships in middle and high school. In M. G. Sanders (Ed.), *School students placed at risk: Research, policy and practice in the education of poor and minority adolescents* (pp. 339-611). New York: Lawrence Erlbaum.
- Serra-Pinheiro, M. A., Guimarães, M. M., & Serrano, M. E. (2005). A eficácia de treinamento de pais em grupo para pacientes com transtorno desafiador de oposição: Um estudo piloto. *Revista de Psiquiatria Clínica*, 32(2), 68-72.
- Silva, A. T., Del Prette, A., & Del Prette, Z. A. (2000). Relacionamento pais-filhos: Um programa de desenvolvimento interpessoal em grupo. *Psicologia Escolar e Educacional*, 3(3), 203-215.

Weber, L. N. D., Brandenburg, O. J., & Salvador, A. P. V. (2006). Programa de Qualidade na Interação Familiar (PQIF): Orientação e treinamento para pais. *Psico*, 37(2), 139-149.

Weber, L. N. D., Selig, G. A., Bernardi, M. G., & Salvador, A. P. V. (2006). Continuidade dos estilos parentais através das gerações: Transmissão intergeracional de estilos parentais. *Paidéia*, 16(35), 407-414.

19



GRUPO DE APOIO COMO ESTRATÉGIA DA TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL PARA PREVENIR E PROMOVER SAÚDE: POSSIBILIDADES E DESAFIOS

Janaína Bianca Barletta

Os programas de prevenção a transtornos, sejam eles mentais ou físicos, visam evitar o adoecimento ou a problemática, bem como minimizar os fatores de risco e/ou aumentar os fatores de proteção. Já os programas promocionais de saúde visam capacitar as pessoas na melhora da própria qualidade de vida e de saúde, fortalecendo o bem-estar psicológico, o manejo

emocional, cognitivo e comportamental, a relação interpessoal e com o ambiente. Dessa forma, pode-se dizer que a prevenção e a promoção de saúde são áreas cujo objetivo se sobrepõe, uma vez que tanto o fortalecimento de fatores protetivos quanto a minimização do impacto de fatores de risco existentes em um contexto específico e/ou para a população-alvo potencializam o bem-estar. Ambos fortalecem o desenvolvimento de “. . . comunidades mais seguras, mais produtivas, mais instruídas, mais coesas e, seguramente, mais felizes . . .” (Murta & Barletta, 2015, p. 10). Segundo Abreu, Barletta e Murta (2015), a relação entre fatores de risco e de proteção é direta, pois, à medida que se aumentam os fatores de proteção, os riscos são minimizados.

Os programas de prevenção e promoção de saúde podem ter diferentes focos: na pessoa, no ambiente ou, ainda, combinado. O foco na pessoa visa promover competências individuais ou determinantes cognitivo-comportamentais, como habilidades sociais, otimismo e práticas relacionais positivas. Já o foco no ambiente é voltado para fatores de proteção e determinantes comunitários e sociais, como aumento de atividades de lazer a partir de parques e centros esportivos, de atividades de leitura e aumento acesso aos livros ou mesmo por fortalecimento de normas culturais e políticas públicas de diminuição da desigualdade e da exposição ao risco na comunidade (Murta & Barletta, 2015).

Portanto, os programas devem levar em consideração aspectos individuais e familiares (idade, sexo, fatores hereditários, estilo de vida e relações interpessoais), da comunidade (incluindo as redes sociais, condições de vida e de trabalho) e/ou das condições mais amplas, como aspectos socioeconômicos, culturais e ambientais (Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde [CNDSS], 2008). Rohrbach (2014) reforça essa ideia, afirmando que, ao se planejar uma intervenção preventiva e/ou promocional de saúde, em função de sua complexidade, é preciso que uma diversidade de aspectos seja levada em consideração na tomada de decisão sobre os comportamentos de saúde que se deseja instalar, fortalecer ou mesmo minimizar. Entre esses aspectos, podemos citar: prevalência, fatores de risco e de proteção que estão associados ao comportamento em questão, a

estratégia mais adequada de intervenção, o subgrupo que irá participar e como este terá acesso à intervenção, bem como a aplicabilidade e execução do programa no contexto específico. Em adição a esses fatores, Westmaas, Gil-Rivas e Silver (2007) indicam que aspectos como a motivação do participante e a identificação de seu repertório inicial também são necessários para o sucesso da intervenção.

Alguns modelos para o planejamento de programas preventivos e promocionais de saúde são descritos na literatura. Por exemplo, De Vries (2014) propõe um modelo em que três etapas devem ser levadas em consideração: a análise inicial, a intervenção em si e a continuação do programa intervencionista. A primeira etapa vislumbra embasar o desenvolvimento da intervenção, a partir do esclarecimento sobre a problemática. Essa etapa é contemplada pela avaliação de necessidades, cuja função é definir o problema, sua extensão e as condições em que ocorre. Além disso, identificar os principais fatores de risco e de proteção possibilita ao profissional elencar as metas que deseja alcançar com sua intervenção. Ressalta-se, ainda, a importância de definir a população-alvo, analisar os determinantes motivacionais e a melhor maneira de ofertar a intervenção para que seja acessível aos participantes. Para essa etapa inicial, várias estratégias de levantamento de informação podem ser utilizadas, como observação direta, opinião da comunidade, entrevistas, documentos oficiais e pesquisas epidemiológicas (Murta & Barletta, 2015).

Na segunda etapa desse modelo, é o planejamento da intervenção que deve ser baseado nas informações elencadas inicialmente e na teoria que guia todo o raciocínio técnico e tático. Esse planejamento abarca três aspectos: os objetivos e resultados esperados, o desenvolvimento da intervenção e a avaliação (Murta & Barletta, 2015; Westmaas et al., 2007). Pode-se dizer que o desenvolvimento da intervenção, as técnicas e estratégias a serem utilizadas e a pré-testagem contemplam esse momento.

A terceira etapa apresentada pelo modelo de De Vries (2014) não acontece em todo programa de intervenção de grupo, mas para a área da prevenção e promoção de saúde é de extrema relevância: o compromisso em difundir as práticas saudáveis, com intervenções continuadas e sustentáveis, que possam

ampliar os ganhos. Dessa forma, adotar estratégias de difusão se faz necessário, como a inserção em diversos serviços que passa, inicialmente, pela possibilidade de adoção do programa por diretores de escolas, líderes comunitários, gestores serviços de saúde e de empresas. A divulgação das intervenções de promoção de saúde requer investimento para a implementação do programa em novos contextos, levando em consideração aspectos do ambiente, o treinamento de profissionais, as adaptações da intervenção, das técnicas ou do material – sem, contudo, perder sua fidedignidade ao programa e à teoria base, bem como o monitoramento da qualidade da atuação. O momento seguinte da difusão seria disseminar o programa para regiões maiores e possibilitar sua sustentabilidade a partir do estabelecimento de parcerias diversas e do desenvolvimento de políticas públicas (Murta & Barletta, 2015).

Outro modelo para a elaboração de projetos de intervenção preventiva e promocional de saúde apresentado na literatura é o de Rohrbach (2014), que também contempla três etapas: o suporte teórico e sua aplicação na intervenção, a concepção da intervenção e o estudo-piloto, a fim de testar a intervenção. Murta e Santos (2015), ao revisarem esse modelo, elaboraram a ilustração reproduzida na Figura 19.1.



Figura 19.1 Resumo das três etapas para elaboração de intervenções segundo Rohrbach.

Fonte: Murta e Santos (2015).

Partindo desse entendimento, verifica-se que um aspecto amplamente citado está na aplicação da teoria que embasa o entendimento dos determinantes sociais, ambientais e comportamentais de saúde, bem como fornece possibilidades e estratégias de intervenção para alcançar as metas e resultados esperados do programa preventivo e/ou promocional de saúde (De Vries, 2014; Murta & Barletta, 2015; Rohrbach, 2014). Com base nesse raciocínio, verifica-se que a terapia cognitivo-comportamental em grupo (TCCG) tem sido utilizada como uma estratégia importante em diversos contextos e para diferentes propósitos, cuja intervenção pode ter objetivos preventivos e/ou promocionais de saúde ou mesmo curativos e/ou de solução de problemas (Santana, Silva, Gonçalves, & Melo, 2014).

A TCCG se assemelha à terapia cognitivo-comportamental individual no que diz respeito aos pressupostos teóricos que embasam a ambas, como a identificação dos pensamentos, a modulação das emoções e o gerenciamento de comportamentos, além das habilidades terapêuticas necessárias (socratização do diálogo, o empirismo colaborativo, a descoberta guiada, o foco claro e metas específicas, entre outras). A estrutura, ainda que com algumas diferenças da intervenção individual, também é uma prerrogativa do processo grupal baseado na perspectiva cognitivo-comportamental. Por sua vez, a literatura aponta algumas características que são específicas da TCCG e que diferem da proposta individual, como a participação de um terapeuta e coterapeuta durante o processo grupal (Neufeld, 2011; Söchteng, 2014).

Neufeld (2011) descreve quatro modalidades da TCCG, sendo que três delas podem ser claramente ligadas às intervenções preventivas e promocionais de saúde: os grupos de apoio, psicoeducativos e de orientação e/ou treinamento. De acordo com Bieling, McCabe e Antony (2008), a intervenção em TCCG pode ser organizada didaticamente em quatro estágios: a) inicial, em que há a exploração de expectativas e a orientação do processo; b) de transição, em que se lida com as resistências apresentadas pelo grupo; c) de trabalho, que tem por objetivo facilitar e encorajar a reestruturação cognitiva e a mudança comportamental; d) final, cujo propósito é fortalecer as mudanças e desenvolver metas contínuas dos participantes.

Ao fazer um paralelo entre os aspectos essenciais dos programas de prevenção e promoção de saúde com a literatura sobre TCCG, entende-se que alguns pontos são indicados como cruciais para ambos. Por exemplo, a partir das informações elencadas anteriormente, identificamos que vários aspectos da análise inicial e do planejamento de intervenção descritos no modelo de De Vries (2014) são similares aos elementos contidos nas três etapas do modelo de Rohrbach (2014). Alguns desses fatores são identificados como questões pré-grupo no desenvolvimento de intervenções de TCCG (Bieling et al., 2008; Neufeld, 2011). Podemos destacar, ao planejar a TCCG para uma população-alvo, os seguintes pontos: a) critérios de seleção, inclusão e exclusão; b) modalidade do grupo a ser ofertada; c) as mudanças cognitivas, emocionais e comportamentais esperadas; d) as técnicas e os recursos necessários para a intervenção; e) o conteúdo a ser abordado; f) o desenho do programa total e de cada sessão; e g) o tempo de duração da intervenção. Outros aspectos citados na literatura de TCCG que se assemelham aos elementos propostos em programas de prevenção e promoção de saúde são referentes às questões pós-grupais, como a possibilidade de *follow up* e a importância da avaliação do processo grupal. Ressalta-se que a avaliação do programa é um passo que não deve ser negligenciado, pois permite aprimorar seu desenvolvimento e qualidade. Seguindo esse raciocínio, em programas de intervenção em prevenção e promoção de saúde, uma das finalidades do estudo-piloto é possibilitar que a avaliação seja realizada, para que a intervenção seja lapidada e chegue ao seu formato definitivo (Murta & Barletta, 2015; Murta & Santos, 2015).

Dessa forma, a depender do objetivo a ser alcançado, o programa de intervenção pode abordar apenas um ou diferentes temas. Essa variação também pode ocorrer na quantidade de sessões, como uma única sessão, em caso de intervenções breves (Leandro-França, Barletta, Murta, & Tavares, 2015), até múltiplas sessões, chegando a mais de 12 (Neufeld, 2011). Para tanto, um passo fundamental no desenvolvimento de programas de prevenção e promoção de saúde é a construção de um modelo lógico da intervenção, considerado como parte da etapa de estudo preparatório por Rohrbach (2014).

O modelo lógico é uma ferramenta que se propõe a facilitar a manutenção da fidedignidade da intervenção, possibilitando uma linguagem comum entre os profissionais que participarão da ação interventiva e ressaltando os componentes centrais do programa em uma representação gráfica. Essa estrutura pode ser adaptada ao longo do programa, em especial durante o estudo-piloto, para que possa ser viável no contexto em que a intervenção será desenvolvida. Nesse sentido, permite expor os temas e atividades relevantes e descrever fatores associados à problemática e ao contexto, assim como os resultados esperados (Romeiro, Nogueira, Tinoco, & Carvalho, 2013). Ou seja, é a descrição visual dos recursos existentes, também chamados de entradas, para a realização de atividades específicas (processo ou intervenção) com o intuito de alcançar resultados proximais e distais em determinado contexto ou para determinada população-alvo. Pode-se dizer que o modelo lógico é a visualização das peças-chave, das ações do programa e do produto que se deseja alcançar (McLaughlin & Jordan, 2010). Uma das vantagens associadas à elaboração do modelo lógico do programa é a possibilidade de formular relações entre os componentes do programa, o que, por sua vez, favorece a identificação de variáveis que indicam a eficácia e a efetividade da intervenção (Murta & Santos, 2015).

Com base na literatura até aqui descrita sobre programas de prevenção e/ou promoção de saúde e de TCCG, este capítulo tem por objetivo relatar uma experiência com um grupo de apoio realizada com casais heterossexuais sorodiscordantes para HIV/aids. As atividades descritas neste capítulo fizeram parte de um projeto maior, e uma das frentes consistia na realização de grupos psicoeducativos e grupos de apoio para a comunidade de uma Região Administrativa (RA) do Distrito Federal (DF). O projeto foi realizado por uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) no formato de uma organização não governamental (ONG), sem fins lucrativos, cujo propósito de ação é a prevenção e a promoção de saúde no combate à aids junto à comunidade do DF.

A escolha de descrever essa modalidade de intervenção foi em função de grupos de apoio serem menos frequentes na literatura em TCCG (Neufeld, 2011) e da necessidade de se compreender e discutir sobre a sexualidade de

peessoas que vivem com HIV/aids, no intuito de promover melhor qualidade de vida (Maksud, 2012; Reis & Gir, 2010; Said & Seidl, 2015). Esses autores salientam que, com a melhora da qualidade da medicação antirretroviral, muitos ganhos foram alcançados, como a menor quantidade de drágeas a serem ingeridas diariamente, menos efeitos colaterais e maior facilidade de alcance de carga viral indetectável. Com a maior qualidade de vida, questões inicialmente entendidas como secundárias saíram do pano de fundo para emergir como foco importante. Entre as questões, a compreensão da sexualidade e das experiências de quem vive com HIV/aids é fundamental para a discussão da adaptação de hábitos, crenças e significados a esse respeito, para aumento do autocuidado, autoconhecimento e autoeficácia dos pacientes e para a qualificação de profissionais da saúde para uma assistência mais adequada.

DESCRIÇÃO DA EXPERIÊNCIA

Para análise inicial, etapa base para o desenvolvimento da intervenção, foi feito um levantamento das pessoas cadastradas na ONG que moravam na RA escolhida. Esse levantamento possibilitou identificar idade, gênero, estado civil, condições socioeconômicas e de habitação, ocupação, uso ou não de medicação antirretroviral, local de tratamento, problemas de saúde, se o indivíduo frequentava as atividades da ONG e as dificuldades que apresentava. Após esse levantamento inicial, foi realizada uma entrevista com as pessoas que mais frequentavam a ONG, a fim de identificar as dúvidas e as dificuldades mais comuns em relação ao tratamento e aos cuidados de saúde. A entrevista também foi realizada com os profissionais da ONG, no intuito de entender quais eram as dificuldades mais frequentes em seus atendimentos e quais eram consideradas as de maior impacto para o cuidado em saúde. Após essa avaliação de necessidades e dos fatores associados à problemática (HIV/aids), escolheu-se a quem os grupos seriam destinados e os principais temas a serem discutidos.

Foram identificados quatro públicos distintos:

- a. Grupo com casais heterossexuais sorodiscordantes, em que apenas um dos cônjuges tem o diagnóstico de HIV. O propósito foi discutir as dificuldades da relação afetiva e sexual e cuidados com a saúde.
- b. Grupo de mulheres, diagnosticadas ou não com HIV, em uso ou não de antirretrovirais, para discussão e compartilhamento de cuidados em saúde, práticas de sexo seguro, relacionamentos familiares e amorosos. Nesse grupo, além das pacientes, suas filhas, netas, irmãs, etc., também poderiam participar.
- c. Grupos de pessoas homossexuais, em uso ou não de antirretrovirais, cujo objetivo foi discutir as dificuldades no cuidado da saúde e do tratamento e o preconceito, incluindo o cuidado com a saúde, o trabalho e as relações amorosas.
- d. Grupos de pessoas transexuais e travestis soropositivas para HIV, no qual a discussão focava a autoaceitação, a relação com a sociedade e o preconceito, a sexualidade, o cuidado com a saúde e dificuldades com o tratamento.

Além dos grupos, que aconteciam em separado, semanalmente, foram planejadas atividades comemorativas, aos sábados, uma vez ao mês, com todos os participantes. O objetivo dessa atividade era aumentar o sentimento de pertencimento à ONG e a rede de apoio social entre pessoas da mesma comunidade. A chamada para o projeto foi realizada no próprio espaço da ONG, com cartazes e por meio do boca a boca entre profissionais e usuários. Além disso, aqueles que tinham sido contatados para o levantamento inicial também foram convidados a participar. Todos os grupos e as duas atividades comemorativas aconteceram em um espaço particular, um clube local, mas que tinha parceria com algumas instituições públicas e com a ONG, facilitando as atividades comunitárias.

Para a elaboração das intervenções, inicialmente algumas perguntas nortearam a tomada de decisão para o planejamento das atividades de grupo pelos profissionais: qual é a necessidade dos participantes deste grupo? Quais os recursos disponíveis para colocar em prática a intervenção? Como parte da

etapa preparatória, a Figura 19.2 representa o modelo lógico do grupo de apoio com casais sorodiscordantes:

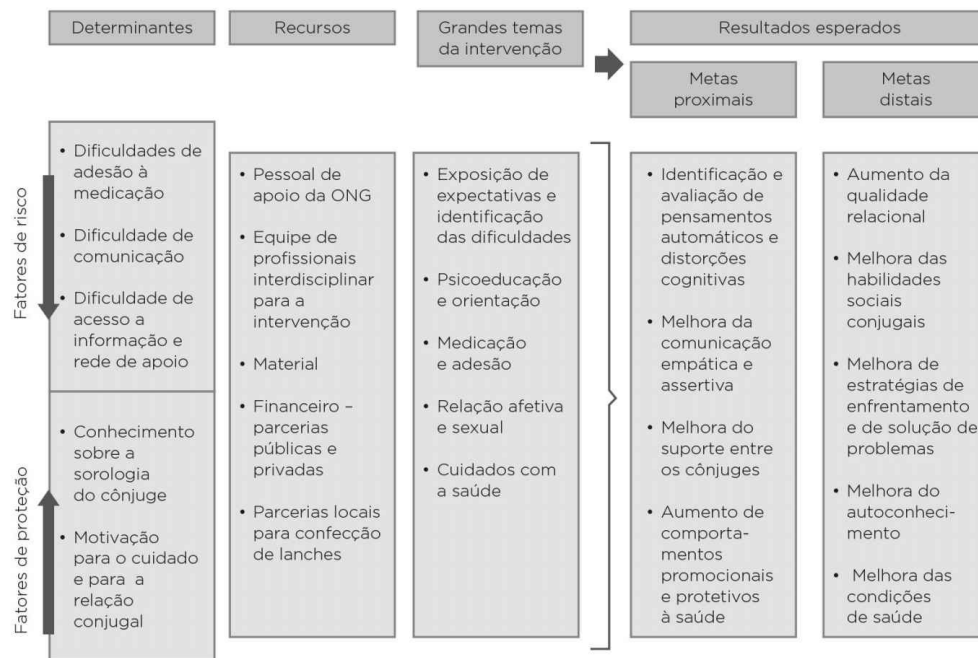


Figura 19.2 Modelo lógico do grupo de apoio com casais sorodiscordantes.

O GRUPO DE APOIO COM CASAIS SORODISCORDANTES

Segundo Neufeld (2011), os grupos de apoio podem ser abertos, com uma estrutura variável, e são, fundamentalmente, espaços para discussão da problemática e suporte à instalação ou à manutenção de comportamentos saudáveis. Não são grupos terapêuticos, mas são coadjuvantes ao tratamento por reforçarem os comportamentos protetivos e minimizarem os de risco, bem como por auxiliarem pessoas no processo de adaptação e de harmonização em momentos de mudanças, podendo promover um reajuste da qualidade de vida (Alvarez, Gomes, Oliveira, & Xavier, 2012). Nesse sentido, são considerados como importante estratégia para prevenir transtornos e promover saúde. Além disso, Seidl e Faustino (2014) sugerem que a escolha da intervenção cognitivo-comportamental tem sido uma alternativa no cuidado de pessoas com doenças crônicas em função da

proposta educativa, de solução de problemas e de desenvolvimento de habilidades pessoais, relacionais e sociais.

Participaram seis casais sorodiscordantes para HIV/aids, com relacionamento estável de pelo menos um ano. Cinco casais descobriram o diagnóstico de um dos cônjuges depois de já estarem juntos, e apenas um dos casais se conheceu após saber sobre o diagnóstico. Os participantes tinham idade entre 28 e 46 anos, com baixa renda, sendo que três mulheres cuidavam da casa, e outras duas pessoas estavam desempregadas, ou seja, cinco participantes não tinham fonte de renda. As ocupações laborais passavam por diarista, jardineiro, frentista e ajudante de pedreiro. O nível de escolaridade variou de fundamental incompleto a ensino médio completo. Duas pessoas alegaram não saber ler, o que dificultava entender e lembrar das orientações médicas. Outras duas informaram que tinham muita dificuldade na leitura e compreensão textual, ainda que soubessem ler.

O grupo de apoio aconteceu em seis sessões de 2 horas de duração cada, intercaladas por dois encontros com atividades comemorativas do grande grupo do projeto. Apesar de seu formato aberto, em que outros casais pudessem entrar ao longo do processo, o grupo permaneceu com os mesmos integrantes do início ao fim. Como facilitadoras do grupo de apoio, sempre havia duas profissionais. Algumas vezes, três profissionais participavam. Uma psicóloga era a terapeuta responsável, enquanto outra psicóloga ou a assistente social participavam como coterapeutas. As sessões grupais foram estruturadas como mostra o Quadro 19.1.

Quadro 19.1. Estrutura dos encontros

Início	• (Re)estabelecimento do <i>rappor</i>t, a fim de facilitar o vínculo e a possibilidade de exposição dos membros do grupo • Estabelecimento da agenda: – Resgate dos principais pontos que foram elencados no fechamento da sessão anterior – Rever o que os casais entenderam do processo até o momento, o que foi útil na semana deles e o que ainda ficou de dúvidas/dificuldades (tarefa de casa) – Apresentação dos objetivos e conteúdos planejados para aquele encontro
Meio	• Discussão ou execução da atividade proposta
Fim	• Sumarização das principais ideias discutidas pelo grupo e <i>feedback</i> • Tarefa de casa: discutir em casa (entre o casal) o que foi entendido e o que é possível colocar em prática na realidade deles e apresentar para o grupo na semana seguinte

Os encontros foram previamente estruturados, mas os temas a serem discutidos no grupo de apoio com casais sorodiscordantes foram sendo elencados a cada encontro. Ainda que se tivesse uma ideia prévia dos assuntos mais importantes a serem trabalhados após a etapa inicial de análise (De Vries, 2014), a proposta era que o próprio grupo pudesse elencar suas prioridades a cada sessão. Dessa forma, cada encontro era finalizado com a sugestão do tema principal para a sessão seguinte, que poderia ser refinada durante a própria sessão. Acredita-se que essa proposta esteja ligada com o objetivo primordial da modalidade de grupo escolhida (de apoio) (Neufeld, 2011) e fortaleça o sentimento de pertencimento dos participantes, já que estes podem ser ativos na construção do próprio processo, de acordo com suas demandas e necessidades. A psicoeducação, o diálogo socrático, a busca de evidências para questionar os próprios pensamentos, a construção de pensamentos alternativos, a seleção de vantagens e desvantagens, a biblioterapia, a solução de problemas e o automonitoramento (ou monitoramento realizado em conjunto pelo casal) foram as técnicas utilizadas e ensinadas no grupo.

1ª SESSÃO

A primeira sessão teve por objetivo o estabelecimento de um *rapport* inicial, a fim de favorecer o vínculo entre os participantes e facilitadores e a possibilidade de exposição no grupo. O acolhimento inicial aumenta a possibilidade do estabelecimento de uma relação adequada e confiável entre os participantes e profissionais, sem audiência punitiva, em que se possa falar abertamente de questões da sexualidade e intimidade sem preconceitos (Seidl & Faustino, 2014). Pretende-se que os integrantes possam se apoiar uns nos outros e servir de modelos com propostas alternativas para solucionar problemas comuns no grupo. A TCCG reconhece e se sustenta na possibilidade de troca e na relação bidirecional e genuína entre seus participantes.

Dessa forma, inicialmente, as facilitadoras, que já conheciam todos os casais, propuseram uma dinâmica de apresentação, já que nem todos os participantes se conheciam. Foram formados três grupos com dois casais, em

que cada pessoa deveriam dizer seu nome, sua principal qualidade e o que mais gostava no companheiro. No momento seguinte, cada casal apresentava o outro casal para todos os participantes do grupo.

Após essa atividade, as facilitadoras apresentaram o objetivo do grupo de apoio e como deveriam funcionar as relações no grupo. O propósito foi estabelecer o contrato verbal, incluindo as questões sobre respeito, dúvidas, horário, tempo de duração, etc. Entende-se que o contrato deve ser pactuado de forma clara e conjunta, mantendo a ideia de que algumas regras podem ser modificadas ao longo do processo, a fim de atender a demanda do grupo. Precisa, ainda, contar com o aceite e a concordância de todos os participantes (Weber, Salvador, & Brandenburg, 2009). Alguns itens, como respeito ao outro e sigilo, foram lembrados em cada início de sessão.

Em seguida, foram identificadas as expectativas sobre o grupo e a motivação para participar. Nesse momento, algumas crenças sobre a medicação, a eficácia do tratamento e os métodos preventivos, assim como sentimentos sobre o diagnóstico e o casamento, também apareceram. Esse primeiro momento foi importante para que temas fundamentais pudessem ser ressaltados e organizados para os próximos encontros, bem como para o estabelecimento de metas proximais.

No fim do encontro, ficou combinado que a sessão seguinte seria destinada a esclarecer conceitos e informações sobre o HIV/aids. Como tarefa de casa, os casais ficaram de fazer uma lista com as principais perguntas e dúvidas. O *feedback* dos casais foi de empolgação para vivenciar o processo e a sensação de acolhimento.

2ª SESSÃO

Para iniciar a segunda sessão, de forma descontraída, foi questionado quem lembrava o nome de mais casais. Essa atividade foi proposta com o intuito de criar um clima amigável, quebrar o gelo inicial e fortalecer a relação entre as pessoas presentes. Nem todos os casais levaram a lista de dúvidas, mas todos afirmaram que conversaram sobre o que conheciam do HIV/aids.

Foi nesse momento que um dos casais destacou que aquela atividade de casa foi a primeira vez que eles conversaram sobre o problema, pois era tido

como um tabu, ainda que ambos soubessem do diagnóstico de um dos cônjuges. Uma das principais distorções encontradas foi “se eu falar sobre minha condição (soropositividade para HIV) com minha esposa, estarei magoando-a, gerando ainda mais sofrimento” (sic). Do outro lado, a esposa apresentava uma percepção semelhante: “se eu puxar conversa sobre o assunto, ele vai achar que eu estou provocando, que eu estou jogando na cara que ele não serve para mim” (sic). Claramente, notou-se uma leitura mental de ambos os cônjuges, o que foi considerado um dos fatores de risco, já que a falta de conversa pode acarretar dificuldades de apoio do parceiro, aumento de percepções distorcidas a respeito do relacionamento e estratégias de enfrentamento inadequadas.

Na experiência de Seidl e Faustino (2014) em intervenções de aconselhamento inicial para uso da terapia antirretroviral, muitas distorções cognitivas de pessoas com HIV/aids sobre a medicação e o tratamento são identificadas, em especial a interferência arbitrária, o pensamento dicotômico, a minimização de eventos positivos e a maximização dos negativos, hipergeneralização e personalização. Vale ressaltar que a literatura sobre o atendimento cognitivo-comportamental com casais aponta que a identificação dos pensamentos automáticos e das distorções cognitivas, bem como sua avaliação e reestruturação para pensamentos alternativos, são partes essenciais e integrantes de qualquer intervenção nessa perspectiva. Assim, a psicoeducação e o automonitoramento sobre as distorções favorecem o entendimento da pessoa e facilitam a comunicação e a solução conjunta de problemas (Dattilio & Padesky, 1998; Worrell, 2015).

A partir dessa primeira discussão no grupo, foi possível iniciar a psicoeducação sobre a relação pensamento, sentimento e comportamento. Também foi com base na dificuldade apresentada por um dos casais e compartilhada por outros que a proposta para o encontro da semana seguinte surgiu: discutir sobre a comunicação entre os parceiros.

Esse segundo encontro também teve uma proposta educativa a respeito do HIV/aids, a fim de esclarecer conceitos e informações equivocados sobre o vírus, as formas de transmissão, de prevenção, os indicadores de carga viral e a medicação. A partir do conhecimento apresentado pelos próprios

participantes, foram iniciadas as discussões. Foram utilizadas algumas cartilhas do Ministério da Saúde, que ficaram com os casais, para que pudessem rever durante a semana, como tarefa de casa, e identificar dúvidas. A biblioterapia pode auxiliar no entendimento sobre o processo saúde-doença e encorajar formas mais adequadas de lidar com os problemas, resultando em maior emissão de comportamentos protetivos (Caldin, 2001). Para tanto, foi pedido para os parceiros das pessoas que tinham dificuldade de ler que as ajudassem. Outra estratégia usada foi manter o foco da discussão em grupo em cima das figuras das cartilhas.

Ainda que a informação não seja responsável pela mudança comportamental, é o primeiro passo para que seja possível mudar. Portanto, outro ponto levantado no grupo e também dado como tarefa para aqueles que fossem à consulta médica naquela semana foi como fazer perguntas para seu médico.

Notou-se que, nesse encontro, os participantes estavam mais ativos no grupo, respondendo dúvidas de outros membros, compartilhando seu entendimento ou reconhecendo a mesma dúvida como sua. De acordo com Neufeld (2011), um dos objetivos do grupo de apoio é que os participantes possam servir como suporte uns para os outros e que as discussões e trocas realizadas no processo sejam o principal fator terapêutico. Entende-se que o grupo começou a realizar sua função primordial.

3ª SESSÃO

No terceiro encontro, todos já sabiam os nomes dos demais, e o grupo estava mais coeso. Em grupos abertos, a coesão é mais lenta e fragilizada, porém, como os participantes se mantiveram os mesmos, foi possível reconhecer a receptividade e o envolvimento entre eles. A coesão também aumenta a probabilidade de a pessoa revelar informações, já que estabelece uma relação de confiança entre os membros e a terapeuta, promove o autoconhecimento e a autoconfiança em se expor sem ser punido pelos outros, assim como potencializa a elaboração de respostas cognitivas alternativas, a modelação e a modelagem de comportamentos novos (Bieling et al., 2008; Neufeld, 2011).

Inicialmente, foram revistos os pontos aprendidos e considerados importantes pelos casais durante o encontro anterior e o que foi importante para o dia a dia. Após a revisão da tarefa de casa, foi introduzido o tema escolhido para o encontro: a comunicação entre o casal. Logo em seguida, foi retomada a fala do casal que apresentou uma lacuna na comunicação, uma dificuldade comum entre os outros participantes do grupo.

Não falar sobre o diagnóstico com o cônjuge evitava o surgimento de sentimentos negativos, o que era percebido como uma forma de cuidado e respeito pelos casais. Ou seja, a falta de conversa minimizava o medo de magoar o outro, de ser considerado incompreensível e pouco empático, evitava que o outro se sentisse inferiorizado. Dessa forma, isso era considerado funcional para a dinâmica do casal, porém a consequência imediata era não encarar as dificuldades, o que, por sua vez, potencializava a falta de estratégias de enfrentamento e de solução de problemas. Uma atividade realizada no grupo foi identificar os sentimentos mais fortes e associá-los aos pensamentos automáticos e comportamentos emitidos. Palha (2016) fortalece a importância de decifrar o que a emoção identificada pretende transmitir sobre a necessidade de cada um. Assim, é possível regular a emoção e aumentar o autocontrole, questionar pensamentos distorcidos e promover pensamentos adaptativos.

Outra dificuldade consequente da falta de conversa era o afastamento entre o casal, o que gerava sentimento de solidão e de desespero, a percepção da falta de companheirismo e a incompreensão das dificuldades e dos sentimentos do outro. Todo esse contexto desfavorecia o apoio social entre o casal e fortalecia o desconhecimento de formas de ajuda. Nesse sentido, a inabilidade social, marcada pela falta da conversa empática e assertiva, foi considerada como um comportamento compensatório e de risco, que trazia um impacto importante para o casal e para o cuidado em saúde. Esse entendimento é sustentado pelos achados do estudo de Maksud (2012), que aponta a existência de segredos e silêncios entre o casal como estratégia de não se tornar vulnerável perante o olhar do outro.

O encontro foi bastante denso, com uma participação efetiva e importante dos casais, em que erros cognitivos, crenças distorcidas, comportamentos

inadequados e socialmente inábeis foram expressos. A troca entre o grupo promoveu o desenvolvimento de alternativas, como: a) incluir no dia do casal momentos de conversa sobre o diagnóstico, prognóstico e problemas enfrentados em relação à problemática de saúde; b) incluir momentos de atividades conjuntas, para que o casal pudesse fortalecer sua “unidade e intersecção”, isto é, pudesse identificar o que os unia e seus objetivos comuns; c) construir a caixa dos segredos compartilhados, em que o casal pudesse colocar seus sentimentos, pensamentos, opiniões sobre a vivência da díade e, em um dia da semana, pudessem ler e conversar sobre eles. Como tarefa de casa, ficou a proposta que todos os seis casais pudessem colocar em prática as soluções encontradas para as dificuldades apresentadas pelo grupo.

Entre a terceira e a quarta sessão, foi realizada uma atividade comemorativa, que contou com os participantes de todos os grupos e todos os profissionais da ONG, desde aqueles que estavam nas atividades de intervenção grupal até aqueles que exerciam a função de apoio. Essa atividade foi nomeada pelos participantes como a “festa do encontro”, já que foi um momento descontraído, de celebração, com música, lanche e muita risada.

4ª SESSÃO

A sessão grupal foi iniciada com a lembrança da atividade comemorativa, que foi bastante elogiada por todos. Nesse encontro, foram retomados os pontos considerados mais significativos até aquele momento. Um *feedback* importante dos participantes foi que os encontros aconteciam de forma conjunta com o companheiro, já que eles não haviam vivenciado outros momentos do tratamento com a participação do cônjuge, seja na própria ONG, seja na unidade de saúde. Partindo dessa observação, foi retomada a necessidade de conversar para prevenir desfechos negativos, sejam nas relações, sejam nas práticas comportamentais pouco saudáveis. A revisão da tarefa de casa foi o ponto inicial para a introdução do tema proposto para a sessão, que estava ligado às práticas sexuais seguras entre o casal.

O casal que se conheceu após o diagnóstico apresentou menos dificuldades. Segundo eles, o uso sistemático do preservativo era uma prática

que não precisava ser negociada, que já estava incorporada na rotina. Porém, os casais que descobriram o diagnóstico após a união estável apontaram o uso da camisinha como uma dificuldade, uma vez que exigia deles uma mudança comportamental que demandava muito esforço. O uso do preservativo, por alguns, não promovia a satisfação sexual. Alguns pensamentos automáticos identificados foram: “Puxa! Lá vou eu, de novo, brigar com esse troço (sic), “eu não consigo gozar, vou brochar, ela vai questionar minha masculinidade” (sic), “esse cheiro horroroso, essa coisa gosmenta, já me dá ânsia de vômito” (sic). Para outros, esse uso evocava os sentimentos de traição, infidelidade, de pouco amor e reforçava a diferença de condição (sorologia) entre o casal.

A dificuldade comum entre os casais foi o medo intenso de contaminar o parceiro e/ou de ser contaminado. Sentimentos de culpa e de responsabilidade pelo futuro da saúde do outro também foram descritos. Portanto, alguns casais adotaram regras rígidas no comportamento sexual, como, por exemplo, a abstinência. Esses comportamentos extremos e rígidos foram considerados consequência do pouco conhecimento sobre as formas de transmissão e de práticas sexuais seguras, o que, por sua vez, foi entendido como fatores de risco. Algumas pesquisas mais recentes trazem resultados semelhantes, indicando o baixo nível de conhecimento, a dificuldade de mudança de comportamento entre o casal e a evitação da relação sexual para evitar a contaminação do parceiro (Reis & Gir, 2010; Said & Seidl, 2015), o que sugere a necessidade de mais intervenções com foco em casais, tanto sorodiscordantes como soroconcordantes.

Nesse encontro, foi realizada uma oficina para que todos os casais pudessem aprender a colocar o preservativo de forma correta, como armazená-lo e quais os cuidados necessários para seu uso. Além disso, foram retomadas algumas informações apresentadas na segunda sessão e no material entregue. O uso do preservativo feminino foi trazido como opção, ainda que visto com estranheza por alguns. A importância da adesão à medicação antirretroviral e como ela pode prevenir o risco de transmissão sexual da infecção quando a carga viral está indetectável também foi colocada em discussão pelo grupo.

A tarefa de casa foi denominada “Perigo vs. Prazer”, e, como as outras, deveria ser realizada pelo casal. A ideia era que pudessem identificar quais eram os pensamentos e sentimentos que apareciam nas situações discutidas na sessão consideradas como perigo e quais apareciam nos momentos considerados como prazer. Depois de elencar esses pontos, o casal deveria identificar pensamentos alternativos ou estratégias de enfrentamento para lidar com as situações de perigo.

5ª SESSÃO

Esse encontro foi iniciado com a discussão da sessão anterior. A revisão da tarefa de casa se tornou a própria discussão central do grupo. A falta de conhecimento foi considerada uma questão importante para os participantes, que retomaram a necessidade de compartilhar informações e estratégias entre o próprio casal. Nesse momento, foi revista a forma de fazer perguntas para o médico, e vários participantes contaram como faziam, quais dificuldades tinham, qual receio sentiam de fazer certas indagações.

Os cônjuges soronegativos, que, em geral, não acompanhavam a consulta, consideraram a reavaliação desse comportamento como fundamental. Esse foi um ponto bastante discutido, e a conclusão do grupo foi que a baixa participação do parceiro acarretava o desconhecimento do tratamento e da medicação, bem como a falta de estratégia de apoio e de ajuda no cuidado à saúde e na adesão terapêutica. O entendimento de que a falta de parceria favorecia afastamento do casal, isolamento, sentimentos de medo e de desconfiança foi resgatado. A discussão do grupo foi finalizada com o desenvolvimento de estratégias de compartilhamento de informações e de ajuda no cuidado entre o casal, como, por exemplo, criar tabelas visuais para lembrar o parceiro do horário da medicação. Duas tarefas de casa foram propostas: a de colocar em prática as estratégias discutidas na sessão e a de acompanhar o cônjuge na próxima consulta médica com o infectologista. A segunda tarefa foi uma proposta e pactuação dos próprios participantes grupo.

6ª SESSÃO

A identificação de maneiras mais efetivas de solucionar problemas vivenciados no dia a dia de quem convive com o vírus HIV foi o último tema de discussão. A proposta final desse encontro foi fazer uma avaliação dos ganhos que os participantes tiveram com o grupo e propor sugestões de melhora da intervenção. A sessão foi repleta de sentimentos de tristeza e alegria. Tristeza pela finalização do programa, e alegria pelo aprendizado e modificação da relação. Um dos pedidos foi o de incluir treinamento de manejo de estresse e de habilidades de vida nas edições seguintes do programa interventivo, porém o propósito do grupo seria outro, bem como a modalidade de TCCG a ser escolhida.

A finalização do projeto contou com mais uma atividade comemorativa com os participantes de todos os grupos e todos os profissionais da ONG. A festa de encerramento também foi marcada por diversão e descontração. Ainda que os participantes do grupo tenham dado *feedbacks* positivos, com pedidos de manutenção da atividade em longo prazo, a maior dificuldade foi o recurso financeiro. Como o projeto teve recurso específico e limitado, com parcerias pontuais, não foi possível sua continuidade após o encerramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao considerar que o avanço da medicina científica no cuidado de pessoas vivendo com HIV/aids aumenta a sobrevida e a qualidade de vida, outros temas ganham força na atualidade, como a compreensão das necessidades e do suporte a casais sorodiscordantes. Os grupos de apoio são ferramentas importantes nesse processo, uma vez que possibilitam o autoconhecimento, a reflexão de dificuldades e potencialidades, o alívio de emoções a partir de reestruturação de pensamentos distorcidos e a reflexão sobre comportamentos de risco e protetivos. Portanto, eles têm sido utilizados por profissionais da saúde na intervenção com foco na prevenção e promoção de saúde. O grupo apresentado neste capítulo exemplificou como essa modalidade de TCCG possibilita um espaço saudável de troca, suporte e discussão que permite a prevenção e a promoção de comportamentos saudáveis, a partir das necessidades dos próprios participantes.

Foi possível observar, neste capítulo, que grupos de apoio são facilmente desenvolvidos na perspectiva cognitivo-comportamental. Pode-se dizer que o grupo descrito utilizou e manteve aspectos fundamentais da TCCG durante todo o processo:

- a. O uso da agenda, em que todos podiam participar. Ainda que as facilitadoras do grupo incluíssem objetivos e conteúdos previamente planejados para aquela sessão, a construção desses conteúdos era realizada com todos os participantes no encontro anterior. Além disso, todas as dificuldades ou dúvidas e sugestões para aquele encontro eram bem-vindas e incluídas na agenda.
- b. Ajuste dos objetivos de cada encontro, conforme as necessidades que apareciam no grupo, o que potencializava a motivação, a participação ativa e o sentimento de pertencimento, bem como satisfazia as necessidades dos próprios membros do grupo.
- c. Uso do *feedback* pelos profissionais, que o davam e solicitavam a todos os participantes, favorecendo a troca e a participação ativa.
- d. Tarefa de casa, que também foi chamada de tarefa terapêutica, em que os casais ampliavam e expandiam as discussões iniciadas no grupo para o dia a dia, podendo colocar em prática estratégias adequadas para a solução de dificuldades em seu convívio diário.
- e. Uso do questionamento socrático, favorecendo a reflexão, a tomada de decisões e o aprendizado dessa ferramenta em suas interações com a díade e com outras pessoas, dentro e fora do grupo.

Vislumbrando pela ótica da prevenção e promoção de saúde, percebe-se que, para a elaboração da intervenção, foi necessário seguir as etapas do processo, iniciando-se com um estudo preparatório, em que a avaliação de necessidade da comunidade atendida e determinantes de saúde foram importantes para a identificação das principais problemáticas e escolha do público-alvo, bem como para o desenvolvimento do objetivo da intervenção e para a construção de um modelo lógico. Por conseguinte, com base na TCCG, foi possível elaborar estratégias, contexto e material de intervenção. A partir desse ponto, o passo seguinte foi aplicar uma intervenção-piloto, que

possibilitasse a avaliação da clareza, viabilidade, atratividade, bem como aspectos que precisassem ser reformulados.

A avaliação realizada a partir dos *feedbacks* dos participantes, das anotações dos coterapeutas e das observações dos profissionais (terapeuta e coterapeutas) possibilitou elencar pontos fortes da intervenção. Verificou-se que, por ter pouca oferta de atividades para casais sorodiscordantes, o grupo foi visto como muito atrativo e relevante, obteve bastante receptividade dos integrantes e alcançou sua meta, que era de suporte, aprendizado e conhecimento interpessoal do casal. A avaliação realizada no último encontro, com todos os participantes do projeto, revelou um alto grau de satisfação. Entretanto, ela foi realizada de maneira assistemática, o que não permitiu a elaboração de dados mais consistentes.

Entre as dificuldades encontradas, duas foram consideradas de maior relevância: o pouco acesso àqueles casais que não tinham muita frequência na ONG e a continuidade do programa preventivo e promocional de saúde. Dessa forma, seria necessário rever os canais de comunicação, a fim de ampliar o grupo de participantes. Além disso, ainda que o grupo aqui descrito possa ser considerado como um estudo-piloto, ressalta-se que uma das barreiras é a sustentabilidade dos programas de prevenção e promoção. Uma vez que o recurso financeiro do projeto era limitado, não foi prevista sua continuidade. Sugere-se que, ao se planejar uma intervenção preventiva e promocional de saúde, já sejam incluídas estratégias de difusão, com todas as etapas (adoção, implementação, disseminação e sustentabilidade), a fim de potencializar as condições de continuidade do programa.

REFERÊNCIAS

Abreu, S., Barletta, J. B., & Murta, S. G. (2015). Prevenção e promoção em saúde mental: pressupostos teóricos e marcos conceituais. In S. G. Murta, C. Leandro-França, K. B. Santos, & L. Polejack (Orgs.), *Implementação de programas de prevenção e promoção no âmbito da saúde mental* (pp. 54-74). Novo Hamburgo: Sinopsys.

Alvarez, S. Q., Gomes, G. C., Oliveira, A. M. N., & Xavier, D. M. (2012). Grupo de apoio/ suporte como estratégia de cuidado: Importância para familiares de usuários de drogas. *Revista Gaúcha de Enfermagem*, 33(2), 102-108.

- Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2008). *Terapia cognitivo-comportamental em grupos*. Porto Alegre: Artmed.
- Caldin, C. F. (2001). A leitura como função terapêutica: Biblioterapia. *Encontros Bibli – Revista Eletrônica de Biblioteconomia e Ciências da Informação*, 6(12), 32-44.
- Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais de Saúde. (CNDSS). (2008). *As causas das iniquidades em saúde no Brasil: Relatório final da Comissão Nacional sobre Determinantes Sociais da Saúde* (CNDSS). Rio de Janeiro: Fiocruz.
- Dattilio, F. M., & Padesky, C. A. (1998). *Terapia cognitiva com casais*. Porto Alegre: Artmed.
- De Vries, H. (2014). *ABC's of health communication and health promotion: A brief reader*. Netherlands: Maastricht University, Departamentof Health Promotion.
- Leandro-França, C., Barletta, J. B., Murta, S. G., & Tavares, T. N. G. (2015) Intervenções breves aplicadas à prevenção e promoção em saúde mental. In S. G. Murta, C. Leandro-França, K. B. Santos, & L. Polejack (Orgs.), *Implementação de programas de prevenção e promoção no âmbito da saúde mental* (pp. 341-367). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Maksud, I. (2012). Silêncios e segredos: Aspectos (não falados) da conjugalidade face à sorodiscordância para o HIV/AIDS. *Cadernos de Saúde Pública*, 28(6), 1196-1204.
- McLaughlin, J. A., & Jordan, G. B. (2010). Using logic models. In J. S. Wholey, H. P., Hatry, & K. E. Newcomer (Eds.), *Handbook of practical program evaluation* (pp. 55-80). San Francisco: Jossey Bass.
- Murta, S. G., & Barletta, J. B. (2015). Promoção de saúde mental e prevenção aos transtornos mentais em terapia cognitivo-comportamental. In C. B. Neufeld, E. M. O. Falcone, & B. Rangé (Orgs.), *ProCognitiva: Programa de atualização em terapia cognitiva-comportamental: Ciclo 1* (pp. 9-62, Vol. 4). Porto Alegre: Artmed Panamericana.
- Murta, S. G., & Santos, K. B. (2015). Desenvolvendo programas preventivos e de promoção de saúde mental. In S. G. Murta, C. Leandro-França, K. B. Santos, & L. Polejack (Orgs.), *Implementação de programas de prevenção e promoção no âmbito da saúde mental* (pp. 168-191). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Orgs.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.
- Palha, M. (2016). *Uma caixa de primeiros socorros das emoções*. Lisboa: Manuscrito.
- Reis, R. K., & Gir, E. (2010). Convivendo com a diferença: O impacto da sorodiscordância na vida afetivo-sexual de portadores do HIV/AIDS. *Revista da Escola de Enfermagem da USP*, 44(3), 759-65.
- Rohrbach, L. A. (2014). Design of prevention interventions. In S. Sloboda, & H. Petras (Eds.), *Defining prevention science* (pp. 275-292). New York: Springer.
- Romeiro, C., Nogueira, J. A. D., Tinoco, S. G., & Carvalho, K. M. B. (2013). O modelo lógico como ferramenta de planejamento, implantação e avaliação do programa de Promoção da saúde na estratégia de saúde da família do Distrito Federal. *Revista Brasileira de Atividade Física & Saúde*, 18(1), 132-142.
- Said, A. P., & Seidl, E. M. F. (2015). Sorodiscordância e prevenção do HIV: Percepções de pessoas em relacionamentos estáveis e não estáveis. *Interface*, 19(54), 467-478.

Santana, S. M., Silva, N. G., Gonçalves, D. M., & Melo, M. C. M. D. (2014). Intervenções em grupo na perspectiva cognitivo-comportamental: Experiências no contexto da clínica-escola. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 10(1), 47-53.

Seidl, E. M. F., & Faustino, Q. M. (2014). Pessoas vivendo com HIV/aids: possibilidades de atuação da psicologia. In E. M. F. Seidl, & M. C. O. S. Miyazaki (Orgs.), *Psicologia da saúde: Pesquisa e atuação profissional no contexto de enfermidades crônicas* (pp. 21-54). Curitiba: Juruá.

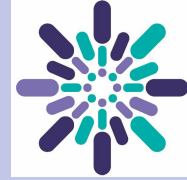
Söchteng, I. (2014). *Cognitive behavioral group therapy: Challenges and opportunities*. Oxford: Wiley Blackwell.

Weber, L., Salvador, A. P., & Brandenburg, O. (2009). *Programa de qualidade na interação familiar: Manual para aplicadores*. Curitiba: Juruá.

Westmaas, J. L., Gil-Rivas, V., & Silver, R. C. (2007). Designing and implementing interventions to promote health and prevent illness. In H. S. Friedman, & R. C. Silver (Orgs.), *Foundations of health psychology* (pp. 52-70). New York: Oxford University Press.

Worrell, M. (2015). *Cognitive behavioural couple therapy: The CBT distinctive Features Series*. New York: Routledge.

20



GRUPOS DE TCC NA SAÚDE PÚBLICA

**Conceição Reis de Sousa
Fernanda Pereira Hildebrandt
Carmem Beatriz Neufeld**

A terapia cognitivo-comportamental (TCC) é um recurso útil no rol das ações de cuidados no campo da saúde pública. As intervenções baseadas na TCC, tradicionalmente desenvolvidas para o contexto individual, vêm sendo cada vez mais adaptadas para a utilização em formato grupal. Apesar da efetividade clínica evidenciada por estudos em diferentes tipos de problemas emocionais (Burlingame, Strauss, & Joyce, 2013), é necessário estar atento à transposição entre esses dois contextos, devendo os terapeutas de grupo considerar uma formação específica para o exercício das práticas grupais. Neufeld (2011) apresenta uma série de critérios que a terapia cognitivo-comportamental em grupo (TCCG) deve atender, reforçando a ideia de que se

trata de uma intervenção baseada na TCC individual, porém com especificidades teóricas e técnicas que necessitam ser levadas em consideração por quem busca atuação na área.

Ao longo do capítulo, é discutida a necessidade de contextualização das intervenções grupais, e são apontados alguns desafios na implementação da TCCG na saúde pública. Algumas particularidades da TCCG na atenção básica, em ambulatórios e em hospitais são apresentadas a partir de exemplos que possibilitam a reflexão sobre a atuação de terapeutas cognitivos nesses cenários.

CONTEXTUALIZAÇÃO DA TCCG NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE

O cuidado com a saúde no Sistema Único de Saúde (SUS) está ordenado em níveis de atenção: básica ou primária, de média complexidade ou secundária e de alta complexidade ou terciária. A porta de entrada do sistema ocorre pela atenção básica, que envolve a prestação de cuidados a grupos populacionais pertencentes a territórios delimitados. O nível de média complexidade, por sua vez, abrange serviços ambulatoriais clínicos ou cirúrgicos e atendimentos de urgência e emergência dos hospitais gerais. Por último, encontram-se os procedimentos mais qualificados que envolvem alta tecnologia e alto custo, compondo o terceiro nível de atenção (alta complexidade). Além da continuidade, a atenção à saúde deve ter caráter integral, envolvendo ações orientadas para a promoção da saúde, a prevenção das doenças e intervenções curativas, cuidadoras, reabilitadoras e paliativas (Brasil, 2007).

Essas ações podem ser oferecidas por meio dos grupos, que têm formatos e objetivos diversos dentro do SUS, mas que apresentam um objetivo comum, que é a oferta de cuidado integral. O esquema apresentado na Figura 20.1 descreve diferentes propostas de intervenções grupais que podem ser conduzidas pelos profissionais da saúde, inclusive terapeutas cognitivos, para atuar de modo eficiente e em consonância com os princípios do SUS (Brasil, 2007).

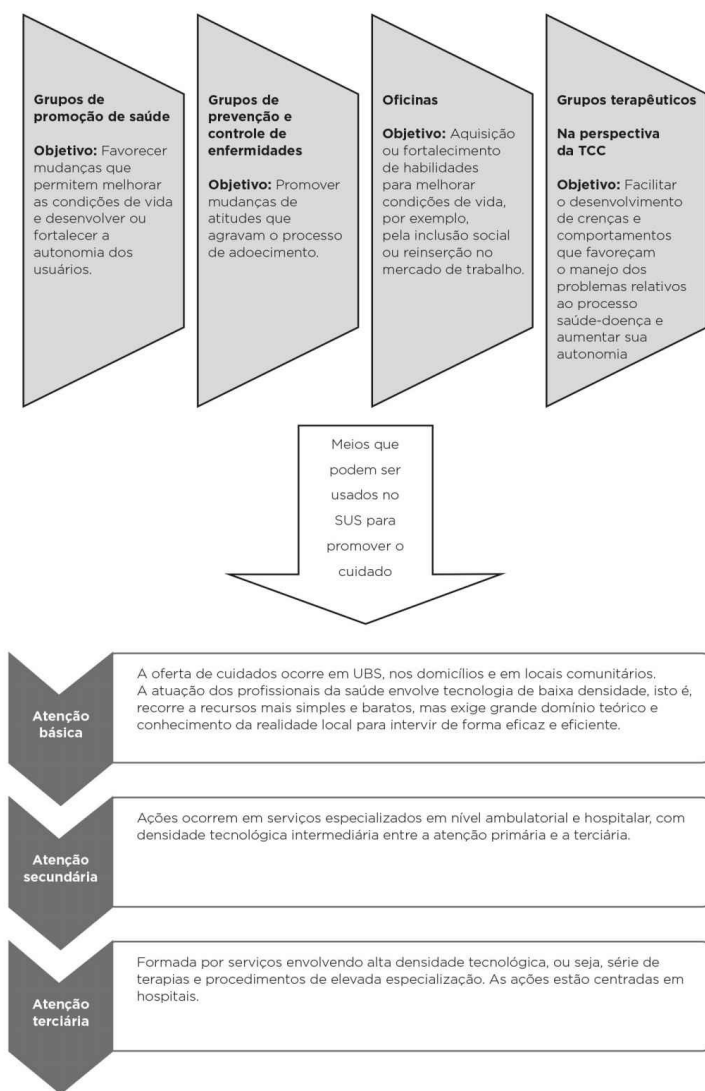


Figura 20.1 Propostas de intervenções grupais que podem ser conduzidas pelos profissionais da saúde.

Para assegurar a eficácia e a efetividade dessas ações no SUS, é necessário que os usuários, os profissionais da saúde e os gestores estejam comprometidos e corresponsáveis por suas ações. Portanto, as práticas grupais no SUS devem estar em consonância com os princípios de integralidade da atenção à saúde, da universalidade do acesso e da equidade. Dessa forma, as intervenções grupais não devem assumir um modelo tecnicista que desconsidere as necessidades da população, bem como suas especificidades culturais e psicológicas. Isso não implica negação do repertório teórico-técnico do terapeuta cognitivo-comportamental; pelo contrário, seu saber específico deve possibilitar o questionamento e a

mudança da significação do processo saúde e doença, bem como desenvolver recursos de enfrentamento dos problemas e promover saúde (Rasera & Rocha, 2010; Silva, Pereira, & Aquino, 2011).

A efetividade das práticas grupais com o referencial da TCC no contexto da saúde pública vem sendo evidenciada em diversas pesquisas. Um estudo realizado por Neves e Molina (2011) sobre TCCG e psicoterapia analítico-comportamental em grupo com pacientes com doenças crônicas aponta a efetividade dessas intervenções. Os autores constataram que os grupos de TCC focavam na discussão da doença crônica e em modos de enfrentá-la, recorrendo à psicoeducação como estratégia de intervenção central. Os grupos caracterizavam-se pelo planejamento prévio das sessões, estruturação destas, duração em torno de 90 minutos e composição entre 3 e 12 participantes em cada grupo. Resultados positivos das práticas grupais em TCC também foram apontados por outra pesquisa, realizada por Gorayeb e colaboradores (2015), em hospital público com pacientes cardiopatas, empregando psicoeducação para a redução dos sintomas de ansiedade, depressão, estresse e medidas fisiológicas.

Graves problemas de saúde pública, como o abuso sexual contra crianças e adolescentes, têm sido o foco de pesquisas interventivas envolvendo TCCG. Habigzang e colaboradores (2009) realizaram um ensaio clínico não randomizado de TCCG para crianças e adolescentes do sexo feminino vítimas de abuso sexual que ainda não haviam recebido atendimento psicológico em um serviço da rede pública. O processo grupoterápico empregou psicoeducação, treino de inoculação do estresse e prevenção à recaída para promover redução dos sintomas de depressão, ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático e reestruturação cognitiva em relação à experiência abusiva.

Brito e Seidl (2015), após realizar uma revisão teórica sobre intervenções cognitivo-comportamentais em pacientes com HIV/aids, destacaram que a TCC, além de sua efetividade nos tratamentos dos transtornos mentais, tem apresentado contribuições relevantes no âmbito da saúde com essa população em função de ser uma abordagem breve, colaborativa, estruturada e diretiva.

A efetividade das intervenções grupais – com diferentes enquadres teóricos, inclusive o da TCC – também é apontada pelo Ministério da Saúde (Brasil, 2013), que as reconhece como uma complexa ferramenta de trabalho com efeitos nos determinantes de saúde dos indivíduos e das coletividades. Apesar disto, Soares e Ferraz (2007) problematizam a frequente ausência de referências teóricas e metodológicas que direcionem as intervenções dos profissionais na coordenação de grupos nos serviços de saúde. Molena (1999 como citado por Rasera & Rocha, 2010) realizou estudos sobre intervenções grupais em saúde pública, nos quais ficou claro o frágil domínio, pelos psicólogos entrevistados, das técnicas grupais, bem como a falta de reconhecimento do profissional sobre seu papel de coordenador do grupo.

A teoria que sustenta, ou não, as técnicas usadas em intervenções em grupo interfere na forma de conduzir o grupo. Estes podem ser classificados, quanto ao principal meio de promover mudanças, como “processuais” ou “estruturados”. Os primeiros valorizam a interação aqui e agora entre os participantes do grupo como o principal recurso promotor da mudança. Já grupos estruturados, como os de TCC, enfatizam a importância de atividades pré-definidas, orientadas a estratégias terapêuticas específicas, para cada encontro (Bieling, McCabe, & Antony, 2008).

Nesse aspecto, a condução de TCC no formato grupal tende a contrastar com outras abordagens mais frequentes no âmbito da saúde pública, pois o terapeuta precisa estar atento aos aspectos interacionais que ocorrem no grupo, sem deixar de promover a aprendizagem de certos princípios e técnicas. O reconhecimento da importância tanto da técnica quanto do processo torna os grupos de TCC muito específicos.

No SUS, existem muitos grupos estruturados na perspectiva da educação em saúde ou focados nas doenças e seu manejo, como, por exemplo, aqueles para pessoas com diabetes ou hipertensão, para planejamento familiar, entre outros. Esses grupos, em geral, são voltados para a transmissão vertical do saber do especialista, contribuindo pouco para o desenvolvimento da autonomia dos usuários. Além disso, nesse tipo de intervenção, não são valorizados os aspectos processuais do grupo.

Por sua vez, um dos princípios da TCC é o de que a aprendizagem interativa promova a autonomia dos pacientes. Portanto, não é o simples planejamento e estruturação do grupo que caracteriza a abordagem cognitivo-comportamental, mas esse é um aspecto muito relevante. A forma de planejar e implementar os grupos orientados pela TCC difere daquela observada em outros grupos pelo estabelecimento claro dos objetivos, pelo modo de selecionar os pacientes e pela estruturação das sessões (Beck, 1997).

Considerando a experiência clínica das autoras deste capítulo, cabe reconhecer que existem algumas particularidades no SUS que dificultam o planejamento das práticas grupais, como:

- a. a escassez de tempo para planejamento em função da grande procura por terapia por conta da demanda espontânea, bem como de encaminhamentos feitos por outros profissionais da saúde e oriundos da rede, como escolas, Conselho Tutelar, fórum e outros (Centro de Referência em Políticas Públicas [CREPOP], 2010);
- b. a necessidade de ampliar o foco para além das dimensões cognitiva e afetiva do sofrimento vivido pelos pacientes, incluindo o desenvolvimento de habilidades de resolução de problemas concretos da vida, como desemprego, violência, falta de moradia e outros;
- c. as dificuldades com a estrutura física e os poucos recursos materiais;
- d. a escassez de profissionais devidamente treinados em TCCG, ou mesmo em intervenção em grupo, para o planejamento e a condução dos grupos.

No entanto, o planejamento adequado do grupo pode tornar o trabalho terapêutico mais eficiente, permitindo a superação da questão do grande número de pacientes que busca tratamento e desiste nos encontros subsequentes.

DESAFIOS NA IMPLEMENTAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE GRUPOS NO SUS

O terapeuta cognitivo enfrenta um grande desafio ao atuar no SUS empregando intervenções grupais. Ele precisa deixar de atuar na perspectiva

do modelo clínico focado apenas na doença e em ações individuais e aproximar-se da clínica ampliada conforme proposta na Política Nacional de Humanização (Brasil, 2007). A clínica ampliada consiste em um cuidado com a saúde voltado não apenas à eliminação das doenças, mas ao desenvolvimento da capacidade da pessoa de manejar as limitações impostas pela condição e ainda assim obter satisfação com outros aspectos da vida. Essa forma de cuidado aproxima-se muito da proposta da TCC de que o indivíduo se torne seu próprio terapeuta, desenvolvendo recursos de enfrentamento das dificuldades vividas ao longo da vida. Assim, ao propor a realização de grupos, o terapeuta cognitivo deve considerar: (a) os desejos dos usuários em relação às ações no grupo, (b) suas próprias expectativas como coordenador do grupo; (c) as possibilidades e limitações da coordenação interprofissional do grupo; e (d) a necessidade de conhecer a realidade, os problemas e as potencialidades da população atendida ao planejar os grupos. A seguir, esses aspectos são apresentados mais detalhadamente.

EXPECTATIVAS DOS USUÁRIOS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES NO GRUPO

Independentemente de o objetivo do grupo ser o tratamento dos transtornos psicológicos ou a promoção de saúde, é preciso preparar o usuário para o tipo de intervenção ao qual será submetido. Muito frequentemente, o público atendido no SUS não conhece o trabalho de um psicólogo, indo ao encontro dele por ter sido encaminhado por outro profissional da saúde (em casos nos quais não foram encontradas causas biológicas para os sintomas relatados pelo paciente) ou sem entender o tratamento (Cimino & Leite, 2016). Então, para incluir a pessoa em um processo de grupo terapêutico é preciso discutir sobre a forma como a psicologia pode contribuir para a redução do sofrimento do usuário.

Além disso, é importante esclarecer os motivos do encaminhado para a intervenção grupal, uma vez que grande parte da população que procura um psicólogo busca psicoterapia individual. Além disso, em casos nos quais o paciente não compreende sua responsabilidade/participação na busca da

resolução de problemas, possivelmente não se beneficiará de um grupo com orientação em TCC. Contudo, o psicólogo deve ter sensibilidade para reconhecer as condições objetivas de vulnerabilidade social, em que muitos estão inseridos, e facilitar o desenvolvimento de soluções compatíveis com a realidade local.

EXPECTATIVAS DOS TERAPEUTAS EM RELAÇÃO ÀS AÇÕES NO GRUPO

O grupo pode assumir um viés preventivo/educativo ou terapêutico. Ainda hoje, grande parte dos psicólogos não se reconhece como um profissional da saúde, tendo como único nível de intervenção o tratamento de transtornos psiquiátricos. Rasera e Rocha (2010) apontam que o psicólogo, frequentemente, atua no campo da saúde focando apenas nas questões psíquicas, partindo da premissa da existência de uma “cultura psicológica” universal.

Na saúde pública, o terapeuta cognitivo precisa desenvolver práticas grupais que sejam apoiadas em modelos que considerem a inter-relação entre fatores pessoais, como as cognições, os estados de humor, as reações físicas e os comportamentos e o ambiente físico e social.

A COORDENAÇÃO INTERPROFISSIONAL DO GRUPO

A eficiência da condução da TCCG está diretamente relacionada ao grau de experiência do terapeuta. Antes de conduzir grupos, o psicólogo deve ter um bom domínio do modelo e das técnicas cognitivas e, preferencialmente, ter observado outro terapeuta cognitivo-comportamental realizar práticas grupais e ter sido coterapeuta (Neufeld, 2011). Ao conduzir um grupo em TCC, é preciso estar atento ao processo grupal e ao processo de ensino-aprendizagem do modelo cognitivo e suas técnicas. Particularmente no SUS, a aprendizagem grupal exige uma abordagem que facilite o desenvolvimento de recursos sem se tornar uma “aula destituída de sentido para aqueles que a assistem” ou “um discurso persuasivo”. O princípio do empirismo colaborativo da TCC converge para a proposta de desenvolvimento da autonomia dos usuários.

No SUS, o trabalho em equipe interprofissional é valorizado porque possibilita a real troca de saberes, e não apenas a realização de trabalhos em paralelo. Portanto, a condução dos grupos por um psicólogo e outro profissional da saúde (enfermeiro, terapeuta ocupacional, assistente social, acompanhante terapêutico e outros) pode enriquecer o processo de aprendizagem grupal. Entretanto, alguns terapeutas cognitivos têm de coordenar sozinhos seus grupos – em função da falta de afinidade teórica com outros profissionais ou do número reduzido de profissionais no equipamento de saúde –, o que implica algumas perdas na forma de conduzir o grupo.

Conforme indicado por Neufeld (2015), uma estratégia que pode ser utilizada é a abertura para a atuação de estudantes ou profissionais que gostariam de se iniciar na prática em TCCG. Essa prática tem sido usada em diferentes locais e tem mostrado resultados animadores, tanto na qualidade dos grupos conduzidos quanto no aumento de investimento em formação para profissionais que buscam atualização.

O PLANEJAMENTO DOS GRUPOS

Ao planejar os grupos para o SUS, é importante ter em mente algumas questões que fornecerão seu contorno, entre elas:

- 1. Quais os objetivos do grupo?** O terapeuta cognitivo-comportamental deve saber, e compartilhar com o usuário, qual o motivo da inclusão de cada membro do grupo e ainda avaliar quais padrões cognitivos e comportamentais de cada membro podem favorecer ou desfavorecer as práticas coletivas. O grupo pode assumir, por exemplo, caráter preventivo/educativo, terapêutico ou de acompanhamento.
- 2. Grupo aberto ou fechado?** No SUS, o formato mais frequente é o aberto; já na TCCG são mais comuns os grupos fechados, com número de encontros previamente definidos e com todos os membros participando de todas as sessões, pois esse formato se encaixa melhor na valorização do processo de aprendizagem de novos recursos de enfrentamento. A escolha deve considerar os objetivos do terapeuta e da equipe de profissionais,

bem como as particularidades da população atendida. Nesse sentido, se o profissional tem apenas a possibilidade de propor grupos abertos na saúde pública, essa decisão impactará na escolha da modalidade grupal e na estrutura das sessões a serem propostas (para mais detalhes, ver Capítulo 2).

3. **Grupo homogêneo ou heterogêneo?** A composição pode contemplar fatores demográficos mais semelhantes, o que favorece a coesão grupal. O gênero, por exemplo, é um dado importante, pois um grupo com várias mulheres e apenas um homem pode dificultar muito a integração deste com o restante (nesse caso, por exemplo, poderia ser incluído mais um participante homem, visando aumentar o equilíbrio). Entretanto, quando questões de gênero estão na base ou no foco do grupo, muitas vezes não é desejável compor grupos mistos nesse quesito.

As diferenças etárias também precisam ser equilibradas, principalmente quando a diferença da idade é um fator que influi diretamente nos objetivos do grupo. Contudo, na saúde pública, muitas vezes o foco pode ser mais aberto, e a heterogeneidade pode auxiliar na flexibilização de padrões e oportunizar aos participantes o contato com novas formas de pensar, sentir e agir (Neufeld, 2011).

A constituição do grupo também deve considerar os diagnósticos/perfis sintomáticos (grupo de hipertensos, grupo de pessoas com ansiedade, grupo de pessoas com depressão, pessoas em uso prejudicial de álcool e/ou outras drogas, etc.). Maior homogeneidade tende a aumentar a coesão e reduzir o abandono do tratamento. No entanto, existem alguns benefícios com certo grau de heterogeneidade entre os membros, como o favorecimento de troca de experiências, mas divergências significativas interferem na coesão grupal (Bieling et al., 2008).

No SUS, é bastante complexa a composição de grupos homogêneos. Por exemplo, há uma recomendação do Ministério da Saúde aos profissionais que assumem, especificamente, o cuidado em saúde mental na atenção básica de evitar a formação de grupos “. . . por tipologia de agravos ou sofrimento psíquico. Deve-se buscar a diversidade grupal, reconhecendo e fazendo-se

reconhecer os sujeitos como pertencentes a um território comum . . .” (Brasil, 2013, p. 122). No entanto, é recomendação da literatura em TCCG (Bieling et al., 2008) que se busque dar prioridade a modalidades não terapêuticas de grupos, pois quanto maior a demanda e a gravidade dos sintomas a serem tratados, mais homogêneos os grupos em TCCG precisam ser para garantir sua eficácia e efetividade (Neufeld, 2011).

Ao planejar intervenções em grupo no SUS, o terapeuta deve considerar, ainda: a) as dificuldades para a realização de uma boa conceituação cognitiva para inserir no grupo, pois nos equipamentos públicos há grande pressão de encaminhamentos feitos por outros profissionais, o que pode comprometer a meta de fazer entrevistas individuais antes de os participantes iniciarem as atividades grupais; b) a grande rotatividade dos participantes, que dificulta o fortalecimento dos vínculos, bem como a estruturação das intervenções grupais; c) a percepção de grande parte da população de cuidado em saúde como uma eliminação de sintomas por meio da medicação (Poersch & Marcondes, 2014), o que pode desfavorecer a participação mais ativa nos grupos, a estruturação dos encontros e a realização de tarefas entre os encontros (para mais detalhes sobre estruturação dos grupos, ver Capítulo 2).

TCCG NA ATENÇÃO BÁSICA

Os termos “atenção básica em saúde” (ABS) e “atenção primária à saúde” (APS), de acordo com a Política Nacional de Atenção Básica, são considerados equivalentes. A saúde da família (reorientação do modo de oferecer assistência em saúde mediante a implantação, em unidades básicas de saúde [UBSs], de equipes compostas por multiprofissionais) assume papel central na atenção à saúde. A inserção como membro da equipe mínima da Estratégia de Saúde da Família (ESF) implicaria a participação do psicólogo como profissional da saúde, e não mais como especialista em saúde mental (Böing & Crepaldi, 2010).

Todavia, uma pesquisa realizada pelo Centro de Referências Técnicas em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP) (2010) indica que existe ampla variedade de ações e diversas formas de intervenção na ABS, entre elas a

coordenação de grupos de diferentes formatos, como acolhimento, psicoterapêuticos e de apoio, orientação, oficinas, temáticos e grupos informativos e palestras. Nesse cenário, as práticas grupais em TCC podem contribuir para a construção de um novo modo de atuar do terapeuta cognitivo, que envolve assumir o caráter interdisciplinar do trabalho na ABS sem deixar de delimitar a especificidade da psicologia. Nesse âmbito, a escolha do tipo de técnicas a se implementar nem sempre poderá ser feita por protocolos fechados, pois na ABS são muito comuns múltiplas queixas que revelam sintomas depressivos, de ansiedade, somatizações ou, frequentemente, os três associados. Nesses casos, o terapeuta cognitivo precisa planejar quais recursos da TCC podem favorecer a maior parte dos participantes do grupo. Por exemplo, técnicas de manejo de ansiedade costumam ser úteis para reduzir o sofrimento de grande parte dos usuários que procuram a atenção básica, como pode ser visto no exemplo apresentado a seguir:

Teresa: “Meu filho foi preso, guardou drogas na nossa casa... eu fiquei louca quando meu marido me ligou e contou. Agora, meu coração dispara toda hora, parece que vou desmaiar, e os médicos dizem que não é nada! Eu não sei onde errei!”

Maria: “Olha, a gente dá valores pros filhos, mas eles crescem e fazem o que querem, foi ele quem se meteu com drogas, não foi você! Olha, eu sei o que é os médicos falarem que a gente não tem nada, quando fiquei sem emprego ia toda hora pro pronto-socorro...”

Julia: “Quando minha mãe morreu eu também senti essas coisas... o coração na boca, dor por todo o corpo, mas acostumei.”

Marisa: “Eu tenho falta de ar, um cansaço nas pernas e uma dor de cabeça que não passa, quando meu ‘ex’ liga, ameaçando tirar meus filhos, minha cabeça parece que vai explodir, tenho que tomar um calmante!”

Terapeuta: “Vocês enxergam algo em comum no sofrimento de vocês? (após um período de silêncio). Vocês passaram ou estão passando por um

momento no qual vocês pensam que algo ruim pode acontecer a qualquer momento, não? (Diante de sinais de concordância) Quando imaginamos, ou de fato existe, a possibilidade de algo ruim ocorrer, nosso corpo se prepara para escapar ou enfrentar o perigo, e isso ocorre com a preparação física de nosso corpo, o que gera várias dessas sensações físicas que vocês já tiveram e que são bem desagradáveis, mas não perigosas!”

Maria: “Mas a gente não consegue parar elas!”

Terapeuta: “É verdade!”

Marisa: “Então, melhor é tomar o calmante.”

Terapeuta: “É um recurso tipo SOS, mas não é a melhor solução em longo prazo.”

Teresa: “Não posso fazer nada, meu filho continua sofrendo, e eu com a batedeira no coração!”

Terapeuta: “Vamos por partes, cada uma de vocês tem problemas com os quais terão que lidar, e um deles é o que fazer com as sensações corporais que surgem aparentemente do nada. Quero propor que pensemos tanto na forma de lidar com os sintomas de ansiedade quanto em possibilidades de resolução de problemas relativos às perdas e aos conflitos interpessoais.”

Ao realizar os grupos na atenção básica, o terapeuta cognitivo precisa agir de forma flexível, compartilhando com os usuários recursos que possam fortalecê-los para o enfrentamento das adversidades.

CASO CLÍNICO: TCCG EM AMBULATÓRIO PÚBLICO

Como forma de exemplificar uma possibilidade de desenvolvimento de grupos de TCC dentro da rede do SUS, citaremos a experiência nessa modalidade desenvolvida na Policlínica Piquet Carneiro (PPC), uma unidade de atenção secundária pertencente ao município do Rio de Janeiro onde são realizadas consultas e serviços ambulatoriais especializados. Em 2011, foi

criada, na PPC, um Núcleo de Saúde Mental (NSM) que é referência para aproximadamente 500 mil pessoas na rede de atenção. Um dos serviços oferecidos pelo NSM é a realização de psicoterapia individual e grupal. Em 2015, foi identificada a necessidade de ampliação do trabalho grupal, sendo a TCC reconhecida como uma abordagem que poderia ser utilizada a fim de aumentar a autonomia e a qualidade de vida das pessoas. A TCCG poderia ser eficaz não só na diminuição de sintomas psiquiátricos, mas também na instrumentalização dos usuários, buscando o desenvolvimento de uma postura mais assertiva diante da realidade.

Optou-se por realizar um grupo-piloto em TCCG para sintomas de ansiedade e depressão, já que a comorbidade entre essas condições é bastante comum (Bieling et al., 2008). Foi elaborada uma proposta de tratamento por meio de um protocolo estruturado de oito sessões e adaptado às necessidades da clientela usuária do SUS. Foram utilizados como critérios de seleção: ter mais de 18 anos, apresentar depressão leve ou moderada na Escala de Depressão de Beck, não apresentar transtorno da personalidade, não fazer uso de substâncias psicoativas e não ter prejuízos cognitivos que prejudicassem a compreensão do conteúdo das sessões de psicoterapia.

Foram selecionadas seis usuárias que aceitaram previamente participar do grupo. A faixa etária oscilava entre 55 e 65 anos, e todas estavam aposentadas e/ou exerciam atividades no lar. O grupo configurou-se homogêneo quanto ao gênero e relativamente homogêneo quanto à idade. As participantes apresentavam também queixas difusas em relação à saúde, como problemas de insônia e dores generalizadas pelo corpo. Com exceção de uma integrante, todas eram casadas. As sessões foram realizadas semanalmente no ambulatório da PPC, tinham duração de 90 minutos e eram conduzidas por uma terapeuta com mais de uma década de experiência em TCC e por uma psicóloga aluna do curso de Especialização em Psicologia Médica da Faculdade de Ciências Médicas da UERJ. Após cada sessão, havia uma supervisão para discussão do atendimento do dia.

A primeira sessão foi dedicada à psicoeducação sobre a depressão e a ansiedade, procurando exemplificar como essas condições podem afetar nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Procurou-se utilizar

uma linguagem objetiva, livre de jargões e próxima da realidade das participantes. Na TCCG, é sempre importante explorar exemplos extraídos das falas dos membros do grupo, não só para dar voz e sentido ao sofrimento psíquico, mas para que seja possível que os demais percebam que existem outras pessoas que pensam, sentem e se comportam de forma similar.

Além das técnicas de TCC, os fatores processuais grupais foram observados e utilizados em prol da utilização da máxima terapêutica do grupo. Desde o início da proposta, já na primeira sessão, foi possível observar alguns dos efeitos terapêuticos descritos por Yalom e Leszcz (2006), como a universalização e o compartilhamento de informações. Estes são exemplificados nas falas de Joelma e Lourdes:

Joelma: “Então tanta coisa que eu sinto é ligada ao nervoso? Até a quentura? Vocês também sentem a mesma coisa que eu sinto, é igualzinho! Pelo menos não estou sozinha, vocês estão comigo na desgraça”.

Lourdes: “Eu também sinto aquela pressão na cabeça quando fico nervosa, parece que vai explodir!”.

Durante a primeira sessão, foram fornecidas informações sobre as causas e o tratamento da depressão e da ansiedade. Foi entregue a cada participante um folheto com as regras de funcionamento do grupo (horário, duração, confidencialidade) e sugestões acerca das regras de funcionamento da terapia. Algumas destas últimas foram: “compartilhe seus pensamentos e ideias com outros membros do grupo”, “escute atentamente aos outros membros”, “esteja aberto ao ponto de vista das outras pessoas” e “participe da discussão”. As sugestões representavam uma forma de sensibilizar o integrante a respeito da peculiaridade do formato grupal, em que se faziam cruciais os comportamentos de ouvir, ser ouvido e respeitar o próximo.

Como tarefa de casa da primeira sessão, foi solicitado que cada membro do grupo relatasse, em um formulário, de que forma sua ansiedade e sua depressão se manifestavam, tentando identificar sintomas físicos, emoções, pensamentos e comportamentos.

Na segunda sessão, as tarefas de casa foram discutidas, e cada participante relatou como vivenciava seus sintomas de ansiedade e depressão, além da maneira como estes se relacionam com seus pensamentos, sentimentos e comportamentos. O foco dessa sessão, assim como o da posterior, foi a ativação comportamental. Como tarefa de casa, foi solicitado um plano de atividades em que cada uma listasse atividades que poderiam ajudá-las a se sentir melhor quando estivessem deprimidas. Foi explorada com o grupo a viabilidade de engajamento em atividades simples com o potencial de melhorar o nível de humor, como visitar amigos/familiares, ler, ver TV, fazer caminhadas, entre outras. É importante que as sugestões de atividades sejam viáveis dentro do contexto de vida do paciente, pois é pouco produtivo, por exemplo, incentivar a prática de caminhadas no bairro se a pessoa descreve esse ambiente como de risco, ou, então, sugerir que ela vá ao cinema se mal consegue pagar o transporte para ir ao serviço de saúde. É importante que o terapeuta tenha essa sensibilidade para que não se afaste dos membros do grupo com comentários não empáticos em relação à situação de vida deles.

Silvia: “Quando eu sinto que minha cabeça está cheia de problemas, eu pego meu tênis e saio caminhando pelas ruas perto da minha casa. Vai tudo embora, igual a nuvem.”

Terapeuta: “Olhem que interessante o que a Silvia está dizendo para a gente. Ela percebeu que a caminhada melhora a forma como ela se sente. Alguém já fez isso para afastar os pensamentos ruins? Ou já fizeram outras coisas que causaram o mesmo efeito?”

Anete: “Ah, o que eu faço que dá certo é bolo.”

Terapeuta: “Como assim, Anete, explica para a gente.”

Anete: “Eu adoro cozinhar, mas fazer bolo é o que eu mais gosto de fazer. Então, quando estou chateada, me mando pra cozinha e começo a fazer bolo!”

Maria: “Ih... então ainda bem que não sou sua vizinha! Já estou comendo igual a uma maluca de tanto nervosismo, só to engordando [risos]...”

imagina sendo sua vizinha com cheiro de bolo invadindo minha na casa?”

[Todos riem no grupo pela primeira vez desde o início do tratamento.]

Joelma: “Quando a gente melhorar, vai todo mundo comer bolo na casa da Anete!”

Terapeuta: “Então vimos aqui que existem coisas que podemos fazer que fazem nos sentir melhor quando estamos tristes ou nervosas. Todas concordam? Também me parece ser uma boa ideia vocês marcarem uma visita para comer bolo todas juntas.”

Foi observado, a partir desses relatos, que começaram a aparecer as primeiras demonstrações de instilação de esperança no grupo. A terapeuta começou a incentivar também ideias para favorecer a coesão grupal, um importante elemento terapêutico.

Na terceira sessão, o foco continuou sendo a ativação comportamental. O grupo discutiu sobre quais atividades poderiam explorar. Foi desenvolvido um plano de ação em que cada participante se comprometeria na realização de uma atividade listada, verificando, a partir de dela, quais pensamentos e sentimentos seriam disparados. Foi enfatizada a importância de cada membro registrar como se sentiu antes, durante e depois de cada atividade, a fim de avaliar o efeito da ativação comportamental.

As tarefas de casa eram sempre revistas durante a sessão, e possíveis dificuldades em realizá-las eram exploradas. Procurava-se deixar claro para o grupo qual era o objetivo e a importância da realização de cada atividade, ainda mais porque elas exigiam um esforço que talvez fosse muito precioso para as participantes do grupo. A partir de uma dessas discussões, houve a oportunidade de a terapeuta desenvolver outra habilidade com as participantes:

Silvia: “Não consegui fazer o papel que foi para casa. Não... não tive tempo... meu filho foi com minha nora e meu neto almoçar lá em casa.”

Ana: “Ai, Silvia, você não me leva a mal no que eu vou te falar, não... mas você já notou que você faz tudo para todo mundo e não tem tempo nunca

para as suas coisas? Não acho certo isso, não...”

Lourdes: “Eu sei como ela se sente... também sou assim. Família em primeiro lugar.”

Ana: “Mas gente... assim a gente fica doente. Tem que dar um basta uma hora.”

Joelma: “Eu já fui assim, eu entendo. Mas eu acho igual a Ana... não podemos fazer tudo pra todo mundo e esquecer da gente, não. Eu me decepcionei muito com as pessoas fazendo tudo para elas, engolindo tudo... agora eu não faço mais nada pra ninguém. Vou logo soltando os cachorros e dando um fora.”

Terapeuta: “Vocês estão trazendo para nosso grupo algo importante. Até que ponto temos que fazer tudo para o outro e deixar a gente de lado? E, quando queremos fazer uma coisa para a gente, será que necessariamente não podemos fazer mais nada para as outras pessoas? [Nota: esse exemplo de pensamento tudo ou nada foi usado na sessão seguinte para exemplificar um dos tipos de distorções cognitivas.] Será que tem como a gente negociar com as pessoas o que a gente quer sem ficar calada ou ‘soltar os cachorros’, como a Joelma falou?”

Por meio dessa situação, as terapeutas decidiram antecipar a introdução do treino de assertividade, que seria feito em uma sessão mais à frente do tratamento.

Na quarta sessão, o objetivo foi ensinar a técnica de resolução de problemas. Um problema foi selecionado a partir dos relatos do grupo e definido pelas participantes. Em seguida, foram listadas todas as possíveis soluções, a partir das quais uma foi selecionada para ser testada ao longo da semana e ter sua efetividade avaliada. Nessa sessão, também foi dada a continuidade do treino de assertividade, iniciado na sessão anterior a partir de dramatizações.

Na quinta sessão, o grupo explorou a relação entre situações, pensamentos, sentimentos e comportamentos, procurando constatar o efeito

dessa cadeia a partir de suas vivências. Aqui, foi dada ênfase à importância dos pensamentos, inclusive mostrando que estados de depressão e ansiedade em geral estão vinculados a eles. Também foi realizado, nessa sessão, o treino em respiração diafragmática e o relaxamento muscular, a fim de serem dadas alternativas de manejo para situações de ansiedade.

O foco da sexta sessão foi a reestruturação de pensamentos disfuncionais. Pensamentos distorcidos foram identificados pelo grupo e reavaliados de acordo com evidências, a fim de gerar respostas mais adequadas à realidade. É interessante ressaltar que os próprios membros do grupo exploravam as evidências, com pouca intervenção das terapeutas. Quanto menos houver direcionamento do terapeuta e coterapeuta, mais sentido fará o exercício, sendo o questionamento socrático de grande valia para a reestruturação cognitiva. O intuito, aqui, foi propiciar o desenvolvimento de pensamentos mais saudáveis e flexíveis.

Na sétima sessão, o grupo começou a se despedir, procurando fazer uma revisão dos conteúdos aprendidos, planos de observação e autocuidado. Aqui, o objetivo foi identificar situações de risco e pensar no que se pode fazer caso elas ocorram, criando verdadeiros “planos de emergência” diante de situações-problema.

Silvia [chorando]: “Não gosto nem de pensar que o grupo está acabando. Conhecer vocês foi a melhor coisa que me aconteceu nesse ano. Eu tenho medo da gente nunca mais se encontrar e se perder no mundo.”

Lourdes: “Isso seria muito triste... está sendo tão legal... a gente não pode continuar com o grupo?”

Terapeuta: “Eu entendo o sentimento de vocês. Foi incrível ver o quanto cada uma se doou para o grupo e ver os progressos e a amizade que cada uma criou aqui. Mas, como havíamos conversado na primeira sessão, o grupo tem uma duração limitada. Mas será que não existem formas de vocês manterem o contato?”

Silvia: “E se a gente criar um grupo de *zap*?”

Maria: “Podíamos combinar um lanche na casa de cada uma, uma vez por mês!”

Anete: “Eu faço bolo! Antes disso, vamos fazer um lanche de despedida aqui no último dia?”

[Todas riem e começam a se descontraírem, trocando os números de telefone. Estabelecem a data e a casa da Anete como o primeiro encontro do grupo após o fim do tratamento. Também decidem o que cada uma irá levar de comida/bebida na última sessão.]

Por fim, na oitava e última sessão, os planos de autocuidado são revisados, e o grupo se despede, procurando relatar como foi sua experiência naquele período. As terapeutas mostram os níveis de depressão e ansiedade individualmente para cada uma, na primeira e na última sessão, por meio dos registros das Escalas de Depressão e Ansiedade de Beck. Todas as participantes saíram de níveis de depressão leve/moderada para oscilações normais de humor. Também foi identificada uma melhora significativa nos níveis de ansiedade. O grupo terminou com uma festa de despedida realizada na sala onde ocorreram as sessões.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O grupo em geral tem uma força terapêutica que está além das técnicas dos protocolos. A possibilidade de compartilhar, de aprender novas formas de lidar com os problemas e de formar laços com pessoas que têm dificuldades semelhantes confere ao grupo um lugar especial entre as modalidades de tratamento para as dificuldades emocionais.

Conhecer a realidade dos usuários do SUS parece ser tão importante quanto dominar técnicas de TCCG. Ao lidar com o outro, é necessário entender sua linguagem, o grau de acessibilidade aos serviços de saúde, suas condições de moradia, de trabalho e de transporte. Somente assim, entendendo a saúde como mais do que ausência de doenças, e por meio do modelo biopsicossocial, será possível conectar-se com a realidade e o

sofrimento alheios, o que pode se tornar um facilitador para mudanças dos comportamentos de saúde.

A contribuição da TCCG para o campo da saúde pública deve estar vinculada ao compromisso com a produção de evidências científicas. Nesse sentido, ainda é necessária a realização de pesquisas que identifiquem variáveis que interferem na eficácia/efetividade da TCCG no SUS. Para além desse compromisso de uma atuação marcada pelo respaldo técnico-científico, a sustentação da escolha em realizar grupos orientados pela TCC no SUS exige flexibilidade do terapeuta para adequar o modelo à realidade brasileira. A TCCG nesse cenário envolve práticas que reconheçam a dimensão subjetiva do sofrimento vivido pelos usuários, sem deixar de considerar o contexto marcado por dificuldades concretas, como a violência, o desemprego, a falta de moradia, entre outras. Dessa forma, a TCCG pode contribuir para o fortalecimento da autonomia dos usuários, bem como ampliar e qualificar a atenção integral à saúde.

REFERÊNCIAS

- Beck, J. S. (1997). *Terapia cognitiva: Teoria e prática*. Porto Alegre: Artes Médicas.
- Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2008). *Terapia cognitivo-comportamental em grupos*. Porto Alegre: Artmed.
- Böing, E., & Crepaldi, M. A. (2010). O psicólogo na atenção básica: Uma incursão pelas políticas públicas de saúde brasileiras. *Psicologia: Ciência e Profissão*, 30(3), 634-649.
- Brasil. Ministério da Saúde. (2007). *Política Nacional de Humanização da Saúde: Documento base* (4. ed.). Brasília: MS.
- Brasil. Ministério da Saúde. (2013). *Saúde mental* (Cadernos de Atenção Básica, n. 34). Brasília: MS.
- Brito, H. L., & Seidl, E. M. F. (2015). Intervenções cognitivo-comportamentais em pacientes com HIV/aids: Revisão da literatura. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 17(2), 66-77.
- Burlingame, G. M., Strauss, B., & Joyce, A. (2013). Change mechanisms and effectiveness of small group treatments. In M. J. Lambert (Ed.), *Bergin and Garfield's handbook of psychotherapy and behavior change* (pp. 640-689). New York: Wiley.
- Centro de Referência em Políticas Públicas. (CREPOP). (2010). *Práticas profissionais de psicólogos e psicólogas na atenção básica à saúde*. Brasília: Conselho Federal de Psicologia.
- Cimino, A. P. N., & Leite, D. F. C. C. S. (2016). Psicologia e saúde pública: Cartografia das modalidades de prática psicológica nas policlínicas. *Revista Psicologia e Saúde*, 8(1), 14-23.

- Goarayeb, R., Facchini, G. B., Almeida, P. L., Siguihura, A. L. M., Nakao, R. T., & Schmidt, A. (2015). Efeitos de intervenção cognitivo-comportamental sobre fatores de risco psicológicos em cardiopatas. *Psicologia: Teoria e Pesquisa*, 31(3), 355-363.
- Habigzang, L. F., Strocher, F. H., Hatzenberger, R., Cunha, R. C., Ramos, M. S., & Koller, S. H. (2009). Grupoterapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual. *Revista de Saúde Pública*, 43(1), 70-78.
- Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In R. Rangé (Org.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B. (2015). Aspectos distintivos de las terapias cognitivo conductuales en grupos. *Anais del Congreso Español de Psicología Clínica*.
- Neves, M. S., & Molina, R. A. (2011). Terapia Analítico comportamental e cognitivo-comportamental em grupo: Intervenções com portadores de doença crônica. *Uniciências*, 15(1), 129-140.
- Poersch, K., & Marcondes, J. L. (2014). Terapia comunitária integrativa: Experiências sobre as rodas no território. *Cadernos de Educação, Saúde e Fisioterapia*, 1(Supl 1).
- Rasera, E. F., & Rocha, R. M. G. (2010). Sentidos sobre a prática grupal no contexto de saúde pública. *Psicologia em Estudo*, 15(1), 35-44.
- Silva, S. S., Pereira, R. C., & Aquino, T. A. A. (2011). A terapia cognitivo-comportamental no ambulatório público: Possibilidades e desafios. *Revista Brasileira de Terapias Cognitivas*, 7(1), 44-49.
- Soares, S. M., & Ferraz, A. F. (2007). Grupos operativos de aprendizagem nos serviços de saúde: Sistematização de fundamentos e metodologias. *Escola Anna Nery*, 11(1), 52-57.
- Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2006). *Psicoterapia de grupo: Teoria e prática*. Porto Alegre: Artmed.

LEITURAS RECOMENDADAS

- Alves, G. G., & Aerts, D. (2011). As práticas educativas em saúde e a estratégia saúde da família. *Ciência & Saúde Coletiva*, 16(1), 319-325.
- Conselho Federal de Psicologia.(CFP). (2009). *A prática da psicologia e o núcleo de apoio à saúde da família* [Versão eletrônica]. Brasília: CFP.
- Del Prette, A., & Del Prette, Z. A. P. (2003). Assertividade, sistema de crenças e identidade social. *Psicologia em Revista*, 9(13), 125-136.
- Mello Filho, J. (Org.). (2011). *Grupo e corpo: Psicoterapia de grupo com pacientes somáticos*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Sarmiento, C. M. (2006). Os doze preconceitos mais frequentes dos analisados em relação ao tratamento grupal. *Revista da Sociedade de Psicoterapias Analíticas Grupais do Estado de São Paulo*, 7(1), 08-16.
- Scohting, I. (2014). *Cognitive behavioral group therapy: Challenges and opportunities*. New York: John Wiley & Sons.
- White, C. A. (2000). *Cognitive behaviour therapy for chronic medical problems*. New York: John Wiley e Sons.

21



TERAPIA COGNITIVO- -COMPORTAMENTAL COM GRUPOS DE IDOSOS: DA REMEDIAÇÃO À PROMOÇÃO DE ENVELHECIMENTO POSITIVO

Altemir José Gonçalves Barbosa

Eduarda Rezende Freitas

Carmem Beatriz Neufeld

Pesquisas têm evidenciado que idosos podem se beneficiar muito com psicoterapia, que os ganhos se equiparam aos de adultos e que muitas vezes eles preferem essa opção de tratamento não farmacológico (American Psychological Association [APA], 2014; Oliveira, 2012; Söchting, O’Neal,

Third, Rogers, & Ogrodniczuk, 2013). Além disso, há concordância entre pesquisadores e profissionais de que a psicoterapia grupal pode ser eficaz para uma série de demandas e especialmente útil para os idosos (APA, 2014; Oliveira, 2012; Söchting et al., 2013). Todavia, há evidências de que faltam pesquisas sobre essa modalidade de psicoterapia com tal população.

Ao consultar a base de dados mais importante quando se trata do tema psicoterapias – PsycNET (APA, 2016) –, e considerando as duas perspectivas teóricas mais comumente adotadas por psicólogos brasileiros – Psicanálise e Cognitivo-Comportamental (Gondim, Bastos, & Peixoto, 2010) –, observa-se (Fig. 21.1) que ambas destinaram pouca atenção à (psico)terapia grupal com idosos na última década. Apenas 1,69% ($n = 85$) dos mais de 5 mil ($N = 5.041$) artigos que relatam pesquisas empíricas sobre terapia cognitivo-comportamental (TCC) têm como descritor a terapia grupal e contaram com a participação de idosos (idade ≥ 65 anos) na amostra. No caso da psicanálise, esse percentual é ainda menor, recuando para menos de 0,5% (0,37%; $n = 2$) de um pouco mais de cinco centenas ($N = 534$) de publicações.

Se o cenário atual é preocupante, as linhas de tendência da Figura 21.1 revelam que, se mantidas as características atuais da produção científica, o estado da arte sobre psicoterapia grupal com idosos será ainda mais alarmante na próxima década. Até mesmo os indicadores da TCC, modalidade de psicoterapia que tende a ter um aumento significativo da publicação de artigos que relatam pesquisas empíricas em geral e também com idosos (TCC-I) nesse período, são apreensivos, pois a produção sobre TCC-I grupal (TCCG-I) tende a diminuir nos próximos anos.

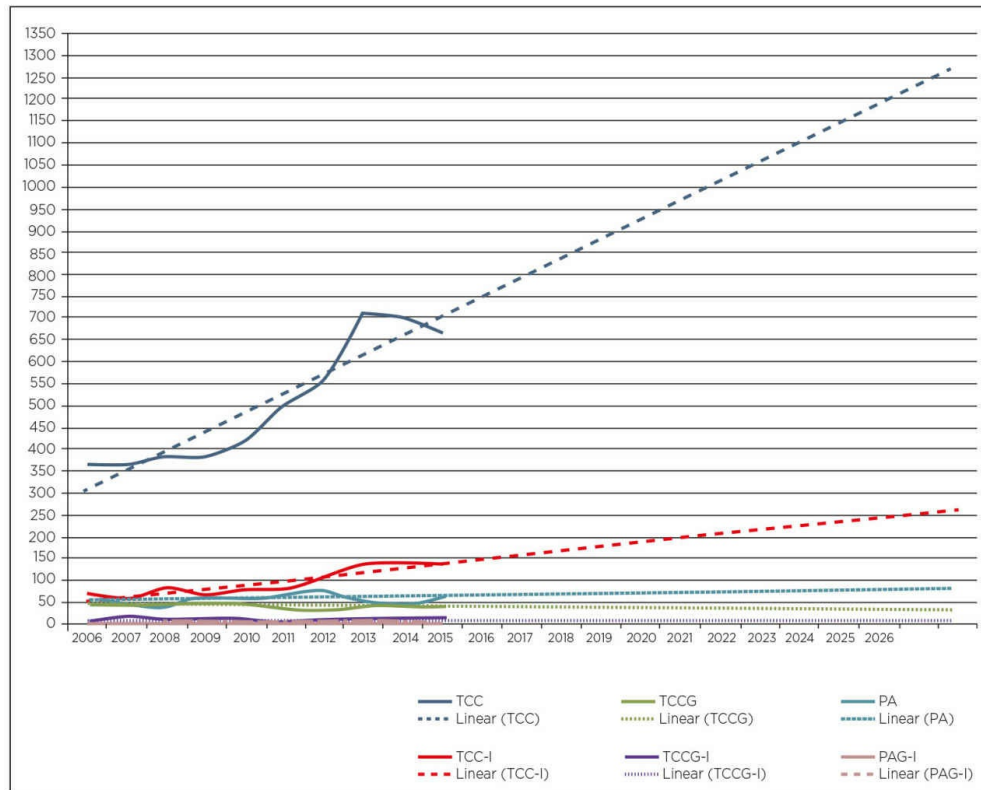


Figura 21.1 Artigos indexados pela PsycNET sobre psicanálise e TCC em uma década (2006-2015) e tendências para a próxima década.

TCC, terapia cognitivo-comportamental; TCC-I, terapia cognitivo-comportamental com idosos; TCCG, terapia cognitivo-comportamental em grupo; TCCG-I, terapia cognitivo-comportamental grupal com idosos; PA, psicanálise; PA-I, psicanálise com idosos; PAG, psicanálise grupal; PAG-I, psicanálise grupal com idosos.

Contrastando com a tendência de diminuição da publicação de artigos que relatam pesquisas empíricas sobre TCCG-I, a população de idosos tende a aumentar substancialmente no Brasil e em vários outros países. Os idosos são, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) (Ervatti, Borges, & Jardim, 2015), o segmento populacional que mais aumenta no País. As taxas de crescimento ultrapassam 4% ao ano no período de 2012 a 2022. Assim, estima-se que o Brasil terá a sexta maior população de idosos do mundo em 2025 (Guedea et al., 2006; Paschoal, 2000), pois, nos próximos 10 anos, haverá um incremento médio de mais de 1 milhão de idosos por ano (Ervatti et al., 2015).

ACRESCER MAIS VIDA AOS ANOS: UM DESAFIO PARA A TERAPIA COGNITIVO- COMPORTAMENTAL

O aumento na longevidade é decorrente de diversos fatores, entre eles a melhora das condições de vida e o avanço das ciências da saúde (Nardi & Grassi-Oliveira, 2011). No entanto, como ressaltado por Vaillant (2004), não basta acrescentar anos à vida; há que se acrescentar vida aos anos. Isso não significa “apenas” remediar e/ou prevenir problemas, mas, principalmente, promover envelhecimento positivo.

A promoção de envelhecimento positivo demanda, muitas vezes, mudanças expressivas na concepção de velhice por parte de profissionais que se envolvem com tão desafiadora e relevante empreitada. Durante muito tempo, a velhice foi tida como uma fase marcada exclusivamente por perdas progressivas e declínios, mas, sobretudo a partir da década de 1960, começou a ocorrer, do ponto de vista do conhecimento psicológico, uma mudança significativa no que se entendia por envelhecimento (Neri, 2006). Graças a “novas” perspectivas em psicologia do envelhecimento, como a do curso da vida ou *life-span* (Baltes, 1987), o envelhecimento passou a ser reconhecido como uma experiência heterogênea, dependente da interação de diversos fatores (p. ex., genéticos e ambientais) e da maneira como a pessoa lida com os acontecimentos de vida, incluindo as patologias (Neri, 1995). Assim, pelo menos três trajetórias de envelhecimento podem ser propostas: o envelhecimento normal, o bem-sucedido e o patológico (Rowe & Khan, 1998).

O envelhecimento normal é caracterizado pelas alterações físicas, cognitivas e sociais esperadas para essa fase do curso de vida, como aumento da pressão arterial, déficits visuais e diminuição da velocidade de processamento de informações (Nascimento & Banhato, 2016). Assim, na velhice é possível que haja um declínio normal das funções, porém com início e progressão variáveis e dependentes de outros fatores, como escolaridade e doenças prévias (Nascimento & Banhato, 2016). Por exemplo, as alterações

podem evoluir para um quadro de comprometimento cognitivo leve (CCL) que pode ou não avançar para uma demência (Stella, 2004).

O envelhecimento saudável ou bem-sucedido (P. B. Baltes & Baltes, 1990) pode ser entendido como uma variação do envelhecimento normal marcada pela funcionalidade física e mental. É como se as alterações ocorressem tão lentamente que o funcionamento cognitivo e funcional desses idosos fosse melhor que o da maioria das pessoas da mesma faixa etária. No envelhecimento bem-sucedido, a capacidade de adaptação às mudanças físicas, emocionais e sociais se destaca (Caldas, 2006).

Por fim, o envelhecimento patológico é aquele decorrente de alterações globais e irreversíveis que comprometem o funcionamento do indivíduo (Nascimento & Banhato, 2016). As doenças e a privação da autonomia representam uma amostra desses comprometimentos. A fragilidade, a incapacidade, a baixa autoestima, a dependência, o desamparo, a solidão, a desesperança, a ansiedade e a depressão também são problemas comumente associados a essa trajetória de envelhecimento. No envelhecimento patológico, observam-se, ainda, grandes prejuízos neuronais, acarretando alterações ou déficits cognitivos (Nascimento & Banhato, 2016). Nesses idosos, verifica-se falta de habilidade em perceber, lembrar, tomar decisões e planejar (Manfrim & Schmidt, 2006).

O envelhecimento normal e o patológico têm sido enfatizados pela TCCG-I. Isso se evidencia, por exemplo, nos principais temas dos artigos que relatam pesquisas empíricas contando com idosos em suas amostras e indexados pela PsycINFO (N = 85). Três dos cinco principais descritores dessa produção científica dizem respeito a psicopatologias, transtornos ou problemas: depressão (n = 16; 18,82%), transtornos de ansiedade (n = 6; 7,06%) e declínio cognitivo (n = 5; 5,88%). Um quarto conjunto de publicações (n = 5; 5,88%) tem um descritor que, se não é negativo, não pode necessariamente ser considerado positivo, pois diz respeito aos mecanismos cognitivos e comportamentais utilizados para enfrentar demandas internas e/ou externas avaliadas como excessivas pelos indivíduos para as capacidades que têm (Folkman, Lazarus, Dunkel-Schetter, DeLongis, & Gruen, 1986), isto é, estratégias de *coping*. Apenas um descritor pode ser considerado positivo:

qualidade de vida ($n = 6$; 7,06%). Ainda assim, não é incomum tratar-se de um tema secundário, como melhorar a qualidade de vida de idosos com depressão, sendo que esse transtorno do humor é o foco principal da investigação/intervenção, como no estudo de García-Peña, Vázquez-Estupiñan, Avalos-Pérez e Robles (2015).

Esse viés negativo que, historicamente, é característico da TCC (a palavra “terapia” tem origem grega – *therapeia* – e significa “o ato de curar”) limita significativamente a população que pode se beneficiar com essa atuação profissional. Ainda que faltem estimativas precisas sobre os percentuais de idosos em cada uma das trajetórias de envelhecimento, isto é, normal, patológico e saudável/positivo, é possível afirmar que, graças aos desenvolvimentos científicos e às políticas públicas de proteção à velhice, um contingente cada vez maior de pessoas vivenciará um envelhecimento positivo. Logo, a TCC deve se dedicar a dois amplos e laudáveis objetivos: atuar para manter trajetórias positivas de envelhecimento e contribuir para que trajetos normais e patológicos sejam redirecionados para uma velhice saudável.

Além desse viés negativo, a crença equivocada de que a velhice seria apenas uma “continuidade” da adultez representa uma barreira para a TCCG-I, pois faz práticas e modelos adotados com adultos serem transpostos linearmente para idosos. Ainda que seja possível pressupor que elementos estruturais – como definição de agenda, conceitualização cognitiva e definição da tarefa de casa – e técnicas terapêuticas – por exemplo, questionamento socrático e descoberta guiada – da clínica com idosos não difiram substancialmente daquela realizada com adultos (Laidlaw, 2001; Laidlaw & McAlpine, 2008), o terapeuta que atende pessoas que estão na velhice não deve meramente transpor sua práxis com adultos para esses clientes. As singularidades desse segmento etário precisam ser consideradas, devendo, muitas vezes, ser utilizadas modalidades terapêuticas específicas para idosos, e não somente adaptadas (Freitas, Barbosa, & Neufeld, 2016a).

Para Rebelo (2007), o trabalho terapêutico com idosos deve levar em conta aspectos centrados tanto no *setting* terapêutico quanto no profissional. No que se refere aos aspectos centrados no *setting*, podem ser citados a

flexibilização da duração e a frequência das sessões (Rebelo, 2007), a utilização de maior número de sessões para trabalhar determinado tema (Reis & Barbosa, 2016), o manejo mais lento das sessões e com pausas mais frequentes, bem como a utilização de *feedbacks* breves (Wilkinson, 1997). Com relação aos aspectos centrados no profissional, alguns exemplos são a necessidade de conhecimento aprofundado sobre psicologia do envelhecimento e gerontologia; a realização de uma reflexão pessoal que envolva as concepções do próprio psicoterapeuta sobre idoso, velhice e envelhecimento – representações muito negativas sobre essa etapa do curso de vida, como “idosos não são capazes de aprender” e “ele está muito velho para mudar”, podem comprometer o sucesso da psicoterapia –; e a aceitação de formas de compreender o mundo diferentes daquelas apresentadas por clientes mais novos (Laidlaw, Thompson, Gallagher-Thompson, & Dick-Siskin, 2003; Rebelo, 2007). Além desses aspectos, o psicoterapeuta deve estar atento para algumas especificidades que caracterizam a população de idosos atualmente, como o nível de escolaridade mais baixo que a média geral e a possibilidade de perdas de capacidade cognitiva e/ou de problemas de acuidade visual, auditiva e/ou motora (Oliveira, 2012; Wright, Basco, & Thase, 2008).

Reis e Barbosa (2016) listam 12 habilidades e competências principais (p. ex., definição e adesão à agenda, realização de *feedback*, estabelecimento de colaboração, efetividade interpessoal, eliciação de expressão emocional adequada e definição da tarefa de casa) que são necessárias ao psicoterapeuta cognitivo-comportamental para a realização de um trabalho eficaz e eficiente; além disso, os autores analisam suas especificidades no trabalho com idosos. No caso da definição da tarefa de casa, por exemplo, os autores alertam, com base em Laidlaw e colaboradores (2003), que muitos idosos não se sentem à vontade para fazer atividades por escrito, receando pular palavras, escrever errado devido a problemas físicos e/ou perceptivos. Assim, o psicoterapeuta deve encorajar seu cliente a realizá-las, mesmo que erros ocorram, adotando uma postura de não julgamento negativo de eventuais falhas. Alternativamente, pode-se sugerir ao indivíduo que faça gravações de áudio de suas atividades, caso se sinta mais confortável e esse recurso esteja

disponível. Para evitar o esquecimento das tarefas, o terapeuta pode, ainda, incentivar a utilização de recursos visuais, como papéis adesivos em geladeiras e banheiros, e auditivos, como os despertadores.

Além de cuidados relativos aos aspectos centrados no *setting* e no psicoterapeuta, às especificidades dos idosos e à necessidade de ter habilidades e competências específicas para atendê-los de modo competente, a avaliação do cliente é uma etapa extremamente importante do processo terapêutico com pessoas que estão na velhice. Fazer uma avaliação aprofundada que identifique as dificuldades de cada cliente é o primeiro passo da TCC na prática clínica (Argimon & Cerutti, 2016). É possível, contudo, argumentar que a avaliação do idoso não difere expressivamente daquela realizada com adultos. Porém, para que seja bem-sucedida, algumas alterações importantes devem ser feitas (Oliveira, 2012). Mencionam-se, como exemplos, ter uma compreensão ampla do processo de envelhecimento e das mudanças normativas dessa fase da vida (como perdas e limitações) e conhecer as características de seus problemas mais comuns (p. ex., doenças crônicas, alterações da memória e transtornos mentais) (S. H. Zarit & Zarit, 2009). Além dos aspectos tradicionais, Laidlaw, Thompson e Gallagher-Thompson (2004) salientam que a avaliação em TCC com idosos deve considerar as crenças de coorte, os papéis assumidos, o contexto sociocultural, as relações intergeracionais e a saúde física.

Alerta-se que a avaliação do idoso na TCC não deve se restringir aos problemas, aos déficits, aos transtornos. Argimon e Cerutti (2016) ressaltam que é preciso identificar potencialidades e habilidades, que podem estar latentes devido a problemas vivenciados pelo idoso, pois, ao serem reconhecidos e desenvolvidos, os pontos fortes podem servir como recursos para o enfrentamento de problemas. Eles também contribuem para a diminuição de sintomas depressivos e o aumento da satisfação com a vida (Cuadra-Peralta, Veloso-Besio, Puddu-Gallardo, Salgado-García, & Peralta-Montecinos, 2012; Seligman, Steen, Park, & Peterson, 2005). Ademais, é possível alcançar maior êxito nas intervenções em TCC quando se acrescentam ao seu objetivo central – desenvolver formas alternativas de pensamentos que irão influenciar sentimentos e comportamentos – a

identificação das forças do paciente e a investigação de como aspectos positivos (p. ex., a sabedoria) interferem em sua resposta aos desafios cotidianos (Hill & Mansour, 2008). Em suma, em todo trabalho com idosos, é igualmente importante valorizar aspectos positivos da velhice e do envelhecimento (Rebelo, 2007).

TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL EM GRUPO COM IDOSOS: CARACTERÍSTICAS E CONTRIBUIÇÕES

A primeira referência sobre grupos terapêuticos com idosos data da década de 1950 (Rebelo, 2007). A partir daí, estudos de diferentes áreas científicas e abordagens foram surgindo.

O formato grupal de psicoterapia tem sido considerado uma forma de tratamento tão eficaz quanto o individual (Yalom & Leszcz, 2006). Com relação à TCCG-I, são exemplos dessa afirmação os estudos de Anderson e Rees (2007), sobre o transtorno obsessivo-compulsivo; de Craigie e Nathan (2009), a respeito da depressão; e de Tristán e Rangel (2009), sobre ansiedade, depressão, crenças disfuncionais e bem-estar subjetivo. Nos três trabalhos, constatou-se que tanto a TCC individual quanto a TCCG foram eficazes. Há autores, como Tristán e Rangel (2009), que sugerem, ainda, que a psicoterapia em grupo com idosos seja mais vantajosa que a individual. Porém, essa não é uma afirmação consensual (ver, p. ex., Sharp, Power, & Swanson, 2004).

Investigações que comparam os resultados da TCCG-I a outras formas de tratamento também têm sido feitas. Pothirat, Phetsuk, Liwsrisakun e Deesomchok (2015) realizaram um estudo com 224 idosos fumantes residentes na comunidade a fim de comparar a TCCG a um programa educacional para a cessação do tabagismo. Nos três *follow-ups* realizados (3, 6 e 12 meses após a intervenção), a taxa de abstinência contínua dos idosos que participaram da TCCG foi significativamente maior do que no grupo de educação, sugerindo que grupos de TCC que tenham como alvo idosos fumantes podem alcançar melhores resultados na cessação do tabagismo que

um programa exclusivamente educacional. Granholm e colaboradores (2007) realizaram um estudo randomizado controlado com 76 pacientes ambulatoriais (42 a 74 anos) com esquizofrenia ou transtorno esquizoafetivo a fim de comparar o tratamento usual (TU) ao tratamento usual associado a um grupo de treinamento cognitivo-comportamental de habilidade sociais (TCCHS), isto é, TCC combinada com o treino de habilidades sociais e de resolução de problemas. Ao serem comparados aos participantes do TU, os pacientes do TCCHS foram mais capazes de aprender e manter novas habilidades e apresentaram melhora em seus autorrelatos de funcionamento diário, mantidos por 12 meses após a intervenção. Além disso, obtiveram percepção cognitiva significativamente superior ao fim do tratamento. No entanto, essa melhora não se manteve no período de acompanhamento.

Em geral, é possível afirmar que as interações presentes nos grupos possibilitam troca de informações e oportunidades significativas de aprendizagem (Bieling, McCabe, & Antony, 2008). Adicionalmente, grupos com idosos contribuem com a contenção de gastos, já que mais pessoas podem se beneficiar em determinado período de tempo (Cummings & Cummings, 2008). A esse respeito, Bieling e colaboradores (2008) verificaram economia de recursos financeiros no sistema de saúde, com a eficiência do tratamento em grupo tendo sido superior a 50% em relação ao individual.

Bieling e colaboradores (2008) e Lima (2004) apresentam uma série de contribuições da modalidade grupal de terapia com pessoas que estão na velhice. O trabalho em grupo com idosos permite ao indivíduo constatar que os próprios problemas não são exclusivos nem imutáveis (descobrir questões em comum com outros participantes pode contribuir para a diminuição da sensação de isolamento sentida por alguns idosos), insuflar a esperança, promover a interação social com o desenvolvimento de novas aptidões relacionais e aumentar a autoestima por meio do altruísmo e da empatia (o idoso se sente valorizado por poder apoiar outros participantes). O formato grupal também contribui para que modelos positivos – outros idosos – sejam apresentados, permitindo a aprendizagem de novos comportamentos, bem como para incentivar a independência em relação ao psicoterapeuta. Essa

modalidade privilegia a aprendizagem e o treino de várias competências e contribui para que o indivíduo obtenha e partilhe informações sobre mudanças e transições características dessa fase. A psicoterapia em grupo na velhice pode proporcionar melhora nos sintomas psicológicos e físicos, bem como na qualidade de vida (Rebelo, 2007).

Em uma revisão de pesquisas sobre TCCG que tiveram idosos em suas amostras, Freitas, Barbosa e Neufeld (2016b) verificaram que são poucos os estudos voltados exclusivamente para essas pessoas, que o principal foco da maioria das investigações foi o tratamento de transtornos (p. ex., redução e manejo de sintomas) e que os transtornos mentais mais frequentemente trabalhados foram, respectivamente, os transtornos de depressão, os transtornos de ansiedade, os transtornos obsessivo-compulsivos e relacionados e os sintomas somáticos e transtornos relacionados (classificação diagnóstica baseada no *Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais* [DSM-5]) (American Psychiatric Association [APA], 2014). Assim, há que se tecer algumas considerações sobre depressão e ansiedade na velhice.

A maior frequência de estudos sobre TCCG com pessoas deprimidas pode ser decorrente do fato de a depressão ser o transtorno do humor mais prevalente entre os idosos (Lobo et al., 2012). No Brasil, especificamente, há alta variabilidade nos dados de sintomatologia depressiva em estudos com esses indivíduos, influenciada por diferenças metodológicas, região e desenho do estudo (Ferreira & Batistoni, 2016). Para idosos da comunidade, a prevalência de depressão pode chegar a 34% (Alvarenga, Oliveira, & Faccenda, 2012), e para aqueles institucionalizados, a 47% (Vaz & Gaspar, 2011). Apesar de não haver consenso sobre a prevalência exata de depressão em idosos brasileiros, não há dúvidas de que se trata de um número bastante elevado (Ferreira & Batistoni, 2016). Alerta-se, ainda, que os fatores de risco para depressão e ansiedade apresentam diferenças entre adultos e idosos, sendo que, na população mais velha, destacam-se o luto, as doenças físicas, as incapacidades e as dificuldades cognitivas (Lobo et al., 2012).

Com relação à ansiedade, são comuns, em idosos, o medo de quedas e a necessidade de acumular, “patologias” que não estão nos descritores das

classificações atuais (Nardi, Grassi-Oliveira, & Pádua, 2016). Ademais, a ansiedade nesses indivíduos pode ser mais bem descrita e sentida como mais somática (p. ex., queixas de tontura e “tremedeiras”) (Flint, 2005). Assim, é necessária a utilização de instrumentos desenvolvidos especificamente para essa coorte etária tanto para a triagem quanto para a avaliação da intervenção.

Ainda no que se refere às queixas somáticas, é preciso alertar que elas podem ser reflexo de uma condição médica ou dor crônica diagnosticável, e não de depressão (Thompson et al., 2003). Assim, utilizar, com idosos, medidas de sintomas depressivos que não contenham itens somáticos – como é o caso da Escala de Depressão Geriátrica, versão reduzida (GDS-15) (Yesavage et al., 1983) – é um aspecto positivo (Thompson et al., 2003).

Alguns dos instrumentos que foram desenvolvidos especificamente para a população idosa, que já contam com adaptação e tradução para o português do Brasil, apresentam propriedades psicométricas satisfatórias e são práticos de aplicar, a saber: Escala de Depressão Geriátrica, versão reduzida (GDS-15) (Yesavage et al., 1983) e adaptada para o contexto brasileiro por O. P. Almeida e Almeida (1999); Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI) (Massena, Araújo, Pachana, Laks, & Pádua, 2014; Pachana et al., 2007), traduzido para o português do Brasil por Martiny, Silva, Nardi e Pechana (2011); versão brasileira (PGCMS-Br) (Barbosa & Freitas, 2012) da Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) (Lawton, 1991), que avalia o bem-estar psicológico; e Miniexame do Estado Mental (MEEM) (Brucki, Nitrini, Caramelli, Bertolucci, & Okamoto, 2003), para rastreio de comprometimento cognitivo.

É mister salientar que pesquisas sobre TCCG com idosos em suas amostras, como a maioria daquelas recuperadas por Freitas e colaboradores (2016b), contribuem para o avanço das discussões a respeito desse tema, mas parcialmente, uma vez que não consideram nem discutem as especificidades do trabalho com pessoas na velhice. Destaca-se, também, que, no Brasil, os estudos são ainda mais incipientes. Todavia, merecem destaque as investigações de Lobo e colaboradores (2012) e de Freitas e colaboradores (2016a). A primeira é uma pesquisa com delineamento quase-experimental que avaliou os efeitos da TCCG com idosos (64-73 anos) sobre sintomas de

ansiedade, depressão e queixas de memória, antes e após a intervenção. Os resultados ratificaram a redução da sintomatologia avaliada, sugerindo que uma intervenção breve, baseada na TCCG, pode ser um tratamento terapêutico viável para essa coorte etária. Algumas das limitações do estudo foram o reduzido tamanho amostral ($n = 6$) e a ausência de grupo-controle. Assim, estudos nacionais baseados na TCCG com participantes exclusivamente idosos, que tenham grupos-controle e um número representativo de participantes são indispensáveis. Já o estudo de Freitas e colaboradores (2016a) refere-se a uma proposta que tem como um de seus objetivos a promoção do envelhecimento positivo. Trata-se da Educação para o Caráter Baseada em Forças para Idosos (Educafi).

EDUCAÇÃO PARA O CARÁTER BASEADA EM FORÇAS PARA IDOSOS

A Educafi é um programa que foi desenvolvido tendo como base a TCCG, a psicologia positiva e a educação para o caráter (Freitas et al., 2016a). Seu objetivo principal é desenvolver as 24 forças do caráter – conceito fundamental na psicologia positiva (Peterson & Seligman, 2004) – em idosos e, especificamente, aumentar a satisfação com a vida e o bem-estar psicológico de seus participantes. As 24 forças são: abertura a novas ideias, criatividade, curiosidade, gosto pela aprendizagem, perspectiva, bravura, autenticidade, persistência, vitalidade, amor, bondade, inteligência social, cidadania, integridade, liderança, autorregulação, humildade/modéstia, perdão/misericórdia, prudência, apreço pelo belo e pela excelência, esperança, espiritualidade, gratidão e humor (Peterson & Seligman, 2004).

Sabe-se que intervenções nesse formato, isto é, com o objetivo de cultivar sentimentos, comportamentos e cognições positivas (Sin & Lyubomirsky, 2009), têm muito a contribuir para um envelhecimento positivo. Assim, na Educafi, são trabalhadas as forças do caráter dos participantes, com foco voltado, também, para a promoção de aspectos positivos da velhice e do envelhecimento.

Reitera-se que, para a realização de grupos com idosos, como a Educafi, os terapeutas cognitivo-comportamentais devem ficar atentos quanto ao fato de que pessoas com 60 anos ou mais podem apresentar déficits sensoriais, cognitivos e/ou motores, como maior dificuldade para enxergar e ouvir, maior tempo de latência de respostas motoras e alterações na memória e na velocidade de aprendizagem. Essas alterações, que são esperadas para a velhice, demandam do terapeuta uma adequação de seu comportamento e do *setting* terapêutico a fim de abranger as necessidades de cada idoso. Menciona-se, uma vez mais, a necessidade de ajustes no tom de voz, velocidade da fala e ritmo de terapia (considerar mais sessões caso o grupo apresente uma dificuldade maior de assimilar e aplicar os conceitos trabalhados). Com relação ao ambiente, recomendam-se espaços iluminados, com pouca ou nenhuma interferência de barulhos (Gallagher-Thompson & Thompson, 2010), e acessíveis para idosos com dificuldades físicas (p. ex., dar preferência a lugares que não tenham escadas ou que tenham disponíveis elevadores, rampas de acesso, etc.).

Neufeld (2011) propõe a existência de quatro modalidades grupais mais comuns em TCCG: grupos de apoio, de psicoeducação, de treinamento e/ou orientação e grupos terapêuticos. Elas podem variar de acordo com o objetivo do grupo, apresentando diferentes papéis no nível de atenção em saúde (primária, secundária ou terciária). Para a Educafi, Freitas e colaboradores (2016a) recomendam que sejam formados grupos do tipo orientação/treinamento. Esses grupos fazem uso de estratégias psicoeducacionais e de atividades práticas, são caracteristicamente fechados e com frequência semanal, com um número de sessões superior a oito – a fim de que as aprendizagens possam ser sedimentadas e colocadas em prática – e com quantidade de participantes inferior a 16 (Neufeld, 2011). Gallagher-Thompson e Thompson (2010) sugerem que, nas intervenções com idosos com depressão, seja utilizado um número maior de sessões (16 a 20), visando a obtenção de respostas melhores de seus participantes.

Para a Educafi, são propostos 26 encontros, sendo dois por semana, de 90 minutos cada e com 10 integrantes em média. A opção pela duração da intervenção, pelo tempo de cada sessão e pelo número de participantes teve

como meta dar a todos os idosos a oportunidade de participar efetivamente do encontro e possibilitar que os conteúdos fossem mais bem trabalhados, já que, por vezes, o terapeuta deverá prosseguir a sessão de modo mais lento e com pausas mais frequentes, a fim de lidar com mudanças características da velhice (Wilkinson, 1997). Há que se ressaltar que a Educafi tem sido testada com idosos saudáveis, o que facilita a proposta de uma intervenção mais longa (26 encontros) e com duração de 1h30min por sessão.

Ao realizar grupos com idosos, o terapeuta deve ter clareza quanto à trajetória de envelhecimento do público-alvo. Crenças como “respostas para idosos devem ser mais bem elaboradas” podem ser inadequadas, pois, conforme apresentado anteriormente, são variadas as possibilidades de envelhecer (normal, patológica ou saudável).

A fim de obter essa informação e ter um grupo de idosos mais homogêneo, recomenda-se que, em uma etapa inicial, ocorram triagens, avaliações psicológicas e verificação das condições psicológicas, queixas cognitivas e/ou dificuldades auditivas, visuais e verbais dos pacientes individualmente (Argimon & Cerutti, 2016). Na Educafi, foram utilizados o MEEM (Brucki et al., 2003), para a avaliação do *status* cognitivo; a GDS-15 (O. P. Almeida & Almeida, 1999), para a avaliação de sintomas depressivos; a Escala de Desesperança (BHS) (Cunha, 2001), para a avaliação dos sintomas de desesperança; a PGCMS-Br (Barbosa & Freitas, 2012), a fim de avaliar o bem-estar psicológico; a Escala de Satisfação com a Vida (ESV), desenvolvida por Diener, Emmons, Larsen e Griffin (1985) e adaptada por Gouveia, Barbosa, Andrade e Carneiro (2005) ao contexto brasileiro, para avaliar a satisfação com a vida; e o Values in Action Inventory of Strengths – versão abreviada (VIA-IS-120) (VIA Institute on Character, 2013), para avaliação das forças do caráter.

O primeiro encontro do grupo – que se dá após a realização das avaliações mencionadas – tem como objetivos fazer um contrato, realizar o enquadramento e estabelecer um bom *rappport* com os idosos. Esse tipo preparação para a terapia pode contribuir para a redução na taxa de desistência dos participantes (Neufeld, Daolio, & Longhini, 2015). Na

Educafi, essa sessão contempla, ainda, uma breve psicoeducação sobre psicologia positiva, forças do caráter e modelo cognitivo.

A promoção das forças, propriamente dita, inicia-se a partir do segundo encontro. Nesse e nos 23 encontros seguintes, uma força do caráter deve ser focada em cada dia, por isso a necessidade de 26 encontros. Recomenda-se que não sejam realizados mais de dois encontros por semana, para que haja um espaçamento entre os dias de atividade grupal, a fim de que os idosos possam realizar as tarefas. No encontro final, quando todas as forças já terão sido trabalhadas, devem ser esclarecidas as dúvidas referentes à força focada no 25º encontro e aquelas referentes a toda a Educafi. Além disso, propõe-se que seja realizada uma síntese de todo o processo, a qual contemple tanto cada idoso individualmente quanto o funcionamento grupal, ressaltando os ganhos e outros aspectos positivos (Freitas et al., 2016a).

A estrutura geral de cada encontro está apresentada na Figura 21.2. A estruturação das sessões e a diretividade são pressupostos importantes na TCC (Beck, 1997; Wright et al., 2008): elas facilitam a execução do programa e aumentam a probabilidade de êxito. De acordo com Lobo e colaboradores (2012), o formato estruturado torna a sessão mais fácil de ser acompanhada pelo idoso. Assim, ressaltam que:



Figura 21.2 Estrutura geral dos encontros.

Fonte: Freitas e colaboradores (2016a).

1. Com exceção do primeiro, os encontros serão iniciados com a revisão da tarefa proposta na sessão anterior. Trata-se de um elemento-padrão da estruturação que permite a ligação entre a sessão anterior e a atual (Wright et al., 2008).
2. A realização de um *brainstorming*, ou tempestade de ideias, sobre a força-alvo do encontro e sobre temas a ela relacionados possibilita ao terapeuta apreender as crenças e as atitudes que os idosos têm a respeito deles. É um tipo de dinâmica que propicia, logo no início, um envolvimento ativo dos participantes. Porém, é necessário que o terapeuta mantenha uma atitude ativa para sustentar o foco do encontro, uma vez que, conforme afirma Rebelo (2007), os idosos podem apresentar uma tendência de utilizar o tempo da terapia para “contar histórias”, divagar e desistir de cumprir

determinadas tarefas importantes. Essa é uma atenção que, na verdade, o terapeuta deve ter durante toda a sessão.

3. Ao aprofundar/explorar o conteúdo, o terapeuta deve lançar mão de técnicas, como o questionamento, a clarificação, a reexposição, que propiciem uma ampliação de seu conhecimento sobre as crenças, as atitudes e os indicadores comportamentais mencionados na etapa anterior. Como exemplos, pode argumentar a respeito da manifestação da força ao longo da vida, enfatizando a velhice, e sobre sua relevância para um envelhecimento positivo. É nessa etapa, também, que o processo de orientação/treinamento ocorre efetivamente, isto é, são apresentadas e ensaiadas estratégias para o desenvolvimento da força-alvo. Para tanto, uma série de técnicas (p. ex., dramatização) e recursos (vídeo, música, textos, charges, etc.) pode ser empregada. A utilização de recursos multimodais, como falar, mostrar, desenhar, escrever, etc., favorece o processo terapêutico com idosos (Gallagher-Thompson & Thompson, 2010).
4. Dar e solicitar *feedback* aos participantes ajuda a manter a sessão estruturada, a construir a relação terapêutica e a corrigir distorções no processamento de informações (Wright et al., 2008). Ainda que apareça como quarta etapa do processo, com idosos é possível e, muitas vezes, necessário efetuar e receber devolutivas ao longo de todo o encontro.
5. Resumir os conteúdos discutidos na terapia, no início e no fim de cada sessão, é uma boa estratégia para favorecer a memória do idoso (Gallagher-Thompson & Thompson, 2010). Sobre o resumo no início da sessão, é possível que, antes da revisão da tarefa de casa, o terapeuta opte por retomar e resumir o que foi discutido no encontro anterior, sendo a revisão da tarefa de casa um seguimento dessa estratégia de recapitulação. Ao fim de cada sessão, também deve ser feita uma revisão daquilo que foi discutido. Caso seja possível, sugere-se, ainda, fornecer a cada um dos idosos um texto breve contendo uma síntese do que foi trabalhado. Esse texto deve ser curto, com tamanho de letra e linguagem adequados aos participantes. Após a entrega desse material, recomenda-se sua leitura em voz alta e o esclarecimento de eventuais dúvidas. A entrega de um

material com o resumo do que foi trabalhado no encontro é uma ótima estratégia mnemônica, já que facilita a aprendizagem dos temas trabalhados e permite ao idoso recorrer quantas vezes desejar ou for necessário a esse material, mesmo após a finalização da intervenção. Há que se ressaltar que esse é um excelente recurso para idosos escolarizados. Para idosos não alfabetizados, devem ser buscadas alternativas.

6. Por fim, apresenta-se a tarefa para o próximo encontro. Sua utilização tem como objetivo manter as informações “vivas” na cabeça dos idosos, estendendo-as para o decorrer da semana (Neufeld, 2011). Além disso, ajuda a fomentar a realização de ensaios comportamentais ou cognitivos relacionados ao que foi trabalhado entre um encontro e outro (Neufeld, 2011). Isso facilita a apreensão do conteúdo e permite seu treinamento em situações reais do dia a dia (Wright et al., 2008). Em suma, as tarefas de casa ajudam o idoso a aplicar na sua vida cotidiana aquilo que aprendeu em terapia, aumentando suas chances de experimentar melhoras reais (Gallagher-Thompson & Thompson, 2010).

Discutida a estrutura geral de cada encontro, será abordada, em seguida, a organização dos temas para cada sessão. No caso da Educafi, foi necessário propor uma ordem de forças para intervenção. Freitas e colaboradores (2016a) sugerem que, nas primeiras sessões – ou, em casos de intervenções com poucos encontros, na primeira sessão –, sejam trabalhados temas mais amplos e, em alguns casos, “menos polêmicos” (ainda que seja uma tarefa complexa, contextual e histórica estabelecer o que é mais ou menos polêmico), a fim de que os idosos se sintam confortáveis em compartilhar experiências e crenças desde o princípio da intervenção. Uma possibilidade de sequência de forças para a Educafi pode ser encontrada em Freitas e colaboradores (2016a).

A Educafi é um programa que permite ampliar as possibilidades de intervenção com idosos, ultrapassando as já existentes focadas em patologias, sintomas e emoções negativas. Alguns grupos já foram realizados, e os resultados revelam sua adequação. Todavia, neste capítulo, optou-se por apresentar uma análise mais qualitativa dessa proposta, uma vez que há uma

restrição em sua dimensão e ainda é necessário aumentar e diversificar a amostra de idosos submetidos à Educafi.

Em síntese, a avaliação feita pelos idosos sobre a Educafi é bastante positiva. Do total de participantes ($n = 15$), 73,33% ($n = 11$) relataram que a duração (26 encontros) da intervenção foi boa; 20% ($n = 3$) assinalaram ter sido curta; e 6,67% ($n = 1$) afirmaram ter sido boa, mas curta. Com relação à duração de cada encontro (90 minutos), 66,67% ($n = 10$) relataram ter sido boa; 20% ($n = 3$) curta; e 13,33% ($n = 2$) boa, mas curta. Todos os participantes assinalaram que os temas trabalhados (forças do caráter) foram bons, e também 100% assinalaram que indicariam o programa para um amigo. Quanto aos benefícios, 93,33% ($n = 14$) assinalaram que a Educafi beneficiou todos os integrantes do grupo, e 6,67% ($n = 1$) marcaram que o programa trouxe benefícios para o próprio respondente e para alguns participantes.

Quando questionados sobre o que poderia ser melhorado para os próximos grupos, as respostas variaram entre: 1) “não tem o que melhorar”, sugerindo a manutenção da estrutura da Educafi como eles a experienciaram ($n = 5$; 33,33%); 2) ter uma continuação, uma “parte II” ($n = 5$; 33,33%); 3) ter uma dinâmica para cada força trabalhada ($n = 1$; 6,67%); e 4) trabalhar “tudo o que nos possa ajudar em nosso envelhecimento” ($n = 1$; 6,67%). Houve, ainda, aqueles que não responderam ($n = 3$; 20%).

Foram selecionados alguns dos relatos dos participantes sobre suas experiências com a Educafi (Quadro 21.1), a fim de ilustrar como a TCCG-I pode e deve promover envelhecimento positivo. Eles evidenciam, também, outros aspectos importantes dessa modalidade terapêutica descritos anteriormente neste capítulo, como as contribuições do formato grupal de TCC.

Quadro 21.1 Exemplos de relatos de idosos sobre suas experiências com a Educafi

“[Participar da Educafi] fez com que eu refletisse sobre os temas trabalhados e procurasse pô-los em prática, na medida do possível. Acho que todo o grupo se beneficiou, tendo em vista os depoimentos dados.”

“Passei a observar mais as minhas atitudes.”

“[A Educafi] trouxe benefícios até para minha família, pois fiquei mais consciente, confiante, mais feliz. Serviu para me sentir realizada como eu sou, valorizar o meu modo de ser.”

“As participantes do grupo, manifestando suas ideias, deram, também, um bom atendimento, sem inibição, formando um encontro prazeroso, amigável.”

“Fortalecimento das forças em cada uma de nós com certeza será favorável nas escolhas dos pensamentos e atividades que proporcionarão uma qualidade de vida melhor e mais feliz.”

“Fiquei mais comunicativa, alegre, acho que todos gostaram.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS: INTEGRAR O “POSITIVO” E O “NEGATIVO” NA TERAPIA COGNITIVO-COMPORTAMENTAL COM IDOSOS

Este capítulo teve como objetivo principal apresentar uma modalidade TCC, mais especificamente a TCCG-I. O aumento da longevidade e as limitações da produção científica sobre essa prática terapêutica em grupos representam dois de muitos motivos que subjazem à proposição da Educafi.

Antes de descrever a Educafi, o capítulo analisa alguns aspectos que constituem barreiras para a TCCG-I, como o viés negativo da TCC e a crença equivocada de que a velhice seria apenas uma “continuidade” da adultez. São discutidas, também, algumas especificidades da terapia com idosos, incluindo a avaliação, que não pode ser apenas uma transposição linear das técnicas e princípios adotados com outras coortes etárias.

A Educafi foi desenvolvida considerando fundamentos e práticas oriundos da TCCG, da psicologia positiva e da educação para o caráter. Ao longo de 26 sessões de orientação/treinamento, busca desenvolver em idosos as 24 forças do caráter propostas por Peterson e Seligman (2004) e, em consequência disso, promover bem-estar psicológico e satisfação com a vida na velhice. É possível afirmar, ainda que muita cautela seja necessária, que tem atingido seus objetivos.

A Educafi pode ser classificada como uma TCCG-I positiva. Bannink (2012) afirma que a TCC positiva é uma combinação que surgiu recentemente porque os terapeutas estão buscando formas para tornar os resultados desse tipo de terapia mais duradouros. A autora esclarece que, ao adotarem essa abordagem que combina TCC com psicologia positiva, os profissionais assumem que as capacidades, as forças e os recursos dos

clientes são mais importantes no processo de mudança do que suas limitações e deficiências. Isso não significa que os transtornos, as patologias, as disfunções, os problemas, os distúrbios, etc., não ocorram e não sejam relevantes. Trata-se de olhar não somente o lado “sombrio” da condição humana.

Há que se destacar que, ao se assumir como uma forma de educação para o caráter, a Educafi reforça o caráter educacional que é, segundo Beck e Steer (1993) e Neufeld (2011), próprio da TCC. Ademais, assume-se, com todos os riscos inerentes à empreitada, que se trata de uma prática terapêutica que almeja promover desenvolvimento moral.

É preciso salientar, por fim e com base em Davidson e Vaillant (2016), que terapias que somente reduzem aspectos negativos e práticas terapêuticas que somente promovem o “positivo” cegam os participantes quanto à complexidade da vida. Assim, além de se consolidar como uma forma de TCCG-I que promove o lado positivo da vida, a Educafi tem como desafio, para os próximos anos, apresentar evidências empíricas de que também é capaz de ser uma prática que lança luz no lado escuro da experiência humana, como a depressão.

REFERÊNCIAS

- Almeida, O. P., & Almeida, S. A. (1999). Confiabilidade da versão brasileira da escala de depressão em geriatria (GDS) versão reduzida. *Arquivos de Neuropsiquiatria*, 57(2-B), 421-426.
- Alvarenga, M. R. M., Oliveira, M. A. C., & Faccenda, O. (2012). Sintomas depressivos em idosos: Análise dos itens da Escala de Depressão Geriátrica. *Acta Paulista de Enfermagem*, 25(4), 497-503.
- American Psychiatric Association. (APA). (2014). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders: DSM-5* (5th ed.). Washington: Author.
- American Psychological Association. (APA). (2014). Guidelines for psychological practice with older adults. *The American Psychologist*, 69(1), 34.
- American Psychological Association.(APA). (2016). *PsycNET*. Recuperado de psycnet.apa.org
- Anderson, R. A., & Rees, C. S. (2007). Group versus individual cognitive-behavioural treatment for obsessive-compulsive disorder: a controlled trial. *Behaviour Research and Therapy*, 45(1), 123-137.
- Argimon, I. I. L., & Cerutti, F. (2016). Aplicação da TCC Beckiana para Idosos. In E. R. Freitas, A. J. G. Barbosa, & C. B. Neufeld (Orgs.), *Terapias cognitivo-comportamentais com idosos* (pp. 155-168). Novo Hamburgo: Sinopsys.

- Baltes, P. B. (1987). Theoretical propositions of Life-Span developmental psychology: On the dynamics between growth and decline. *Developmental Psychology*, 32 (5), 611-626.
- Baltes, P. B., & Baltes, M. M. (1990). *Successful aging: Perspectives from the behavioral sciences*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Bannink, F. P. (2012). *Practicing positive CBT: From reducing distress to building success*. New York: Black-Wiley.
- Barbosa, A. J. G., & Freitas, E. R. (2012). *Philadelphia Geriatric Center Morale Scale (PGCMS) – Versão Brasileira*. Juiz de Fora: Autores.
- Beck, A. T., & Steer, R. A. (1993). *Beck Depression Inventory: Manual*. San Antonio: Psychological Corporation.
- Beck, J. S. (1997). *Terapia cognitiva: Teoria e prática*. Porto Alegre: Artmed.
- Bieling, P. J., McCabe, R. E., & Antony, M. M. (2008). *Terapia cognitivo-comportamental em grupos*. Porto Alegre: Artmed.
- Brucki, S. M. D., Nitrini, R., Caramelli, P., Bertolucci, P. H. F., & Okamoto, I. H. (2003). Suggestions for utilization of the mini-mental state examination in Brazil. *Arquivos de Neuropsiquiatria*, 61(3B), 777-781.
- Caldas, C. P. (2006). O autocuidado na velhice. In E. V. Freitas, L. Py, F. A. X. Cançado, J. Doll, & M. L. Gorzoni (Orgs.). *Tratado de geriatria e gerontologia* (pp. 1117-1121). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- Craigie, M. A., & Nathan, P. (2009). A nonrandomized effectiveness comparison of broad-spectrum group CBT to individual CBT for depressed outpatients in a community mental health setting. *Behavior Therapy*, 40(3), 302-314.
- Cuadra-Peralta, A., Veloso-Besio, C., Puddu-Gallardo, G., Salgado-García, P., & Peralta-Montecinos, J. (2012). Impacto de un programa de Psicología Positiva en sintomatología depresiva y satisfacción vital en adultos mayores. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 25(4), 644-652.
- Cummings, N. A., & Cummings, J. L. (2008). Psychoeducation in conjunction with psychotherapy practice. In W. T. O'Donohue, & N. A. Cummings (Eds.), *Evidence-based adjunctive treatments* (pp. 41-59). New York: Academic Press.
- Cunha, J. A. (2001). *Manual da versão em português das Escalas Beck*. São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Davidson, A., & Vaillant, G. (2016). Positive clinical gerontology. In A. Davidson, & G. Vaillant (Orgs.), *The Wiley handbook of positive clinical psychology: An integrative approach to studying and improving well-being* (pp. 167-179). New Jersey: John Wiley & Sons.
- Diener, E., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. *Journal of Personality Assessment*, 49(1), 71-75.
- Ervatti, L., Borges, G. M., & Jardim, A. P. (Eds.) (2015). *Mudança demográfica no Brasil no início do século XXI: Subsídios para as projeções da população*. Rio de Janeiro: IBGE.
- Ferreira, H. G., & Batistoni, S. S. T. (2016). Terapia cognitivo-comportamental para idosos com depressão. In E. R. Freitas, A. J. G. Barbosa, & C. B. Neufeld (Orgs.), *Terapias cognitivo-comportamentais com idosos* (pp. 261-285). Novo Hamburgo: Sinopsys.

- Flint, A. J. (2005). Generalised anxiety disorder in elderly patients: Epidemiology, diagnosis and treatment options. *Drugs Aging*, 22(2), 101-114.
- Folkman, S., Lazarus, R. S., Dunkel-Schetter, C., DeLongis, A., & Gruen, R. J. (1986). Dynamics of a stressful encounter: cognitive appraisal, coping, and encounter outcomes. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50(5), 992-1003.
- Freitas, E. R., Barbosa, A. J. G., & Neufeld, C. B. (2016a). Educação para o caráter: Proposta de intervenção em grupo com idosos para promover forças e virtudes. In E. R. Freitas, A. J. G. Barbosa, & C. B. Neufeld (Orgs.), *Terapias cognitivo-comportamentais com Idosos* (pp. 329-351). Novo Hamburgo: Sinopsys
- Freitas, E. R., Barbosa, A. J. G., & Neufeld, C. B. (2016b). Positive aspects in Cognitive-Behavioral Group Therapy for elderly: A systematic review of the literature. *Revista Brasileira de Terapia Comportamental e Cognitiva*, 18(2), 86-99.
- Gallagher-Thompson, D., & Thompson, L. W. (2010). *Treating late-life depression: a cognitive-behavioral therapy approach* [Therapist guide-treatments that work]. New York: Oxford University Press.
- García-Peña, C., Vázquez-Estupiñan, F., Avalos-Pérez, F., & Robles, L. V. (2015). Clinical effectiveness of group cognitive-behavioural therapy for depressed older people in primary care: A randomised controlled trial. *Salud Mental*, 38(1), 33-39.
- Gondim, S. M. G., Bastos, A. V. B., & Peixoto, L. S. A. (2010). Áreas de atuação, atividades e abordagens teóricas do psicólogo brasileiro. In A. V. B. Bastos, & S. M. G. Gondim (Orgs.), *O trabalho do psicólogo no Brasil* (pp. 174-199). Porto Alegre: Artmed.
- Gouveia, V. V., Barbosa, G. A., Andrade, E. D. O., & Carneiro, M. B. (2005). Medindo a satisfação com a vida dos médicos no Brasil. *Jornal Brasileiro de Psiquiatria*, 54(4), 298-305.
- Granholt, E., McQuaid, J. R., McClure, F. S., Link, P. C., Perivoliotis, D., Gottlieb, J. D., ... Jeste, D. V. (2007). Randomized controlled trial of cognitive behavioral social skills training for older people with schizophrenia: 12-month follow-up. *The Journal of Clinical Psychiatry*, 68(5), 730-737.
- Guedea, M. T. D., Albuquerque, F. D., Tróccoli, B. T., Noriega, J. A. V., Seabra, M. A. B., & Guedea, R. L. D. (2006). Relação do bem-estar subjetivo, estratégias de enfrentamento e apoio social em idosos. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, 19(2), 301-308.
- Hill, R. D., & Mansour, E. (2008). The role of positive aging in addressing the mental health needs of older adults. In D. Gallagher-Thompson, A. Steffen, & L. W. Thompson (Eds.), *Handbook of behavioral and cognitive therapies with older adults* (pp. 309-322). New York: Springer.
- Laidlaw, K. (2001). An empirical review of cognitive therapy for late life depression. Does research evidence suggest adaptations are necessary for cognitive therapy with older adults? *Clinical Psychology and Psychotherapy*, 8(1), 1-14.
- Laidlaw, K., & McAlpine, S. (2008). Cognitive behaviour therapy: How is it different with older people? *Journal of Rational-Emotive & Cognitive-Behavior Therapy*, 26(4), 250-262.
- Laidlaw, K., Thompson, L. W., & Gallagher-Thompson, D. (2004). Comprehensive conceptualization of cognitive behavior therapy for late life depression. *Behavioural and Cognitive Psychotherapy*, 32(4), 389-399.

- Laidlaw, K., Thompson, L. W., Gallagher-Thompson, D., & Dick-Siskin, L. (2003). *Cognitive behaviour therapy with older people*. England: John Wiley & Sons.
- Lawton, M. P. (1991). A multidimensional view of quality of life in frail elders. In R. P. Abeles (Ed.), *The concept and measurement of quality of life in the frail elderly* (pp. 3-27). New York: Academic Press.
- Lima, M. P. (2004). *Posso participar? Atividades de desenvolvimento pessoal para idosos*. Porto: Ambar.
- Lobo, B. O. M., Rigoli, M. M., Sbardelloto, G., Rinaldi, J., Argimon, I. L., & Kristensen, C. H. (2012). Terapia cognitivo-comportamental em grupo para idosos com sintomas de ansiedade e depressão: Resultados preliminares. *Psicologia: Teoria e Prática*, 14(2), 116-125.
- Manfrim, A., & Schmidt, S. L. (2006). Diagnóstico diferencial das demências. In E. V. Freitas, L. Py, A. L. Neri, F. A. X. Cançado, M. L. Gorzoni, & S. M. Rocha (Orgs.), *Tratado de geriatria e gerontologia* (2. ed., pp. 242-251). Rio de Janeiro: Guanabara Koogan.
- Martiny, C., Silva, A. C. O., Nardi, A. E., & Pechana, N. A. (2011). Tradução e adaptação transcultural da versão brasileira do Inventário de Ansiedade Geriátrica (GAI). *Revista de Psiquiatria Clínica*, 38(1), 8-12.
- Massena, P. N., Araújo, N. B., Pachana, N., Laks, J., & Pádua, A. C. (2014). Validation of the Brazilian Portuguese Version of Geriatric Anxiety Inventory – GAI-BR. *International Psychogeriatrics*, 27(7), 1113-1119.
- Nardi, T. C., & Grassi-Oliveira, R. G. (2011). A terapia cognitivo-comportamental e o envelhecimento. In I. Andretta, & M. S. Oliveira (Orgs.), *Manual prático de terapia cognitivo-comportamental* (pp. 507-520). São Paulo: Casa do Psicólogo.
- Nardi, T. C., Grassi-Oliveira, R., & Pádua, A. C. (2016). Terapia cognitivo-comportamental no tratamento dos sintomas de ansiedade em idosos. In E. R. Freitas, A. J. G. Barbosa, & C. B. Neufeld (Orgs.), *Terapias cognitivo-comportamentais com idosos* (pp. 207-230). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Nascimento, E., & Banhato, E. F. C. (2016). Avaliação da inteligência em idosos e sua contribuição para a terapia cognitivo-comportamental. In E. R. Freitas, A. J. G. Barbosa, & C. B. Neufeld (Orgs.), *Terapias cognitivo-comportamentais com idosos* (pp. 55-83). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Neri, A. L. (1995). Psicologia do envelhecimento: Uma área emergente. In A. L. Neri (Ed.), *Psicologia do envelhecimento* (pp. 13-40). Campinas: Papirus.
- Neri, A. L. (2006). O legado de P. B. Baltes à psicologia do desenvolvimento e do envelhecimento. *Temas de Psicologia*, 14(1), 17-34.
- Neufeld, C. B. (2011). Intervenções em grupos na abordagem cognitivo-comportamental. In B. Rangé (Ed.), *Psicoterapias cognitivo-comportamentais: Um diálogo com a psiquiatria* (2. ed., pp. 737-750). Porto Alegre: Artmed.
- Neufeld, C. B., Daolio, C. C., & Longuini, L. Z. (2015). Desafios da terapia cognitivo-comportamental em grupo com crianças e adolescentes. In C. B. Neufeld (Org.), *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes* (pp. 17-34). Porto Alegre: Artmed.
- Oliveira, R. L. (2012). Psicoterapia breve cognitivo-comportamental para os idosos. In M. E. N. Lipp, & E. M. P. Yoshida (Orgs.), *Psicoterapias breves nos diferentes estágios evolutivos* (pp. 219-239). São Paulo: Casa do Psicólogo.

- Pachana, N. A., Byrne, G. J., Siddle, H., Koloski, N., Harley, E., & Arnold, E. (2007). Development and validation of the Geriatric Anxiety Inventory. *International Psychogeriatrics*, 19(1), 103-114.
- Paschoal, S. M. P. (2000). *Qualidade de vida do idoso: Elaboração de um instrumento que privilegia sua opinião* (Tese de Doutorado não publicada, Faculdade de Medicina, Universidade de São Paulo, São Paulo).
- Peterson, C., & Seligman, M. E. P. (2004). *Character strengths and virtues: A handbook and classification*. Washington: American Psychological Association.
- Pothirat, C., Phetsuk, N., Liwsrisakun, C., & Deesomchok, A. (2015). Real-world comparative study of behavioral group therapy program vs education program implemented for smoking cessation in community-dwelling elderly smokers. *Clinical Interventions in Aging*, 10, 725-731.
- Rebelo, H. (2007). Psicoterapia na idade adulta avançada. *Análise Psicológica*, 4(25), 543-557.
- Reis, G. A., & Barbosa, A. J. G. (2016). Competências de terapeutas cognitivo-comportamentais de idosos. In E. R. Freitas, A. J. G. Barbosa, & C. B. Neufeld (Orgs.), *Terapias cognitivo-comportamentais com idosos* (pp. 305-325). Novo Hamburgo: Sinopsys.
- Rowe, J. W., & Kahn, R. L. (1998). *Successful aging*. New York: Pantheon Books.
- Seligman, M. E. P., Steen, T. A., Park, N., & Peterson, C. (2005). Positive psychology progress: Empirical validation of interventions. *American Psychologist*, 60(5), 410-421.
- Sharp, D. M., Power, K. G., & Swanson, V. (2004). A comparison of the efficacy and acceptability of group versus individual cognitive behaviour therapy in the treatment of panic disorder and agoraphobia in primary care. *Clinical Psychology & Psychotherapy*, 11(2), 73-82.
- Sin, N. L., & Lyubomirsky, S. (2009). Enhancing well-being and alleviating depressive symptoms with positive psychology interventions: A practice-friendly meta-analysis. *Journal of Clinical Psychology*, 65(5), 467-487.
- Söchting, I., O'Neal, E., Third, B., Rogers, J., & Ogrodniczuk, J. S. (2013). An integrative group therapy model for depression and anxiety in later life. *International Journal of Group Psychotherapy*, 63(4), 502-523.
- Stella, F. (2004). Envelhecimento Cognitivo. In L. Py, J. L. Pacheco, J. L. M. Sá, & S. N. Goldman (Eds.), *Tempo de envelhecer: Percursos e dimensões psicossociais* (pp. 283-321). Rio de Janeiro: Nau.
- Thompson, L. W., Powers, D. V., Coon, D. W., Takagi, K., McKibbin, C., & Gallagher-Thompson, D. (2003). Terceira idade. In J. R. White, & A. S. Freeman (Eds.), *Terapia cognitivo-comportamental em grupo para populações e problemas específicos* (pp. 269-299). São Paulo: Roca.
- Tristán, S. V. L., & Rangel, A. L. G. (2009). Psicoterapia cognitivo conductual de grupo manualizada como una alternativa de intervención con adultos mayores. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 11(2), 155-189.
- Vaillant, G. E. (2004). Positive aging. In P. Linley, & S. Joseph (Eds.), *Positive psychology in practice* (pp. 561-578). New York: John Wiley.
- Vaz, S. F. A., & Gaspar, N. M. S. (2011). Depressão em idosos institucionalizados no distrito de Bragança. *Revista de Enfermagem Referência*, 11(4), 49-58.
- VIA Institute on Character. (2013). *VIA-IS 120*. Recuperado de <https://www.viacharacter.org/>
- Wilkinson, P. (1997). Cognitive therapy with elderly people. *Age and ageing*, 26(1), 53-58.

Wright, J. H., Basco, M. R., & Thase, M. E. (2008). *Aprendendo a terapia cognitivo-comportamental: Um guia ilustrativo*. Porto Alegre: Artmed.

Yalom, I. D., & Leszcz, M. (2006). *Psicoterapia de grupo: Teoria e prática* (5. ed.). Porto Alegre: Artmed.

Yesavage, J. Á., Brink, T. L., Rose, T. L., Lum, O., Huang, V., Adey, M., & Leirer, V. O. (1983). Development and validation of a geriatric depression screening scale: A preliminary report. *Journal of Psychiatric Research*, 17(1), 37-49.

Zarit, S. H., & Zarit, J. M. (2009). *Transtornos mentais em idosos: Fundamentos de avaliação e tratamento* (2. ed.). São Paulo: Roca.

Conheça também:

BECK, J. S. Terapia cognitivo-comportamental: teoria e prática – 2.ed.

DATILLIO, F. M. Manual de terapia cognitivo-comportamental para casais e famílias

HOFMANN, S. G. Introdução à terapia cognitivo-comportamental contemporânea

LEAHY & Cols. Terapia cognitiva contemporânea: teoria, pesquisa e prática

NEUFELD, C. B. (org.) Terapia cognitivo-comportamental em grupo para crianças e adolescentes

NEUFELD, C. B. (org.) Terapia cognitivo-comportamental para adolescentes: uma perspectiva transdiagnóstica e desenvolvimental

RANGÉ & Cols. Psicoterapias cognitivo-comportamentais: um diálogo com a psiquiatria

SOBELL & SOBELL Terapia de grupo para transtornos por abuso de substâncias: abordagem cognitivo-comportamental motivacional

Sobre o Grupo A

O Grupo A está preparado para ajudar pessoas e instituições a encontrarem respostas para os desafios da educação. Estudantes, professores, médicos, engenheiros, psicólogos. Profissionais das carreiras que ainda não têm nome. Universidades, escolas, hospitais e empresas das mais diferentes áreas. O Grupo A está ao lado de cada um. E também está nas suas mãos. Nos seus conteúdos virtuais. E no lugar mais importante: nas suas mentes.

Acesse

0800 703 3444

sac@grupoa.com.br

Av. Jerônimo de Ornelas, 670

Santana

CEP: 90040-340 • Porto Alegre / RS

